

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

BÁRBARA BIRK DE MELLO

**SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: OLHARES A PARTIR DE
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE-RS**

Porto Alegre

2026

BÁRBARA BIRK DE MELLO

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: OLHARES A PARTIR DOS AGENTES
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas como requisito parcial para
obtenção do doutorado em Políticas Públicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientadora: Andréa Fachel Leal

Porto Alegre

2026

Bárbara Birk de Mello

**SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: OLHARES A PARTIR DE
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE-RS**

Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de Doutora e aprovada em sua forma final/com alterações indicadas pela banca.

Porto Alegre, 24 de FEVEREIRO de 2026.

Prof. Luciana Pazini Papi, Dra.

Coordenadora do PPG

Banca Examinadora:

Prof.^a Andréa Fachel Leal, Dra.

Orientadora

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Luciana Leite Lima, Dra.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Gabriela Spanghero Lotta, Dra.

FGV

Prof. Cláudia Fonseca, Dra.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Catalogação na Publicação

Birk de Mello, Bárbara
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: OLHARES A
PARTIR DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS / Bárbara Birk de Mello.
-- 2026.
351 f.
Orientadora: Andréa Fachel Leal.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Saúde sexual e reprodutiva. 2. Educação. 3.
Juventude. 4. Escolas. 5. Unidades de saúde. I. Fachel
Leal, Andréa, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

DEDICATÓRIA

À minha irmã, que é a maior alegria da minha vida.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - Código de Financiamento 001, pelo apoio financeiro nestes quatro anos, o que foi central para o desenvolvimento desta pesquisa.

Iniciando os agradecimentos às pessoas que estiveram comigo, muito obrigada à minha orientadora, que esteve ao meu lado estes quatro anos e foi essencial para chegarmos a este momento. Sem ela, o doutorado e a tese não seriam uma experiência tão marcante quanto foram. Obrigada por tanto!

Também agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, universidade que foi minha casa durante estes últimos quatro anos e que me acolheu tão bem! Estendo meus agradecimentos para os professores, professoras e colegas tão queridos que encontrei pelo caminho, tanto no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas quanto no Programa de Antropologia e no de Educação. Um carinho especial aos meus colegas Guilherme, Mutaro, Laura, Drisa, Luciana, Tifani e Gabriela. Compartilhar as alegrias e apreensões do doutorado com vocês foi o que muitas vezes me deu energia para seguir.

Foram quatro anos de vida dedicados ao doutorado em que muita coisa aconteceu: comecei as aulas no on-line devido à pandemia da COVID-19, passei por uma mudança para a capital, Porto Alegre, me mudei três vezes de apartamento e em 2024 passei por um dos momentos mais traumáticos da minha vida, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Nesses quatro anos muita coisa aconteceu para além do dia a dia de aulas, idas a congressos e escrita da tese e por vezes eu me senti sufocada e extremamente ansiosa. Desde já agradeço à minha psicóloga, Milena, que está comigo desde 2022, e à minha psiquiatra, aquisição mais recente (risos), e que vem me ajudando desde 2025.

Mas para além delas, meu agradecimento muito especial e necessário a todas as pessoas que viveram comigo nesses quatro anos e antes deles também. Alicena e Amarilis, as irmãs que a vida me deu e que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos. Martina, Letícia e Alana, amigas de escola que seguem até hoje do meu ladinho e conhecem bem os percalços da vida acadêmica. Ainda, tenho que falar da minha companhia para todos os almoços no restaurante universitário, Laura, que dividia comigo os desafios da pós-graduação e da vida cotidiana. E um muito obrigado também à amiga Alice que esteve comigo desde os tempos de escola e vôlei - apesar de ela achar o suficiente me ver a cada dois meses (risos).

E muito obrigada pela amizade também para a Su, nova mamãe do grupo, que eu tenho um enorme carinho. Também um agradecimento pela amizade e carinho nesses anos para a

Mari e a Bru, amigas que fiz no vôlei de Nova e mantive em Porto, queria poder guardar as duas bebês num potinho.

Falando em vôlei, um agradecimento muito especial a todas as amigas que dividiram as quadras de areia e ginásios comigo. Obrigada a minha duplinha de sempre, Aninha, que além de grande amiga do vôlei, é uma amiga pra vida que eu sempre quero manter do meu ladinho. Um carinho muito grande também pela minha baby, Ludi, que foi minha dupla em muitos treinos aqui em Porto Alegre. E um muito obrigada para as meninas lá de Nova Petrópolis, como minha eterna dupla do vôlei de quadra, a Ca. E também meu muito obrigada a todo o time do Sputnik que me acolheram tão bem em 2025 e encheram meus dias de alegria!

Chegando mais perto de casa... meu agradecimento diário pela amizade e apoio da Thaia e também do Dioni, vocês me deram os melhores presentes nestes anos de doutorado: minhas afilhadas. Mali e Aninha, vocês são o amor da dinda, não tenho nem palavras pra expressar o quanto vocês são amadas por mim e o quanto eu quero que cresçam em meio à felicidade e alegria. Obrigada por deixarem eu amar vocês e me amarem de volta.

Aos meus dois bebês de quatro patas: Thunder e Cuquinha. Vocês não fazem a menor ideia disso, mas foram essenciais para eu passar por esse período. O amor e carinho de vocês me trouxe muita alegria e acalmou meu coração em tantos momentos e seria impossível não agradecer a vocês.

Ao meu namorado, Matheus, o qual não desistia de me chamar em 2024 - quando eu estava o ano todo no campo de pesquisa e não tinha tempo pra nada -, meu muito obrigada pela paciência (risos). Nos aproximamos no final de 2024 e desde então não nos desgradamos mais. Você passou por muitos momentos difíceis meus e sempre esteve ao meu lado, me apoiando e cuidando de mim com todo o amor e carinho. Te amo muito e estou louca pra passar o resto dos meus dias contigo! Prometo que se eu fizer mais um doutorado ou pós-doc, vai ser mais tranquilo (risos).

Agora, aos meus pais, Suzana e Celso, que sempre me apoiaram na minha escolha de seguir a vida acadêmica, tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre brincamos que minha mãe dizia que era pra eu estudar e que levei muito a sério e nunca mais parei (risos). Agora vou parar por um tempo, prometo. Sou muito grata por todos os aprendizados que tive com vocês e por sempre acreditarem em mim. Se sou quem sou hoje - e acho que sou uma pessoa bem legal (risos) - é por causa de vocês.

Por fim, minha irmã, a pessoa que mais amo nesse planeta inteirinho e pela qual eu daria a minha vida. Sempre digo que o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que ela nasceu. Obrigada por ser exatamente como você é, mana. Te amo daqui até o infinito e de volta. Vou

estar sempre do seu lado, assim como você esteve comigo nesses anos todinhos. Te dedico essa tese, pois você é a razão de eu ter chegado até aqui. Sem você me apoiando, eu não teria conseguido.

RESUMO

Este estudo tem como foco a implementação de políticas de saúde e educação juvenil em Porto Alegre, RS, Brasil. Mais especificamente, focamos nas políticas que abarcam a saúde sexual e reprodutiva juvenil. Olhamos para o cotidiano de implementação de políticas que afetam a sexualidade de jovens, focando no trabalho de professores(as), técnicas de enfermagem, Agentes Comunitárias de Saúde, médicos(as) e enfermeiros(as) de um bairro de camadas populares da região Leste de Porto Alegre, RS. Temos como objetivo central do estudo: identificar e analisar quais são os micromecanismos de governança reprodutiva que os(as) agentes de saúde e educação fazem uso para abordar a SSR com os(as) jovens porto-alegrenses residentes em uma periferia. Para tanto, fez-se uma revisão das principais políticas que orientam e normatizam a atuação dos(as) agentes de saúde e de educação de Porto Alegre no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva dos jovens porto-alegrense, observando em que medida tais políticas estão presentes no cotidiano dos(as) agentes. Também analisamos as relações que se estabelecem entre os(as) agentes e jovens no domínio da saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens. Na sequência, examinamos a experiência dos(as) jovens no serviço público de saúde quanto à sua saúde sexual e reprodutiva e, ainda, como, no ambiente escolar, se dão as discussões acerca da saúde sexual e reprodutiva dos jovens. Para atingir estes objetivos, centramos nosso olhar na agência dos(as) profissionais de saúde e educação já citados tendo como base autores do campo de públicas voltados para a implementação, principalmente Maynard-Moody e Musheno (2022, 2012), e autores do campo da antropologia das políticas públicas, como Shore e Wright (1997). Para analisar a atuação dos(as) profissionais, trazemos o conceito de micromecanismos de governança reprodutiva, baseados em Morgan e Roberts (2012). Foram realizadas entrevistas com profissionais da saúde e educação e jovens beneficiários das políticas, rodas de conversa com jovens em escolas e observações de cunho etnográfico em duas escolas e numa unidade de saúde do território. A análise dos dados é do tipo análise de conteúdo (Bardin, 2016). Entendemos que a agência dos(as) profissionais de saúde e educação no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva pode ser interpretada através de cinco micromecanismos: contenção reprodutiva, coerção contraceptiva, acumulação reprodutiva feminina, vigilância reprodutiva e omissão da sexualidade.

Palavras-chave: Escola. Jovens. Saúde sexual. Saúde reprodutiva. Unidades de saúde.

ABSTRACT

This study focuses on the implementation of youth health and education policies in Porto Alegre, RS, Brazil. More specifically, we focus on policies encompassing youth sexual and reproductive health. We examine the daily implementation of policies affecting the sexuality of young people, focusing on the work of teachers, nursing technicians, Community Health Agents, doctors, and nurses in a working-class neighborhood in the eastern region of Porto Alegre, RS. Our central objective in this study is to identify and analyze the micro-mechanisms of reproductive governance that health and education agents use to address reproductive health issues with young people from Porto Alegre living in a peripheral area. To this end, a review was conducted of the main policies that guide and regulate the actions of health and education agents in Porto Alegre regarding the sexual and reproductive health of young people in the city, observing the extent to which these policies are present in the daily lives of these agents. We also analyzed the relationships established between agents and young people in the field of sexual and reproductive health. Subsequently, we examined the experience of young people in the public health service regarding their sexual and reproductive health, and how discussions about sexual and reproductive health take place in the school environment. To achieve these objectives, we focused on the agency of the aforementioned health and education professionals, drawing on authors in the field of public policy implementation, primarily Maynard-Moody and Musheno (2022, 2012), and authors in the field of the anthropology of public policy, such as Shore and Wright (1997). To analyze the professionals' actions, we used the concept of micro-mechanisms of reproductive governance, based on Morgan and Roberts (2012). Interviews were conducted with health and education professionals and young beneficiaries of the policies, discussion groups were held with young people in schools, and ethnographic observations were carried out in two schools and a health unit in the territory. The data analysis is of the content analysis type (Bardin, 2016). We understand that the agency of health and education professionals with regard to sexual and reproductive health can be interpreted through five micro-mechanisms: reproductive restraint, contraceptive coercion, female reproductive accumulation, reproductive surveillance, and omission of sexuality.

Keywords: School. Youth. Sexual health. Reproductive health. Health units.

LISTA DE QUADROS

Quadro 155

Quadro 2.....57

Quadro 3.....64

Quadro 4.....87

Quadro 5.....87

Quadro 6.....88

Quadro 7.....89

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS - Agente Comunitário de Saúde

AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

APS - Atenção Primária à Saúde

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

BNCCEM - Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio

BNR - Burocratas de Nível de Rua

BVAPS - Biblioteca Virtual de Atenção Primária à Saúde

CAEE - Certificado de Apresentação de Apreciação Ética

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais

DCNEM - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

DF - Distrito Federal

DIU - Dispositivo Intrauterino

DST - Doença Sexualmente Transmissível

GERCON - Gerenciamento de Marcação de Consultas

GRAVAD - Pesquisa Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e Reprodução no Brasil

HIV - Human Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Humana)

HPV - Papilomavírus Humano

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

IST - Infecção Sexualmente Transmissível

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MMFDH - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

MS - Ministério da Saúde

OMS - Organização Mundial da Saúde

ONG - Organização Não Governamental

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

PAIGA - Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais

PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio

PEAISA - Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes

PEE - Plano Estadual de Educação

PeNSE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar

PEP - Profilaxia Pós-Exposição

PME - Plano Municipal de Educação

PNA - Pesquisa Nacional de Saúde

PNAISH - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

PNAR - Pesquisa Nacional sobre Aborto

PNE - Plano Nacional de Educação

PrEP - Profilaxia Pré-Exposição

PSE - Programa Saúde na Escola

RCGEM - Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio

RS - Rio Grande do Sul

SAPS - Secretaria de Atenção Primária à Saúde

SASE - Serviço de Apoio Sócio Educativo

SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

SSR - Saúde Sexual e Reprodutiva

SUS - Sistema Único de Saúde

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)

UPA - Unidade de Pronto Atendimento

US - Unidade de Saúde

VD - Visita domiciliar

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	17
2. IMPLEMENTAÇÃO, ANTROPOLOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA REPRODUTIVA.....	27
2.1 AQUELES E AQUELAS QUE FAZEM A POLÍTICA	27
2.2 GOVERNANÇA REPRODUTIVA.....	31
2.2.1 Os micromecanismos	41
3 PERCURSOS METODOLÓGICOS.....	47
3.1 CONSTRUINDO O REFERENCIAL METODOLÓGICO.....	47
3.2 DA ESCOLHA DO TERRITÓRIO DA PESQUISA.....	60
4 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA – O QUE A LITERATURA TEM A NOS DIZER.....	65
4.1 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: ONDE ESTAMOS?.....	67
4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL.....	72
4.3 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS JOVENS E US.....	74
4.4 SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA JUVENIL NO AMBIENTE ESCOLAR.....	76
5. “EU NÃO ME SINTO SEGURO DE ANDAR POR AQUI NÃO”.....	82
5.1 PASSOS INICIAIS DA PESQUISA DE CAMPO.....	83
5.2 ADENTRANDO O TERRITÓRIO.....	89
5.3 COMO SE ESTRUTURAM AS ESCOLAS.....	103
5.4 E COMO É DENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE?.....	110
6. “SEGUIMOS AS DIRETRIZES”.....	122
6.1 DA LEI AO CHÃO DA ESCOLA.....	123
6.1.1 “Ah, isso tem lá na BNCC”	130
6.2 DA LEI AO CHÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.....	134
6.2.1 “A gente segue os protocolos”	142
7. “SIM, JÁ OUVI FALAR EM PRESERVATIVO. E A SENHORA JÁ OUVIU FALAR EM GRAVIDEZ QUE A GENTE QUER?”	152
7.1 VISÕES SOBRE A GESTAÇÃO NA JUVENTUDE.....	152

7.2 DIÁLOGOS COM PROFESSORES(AS) DE BIOLOGIA.....	163
7.3 E PARA ALÉM DOS(AS) PROFESSORES(AS) DE BIOLOGIA?.....	171
7.4 GESTAÇÃO E PUERPÉRIO NA ESCOLA.....	175
7.5 GESTAÇÃO, PUERPÉRIO E UNIDADE DE SAÚDE.....	177
8. “TEM QUE COLOCAR A CONTRACEPÇÃO NELAS PARA ELAS NÃO ENGRAVIDAREM.”.....	193
8.1 ESCOLA E CONTRACEPÇÃO.....	194
8.2 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E O SERVIÇO DE SAÚDE.....	200
8.3 “ANTICONCEPCIONAL É COISA DE MULHER” SERÁ?.....	209
9. “IST? AH, AQUELAS DOENÇAS LÁ, NÉ?”.....	213
9.1 ESCOLAS E OLHARES PARA “AQUELAS DOENÇAS SEXUAIS LÁ”.....	213
9.2 OS ATENDIMENTOS NA US ACERCA DE ISTS.....	221
10. “NÃO TEMOS ESSAS DISCUSSÕES SOBRE SEXUALIDADE AQUI”.....	229
10.1 ORIENTAÇÃO SEXUAL: “MELHOR NÃO FALAR”.....	229
10.2 VIOLÊNCIA E PRAZER SEXUAL.....	235
10.3 GÊNERO: QUASE COMO UMA PALAVRA PROIBIDA.....	237
11. “SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA? AH, SORA, TU VEIO FALAR SOBRE GRAVIDEZ, NÉ?”.....	240
11.1 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E GOVERNANÇA.....	240
11.2 APROFUNDANDO O ENTENDIMENTO DA AÇÃO DOS(AS) PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS E US.....	244
11.2.1 Contexto de atuação dos(as) implementadores(as) de políticas públicas.....	245
11.2.2 Micromecanismos de contenção reprodutiva.....	254
11.2.3 Micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.....	258
11.2.4 Micromecanismos de vigilância reprodutiva.....	263
11.2.5 Micromecanismos de coerção contraceptiva.....	267
11.2.6 Micromecanismos de omissão da sexualidade.....	271
12. “MAS O QUE TU VAI FAZER COM ESSA PESQUISA, SORA?”.....	273
REFERÊNCIAS.....	284
APÊNDICES.....	313
ANEXO.....	339

INTRODUÇÃO

Sabemos que a existência de uma pesquisa totalmente objetiva é uma ilusão. Desde o momento em que escolhemos um tema de pesquisa, o fazemos porque algo, ou melhor, algo(s) nos mobiliza. Quem somos tem grande peso na escolha do nosso objeto de pesquisa, e também na maneira como conduzimos a mesma. No meu caso, olhar para a sexualidade na juventude me mobiliza a partir de vários lugares.

A sexualidade juvenil recebeu um olhar atento de pesquisadores(as) nos anos 2000, o maior exemplo é a pesquisa Gravidez na Adolescência: Estudo Multicêntrico sobre Jovens, Sexualidade e Reprodução no Brasil (GRAVAD)¹, onde a centralidade das múltiplas formas de vivenciar a juventude, a sexualidade e a reprodução foram pesquisadas por diversos(as) profissionais. Passados quase vinte anos de sua publicação, tenho a impressão de que regredimos nas percepções acerca da gestação na juventude dentro de um contexto de crescente conservadorismo a nível mundial - tendo como maior exemplo os Estados Unidos da América - e a nível nacional com o governo Bolsonaro (2018-2022) e seus discursos moralistas em relação a inúmeras questões, entre elas, a gestação na juventude, que, segundo a extrema-direita brasileira, sempre é de “risco” e “indesejada”. É devido à sexualidade juvenil ter voltado à tona nas discussões nacionais, que vi a importância de novamente discutirmos sobre as múltiplas formas de viver a juventude e o direito dos(as) jovens à escolha de gestar - ou não.

Ao ingressar no doutorado em Políticas Públicas me inseri no Grupo de Pesquisa em Saúde e Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual estava atuando, junto de outras quatro universidades do Brasil, na pesquisa “Jovens na era digital: sexualidade, reprodução, redes sociais e prevenção à IST/Aids”.

A pesquisa foi realizada em parceria de cinco universidades brasileiras, em cinco regiões do País, onde, em cada local, foram entrevistados, em média, 40 jovens, possibilitando uma base riquíssima de cerca de 200 entrevistas. Nesta pesquisa, foram entrevistados 37 jovens do Rio Grande do Sul, sendo a grande maioria de Porto Alegre, capital do Estado, e entre idades de 16 e 24 anos. Ao participar desta pesquisa, pude realizar entrevistas, analisar diversas delas, ter mais leituras sobre gestação na juventude e refletir sobre a necessidade e importância de se discutir com os(as) jovens sobre a temática.

¹ Para ter mais informações sobre a pesquisa GRAVAD, sugiro que acessem o livro oriundo da mesma: Heilborn, M. L.; Aquino, E.; Bozon, M.; Knauth, D. R. (Orgs.). O Aprendizado da sexualidade. Reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Garamond e Fiocruz, 2006.

Vale aqui discutir brevemente a minha posicionalidade dentro desta pesquisa. Como destaquei no início da introdução, nenhuma pesquisa é totalmente objetiva e sempre nos movemos a partir de “algo”. No meu caso, o tema da saúde sexual e reprodutiva juvenil me toca de diversas formas no nível pessoal e acadêmico.

Em nível pessoal, sou uma mulher branca de camadas médias e heterossexual que estudou a maior parte da vida em escolas privadas e que cresceu em uma cidade pequena da Serra Gaúcha onde a religião católica era predominante, assim como o tabu em torno da sexualidade. Minha mãe nunca falou comigo sobre sexo, era como se fosse uma palavra proibida, nem depois de eu ter dezoito anos e ter começado a namorar. Nunca tive conversas sobre esse assunto com minhas amigas, tínhamos vergonha de falar sobre isso.

Lembro-me bem de uma menina de dezessete anos da escola que ficou grávida e que foi um grande choque para todos(as) nós na escola e que a maioria das pessoas ficou falando muito mal dela, de que a vida dela iria acabar e que ela deveria ter vergonha do que fez. Eu simpatizava com ela e nunca falei mal dela ou da filha, muito pelo contrário, mas isso não evitava que eu morresse de medo de ter o mesmo destino que ela.

A primeira vez que fui numa ginecologista foi com dezoito anos, pois tinha começado a namorar e queria começar a tomar anticoncepcional. Lembro que conversamos - ela é mãe de uma amiga minha - e ela disse que eu não precisava dizer para a mãe que era por medo da gestação, já que a gente não falava sobre sexo. Eu deveria dizer que era só para regular a menstruação. Minha mãe acreditou ou sabia o que era na verdade, mas tinha medo de falar comigo sobre.

A única vez que eu tive contato com o sistema reprodutivo feminino foi na aula de Ciências onde a professora fez aquela clássica aula e falou sobre as ISTs de forma breve. Eu e minhas amigas morríamos de medo delas, bem como de ficarmos grávidas. Aliás, a gravidez na adolescência é algo que tenho medo até hoje, mesmo com vinte e oito anos. Ainda acho que seria um grande problema eu estar grávida hoje sem ter passado ainda num concurso e sem ter casado.

E foi justamente por esse meu medo da gestação e pela minha falta de acesso ao conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva, quando eu era jovem, que eu me interessei em estudar a saúde sexual e reprodutiva juvenil, no doutorado, quando vi a oportunidade através de um projeto de pesquisa que estava sendo desenvolvido na UFRGS em parceria com outras universidades acerca da sexualidade juvenil.

Se olharmos pela trajetória acadêmica, minha graduação em História foi atravessada pela proximidade com a história do tempo presente e com as infâncias e juventudes, quando

estudei sobre o processo de criação e primeiros anos de atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul (Mello, 2019).

Na sequência, no mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social segui em uma linha de pesquisa denominada: Políticas Públicas e Inclusão Social. Ali, estudei a partir da etnografia da duração (Rocha; Eckert, 2013) e os 30 anos de existência do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, RS, interessada em como a instituição buscava garantir o direito das infâncias e juventudes daquela cidade (Mello, 2022). Assim, infâncias e juventudes sempre estiveram em pauta nas minhas pesquisas, tendo nos últimos anos me aproximado do campo das Políticas Públicas ao ingressar no doutorado.

Nesse contexto, a vontade de pesquisar sobre saúde sexual e reprodutiva (SSR), não posso negar, parte também de uma vontade minha de entender este meu medo e como ele é tão presente para mim enquanto que não é para outras jovens. O que muda entre nós? Que diferença faz? Por que tenho tanto medo?

Nesse sentido, ao iniciar as leituras sobre gravidez juvenil e ver outras jovens que queriam engravidar, eu me deparei com um mundo que eu nem sabia que existia: como alguém com dezesseis anos iria querer ser mãe? No início da minha trajetória no doutorado eu comecei a refletir justamente sobre a minha posicionalidade, de onde vinha meu pensamento e como abordar isso ao longo da tese. Posso dizer que aqui eu quebrei vários tabus meus acerca da gestação na juventude, e também da importância de discussões sobre saúde sexual e reprodutiva com os(as) jovens.

Quando eu tinha dezoito anos, morria de medo de gestar, não falava sobre sexualidade e não conhecia uma garota que quisesse passar por isso. Dez anos depois, eu ainda morro de medo, mas conheço histórias de jovens que querem gestar, que gestaram e que são muito felizes com seus(as) filhos(as). Hoje em dia percebo como teria sido importante eu ter tido maior acesso à saúde sexual e reprodutiva, seja na escola e/ou outros espaços de saúde. Dez anos depois, eu defendo que os(as) jovens precisam ter mais discussões na escola, em unidades de saúde ou em outros espaços de sua socialização acerca da SSR. Defendo que os(as) jovens tenham pleno acesso aos seus direitos sexuais e reprodutivos e que eles(as) tenham uma formação diferente da que eu tive.

Ao realizar meu trabalho de campo, me vi nas falas de profissionais e de jovens diversas vezes; na fala de profissionais que dizem que não se deve ser mãe tão jovem, que as meninas não têm estrutura familiar e financeira para tanto - tal qual diria a Bárbara de dezoito anos - e na fala das jovens que destacam ter medo de gestar, que primeiro precisam se organizar

financeira e mentalmente. Também dos(as) jovens que disseram ter tido apenas uma aula de Biologia sobre evitar a gestação e como funcionava a reprodução.

Mas também passei a entender o pensamento das jovens que queriam gestar e/ou que já eram mães e se sentiam muito felizes com suas escolhas. A realidade delas é muito diferente da minha que sempre tive acesso à educação de qualidade, nunca precisei trabalhar enquanto era jovem e cresci com o discurso de que era necessário estudar, ter uma graduação, ter um bom salário, casar e depois pensar em ter filhos(as).

Essas jovens, com quem tive contato ao longo da minha pesquisa, não são incentivadas a dar sequência aos estudos, não têm a perspectiva, nem as chances que eu tive. Elas não construíram sua juventude em torno da possibilidade de ter uma carreira, até porque precisavam, desde jovens, trabalhar muito para se sustentar e ajudar sua família. Muitas dessas jovens entendem a gestação como a possibilidade de se tornarem mulheres perante a comunidade que vivem, de assumirem um papel social, muitas vezes o único papel que elas acham possível assumir. Ainda, às vezes ter um filho dá proteção a estas jovens que vivem em meio a um território vulnerável, com grande presença de tráfico. Então, eu as entendo e respeito suas decisões acima de tudo, pois essas mulheres têm o direito de escolher quando e como gerar uma vida.

E é isso que eu defendo ao longo da tese: que os jovens, mas que principalmente as jovens, tenham seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados. Que todos tenham acesso à saúde sexual e reprodutiva de qualidade e que não sejam desrespeitadas(os) em suas escolhas, sejam elas quais forem. Claro que este é um pensamento que vai contra a maior parte da sociedade atual, que é extremamente conservadora e não acredita na importância da educação sexual. Por isso, também, a importância que eu dou a este trabalho, o qual busca um novo olhar para nossos(as) jovens para que tenham uma juventude diferente da minha, no que tange seus acessos e conhecimentos à saúde sexual e reprodutiva.

Quando me deparei com a literatura para realização da pesquisa sobre jovens e a sexualidade, principalmente de Heilborn (2006) e Reyes e Almontes (2014), comecei a refletir sobre as construções sociais em torno da gravidez na juventude e sobre como a gravidez não deveria ser sempre *a priori* vista como indesejada, precoce e problemática. Fazê-lo dessa forma acarreta na institucionalização da gestação juvenil, como bem aponta Heilborn (2006).

Heilborn (2006) também destaca a construção da noção de que a gravidez na juventude é um problema social, vista como um evento perturbador. Para ela, essa visão ignora a diversidade de circunstâncias e desdobramentos que a maternidade e paternidade juvenil podem trazer. Segundo a autora:

A mobilização em torno da gravidez na adolescência desemboca em diversas formas de institucionalização, isto é, de homogeneização do modo de tratamento do problema. Não se trata de negar que jovens que engravidam antes dos 20 anos suscitem preocupações sobre o desenvolvimento de sua trajetória de vida e da possível consequência desta sobre a vida da criança nascida. Contudo, esse episódio é enquadrado a priori em concepções generalizantes e, sobretudo, antecipadamente dramatizadas (Heilborn, 2006, p. 4)

Reyes e Almontes (2014) indicam que a percepção da gravidez na juventude, como um problema, é justificada por alguns fatores principais: infrequência escolar, riscos de saúde, dificuldades de conseguir emprego e manutenção da pobreza. Porém, os autores demonstram que a maioria dos jovens desistem da escola antes de engravidar, enfrentam condições de saúde impróprias muito antes de ter filhos, já não conseguiam trabalho antes do nascimento da criança e que já estavam na condição de pobreza antes de passarem pela experiência de reprodução sexual.

Em outro estudo, Altmann (2009, p. 178) também traz essa discussão:

Assim, uma gravidez nessa faixa etária parece nunca ser chamada simplesmente de gravidez. Ao contrário, ela é recorrentemente adjetivada de, por exemplo, “na adolescência”, “precocidade”, “indesejada”, “não planejada”, “de risco” ou “inesperada”. Cabe observar que, sendo a idade adulta o período da vida considerado ideal para gerar um filho, não se fala, por exemplo, em gravidez na idade adulta ou “gravidez na adultescência” – expressão que nem mesmo consta nos dicionários. É necessário nomear apenas o que foge à norma.

A literatura aponta para a existência de um momento “normal”, “ideal” ou “padrão” para a reprodução. Isso nos levanta questionamentos acerca da saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens, sendo que ela é taxada, muitas vezes, como sexualidade de risco (Bozon, 2009). A potência de discuti-la se dá pelo fato de que também discutimos normas, valores, saberes, conhecimentos e disciplinas da sexualidade que são resultados culturais e históricos (Bozon, 2004).

A sexualidade não é algo natural, ela é construída socialmente. Segundo Bozon (2009, p. 160):

A vida sexual estaria modelada pelas estruturas objetivas das relações entre os sexos existentes em cada cultura, o sistema de gênero, mas também pelas implementações específicas do sistema – poder, dominação, igualdade operante em uma dupla. Por último, a vida sexual, os lugares e os riscos decorrentes dependem das condições de vida das pessoas.

Nesta tese, como foca-se na sexualidade, é importante discutir mais da sexualidade no contexto destes sujeitos. Sabemos que:

Com frequência a mídia e a opinião pública expressam a ideia de que os jovens no Brasil têm hoje em dia uma tendência aparentemente incontrolável à precocidade sexual, o que acarreta múltiplas consequências negativas. [...] A análise dos dados da

nossa pesquisa conduz a uma hipótese inteiramente diferente: a iniciação sexual não se dá de forma tão precoce e continua a se realizar em um contexto bastante estruturado, por vezes rígido, sobretudo no que diz respeito às relações entre homens e mulheres (Bozon; Heilborn, 2006, p. 155).

Os mesmos discursos negativos acerca da precocidade sexual dos jovens brasileiros também respingam nos discursos sobre a gravidez na juventude. Nesse sentido, Bozon e Rennes (2015), apontam que a sexualidade e a idade se tornaram duas formas de administração contemporânea da população tanto em nível governamental quanto no campo acadêmico.

E aqui entra um ponto dentro dos estudos de Bozon que se considera importante abordar mais: o pânico moral adulto. O pânico moral adulto advém, segundo Bozon (2012), do fato de cada vez mais a socialização dos jovens ser mais horizontal do que vertical, sem um controle tão forte dos pais e/ou responsáveis. Nessa socialização, os jovens não são influenciados apenas pelos pais e por instituições como igreja e escola, mas também por meios de comunicação, pelos seus pares, a internet, as diferentes culturas e experiências pessoais (Bozon, 2012).

A partir dessas considerações, comecei a me perguntar: de que forma as discussões sobre sexo e sexualidade são tratadas com os jovens nas escolas e postos de saúde?; qual o preparo dos agentes de saúde² e a educação em relação à sexualidade e gravidez de jovens?; e que políticas públicas orientam o trabalho dos profissionais de educação e da saúde para falar sobre essas temáticas?

Para responder a estas questões, entendemos que é central olharmos para a saúde sexual e reprodutiva juvenil. Aqui, entendemos que a saúde sexual se refere a:

um estado de bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade, que não é a ausência de doença, disfunção ou incapacidade. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de qualquer coerção, discriminação e violência. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e plenamente exercidos (OMS, 2006, p. 1).

Assim, sublinhamos que a complexidade da sexualidade “envolve dimensões de ordem biológica, social, psicológica, espiritual, religiosa, política, legal, histórica, ética e cultural que evoluem ao longo da vida” (UNESCO, 2018, p. 17, tradução nossa). A falta de saúde sexual pode ocasionar certas dificuldades na manutenção da saúde reprodutiva e vice-versa, visto que ambas estão interligadas. A saúde reprodutiva se refere à possibilidade de reprodução e,

² Ao longo da tese, usaremos a expressão “agente de saúde” diversas vezes para nos referirmos aos(as) profissionais da Unidade de Saúde como um todo - médicos(as), enfermeiros(as), técnicas de enfermagem e ACS - e não só às agentes comunitárias de saúde. As últimas serão referidas como “ACS” e/ou Agente Comunitária.

principalmente, ao direito de decidir ou não gestar, quantas vezes e das formas que desejar, bem como ter acesso aos serviços e às informações corretas para realização do planejamento familiar. Também, cuidados durante a gravidez, parto e puerpério tendo seus direitos garantidos.

A partir daí, entendemos que olhar para a saúde sexual e reprodutiva através das políticas públicas possibilita uma análise para a institucionalização de que Heilborn (2006) fala e dá campo para um olhar mais atento de como se dá a construção social deste fenômeno e como ele se apresenta hoje em nossa sociedade.

Entendemos que as políticas públicas são primordiais para discussões de Ciências Sociais na contemporaneidade (Shore, 2010). Partimos do pressuposto que “a discussão sobre o alcance e os limites das políticas públicas é, na verdade, uma discussão sobre o alcance e os limites das funções desempenhadas pelos burocratas de nível de rua” (Fernandez, Guimarães, 2020, p. 293).

Assim, interessava-me entender como se dava, na prática, o cotidiano das políticas públicas tanto a partir de quem executa quanto a quem se destina. A literatura de Lipsky (1980) e seu conceito de burocratas de nível de rua (BNR) foi a base inicial para estudar a implementação de políticas a partir do cotidiano de agentes, uma vez que os “burocratas de nível de rua fazem a política pública” (Lipsky, 1980, p. 84).

A partir de Lipsky (1980), inúmeros outros trabalhos foram se desenvolvendo no campo da BNR, como veremos em capítulo subsequente. Aqui, focaremos em uma análise a partir da literatura de Maynard-Moody e Musheno (2000, 2012, 2015, 2022) e sua noção de agência, a qual é formada a partir de crenças culturais sobre o que é digno ou não, o que vale a pena ou não, o que é seguro ou não, aquilo que é certo ou errado. Os autores entendem que existem as regras e normas das políticas, mas, para além delas, os(as) profissionais também trabalham a partir de seus valores e suas moralidades, eles(as) têm agência, ou seja, espaço de manobra para atuar a partir de seus julgamentos acerca dos(as) usuários(as).

Para trabalhar a partir dessa perspectiva, buscamos alicerce na *anthropology of policy*. Ela tem como principais expoentes Shore e Wright (1997) e Shore; Wright e Però (2011) e nos traz mecanismos e ferramentas que auxiliam a pensar na complexibilidade do cotidiano das políticas que envolvem a saúde sexual e reprodutiva na juventude no Brasil. Shore e Wright (1997), quando falam em antropologia das políticas públicas, pela primeira vez, apontam que tais pesquisas “revelam como as políticas funcionam como instrumentos de governança, como veículos ideológicos e como agentes de construção de subjetividades e organização de pessoas dentro de sistemas de poder e autoridade” (Shore; Wright, 1997, p. 35, tradução nossa).

Ao falarem em instrumentos de governança, trazemos para a cena o conceito de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012). Aqui, o conceito de governança reprodutiva irá nos ajudar a entender os cotidianos e as expressões da agência dos(as) BNR acerca da saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens. A governança reprodutiva se refere aos

mecanismos pelos quais diferentes configurações históricas de atores, como instituições estatais, religiosas e internacionais financeiras, ONGs e movimentos sociais, usam controles legislativos, incentivos econômicos, injunções morais, coerção direta e incitamentos éticos para produzir, monitorar e controlar comportamentos reprodutivos e práticas populacionais (Morgan; Roberts, 2012, p. 243).

Ginsburg e Rapp (1995), que iniciaram as discussões sobre governança reprodutiva, apontam que ela dá um aporte teórico para entender a regulamentação das opções reprodutivas, comportamentos e identidades disponíveis para mulheres e homens. Morgans e Roberts (2012) se fazem valer da noção de regimes morais para analisar como atores moldam práticas reprodutivas através de legislação, argumentos morais e medidas coercitivas.

Morgan e Roberts (2012, 2019) apontam para estes mecanismos de governança em um nível global, mas vários estudos também destacam a possibilidade de fazer uma análise no nível micro (Duffy et al, 2022; Castro, Savage; 2019; Haaland et al, 2020; Freitas, 2024). Nesse sentido, entendemos aqui que no encontro entre usuários(as) e agentes é possível visualizar micromecanismos de governança reprodutiva, os quais são criados a partir da agência dos(as) profissionais, logo, através de seus valores e moralidades.

Aqui, queremos olhar para a saúde sexual e reprodutiva bem como os agentes trabalham em seus cotidianos estas temáticas, porém o campo de políticas públicas é muito amplo, logo, desde o início, foi necessário delimitar a área de pesquisa. Assim, decidimos focar em educação, especialmente em escolas, e, em saúde, com prioridade na atenção primária.

Focamos em educação devido à escola ser um dos principais – senão o principal – espaço de socialização secundária (Berger; Luckmann, 1985) no qual jovens têm, muitas vezes, os primeiros contatos com as discussões sobre sexualidade. E o foco nas políticas de saúde se dá pelo fato de elas serem centrais e de suma importância quando se trata de saúde sexual e reprodutiva. Mesmo não concordando com a afirmação simplista “de que a gravidez na juventude é um problema de saúde pública”, concordamos que ela é um episódio que merece total atenção em relação à saúde dos sujeitos envolvidos.

Adiante, iremos abordar todo o percurso metodológico da pesquisa, mas de início já vale destacar que ela foi realizada num bairro de periferia de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde foram entrevistados(as) vinte e um(a) jovens, quatorze profissionais de uma Unidade

de Saúde (US) e quatro professores de Biologia de duas escolas (aqui identificadas como escola A e escola B). Além das entrevistas, a antropologia das políticas públicas nos foi central, pois utilizamos da observação de cunho etnográfico da US e das escolas, bem como na realização de rodas de conversa com turmas, tanto da escola A, quanto da escola B.

Investigou-se como os agentes de saúde e da educação abordam a saúde sexual e reprodutiva dos jovens em seus trabalhos. Tem-se como objetivo geral da pesquisa identificar e analisar quais são os micromecanismos de governança reprodutiva que os(as) agentes de saúde e educação fazem uso para abordar a SSR com os(as) jovens porto-alegrenses residentes em uma periferia.

Justificamos a escolha deste tema e deste objetivo, para além do fato do meu interesse pelo tema e do que já discutimos aqui, devido à lacuna teórica que visualizamos em torno de estudos que abordem a saúde sexual e reprodutiva juvenil em uma perspectiva de um olhar tanto para agentes de saúde, quanto de educação e para os(as) jovens. Ainda, como veremos no capítulo de revisão narrativa da literatura, são poucos os estudos que trabalham esta temática a partir do campo de pesquisas das políticas públicas, focando na implementação e na agência (Maynard-Moody; Musheno, 2022).

Assim, vemos aqui uma oportunidade de discutir como a agência dos(as) profissionais é percebida nos seus cotidianos de atuação, no que se refere à SSR juvenil, e traçar este olhar a partir da noção de mecanismos de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012), algo que nunca antes foi feito. Aqui, buscamos preencher a lacuna teórica que explica o cotidiano de atuação dos(as) profissionais de saúde e da educação a partir de cinco micromecanismos: contenção reprodutiva, coerção contraceptiva, vigilância reprodutiva, omissão da sexualidade e acumulação reprodutiva feminina.

Na sequência, para entendermos melhor como se deu a construção deste objetivo geral e dos objetivos específicos, iremos aprofundar a discussão teórica sobre burocracia de nível de rua, a agência dos burocratas (Maynard-Moody; Musheno, 2022) e a governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012) até chegarmos na noção de micromecanismos que aqui criei para analisarmos o cotidiano da implementação da política pública.

Depois, falaremos sobre os percursos metodológicos da pesquisa para, então, discutir o território da pesquisa, o qual entendemos que é central na análise aqui desenvolvida. Por fim, partiremos para a análise das políticas no cotidiano dos(as) agentes e traremos capítulos abordando como se dá na prática os cuidados em relação à saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens nas escolas e na unidade de saúde.

2. IMPLEMENTAÇÃO, ANTROPOLOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA REPRODUTIVA

Iniciaremos as discussões da base teórica sobre o campo de políticas públicas e implementação destas políticas com auxílio da antropologia para, depois, podermos falar de governança reprodutiva. Estas são as bases que nos ajudarão a compreender mais do cotidiano dos(as) profissionais das escolas e da unidade de saúde, bem como das formas com que eles lidam com a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens. Ademais, nos ajudarão a entender o dia a dia dos(as) jovens no que tange o acesso ao serviço de saúde, à escola e às relações estabelecidas com os fazedores de política.

Aqui, conceitos como burocracia de nível de rua e agência são aportes importantes para entendermos em que local no campo de políticas públicas situamos a implementação. Para além destes conceitos, temos como fio condutor do estudo as discussões sobre governança reprodutiva, regimes morais e pânico moral, que nos ajudarão a entender especificamente como se dá - ou não - a implementação de políticas juvenis ligadas à saúde sexual e reprodutiva, como veremos a seguir.

2.1 AQUELES E AQUELAS QUE FAZEM A POLÍTICA

No campo das políticas públicas existem inúmeras definições do que é uma política pública e do que mobiliza essas políticas, uma delas demonstra que ela é tudo o que o governo escolhe ou não fazer (Dye, 2010); um conjunto de atividade dos governos que influencia no cotidiano dos cidadãos (Peters, 1986; Tronco, 2018); ou uma forma de cuidar daquilo que é público (Schmidt, 2018). Todas estas definições nos ajudam a pensar a política pública como é a forma do governo buscar melhorias para a vida de uma população através de leis, decretos, normativas, entre outros.

Aqui, entendemos que as políticas públicas são um instrumento para analisar como o governo e as formas de governança funcionam. Nesse sentido, Shore e Wright (1997), Lander (2022), Shore e Wright (2011) e Shore (2011), estudiosos da antropologia das políticas públicas nos sinalizam que as políticas são muito mais do que documentos contendo regras e diretrizes. Elas acontecem na relação entre agente e usuário(a) e estão embrenhadas de valores, normas e moralidades destes sujeitos.

Logo, as políticas são expressão do nosso mundo, reflexo dos nossos modos de vida. E ao mesmo tempo que são reflexos, elas também moldam, restringem e administram comportamentos. É uma via de mão dupla onde as políticas são modelos de organização social por vezes impostos, mas por vezes construídos coletivamente com a população.

Assim, a antropologia das políticas públicas aponta para a centralidade do(a) agente em contato direto com o usuário: “De uma perspectiva antropológica, o que acontece na sala de reuniões do conselho executivo, na reunião do gabinete ou na assembleia geral anual dos acionistas não é menos importante do que o que acontece ao nível do chão de fábrica ou da localidade” (Wedel et al, 2005, p. 34, tradução nossa).

O campo de políticas públicas aponta para Pressman e Wildavsky (1973) como importantes autores nos estudos de implementação e também outros como Martha Derthick (1972) e Eugene Bardach (1977). Nesse contexto surge a linha de estudos *bottom-up* que é a base inicial em que se funda a presente tese. Importam aqui os trabalhos seminais de Lipsky (1980), Benny Hjern (1982) e Hjern e Hull (1983) e a ideia dos *street level bureaucrats* como ponto central para a análise da implementação, em divergência com os *top-downers*.

Lipsky (1980) lança o termo burocracia de nível de rua (BNR) para nomear aqueles(as) que trabalham “cara a cara” com as pessoas usuárias da política. É a partir de seu trabalho que os estudos sobre implementação ganham uma nova toada ao destacar que os(as) “burocratas de nível de rua fazem a política pública” (Lipsky, 1980, p. 84).

Diversos autores, apoiados em Lipsky (1980), estudam a burocracia de nível de rua (Lotta, 2010, 2022, 2015; Pires; Lotta; Junior, 2018; Assis, 2023; Fernandez; Guimarães, 2020; Oliveira, 2012, Ferreira; Medeiros, 2016; Bonelli et al, 2019, Lotta; Pires, 2020) e a discricionariedade, ou seja, as ações que os(as) agentes tomam para além daquilo que está escrito na norma/protocolo, sendo um fator central para analisar a implementação das políticas públicas.

Neste sentido, os BNR “também têm o poder de implementar as políticas públicas de forma própria, uma vez que há uma série de brechas nessas estruturas que lhes possibilitam agir com substancial grau de discricionariedade.” (Fernandez; Guimarães, 2020, p. 299). E é isso que queremos ver neste estudo: os espaços de atuação dos(as) agentes para além da política pública escrita. Ou seja, o professor de Biologia conversa sobre uso de camisinha, por exemplo, com suas turmas para além daquilo que está definido na Base Nacional Comum Curricular? Se sim, como são essas conversas? Por que elas ocorrem?

No campo das políticas públicas, existem múltiplas formas de interpretar os cotidianos de trabalho dos BNR e o que influenciam suas atuações. Aqui, partimos de Maynard-Moody e

Musheno (2000, 2012, 2015, 2003, 2022), os quais desenvolveram uma análise acerca das percepções dos(as) agentes de nível de rua analisando suas narrativas. Apesar de aqui não focarmos nas narrativas que os(as) agentes têm de si, Maynard-Moody e Musheno (2022) nos ajudam a pensar no cotidiano da política para além das leis e diretrizes, focando na relação agente e cidadão, e dando destaque aos valores morais que cercam a atuação dos(as) agentes e que influenciam na implementação das políticas públicas.

Os autores desenvolveram, baseado em Lipsky (1980), o conceito de agência. Para Maynard-Moody e Musheno (2012, p. 3, tradução nossa) a agência é “uma construção que utilizamos para descrever os trabalhadores como centrados no Estado e na cultura, ao fazerem os seus julgamentos.” Ou seja, sim, os(as) profissionais da linha de frente atuam a partir dos protocolos, normas e diretrizes de seu trabalho, mas também a partir de suas percepções acerca do que é “certo” e “errado”, “justo” e “injusto”. Assim, Maynard-Moody e Musheno (2012, 2022) destacam que a agência é formada a partir de crenças culturais sobre o que é digno ou não, o que vale a pena ou não, o que é seguro ou não, aquilo que é certo ou errado. Ainda, agentes podem ter predisposições sobre as pessoas e sobre aquilo que eles consideram um problema ou não.

Logo, a agência é algo profundamente social. Ela mostra tanto os padrões quanto a imprevisibilidade dos encontros na “linha de frente”. A agência se dá nos microencontros – e desencontros – entre agentes e usuários(as) onde os(as) primeiros(as) agem a partir das normas, mas também levando em conta suas visões pessoais, valores morais e categorizações que fazem dos(as) usuários(as) antes, durante e após seus encontros. Aqui, iremos olhar para a agência dos BNR no que tange a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens e entender que julgamentos os(as) agentes tomam e como isso se reflete nas relações que estabelecem e no cotidiano da política.

Sendo assim, no cotidiano dos(as) agentes, a relação que os(as) agentes estabelecem com os(as) usuários(as) das políticas nos é primordial. O mesmo acontece a partir da antropologia das políticas públicas, onde Shore e Wright (1997, 2011) apontam para a centralidade das pessoas beneficiárias das políticas e como elas podem influenciar no resultado das mesmas, sendo central acompanhar estes encontros para entender a política.

Assim, apontamos para uma relação complexa entre agentes e usuários(as). Diversos outros estudos do campo de públicas também falam sobre essa relação – que é de poder e, por vezes, conflituosa – e sua centralidade para a implementação das políticas públicas ao olharem para a discricionariedade dos(as) agentes (Bartels, 2014, 2013; Lotta; Costa, 2020; Raaphorst; Loyens, 2018; Follet, 2013; Oldenhof; Linthorst, 2022; Raaphorst, 2018; Lotta, 2010; Bonelli;

Fernandes; Coêlho; Palmeiras, 2019; Bruhn; Ekström, 2017; Bronzo; Costas; Guimarães, 2022; Lotta; Pires, 2020). Aqui, o trabalho de nível de rua não é insociável, mas pessoal e aproximado.

Como Bartels (2014) indica, o processo e o resultado das decisões dos(as) agentes dependem da interação entre estes(as) e os cidadãos. Bruhn e Ekström (2017) destacam que as ações de agentes deveriam ser vistas como “*interactional achievements*” (p. 199), pois sempre dependem das relações que se estabelecem. Visto que a atuação dos(as) BNR depende de suas percepções das interações com os cidadãos, Raaphost (2018) se refere ao processo de implementação de políticas como sendo cada vez mais incerto.

Estudiosos da antropologia das políticas públicas seguem na mesma linha de raciocínio trazendo a importância das categorias que agentes usam (Barberri, 2022), olhando para a autonomia e a margem de ação dos(as) agentes (Mello, 2022), analisando práticas e sentidos de seus trabalhos (Ciordia, 2022) e compreendendo como funcionam códigos, regras e símbolos que estes(as) utilizam (Brunello, 2018). Logo, o que os agentes fazem no cotidiano é a política pública.

Shore e Wright (1997, 2011) também destacam a centralidade das pessoas beneficiárias das políticas e como elas podem influenciar nas mesmas. Wendel et al (2005) destacam que a antropologia das políticas públicas busca analisar como os(as) *policy makers* se relacionam com a população local e, ao mesmo tempo, com a ajuda da etnografia, entender como as políticas de estado são experienciadas pelas pessoas da comunidade.

Então, também a partir da antropologia das políticas, entendemos a necessidade de ouvir os sujeitos que são afetados (ou deveriam ser) pela política em seus cotidianos. Até porque estes sujeitos também fazem a política no seu contato com os(as) agentes. Assim, aqui, realizamos rodas de conversa e entrevistas com jovens porto-alegrenses acerca de seus acessos à saúde sexual e reprodutiva, tanto na escola como na unidade de saúde. As histórias que colhemos falam, em sua maioria, de jovens com poucas discussões sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas, em uma relação desconfortável para conversar com algum(a) professor(a) sobre as temáticas. Ainda, acessando pouco a unidade de saúde, rindo e ironizando a possibilidade de algum dia alguém lhes atender no local caso pedissem por uma conversa sobre saúde sexual.

Entendemos que a implementação de políticas tem como personagem central o(a) agente de nível de rua em relação ao(à) usuário(a). E que este(a) trabalha para além das normas e diretrizes colocadas pela instituição, fazendo valer suas crenças e seus valores através da agência (Maynard-Moody e Musheno, 2012, 2022) ou discricionariedade (Lipsky, 1980; Lotta; Costa, 2020; Lotta; Santiago, 2017; Pires, 2009), onde os(as) trabalhadores têm espaço de manobra para tomada de decisão, dentro de certos limites das leis. Nessas estratégias, as ações

dos agentes são mediadas por seus sistemas de crenças, valores e pelas categorizações que atribuem aos indivíduos. Tal dinâmica é potencializada pelas interações estabelecidas com os cidadãos, caracterizadas, majoritariamente, por uma lógica verticalizada e assimétrica.

Aqui, ao olharmos para os(as) agentes de nível de rua, estamos observando o cotidiano da política pública acontecendo nos encontros e desencontros entre agentes e usuários(as). Mas, para entender como se dá essa política na prática, queremos conhecer mais os mecanismos que levam os(as) agentes a tomar suas atitudes, pois sabemos que eles(as) não seguem única e fielmente os protocolos com os quais trabalham. Por isso, agora entraremos na discussão central e fio condutor deste estudo: governança reprodutiva.

2.2 GOVERNANÇA REPRODUTIVA

A governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012) é um conceito que ajuda a entender a atuação de profissionais no que concerne justamente à saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens, porém, antes de adentrarmos na governança reprodutiva, é necessário pensarmos o que é governança em primeiro lugar. A discussão sobre governança já vem angariando espaço nos estudos de políticas públicas nas últimas décadas, sendo um termo popularizado, com uma ampla gama de significados que, por vezes, acabam o tornando multifacetado, vago e de difícil compreensão, tendendo para diferentes esferas e arranjos conceituais e tendendo a uma definição *a priori* quase impossível (Ezzemel; Reed, 2008; Hupe; Pollitt, 2011; Schabbach, 2022; Rose-Ackerman, 2017; Ivo, 2016; Franco, 2016). Governança pública, governança territorial, governança global, governança corporativa, governança participativa, governança eletrônica, governança orçamentária e governança regulatória são apenas alguns dos exemplos de múltiplos usos e sentidos que o termo governança vem tomando.

Tate (2020) aponta que as políticas acontecem nas relações que se estabelecem entre agentes e usuários(as) e nos processos de governança. Entendemos que a governança se dá na relação dos(as) agentes com usuários(as), e que a política pública é o que os agentes fazem, ou não, no seu cotidiano.

Por ser um termo polissêmico, dentro dos estudos de governança pública, há diferentes perspectivas para abordá-lo. Um meio é focar principalmente nas relações entre atores interconectados (governamentais e não governamentais) por instituições formais e informais (Capano; Howlett; Ramesh, 2015; Cavalcante, 2018; World Bank 2018), buscando um nível

horizontal no processo de elaboração das políticas públicas (Secchi, 2019) e tentando resolver problemas sociais (Kooiman, 2003).

Partimos de uma perspectiva mais legalista da governança e entendemos que se refere às leis, normas e regras, mas sem deixar de lado “as práticas que restringem, prescrevem e habilitam a atividade de governo.” (Lynn; Heinrich; Hill, 2000, p. 235) A governança se refere a “mandatos políticos; estruturas organizacionais, financeiras e programáticas; níveis de recursos; regras administrativas e diretrizes; normas e regras institucionalizadas que restringem e habilitam as tarefas, prioridades e valores que são incorporados nos processos regulamentares, de produção e entrega de serviços.”(Lynn; Heinrich; Hill, 2000, p. 235).

A governança dá conta das estruturas formais como estatutos e protocolos, e também do que Lynn, Heinrich e Hill (1999) chamam de exercício informal de julgamento dos(as) atores e atrizes envolvidos na implementação de políticas. Assim, aqui, quando falamos em implementação de políticas públicas, a governança se dá no cotidiano dos(as) agentes de nível de rua não só quando estes trabalham com os protocolos, mas também com suas prioridades e valores que podem mudar (ou não) o “caminho da norma” da política pública. Há o protocolo, mas há um(a) agente que deve executá-lo, e nem sempre vai haver concordância entre a lei escrita, a realidade social e aquilo que o(a) agente considera justo, certo e o melhor para aquela situação. Daí que podemos ver os mecanismos que estes(as) agentes utilizam.

No íterim de entender a governança, Crouch (2005, p. 20, tradução nossa) define a mesma como “aqueles mecanismos pelos quais as regularidades comportamentais que constituem as instituições são mantidas e aplicadas.” Ao falar de comportamento, ele está falando de valores e normas que regulam a atuação dos(as) agentes de políticas públicas. Os mecanismos de governança são diversos e de vários tipos, dependendo do encontro entre os(as) agentes e as regras que eles(as) devem seguir, segundo Crouch (2005).

Acrescentaríamos ainda nesta equação a relação entre agente e usuário(a) da política pública como um fator crucial na escolha dos mecanismos. A literatura conceitua essa relação entre usuário e agente como **burocracia de nível de rua**. Segundo Lotta (2015), os agentes operam a partir da criação de categorias para os usuários, enquanto Maynard-Moody e Musheno (2022) ressaltam que a análise da identidade do cidadão precede a conduta do burocrata. Nesse sentido, Samanta e Hand (2022) enfatizam a relevância do *in between* - o espaço da interação direta - como o fator determinante para o resultado final da política pública.

Para Crouch (2005) os mecanismos de governança são os meios pelos quais o cotidiano de atuação das instituições é preservado. Este autor aponta que os mecanismos de governança podem ser de nove tipos: exógenos ou endógenos; formais ou informais; substanciais ou

procedimentais; de sinalização ou de diálogo; vertical ou horizontal; aplicação forte ou aplicação fraca; de alcance extensivo ou limitado; de saída difícil ou de saída fácil; e de bens públicos ou privados.

Analisaremos os mecanismos de agentes das escolas e unidade de saúde adiante, a partir da classificação de Crouch (2005), mas já destacamos que estes são endógenos - advindo de dentro das instituições a partir da ação de agentes -, verticais - se refere à comunicação vertical onde há um centro de autoridade (agente) - e informais - esses mecanismos não estão em normas ou protocolos, mas nos valores, moralidades e concepções dos(as) agentes.

Existem diferentes níveis de governança, desde a global até o nível local (que se refere normalmente aos municípios). Dentre estes diferentes graus, Lynn, Heinrich, Hill (2000), apontam para o nível técnico, o qual se preocupa com a governança no “*primary work level*”. Esta se refere aos efeitos e resultados das ações e julgamento dos trabalhadores de primeiro nível, no nosso caso, os(as) agentes de escolas e unidades de saúde.

Lynn, Heinrich e Hill (2000) fazem uma aproximação com o campo da burocracia de nível de rua quando apontam que o trabalho destes(as) agentes envolve discricionariedade e citam Lipsky (1980). Nesse sentido, Maynard-Moody e Musheno (2022, p. 196, tradução nossa) também falam que olhar para o trabalho dos(as) agentes é um processo de “exploração da governança de linha de frente”.

Associando a noção de governança no nível técnico de Lynn, Heinrich e Hill (2000, 1999), com a ideia de mecanismos de governança (Crouch, 2005), entendemos que existem diferentes tipos de mecanismos no cotidiano de atuação de agentes de nível de rua, e que são através desses mecanismos que conseguimos ver a agência: “a capacidade humana de formar julgamentos, tomar ações e assumir responsabilidades.” (Maynard-Moody; Musheno, 2022, p. 175-176, tradução nossa). Os próprios autores argumentam que existe governança na linha de frente, ou seja, no cotidiano de agentes.

Por isso que a noção de mecanismos de governança nos é tão cara. Eles nos revelam o cotidiano da política pública. São através de mecanismos de governança que conseguimos ver os valores, preceitos éticos e moralidades que circundam os(as) agentes. No nosso caso, ao olharmos para saúde sexual, reprodutiva e para agentes de escolas e unidades de saúde, o conceito de governança reprodutiva nos parece adequado.

Foram Ginsburg e Rapp (1995) as primeiras a falar sobre governança reprodutiva, apontando para o fato de ela nos dar um *framework* teórico analítico para entender as regulações acerca das opções reprodutivas, comportamentos e identidades que homens e mulheres devem

seguir. Morgan e Roberts (2012) partem de Ginsburg e Rapp (1995) e da noção de governança de Foucault (1991). Ele diferencia a governança entre poder soberano ou força explícita e governança, por meio do biopoder, onde os sujeitos passam a se governar em níveis corporais íntimos (Foucault, 1991).

Para Foucault (1991), a governança se dá através das relações de poder e conhecimento. Neste caso, o poder seria aquele advindo do governo, de suas instituições e, no nível micro, dos(as) agentes que executam as políticas. Já o conhecimento advém das formas com que a governança de populações pode ser feita, novamente no nível micro pelos(as) agentes, ou seja, quais mecanismos serão utilizados para além do poder da lei, norma e protocolo.

Nesta linha, Carruthers (2023) aponta que a governança reprodutiva descreve o entrelaçamento entre o campo legislativo e o de normas sociais, os quais têm grande influência nos indivíduos. Neste caso, vários atores moldam práticas reprodutivas através da legislação, da moral e dos argumentos coercitivos (Hemer, 2019). Assim, estamos tratando de configurações históricas e sociopolíticas (Brandão, 2023), que influenciam na criação, utilização e manutenção dos mecanismos de governança reprodutiva.

Trazemos a análise dos mecanismos de governança reprodutiva para o nível micro de trabalho de burocratas de nível de rua (Lipsky, 1980), aqueles que estão no contato direto com usuários(as) da política, ou, como destaca Lynn, Heinrich e Hill (2000), no *primary work level*. No nosso caso, não temos presença de incentivos econômicos no cotidiano de trabalho dos(as) agentes, como veremos adiante, mas sim os demais citados por elas como injunções morais, coerção e estímulos éticos.

Aqui, entendemos que “O conceito de governança reprodutiva direciona nossa atenção para como a reprodução é mobilizada e ativada em momentos históricos específicos.” (Morgan, 2019, p. 113, tradução nossa). Acreditamos que agora estamos vivendo um destes momentos a nível internacional e nacional com a ascensão da extrema direita e, principalmente no Brasil, o crescimento da bancada evangélica e de discursos religiosos em um Estado laico. Morgan (2019) aponta ela mesma para a religião como uma das fronteiras da governança reprodutiva.

O conceito de governança reprodutiva possibilita também observar um nível global (Morgan; Roberts, 2012; Morgan, 2019), porém iremos focar no nível local devido ao interesse em aprofundar nosso olhar para as narrativas dos(as) agentes de um bairro específico de Porto Alegre.

Olhar para o nível local, por suposto, não significa que não serão feitas associações com políticas a nível nacional, principalmente. Até porque muitas delas ditam aquilo que os(as)

agentes devem fazer em seu cotidiano, como o exemplo da Base Nacional Comum Curricular e das diretrizes do Programa Saúde na Escola.

Apesar de Morgan e Roberts (2012) e Morgan (2019) não cunharem o termo governança reprodutiva pensando em um nível de relação entre agente da linha de frente e usuários(as) das políticas, as autoras destacam como a governança reprodutiva possibilita traçar como diferentes atores institucionais modelam o comportamento das populações. Morgan (2019) aponta que a organização e as práticas dos sistemas de saúde são tecnologias centrais da governança reprodutiva. Apesar de não discutir especificamente sobre escolas, aqui empregamos o conceito, para além dos(as) agentes da unidade de saúde como médicos(as) e enfermeiros(as), e nos defrontamos com professores(as) e como as ações destes(as) pode revelar mecanismos de governança reprodutiva.

Kotni e Signer (2019, p. 119, tradução nossa) destacam que: “A governança reprodutiva é promulgada ‘de cima’ - entregue na forma de leis e políticas, decretos religiosos e programas estaduais -, e também está envolvida em cuidados clínicos, discurso público e mensagens da mídia”. Então, temos algo superior aos(as) agentes de nível de rua no que tange às leis e aos regulamentos que regem seus trabalhos, mas eles(as) também têm agência, como já vimos com Maynard-Moody e Musheno (2022) e têm o poder de tomar ações a partir de seus julgamentos, noções e valores. É neste momento que entram os mecanismos de governança reprodutiva no nível micro.

Estudos que abordam a governança reprodutiva, no nível local, estudam primariamente as relações que se estabelecem entre profissionais e usuários a partir do “fluxo de informações”. Ocorre também discussões sobre tipologias de violências que profissionais da saúde usam, no cotidiano, com jovens que sofreram violência obstétrica, bem como discussões sobre o distanciamento dos profissionais das leis que oficialmente baseiam os seus trabalhos para dar lugar aos micromecanismos (Duffy et al., 2022; Castro; Savage, 2019; Haaland et al., 2020; Freitas, 2024).

Aqui, vamos além no sentido de destacar que os(as) agentes não seguem apenas o que restritamente consta nos protocolos, mas eles(as) têm a agência. Logo, podem abrir mão de mecanismos de governança para atuar além daquilo que está contidos nos protocolos e regimentos e para além da estrutura de trabalho (no nosso caso, da unidade de saúde e da escola). Nesse sentido, poderíamos pensar sim nos micromecanismos de governança reprodutiva a partir da prática de agentes de nível de rua.

Podemos ver que todos os estudos até então citados, trabalham os mecanismos de governança reprodutiva em contextos de saúde relacionados às unidades de saúde e/ou aos hospitais. Aqui, temos um novo desafio de abordar a governança reprodutiva a partir de escolas e da atuação de professores(as).

Como bem já destacava Briggs (2017), toda política é reprodutiva, ou seja, mesmo aquelas que não aparentam, estreitamente, relacionadas à reprodução têm impactos significativos sobre as decisões reprodutivas e as experiências de cuidado e parentalidade. Aqui, fica ainda mais claro, nas políticas, que olharemos acerca da saúde sexual e reprodutiva.

Nesse sentido, nos é central a noção de regimes morais. Morgan e Roberts (2012, p. 242, tradução nossa) destacam que “Regimes morais referem-se aos padrões privilegiados de moralidade que são usados para governar comportamentos íntimos, julgamentos éticos e suas manifestações públicas.”

Fonseca, Marre e Rifiotis (2021) apontam que regimes morais, a partir de lógicas globais, respingam nas estratégias nacionais de intervenção e buscam padronizar as práticas de reprodução, as relações de gênero e os comportamentos sexuais e estão no centro das questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, na América Latina (Silva, 2023). Aqui, atentaremos àquilo que é moralmente aceito ou que é “imoral” para os(as) agentes, bem como isso influencia no cotidiano destes.

No caso de nossa pesquisa, tanto em escola quanto em unidade de saúde, as moralidades em torno dos jovens perpassam as falas dos(as) agentes: “Hoje em dia começam a ter relações muito cedo.” “As meninas não se cuidam e depois aparecem grávidas.” Ou como um professor disse para as alunas: “Meninas, vocês não podem sair transando por aí com todo mundo.”

Também podemos associar a ideia de regimes morais à noção de pânico moral de Bozon (2012):

Paradoxalmente, o surgimento de uma autonomia privada da adolescência e da juventude veio de encontro com uma explosão de inquietações adultas. Este alarmismo sexual, que frisa o pânico moral em relação à jovem, é um dos contra-ataques do fim do controle direto dos adultos (Bozon, 2012, p. 121, tradução nossa).

Quando o autor fala sobre o pânico moral adulto acerca da juventude, isso se adequa principalmente às questões relacionadas à sexualidade. Como Bozon (2014) mesmo disse, a sexualidade juvenil é considerada como sexualidade de risco. São múltiplos os valores morais em torno do que a juventude deve ou não fazer; logo, diversos regimes morais perpassam a visão dos(as) agentes que atuam no cotidiano com os(as) jovens, como buscaremos aqui demonstrar.

O pânico moral sempre esteve presente nos ambientes da escola e da unidade de saúde quando se trata da sexualidade juvenil e, principalmente, da gravidez: “Esses jovens não sabem se cuidar.” “Toda hora tem alguma jovem grávida.” “Não poderiam sair assim tão novos já se relacionando.”

Nesse sentido, Fassin (2009) traz a ideia de uma “economia moral” em torno da família e da reprodução e, no nosso caso, também acrescentaria, dos jovens. Esta economia aponta para valores, normas, padrões e definições daquilo que é “ideal”, “certo” ou “normal”. Uma economia moral totalmente centrada na mulher e na figura de mãe. Nossa pesquisa revela como as falas dos(as) agentes sempre destacam a mãe em primeiro lugar, na criação dos(as) filhos(as), assim como as jovens, quando questionamos sobre responsabilidades com crianças sempre falam: “Óbvio que a responsabilidade maior é da mãe, né, sora. Deveria ser meio a meio, mas não é.”

Além dos regimes morais, outro ponto que aqui nos interessa é o de reprodução estratificada, desenvolvida por Colen (1995). Brandão e Cabral (2021, p. 52) apontam que esta noção se refere ao:

acesso desigual e estratificado a condições sociais estruturais para se reproduzir, elas destacam as intrincadas relações entre movimentos mais amplos, em nível global, que rearticulam interesses financeiros, hegemonias políticas, imperialismos coloniais, ativismos sociais e tecnologias biomédicas na direção de um bem-estar global que se consubstanciam de modo difuso, intersticial em práticas políticas locais, as quais consolidam “regimes morais de reprodução”.

Morgan (2019) aponta que a reprodução estratificada destaca que certos grupos de pessoas são encorajadas a reproduzir, enquanto outros ocorre o oposto e ainda são estigmatizados e punidos. Entendemos que essa diferenciação tem relação com gênero, raça e classe social, dentre outros.

Veremos, no caso deste estudo, que idade é um fator, mas as condições econômicas das jovens são mais ainda. Jovens de forma alguma são incentivadas a gestar, seja por médicos(as), agentes de saúde, enfermeiros(as), técnicas de enfermagem ou professores(as), mas caso aconteça estes(as) referem que a jovem com “família mais estruturada” consegue ter uma gestação “mais tranquila”.

Ou seja, existem mulheres que estariam “bem preparadas” para serem mães e outras não. Nesse sentido, mais um conceito que se formula, tendo como base moralidades e que soma ao de reprodução estratificada, é o da parentalidade. Esta se refere às disputas sobre as “boas práticas” que pais, mães e/ou responsáveis devem ter no cuidado e desenvolvimento de uma criança, mas que principalmente recaem sobre a mãe. Hoje percebemos uma:

ampliação do discurso público sobre a “parentalidade” e interpelam os poderes públicos quanto à gestão que estes devem fazer da questão familiar, cada vez mais centrada na questão parental. Mais do que nunca, é possível observar, parafraseando Oullette e Goubau (2009), uma penetração até então inédita dos poderes públicos nas dinâmicas de parentalidade (Rinaldi; Rifiotis; Marre, p. 4, 2025).

Nesse sentido, os julgamentos sobre ser uma “boa mãe” ou “bom pai” passam a ser exercidos por implementadores(as) de políticas públicas. E essa é a questão central para nós aqui ao olharmos para as percepções que os(as) profissionais de saúde e de educação têm sobre os(as) jovens, principalmente as primeiras, e como isso influencia em seus discursos acerca da reprodução e em seus contatos no dia a dia com elas. Para a grande maioria dos(as) funcionários(as), uma jovem não é capaz de exercer uma parentalidade positiva, a qual se refere a cuidar das crianças de uma certa forma com educação de qualidade, com tempo livre para desenvolver atividades em conjunto, na alimentação saudável, na moradia segura e até no apoio psicológico; pontos que têm estreita relação com a noção de camadas médias e altas do que seria uma “boa mãe” e um padrão ideal para a criança baseado na moralidade.

O cuidado da criança é individualizado e centrado na figura da mãe que é categorizada e estigmatizada. As categorias colocadas, principalmente, sobre as mães jovens como, por exemplo “descuidada”, “nova demais” e “incapaz” acabam por individualizar, patologizar e despolitizar a reprodução e cuidado com a criança, colocando no centro a mulher, individualmente, e não as políticas públicas como aquilo que é necessário para garantir que as crianças cresçam com acesso a todos os seus direitos básicos. Ou seja, hoje em dia existe muito mais a presença de políticas de família do que políticas públicas para o cuidado desta família, para melhorar as condições de moradia, alimentação, estudo e saúde das(os) jovens para que elas(es) possam ter a escolha de gestar de forma segura e garantir qualidade de vida para seus filhos. Na realidade, o que vemos é uma parentalização das políticas sociais.

Ao longo desta tese observamos a centralidade que as jovens ocupam e como elas se tornam responsáveis pela gestação e pelo “bom” ou “mau” cuidado da criança, por uma família “organizada” e/ou “estruturada”, falas de professores(as), médicos(as), enfermeiros(as), técnicas de enfermagem e agentes comunitárias de saúde, acionadas a partir de sua agência (Maynard-Moody; Musheno, 2022).

Pensando na noção de parentalidade, outro ponto que Morgan e Roberts (2012) abordam e que aqui nos interessa é a emergência contraceptiva e a modernização dos métodos contraceptivos, e como isso a interferência na governança reprodutiva, tanto como forma de maior liberdade para mulheres, como de controle populacional. As autoras analisam

criticamente as dinâmicas de poder por detrás das políticas de contracepção, apontando como elas afetam desproporcionalmente as mulheres em situações de vulnerabilidade social e econômica.

Nos últimos anos, é o conceito de coerção contraceptiva que tem ganhado mais força e nos é interessante para pensar na governança reprodutiva, conceito cunhado por Senderowicz (2019). Ela aponta que a coerção contraceptiva se manifesta tanto através de forças estruturais quanto de ações individuais:

Terceiro, a coerção contraceptiva, na medida em que foi teorizada, é historicamente concebida como um fenômeno unidirecional no qual as mulheres são forçadas a adotar um método que não desejam - o que chamo de "coerção ascendente". No entanto, a coerção contraceptiva também pode viajar na outra direção: as mulheres podem ser impedidas de acessar ou usar um método contraceptivo que desejam, o que chamo de "coerção descendente" (Senderowicz, 2019, p. 3).

Brandão e Cabral (2021) utilizam deste conceito ao olharem para documentos legais que, segundo elas, apontam para uma redução significativa da atenção à saúde reprodutiva das mulheres. Nesse sentido, elas concluem que há uma: “sujeição sistemática de mulheres jovens, negras, pobres, em situação de exclusão social a mecanismos de tutela do aparato estatal, de cariz racista e eugênico, que acirram a desigualdade social e infringem de maneira inadmissível e violenta a dignidade e integridade corporal dessas mulheres.” (Brandão, Cabral, 2021, p. 63).

Na tese, atentamos para os momentos em que as discussões sobre contracepção aparecem nas narrativas de médicos(as), enfermeiros(as), ACSs, técnicos em enfermagem e professores(as) buscando entender se a contracepção é discutida no ambiente escolar e de que forma é ofertado ou não às mulheres ao acessarem o serviço único de saúde. Ademais, observamos se a questão da contracepção é discutida com os jovens homens.

Dito isso, entendemos que a política pública ocorre no cotidiano dos encontros entre agentes e usuários(as), no nosso caso, jovens, e nas decisões que são tomadas pelos(as) agentes antes do contato, durante e após o mesmo. São nesses encontros (e desencontros) que se faz a política e “se governa”. Os micromecanismos de governança se concentram nesses microencontros que podem ser mais aproximados ou não daquilo que as normas e diretrizes da política se referem.

Ao partirmos da noção de micromecanismos de governança reprodutiva, e através das vivências de profissionais de saúde e de educação e dos(as) jovens da comunidade, criamos quatro micromecanismos que discutiremos ao longo da tese, com maior profundidade teórica, explicando como chegamos a eles. Estes micromecanismos são de contenção reprodutiva, de coerção contraceptiva, de acumulação reprodutiva feminina e de vigilância reprodutiva.

Ademais, trazemos o micromecanismo de omissão da sexualidade, este não sendo ligado à noção de governança reprodutiva, que tem sido um fator relevante para a interpretação dos dados do campo.

Os micromecanismos de contenção reprodutiva se referem às formas com que os(as) agentes de saúde e de educação buscam coibir as jovens e os jovens - majoritariamente as primeiras - a gestar e reforçam discursos acerca das dificuldades e dos problemas que a gravidez ocasiona, segundo as percepções dos(as) agentes. Já os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina se referem à ação dos(as) profissionais que reforçam a centralidade feminina e a inércia dos homens em suas responsabilidades antes da gestação, durante e após, com o cuidado da criança. Por sua vez, os micromecanismos de vigilância reprodutiva se referem às formas que os(as) agentes de saúde encontram para buscar controlar e vigiar a gestação das jovens e os primeiros meses após o nascimento da criança. Este é o único micromecanismo que vemos apenas na US, pois nas escolas as jovens não são acompanhadas com maior atenção em sua gestação, muito pelo contrário. Por fim, os micromecanismos de coerção contraceptiva se referem às ações dos(as) agentes, que visam à pressão e/ou à imposição de um método contraceptivo, também ao impedimento das mulheres de acessarem o método que desejam, à ocultação de informações, acerca de todos os métodos disponíveis no sistema de saúde, e/ou ao compartilhamento de informações errôneas sobre algum método contraceptivo.

Já no que se refere ao micromecanismo de omissão da sexualidade, ele se refere à falta de discussões acerca das escolhas sexuais, de identidade de gênero e de relacionamentos para além do espectro heterossexual, da binaridade homem cisgênero e mulher cisgênero. Entendemos que esta é uma forma de reproduzir o discurso da heteronormatividade. Olharemos para todos os micromecanismos com mais atenção agora.

2.2.1 Os micromecanismos

Chegamos, assim, aos micromecanismos. Desde o princípio, devemos deixar claro que os micromecanismos não foram conceitos desenvolvidos por nós para “acusar” os(as) profissionais de saúde e de educação de serem espécies de “vilões”. Nem apontar que eles não se importam com os direitos sexuais e reprodutivos juvenis, mas sim para pensarmos em como a agência destes cria formas de organização de seus trabalhos, que são baseadas em regimes morais e pânico moral, mas também que dependem de diversos outros fatores como: falta de formação sobre SSR ao longo da vida profissional, falta de recursos financeiros e de tempo,

falta de apoio das secretarias de Saúde e Educação para a discussão da temática, relações distantes entre usuários(as) e profissionais e, principalmente, o próprio contexto em que os(as) agentes vivem: uma sociedade em que o tabu e o conservadorismo em torno da SSR são presenças constantes entre a própria sociedade. Veremos ao longo da tese que os cinco micromecanismos em questão, em alguns casos, são utilizados, inclusive, como forma de proteção dos(as) profissionais contra investidas da comunidade contra suas formas de trabalhar.

O primeiro micromecanismo que iremos tratar é o de contenção reprodutiva. Este conceito foi criado com base, por óbvio, na noção de mecanismos de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012), mas também na noção de reprodução estratificada, desenvolvida por Colen (1995). Esta aponta que a reprodução ocorre de maneiras diferentes dependendo da raça, classe, gênero, religião, território, escolaridade, entre outros marcadores sociais da diferença.

Ou seja, algumas pessoas são inclusive estimuladas a gestar enquanto outras não e, no caso dos(as) jovens da nossa pesquisa, esse desincentivo se dá principalmente através de falas de professores e professoras, em sala de aula, sobre os perigos da gestação na juventude e nos atendimentos das jovens na unidade de saúde, seja nas consultas que se referem à contracepção ou naquelas que as jovens buscam fazer o planejamento familiar.

Outro conceito que nos ajuda a formular a noção de contenção reprodutiva é o de coerção reprodutiva. Esta se caracteriza por uma forma de violência contra o parceiro íntimo, normalmente contra a mulher, caracterizada pela interferência na saúde reprodutiva e na autonomia de uma pessoa, como forma de afirmação de poder e controle. Normalmente, ocorre quando um parceiro tenta engravidar uma mulher retirando o preservativo peniano antes do fim da relação ou danificando o mesmo (Miller et al., 2010; Miller et al., 2014).

Dejoy (2019), assim como nós, analisa a coerção reprodutiva por meio da ação de agentes de saúde do nível de rua, mas olhando para profissionais de centros de cuidado de saúde. Ela conclui que “Quando as políticas estatais tornam a contracepção e o aborto inacessíveis para algumas pessoas, elas estão, na verdade, replicando a coerção reprodutiva em um nível estrutural.” (Dejoy, 2019, p. 45). Assim como a autora atentou para os trabalhos dos(as) agentes de nível de rua nos Estados Unidos, olhamos aqui para os(as) agentes de saúde e educação e trazemos o termo contenção reprodutiva.

Já o conceito de micromecanismo de coerção contraceptiva foi por nós adaptado a partir da noção de coerção contraceptiva desenvolvida por Senderowicz (2019) onde a autora aponta para a pressão e - por vezes - imposição para que mulheres tenham que utilizar métodos contraceptivos e/ou serem impedidas de acessar ou usar o método que desejam.

Aqui, além destes dois pontos, acrescentamos que os micromecanismos de coerção reprodutiva também se dão a partir da fala de profissionais de saúde e de educação acerca de apenas alguns métodos contraceptivos disponíveis hoje no mercado e/ou Sistema Único de Saúde. Assim, micromecanismos de coerção contraceptiva englobam estes três pontos de ação dos(as) profissionais: pressão e/ou imposição de uso de algum método, por vezes de um método que a mulher não quer, ao mesmo tempo em que não são apresentados todos os métodos que ela teria direito, orientando sua escolha para aquilo que os(as) profissionais de saúde e/ou educação julgam mais adequado.

Ao olhar para o conceito de coerção contraceptiva, também destacamos a definição de Quintero Veloz et al (2025, p. 8, tradução nossa) que olhava para profissionais de saúde, mas aqui também olhamos para professores(as):

Definimos coerção contraceptiva como o comportamento de profissionais de saúde que exercem - em maior ou menor grau - força, violência, intimidação, manipulação, engano ou condicionamento de serviços ou direitos para interferir no processo de tomada de decisão autônoma de uma mulher em relação à sua saúde reprodutiva, especificamente, a escolha, o uso, a troca ou a descontinuação de um método contraceptivo. A coerção pode ser implementada individual, coletiva ou institucionalmente (como uma política interna dentro de uma unidade de saúde ou como uma política pública que rege os serviços contraceptivos em nível estadual ou nacional).

No nosso caso, falamos na implementação de maneira individual, uma vez que nos referimos aos micromecanismos, em uma relação cotidiana entre agente e usuário(a). O mesmo acontecerá com o conceito de micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina, que se dá nos encontros cotidianos entre agentes de saúde e educação e os(as) jovens.

Este último micromecanismo foi desenvolvido a partir de múltiplas leituras do campo feminista sobre o gênero, sendo este o elemento-chave para explicar grande parte, senão toda, a tese. Scott (1995) destaca que “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder.” (Scott, 1995, p. 86). Ainda, “O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (Butler, 2012, p. 59).

Para formularmos a noção de acumulação reprodutiva feminina, partimos da noção de que o gênero é uma construção social baseada na heteronormatividade em que os valores atribuídos a cada gênero também são construídos e revelam estruturas de poder centrais para o funcionamento da sociedade capitalista e que dita os papéis de cada um dos sexos.

As assimetrias de gênero perpassam nosso cotidiano e, com certeza, as ações dos(as) agentes de saúde e da educação, bem como os(as) jovens, dos(as) quais trataremos logo adiante. Entendemos que as relações entre os gêneros em qualquer espaço, seja público ou privado, são caracterizadas por relações em que há desigualdade entre pessoas, tanto no espaço privado do lar, quanto no espaço público das relações civis. Estas desigualdades são comumente explicadas por diferenças físicas, sexuais e biológicas, onde a “natureza” da mulher é de sujeição.

Federici (2019, 2017) cunhou um conceito que muito nos ajuda a entender as assimetrias e os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina: a noção de trabalho reprodutivo não remunerado. Este trabalho se dá a partir das obrigações com o cuidado familiar, no preparo de alimentos, no cuidado com higiene, no cuidado da casa, no cuidado das crianças, dos doentes e dos idosos. É um trabalho que ocorre no âmbito doméstico, “invisível” e não remunerado.

Aqui, entram as discussões acerca do cuidado que é majoritariamente ligado ao feminino e associado como “coisa de mulher”, como um aluno me disse em roda de conversa enquanto falávamos sobre cuidados com a casa. Muitas das jovens com quem conversei tinham inclusive pavor de gestarem porque já tiveram que cuidar de seus irmãos. Uma delas, de 17 anos, inclusive, me contou que seu irmão lhe chamava de mãe até os cinco anos de idade.

À mulher é atribuída a maternidade e o cuidado enquanto que ao homem essas responsabilidades não são social e culturalmente prescritas. Aqui, entender o cuidado implica:

uma leitura da categoria de gênero incluída num contexto de complexidade, que pode ser vislumbrada em diferentes dimensões: a dimensão cultural, quando nos referimos aos símbolos disponíveis nos diversos discursos de um povo [...]; a dimensão social das instituições que regulam, (re)produzem e atualizam os significados desses símbolos, tais como famílias, religiões, seitas, escolas, universidades, instituições jurídicas e políticas, etc.; a dimensão da identidade subjetiva, das identidades de gênero atualizadas por homens e mulheres, de como ambos tomam para si os conteúdos das imagens simbólicas do discurso cultural e institucional (Lyra et al., 2007, p.86).

Logo, as distribuições das atividades de cuidado possuem papel central na desigualdade das relações de gênero. Guimarães e Hirata (2020) criam o conceito de circuitos de cuidado. Para elas, o cuidado se dá em três dimensões: o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho mercantilizado, exemplo de cuidadora de idosos, e o terceiro se refere às “ajudas” pensando na reciprocidade da vida comunitária. E todos os circuitos de cuidados - sem espanto algum - são espaços femininos.

Como diz Tronto (2009, p. 156), “não é apenas o gênero, mas também o pertencimento de classe e de raça que, na nossa cultura, permitem identificar quem pratica o *care* e de que maneira”. Entendemos a centralidade da raça, mas aqui visualizamos que a maioria das

mulheres jovens são negras, então não conseguimos realizar, por exemplo, uma comparação maior entre brancas e pretas ao longo da pesquisa, mas, claro, concordamos que o fator raça e gênero não são dissociados até porque jovens negras e pobres são àquelas que mais assustam e preocupam os(as) profissionais de saúde e da educação quando estão grávidas, como pude observar, apesar de raça nunca ter sido citada por nenhum(a) destes(as) agentes.

O quarto micromecanismo ligado à governança reprodutiva é destacado como micromecanismo de vigilância reprodutiva. Este tipo de mecanismo parte da percepção de que os(as) profissionais vigiam as gestantes jovens, tanto antes quanto após o parto, buscando um maior controle sobre elas, o feto e, posteriormente, a criança. Este é o único dos quatro micromecanismos que encontramos apenas na US.

A noção de micromecanismo de vigilância reprodutiva, o qual teve seu conceito desenvolvido a partir da expressão “vigilância”, que teve inspiração em Foucault (1975) e seu clássico “Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão”. Nesse sentido, a vigilância se refere a uma técnica de poder disciplinar, que substitui punições corporais por um controle contínuo, sutil e normalizador dos corpos e comportamentos. Este controle induz as pessoas, no nosso caso jovens gestantes, à autodisciplina.

Ademais, a ideia de micromecanismos de vigilância reprodutiva tem sua base no trabalho de Barnes e Fledderjohann (2020) que cunharam a expressão “vigilância reprodutiva” ao estudarem sistemas como a Integrated Fertility Survey Series nos Estados Unidos. As autoras destacam que os sistemas impõem uma vigilância reprodutiva seletiva sobre populações vulneráveis, incluindo adolescentes “não normativas”, o que as torna “invisíveis” em dados oficiais, mas hipervisíveis em intervenções clínicas que visam moldar comportamentos maternos e fetais para padrões normativos. Aqui, as adolescentes “não normais” seriam aquelas fora do padrão de mulheres heterossexuais, cisgênero, brancas, de classe média, educadas e em idade fértil “ideal” (tipicamente 20-30 anos, casadas ou em uniões estáveis). Ou seja, as mesmas jovens que os(as) profissionais de saúde lidam cotidianamente na US.

Ulrich e Fowler (2023) aprofundam essa dinâmica ao analisar como a vigilância contínua de gestações em adolescentes pobres e minoritárias, nos EUA, ocorre via coleta de dados digitais e visitas pré-natais, promovendo uma disciplina sutil que estende o controle ao feto e à criança no pós-parto. Essa técnica de poder não punitiva, mas normalizadora, corrobora com a ideia de micromecanismo que aqui elaboramos. Segundo Ulrich e Fowler (2023, p. 570, tradução nossa): “A vigilância e o controle reprodutivos generalizados persistem, especialmente contra comunidades marginalizadas.”

Por fim, mas não menos importante, o micromecanismo de omissão da sexualidade tem sua inspiração empírica a partir do contato cotidiano com alunos(as), agentes de saúde e de

educação. Apesar de não ser um conceito desenvolvido por meio da governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012) destacamos que sua inclusão na tese é importante para tratarmos das lacunas nos diálogos em torno da sexualidade tanto no que se refere à orientação quanto à identidade e relacionamentos.

Este micromecanismo está, assim como os outros quatro, intimamente ligado com o pânico moral em relação à sexualidade juvenil (Bozon, 2012) e regimes morais (Morgan; Roberts, 2012), uma vez que os últimos destacam a heteronormatividade como padrão a ser seguido. Veremos, na tese, muito presente a palavra “tabu” para justificar a omissão das discussões sobre sexualidade, tanto por parte de agentes de saúde, quanto de educação.

No Brasil, as discussões acerca da sexualidade no campo da educação estão cada vez mais defasadas, enfrentando barreiras por parte de pais, professores e direção (Paiva; Brandão, 2023, Leite, 2019, Checa; Scisleski, 2018, Cid; Sousa e Duarte, 2020). No que se refere às unidades de saúde, a situação não muda muito de figura, visto que o acolhimento é centrado no atendimento das enfermidades, e não na proteção ou promoção da saúde com um olhar atento aos(as) jovens e sua sexualidade (Bellenzani; Santos; Paiva, 2012, Guimarães; Cabral, 2022).

Após olharmos com mais atenção para os micromecanismos, destacamos que a presente tese objetiva analisar de que forma o cotidiano dos(as) agentes de escolas e de uma unidade de saúde revelam micromecanismos de governança reprodutiva em relação a jovens porto-alegrenses, residentes em uma periferia. Para tanto, fez-se uma revisão das principais políticas que orientam e normatizam a atuação dos(as) agentes de saúde e de educação de Porto Alegre, no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva dos jovens porto-alegrense, observando em que medida tais políticas estão presentes no cotidiano dos(as) agentes. Analisamos as relações que se estabelecem entre os(as) agentes e jovens no domínio da saúde sexual e reprodutiva. Examinamos a experiência destes jovens no serviço público de saúde quanto à sua saúde sexual e reprodutiva e, ainda, como, no ambiente escolar, se dão as discussões acerca da saúde sexual e reprodutiva dos jovens.

Assim, nas páginas que seguiremos olharemos para como os(as) agentes - professores(as), médicos(as), enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem e agentes comunitárias de saúde - atuam em seus cotidianos e quais são os mecanismos de governança reprodutiva que eles(as) utilizam. Sem esquecer, claro, de olhar para os(as) jovens e entender como estes(as) acessam o tema da saúde sexual e reprodutiva em suas escolas e unidade de saúde, uma vez que as relações que eles(as) estabelecem com os(as) agentes podem mudar o micromecanismo a ser utilizado.

3 PERCURSOS METODOLÓGICOS

Aqui, a pesquisa se desenvolveu a partir da literatura sobre burocracia de nível de rua, antropologia das políticas públicas e governança reprodutiva, as quais foram centrais para delimitar questões metodológicas. Após, falaremos da escolha do território e dos participantes, bem como das técnicas de coleta de dados empregadas, como observação de cunho etnográfico, rodas de conversa e entrevistas com professores(as), médicos(as), enfermeiros(as), ACSs, técnicas de enfermagem e jovens, homens e mulheres, com e sem experiência reprodutiva.

3.1 CONSTRUINDO O REFERENCIAL METODOLÓGICO

Esta é uma pesquisa qualitativa que faz uso de análise documental, observações de cunho etnográfico, em unidade de saúde (US) e em duas escolas, entrevistas semiestruturadas com agentes de escolas e US, entrevistas com jovens de ambos os sexos e rodas de conversa com jovens nas escolas. Estas escolhas se deram a partir da literatura da BNR e da antropologia das políticas públicas ao destacarem a centralidade dos sujeitos envolvidos no processo de implementação das políticas e a centralidade das ações dos(as) agentes que, em última instância, fazem a política.

Ao iniciar este capítulo, pontuamos que foi realizada uma revisão narrativa da literatura com o intuito de explorar o campo de estudos sobre políticas públicas juvenis, saúde sexual e reprodutiva em escolas e unidades de saúde. A revisão foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES e na Base Scielo resultando em 891 artigos, dos quais foram analisados 78 estudos, sendo 77 deles artigos. Essa diminuição se deu devido à estudos repetidos e/ou estudos que os resumos não condizem com o tema da revisão. Os descritores buscaram atingir o máximo de estudos que abordassem saúde sexual, saúde reprodutiva, juventude, políticas públicas, escola e unidade de saúde.

Essa análise endossou a escolha do tema e objetivos da pesquisa uma vez que, como veremos no quarto capítulo, como principais achados da revisão temos: a) falta de estudos acerca da implementação das políticas de saúde sexual e reprodutiva juvenil em unidades de saúde; b) nas escolas o foco da maioria dos estudos se dá na gestação e não abordam outros pontos da saúde sexual e reprodutiva, como violência sexual ou identidade de gênero; c) não há

estudos que explorem a implementação de políticas públicas juvenis no que tange a saúde sexual e reprodutiva tanto no âmbito escolar quanto na saúde, sendo assim esta é uma pesquisa inovadora.

Também foram analisados os documentos das principais políticas para a atuação dos agentes da saúde e da educação de Porto Alegre, no que tange a experiência sexual e reprodutiva de jovens. Essa é uma parte inicial e importante da nossa pesquisa, uma vez que após apresentar as políticas, poderemos dar sequência na análise do cotidiano dos(as) agentes, tendo como pano de fundo as políticas nas quais eles(as) têm como referência.

A literatura sobre burocracia de nível de rua atenta para a centralidade das pessoas que trabalham no cotidiano com os(as) usuários(as) das políticas públicas, dos(as) burocratas de nível de rua ou agentes, como aqui nos referimos (Lipsky, 1980; Maynard-Moody; Musheno, 2000, 2003, 2012, 2015, 2022; Pires; Lotta; Junior, 2018; Pires, 2019; Lotta, 2010; Bonelli et al, 2019; Lima; D’Ascenzi, 2013; Ferreira; Medeiros, 2016; Ferreira; Guimarães, 2020). São inúmeras as pesquisas que utilizam de entrevistas com BNR e/ou grupos focais como ferramenta para a pesquisa, logo, nosso interesse por utilizá-las aqui.

Agregado a isso, o campo da antropologia das políticas públicas preza por análises *in loco*, focando na observação de cunho etnográfico e em entrevistas. A antropologia não tem sempre um método e instrumentos prontos para serem aplicados, sendo que a escolha das ferramentas usadas requer sensibilidade etnográfica, como apontam Shore e Wright (2011, 1997). Para os autores, toda experiência, encontro, diálogo, evento público ou documento pode resultar em material etnográfico. Citando Peirano (2014, p. 340):

como todos sabemos, a etnografia é a ideia-mãe da antropologia, ou seja, não há antropologia sem pesquisa empírica. A empiria – eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos afeta os sentidos –, é o material que analisamos e que, para nós, não são apenas dados coletados, mas questionamentos, fonte de renovação.

Silva (2009) entende a observação como andar, ver e escrever. Existe uma: “tensão básica, no entanto, estará sendo produzida pelo desconhecimento, pela dúvida, pelo empenho em descobrir e saber. A experiência etnográfica consiste sobretudo nisso.” (Silva, 2009, p. 180). As práticas devem levar em conta que “A pesquisa joga de acordo com a norma da reciprocidade, com o prazer de prestar serviço, com as regras do jogo das relações pessoais”. (Beaud; Weber, 2007, p. 32).

A escrita acerca da observação de cunho etnográfico se deu por meio de diário de campo. Oliveira (2000) destaca como o diário de campo é central e ferramenta fundamental na observação. Ele serve para anotar a percepção da pesquisadora sobre o ambiente que a cerca,

das ações dos(as) agentes, dos contatos dos(as) agentes com os(as) jovens e das percepções destes acerca da sexualidade juvenil, gravidez, maternidade e paternidade juvenil.

As observações ocorreram de diferentes formas nas escolas e na unidade de saúde. Em ambos os locais de ensino, foi-me indicado acompanhar os(as) professores(as) de Biologia em seus cotidianos tanto no turno da manhã quanto no turno da noite. Além disso, observei intervalos na sala dos(as) professores(as), no pátio e outras atividades escolares como palestras e passeios. Já na US, acompanhei médicos(as), enfermeiros(as), técnicas de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em seus cotidianos de trabalho. Além disso, observei a recepção da US, tanto atrás do balcão quanto em meio à população que esperava atendimento. Foram feitas atividades fora da US como idas à escola para realização de atividades do Projeto Saúde na Escola, visitas domiciliares e participação em reuniões de rede, reuniões do Conselho Local e reuniões distritais.

Além da observação, foram feitas entrevistas com agentes de saúde e educação e com jovens que acessam a US e/ou uma das escolas onde foi feita a pesquisa. A escolha por realizar entrevistas se deu por acreditar que:

Enquanto técnica de obtenção de informações, [a entrevista] trata-se de uma conversa interessada, orientada pelo entrevistador para fins de pesquisa, pela qual objetiva-se apreender informações sobre o comportamento e a consciência dos entrevistados, tanto quanto possível, em seu estado dado, objetivo. [...] Entrevista-se porque acredita-se que o entrevistado detém informações que, transmitidas ao entrevistador, podem ajudar a elucidar questões (Colognese, Mélo, 1998, p. 143).

A decisão por entrevistar agentes de saúde e da educação se deu devido à centralidade destes na nossa pesquisa e no cotidiano de implementação das políticas. Também ouvimos os(as) jovens devido à importância destacada pela antropologia das políticas públicas em dialogar com os(as) beneficiários(as) destas políticas e não só com aqueles que as executam, visando tratar da relação entre usuário(a) e agente (Bartels, 2014; Bruhn; Ekström, 2017; Raaphost, 2018). Até porque, a maneira com que os(as) jovens se relacionam com os(as) agentes pode mudar suas formas de tratamento, como Maynard-Moody e Musheno (2022) nos alertam.

O roteiro de entrevistas desta tese tem como inspiração o roteiro de entrevistas da pesquisa “Jovens na era digital: sexualidade, reprodução, redes sociais e prevenção às IST/Aids”, mas a partir dele fomos mobilizando outros aspectos importantes tendo em vista os objetivos da pesquisa. O roteiro para a entrevista com os agentes de escolas (apêndice A), o roteiro de agentes da US (apêndice B) e o roteiro com jovens (apêndice C) teve como foco

central entender como a saúde sexual e reprodutiva juvenil é vivenciada cotidianamente por estes grupos.

Importante destacar que ao longo das entrevistas se fez uso do diário de campo, anotando as principais percepções da entrevistadora, pontos de interesse, questões para reflexão, sentimentos em relação à entrevista, formas, gestos e ações dos(as) entrevistados(as), entre outras coisas que possivelmente aparecerão ao longo dos encontros. Assim, o diário de campo também é um documento para a análise da tese.

As entrevistas semiestruturadas ocorreram tanto com agentes de saúde e de educação quanto com jovens. Elas foram realizadas já nos últimos meses de 2024 após eu ter acompanhado o máximo possível a atuação dos(as) agentes. O roteiro pode ser encontrado no apêndice (apêndice A) e, além dele, outras questões mais específicas foram feitas para cada um(a) de acordo com aquilo que havia acompanhado ao longo dos meses nas consultas e no cotidiano.

Os(as) entrevistados(as) foram selecionados(as) a partir dos diálogos que se estabeleceram ao longo da pesquisa, sendo necessário que fossem funcionários da US ou da escola A ou B. Nas escolas, apenas os professores de Biologia foram entrevistados(as), visto que essa foi a indicação que as direções das escolas me deram quando apresentei minha pesquisa. Essa falta de outros(as) agentes de educação também, já num primeiro momento, diz muito sobre a organização da escola, no que se refere à saúde sexual e reprodutiva de jovens, dando centralidade à temática apenas no contexto biologicista. Assim, nas escolas foram entrevistados três professores de Biologia e uma professora de Biologia, todos ligados às turmas de Ensino Médio.

No que tange profissionais do serviço de saúde, de maneira geral, todos(as) foram solícitos(as) com a minha pesquisa, mas não foi com todos(as) que senti abertura para conversarmos sobre a possibilidade de realizar entrevistas. As entrevistas variaram entre 1 hora e 30 minutos até 4 horas e 15 minutos de duração e foram realizadas em local de escolha das pessoas participantes.

Os(as) profissionais entrevistados(as) foram selecionados(as) a partir dos diálogos estabelecidos na US, onde buscou-se acompanhar todos(as) os(as) enfermeiros(as), todas as técnicas de enfermagem, todas as ACSs e todos(as) médicos(as) da US. As entrevistas ocorreram com quatro enfermeiras, um enfermeiro, três técnicas de enfermagem, duas ACSs - as duas únicas Agentes da US até metade de outubro de 2023 - e três médicos e uma médica. Estabelecemos como cotas para as entrevistas um(a) profissional de enfermagem, uma técnica, uma ACS e um(a) médico(a) de cada equipe da US.

Recebi três recusas de profissionais da saúde para as entrevistas devido à falta de disponibilidade dos(as) agentes. Nesses momentos - com um médico, uma médica e com uma enfermeira - o período de realização das entrevistas coincidiu com o período de desligamento deles da instituição e eles(as) não se sentiram mais confortáveis para fazer parte do estudo, que anteriormente tinham dado como positivo. Outros três profissionais que acabaram se desligando da US concederam entrevistas mesmo assim. Foi cogitado entrevistar novas médicas e enfermeiras que recém haviam chegado na unidade em dezembro de 2024, mas achou-se melhor não fazê-la, visto que tinham pouquíssimo tempo de experiência na US. Ao final de 2024 somaram-se quatorze profissionais do serviço de saúde entrevistados(as).

Já, no que tange os(as) jovens participantes da pesquisa, reforçamos a importância de escutá-los, partindo da perspectiva da antropologia das políticas públicas (Shore; Wright, 1997) que preza por um estudo que olhe também para os(as) beneficiários(as) das políticas. Ao delimitar o perfil de jovens desta pesquisa, vale a pena reforçar que a definição pela faixa etária possui elementos objetivos no aspecto da maturidade biológica que são importantes para a definição de políticas e recursos orçamentários (Carrano, 2011). Porém, como sinaliza ainda Carrano (2011, p. 243), “(...) compreender os jovens apenas pelo fator idade, contudo, seria simplificar uma realidade complexa, que envolve elementos relacionados ao simbólico, ao cultural e aos condicionantes econômicos e sociais que estruturam as sociedades”.

Seguindo preceitos da OPAS/OMS (1995), gravidez na juventude é aquela que ocorreu entre os 10 e 20 anos de idade incompletos, então este é o primeiro recorte a ser levado em conta. No presente estudo, optamos por entrevistar jovens entre 16 e 20 anos de idade (considerando que a experiência da gestação pode ter se dado aos 19 anos e vamos fazer a entrevista logo depois desse evento).

Outro motivo para a escolha entre 16 e 20 anos é que a Pesquisa Nacional de Saúde (PNA) realizada em 2019 pelo IBGE aponta que a idade média de iniciação sexual das pessoas em nível nacional é de 17 anos (IBGE, 2019). Ou seja, dentro da faixa de idade das pessoas entrevistadas.

Aqui, escolhemos entrevistar jovens com experiência de gravidez, incluindo, possivelmente, pessoas que passaram pelo processo de interrupção da gravidez - apesar de não haver nenhum destes casos entre nossas entrevistas - e jovens sem experiência gestacional. Não foram estabelecidas cotas do número de jovens homens e mulheres com experiência reprodutiva, mas seguimos pela saturação dos dados.

Ao decorrer da pesquisa, o que realmente acabou ocorrendo, em se tratando das jovens com experiência reprodutiva, foi que elas eram jovens que eram atendidas pela US, estando

gestantes ou puérperas. Foram entrevistadas 10 jovens entre 16 e 20 anos (todas aquelas com 20 anos haviam ficado grávidas aos 19). O convite era feito após acompanhar algumas consultas das jovens e/ou a sua presença no Grupo de Gestantes ou no Grupo de Puericultura. Quando jovens indicaram outras amigas, estas também, coincidentemente, faziam acompanhamento na US.

Tentou-se contato com jovens homens com experiência reprodutiva, sendo que dois haviam dado retorno positivo sobre, mas nos momentos das entrevistas, não compareceram. Com um deles a entrevista foi remarcada cinco vezes, mas não se obteve sucesso. Os silêncios, neste caso, nos dão indícios, principalmente, da centralidade da mulher no cuidado e na ausência dos genitores em assumir a paternidade, pontos que veremos recorrentes nas falas da maioria das jovens gestantes que foram entrevistadas.

Ao estar nas escolas, conversei com jovens sobre a minha pesquisa, falei sobre as entrevistas com jovens pais, mas nenhum aluno demonstrou interesse. Na escola B, descobri por conversas de corredores o caso de um jovem de 17 anos que era pai, mas não havia assumido para qualquer pessoa que tinha uma filha e, ao longo das nossas conversas em sala, ele sempre perguntou várias coisas para mim relacionadas à contracepção, mas nunca deu indícios de que era pai.

Foram 10 jovens com experiência reprodutiva entre 16 e 20 anos entrevistadas e cinco delas tiveram filhos com jovens de até 20 anos e apenas duas ainda seguiam se relacionando com estes e os convidaram para participarem da entrevista. Foram os dois que acabaram aceitando a participação, mas depois não compareceram nas tentativas feitas.

No que tange jovens sem experiência reprodutiva entrevistei um homem e uma mulher com 16 anos, o mesmo com 17, 18, 19 e 20 anos totalizando dez jovens sem experiência reprodutiva. Utilizamos a saturação de informações para definir o número de entrevistas com jovens, tanto quanto sem experiência reprodutiva. Estas entrevistas se desenvolveram a partir da ferramenta de bola de neve e se iniciaram pelo interesse de alunos(as) da escola B em participar das entrevistas: “Sora, achei muito legal a pesquisa, quero participar conversando contigo.” Assim, as únicas entrevistas com homens acabaram sendo com jovens sem experiência reprodutiva.

As entrevistas com jovens sem experiência reprodutiva aconteceram em sua maioria nas escolas A e B durante o próprio horário de aula dos(as) jovens, pois estes(as) tinham dificuldade em estar disponíveis em outros horários ou a se deslocarem para outros locais. Estas entrevistas tinham em média 1 hora e 15 minutos de duração.

Já as entrevistas com jovens gestantes e/ou mães ocorreram em sua maioria na US em uma sala disponibilizada pela gerência após consultas das jovens. Em três casos realizei as entrevistas na casa da participante e em um caso, na escola. Estes diálogos tiveram em média 1 hora e 30 minutos de duração.

Visando conhecer mais das experiências de jovens e saúde sexual e reprodutiva utilizamos rodas de conversa com jovens nas escolas. Entendemos que elas:

são reputadas também por sua potencialidade na produção de narrativas individuais e/ou coletivas. Então, os depoimentos apresentados nas discussões são tomados para sistematização não só com finalidade devolutiva, mas com o fito de elencar conteúdos e sustentar análises sobre inserções sociais, vivências de práticas específicas, experiências subjetivas em dado tema (Pinheiro, 2020, p. 4).

Inicialmente, a pesquisa não envolveria a realização de rodas de conversa, mas esta ideia surgiu de um dos professores de Biologia, de uma das escolas em que fiz a pesquisa, e ele achou que seria interessante para “tu poder conversar mais com os jovens sobre esses assuntos, já que a gente não fala muito e pra eles vai ser bem importante.” Os três outros professores também apoiaram a ideia e tiveram falas parecidas com esta. Adiante, iremos abordar mais sobre como foram as rodas de conversa cujo roteiro (apêndice F) foi elaborado tendo como base o roteiro para entrevistas com jovens, mas com alterações, por óbvio, para se adequar a uma discussão a ser realizada em grupo.

Importante abordar que as rodas de conversa ocorreram em turmas do Ensino Médio de primeiro a terceiro ano, em ambas as escolas da pesquisa, tanto no turno diurno quanto no noturno. Realizei rodas de conversa com uma turma do terceiro ano, no turno da manhã, na escola A e com as três turmas do Ensino Médio, da noite, uma de primeiro, uma de segundo e uma de terceiro ano. Em média, eram 15 alunos(as) por sala, a maioria negros(as) e em torno de oito jovens mulheres e sete jovens homens. Em geral, as idades eram compatíveis com o ano que os(as) jovens estavam cursando, ou seja, primeiro ano com dezesseis anos, segundo ano com dezessete anos e terceiro ano com dezoito anos de idade. As rodas de conversa duraram em média uma hora, que é o tempo de dois períodos de aula das turmas.

As rodas de conversa na escola B foram realizadas em três turmas de primeiro ano do Ensino Médio, sendo a média de idade de dezesseis anos; duas turmas de segundo ano, com média de idade de dezessete anos e três turmas de terceiro ano, em que a média de idade era dezoito anos (mas havia mais alunos com dezenove e vinte anos de idade). Assim como na escola A, a média de participantes também era de 15 alunos(as), sendo a maioria negros(as) e divididos de forma homogênea entre homens e mulheres. Apenas uma turma de terceiro ano saiu do padrão em relação a homens x mulheres, pois havia apenas oito jovens homens no dia

da aula em que foi feita a roda de conversa. Esta turma era composta por mais cinco jovens mulheres, mas conforme a professora Monique, elas raramente frequentam o ambiente escolar. A maioria das rodas teve cerca de uma hora de duração, comportando dois períodos de aula.

Ao falarmos das pessoas entrevistadas, rodas de conversa e observação de cunho etnográfico, é importante destacar que devido a questões éticas da pesquisa, os(as) participantes não tiveram os seus nomes ou dados, que pudessem identificá-los(as), divulgados. Ao submeter o projeto de tese para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, destacamos que todos(as) os(as) participantes da pesquisa deveriam assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice D, apêndice E), tendo garantia de que sua identidade não fosse revelada e que a entrevista seria transcrita e utilizada para fins desta pesquisa.

Como entrevistamos jovens menores de 18 anos, é importante dizer que fizemos um pedido de dispensa de TCLE aos responsáveis, o qual foi aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS em dezembro de 2023, CAEE 75941623.5.0000.5347 (Anexo A). Se fosse necessário o consentimento de responsável, em se tratando de uma pesquisa que aborda a sexualidade juvenil, possivelmente alguns responsáveis não deixariam que os(as) jovens participassem ou poderiam buscar direcionar suas falas. Na solicitação, para endossar nosso pedido, sinalizamos que o CONEP aprovou recentemente a pesquisa “Contextos de vulnerabilidade ao HIV entre jovens de camadas populares: um estudo multicêntrico em cinco cidades do Brasil - Espaços Jovens”, CAAE 36495120.7.0000.5327.

Para realizar a análise de todo este material, partimos da análise de dados qualitativos, a partir do pressuposto que ela envolve interação entre teoria e prática (Babbie, 2014), o que buscamos fazer aqui. As análises foram realizadas com auxílio do *software* NVivo tendo como base a análise de conteúdo temática (Bardin, 2016).

A análise de conteúdo é uma metodologia de análise de textos na qual se examina a ocorrência de determinados termos, construções e referências em um dado texto. Ela incide sobre várias mensagens, desde obras literárias, até entrevistas. Tradicionalmente, ela trabalha a partir de dois tipos de textos: textos que são construídos no processo de pesquisa, tais como transcrições de entrevista e diários de campo; e textos que já foram produzidos para outra finalidade quaisquer, como jornais, leis, atas, prontuários ou memorandos de corporações.

Para Bardin (2016) a análise de conteúdo possui:

uma função heurística: a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à descoberta. É a análise de conteúdo ‘para ver o que dá’. Uma função de ‘administração da prova’: hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações provisórias servindo de directrizes, apelarão para o método de análise

sistemática para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma afirmação. É a análise de conteúdo ‘para servir de provas’ (Bardin, 2016, p. 30).

Aqui, utilizamos dos seguintes elementos para a estruturação da nossa análise de conteúdo influenciada por Abella (2002), Bardin (2016), Sampaio, Lycarião (2021) e Moraes (1999): 1. pré-análise; 2. codificação; 3. categorização; 4. Interpretação dos resultados. Há diversos tipos de análise de conteúdo e aqui optamos pela análise de conteúdo temático ou categorial, como também é conhecida. Segunda Bardin (2016), a análise temática visa descobrir os “núcleos de sentido”, que fazem parte da comunicação. Escolhemos a análise temática por entender que ela dá conta de ajudar a cumprir os objetivos e responder às perguntas centrais da pesquisa ao olhar através de temas e não de palavras, por exemplo.

O primeiro passo da análise de conteúdo, ou seja, a pré-análise, consistiu justamente em reunir todos os materiais para a análise - no nosso caso, utilizando do *software* NVivo - sendo eles: diários de campo, transcrição das entrevistas, transcrição das rodas de conversa com jovens e documentos das políticas de saúde e educação a serem analisadas. Após, ocorreu a leitura flutuante onde algumas anotações e destaques foram feitos em comentários junto aos documentos.

No processo de codificação, trabalhamos a partir da criação de unidades de registro, unidades de contexto e escolha das regras de contagem. A unidade de registro que aqui utilizamos é o tema. Conforme Bardin (2016, p. 135), "O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc." Assim, se encaixa apropriadamente com o que buscamos fazer aqui.

Já a unidade de contexto é uma espécie de apoio para entendermos a unidade de registro; assim como o nome destaca, ela traz o contexto daquela unidade (Moraes, 1999; Bardin, 2016; Sampaio, Lycarião, 2021) e é elemento central para entendermos o processo de análise, sempre sendo mais abrangente que a unidade de registro. Como nossa unidade de registro é temática, a unidade de contexto se dá em um parágrafo completo, normalmente.

A seguir, temos as regras de enumeração, as quais são importantes para observar o modo de contagem das unidades. Bardin (2016) aponta algumas regras e aqui utilizamos de três: presença e/ou ausência, frequência, intensidade e valência subdividida em positiva, negativa ou neutra.

Depois, a codificação das unidades de registro foi feita, como o nome diz, através da designação de códigos para as unidades de registro. Aqui “a codificação corresponde a uma transformação - efetuada segundo regras precisas - dos dados brutos do texto, transformação

esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo” (Bardin, 2016, p. 134).

Já nossa terceira etapa se refere à categorização. Aqui também utilizamos da categorização temática. Júnior, Melo e Santiago (2010, p. 35) apontam que “A categorização evidencia um caminho de ordenação da realidade investigada, na intenção de apreendê-la conceitualmente.” Muitos acabam considerando a categorização como a etapa mais importante da análise de conteúdo, sendo aqui que os códigos são aglomerados em categorias temáticas.

A escolha das categorias, segundo Bardin (2016) pode se dar de duas formas: prévia ou durante a leitura dos materiais. Aqui, utilizamos da segunda por entender que nos dá mais liberdade de análise e deixamos o “material falar”. Trabalhamos com categorias semânticas, ou seja, os códigos são agregados em categorias a partir de seus significados em comum.

Carlomagno e Rocha (2016) apontam para elementos importantes ao criar categorias: regras claras de inclusão ou exclusão de categorias, categorias precisam ser mutuamente excludentes, elas precisam ser homogêneas, elas devem se ocupar de todos os conteúdos possíveis e devem ser objetivas. Neste sentido, as seguintes categorias foram criadas para esta tese:

Quadro 1- Categorias temáticas para a análise dos achados da tese

CATEGORIAS TEMÁTICAS	DESCRIÇÃO
ESTRUTURA DA ESCOLA	Trata de como a escola se organiza em números, espaço, financeiro, perfil de alunos, território, entre outros.
PROTOCOLOS ESCOLA	Aborda as políticas em torno dos(as) professores(as) de Biologia no que tange SSR.
SSR NAS AULAS DE BIOLOGIA	Aborda as políticas em torno dos(as) professores(as) de Biologia no que tange SSR.
SSR NA ESCOLA	Trata de como as temáticas de SSR são desenvolvidas por professores(as) de Biologia na escola, seja dentro de sala de aula ou em conversas paralelas.
RELAÇÕES JOVENS E ESCOLA	Aborda as relações que se estabelecem entre jovens e funcionários(as) da escola dando atenção ao que se refere à SSR.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	DESCRIÇÃO
VISÃO JOVENS SSR NA ESCOLA	Aborda a percepção dos(as) jovens acerca de como as temáticas de SSR são desenvolvidas na escola, seja durante aula, palestras ou conversas de corredor.
ESCOLA E GESTAÇÃO	Trata de como a escola se organiza quando possui jovens gestantes e/ou no puerpério e como os(as) professores(as) dialogam com as jovens.
VISÃO JOVENS GESTAÇÃO	Aborda as visões dos(as) jovens acerca da gestação na juventude.
VISÕES JOVENS TERRITÓRIO	Aborda a visão dos jovens acerca do território em que vivem.
CONHECIMENTOS JOVENS SSR	Trata dos conhecimentos que os(as) jovens possuem acerca da SSR.
ESTRUTURA DA US	Trata de como a US se organiza em espaço, parcerização, perfil de atendimento de jovens, território, entre outros.
PROTOCOLOS US	Aborda as políticas em torno dos(as) funcionários(as) da US no que tange SSR.
PSE	Aborda as ações do PSE na visão dos(as) funcionários(as) de escolas, US e jovens.
GESTAÇÃO NA US	Trata das formas com que a gestação é abordada na US.
CONTRACEPÇÃO NA US	Trata das formas com que a contracepção é abordada na US.
ISTS NA US	Trata das formas com que as ISTs são abordadas na US.
OUTRAS DISCUSSÕES SSR NA US	Aborda outras discussões referentes à SSR que não tenham relação com gestação, ISTs e/ou contracepção.
RELAÇÕES JOVENS E US	Aborda as relações que se estabelecem entre jovens e funcionários(as) da US dando atenção ao que se refere à SSR.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	DESCRIÇÃO
VISÃO JOVENS SSR NA US	Aborda a percepção dos(as) jovens acerca de como as temáticas de SSR são desenvolvidas na US, seja durante consultas, acolhimento e/ou outros momentos.

Fonte: Elaborado pela autora

Por fim, na última etapa da análise, temos a interpretação dos resultados. Bardin (2016) chama a atenção para a inferência, ou seja, ter conhecimento sobre a mensagem: quem escreveu, para quem, como, quando, o porquê e qual a sua significação. Após isso, a interpretação se dá através do referencial teórico, no nosso caso: burocracia de nível de rua, agência e mecanismos de governança reprodutiva. Mostramos a seguir um quadro com as categorias analíticas sistematizadas:

Quadro 2- Categorias analíticas utilizadas para a interpretação dos achados da tese

CATEGORIAS ANALÍTICAS	DESCRIÇÃO
Micromecanismos de contenção reprodutiva	Formas com que os(as) agentes de saúde e educação buscam coibir as jovens e os jovens - mas majoritariamente as primeiras - a gestar e reforçam discursos acerca das dificuldades e problemas que a gravidez ocasiona segundo as suas percepções.
Micromecanismos de coerção contraceptiva	Ação dos(as) agentes que visam à pressão e/ou imposição de um método contraceptivo, também ao impedimento das mulheres de acessarem o método que desejam, ocultação de informações acerca de todos os métodos disponíveis no sistema de saúde e/ou compartilhamento de informações errôneas sobre algum método contraceptivo.
Micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina	Ação dos(as) profissionais que reforça a centralidade feminina e a inércia dos homens em suas responsabilidades antes da gestação, durante e após, com o cuidado da criança.
Micromecanismos de vigilância reprodutiva	Formas que os(as) agentes de saúde encontram para buscar controlar e vigiar a gestação das jovens e os primeiros meses após o nascimento da criança.
Micromecanismo de omissão da sexualidade	Falta de discussões acerca das escolhas sexuais, identidade de gênero e relacionamentos para além do espectro heterossexual da binaridade homem cisgênero e mulher cisgênero.

CATEGORIAS ANALÍTICAS	DESCRIÇÃO
Lacunas nas discussões sobre saúde sexual e reprodutiva	Lacunas nas discussões da temática da saúde sexual e reprodutiva nas escolas e na unidade de saúde. Assuntos majoritariamente silenciados são sobre orientação sexual, coerção e violência sexual e assimetrias de gênero.
Pânico moral	Conceito de Bozon (2012) que aponta para o pânico e alarmismo de adultos em relação à jovens. É ligado a um discurso moralizante em torno da sexualidade.
Regimes morais	Conceito de Morgan e Roberts (2012) que se refere aos padrões morais que são usados para controlar os comportamentos íntimos, julgamentos éticos e como se manifestam na sociedade.
Categorização de usuários(as)	Tema trabalhado por Lotta (2015, 2019) que indica categorias que os(as) profissionais criam para poder lidar com os(as) usuários(as). Estas são criadas a partir de valores, moralidades do que é certo ou não, adequado ou não.
Relações sociais verticalizadas e assimétricas	Se refere às relações que se estabelecem entre jovens e profissionais da saúde e educação no cotidiano. São relações verticais onde os(as) primeiros(as) têm menos conhecimento e poder de ação que os(as) agentes.
Território conflagrado	Conceito de Costa, Baptista e Cunha (2022) que trata de territórios com presença do tráfico, violência armada, precarização de serviços públicos e pouca presença do Estado com falta de segurança generalizada.

Fonte: Elaborado pela autora

Nesse contexto, acreditamos que a análise de conteúdo é o mecanismo mais indicado para auxiliar na realização dos objetivos da tese na medida em que ocorre um profundo processo de adentrar nos materiais e dados coletados. Por fim, apontamos para a centralidade de: “identificar vieses e anotar impressões; reduzir, organizar e codificar; buscar padrões e interconexões; mapear e construir temas; construir e verificar teorias; e tirar conclusões.” (O’Leary, 2014, p. 319, tradução nossa).

A seguir, iremos discutir como se deu a escolha do território em que a pesquisa se desenvolveu, para depois falar sobre os sujeitos da pesquisa e detalhar as entrevistas, rodas de conversa e observação de cunho etnográfico.

3. 2 DA ESCOLHA DO TERRITÓRIO DA PESQUISA

O estudo se desenvolveu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A escolha por este município se deu devido a ser a cidade com maior coeficiente de HIV/aids do país (Ministério da Saúde, 2021) e o fato do estado ter se tornado o segundo colocado no índice de detecção de sífilis entre todos os estados do Brasil, perdendo apenas para o de Santa Catarina (Brasil, 2019).

Ainda, a escolha por focar em Porto Alegre se dá pela falta de estudos qualitativos recentes no tratamento da sexualidade juvenil na capital, sendo o último de relevância organizado em 2006 por Heilborn e colaboradores(as) intitulado “O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros”, o qual citamos anteriormente.

No ano de 2022, houve registro de 937 crianças nascidas de mães entre 13 e 19 anos completos em Porto Alegre, sendo que ao todo, no ano, foram 13.700 nascimentos. Os(as) filhos(as) nascidos de mães jovens representaram 6,83% do total de nascidos vivos daquele ano. Este é um dado importante que aponta para a baixa representatividade em números absolutos da gravidez na juventude embora haja um discurso acerca da problemática da gravidez nessa faixa etária.

Após escolhida a cidade, como tínhamos interesse em olhar para os micromecanismos que se estabeleciam nas relações entre profissionais de saúde, de educação e jovens, optamos por uma análise aproximada de um território específico. A escolha deste território se deu a partir da análise da taxa de natalidade de todas as dezessete regiões distritais de Porto Alegre, e também pela minha inserção facilitada no campo a partir de contatos com profissionais da saúde de US do território.

Optamos por não divulgar o nome do bairro onde foi feita a pesquisa devido a questões éticas, visando o sigilo das identidades dos(as) pessoas participantes do estudo, então iremos discutir o território por ser central na implementação das políticas, mas não o nomearemos. Da mesma forma, não nomearemos as escolas e a US onde foi realizada a pesquisa.

A procura por dados mais específicos acerca da gestação juvenil nos levou a uma base de dados disponibilizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre (DVS). Esta base foi criada a partir de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Os dados podem ser consultados em http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgvs/default.php?p_secao=2444, sendo possível consultar distintas variáveis para analisar o fenômeno da gravidez no município de Porto Alegre.

A escolha pelo território da pesquisa se deu em 2022, então os dados que baseamos a análise foram daquele ano, em cada um dos dezessete distritos de saúde de Porto Alegre.

O cálculo foi realizado com base na relação entre o número de nascidos vivos em 2022 e o número de habitantes do local. Esta é uma taxa estimada, visto que não se tem acesso a todos os dados necessários nem aos mais recentes. Foi feito cruzamento de dados, do IBGE de 2010, do número de habitantes entre 12 e 18 anos de cada uma das 17 regiões de Porto Alegre com dados do SINASC, de nascidos vivos em 2022, de jovens entre 13 e 19 anos de cada uma das regiões.

No SINASC, os dados estão disponíveis apenas a partir dos 13 anos e foram selecionados até os 19 anos, abrangendo o período da gravidez na juventude segundo a delimitação que aqui seguimos da OPAS/OMS (1995). Já referente aos dados de cada uma das regiões de Porto Alegre, é possível analisar a sequência de anos de 12 a 18, que é a categoria “adolescente” para o IBGE. Os habitantes de 19 anos estão categorizados em “jovens” abrangendo entre 19 e 29 anos. Não há uma forma de separar por idade específica para, por exemplo, não somar os 12 anos ou adicionar os 19 anos, o que deixaria o cálculo da taxa de natalidade mais exato.

As taxas reveladas são na proporção de mil habitantes e variam entre 1,7 jovens gestantes no ano de 2022 até 12,68 jovens, sendo justamente a região com maior taxa de natalidade juvenil. Esta região é composta por apenas um bairro e teve um número de 71 nascidos de mães jovens em 2022.

A população do bairro é de 44.068 habitantes e corresponde a 3,1% da população de Porto Alegre, sendo o quarto bairro mais populoso da capital do RS (IBGE, 2022). O território tem densidade demográfica de 5.491,74 habitantes por km², taxa de analfabetismo em 5,8% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 1,68 salário mínimos (Ferreira; Menezes, 2017). Segundo dados mais atualizados, que temos acesso, o número de jovens entre 12 e 18 anos no bairro é de 4.558 (IBGE, 2010).

Atualmente, 26% da população residente em Porto Alegre é negra (IBGE, 2022) com concentração dessa população em zonas periféricas da cidade, como é o caso do território aqui estudado. Segundo dados do IBGE (2022) o bairro possui mais de 40% da população autodeclarada negra. Dados de 2023 apontam que 43,5% dos nascidos vivos do bairro são filhos de mães negras, sendo o quarto percentual mais elevado de Porto Alegre (SINASC, 2024).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o qual tem a máxima de 1, é de 0,643 no bairro em questão, considerado médio, mas abaixo dos 0,805 apontados para Porto Alegre, valor considerado muito bom (IBGE, 2022). O Índice de Vulnerabilidade Social também tem máxima de 1 e é de 0,346 no território, sendo considerado como de

vulnerabilidade, e pior do que o valor atribuído a todo o município, que ficou em 0,249 em 2010 (IBGE, 2022).

Acerca da educação, segundo o IBGE (2010), 4,40% dos habitantes do bairro com idades entre 6 a 14 anos não acessavam a escola e 34,09% moravam em domicílios onde nenhum dos moradores tinha concluído o Ensino Fundamental. Também segundo dados do IBGE (2010), a taxa de analfabetismo no bairro é de 5,60%, sendo que a média da cidade é de 3,86%.

Além de viver em contexto de vulnerabilidade econômica, segundo relatos das pessoas do bairro, a comunidade do bairro em questão lida diariamente com contextos de violência, insegurança e criminalidade. Segundo Da Cunha (2022), dos locais de residência dos adolescentes de 12 a 21 anos, vítimas de homicídio em Porto Alegre, entre os anos 2010-2019, o bairro é o quarto do município com maiores taxas, somando 84 mortes de jovens.

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre destaca que:

A análise dos condicionantes e determinantes de saúde mostra uma correlação entre mortalidade juvenil com a violência e violação de direitos. Verificase nos territórios com maiores taxas de mortalidade, um maior percentual de negros, altas taxas de analfabetismo e baixa renda percapita, com grande parte das famílias vivendo com um salário mínimo. Neste sentido, é possível identificar uma relação da mortalidade juvenil com a violência, tráfico de drogas e ausência de políticas de inserção destes jovens na sociedade (Secretaria de Saúde de Porto Alegre, 2021, p. 205).

Assim, temos o panorama de um bairro com baixíssimo nível de renda, alta associação com o tráfico de drogas e níveis de violência e insegurança que percebi ao conversar com a grande maioria das pessoas da comunidade. Desde meu primeiro dia na US, fui instruída a sair da US sempre acompanhada de funcionários(as) e nunca no turno da noite. Em 2023 eu estive na US em períodos de disputa por pontos de tráfico onde a US não fechou suas portas, mas havia um toque de recolher e trocas de tiroteios rotineiramente durante duas semanas. Depois disso não presenciei mais nenhuma troca de tiros, assaltos, roubos ou disputas de facções rivais perto da US ou das escolas onde fiz a pesquisa, apesar dos(as) jovens me contarem eventos que aconteciam no bairro relacionados a isso.

Além de elencar este bairro por ser o local com mais alta taxa de natalidade de Porto Alegre, também possuíamos maiores possibilidades de inserção no espaço por ter um colega do Programa de Pós-Graduação que já atuou no bairro como gerente interino de uma US do local. Entramos em contato com o gerente - naquele momento - da US para pensar em um primeiro reconhecimento do bairro.

Nesses primeiros contatos, nosso interlocutor foi receptivo e se mostrou interessado pela nossa pesquisa, tendo dito que os(as) agentes comunitários(as) ficaram entusiasmados(as) com a proposta. Dias depois fomos à US para conhecer a ACS Fernanda e ela nos indicou como funcionava a US e nos apresentou o entorno do território. Importante sempre deixar claro que esta foi uma pequena incursão em caráter exploratório para avaliar a possibilidade de realizar a pesquisa, não tendo sido iniciado o trabalho de campo. Este só começou após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (Anexo A) e da Secretaria de Saúde de Porto Alegre.

Como o bairro é extenso e conseguimos a inserção a partir desta unidade de saúde, focamos a pesquisa nesta Unidade. O entorno do serviço de saúde é composto por uma escola de Ensino Fundamental, um parque, um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, uma escola de Educação Infantil e uma associação de moradores. A US é próxima de pontos de ônibus, supermercados e comércios do bairro, estando numa região central do mesmo.

A Unidade de Saúde, segundo conversa com a gerente do local, já em 2024 durante a pesquisa de campo, tem 14.135 pessoas cadastradas, mas ela acredita que na realidade são em média de 18.000 usuários(as), pois parte do território ainda não foi cadastrada. Baseado no acesso, ela aponta que são, em média, 3.500 pessoas da comunidade que acessam o serviço.

Em capítulos posteriores, falaremos mais sobre as características da US, mas desde já é relevante destacar que ela é uma Unidade que atende das 7 horas da manhã até as 22 horas da noite, possui cinco equipes de estratégia de Saúde da Família com, a princípio, dois técnicos(as) de enfermagem, um(a) ACS, um(a) enfermeiro(a) e um(a) médico(a). A farmácia funciona diariamente com farmacêutico atendendo das 13 horas até as 22 horas. A US também possui duas equipes de odontologia compostas por dois auxiliares de odontologia e dois dentistas, que atuam desde a abertura até o fechamento do serviço de saúde.

Foi depois dessa incursão inicial no serviço de saúde que passamos a olhar para possíveis escolas onde realizar a pesquisa. As escolas do bairro também foram visitadas, pensando na possibilidade de ocorrer ali a pesquisa, essa definição se deu também conversando com a coordenação dos locais. Foram quatro escolas, sendo duas de Ensino Fundamental, as quais decidimos que não iríamos adentrar na pesquisa devido a atenderem alunos até o nono ano do Ensino Fundamental, os quais normalmente estão na faixa etária

até os 15 anos, o que não se enquadra no público-alvo da pesquisa.

As duas escolas selecionadas, para a pesquisa, são escolas estaduais que possuem Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo as turmas de Ensino Médio à manhã e à noite. A escola A fica dentro dos limites do bairro em questão, “bem no meio da vila” como falam diversas pessoas da comunidade, e a cinco minutos a pé da US. A outra escola, a escola B, fica na divisa do bairro, mas os(as) jovens do território acabam estudando em uma das duas. Esta escola fica a cerca de 15 minutos a pé da US.

Em ambas as escolas, a coordenação foi receptiva e, ao eu falar sobre os objetivos da pesquisa, a coordenadora da escola A me disse: “Ah, aqui se tu ver isso, vai ser com professor de Biologia.” Enquanto a vice-diretora da escola B disse: “Trabalhar esses temas de sexualidade e gravidez com jovens é difícil, vai ser ótimo quando tu vier aqui trabalhar com eles, porque ninguém estuda sobre.” Nestas primeiras interações, antes de iniciar o campo propriamente dito, já foi possível pontuar uma falta de discussões sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas, como discutiremos ao longo da tese.

4 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - O QUE A LITERATURA TEM A NOS DIZER

Neste capítulo, iremos abordar as formas com que a saúde sexual e reprodutiva de jovens vêm sendo discutidas no ambiente escolar e em unidades de saúde pelas pesquisas brasileiras. Nossa pretensão não é analisar cada um dos artigos que discutem a temática, mas trazer pontos importantes para refletir sobre a nossa própria pesquisa, pensando inclusive em lacunas na literatura para aprofundarmos neste estudo.

Para tanto, foi feita uma revisão narrativa da literatura na base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Científica Digital Online (SciELO), sendo os descritores nominados no quadro três e o período da busca foi de janeiro de 2010 a junho de 2025. A revisão focou no Brasil, com o objetivo de analisar mais especificamente o panorama das políticas públicas no País, já que nosso campo se desenvolveu todo aqui.

Os descritores buscaram abranger o máximo de estudos acerca da temática que envolve a tese, portanto escola, unidade de saúde e políticas públicas foram palavras-chave utilizadas em muitas das combinações de buscas. No que se refere à “saúde sexual” e à “saúde reprodutiva”, trabalhamos com esses dois termos somados à “sexualidade” e à “educação sexual”. Os termos “adolescência” e “juventude” sempre foram utilizados nas combinações de descritores, devido ao próprio campo de estudos fazer uso dos termos adolescência ou juventude, embora a maioria dos estudos ainda se refira à adolescência.

Quadro 3 - Total de artigos localizados nas bases do Portal de Periódicos da CAPES e SciELO com informações sobre os descritores utilizados

Descritores	Número de artigos em cada base	
	Portal de Periódicos da CAPES	SciELO
Saúde sexual, saúde reprodutiva, juventude, políticas públicas	4	3
Saúde sexual, saúde reprodutiva, adolescência, políticas públicas	17	4
Saúde sexual, adolescência, políticas públicas	95	10
Saúde sexual, juventude, políticas públicas	5	5
Saúde reprodutiva, juventude, políticas públicas	5	2
Saúde reprodutiva, adolescência, políticas públicas	19	4

Descritores	Número de artigos em cada base	
	Portal de Periódicos da CAPES	Scielo
Saúde sexual, saúde reprodutiva, escola, adolescência, políticas públicas	4	1
Saúde sexual, saúde reprodutiva, escola, juventude, políticas públicas	1	0
Saúde sexual, escola, juventude, políticas públicas	2	1
Saúde sexual, escola, adolescência, políticas públicas	20	3
Saúde reprodutiva, escola, adolescência, políticas públicas	4	1
Saúde reprodutiva, escola, juventude, políticas públicas	1	0
Saúde reprodutiva, unidade de saúde, juventude, políticas públicas	0	0
Saúde reprodutiva, unidade de saúde, adolescência, políticas públicas	0	0
Saúde sexual, unidade de saúde, adolescência, políticas públicas	6	0
Saúde sexual, unidade de saúde, juventude, políticas públicas	2	0
Educação sexual, escola, juventude, políticas públicas	2	1
Educação sexual, escola, adolescência, políticas públicas	17	2
Educação sexual, unidade de saúde, adolescência, políticas públicas	4	0
Educação sexual, unidade de saúde, juventude, políticas públicas	0	0
Sexualidade, unidade de saúde, juventude, políticas públicas	0	0
Sexualidade, unidade de saúde, adolescência, políticas públicas	2	0
Sexualidade, escola, adolescência, políticas públicas	15	0
Sexualidade, escola, juventude, políticas públicas	3	0
Sexualidade, juventude, políticas públicas	0	3
Sexualidade, adolescência, políticas públicas	8	0
Adolescência, sexualidade, escola	184	12
Juventude, sexualidade, escola	48	3
Juventude, sexualidade, unidade de saúde	3	0
Adolescência, sexualidade, unidade de saúde	12	0

Descritores	Número de artigos em cada base	
	Portal de Periódicos da CAPES	Scielo
Saúde sexual, adolescência, unidade de saúde	68	0
Saúde sexual, juventude, unidade de saúde	1	0
Saúde sexual, adolescência, escola	215	13
Saúde sexual, juventude, escola	6	1
Saúde reprodutiva, adolescência, unidade de saúde	21	0
Saúde reprodutiva, juventude, unidade de saúde	1	0
Saúde reprodutiva, adolescência, escola	23	3
Saúde reprodutiva, juventude, escola	1	0
Total	819	72

Fonte: Elaborado pela autora

Os critérios de inclusão dos estudos foram: trazer os descritores ao longo do texto, ser uma publicação de livre acesso, tratar da temática no Brasil e ter sido publicado em revistas classificadas como de qualis A1 a A4. Como nosso objetivo aqui é destacar as formas que a temática vem sendo abordada no Brasil, não foram utilizados descritores em nenhum outro idioma e, estudos localizados na revisão sobre outros países foram excluídos de nossa análise. Dos 891 artigos, ao final da análise, foram selecionados 78 estudos, sendo 77 deles artigos. A diminuição do número de textos, além da falta de preenchimento dos créditos estipulados, se deu devido a artigos terem sido localizados em mais de uma das buscas com diferentes descritores e em ambos os portais de periódicos.

4.1 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL: ONDE ESTAMOS?

As discussões e autores(as) abordados a partir de agora são aqueles(as) identificados(as) na revisão narrativa da literatura. Os diálogos sobre juventude no Brasil andam lado a lado de debates acerca da sexualidade, principalmente trazendo preocupações em relação à gravidez "precoce", de "risco" e "indesejada" (Altman, 2009; Moraes; Ceccin, 2017), contrastando com a defesa pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos juvenis, que preza pela liberdade de escolha de cada um(a) em gestar ou não no momento em que considerar adequado.

Nestes últimos anos, no Brasil, identificamos inúmeros discursos em relação a gênero e sexualidade buscando “proteger” crianças e jovens, como destaca Leite (2019), ao tratar do

conservadorismo e moralismo que estão presentes nessas falas. Assim como Leite (2019), entendemos que a infância e a adolescência são cruciais para analisar os processos de transformação da política sexual brasileira, uma vez que estas populações estão no “olho do furacão” das discussões sobre sexualidade e gênero, sendo a escola um *locus* deste conflito.

Também, Acosta (2019) fala sobre o pânico moral (Bozon, 2004) em relação às formas de vivência da sexualidade e dos corpos dos(as) jovens que estão no centro da questão política brasileira e do conservadorismo no Brasil. No contexto da ascensão de um discurso conservador, tivemos a eleição para presidente de Jair Messias Bolsonaro, o qual propunha um discurso deliberado contra discussões de gênero e sexualidade nas escolas em sua campanha eleitoral.

Um ponto inicial que nos é caro nesta revisão: não foram localizados estudos que abordem a saúde sexual e reprodutiva de jovens concomitantemente no ambiente escolar e em unidade de saúde. Percebemos aí um espaço para atuação, podendo analisar cruzamentos entre as atuações de agentes de educação e de saúde, bem como entender melhor como os(as) jovens circulam nestes dois ambientes centrais para garantia de seus direitos sexuais e reprodutivos.

Ao mesmo tempo, essa via dupla estabelece um desafio na medida em que são espaços e profissionais com formações e atuações muito diversificadas, bem como o contato variado com jovens. A escola é um espaço primordial para que se discuta sobre saúde sexual e reprodutiva (Lopes, 2020), sendo um ambiente promissor para falar sobre práticas de saúde, uma vez que os(as) jovens acessam pouco esses serviços, segundo Conceição e Costa (2017). Este também é um fator muito percebido na Unidade onde foi feito nosso estudo. Logo, entende-se que escola e Unidade de Saúde podem exercer um trabalho de educação em saúde sexual e reprodutiva, que seja cooperativo e promotor de saúde e de discussões mais profícuas sobre a sexualidade.

Como foi possível observar no quadro três, a busca na literatura com o descritor “escola” resulta em maior quantidade de artigos do que com unidade de saúde. Da seleção feita, trinta e oito artigos se referem à sexualidade e ao ambiente escolar, enquanto seis se referem às unidades de saúde. Acreditamos que a grande mobilização, em torno das pesquisas na escola, se dá pelas crescentes discussões políticas, em torno do tema com a questão da “ideologia de gênero”, sempre em alta nos discursos da direita brasileira. Percebemos aqui uma lacuna para avaliar o trabalho de médicos(as), enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem e agentes comunitários(as) de saúde.

Como discutido no capítulo dois, temos como base teórica a burocracia de nível de rua, a antropologia das políticas públicas e a presença de mecanismos de governança no trabalho

dos(as) agentes de nível de rua. Nenhum dos estudos da revisão narrativa utiliza da antropologia das políticas públicas, apenas um estudo (Costa et al, 2022) aborda os(as) profissionais de APS com uma relação com as discussões de burocracia de nível de rua, trazendo a noção de categorização dos(as) agentes para com os(as) usuários(as) ao realizarem seu trabalho, o que será central a seguir, ao analisarmos o cotidiano das escolas e unidade de saúde onde foi desenvolvida esta pesquisa.

Apesar de nenhum estudo da revisão abordar a noção de mecanismos de governança, identificamos alguns que trabalham com Foucault em sua base teórica ao falar de sexualidade (Alegria, 2018; Nascimento; Cruz, 2018; Dornelles; Dal’Ignal, 2015; Carvalho; Almeida, 2021). A perspectiva foucaultiana foi central para a formulação da noção de Morgan e Roberts (2012) dos mecanismos de governança, na medida em que Foucault (1991) aponta para a noção de governança por meio do biopoder, através das relações entre poder e conhecimento. Assim, os mecanismos são construídos a partir de relações de poder que englobam normas e valores dos sujeitos em relação uns com os outros. No que tange a SSR, estas relações se dão entre jovens e profissionais da saúde e da educação de forma assimétrica e verticalizada.

Nesse sentido, apontamos que a sexualidade é um instrumento de regulação e normalização dos corpos e de desejos dentro da escola (Foucault, 1980) influenciando em planos de aula e regimentos escolares (Alegria, 2018). A escola, para Foucault (2001) é um lugar de coerção onde a sexualidade é constantemente policiada, como destacam Nascimento e Cruz (2018) e Dornelles e Dal’Ignal (2015). Já Almeida e Carvalho (2021) apontam para Foucault (1979) e os mecanismos de poder-saber, que agenciam os sujeitos em sua moral e nas normas a serem seguidas. As questões da sexualidade para Foucault (1988) foram e seguirão sempre sendo alvo de discursos disciplinadores e normatizadores, buscando controlar os corpos, seja na escola, na unidade de saúde ou em qualquer outro lugar. Os mecanismos de governança são, então, uma forma de podermos olhar com mais atenção para a sexualidade e os dispositivos que buscam controlá-la.

Outros aportes teóricos, que são centrais para nossa pesquisa, podem ser encontrados nos estudos que defendem a necessidade de mais discussões acerca da saúde sexual e da reprodutiva nas escolas ou em unidade de saúde, ultrapassando a barreira da focalização na reprodução masculina e feminina, e que apresentam resultados de práticas com jovens em escolas e/ou agentes em unidades de saúde e da escola.

Em seis artigos da revisão encontra-se a ideia de pânico moral, a partir da guinada de conservadorismo e discursos acerca da sexualidade juvenil como de “risco” e como um “problema”. O discurso do pânico moral reforça, que a sexualidade juvenil não deve ser

incentivada, o que interfere diretamente na forma com que a saúde sexual e reprodutiva é abordada na escola, sendo de forma majoritariamente biologicista (Leite, 2019; Heilborn, 2012; Paiva; Brandão, 2023; Checa; Scisleski, 2018; Nascimento; Cruz, 2018; Acosta, 2020). Acredita-se que a noção de pânico moral foi essencial nessa análise para explicar as falas e posicionamentos de profissionais de saúde e de educação, principalmente no que se refere ao “problema” da gravidez na adolescência, e, também, entender os mecanismos de governança reprodutiva utilizados por estes(as) ao lidar com jovens sem e com experiência reprodutiva.

Todas as discussões que envolvem saúde sexual e reprodutiva também estão entrelaçadas com as discussões de gênero, que aparecem na maioria dos artigos revisados. Scott (1995, p. 86) é citada em diversos artigos, através de sua percepção de gênero como “elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos”. Ou seja, o gênero é contextual e não universal.

Nesse sentido, Heilborn (2012, p. 65) destaca que “As relações de gênero encarnam formas desiguais de poder que assumem modulações específicas em cada esfera da vida e contexto social.” A mesma autora e colaboradores (2006) realizaram um amplo estudo no Brasil acerca da sexualidade juvenil, o qual é citado em diversos artigos da revisão, destacando, dentre outros pontos, a necessidade de políticas públicas que se centram nos(as) jovens e na promoção de seus direitos sexuais e reprodutivos, respeitando suas singularidades.

Também apontamos para o fato de a gravidez, na juventude, não poder ser *a priori*, vista como um “problema” ou uma “vida acabada” (Heilborn, 2012), uma vez que isso reflete os ideários de uma parte da população, que preza pelos estudos, trabalho e um tempo “ideal” para se gestar. Iremos discutir este pensamento, ao longo da tese, ao refletir sobre as falas de jovens e agentes acerca da reprodução e do fato de existir ou não um momento melhor para ter filhos.

Outra autora citada em diversos artigos é Louro (2000, 2004, 2008) e suas discussões, acerca do gênero, inclusive dentro do ambiente escolar, onde ele destaca construções culturais que normalmente mantêm o padrão heteronormativo. Logo, a escola é um lugar de controle e vigilância da sexualidade que, habitualmente, silencia outras orientações sexuais. Foucault (1989) também aparece como um autor que discute a escola como ambiente de controle dos corpos e sexualidades. Conforme Louro (2000), os discursos sobre a sexualidade encontram-se cada vez mais ligados aos apelos conservadores e à volta de um dito tradicionalismo. Aqui, entendemos que a sexualidade não é apenas algo pessoal, mas é social, cultural e político, sendo construída ao longo da vida dos sujeitos (Louro, 2012). Logo, a escola e a unidade de saúde são importantes espaços para essa construção.

Nesse contexto, os textos da revisão destacam que a vivência da sexualidade na juventude e as decisões que rondam essas experiências sexuais, principalmente sem uso de preservativo, são influenciadas diretamente por assimetrias de gênero (Silva; Borba, 2018; Barbosa et al, 2022a; Cid; Sousa; Duarte, 2020; Cedaro; Villas Boas; Martins, 2012; Oliveira; Fonseca, 2019; Ferrari; Peres; Nascimento, 2018), onde a mulher se submete aos desejos do homem ao mesmo tempo que ela “não deve ser fácil”, ou seja, não se relacionar com vários homens. Sem contar a responsabilidade de criação de filhos que fica toda - ou quase toda - a cargo da mulher.

Ademais, os textos da revisão (Silva; Borba, 2018; Barbosa et al, 2022; Cid; Sousa; Duarte, 2020; Cedaro; Villas Boas; Martins, 2012; Oliveira; Fonseca, 2019; Ferrari; Peres; Nascimento, 2018) apontam que tudo aquilo que foge ao padrão heteronormativo da binaridade de gênero é socialmente excluído. Estes pontos também serão observados nas escolas, principalmente nas rodas de conversa, em que as próprias alunas destacam que quem tem mais responsabilidade pelo filho é a mãe. Também, na unidade de saúde, quando o pai não participa de uma consulta sequer de pré-natal, por exemplo.

Outro ponto que nos é importante é o fato de diversos artigos (Mocelin; Rissotti; Nunes; Oliveira, 2024; Pariz; Mengarda; Frizzo, 2011; Guimarães; Cabral, 2022; Rohr; Schwengber, 2011; Bellenzani; Santos; Paiva, 2012; Bastos; Lüdke, 2017; Sena Filha, Castanha, 2014) destacarem a necessidade de analisar a gravidez na juventude inserida dentro de diferentes contextos, de forma multifatorial, que fogem à noção de um ideal ocidental branco de desenvolvimento linear do(a) jovem onde este deve terminar os estudos, trabalhar, casar e então depois ter filhos(as).

Isto porque o Brasil é um país de extrema desigualdade social, racial, étnica e de gênero, que demonstram a existência de diferentes noções de “planos de vida” e, que para algumas mulheres ter filhos é um desejo e as coloca em um lugar de importância dentro de suas comunidades. Assim: “A gestação entre as adolescentes, principalmente nas camadas de baixa renda da população, não condiz, necessariamente, com uma perda ou descontinuidade dos seus projetos de vida” (Sena Filha; Castanha, 2014, p. 86). Neste caso, a gravidez pode sim trazer resultados positivos e ser desejada por jovens como destacado: “Outra questão a ser levada em consideração, consiste no fato de que, nem toda gravidez na adolescência é indesejada. Levar em consideração tal perspectiva significa focar nos diferentes contextos que perpassam a vida do adolescente e os significados da reprodução entre as diferentes classes sociais.” (Mocelin; Rissotti; Nunes; Oliveira, 2024, p.10). E, para além de classes sociais, acrescento: contextos culturais, raciais e de gênero.

No outro extremo, alguns artigos incluídos nesta revisão seguem com uma visão unidimensional da gravidez na juventude como “indesejável”, de “risco” e um “problema” destacando justamente a “imaturidade” e a falta de estrutura dos(as) jovens (Nery et al, 2011; Barbosa et al, 2022; Lopes et al, 2020; Honorato, et al. 2024; Sá; Dutra; Aninger; Pereira, 2019). Esse discurso se assemelha muito com aquele presente nas falas dos(as) agentes com quem conversei ao longo da tese e que veremos na sequência como influenciam na implementação de políticas públicas.

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL

No que se refere à discussão sobre políticas públicas, dentre os artigos incluídos na revisão da literatura, não localizamos qualquer discussão teórica acerca de desenho, agenda, implementação, avaliação, entre outros. São poucos os artigos que discutem x ou y política. Num geral, os estudos destacam a necessidade de mais políticas, mas não aprofundam na temática, sendo isso discutido no final do estudo com frases apontando para a necessidade de mais políticas públicas, como Sena Filha e Castanha (2014, p. 87): “além de verificar-se a importância da formulação de estratégias na implementação de políticas públicas, de promoção e educação em saúde, com o intuito de minimizar o impacto biopsicossocial da gravidez na adolescência”. Mais uma lacuna evidenciada nos estudos que visamos trabalhar, destacando quais são as políticas que regem o trabalho de agentes de Porto Alegre, RS.

Para a tese, tem centralidade o Programa Saúde na Escola, PSE, criado em 2007, visto que ele é o principal meio de conexão entre escola e unidade de saúde, tendo a sexualidade como uma das possíveis temáticas a serem discutidas como apontam Campos e Silva (2014), Guimarães e Cabral (2022) e Silva et al (2018) em seus artigos, porém, sem aprofundar mais sobre o Programa.

Outro estudo que aborda políticas específicas é o de Paiva e Brandão (2023), que trata da chegada de Bolsonaro ao poder com um discurso pautado em moralismos e valores conservadores, que condenam a sexualidade juvenil a um lugar de risco e irregularidade, como também destaca Bozon (2009). Paiva e Brandão (2023) estudam as políticas sexuais naquele governo (2018-2022) e destacam a “preservação sexual” como (des)política pública de seu mandato.

As autoras dão destaque à criação da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, através da Lei nº 13.798/2019, e a primeira campanha da mesma, “Adolescência

primeiro, gravidez depois - tudo tem o seu tempo”. Esta campanha propagava a ideia de postergar as relações sexuais para evitar a gravidez, ou seja, promovia a abstinência sexual, ao mesmo tempo em que não informava sobre ISTs, uso de preservativos, ou qualquer outro método contraceptivo. A campanha tampouco abordava qualquer discussão relacionada a temáticas que englobam a gestação, como relações de gênero, por exemplo. Isso demonstra a onda de conservadorismo e o pânico moral que se instaurou no país e, possivelmente, em profissionais de saúde e de educação com quem dialogamos.

Nesta revisão, a maioria dos estudos são qualitativos, sendo que apenas cinco são quantitativos, dois são quantitativos e quatro deles são de revisão da literatura. A maior parte dos artigos contou com entrevistas, mas nenhum deles fez uso de entrevistas, tanto com jovens, quanto com profissionais da saúde e da educação, como fizemos aqui. Isso abre um espaço para analisarmos ao mesmo tempo como os(as) jovens constroem sua saúde sexual e reprodutiva, em escola e/ou em unidade de saúde, e como os profissionais se mobilizam nesta construção em uma relação dialógica.

Entendemos a centralidade de olhar para o público alvo das políticas e o que ele tem a dizer sobre as mesmas, em seus cotidianos, a partir da perspectiva da antropologia das políticas públicas (Shore; Wright, 1997; Wendel, 2005). Outros autores do campo de políticas públicas também dão destaque para a implementação como resultado das decisões dos(as) agentes em relação com usuários(as) (Bartels, 2014; Bruhn; Ekström, 2017; Raaphost, 2018). Assim, ao olhar para os(as) jovens conseguimos aprofundar ainda mais as discussões sobre o campo de implementação de políticas públicas.

Dentre os 78 artigos analisados, apenas cinco trouxeram abordagem etnográfica: Rohr e Schwengber (2011) analisaram os rastros da gravidez nas trajetórias afetivo-sexuais e escolares de jovens entre 2008 e 2009, a partir de observações prolongadas e entrevistas em profundidade; Bellenzani, Santos e Paiva (2012) analisaram o trabalho de agentes comunitários de saúde frente à saúde sexual e reprodutiva de jovens; Alegria (2018) realizou pesquisa etnográfica entre alunos(as) de movimento estudantil, de uma escola do Rio de Janeiro, analisando as experimentações da sexualidade destes; Carvalhaes e Cárdenas (2015) atuaram em uma pesquisa focada em violências sofridas por jovens, em relacionamentos onde os autores utilizaram da etnografia para acompanhar os intervalos de aulas da escola durante seis meses, e entrevistas com alguns(as) alunos(as); e Guimarães e Cabral (2022) analisaram atividades de educação sexual em escolas a partir das práticas de profissionais de saúde de US em São Paulo.

O que todos esses estudos com abordagem etnográfica têm em comum e que queremos, também, trazer para esta tese é um olhar atento para as pessoas participantes das pesquisas, sem

partir da premissa de que a gravidez na juventude é um problema ou que a sexualidade juvenil deve ser controlada. Na realidade, a etnografia busca aprofundar as narrativas dos(as) jovens e dos(as) agentes de saúde e de educação, acerca da sexualidade, bem como destacar as desigualdades de gênero em um diálogo crítico com as formas que a escola e a unidade de saúde abordam a saúde sexual e reprodutiva de jovens.

Centramos nosso olhar nos(as) profissionais destes dois ambientes, sendo que o trabalho deles(as) é condicionado pelas leis, normas e protocolos instituídos pelas políticas, mas, como já vimos, existem mecanismos de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012) que vão além dos documentos oficiais e se apoiam em valores e moralidades dos(as) agentes. Neste sentido, podemos pensar na ideia de categorização dos(as) usuários(as) dos serviços, por parte de agentes, como Costa et al (2023) fazem ao estudar HIV e juventudes em serviços de APS. Eles destacam que os(as) agentes fazem uso de suas percepções pessoais para criar categorias de usuários(as), o que pode, muitas vezes, aumentar desigualdades na implementação de políticas públicas (Pires, 2019) e reforçar estigmas em relação aos jovens.

Pensando nos mecanismos de governança reprodutiva, dialogamos com a noção de regimes morais dos(as) agentes que trabalham no cotidiano da APS. Queremos, na tese, olhar em que medida estes regimes aparecem nas ações de agentes e como influenciam nas relações com os(as) jovens e na implementação das políticas. Relações estas que desde já apontamos como relações sociais verticalizadas e assimétricas.

4.3 SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DOS JOVENS E A US

Na revisão da literatura foram encontrados apenas seis artigos que abordam a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens no ambiente de unidades de saúde, sendo esta uma lacuna importante para a nossa análise. Bellenzani, Santos e Paiva (2012) realizaram um estudo etnográfico com observações e entrevistas com seis agentes comunitárias que destacavam que eram “‘tantas as necessidades e as faltas’ para além do campo da saúde, que o lugar ocupado pela saúde sexual não era, definitivamente, um lugar de prioridade” (Bellenzani; Santos; Paiva, 2012, p. 641).

Ainda, as visões das Agentes acerca da sexualidade eram fortemente marcadas por valores pessoais e padrões heteronormativos de “certo e errado”, novamente remetendo para a noção de regimes morais (Morgan; Roberts, 2012). No estudo de Bellenzani, Santos e Paiva

(2012), os profissionais de saúde sempre associavam saúde sexual à mulher e raramente falavam com homens sobre a temática. Ademais, quando questionadas sobre as dificuldades enfrentadas pelos jovens, destacaram que os Agentes citavam a questão do “problema da gravidez na adolescência” (Bellenzani, Santos, Paiva, 2012).

Já Guimarães e Cabral (2022) realizaram um estudo etnográfico acompanhando ações de educação sexual organizadas por ACSs em uma US e em uma escola da periferia de São Paulo. Os resultados que as autoras chegam são muito similares àqueles que discorreremos adiante em relação à dificuldade de falar sobre sexo, à tendência de julgar comportamentos sexuais de jovens, a trazer comentários moralistas acerca dos comportamentos no serviço de saúde, à incompatibilidade entre as responsabilidades atribuídas pelos profissionais para cada gênero nas relações sexuais e à incompreensão de profissionais da escola e da US quanto a "pessoas tão jovens" quererem ter filhos. No nosso caso, "ela é só uma criança" é algo muito referido quando estes profissionais criticam o desejo das jovens de terem filhos.

Outro estudo que abarca profissionais de unidades de saúde é o de Sena Filha e Catanha (2014). Esta pesquisa é centrada nas representações sociais de profissionais de unidades de saúde sobre a gravidez na juventude e, apesar de nesta tese não focarmos nas representações, as autoras trazem um ponto central para a análise: o fato de estes(as) agentes terem sua formação acadêmica em um olhar técnico que se mistura com as visões presentes nas relações estabelecidas com os usuários, com seus valores e com suas moralidades, como já vínhamos discutindo sobre a agência dos(as) profissionais (Maynard-Moody; Musheno, 2022).

No estudo de Sena Filha e Catanha (2014), seus interlocutores expressavam no geral um pânico em relação à gravidez na juventude, o que pode ser pensado em termos de pânico moral de Bozon (2004). As autoras destacam que a maioria associa de forma negativa a gravidez na juventude, muito ligada ao risco, irresponsabilidade, imaturidade e problemas. Os(as) profissionais entrevistados na pesquisa de Sena Filha e Catanha (2014) também apontam que a falta de qualificação maior destes(as) acaba barrando a execução de trabalhos acerca da saúde sexual e reprodutiva.

Dentre todos os 78 estudos da revisão narrativa que abordam a perspectiva de jovens, apenas um deles tem como foco avaliar a vivência de mulheres quanto à contracepção no ambiente do serviço de saúde (Medeiros et al., 2016). Os autores identificaram que os serviços de saúde têm poucas relações com as jovens e destacam lacunas na falta de informação, orientação e meios de obter contracepção. O mesmo distanciamento que eu encontrei ao realizar minhas conversas com os(as) jovens de Porto Alegre. Nesse sentido, Medeiros et al (2016) nos ajudam a reafirmar a importância que os serviços de saúde têm para a garantia dos direitos

sexuais e reprodutivos juvenis e, conseqüentemente, o combate das desigualdades de gênero que circundam os debates em torno da sexualidade.

De início, a partir da literatura podemos destacar que os(as) jovens percebem uma maior necessidade de trabalhar educação sexual nas escolas, mas não se sentem confortáveis de conversar com professores(as) acerca da temática, percebem, em geral, a gravidez como um problema e têm medo. Um fato importante a ser destacado é que nenhum estudo aborda a percepção dos(as) jovens acerca de seus acessos à saúde, sendo as entrevistas e a observação do participante sempre vinculadas ao ambiente escolar. Esta é mais uma lacuna importante que esta tese preenche.

4.4 SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA JUVENIL NO AMBIENTE ESCOLAR

Tratando-se do ambiente escolar, o tema da sexualidade sempre foi tensionado em diferentes disputas, como destacam Demartini e Silva (2016) e Martin (2010), sendo que o moralismo e o conservadorismo político acabam afetando a forma com que o assunto é abordado em sala de aula, normalmente de maneira biologicista (Carvalho; Almeida, 2021). Paiva e Brandão (2023) também citam o crescimento do pânico moral em relação à sexualidade juvenil nos últimos anos.

Hoje a pauta conservadora e moralista vem crescendo como atestam Checa e Scisleski (2018) ao discutir o projeto de lei “Escola sem Partido” na Câmara Municipal de Campo Grande - MS, ou quando olhamos para o discurso de Bolsonaro acerca do “kit gay” (Paiva; Brandão, 2023; Leite, 2019) e sua disputa contra a “ideologia de gênero”, sendo este um dos pontos importantes para sua eleição.

De modo geral, as pesquisas sobre o ambiente escolar destacam a importância da educação sexual, defendendo a educação integral, e também os desafios que esta vem enfrentando como falta de qualificação e barreiras de professores(as) em conseguir tratar da temática (Cid, Sousa e Duarte, 2020; Seixas, Favaro, 2020; Demartini, Silva, 2016; Martin, 2010; Queiroz; Almeida, 2017; Borduque et al, 2024; Douglas; Pessoa; Cunha, 2020), sendo a educação sexual uma necessidade e um direito dos jovens (Amorim; Maia, 2012).

Algumas pesquisas citam formas de trabalhar a sexualidade, em sala de aula, a partir de abordagens diferenciadas como histórias em quadrinhos (Seixas; Favaro, 2020), criação de jogo aplicado (Tamashiro; Fonseca, 2020), atividades através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Amaral et al, 2015). Bastos e Ludke (2017) realizaram uma discussão

sobre o documentário “Meninas” de Werneck e trataram principalmente de gravidez na juventude e assimetrias de gênero. O mesmo fazem Oliveira e Fonseca (2019) ao discutirem a normatização de estereótipos como efeito discursivo do gênero nas concepções dos adolescentes, onde a natureza da mulher, como a emoção, deve ser controlada pelo homem. A hierarquia de gênero surge nos discursos dos jovens, inclusive, quando falam de relações sexuais onde a conduta seria do domínio masculino.

Outro estudo que mostra como a sexualidade pode ser trabalhada para além do aspecto biologicista foi o de Rezende, Ferreira e Vargas (2014) ao apresentar a comunidade virtual Sexualidade para garot@s do Portal EMdiálogo, espaço criado por um projeto de extensão e destinado para trocas entre jovens, que buscam entender mais sobre sexo e relações de poder e de gênero, fugindo dos aspectos biologicistas trabalhados majoritariamente em escolas. Nenhum(a) dos(as) jovens com quem dialoguei na minha pesquisa acessou alguma vez um canal de proposta semelhante na internet, apesar de alguns relatarem que usam o Google para tirar dúvidas quando pessoas próximas não conseguem lhes ajudar.

Silva, Dias e Bezerra (2021) organizaram trabalhos de língua portuguesa junto de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir de práticas de leitura, de análise linguística e escrita. Todas estas práticas diferem da realidade da maioria dos(as) alunos(as) que estudam sobre sexualidade, na escola no oitavo ano do Ensino Fundamental, e isso somente ocorre a partir do aspecto biologicista (Seixas; Favaro, 2020; Queiroz; Almeida, 2017; Rezende; Ferreira; Vargas, 2014). Também difere daquilo que observamos em nossa pesquisa: apenas professores de Biologia e/ou Ciências discutindo o conteúdo de forma biologicista sem tocar em temas para além dos perigos da gravidez na adolescência ou, no máximo, de ISTs.

Sabemos que a educação sexual, que nasceu no Brasil, é comumente restrita às aulas de Ciência e Biologia e as discussões sobre sexualidade continuam ocorrendo nessas disciplinas, em sua maioria (Almeida; Carvalho, 2021; Silva, 2015; Bastos; Lüdke, 2017; Campos; Silva, 2014).

Neste caso, as aulas costumam se restringir ao oitavo ano do Ensino Fundamental, quando os(as) professores(as) de Ciências adentram o capítulo, normalmente, intitulado “Reprodução humana”. Ali se discute em termos biológicos o que é um pênis, uma vagina e como ocorre a reprodução, e se discorre sobre prevenção à gravidez e ISTs. Nessas discussões, assim como pude observar nas escolas em que estive, não se abordam mais questões da sexualidade, que envolvem fatores psicológicos, culturais, sociais e históricos (Demartini; Silva, 2016; Almeida, 2015).

Nos artigos da nossa revisão, são poucos aqueles que atuam diretamente com a visão dos(as) professores(as) acerca do trabalho em saúde sexual e reprodutiva no ambiente escolar, sendo que nenhum deles aborda a perspectiva destes(as) profissionais como agentes de nível de rua, logo, pessoas que fazem a política pública cotidianamente.

Alguns estudos trouxeram percepções de professores(as) destacando, por exemplo, entraves no trabalho a respeito da saúde sexual e reprodutiva juvenil, como falta de maior aprendizado acerca da temática nos cursos de graduação, e de formação continuada sobre o tema da sexualidade (Martin, 2010).

Em outro estudo realizado com 27 professores, de uma escola estadual de ensino médio em Sorocaba, São Paulo (Queiroz; Almeida, 2017), também vimos similaridade com as falas dos(as) professores(as) com quem conversei nas duas escolas, no que se refere aos adolescentes com relação ao aspecto da sexualidade. Os dois grupos de professores dão ênfase às situações de gravidez indesejada e ao risco de contrair ISTs, trabalhando a sexualidade em sala de aula a partir de aspectos biologicistas. Este ponto de vista também é percebido em Pessoa (2020), ao destacar que a sexualidade é quase exclusivamente trabalhada na escola nas Ciências Biológicas onde se fala sobre a saúde sexual, reprodução humana e os aspectos fisiológicos do corpo.

A gravidez é de "risco" e é uma etapa de "vulnerabilidade", segundo professores(as) entrevistados(as) por Queiroz e Almeida (2017). Os(as) professores(as) em todos os artigos se referem sempre à gravidez como um problema e fator de “atraso” na vida dos(as) jovens, levando em conta suas percepções e embutindo-as nos diálogos com os(as) jovens (Queiroz; Almeida, 2017; Lima et al, 2022; Demartini; Silva, 2016; Almeida, 2015). Nesses contextos vemos profissionais que tentam dissuadir os jovens da ideia de gestar, e a isso chamamos na tese de micromecanismos de contenção reprodutiva.

Para além do discurso do problema da gravidez na adolescência, o estudo de Brandão e Cabral (2021) fala da coerção contraceptiva e métodos de LARC nas US. Um dos exemplos que Brandão e Cabral (2021, p. 2675) citam é “informações médicas parciais (vantagens do método e não seus efeitos colaterais)”, ponto que veremos muito ao longo da tese sendo praticado, cotidianamente, por profissionais da saúde e que aqui damos o nome de micromecanismos de coerção contraceptiva.

O trabalho de Silva (2015) atenta que apesar de a temática sexualidade estar incorporada no PCN, como tema transversal, devendo ser tratada por professores(as) de qualquer disciplina, normalmente são os(as) profissionais de Ciências e Biologia que ficam incumbidos da tarefa. Em 2009, Ribeiro (p. 138) já alertava para o fato de que “não há, ainda, por parte dos órgãos governamentais, ações efetivas de educação continuada e de formação de professores que

tragam a sexualidade para o debate”. Quase vinte anos depois desta pesquisa, Lima et al (2022) entrevistou 10 professores(as) sobre suas aprendizagens acerca da saúde sexual e reprodutiva, tendo sido destaque o fato de a maioria (80%) concordar que deveriam existir pessoas mais qualificadas que eles(as) para discutir educação sexual na escola.

Pensando na formação de profissionais, Silva et al (2018) aplicaram questionários com graduandos(as) de Biologia-Licenciatura, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social visando identificar como os cursos abordam a temática da sexualidade. Como já esperado, 95% dos alunos de Biologia já tinham tido contato com o tema na universidade, seguido por alunos de Psicologia (84,61%), Serviço Social (70%) e Pedagogia (53,33%). Mas, os(as) alunos(as) das três últimas graduações destacam terem visto a temática em disciplinas eletivas, ou seja, não é algo que todos(as) irão acessar. Ademais, os(as) estudantes de Biologia, ao aprenderem sobre sexualidade, o fazem quase que estritamente discutindo sobre reprodução.

O que a revisão da literatura tem a nos dizer sobre a visão dos(as) jovens acerca da saúde sexual e reprodutiva, seja no ambiente escolar ou em espaços de saúde? Reis, Rodríguez e Brandão (2024) compartilham resultados de uma pesquisa que entrevistaram 194 jovens entre 16 e 24 anos, tendo também chegado à conclusão de que as atividades sobre saúde sexual e reprodutiva acontecem raramente na escola e são focadas apenas nos aspectos biologicistas. Almeida (2015) chega na mesma conclusão ao entrevistar alunos(as) da periferia de São Paulo. Ainda, destacam-se as barreiras nos atendimentos de saúde “pouco permeáveis e compreensivos com a população juvenil” (Reis; Rodríguez; Brandão, 2024, p. 10).

Em questionário aplicado com 108 alunos(as) entre 15 a 22 anos, a maioria dos meninos (91%) e meninas (96%) defende que a escola deve abordar a saúde sexual e reprodutiva em sala de aula e, também, em média, metade deles(as) disse que já teve alguma atividade sobre sexualidade na escola (Lima et al, 2022). Estas duas descobertas do estudo também se aproximam dos meus dados de campo, onde jovens defendem mais atividades sobre sexualidade na escola e, em média, a metade deles(as) não se lembra de ter tido atividades sobre o assunto, no Ensino Fundamental ou Médio.

Outro estudo chega às mesmas conclusões e aponta que os(as) alunos(as) percebem de maneira negativa a gestação na juventude (Bastos; Ludke, 2017), assim como a maioria dos(as) estudantes com quem conversei na minha pesquisa. Ademais, Bastos e Ludke (2017), assim como eu, identificaram diferentes tratamentos de acordo com o gênero, sendo as mães muito mais cobradas que os pais por terem que ter "mais responsabilidade", assim como me falou uma jovem do primeiro ano da Escola A, certo dia no intervalo. Aqui já vemos micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Na mesma toada, Cid, Sousa e Duarte (2020) destacam que os jovens de terceiro ano de Ensino Médio apontam, dentre outras coisas, que jovens mulheres não "podem" ficar com vários rapazes, mas eles podem se relacionar com quantas quiserem sem sofrer estigmas. Para uma das alunas entrevistadas por Cid, Sousa e Duarte (2020, p. 81): "As mulheres não se libertaram totalmente, acredito que nesse ponto de vista os pais ainda hoje veem as mulheres como sexo frágil. A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, já o homem pode, e essas distinções estão bem presentes no nosso convívio" (Sandra, 16 anos, sem experiência reprodutiva).

Ainda, Almeida (2015) destaca que as(os) jovens que entrevistou apontam que "ser homem" é muito mais fácil e que "ser mulher" é mais complicado. Sá e Silva (2019) também relatam diferentes expectativas em relação ao gênero para meninos e meninas. Nesse sentido, voltamos o olhar para as discussões sobre assimetrias e hierarquia de gênero, refletindo sobre a própria visão dos(as) jovens acerca da sexualidade, onde entendem que para o homem é muito mais fácil exercer a sexualidade.

Monteiro, Gontijo, Facundes e Vasconcelos (2015) também chegaram à conclusão de que as jovens percebem a sexualidade mais livre para os homens do que para elas. Os primeiros são incentivados a ter heterossexualidade ativa, enquanto as segundas a terem sexualidade controlada por elas mesmas, por pessoas do convívio escolar e em casa.

Amorim e Maia (2012) realizaram uma pesquisa com 20 jovens entre 11 e 15 anos, buscando entender mais sobre seus conhecimentos acerca da sexualidade, sendo que um destaque interessante é que nenhum(a) deles(as) citou a escola ou a figura do(a) professor(a) como fonte desta informação, mas oito deles citam o diálogo com os pais. Em nossa pesquisa, também veremos a falta de diálogo com professores(as) e o entendimento dos jovens de que "na escola a gente não tem espaço para falar disso" (Suélen, 17 anos, sem experiência reprodutiva).

Na mesma linha Cedora, Villas Boas e Martins (2012) acompanharam 52 jovens entre sétimo ano do Ensino Fundamental e segundo ano do Ensino Médio em uma escola de Porto Velho, RO, sendo que apenas 2,9% disseram que recorreriam a profissionais de saúde para obter informações sobre sexo e a mesma porcentagem apontou que recorreria a um(a) professor(a), ou seja, um número muito baixo.

Nesse contexto, Savegnago e Arpini (2014) realizaram grupos focais com 15 jovens também do Rio Grande do Sul, mas de uma cidade interiorana, e chegaram a resultados muito próximos, destacando que os pais não são vistos pelas jovens como pessoas abertas para o diálogo, sendo que elas recorrem à mãe e, normalmente, estas enfatizam a prevenção e uso de

camisinhas. As autoras destacam hipóteses para a centralidade da mãe devido a ela exercer o papel de cuidado na casa e às diferenças de gênero na socialização referente à sexualidade, ponto este importantíssimo para observarmos na construção da tese. Logo, a vivência da sexualidade na juventude e as decisões que permeiam a iniciação sexual são influenciadas, como destacam Ferrari, Peres e Nascimento (2018), pelas relações desiguais e assimétricas de gênero.

O que vimos na grande maioria dos estudos da revisão narrativa foi o destaque dado à importância de se discutir a saúde sexual e reprodutiva juvenil, seja em sala de aula, seja na unidade de saúde. Os estudos analisados mostraram diferentes formas de se discutir a temática e/ou apontam a necessidade de aumentar discussões defendendo que os(as) jovens tenham seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos.

A revisão aqui feita deixou evidente diversas similaridades entre escolas, unidades de saúde e jovens, que veremos nos capítulos seguintes. Agora iremos ingressar na análise do nosso território de pesquisa, o qual entendemos ser necessário conhecer para, posteriormente, olhar para as políticas e cotidiano de atuação dos(as) agentes de saúde e educação.

5. “EU NÃO ME SINTO SEGURO DE ANDAR POR AQUI NÃO”

A frase que dá título a esse capítulo foi dita pelo enfermeiro Rafael durante conversa em seu consultório, e é repetida por quase todos(as) que trabalham na US, exceto as ACS. Este capítulo discute o território e como ele afeta o cotidiano das escolas e da unidade de saúde, entendendo que estes contextos importam ao discutir, por exemplo, porque os(as) jovens não acessam a unidade de saúde, procurando saber mais sobre sua saúde sexual e reprodutiva.

Sabemos que existem regras que organizam o espaço urbano em padrões de diferenciação social e segregação (Caldeira, 2011). O território é um local de poder, ele é “um

conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único na qual a história se dá” (Santos, 2004, p. 63).

O território é peça central para analisar o contexto de atuação dos(as) agentes, inclusive sua agência, e as percepções dos(as) próprios(as) jovens em relação à escola e à unidade de saúde. O território não é um mero espaço onde as coisas acontecem, mas também é um agente. O território se apresenta aqui como marcador social da saúde, de educação, de lazer, de acesso à cultura, de segurança e de possibilidades de trabalho.

As políticas de saúde e de educação destacam, ambas, a centralidade do território. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) menciona a importância de conhecer os territórios em que os(as) profissionais de saúde se inserem para entender as dinâmicas contidas nos territórios, que vão ter influência direta sobre a saúde da população (Brasil, 2017a). Da mesma forma, o Plano Nacional de Educação (PNE) cita a importância de conhecer o território em que a escola está inserida e realizar atividades, respeitando as identidades socioculturais de cada espaço (Brasil, 2014). Aqui, buscaremos conhecer o território da pesquisa, utilizando da observação de cunho etnográfico realizada através das conversas com jovens, agentes de saúde e da educação, bem como das entrevistas.

As primeiras incursões no território se deram ainda no segundo semestre de 2023, na US, com o objetivo de conhecer a unidade e estudar as possibilidades de realizar a pesquisa ali, enquanto nas escolas as conversas se estabeleceram a partir de janeiro de 2024. Importante destacar que esse primeiro momento foi de uma aproximação com o campo e a pesquisa de cunho etnográfico e teve início no final do primeiro semestre de 2024, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A seguir iremos discutir como se deu essa entrada em campo.

5.1 PASSOS INICIAIS DA PESQUISA DE CAMPO

A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre aconteceu no dia cinco de maio de 2024, dia que infelizmente ficou marcado na história de Porto Alegre. Foi o dia do início das enchentes na cidade. O Rio Guaíba chegou à cota de inundação neste dia e ao longo do mês atingiu a marca histórica de 5,37 metros, no Cais Mauá.

A cidade mudou totalmente de figura com este desastre climático em curso, sendo que eu me voluntariei durante todo o mês em abrigos pela cidade, assim como fizeram muitos porto-alegrenses ao longo do período. Além de estar envolvida com o voluntariado, fui impossibilitada de começar o campo de pesquisa, uma vez que as duas escolas onde iniciaria a pesquisa tiveram suas aulas suspensas. A escola B, inclusive, serviu de abrigo para pessoas e animais durante mais de um mês.

A US continuou atuando, mas num sistema de portas abertas durante todo o dia, recebendo pessoas de qualquer parte do município e os atendimentos de pré-natal foram suspensos para ter mais horários para atender a população desabrigada. Todo o serviço de saúde primário se mobilizou para atender as pessoas afetadas pelas enchentes, então o perfil dos(as) usuários(as) mudou muito, assim como o dos(as) profissionais da US, pois muitos(as) não tinham como se deslocar até a unidade de suas casas ou ficavam também em postos improvisados nos abrigos.

Dentro deste contexto de suspensão das atividades escolares, da suspensão de atendimentos na US de pré-natal, de descaracterização do serviço durante aquele mês de catástrofe, de dificuldade de deslocamento até o território e da minha concentração de esforços em tentar ajudar as vítimas do desastre, não foi possível começar antes o campo de pesquisa.

Em junho comecei a acessar a US e retomar o contato com as escolas, mas na US, aquele mês, ainda foi de muitos atendimentos para pessoas que não eram do território, com muitos casos de leptospirose e de pessoas que perderam tudo durante as enchentes. Meu campo se iniciou nesse contexto de uma tentativa de volta àquilo que considerávamos normal.

Os meus dias de junho a dezembro passaram a ser divididos entre US, escola A e escola B, em média de 12 horas diárias. Ali, realizei a observação de cunho etnográfico junto de diferentes agentes de saúde e de educação, além de jovens, sempre buscando atentar para como a saúde sexual e reprodutiva dos jovens estava sendo discutida.

Na US, meus primeiros contatos foram com duas ACSs, Fernanda e Carolina, as quais eu passei alguns dias acompanhando o trabalho e conversando sobre jovens, acesso à unidade, sexualidade e gravidez. Também iniciei, acompanhando o Grupo de Gestantes, espaço central para observar as discussões sobre saúde reprodutiva. O Grupo acontecia toda sexta-feira e era coordenado por Carolina e pela enfermeira Olívia. Conforme fui acompanhando Olívia, Carolina e Fernanda, aos poucos fui conhecendo e conversando com outros(as) integrantes das equipes de Saúde da Família (eSF) (há mais de uma equipe na US).

No serviço de saúde acompanhei as atividades de todas as equipes de Saúde da Família, desde técnicas de enfermagem a médicos(as), passando por todos os ambientes da unidade, da

recepção até o consultório de consulta. Participava de reuniões de cada equipe da US, de reuniões gerais da Unidade, de visitas domiciliares (VDs), de atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) e de reuniões distritais e de Conselho Local.

Foram raros os casos que não pude acompanhar uma consulta e quando acontecia era devido a ser uma consulta de saúde mental, que os(as) profissionais de saúde achavam melhor eu não participar. Eu costumava sentar ao lado do(a) profissional em um puff forrado com courino rosa - que inclusive ficou conhecido como “banco da Bárbara” - o que dava uma impressão de que eu era uma estagiária do local. As salas eram todas pequenas, então sentar numa outra posição, como, por exemplo, entre agente e usuário(a) não era fisicamente possível. E, sentar atrás dele(a) também considerava que poderia deixar os presentes desconfortáveis.

Cada um(a) me apresentava de uma forma nas consultas: “Essa é Bárbara, vai acompanhar nossa consulta hoje.” ou “A minha colega Bárbara vai nos acompanhar.” As pessoas apenas assentiam com a cabeça. Algumas vezes, enquanto o(a) médico(a) saía da sala, algumas pessoas perguntavam o que eu fazia e eu ia explicando toda a pesquisa. Certa vez, estava conversando com um médico sobre formas de me apresentar e ele disse: “Ih, até tu conseguir explicar para eles o que é um doutorado, já passou os 20 minutos de consulta” e deu uma risadinha.

De qualquer forma, eu sempre andava com meu crachá da universidade para identificação. Cheguei a perguntar para a gerência da unidade se era necessário usar outros equipamentos de proteção individual, mas ela indicou que não havia necessidade. Eu realmente apresentava toda a minha pesquisa e conversava mais com as pessoas que me perguntavam e, claro, com os(as) jovens que vinham em consultas na unidade.

Os dias mais produtivos eram aqueles que tinham consultas de pré-natal com gestantes jovens ou outras consultas relacionadas à saúde sexual juvenil, mas estas eram mais raras de acontecer. Logo após completar um mês de pesquisa na unidade, começou a ser organizada uma planilha com horários de consultas de pré-natal que médicos(as) e enfermeiros(as) deveriam preencher para controle das consultas, realização de testes, ida ao dentista, entre outros. Eu recebi acesso àquela planilha e ela facilitou minha organização para participar de consultas de gestantes. Mesmo que nos primeiros meses tal planilha não fosse preenchida com tanta assiduidade, consegui direcionar algumas consultas. Já no que se tratava de jovens homens e de jovens mulheres vindo por outras demandas, era a “sorte” do dia.

Já nas escolas, ao voltar para iniciar a pesquisa após as enchentes, a coordenação de ambas as escolas me colocou em contato com os professores de Biologia: “Ah, se tiver alguma coisa sobre esse conteúdo vai ser na aula de Biologia”, foi o que disse a coordenadora da escola

A. Na escola B, a diretora falou: “Não acho que vai ter muita coisa para ver, mas conversa com a professora de Biologia”. Eu acompanhava as aulas de Biologia do turno da manhã e do turno da noite em ambas as escolas. Também observava intervalos, conversava com outros(as) professores(as), coordenação da escola e, principalmente, com os(as) estudantes.

O fato de ser encaminhada de antemão para professores(as) de Biologia já é um indicativo de que a saúde sexual e reprodutiva das escolas não é abordada para além de seu aspecto biologicista. Minhas observações na escola A e na escola B ocorreram tanto nas turmas da manhã, quanto nas turmas da noite, sempre do Ensino Médio. Os professores e a professora de Biologia me apresentavam como pesquisadora e, aos poucos, os(as) alunos(as) se aproximavam mais de mim para entender o que eu fazia e dar as opiniões deles(as) sobre gestação, contracepção, ISTs e outros temas que iam surgindo em nossas conversas. Eles(as) acabavam me chamando diariamente de “profe”.

Neste capítulo traremos essas falas de jovens, de agentes de saúde e da educação que fizeram parte da pesquisa tanto concedendo entrevistas, participando das rodas de conversa, quanto dialogando comigo ao longo dos meses de observação, que fiz nos espaços. Lembramos que em se tratando das escolas, focamos nos três professores e na professora de Biologia dos locais, como mostra o quadro quatro.

Quadro 4: Características dos(as) professores(as) entrevistados(as)

Nome fictício	Raça/cor (autodeterminação)	Camada social (segundo IBGE)	Escolaridade	Reside no território	Idade	Escola
Monique	Branca	Camadas médias	Especialização incompleta	Não	38 anos	Escola B
Felipe	Branco	Camadas médias	Mestrado	Sim	50 anos	Escola A
Ricardo	Branco	Camadas médias	Especialização incompleta	Não	44 anos	Escola B
Gabriel	Branco	Camadas médias	Ensino Superior completo	Não	33 anos	Escola A

Fonte: Elaborado pela autora

Na US entrevistamos três técnicas de enfermagem, três médicos, uma médica, quatro enfermeiras, um enfermeiro e duas ACS. No quadro cinco podemos ver algumas de suas características.

Quadro 5: Características dos(as) funcionários(as) da US entrevistados(as)

Nome fictício	Função na US	Raça/cor (autodeterminação)	Camada social (segundo IBGE)	Reside no território	Idade	Escolaridade
Fernanda	ACS	Preta	Camadas médias	Sim	45 anos	Ensino Superior em andamento
Carolina	ACS	Preta	Camadas médias	Sim	33 anos	Ensino Técnico
Amarilis	Médica	Branca	Camadas altas	Não	29 anos	Ensino Superior
Cláudio	Médico	Branca	Camadas altas	Não	29 anos	Ensino Superior
JP	Médico	Branca	Camadas altas	Não	26 anos	Ensino Superior
Benjamin	Médico	Branca	Camadas altas	Não	28 anos	Ensino Superior
Rafael	Enfermeiro	Branca	Camadas altas	Não	33 anos	Ensino Superior
Polina	Enfermeira	Branca	Camadas médias	Não	26 anos	Ensino Superior
SRT	Enfermeira	Branca	Camadas médias	Não	29 anos	Ensino Superior
Olívia	Enfermeira	Branca	Camadas altas	Não	39 anos	Ensino Superior
Cássia	Enfermeira	Branca	Camadas médias	Não	27 anos	Ensino Superior
Maria	Técnica de Enfermagem	Preta	Camadas médias	Não	47 anos	Ensino Técnico
Ana	Técnica de Enfermagem	Preta	Camadas médias	Não	24 anos	Ensino Técnico
Sofia	Técnica de Enfermagem	Branca	Camadas médias	Não	29 anos	Ensino Superior em andamento

Fonte: elaborado pela autora.

Tratando-se das pessoas jovens, usuários(as) das políticas públicas, foram entrevistadas dez jovens mulheres com experiência reprodutiva. Segue o quadro com algumas características delas, sendo que todas são de camadas populares.

Quadro 6: Características dos(as) jovens gestantes e/ou mães entrevistadas

Nome fictício	Idade	Raça/cor (autodeterminação)	Nível de escolaridade	Ocupação	Relacionamento
---------------	-------	-----------------------------	-----------------------	----------	----------------

Camille	19	Branca	Ensino Médio completo	Desempregada	Solteira
Sabrina	20	Parda	Ensino Médio incompleto	Atendente de supermercado	Relacionamento sério com o genitor do filho
Letícia	18	Preta	Ensino Médio completo	Do lar	Relacionamento sério com o genitor do filho
Natália	19	Preta	Ensino Médio incompleto	Cuidadora de idosos	Relacionamento sério com o genitor do filho
Alice	16	Preta	Ensino Médio incompleto	Do lar	Solteira
Martina	17	Preta	Ensino Médio incompleto	Do lar	Relacionamento sério com o genitor do filho
Heloá	16	Preta	Estudante de Ensino Médio	Estudante	Relacionamento sério com o genitor do filho
Gabriele	18	Branca	Curso técnico	Desempregada	Relacionamento sério com o genitor do filho
Jasmin	19	Preta	Ensino Médio incompleto	Do lar	Relacionamento sério com o genitor do filho
Kailany	19	Branca	Ensino Médio completo	Serviços de limpeza	Solteira

Fonte: elaborado pela autora.

Além das jovens com experiência reprodutiva, cinco jovens mulheres sem experiência reprodutiva e cinco jovens homens também sem experiência foram entrevistados, conforme mostra o quadro sete.

Quadro 7: Características dos(as) jovens sem experiência reprodutiva entrevistados(as)

Nome fictício	Idade	Raça/cor (autodeterminação)	Nível de escolaridade	Ocupação	Relacionamento
Fabício	16	Parda	Ensino Médio em andamento	Vendedor de pulseiras de fabricação própria	Solteiro
Liz	16	Parda	Ensino Médio em andamento	Vendedora de crochê de fabricação própria	Solteira
Anderson	17	Parda	Ensino Médio em andamento	Estudante	Namora
Ella	17	Preta	Ensino Médio em andamento	Funcionária de supermercado	Namora
K	18	Preta	Ensino Médio em andamento	Estudante	Solteiro

Patrícia	18	Branca	Ensino Médio em andamento	Funcionária de lancheria	Solteira
Emanuel	19	Branca	Ensino Médio completo	Marceneiro	Solteiro
Morgana	19	Branca	Ensino Médio em andamento	Funcionária de supermercado	Namora
Lucas	20	Preta	Ensino Médio em andamento	Funcionário de loja de móveis	Namora
Franciele	20	Preta	Ensino Médio em andamento	Funcionária de supermercado	Solteira

Fonte: elaborado pela autora.

Após esse breve contexto dos(as) participantes da pesquisa, traremos um olhar mais atento para o território, entendendo que ele, tanto quanto características das pessoas participantes da pesquisa, são centrais para analisarmos como se discute a saúde sexual e reprodutiva com jovens em escolas e na US.

5.2 ADENTRANDO O TERRITÓRIO

Carmo e Guizardi (2018, p. 2) apontam que a vulnerabilidade está “não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos”. Ou seja, a vulnerabilidade é multifatorial e tentaremos dar um panorama da mesma nesta seção.

Relembramos que a vulnerabilidade financeira da população é o plano de fundo do território da pesquisa. A renda média da população do bairro é de 1,68 salários mínimos (Ferreira; Menezes, 2017). É observável que muitos moradores possuem empregos sem carteira assinada e muitos atuam em “bicos”. E é a renda que, muitas vezes, no sistema capitalista, determina nossa mobilidade, lazer, cultura, educação e saúde de qualidade.

Em conversa com Ana, técnica de enfermagem, que é responsável por organizar o Bolsa Família dentro da US, ela destaca que acredita que em torno de 90% das pessoas que acessam a US possuem algum familiar que recebe o Bolsa Família. São 3.000 pessoas cadastradas na planilha da US no que se refere a este benefício.

O bairro da pesquisa é considerado uma zona periférica de Porto Alegre e uma região estigmatizada pela população porto-alegrense por ser violenta e perigosa, muito associada ao

tráfico de drogas. Eu, inclusive, tinha essa mesma percepção antes de ingressar no campo e após ter feito a pesquisa, continuo considerando perigosa caso você não seja da comunidade ou da “vila” - como alguns(as) alunos(as) se referem - e não souber por onde andar. Durante sua entrevista, Alice, jovem de 16 anos que estava no puerpério, disse: “Pra mim é tranquilo essa questão de me sentir segura. Talvez seja mais nesse sentido, né, de tu ser de fora” (Alice, 16 anos, com experiência reprodutiva).

Quase sempre que se conversava sobre o território, tanto com professores(as), funcionários(as) da US ou jovens, o tráfico era uma das primeiras coisas que aparecia. Na US, certo dia estava conversando com a ACS Fernanda e ela me disse: “É, tem que ver se vão aceitar essa nova enfermeira que chegou, né? Se eles [se referindo aos traficantes] não quiserem, ela não fica” (ACS Fernanda). Logo, “penso que em algum momento alguém deve ter aceitado a minha pesquisa sem mesmo eu saber, pois senão não estaria aqui há meses já.” (Diário de campo).

Durante as rodas de conversa, ao perguntar para os(as) jovens sobre como circulavam no bairro, havia divergências quanto à segurança: “Ah, tem uma pracinha ali que é legal ir” (Igor, 16 anos, sem experiência reprodutiva). “Mas tu tá louco, ali é do lado de uma boca! [local de venda e consumo de drogas]” (Maria Alice, 16 anos, sem experiência reprodutiva). Em geral, as alunas tinham mais medo do que os alunos, apesar de ser de consenso de que à noite não se deve andar pelo bairro: “De noite é tenebroso” disse K (18 anos, sem experiência reprodutiva), aluno de terceiro ano do Ensino Médio, durante entrevista.

Os(as) estudantes adoravam me contar histórias sobre a violência do bairro: “Sora, semana passada a gente tava saindo da escola às 20:30 e uma esquina depois da escola um cara foi nos assaltar e a gente saiu correndo de volta pra escola, mas levou o celular de um. Onde já se viu assaltar um estudante? Pára, né?” (Enzo, sem experiência reprodutiva).

Nas entrevistas com os(as) catorze funcionários(as) que trabalham na US, apenas duas denotam andar sem medo pelo território. São elas as duas ACS que obrigatoriamente também moram no território e atuam na US há anos, uma há oito anos e outra há dez anos. Nos dias que se realizam visitas domiciliares, fica nítido o quão distante são os(as) funcionários(as) da comunidade. Têm eESF que só saem para o território com ACS, “pois não vou ficar me expondo nesse lugar que não conheço” disse para mim uma enfermeira que ficou apenas dois meses trabalhando lá.

Neste sentido, entendemos que o trabalho das ACS é central para ligar território à unidade de saúde, na medida em que faz mediações entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular, conhece a realidade da população e consegue, a partir disso, criar

vínculos mais fortes, inclusive afetivos, buscando aproximar as pessoas de estratégias para melhorar suas condições de saúde e trazer os(as) próprios(as) funcionários(as) da unidade para mais perto da população (Pinto et al. 2017; Bezerra; Feitosa, 2018). Segue trecho de entrevista com um médico:

O nosso território é um território bem complicado, desde que eu cheguei não teve nada, mas segundo as pessoas mais velhas já teve bastante coisa de tráfico mais intenso. Os jovens, atualmente, infelizmente a maioria é - bem, como que eu posso falar? - imerso nisso, a maioria por não ter nenhum tipo de outra oportunidade. Mas eu nunca tive uma paciente gestante que chegou e me falou isso do seu marido, meu namorado, aí eles não costumam falar. E, é difícil tu ver em consultas, vê se é ou não, é quase impossível, a gente não tem acesso do que acontece fora da comunidade, a não ser com as ACSs que falam que aconteceu tal coisa, vai ter briga. Esse tipo de coisa assim (Med. Cláudio).

Durante as entrevistas, os três médicos e a médica destacaram que só vinham trabalhar e voltavam para suas casas. Saíam no território apenas quando era dia de VD. Um dos médicos, inclusive, preferia sair em VD sempre de carro. No que diz respeito ao enfermeiro e a quatro enfermeiras, também destacam que saem pelo bairro quando é dia de VD. O enfermeiro Rafael me contou que uma vez foi correr pelas ruas paralelas da US, mas que “foi estranho, fiquei com medo.”

Temos a particularidade de uma enfermeira, Cássia, que foi criada nesse bairro, sendo que sua mãe reside a dois minutos a pé da US. Apesar de ela sair para fazer VD sem ACS, ela destaca: “Minha mãe nunca me deixou andar muito pela vila porque é perigoso, né? Mas eu conheço as pessoas sim, não vejo problema de andar enquanto estou no meu turno de trabalho” (Enf. Cássia).

Essa distância entre agentes de saúde e usuários(as) acaba não sendo somente física, mas de criação de vínculos e relações mais horizontais, o que é central na Atenção Primária à Saúde. A maioria dos(as) usuários(as) coloca o(a) médico(a) e/ou enfermeiro(a) num lugar muito diferente do deles e estes(as) colaboram para esta relação vertical que os(as) destaca como detentores(as) do conhecimento e da certeza sem, muitas vezes, ter espaço para o(a) paciente ser realmente ouvido em suas demandas, criar autonomia e construir momentos que possibilitem mudança de comportamento dos(as) usuários(as) (Faquinello; Carreira; Marcon, 2010). Se o(a) profissional não conhece a realidade da pessoa que está a sua frente, como realizar um atendimento que seja eficiente para ela? Por isso, um dos preceitos do SUS é a territorialização (Prado; Caetano, 2024; Alvarenga, Martins, 2010; Lotta, 2015).

A US organiza poucos momentos de integração entre unidade e território. Ações extramuros acontecem basicamente apenas saindo em VD, ou no Programa Saúde na Escola, o

qual, como veremos nos próximos capítulos, os(as) profissionais de saúde não têm grande interesse em realizar: “É como se esse fosse um mundo totalmente à parte do deles, chega e sai da unidade sem nem olhar para os lados.” (Diário de campo).

Certo dia, participei de uma formação com todos(as) os(as) funcionários da US chamada “Protocolo Acesso mais seguro”. O objetivo da formação era criar um protocolo de ações da US em relação ao que acontecia no território, sendo as classificações verde, amarelo, laranja e vermelho. A ideia era “minimizar as situações de violência com vocês e criar planos de contingência, já que é importante ter uma rota de evacuação no território de vocês”, disse a funcionária da prefeitura que ministrava a atividade. Na sequência ela disse: “Tem que ser quando vocês percebem que não é seguro mesmo circular pelo bairro.” Uma enfermeira respondeu baixinho para o seu grupo: “Ah, então nunca, né?” Fato este que gerou risos entre os colegas de trabalho.

Nas escolas, a visão dos(as) professores(as) não difere da vista pelos funcionários do serviço de saúde. Tratando-se de insegurança, os(as) professores da escola A relatam que estão num espaço “muito perigoso”, “só vou pra escola e volto pra casa” e “não dá pra ficar bobeando, ainda mais de noite”. O professor Felipe dá aula há anos na escola A e faz cinco que está morando no bairro para ficar mais fácil seu deslocamento. Eu perguntei certo dia se ele conhecia o território e ele: “Não, eu não saio assim, o máximo que vou é no mercadinho da esquina e volto. Só moro aqui porque é mais perto do trabalho, mas não tem segurança, não.”

Os professores da escola B têm relatos, que apontam para a noção da violência no bairro, mas não tanto nos arredores da escola. Porém, sabem que existem alunos(as) com envolvimento no tráfico e/ou famílias envolvidas e que a violência influencia sim na vida dos(as) estudantes:

Então eles se preocupam muito. Tu vê que quando tem essa questão de guerra de facções, eles querem ir embora mais cedo. Eles já nem vêm. E eles moram em lugares também muito, não só os que são inseridos, mas os demais que moram próximo ou que moram dentro dessas vilas... Eles ficam bem atentos, eles ficam preocupados, eles ficam nervosos (Prof. Monique).

No que se refere a como os(as) jovens percebem seu território, em roda de conversa do terceiro ano do Ensino Médio da escola A, André (18 anos, sem experiência reprodutiva) falou: “Eu acho que é perigoso, assalto, essas coisas, mas não tráfico.” Ao que o colega retrucou: “Sim, mas tu acha que te assaltam por quê? Pra comprar bala no mercado? Tá tudo interligado.” (Caique, sem experiência reprodutiva). Ao que alguns(as) colegas concordaram e André mesmo se convenceu: “É, é uma bola de neve.” (18 anos, sem experiência reprodutiva).

A maioria dos(as) jovens me contavam que tinha pelo menos uma pessoa da família que era envolvida com o tráfico, apesar de eles(as) próprios(as) não serem. Vi vários jovens de catorze, quinze e dezesseis anos pelos becos atuando como “aviõezinhos” (pessoa que observa o local e passa informações relevantes aos traficantes) e cuidando de “bocas” (pontos de venda de drogas), mas apenas um dia conversei diretamente com um jovem que atua em uma “boca”:

Hoje eu estava com a Carolina no posto de saúde e ela me convidou para ir fazer uma VD com ela que ela tinha que deixar uma receita para uma senhora. Passamos por um beco que é ponto de venda de drogas e sempre quando passo por ali, só passo acompanhada dela. Quando estávamos passando, um dos meninos que é aviõezinho nos parou e tinha uns 14 anos, ele pediu para Carolina: "Tia consegue um curativo para mim? Eles me pegaram e bateram na minha cabeça." Então ele mostrou o galão que tinha na cabeça e também partes da perna com cortes. Carolina pediu se ele não conseguiria ir para o posto para o médico examinar que o ferimento era profundo e ele disse "Tô foragido, não posso". Então Carolina começou a explicar que no Posto de Saúde ninguém ia falar nada para polícia, que ninguém ia registrar em uma ficha, mas mesmo assim ele continua dizendo que não. Então ela falou que ia pegar um curativo para ele e também dipirona. Ele disse: "Obrigado tia, obrigado por cuidar tanto da gente. Obrigado." Depois voltamos e o jovem agradeceu a ACS e ela ainda falou que pegou a receita no nome de outra pessoa para ele não ter medo. Ele quis dar R\$20,00 para ela e ela disse que não queria. Daí ele disse: "Pega tia. Aqui nós estamos na boca. E se alguém pensar em fazer mal para a senhora, morre." Ela agradeceu e voltamos. Depois ela me disse: "Só estava fazendo meu trabalho, cumprindo o princípio de equidade e de universalidade porque o SUS é para todos." Ela falou: "tem mais uma outra palavra que eu esqueci o nome agora além de universalidade e de equidade. Eu disse: “integralidade?” E ela: “Isso, isso.” Eu tive a sensação de que logo mais esse menino seria morto por uma bala assim como tantos outros jovens pretos de periferia ligados ao tráfico (Diário de campo).

É um trecho longo do diário de campo, mas que traz pontos centrais: a vivência de jovens alicerçados pelo tráfico, a possibilidade de morte iminente desses rapazes, a impossibilidade deles terem acesso à US, o importante papel da ACS, buscando ligar território e unidade, e sua fala sobre os princípios do SUS, que ela tentou cobrir da melhor forma possível. Ao refletir sobre esse contexto, trazemos afirmação de Silva e Oliveira (2015, p. 14):

A existência de deficiências e barreiras de acesso dos jovens pobres à educação e ao trabalho [...] nos campos da saúde, lazer e cultura, contribuem para o agravamento da sua situação de vulnerabilidade social. Sem escola, sem trabalho ou com inserção laboral precária, os jovens ficam mais desprotegidos e, consequentemente, mais expostos, por exemplo, à cooptação pelo crime organizado.

Nesse contexto de falta de oportunidades destacada pelos autores, Fernanda, ACS, aponta o seguinte:

Na questão do tráfico, eu acho que não são todos, mas é bem dividido, assim. Tem aquele jovem organizado, que eles são focados, assim, que nem eu digo, assim, que tem uma estrutura melhor de família, um vínculo melhor, que são organizados em estudar. E focados a, que nem eles dizem, crescer, enfim, na vida, serem alguém. E tem os que estão aí, daí esses, né, acabam se transformando. Acabam sendo aliciados pelo tráfico, querem festa, querem curtidão e acabam, né, ficando aí pelos territórios. Esses são os dois perfis, assim, do território, assim, de juventude, assim. Tem os que estão focados ali, estão ali estudando, fazendo curso, estão crescendo, estão avançando, estão até saindo do território. E tem os que ficam aí pelo território. Estão mais focados em festa, estão mais focados em curtidão, em grupinhos. E acabam ficando (ACS Fernanda).

Aqui, quem consegue “avançar” está “até saindo do território”, segundo a ACS, ou seja, está transpondo a barreira invisível da periferia e se distanciando do tráfico. Durante meu tempo no bairro, teve jovem que contou sobre o pai do filho ser traficante e estar preso, jovem que me falou sobre marido que saiu do tráfico para formar família com ela, pessoas falando de tio, de primo e outros parentes próximos ligados ao meio.

De toda forma, não devemos objetivar o tráfico presente na vida de toda a população como já fez a coordenadora de uma escola próxima da US ao dizer: “Ah, aqui 95% dos alunos são ligados ao tráfico” (Sabrine). Quando contei sobre essa conversa para ACS Carolina ela retrucou:

É, eu acho que ele [tráfico] é muito presente. [...] Todo mundo tem envolvimento com tráfico? Às vezes não tem. Tem conhecimento? Sim. A gente conhece, a gente sabe onde vende, na esquina da nossa casa, na outra quadra, a gente tem uma noção de quem tá ali. [...] Então, assim, ó, eu vou te dizer que não, não é 90%. Eu acho que é bem menos, bem menos mesmo, mas é esse preconceito que eu te disse, de dentro da comunidade” (ACS Carolina).

Nesse momento da fala de Carolina, vemos que ela se coloca no lugar de moradora, além do de funcionária. Ela critica os colegas de trabalho que generalizam e acham que todos são ligados ao tráfico ao mesmo tempo que tem ciência da força do mesmo no território. Essa estigmatização dos moradores afeta mais ainda os jovens que são rotulados de antemão como “envolvidos”.

Podemos aqui pensar na noção de território conflagrado, que segundo Costa, Baptista, Cunha (2022) teria características muito similares com as do nosso estudo: território com presença de violência armada, sob domínio do tráfico, localidade com fraca presença do Estado, mostrando a precarização dos serviços públicos e a falta de segurança pública, sendo que, quando esta se apresenta, é como segurança armada e violenta. A ideia de território conflagrado inclui “os processos que se desenvolvem nestas localidades e a sobreposição de violências,

abrangendo as produzidas por políticas e agentes públicos e não somente as relacionadas aos ilegalismos” (Costa; Baptista; Cunha, 2022, p. 981).

Nesse sentido Jasmin - mãe de Luan e grávida do segundo filho, 19 anos, preta e de camadas populares - falou em entrevista sobre a segurança armada e violenta:

Sim, volta e meia, volta e meia acontece algo assim [tiroteio], é, daí muitas vezes tu não tem segurança da polícia porque a *polícia aparece aqui quando quer, né!? Tipo, vai ali onde que eu moro quando quer, tipo, é raro assim eles irem. Aí quando eles vão, eles querem incomodar todo mundo, até os moradores, né, eles vão incomodar até os moradores, que às vezes não têm nada a ver, eles vão assim* (Jasmin, 19 anos, com experiência reprodutiva, grifos meus).

A segregação socioespacial de recursos materiais, imateriais, públicos e privados, conforme Almeida (2023) destaca, fixa diferenças entre localidades e cria estigmas entre os moradores de cada área. Certa vez, a ACS Fernanda me contou que muitos(as) moradores(as) do bairro não falam que residem ali, pois as empresas não costumam aceitar quem é do local. Aqui, a citação de Galvão et al (2022) nos parece muito propícia:

Morar em um bairro periférico representa, portanto, muito mais do que apenas ser segregado, significa ter oportunidades desiguais em nível social, econômico, educacional, de renda e cultural. Isto quer dizer que os habitantes de um território marcado por vulnerabilidades apresentam condições limitadas de ter acesso a avanços sociais e econômicos (Galvão et al, 2022, p. 10).

Nesse contexto, ao conhecer a escola que fica ao lado da Unidade de Saúde pesquisada - escola esta que não se encontra entre as escolas de minha pesquisa por ser apenas de Ensino Fundamental - uma supervisora me disse algo que dialoga com a fala da ACS Fernanda: “Esses alunos nascem, crescem e morrem aqui no bairro. É muito difícil sair daqui.” Mais adiante na pesquisa de campo, uma professora disse no intervalo: “O mais comum é que nossos alunos virem empacotadores de algum mercado do bairro.”

No final de 2024, fiz um passeio com as turmas do terceiro ano do Ensino Médio da escola B, era um passeio de comemoração da formatura que tinham ganho da escola. Fomos até o zoológico de Sapucaia do Sul, cidade próxima. Uma aluna me disse, toda animada, durante o passeio: “Eu tô achando incrível, nunca tinha ido antes para um zoológico. Não costumo sair muito do bairro.” Conversando com a professora que organizou o passeio, ela apontou: “É, é muito bom poder fazer isso porque eles quase nunca saem do bairro. Então eles gostam muito.”

Realmente, ao conversar com os(as) jovens sobre sua sociabilidade e o que gostam de fazer no território, eles(as) citam um bairro vizinho - também considerado periférico - como local para ir em festas. Além disso, restam os campos de futebol, as pracinhas ou as próprias

casas para realizar “sociais”. Não apontam para o cinema, museu ou outros espaços de lazer, esporte e cultura fora do território.

Alguns dos(as) próprios(as) alunos(as) falam na palavra “oportunidade” que Galvão et al (2022) apontam: “Falta mais oportunidade de a gente fazer uma coisa diferente e, quando tem, acontecem esses babados aí.” (Vitor, sem experiência reprodutiva). O aluno se referia a um teatro que estavam organizando na escola A e que foi barrado pela direção, segundo me contaram durante a roda de conversa, devido a estarem ensaiando durante o período das aulas.

Outro exemplo é que apenas uma jovem entre 20 entrevistados(as) possui uma atividade regular de prática esportiva com treinos semanais fora do território da pesquisa. Liz tem 16 anos, é parda, de camadas populares e estuda na escola B. Ela pratica *ballet* cerca de quatro vezes na semana, mas relata que é muito difícil se manter financeiramente na atividade e que faz blusas e acessórios de crochê para conseguir ajudar os pais a pagar a escola de dança.

É quase como se houvesse uma barreira intransponível entre a periferia e a cidade. Mas o que consideramos aqui como periferia? Concordamos com Santos (1979) ao destacar que a periferia não é definida por distância física com o centro, mas em termos de acessibilidade e possibilidade de usufruir de bens e serviços. Para ele, não ter acesso a estes bens e serviços é suficiente para repelir o sujeito e confirmar sua situação periférica.

Jesus (2021, p. 64) aponta que os(as) moradores(as) de periferia sofrem estigmas que ferem suas experiências morais, o que cria “uma classe de pessoas com base no local em que vivem e naquilo que intrinsecamente se atrela a esse referencial, modulando sua inserção social, suas oportunidades e sua (in)visibilidade.”

Se falamos de invisibilidade, devemos tratar também da vulnerabilidade territorial e da pouca presença de serviços públicos no território em questão. Ali temos duas escolas de educação infantil (sempre com fila de espera, que gira em torno de um ano), três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), uma Associação de Moradores (que já foi mais ativa no passado), duas escolas de Ensino Fundamental e duas de Ensino Médio (que são a escola A e B, onde realizamos parte da pesquisa).

Muitos(as) profissionais da Unidade comentam que as pessoas que a frequentam são “hiper usuários(as)” do local. Sobre isso, uma técnica traz:

É isso aqui que é a rotina deles. Porque é questão de vulnerabilidade, falta de acesso, de, enfim, sim, lazer, cultura, não têm. Não tem nada então, eles não têm nada. Então a única coisa, o hobby deles é o posto. O nosso hobby é outras coisas, né, enfim, que a gente tem acesso, mas o hobby deles, às vezes, é vir aqui no posto. Não se importa nem de ficar duas horas esperando pra verificar uma pressão, porque eles gostam de

vir aqui, às vezes, até pra conversar, pra alguma coisa e ficar por aqui pra ter algo pra fazer (Téc. Enf. Sofia).

A Unidade de Saúde, nesta perspectiva, torna-se um local de sociabilidade destas pessoas adultas e/ou mais idosas. O mesmo não acontece com os(as) jovens, sendo a escola o principal espaço de sociabilidade deles(as). A falta de investimento público em territórios periféricos não é de hoje. As disputas em torno de melhorias no território são acirradas e muitas vezes, as disputas por incrementos, são reduzidas no discurso político e social (Bittencourt; Farias, 2021) onde os grupos periféricos acabam sendo invisibilizados.

Particpei de algumas reuniões do Conselho Local de Saúde, que acontecem mensalmente na US. Durante uma em específico estavam duas ACSs, a gerente da Unidade, eu e uma moradora do bairro. A senhora falava indignada: “Sempre que a gente vai para essas reuniões maiores, as Distritais, ouvem falar de outros bairros, mas o nosso nunca. Sempre esquecem da gente como se aqui não tivesse um monte de problema para resolver.” Todos concordam com a fala dela.

Diversas vezes, a ACS Carolina comentou comigo sobre a expansão da Unidade de Saúde, que deveria se mudar para a rua lateral, e o atual espaço da Unidade viraria um CRAS, “Mas a última vez que eles vieram ali arrancar a árvore, eu estava grávida. Já tem sete anos. Então, assim, é muita lenga lenga, né. [...] Sim, é para vir, mas quando? Não tenho certeza. Então, quem sabe os filhos dos meus filhos verão” (ACS Carolina). Outras pessoas também comentam com desesperança sobre “a construção prometida”, como se referiu ACS Fernanda.

Certo dia a gerente destacou: “É faltoso de dispositivo social no território. Ali é o local que eles têm e eles sabem que vai ter atenção. Porque é onde eles têm pra ir. A gente é tipo um castelinho dentro do território. O usuário só tem nós. Eles não têm praça, não têm academia pública, não têm nada.” (Débora).

Se formos falar em oportunidades para além da escola, os(as) jovens com quem eu conversava apontavam que alguns(as) participaram da Sociedade de Assistência Social e Educacional (SASE) quando eram mais novos, mas em referência a um outro centro cultural ou um centro de aprendizado com oportunidades de cursos técnicos, por exemplo, não existe. Pouquíssimos alunos(as), talvez 15% deles(as) faziam algum curso extra ao horário escolar e normalmente faziam, pois tinham ganho bolsa de estudos.

Dos(as) jovens que conversei no terceiro ano do Ensino Médio, são poucos os que me falaram sobre prestar vestibular, e acredito que muitos não saibam o que é uma universidade. Na escola B, apenas trinta alunos(as) das cinco turmas de terceiro ano do Ensino Médio, em média de 150 alunos matriculados, se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM) e têm interesse em prestar vestibular. Um professor da escola A me disse que faz cerca de quatro anos que não vê nenhum(a) aluno(a) dali ingressar na universidade. Ou seja, a faculdade é uma realidade muito distante da deles, não geograficamente falando, mas financeira, social e culturalmente.

Para muitos(as) dos(as) jovens da comunidade, o estudo termina quando se conclui o Ensino Médio. Certo dia, acompanhando a abertura de um pré-natal de uma jovem de 19 anos, na US, a enfermeira lhe perguntou se ela estudava ao que recebeu a seguinte resposta: “Não, já me formei no Ensino Médio, já terminei os estudos.” (Vivian, com experiência reprodutiva). Em conversas pela escola com outros(as) jovens, eram poucos(as) que falavam sobre fazer faculdade e alguns(as) que falavam em cursos técnicos: “Ah, eu vou terminar a escola e daí deu, né, sora? Chega de estudar.” (Tiago, sem experiência reprodutiva).

Sobre inserção no meio acadêmico, vale falar que houve uma vinda da UFRGS para a escola B com representantes falando sobre o vestibular e como essa universidade “era para eles.” Tenho ressalvas quanto a essa afirmação, visto que a inscrição para o vestibular por si só é de R\$ 120,00 - apesar de ser possível conseguir a gratuidade preenchendo certos documentos -, o nível de dificuldade do vestibular é muito elevado e a instituição possui diversos cursos diurnos que impossibilitam a manutenção de alguns empregos.

Assim, se coloca uma grande distância entre a instituição e os(as) jovens, a qual, novamente, não é territorial num sentido de quilômetros, mas é territorial no que toca o acesso à educação de qualidade, à cultura, ao lazer, às oportunidades, se tornando uma distância social. Se fosse apenas uma questão de distância física, um dos *campi* da UFRGS fica próximo à escola B, mas mesmo assim nenhum(a) aluno(a) nunca havia ouvido falar sobre a instituição. Invisíveis à universidade e vice-versa.

O professor Felipe relatou que é muito raro ver um aluno ou aluna que conseguiu ingressar na faculdade. Ele disse: “Mas a gente tem que se apegar àqueles alunos que querem prestar atenção, que tu vê que tem algum futuro. Normalmente tem uns três desses por turma.” (Prof. Felipe). Ao final da nossa entrevista ele ficou melancólico ao começar a falar sobre o futuro dos(as) jovens que, segundo ele, provavelmente seria seguir no bairro sem dar sequência aos estudos.

Tratando-se do ensino, conforme Ben Ayed e Broccolichi (2008), as desigualdades educacionais estão associadas à segregação das populações, ou seja, não é só o território onde moram pessoas, mas é um lugar que expressa propriedades sociais, econômicas e culturais. Temos um exemplo prático em relação à educação com as próprias escolas onde esta pesquisa se desenvolveu. Como veremos, a escola A fica no meio da vila, próxima de diversos pontos de

tráfico, bem “na boca”, como jovens falam. A escola B fica na divisa entre este bairro e outro em uma avenida movimentada da cidade. Apesar de ainda ser uma região vulnerável não é “no meio de tudo aquilo”, como disse a professora de educação física que dá aula nas duas escolas.

Muitos(as) dos(as) jovens do território acabam não frequentando as aulas do Ensino Médio. Não obtive acesso ao número total de desistências de alunos(as) por escola em 2024, mas a diretoria da escola A afirma que as turmas costumam iniciar com 30 estudantes e metade destes(as) permanecem até o final do ano. Na escola B, o nível de desistências me parece um pouco menor, iniciando com 30 alunos e finalizando com, em média, 20 por turma. Um fator central para entender isso é, agregado à necessidade de trabalhar, uma falta de perspectiva de futuro, através da escola e a insatisfação destes(as) com o ambiente educacional.

Tanto alunos(as) da escola A quanto da B compartilham destes sentimentos, apesar de na A eles serem mais eloquentes. Reclamações acerca de professores(as) que “vivem faltando, não querem dar aula e não tão nem aí pro aluno” (Caíque, sem experiência reprodutiva) são frequentes. “A gente também não aprende nada útil pra nossa vida. E essas trilhas de aprendizagem, mó furada, uns conteúdos nada com nada.” (Flávia, sem experiência reprodutiva).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira mediu em 2024 a taxa de distorção idade-série por escolas e a Escola A possui taxa de 50,4% no primeiro ano, 36,5% no segundo ano e 33,3% no terceiro ano do Ensino Médio. Já a escola B possui 44,7%, 33,1% e 37,5% correspondentemente (INEP, 2024). Ou seja, os dados mostram que uma parte considerável dos alunos está com atraso nos estudos. Isso pode indicar problemas de qualidade educacional, dificuldades socioeconômicas e evasão, que dificultam a continuidade e o sucesso escolar no ritmo esperado.

Outro dado para termos um panorama das escolas do território é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Ele mede a qualidade do ensino no Brasil, combinando dados sobre taxa de aprovação escolar, com resultados em exames padronizados (Saeb e Prova Brasil) sendo 10 a maior nota. O último cálculo do Índice apontou que a escola B possuía índice de 4,5 em 2021 e a escola A não teve resultados divulgados nesta pesquisa (INEP 2021). O último índice da escola A foi avaliado em 2015 com um IDEB de 2,6 e nesta ocasião, o IDEB da escola B era de 3,1 (INEP, 2015). Acerca da possibilidade de aprendizagem:

As crianças (e jovens) que passam a desfrutar de um ambiente escolar mais estruturado e qualificado dispõem de melhores condições para se desenvolver, mas se continuam chegando a suas casas e convivendo em ambientes insalubres e sem espaço adequado para o estudo, ou se não dispõem de espaços de convivência e lazer estimulantes e

seguros em seu tempo livre, essa oportunidade de melhoria de desenvolvimento tem uma chance muito menor de se materializar (Almeida, 2023, p. 43).

Aqui, como exemplo, vale apontarmos para a pandemia de COVID-19 e, mais recentemente, as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Os(as) jovens com quem conversei estavam no Ensino Fundamental em 2020 e 2021 e me falaram sobre o período da pandemia: muitos(as) relatam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem não tendo acesso à internet em casa, ou tendo apenas um dispositivo móvel para visualizar os conteúdos divididos entre todos da família. Buscar o material na escola era a saída mais viável para a maioria.

Durante as enchentes de maio de 2024, em Porto Alegre, a escola B serviu de abrigo e ficou um mês com as atividades suspensas. Nesse período, os(as) professores(as) deveriam disponibilizar material on-line, mas os(as) estudantes destacaram a dificuldade de acesso e, quando conseguiam acessar, apontavam para poucos conteúdos ali. O professor Ricardo apontou: “É, ali foi um mês perdido, não teve o que fazer. Não tem como os nossos alunos terem aula on-line.” (Prof. Ricardo).

Relacionando território e educação, ainda devemos falar da dificuldade dos(as) alunos(as) do turno da noite da escola A e da escola B no que tange o tempo de aula. Os alunos do turno da manhã costumam sair mais cedo para poder trabalhar e/ou devido à falta de professores(as). O professor de Biologia da manhã da escola A disse que tem uma turma que ele nunca consegue lecionar, pois só tem um período e é o último do dia, ou seja, os alunos daquele segundo ano não tiveram uma aula de Biologia, pelo menos até outubro de 2024.

À noite, a situação piora: o professor de Biologia do turno noturno da mesma escola, Gabriel, falou: “Aqui tu nunca vai ver a gente sair no último horário do dia, no máximo, no máximo às 21:30 porque depois fica muito perigoso deixar os alunos na rua. E até porque sempre falta professor, né? Mas o normal é acabar às 20:30 mesmo.” (Prof. Gabriel,). Na escola B o cenário não muda.

Um dia, conversando com a ACS Fernanda, ela relatou o seguinte: “Os pais que conseguem se organizar um pouco mais mandam os filhos para outra escola (no nosso caso, escola B) para tirar eles daqui do meio da vila e tentar dar uma oportunidade melhor de futuro. Conseguem aqueles que têm um pouco mais de dinheiro para transporte e etc.” Aqui, vemos uma percepção própria de alguns(as) moradores(as) sobre a necessidade de sair do território para conseguir mais oportunidades.

Galvão et al (2022, p. 17) chegou à mesma conclusão em sua pesquisa: pais que têm maior condição econômica e que têm expectativas educacionais nos filhos “procuram romper a

bolha dos limites territoriais e acabam por matricular as crianças e os jovens em outras escolas, consideradas de referência e em áreas de menor vulnerabilidade.”

Na escola B, nas turmas do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio, dos quinze alunos(as) em sala, pelo menos cinco moravam mais próximos da escola A do que da qual estudavam. Em conversas sobre não continuar no colégio A vinham respostas como: “É que lá é muito no meio do tráfico, né, Sora?” (Luíza, 17 anos, sem experiência reprodutiva); “Minha mãe queria que eu tivesse mais oportunidade, então vim pra cá.” (João Guilherme, 16 anos, sem experiência reprodutiva); “É que aqui o ensino e a estrutura é bem melhor né?” (Tainá, 19 anos, sem experiência reprodutiva).

Aqui, entendemos que existe correlação entre níveis de fragilidade econômica, social e cultural no entorno das escolas e a qualidade de oportunidades educacionais naquele local. Érnica e Batista (2012) realizaram pesquisa em territórios considerados vulneráveis durante dois anos e constataram que os(as) alunos(as) com baixos recursos culturais e familiares, estudantes de escolas em entornos mais vulneráveis, tendem a ter níveis educacionais mais baixos, enquanto os(as) estudantes nas mesmas condições, mas que estudam em contextos menos vulneráveis, tendem a obter melhor desempenho.

Independente de ser estudante da escola A ou B, a maioria dos(as) jovens trabalham, mas raras vezes com algo de sua escolha pensando em um futuro profissional ou que realmente gostam. Num geral são estágios por necessidade financeira para uma contribuição com a renda familiar. Os(as) jovens do turno da manhã costumam trabalhar meio turno e os da noite, turno integral. Sobre isso, professora de Biologia da escola B, Monique, aponta:

Aí tu entra com a vulnerabilidade de alguns, a questão de envolvimento até em crime em situação, eu não digo crime, mas essa relação de drogas. Eu vejo assim que são alunos que tão jovens, eles já precisam trabalhar para sustentar uma casa, não é nem para ajudar, mas para sustentar a casa, para poderem comer. Tu vê essa relação assim que eles já não têm mais o mesmo pique, eles já não conseguem acompanhar, já vêm de uma realidade diferente, já tiveram que acabar o ensino médio um pouco mais tarde. Pessoas com mais idade, pessoas que já não tiveram as mesmas possibilidades que o pessoal da manhã tem (Prof. Monique).

Estudos apontam o trabalho como um dos causadores do abandono escolar (Abramo; Venturi; Corrochano, 2020 ; Fritsch *et al.*, 2019) apesar de não ser o único, pois o abandono é multifatorial. No nosso contexto, vários(as) dos(as) alunos(as) do turno da manhã tinham que sair mais cedo do colégio todos os dias para pegar o transporte até o estágio, perdendo no mínimo o último período de aula. Já os(as) jovens do turno da noite chegavam na escola exaustos depois da intensa jornada de trabalho.

Na unidade de saúde o efeito do território também fica nítido, assim como acabamos de ver no que se refere à educação. Quando falamos das comorbidades que acometem as pessoas até as formas que elas acessam esse espaço, é o território o elemento chave para entender seus cotidianos. Aqui:

A apropriação social do espaço produz territórios e territorialidades propícias à disseminação de determinadas enfermidades. Os usos e as funções que cada recorte espacial admite podem conformar perfis territoriais que revelam as condições de acesso aos serviços de saúde, exposição a fatores de risco, exclusão socioespacial, entre outros fatores determinantes das situações de saúde em grupos sociais (Faria, Bortolozzi, 2009, p. 39).

Neste sentido, pensamos nos determinantes sociais da saúde (Barata, 2009) e o território como sendo um dos principais. Como lembram Prado e Caetano (2024) a noção de território é central para o SUS e é base de alguns de seus preceitos fundantes como equidade, descentralização, controle social, universalização, participação, entre outros. Aqui temos um território sem acesso à saneamento básico, à água potável, à moradia adequada, onde pessoas passam fome e frio.

No que se refere aos atendimentos na US essas vulnerabilidades ficam muito claras nas necessidades dos(as) usuários(as). A maioria das pessoas com limitações e desgaste físico, o têm devido ao trabalho a vida inteira em serviços braçais: as mulheres em faxinas e os homens em obras ou como seguranças. E muitos trabalhos sem carteira assinada, que geram ainda mais instabilidade financeira e dependência, sendo que ficar doente muitas vezes não é uma opção: “Sora, eu não posso ir pro posto pegar ficha as 7 da manhã e só sair de lá meio dia porque eu trabalho em obra, se eu não vou, não recebo nada.” (Kaue, 17 anos, sem experiência reprodutiva).

Em uma sexta-feira, eu estava com o enfermeiro Rafael e ele atendeu mais de um caso com sintomas de virose. A última paciente que ele atendeu de manhã saiu da sala e ele comentou comigo que já tinha perdido a conta de quantos atendeu aquela semana com os mesmos sintomas. Ele me disse: “Normalmente quando é algo assim que vem muitos, a gente vê onde moram e sabe que provavelmente é alguma coisa com a água que estão tomando, que não é bem tratada.” (Enf. Rafael).

Ainda, em conversas com funcionários(as), estes(as) relatam que a saúde mental está cada vez mais demandante, principalmente em jovens. Saúde esta que tem relação direta com segurança, moradia digna, alimentação de qualidade, estabilidade financeira, entre outros.

Outro ponto é o das dificuldades de realização de exames ou idas para consultas, fatos recorrentes no dia a dia de usuários(as) da unidade de saúde.

Como exemplo, certo dia estava com a ACS Fernanda e levamos a notificação de consulta para um usuário: “Mas não vou ter dinheiro para a passagem.”, disse ele ao que a ACS retrucou: “Vou tentar um vale transporte, mas não sei se vou conseguir.” Conversando com a enfermeira Olívia, ela relatou que quando ganhou alguns vales transportes por ter sido chamada para participar de um júri, ela não gastou os vales e acabou entregando aos seus pacientes para que estes tivessem condições de ir às consultas e aos exames.

Também vemos a dificuldade de deslocamento da população em dias de chuva dependendo do local da residência, pois, como diz a ACS Fernanda “realmente alguns lugares fica impossível de se deslocar de tanto barro e água.” Ou também, mas acontecendo com muito menos frequência, a dificuldade de deslocamento por questões de segurança quando há tiroteios.

Nesse sentido, o território deve ser entendido como “território-processo, ou seja, um território social, econômico, político e epidemiológico, onde se encontram as variáveis sobre as quais ocorre o processo saúde-doença da população.” (Lisboa, 2013, p. 255). Tendo agora este contexto do território, passamos para a análise de como funcionam as duas escolas e a unidade de saúde, que são os espaços centrais do território para nós. Percebe-se que entender mais como elas se estruturam é fundamental para analisar mais à frente os micromecanismos de governança reprodutiva que os(as) agentes utilizam em seus cotidianos.

5.3 COMO SE ESTRUTURAM AS ESCOLAS

Começaremos falando da escola A, escola que fica localizada bem “no meio da vila” e mais próxima também da unidade de saúde onde foi feita a pesquisa. Esta escola conta com 967 alunos(as) divididos entre Ensino Fundamental e Ensino Médio. No Ensino Médio, foco da nossa pesquisa devido à faixa etária dos(as) jovens entre 16 e 20 anos, há turmas no turno da manhã e da noite. No primeiro turno, são três turmas de cada um dos anos (primeiro, segundo e terceiro) e na noite é uma turma de cada ano do Ensino Médio.

No meu primeiro dia, ao entrar na sala dos professores da escola em questão, uma professora me perguntou: “Você é uma professora nova?” Eu: “Não, eu vim fazer...” Ela me interrompeu e falou: “Ainda bem.” Eu expliquei então sobre a proposta da pesquisa e ela: “Bem-vinda ao inferno” e ficou dando risadas acompanhada dos(as) demais professores(as) da sala.

Cada uma das turmas têm cerca de 30 alunos(as) matriculados(as), mas uma média de 15 pessoas por dia em sala de aula. Em dias de muito frio ou muita chuva o número diminui um pouco mais. À noite, a desistência e/ou baixa frequência dos(as) jovens é ainda maior, tendo em média dez jovens por sala. A supervisora do noturno da escola A me apontou durante uma conversa: “É triste, às vezes começamos o ano na escola com quatro primeiros anos e no terceiro ano só tem mais uma turma. Não conseguimos segurar mais os alunos.” (Carla).

Já comentamos no subcapítulo anterior acerca do abandono escolar, da realidade de trabalho da maioria dos(as) jovens e das dificuldades destes(as) verem possibilidades de emprego a partir da continuidade do estudo. Quando perguntava nas rodas de conversa - foram quatro realizadas na escola A - se os(as) jovens gostavam do ambiente de estudo, a resposta geral sempre era não, seguida de risinhos constrangidos. Segue um exemplo com a turma do segundo ano noturno:

Bárbara: Vocês gostam da escola?

Marcelle: Não.

(Todos concordando).

Heitor: Deveria ter educação financeira.

Mônica: A gente sai do colégio sem saber nada.

Bárbara: Vocês têm ideia de fazer faculdade?

Lucas: Não, Deus me livre.

(Outros concordando que não, sendo a maioria) (Roda de conversa 2º ano do Ensino Médio, sem experiência reprodutiva).

Vale citar mais alguns diálogos que tive com jovens da escola pelos corredores, intervalos, rodas de conversa e sala de aula: “Bah, sora, isso daqui é uma confusão!” (Márcio, 17 anos, sem experiência reprodutiva); Sabrina (18 anos, sem experiência reprodutiva): “Se pelo menos a gente aprendesse alguma coisa que pudesse usar pra nossa vida.”.

Sobre as trilhas de aprendizagem, todos(as) professores(as) da escola A e da escola B, têm reclamações. Especificamente da escola A, o professor Felipe destacou exaltado certo dia no recreio: “Querem que a gente inove com o quadro negro e giz!? Então vai ser pegar uns giz de uma cor diferente, porque não tem outros materiais para fazer inovação!” (Prof. Felipe). A professora de Educação Física da escola também já falou: “Eu tenho uma aula que é de ciência do movimento, uma coisa assim. Nunca recebi nenhum material sobre o que trabalhar e vou lá no google pesquisar o que passar pra eles.” (Prof. Fabiana).

Ao acompanhar o dia a dia na sala de aula, eu notava que a maioria dos(as) estudantes permanecia conectado no celular, alguns inclusive o tempo inteiro com música no fone de ouvido. Eram poucos os alunos que abriam o caderno para copiar o conteúdo. O professor de

Biologia, da noite, Gabriel, disse para mim certo dia: “Eu sempre digo que vai valer nota o caderno para pelo menos eles copiarem.” (Prof. Gabriel).

Os dois professores de Biologia que acompanhei de perto, nesse período na escola A, professor Felipe e professor Gabriel comentaram diversas vezes sobre como as aulas são rápidas e se queixavam da falta de tempo para organizar o conteúdo. Uma das situações mais críticas é a turma onde Felipe só ministra aulas uma vez na semana, no último período do dia, ou seja, quase nunca entra em sala de aula. Até novembro de 2024, ele havia ministrado uma aula de Biologia no ano. Há dois períodos de Biologia no primeiro ano do Ensino Médio e apenas um no segundo e terceiro anos, sendo que nestes dois anos há mais disciplinas relacionadas às trilhas de aprendizagem na grade horária.

Observando as aulas de Biologia do turno da manhã, elas costumavam seguir o mesmo roteiro: o professor Felipe entrava na sala de aula, pedia onde ele tinha parado de passar o conteúdo na última aula, uma ou duas pessoas respondiam e ele seguia o livro didático a partir daí. Escrevia no quadro as informações que considerava centrais do livro e depois explicava em alguns minutos para os(as) poucos(as) alunos(as) que prestam atenção. Perguntas vindas destes(as) sobre o conteúdo são raras. Às vezes, Felipe solicitava que a turma fizesse atividades no livro didático, e eles(as) precisavam encontrar os livros em alguma das salas da escola e se juntar em duplas para ter livro suficiente.

À noite, o professor Gabriel não altera muito sua didática, passando material a partir do livro didático. Ele faz o caderno dos(as) jovens valer nota no final do trimestre, pois “pelo menos assim eles copiam” (Prof. Gabriel). A turma do terceiro ano tem aula em uma sala onde há retroprojetor e um computador, então ao invés de escrever no quadro Gabriel passa *slides*, que montou há alguns anos baseado em livros didáticos e no seu conhecimento.

Ambos os professores de Biologia e os(as) demais profissionais da escola A têm uma reclamação geral com a diretriz recebida pela Secretaria Estadual de Educação, segundo eles(as), de não reprovarem qualquer aluno(a). “Então eu nem faço prova, nem tem porque, depois vou ter que aprovar todo mundo igual.” (Prof. Cátia). São poucos(as) professores(as) que dão provas, pelo que anotei, apenas de duas matérias.

O horário inicial da aula do turno da manhã deveria ser 7:30, mas a comunidade pressionou para começar às 8:00, pois não desejavam que fosse tão cedo. As primeiras aulas da manhã ainda são mais longas com períodos de 50 minutos, mas as três aulas após o intervalo são de 30 minutos, os quais acabavam virando 20 até acalmar a turma e fazer a chamada, conforme observei ao longo dos meses na escola. A aula, regularmente, teria seis períodos e iria

até 12:30, mas normalmente às 11:50 as turmas eram liberadas devido à falta de professores(as) e a necessidade dos(as) jovens irem para o trabalho.

O intervalo é de 15 minutos, sendo que de merenda, em média, dois dias da semana é de refeições como arroz e feijão ou massa e os restantes é de bolacha e iogurte com uma fruta. O professor Rafael e o professor Gabriel já comentaram comigo diversas vezes da importância da refeição para os(as) estudantes e como muitas vezes é a única refeição mais substanciosa que eles têm no dia. Gabriel contou que anos atrás era ainda pior, sendo que ele percebia que os(as) alunos(as) vinham para a escola apenas pela merenda.

Já no turno da noite, a aula inicia às 18:00, mas os(as) alunos(as) costumam chegar por volta das 18:15. Eles recebem refeições parecidas com as da manhã e os(as) alunos(as) nunca gostam quando não é “comida quente” como massa, feijão ou carreteiro. Eles(as) não possuem intervalo, uma escolha da direção para que aproveitem mais o período em sala, visto que as aulas sempre acabam mais cedo, como já comentamos, devido à falta de professores e, principalmente, ao perigo de deixar os(as) alunos(as) circulando muito tarde pelo território.

Todos os períodos têm 30 minutos de duração e a aula vai no máximo até 21:30, porém o mais comum é que a aula finalize às 20:30. Oficialmente, nem o professor de Biologia sabia me dizer que horário finalizavam as aulas: “Acho que 22:30, 23:00, nem eu sei. Só sei que não tem condições de ficar até tão tarde.” (Prof. Gabriel).

Sempre durante a manhã e também no turno da noite, uma coordenadora passa em sala de aula anunciando que horário cada turma será liberada. Como os(as) alunos(as) me falavam, é sempre uma surpresa. Também é uma surpresa a quantidade de professores(as) que vão à escola. É raro que um(a) professor(a) consiga seguir o horário de aulas pré-estabelecido. “Subir período” é algo muito comum e dar aula concomitante em duas turmas também, o que dificulta muito o planejamento de aulas.

Ao falarmos em estrutura da escola, temos um outro fator complicador. O prédio é de tijolo à vista, possui dois andares e as janelas são gradeadas. A frente da escola não possui pátio, mas sim um espaço onde professores(as) estacionam carros e grama numa altura considerável que não recebe cuidados de jardinagem há tempos. Na parte dos fundos da escola, há uma quadra de futsal descoberta, um espaço do tamanho de outra quadra de concreto e uma parte com grama, mas que não recebe manutenção frequente. Os corredores da escola também não são receptivos e não há muitas exposições de trabalhos de alunos(as) ou outros cartazes que “dessem mais vida ao local”.

Professores(as) e alunos(as) têm reclamações quanto à estrutura da escola. Acerca disso, não há sala de computação, por exemplo, nem Wi-Fi para os(as) alunos(as). O laboratório de

Ciências possui poucos recursos e não é usado com frequência. A biblioteca foi reformada através de uma ação de uma universidade há cerca de dois anos, mas também é muito pouco utilizada e com poucos materiais. A escola também não possui quadra de educação física poliesportiva coberta. Há uma sala com retroprojektor, mas a maior parte dos meses que estive lá, o mesmo não estava funcionando.

As salas possuem quadros verdes, classes e cadeiras antigas com diversos rabiscos, sendo que não há ar condicionado, os ventiladores de algumas salas não funcionam e a maioria delas têm janelas quebradas. Os dias de inverno, que passei naquela escola foram extremamente difíceis devido ao frio intenso, sendo este realmente um fator que desestimula os(as) jovens a irem para a escola.

Agora, falaremos da escola B que, como já comentado, fica localizada próximo de uma avenida movimentada e do outro lado da rua está a divisa oficial entre o bairro foco dessa pesquisa e o seu vizinho. A escola B fica mais próxima de comércio e de paradas de ônibus, sendo mais movimentada e “não tão dentro da vila” como já destacaram alunos que estudam ali. No Ensino Médio são 1.019 alunos matriculados. A média de estudantes por turma é de 30 alunos(as) matriculados(as) na manhã, mas cerca de 20 comparecem por dia na aula. À noite, a média é de 40 estudantes matriculados(as), com cerca de 15 comparecendo à aula.

A escola B possui alguns pontos em comum com a A: falta de professores, a necessidade de “subir períodos”, reclamações por parte de funcionários e alunos(as) no que se refere às trilhas de aprendizagem, poucos períodos de Biologia e outros conteúdos como Física e História, questões de organização de merenda na manhã e na noite, finalização da aula mais cedo do que o regulamento dos dois turnos (diurno e noturno) e reclamação dos professores quanto à diretiva de não reprovar alunos(as).

Nesta escola também há desinteresse dos(as) alunos(as) quanto às aulas e à falta de perspectiva de acesso à universidade ou curso profissionalizante. Nas rodas de conversa, eram três ou quatro jovens por turma do terceiro ano do Ensino Médio que expressavam algum desejo de realizar a faculdade.

Acerca dos sentimentos dos(as) estudantes quanto à escola, havia divergências: alguns(as) consideravam boa, outros(as) diziam ser ruim. Um aluno, que já estudou tanto no período da manhã quanto da noite, destaca: “Ah, acho que é bom. É, a noite é um pouco desleixada. Não tem professor. Não tem professor. A gente nunca sabe o que vai ter todo dia. Se não tem professor, é sempre surpreendente.” (Diogo, 20 anos, sem experiência reprodutiva).

No que se refere aos horários de aulas, na escola B, ela inicia às 7:30 e, normalmente, finaliza no quinto período de aula, 11:55, sendo que pela grade horária seriam seis períodos,

ou seja, até às 12:45. Aqui, cada período tem 50 minutos, diferente da escola A. O intervalo é de 15 minutos. O Ensino Médio pela manhã possui quatro turmas de primeiro ano, três turmas de segundo e três de terceiro anos.

À noite são duas turmas de primeiro ano, uma turma de segundo ano e duas turmas de terceiro ano. As aulas iniciam às 19:00 e normalmente finalizam às 20:30, raramente se estendendo mais devido às mesmas questões que a escola A: falta de profissionais e segurança. Percebemos que em comparação à escola A, na B são mais alunos(as) matriculados(as) no turno da noite e também menos desistências.

No que se refere ao dia a dia em sala de aula, os(as) jovens da escola B são mais assíduos que os(as) da escola A, não há tanto uso de celulares e fones de ouvido, os(as) jovens costumam prestar, minimamente, atenção ao conteúdo, e, pelo que percebi, o nível de aprofundamento das discussões em sala de aula parece ser um pouco maior. Na escola B, os(as) professores(as) também se fazem valer do uso do livro didático e, da mesma forma, ele tem que ser dividido entre os colegas e os exemplares devem ser procurados pelo colégio, estando normalmente espalhados pelas salas.

A professora Monique, a única professora de Biologia que entrevistamos, leciona as aulas de Biologia para os primeiros e terceiros anos do turno da manhã e para todos os anos no turno da noite na escola B. Ela não faz tanto uso do quadro, se utilizando mais do livro didático e pede para que os(as) alunos(as) copiem e façam as atividades. Às vezes, trabalha questões entregues em xerox. Ela também é presidenta do Conselho Escolar, o que dificulta sua presença em sala de aula, sendo que se ausenta para resolver questões referentes ao Conselho, cotidianamente.

Conversando sobre suas aulas, ela me referiu falta de tempo com algumas turmas e também a dificuldade de aprendizado, que: “não posso passar conteúdo mais difícil que isso senão eles não acompanham.” Vale apontar que ela tem uma relação próxima com todas as turmas, o que torna o ambiente mais acolhedor e agradável sem um distanciamento tão grande entre professor/aluno. Apesar disso, não há uma demonstração de interesse pelas matérias que ela ministra por grande parte dos(as) jovens.

Já o professor Ricardo ministra aulas de Biologia para as duas turmas de segundo ano do Ensino Médio e para o Ensino Fundamental na escola B. No segundo ano, ele costuma se basear no livro didático para ministrar os conteúdos. Normalmente, ele chega em sala de aula, confere onde parou a explicação e segue o livro didático. Alguns(as) jovens prestam atenção, outros(as) não. O professor passa um pouco do conteúdo, explica, pede para copiarem e se senta novamente.

Em relação aos(as) professores(as), os(as) estudantes têm reclamações similares a dos(as) da outra escola: os(as) alunos(as) não prestam atenção, não se dedicam, “estão nem aí para nada” e “não querem saber de estudar”. Os(as) professores(as) aparentam estar menos cansados(as) e desgastados(as) que os(as) da escola A, porém, mesmo assim, certo dia conversando com o professor de filosofia, ele desabafou: “Uma vez perguntei na aula pra eles: quem não queria estar aqui? Todo mundo disse que não, que preferia estar dormindo. Então nós, educadores, falhamos. É duro de falar. Mas também, que ferramentas nos deram?” (Prof. Marcos).

A estrutura da escola B difere da A em vários aspectos apesar de esta também ser de dois andares e de tijolo à vista. A escola B possui duas quadras esportivas, cestas de basquete, rede de vôlei e sala para atividades como futebol de mesa e ping pong. A entrada da escola possui diversos cartazes de boas vindas aos(as) estudantes e as portas das salas são amarelas, o que traz uma “vida a mais para a escola” que também possui trabalhos de alunos(as) pendurados pelos corredores.

As salas de aula possuem classes de plástico cinzas com azul e cadeiras azuis, que foram trocadas há dois anos. Os quadros são brancos e nem todas as salas possuem projetor multimídia, mas algumas delas sim. A biblioteca tem pouca movimentação de estudantes, e é bem organizada, apesar de não ter uma bibliotecária fixa. A escola conta com uma sala multimídia onde são feitas palestras, em alguns momentos as turmas vão para assistir filmes e/ou são organizadas para reuniões dos conselhos da escola. Há uma sala de informática com acesso a wi-fi. O laboratório de Ciências é bem organizado, mas como contam os alunos(as) “não é muito bem aproveitado”. Nesta escola, os(as) alunos(as) acessam o prédio e as salas antes das aulas iniciarem, o que parece dar um sentimento maior de acolhimento e pertencimento ao local, se comparado com a escola A.

Ao longo do subcapítulo e no decorrer do meu campo, não podia deixar de comparar a escola A com a B. Os(as) alunos(as) da primeira realmente têm uma condição de vulnerabilidade social mais acentuada, sendo todos(as) das redondezas da escola. Já na escola B, há alunos(as) do território que pesquisamos, mas também de outras localidades próximas, os(as) quais não deixam de ter seu grau de dificuldades financeiras, mas em menor intensidade. Visualmente isso também é percebido nas roupas, celulares, materiais escolares, e formas dos(as) jovens chegarem à escola. Também percebemos as diferenças financeiras em conversas sobre com o que familiares destes(as) jovens trabalham e conversas sobre a necessidade dos(as) estudantes trabalharem ou não.

Realmente, a ACS Fernanda já havia alertado que jovens do território, que têm melhor condição financeira, buscam estudo na escola B por ter melhor estrutura e por imaginarem que ali terão maior qualidade de ensino e de oportunidades de trabalho do que se seguissem “dentro da vila”.

5.4 E COMO É DENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE?

Já falamos aqui sobre como o território tem relação direta com a saúde das pessoas e trouxemos algumas questões que circundam a unidade de saúde como dificuldade de acesso à US, falta de recursos para realizar exames e consultas fora do território, problemas de saúde tendo ligação com trabalhos braçais repetitivos, com ambiente de moradia e saúde mental.

Também é importante citar a dificuldade da população no acesso de medicamentos. Como o médico JP destaca:

Porque tu não pode só prescrever o que tu acha que vai ser o tratamento. Entendeu? Tu tem que se adaptar com o que tu tem. Sabe? Medicamento em pomada são dois. E é aquilo dali. Todos esses dois. E torce pra dar certo, porque muitas vezes 99% dos pacientes não vai ter condição de comprar um medicamento mais caro (Med. JP).

Os demais médicos, a médica, o enfermeiro e as enfermeiras que entrevistamos apontam na mesma direção que JP. A ACS Fernanda destacou: “O perfil do nosso usuário é de muita pobreza, então não adianta indicar um remédio que não tem no SUS, pois eles não vão conseguir comprar.” O médico Benjamin já me relatou: “Eu já comprei sim, remédio pra paciente meu, sei que não deveria, mas comprei, pois ele precisava para melhorar.” (Med. Benjamin).

Falando em dificuldades econômicas, outro ponto a ser apontado sobre o perfil da comunidade é a alimentação. A médica Amarilis me disse durante conversa entre consultas: “Não adianta eu dizer para a pessoa que ela precisa comer tantas castanhas e nozes e etc. por dia, pois é algo que ela não vai conseguir. Temos que trabalhar a partir da realidade deles.” (Med. Amarilis).

Aqui, vale apontar sobre o dia em que realizei atividade do PSE junto da equipe de odontologia. A ideia da dentista Vanessa era falarmos sobre escovação, cáries e alimentação. Eram turmas de primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental e uma das atividades era pintar alimentos saudáveis e não saudáveis de cores diferentes. Durante esta atividade, conversei com um aluno que me relatou que gostava de comer brócolis, mas que não podia porque era muito caro e “minha mãe não tem dinheiro para comprar”.

Sobre o perfil da população, como já nos destacou uma das técnicas de enfermagem da US, temos cerca de 90% dos(as) usuários(as) que se beneficiam direta ou indiretamente do Bolsa Família. Então, é necessário que os(as) profissionais saibam trabalhar a partir da realidade da comunidade, sendo que sabemos que a classe também é um dos determinantes sociais da saúde (Barata, 2009).

A dificuldade econômica é um dos fatores que frustra os profissionais, visto que nem sempre estes conseguem passar o tratamento que sabem que seria ideal para o paciente, pois não tem o medicamento no SUS ou a espera para conseguir uma consulta com o especialista está muito alta - às vezes a fila no Sistema de gestão de solicitações de consultas especializadas e exames (GERCON) chega a ser de seis meses - e o(a) paciente não pode ficar tanto tempo sem o atendimento.

Neste sentido Galvão, Oliveira, Germani e Luiz (2021, p. 9) citam que “Classe social é relacionada à saúde, na medida em que determina diferentes acessos às oportunidades e aos bens sociais, como moradia, educação, emprego, riqueza e ações de bem-estar, bem como padrões diferenciais de comportamento de estilo de vida.”

Todos(as) os(as) profissionais com quem conversei, ao longo da pesquisa, referem que a maioria das pessoas que acessam a US é de mulheres a partir dos 40 anos, gestantes e crianças, sendo que apenas os homens mais velhos frequentam o local. É unanimidade entre os(as) profissionais que os jovens acessam raramente o serviço de saúde e que as jovens acessam um tanto mais devido a contracepção e/ou gestação.

Acompanhando o dia a dia da unidade na recepção, minha percepção não divergiu da dos(as) profissionais: idosas, gestantes e mães com crianças de até 10 anos, mulheres adultas a partir dos 35 anos, seguidas por idosos e depois por homens a partir dos 40 anos. Depois vão aparecer mulheres mais jovens, em média de 20 a 35 anos, na sequência jovens de 15 a 20 anos - se enquadrando no público alvo da pesquisa - seguidas pelos homens de 20 a 35 anos e, por fim, os mais jovens de 15 a 19 anos.

No perfil de acesso, sobressaem-se dois pontos: gênero e faixa etária. Se o gênero é um dos elementos constitutivos das relações sociais, como destaca Scott (1990), certamente o gênero está presente no cotidiano da US. Percebe-se esse ponto presente na própria equipe quando temos uma maioria de nove técnicas de enfermagem, apenas um técnico, quatro enfermeiras e apenas um enfermeiro, temos cinco médicos e apenas uma médica e quatro ACS sem qualquer homem ocupando este cargo.

As mulheres, como destaca Federici (2019), ao ingressarem no mercado de trabalho, foram direcionadas para serviços ligados ao cuidado, muito associado à estrutura patriarcal

capitalista onde o cuidado é feminino. A US tem mais homens ocupando cargos de médicos, o que tem relação direta com o fato de que a medicina é uma das profissões mais antigas e renomadas do Brasil, ligada à masculinidade (Santos, 2004). Atualmente, temos o panorama da medicina mudando, com mulheres ingressando na profissão, mas essa mudança ainda não se nota nessa unidade.

Voltando ao público que acessa a US, se o cuidado é construído historicamente e socialmente como feminino, tanto o cuidado com sua saúde, com a dos filhos, com os demais membros da família e o cuidado doméstico é realizado pelas mulheres (Federici, 2017, 2019; Cobo; Cruz; Dick, 2021; Barata, 2009; Cobo, 2020). São as mães que levam as crianças para a US e, inclusive, que levam os maridos. Já acompanhei um atendimento em que o homem de 43 anos estava há meses com dores e só foi à consulta devido à insistência da companheira, a qual teve que explicar tudo para o médico, pois o homem não sabia o que falar. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 confirmou a tendência de mulheres serem mais cuidadosas com a saúde do que homens (IBGE, 2019).

Se, por um lado, temos uma sobrecarga das mulheres em relação ao cuidado - o que discutiremos muito aqui ao falarmos sobre a gestação das jovens - por outro lado temos uma falta do cuidado no que tange aos homens, o que acaba sendo prejudicial para a saúde destes, tanto física quanto mental. Frases como “homem não chora”, “homem tem que ser forte” e “sentir dor é coisa de mulher” são reflexos de gênero associados ao machismo e ao sexismo, que acabam por dificultar o cuidado do homem com sua saúde. Almeida, Dos Santos e Souza (2020) abordam estas construções em torno da masculinidade como complicadores na busca por serviços de saúde e adesão à práticas preventivas.

Tratando-se de Brasil, segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 34% dos homens brasileiros, que estão na faixa etária de 20 a 59 anos, não estão cadastrados nos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) (Brasil, 2022), representando participação significativamente menor que as mulheres.

Diversos fatores influenciam na ida em menor frequência dos homens às USs para além do cuidado associado ao masculino, como: falta de campanhas de promoção da saúde dos homens na APS (Carneiro; Adjuto; Alves, 2019; Vieira et al, 2020), horário de trabalho que impossibilita o comparecimento na US, medo de descobrir doenças graves, insatisfação quanto às formas de atendimento e a vergonha de se expor (Bichara et al., 2023).

A própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) aponta que vários dos obstáculos, na relação dos homens e o cuidado com a saúde, estão relacionados a barreiras socioculturais e institucionais que destacamos até aqui. E, a PNAISH aponta que há

uma propensão na juventude à exposição a riscos e agravos à saúde pela não adoção de práticas preventivas e por maior exposição a situações de risco, tais como: uso de drogas e situações de violência (Brasil, 2009), fator central no território que abordamos.

Se formos agregar o fator gênero à faixa etária, a situação fica ainda mais delicada: “Jovem homem? Nossa, quase nunca vejo aqui.” me disse certa vez o médico Benjamin, sendo que os(as) demais profissionais se referem da mesma forma. Barros et al (2018) aponta não só para a falta de presença deste público na US, mas para a necessidade de que a unidade tenha mais atenção para as demandas de saúde dos jovens. Também, um destaque que os jovens entrevistados por Barros et al (2018) dão é a necessidade de trabalho e a dificuldade de horário somado ao fato de não priorizarem a saúde.

Como destaca a ACS Fernanda: “É, o jovem não tem nada aqui na unidade pra ele, eu até entendo ele não vir. Vai fazer o que aqui?” Outra fala frequente é a do enfermeiro Rafael: “O jovem já tem escola, já tem trabalho, então ele só vai vir aqui se realmente estiver quase morrendo.” (Enf. Rafael).

No que se refere aos cinco jovens homens que entrevistei, os cinco entre 16 e 20 anos, estes destacam ir raramente à US com dizeres parecidos com este: “Vou só quando eu estiver quase morrendo” (Lucas, sem experiência reprodutiva). Durante as rodas de conversa e diálogos pela escola, os demais jovens mantinham o mesmo discurso de ter muita fila e espera, serem desrespeitados na US, não terem tempo entre trabalho e estudo e não verem necessidade de ir à US a não ser que estejam com alguma doença persistente.

Entre as jovens gestantes e/ou já no puerpério, que foram entrevistadas, todas as dez tinham respostas muito similares. Sabrina (com experiência reprodutiva), por exemplo: “Ah, eu comecei a vir quando descobri que estava grávida, né? Antes eu só vim para começar o anticoncepcional.” As cinco jovens sem experiência reprodutiva também destacam não acessar a US, só quando iniciaram a contracepção ou em caso de doença, como diz Liz, que nunca foi ao posto para falar sobre contracepção: “Mesmo quando tô doente, raramente eu vou. [...] Não tenho tempo, não tenho tempo. Tem muita fila.” (Liz, sem experiência reprodutiva).

Ao conversar com ambos(as) os(as) jovens, homens e mulheres, sobre o que achavam da ida na unidade para conversar sobre sua saúde sexual e reprodutiva, todos(as) riram e deram respostas como a de Samuel, que eram frequentes: “Sora, eles não querem nos atender nem quando a gente está quase morrendo, acham que estamos fingindo para pegar atestado, quem dirá ir falar sobre sexualidade. Vão rir da nossa cara e nos mandar embora.” Eu não tinha como contradizer a fala deles(as), pois sabia que muito provavelmente seria isso que aconteceria.

Para muitas técnicas de enfermagem e enfermeiros(as) que conversei, e pelas conversas de corredor, percebo que eles(as) pensam majoritariamente que o(a) jovem vem para a unidade “querendo atestado”. Este por si só já é um fator que dificulta um acolhimento mais atento e uma escuta cuidadosa. Apesar de que, alguns alunos me disseram que só vão mesmo à unidade quando querem atestado, essa percepção dificulta a relação entre jovem e funcionários(as) da saúde.

Os atendimentos para as jovens mulheres costumam ser referentes ao início da contracepção, gestação ou quando estão com algum outro problema de saúde. Para os jovens homens, costumam ser testes de ISTs ou algum outro agravante. A percepção dos(as) profissionais acerca das demandas do público em geral atendido na US é de grande procura por saúde mental, gestantes, diabéticos, hipertensos, sintomas gripais e viroses. Verificando-se nos relatórios de atendimento da unidade relativos a todo o público atendido na US, que costumam destacar o seguinte: hipertensão, diabetes, sintomas de ansiedade, depressão, puericultura, gravidez, tosse e sintomas de garganta, amigdalite e dores musculares.

Falando em estrutura e funcionamento da US, ela tem cinco equipes de Estratégia de Saúde da Família, sendo que três equipes são compostas por um(a) médico(a), um(a) enfermeiro(a), dois(as) técnicos(as) de enfermagem e uma ACS. Uma das equipes possui dois médicos - sendo um deles do Programa Mais Médicos. E a última das equipes não possui ACS. A US possui uma equipe de odontologia composta por dois dentistas e duas auxiliares de odontologia. A farmácia possui um farmacêutico e uma auxiliar de farmácia. A gerente da unidade possui uma auxiliar administrativa e há mais duas pessoas trabalhando na recepção.

A US abre às 7 horas da manhã e, a princípio, deveria sempre começar o dia com duas enfermeiras e dois médicos atendendo, além de quatro técnicas de enfermagem. Os(as) funcionários(as) que iniciam o trabalho no primeiro horário da manhã trabalham até as 16 horas. Na sequência da manhã, chegaria a outra enfermeira (8 horas) e a outra médica (9 horas e 30 minutos), ambas trabalhando oito horas diárias. A partir das 13 horas, chegam mais outros quatro técnicos, um enfermeiro, uma enfermeira e dois médicos. Estes(as) últimos(as) ficam na Unidade até às 22 horas. Das 18 às 22 horas, a US atende qualquer pessoa que esteja buscando atendimento, independente de morar no território que abrange a unidade, sendo que antes disso os atendimentos são focados nos moradores do território, seguindo a adstrição territorial do SUS.

O trabalho dos(as) funcionários(as) é dividido em escalas por turnos de manhã, tarde e noite. As técnicas de enfermagem têm uma escala semanal que envolve curativo, procedimentos, vacinação, escuta inicial, central de material esterilizado (CME) e

almoxarifado. Os(as) médicos(as) possuem um turno semanal de administrativo, um turno de visitas domiciliares (VDs), dois turnos de demanda do dia e cinco de agenda. Enfermeiros(as) têm um turno de escuta por semana, onde ficam de prontidão para auxiliar técnicas na escuta inicial, um turno de administrativo, um de VD e o restante de agenda. Uma vez por semana, cada equipe faz uma reunião de equipe. Mensalmente, há uma reunião geral da unidade, de todas as equipes. As reuniões específicas de enfermeiros e/ou da equipe de enfermagem - enfermeiros e técnicas de enfermagem - são raras.

Na maior parte do período que fiquei na US havia apenas duas ACS e nos últimos dois meses entraram mais duas - em 17 e 23 de setembro de 2024 - ainda não suprimindo o número de uma Agente por equipe, mas já ajudando muito mais no trabalho. Antes, apenas com as duas ACSs, algumas regiões do território ficavam mais desprovidas de atenção.

Durante os últimos três meses, de observação, estive em contato com a equipe E-multi, novidade na APS, programa instituído pela Portaria nº 635/2023 do Ministério da Saúde. Não acompanhei a equipe E-multi devido a não ser o foco desta pesquisa, e também por estarem num período muito inicial de trabalho onde ainda estavam organizando sua estrutura de funcionamento e entendendo melhor como executar seus trabalhos. Esta E-multi é composta por uma psiquiatra, duas psicólogas, uma assistente social, uma educadora física, uma fonoaudióloga, duas fisioterapeutas e duas nutricionistas. Estas profissionais se dividem entre esta US e outras três próximas.

A unidade, em si, fica situada numa rua principal na frente do maior supermercado do bairro, ao lado de uma farmácia e com vários outros comércios ao redor como lojas de roupas, academia, *pet shop*, loja de sorvete, mecânica, entre outros. Na rua seguinte fica um dos lados de um parque grande e bem arborizado, o qual é comentado por jovens como um local de sociabilidade. Essa rua principal tem paradas de ônibus e há normalmente bastante gente circulando por ali.

Atrás do posto de saúde fica uma escola de Ensino Fundamental. É na esquina desta escola que fica o ponto de trânsito mais próximo da US. Em momentos de maior tensão no território, devido à guerra de facções, ali é um lugar propício para tiroteios, mas fora estes momentos de maior tensão, funcionários da US e população circulam com tranquilidade durante o dia. Conforme se vai adentrando nos acessos e nos becos, os pontos de trânsito e os olheiros vão aumentando e a precariedade das condições de moradia também.

Aqui, um último ponto importante a ser tratado e que interfere também na relação que os(as) agentes estabelecem com a US é a chamada parceirização, tendo sido realizada com base no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014). Este processo

de parcerização se iniciou no município de Porto Alegre em 2020, tendo hoje já 95% das unidades de saúde com sua gestão terceirizada para organizações civis sem fins lucrativos. Atualmente, dos 145 postos de atendimento da Atenção Primária, apenas 13 ainda se mantêm com gestão pública.

A US que aqui tratamos é coordenada por um grupo hospitalar de Porto Alegre desde o segundo semestre de 2022, tendo sido uma das últimas da região a ser parcerizada através de um processo difícil e de revolta da população, como contam a ACS Fernanda e a ACS Carolina. Em junho de 2022, antes da parcerização, moradores foram às ruas protestar contra essa parceria, trazendo a questão de que o quadro de funcionários já estava há mais de 20 anos na localidade e que seria um retrocesso para a população a mudança de gestão e de funcionários(as) da unidade.

“Somos só números”. Eu escutei essa frase de uma enfermeira enquanto falávamos no almoço, na cozinha da unidade. Segundo ela, tiraram-na de um lugar que ela adorava, sua antiga unidade, para substituir uma enfermeira que foi demitida na US em questão. Sobre a parcerização, o médico JP destaca:

Não combina nada com a atenção primária, é, tipo, totalmente contraditória. Até porque muitas vezes, sei lá, é isso sobre uma visão de, de, da forma como as empresas, elas são conduzidas, eles estão preocupados em números, né. Sempre assim. Então eles só vão ligar pra bater as metas que são propostas em contrato e é isso. Se o restante tá sendo bem feito, eles não tão ligando muito. E tem muita coisa que não entra em número e que é fundamental, né, pra população. E essa própria questão de ter um vínculo, né, que eu acho tão importante, mas que não tem. É o fundamental. É um dos princípios, inclusive (Med. JP).

É difícil ter um(a) profissional da US que não fale sobre a parcerização com, no mínimo, certas ressalvas, senão com desgosto. Em conversa com a própria gerente, ela vê que a parcerização tem aspectos ruins, mesmo ela sendo uma funcionária do hospital, que tem o contrato com a prefeitura para esta US. O principal desafio que a gerente, Débora, cita é a rotatividade dos profissionais e falta de vínculos, que é a base da APS.

As quatro ACS no posto ainda são funcionárias da prefeitura. Fernanda e Carolina, ACSs que acompanhei no cotidiano, falam com desgosto da parcerização e dá pra se sentir uma tensão inerente (ou muitas vezes explícita) com a gerência da US. Em entrevista, Cássia, enfermeira, falou durante um bom período sobre os problemas e perigos da parcerização: “A atenção primária está toda retalhada”, “A gente se resume a interesses de empresa quando parcerizamos.” e “Tudo sempre é sobre o número que precisa bater e não sobre o cuidado com a pessoa.” (Enf. Cássia).

Referente à rotatividade de funcionários(as):

Agora na recepção aconteceu uma sequência de três atendimentos que me fizeram pensar muito na parcerização. Chegou um paciente e disse que tinha que mostrar os exames para o doutor Benjamin, mas o doutor pediu demissão e saiu do posto, e o paciente ficou muito triste quando ouviu que Benjamin não trabalhava mais ali. Na sequência veio uma senhora e disse que tinha que mostrar exames que a Patrícia pediu, mas Patrícia foi demitida anteontem, e nisso já olhei pro Gustavo no balcão com uma cara de “que merda hein?”. A terceira pessoa que chegou soltou um: “Preciso reagendar consulta de pré-natal com a Olívia”, mas essa enfermeira foi demitida há duas semanas. Gustavo deu a mesma resposta protocolar para os três: “Essa pessoa infelizmente não trabalha mais com a gente” (Diário de campo).

Se a atenção primária prega por criação de vínculo, por um atendimento mais humano e aproximado, a parcerização não segue o mesmo fluxo, segundo dizem os(as) profissionais da US. Podemos exemplificar a rotatividade dos(as) agentes de saúde a partir de reunião na US, onde cada um devia falar seu nome, função e o tempo que estava trabalhando ali. As ACS foram as únicas que falaram nove e oito anos. Depois disso, a dentista falou dois anos e todos ficaram: “Uau!”, “Nossa!” “Uou!” e vários burburinhos seguidos disso. A maioria está lá há cerca de seis meses. Já foram mais de 10 profissionais, que saíram da unidade no meu período de observação (junho a dezembro de 2024).

Em janeiro de 2026, em torno de seis meses após finalizar minhas observações na US, fui até o local e apenas duas ACSs e um médico, que entrevistei, seguem na unidade do total de catorze pessoas entrevistadas. A gerente da US também foi realocada para outra Unidade no início de 2026. Segue trecho do diário de campo: “Ao ir até a US e encontrar tão poucos rostos conhecidos, eu me senti deslocada e como se fosse uma estranha lá dentro. Quem dirá como a população não se sente.” (Diário de campo, 2026).

Alguns funcionários destacam pontos positivos na parcerização e normalmente se referem a haver mais possibilidades de trabalho para pessoas qualificadas na nova gestão, pois alguns profissionais “da época da prefeitura não faziam um bom trabalho.” A maioria dos(as) profissionais com quem conversei sempre trabalhou no esquema da parcerização, então não tem muita noção de como era antes da mesma.

A US, como já comentado, é um dos principais serviços públicos do território, mas sua estrutura, segundo funcionários(as) não comporta as necessidades do espaço. O local possui um andar, é de tijolos à vista e possui uma grade verde ao redor. Quase não há espaço do lado de fora da unidade, apenas um banco que rapidamente lota no momento em que a unidade abre. Ao ingressar na US, há o espaço da recepção com cerca de 15 cadeiras que raramente não estão ocupadas. Pessoas esperando de pé e do lado de fora é algo cotidiano.

A farmácia fica junto da recepção e é uma sala com cerca de 5 metros quadrados. É muito difícil ficar mais de uma pessoa ali e a fila, para pegar medicação, sempre se confunde com a fila para atendimento da recepção. Não existe um fluxo de pegar ficha e esperar na farmácia, então as pessoas passam por volta de cinquenta minutos de pé na fila em horários de maior movimentação.

Depois da recepção, a unidade tem duas portas: a da direita leva às salas médicas, de enfermagem, almoxarifado e a sala e-multi; a da esquerda leva às salas de vacinas, de procedimentos e duas de escuta. No meio do corredor entre elas fica a “sala do meio” onde são feitos os atendimentos de intercorrências, pois tem uma maca e oxigênio. Além disso, tem uma divisória nessa sala com uma sala secundária bem pequena, com cerca de 6 metros por um e meio, onde também são feitos acolhimentos de usuários(as).

Ainda do lado esquerdo, depois da última sala de escuta, tem a sala da gerência e ACSs com três computadores, normalmente todos ocupados. Na sequência, a sala de organização e higienização de materiais utilizados na US, a cozinha, o banheiro feminino e o masculino para profissionais. Depois da cozinha, há outra porta de entrada e saída para a US de uso dos(as) funcionários(as).

Os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) reclamam do fato de terem que dividir a sala com outros(as) colegas e também do espaço da mesma ser pequeno. Sempre no turno do administrativo é necessário “correr atrás de algum computador”, pois os(as) profissionais precisam usar um computador, mas não podem mais ficar nas salas em que normalmente atendem. O farmacêutico também comenta que sente muito o fato de não ter uma sala para fazer suas consultas e sempre está andando de um lado pro outro à procura de um ambiente para conversar com seus(as) pacientes.

A sala do meio é uma sala aberta onde circulam muitas pessoas atravessando pela Unidade, então não há sigilo e privacidade ali. São pacientes em estado crítico na maca e/ou pessoas fazendo testes, no mesmo ambiente, sendo que essa exposição constrange tanto usuários(as) quanto trabalhadores(as).

Junto à estrutura física das salas, tem a questão da falta de computadores, impressoras, quase que diariamente com problemas, e muita falta de materiais como termômetros, réguas antropométricas, oxímetros, aparelhos de medir pressão, balanças, entre outros de uso básico da unidade. Muitos(as) profissionais já compraram materiais próprios, pois desistiram de trabalhar correndo atrás de algum ou com os que tinham disponíveis, mas que nunca funcionavam. A falta de medicamentos disponíveis na farmácia, a falta de insumos para fazer

curativos, falta de luvas e máscaras são coisas que vão somando ao estresse e as dificuldades que profissionais citam no dia a dia.

Assim como destacamos na seção anterior sobre os(as) professores(as) demonstrarem cansaço, indignação e tristeza, sentimentos parecidos acometem os(as) agentes de saúde: “Tu tá acompanhando uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não atenção primária”. Essa frase eu ouvi de uma enfermeira no primeiro dia que estava no posto. E depois segui ouvindo de muitas pessoas, em diferentes momentos. E ela seguia com reclamações de ter uma demanda muito alta de casos mais complexos e dos(as) profissionais sempre estarem “apagando o fogo”, nunca conseguindo fazer promoção e prevenção, que são uns dos pilares da atenção primária no SUS.

Sobre o dia a dia na US, destaquei em meu diário: “O cotidiano do posto de saúde é insano, caótico eu diria. E todos(as) os(as) funcionários(as) que eu conversei até agora citaram pelo menos uma vez a palavra caos quando se referiram ao trabalho.” (Diário de campo). Além da estrutura e falta de materiais, a US está sempre lotada, salvo em dias de muita chuva.

Os(as) profissionais indicam que a US se trata de uma UPA, devido à demanda altíssima que recebem. JP, médico, já me disse que poderiam ter dez médicos a mais na US e a demanda sempre ia continuar altíssima, pois a população é muito demandante. Demandante, conforme eu anotei ao longo de minhas observações, devido a própria situação de vulnerabilidade socioeconômica. É importante destacar que para além da demanda alta de atendimentos, outro ponto que pode auxiliar na visão da US como uma UPA é o fato de ela ficar aberta desde as 7 da manhã até as 22 horas.

Se a saúde da população está tão fragilizada, temos que olhar também para as condições que essas pessoas vivem. Existe saneamento básico? Tem água potável? Tem dinheiro para frutas, legumes, castanhas, etc. no mercado? Tem trabalho com condições dignas e carteira assinada? Tem moradia digna? Tem espaços de cultura e lazer para as pessoas? Tem uma educação de qualidade? Tem um bairro seguro para se morar? Tem roupa suficiente pra usar no inverno e não ficar doente com tanta facilidade? Todas as respostas para essas perguntas são negativas. Então, como as pessoas vão deixar de acessar o posto de saúde com problemas agudos? Segundo enfermeira Cássia:

Então, claro, no turno inteiro da unidade, desde a hora que abre até o final, as demandas da atenção primária, elas têm sido mais agravadas. Então, não é mais o hipertenso, o diabético já é o hipertenso completamente descompensado, que chega com uma pressão super alterada, é o diabético que já tá, enfim, sendo amputado já por lesão. As coisas estão mais graves porque o sistema de saúde municipal tá muito frágil, tá muito fragilizado. Os acessos à atenção secundária e outros serviços mais

especializados é muito dificultado. A gente vê pela nossa lista do GERCON lá. A nossa fila de espera do GERCON, às vezes pra uma coisa muito básica, muito simples, é de 3.000 dias. Esses dias mesmo teve uma paciente com muita dor, uma hérnia umbilical, várias coisas e 3 mil dias de fila de espera. Com todos os exames, com tudo, com toda a prioridade. E não estava aquela prioridade 5 no sistema, já estava uma prioridade 3. Então essa é a fila de espera para quem já está agravado. Então daí é uma coisa que, acho que a nível municipal; Não se tem feito atenção primária preventiva, né? Que é a ideia toda de uma primária, né? Não se tem feito. E daí isso vai refletir lá no posto, isso vai refletir na emergência lotada, isso vai refletir em tudo, entendeu? (Enf. Cássia).

E essa demanda intensa acaba por pressionar os(as) funcionários(as) a realizar de forma rápida os atendimentos aos pacientes e muitas vezes não conseguirem dar maior atenção a eles. As técnicas de enfermagem têm cerca de trinta pessoas para chamar no acolhimento durante alguns momentos do dia. Têm médicos que, numa manhã apenas, fazem vinte atendimentos. Têm enfermeiros(as) que estão com uma lista enorme de demandas e às vezes apagando três “incêndios” ao mesmo tempo.

E como há muita demanda, a fila no acolhimento costuma demorar em torno de uma hora e trinta minutos até duas horas. Algumas pessoas já chegam mais bruscas para o primeiro atendimento e com mais reclamações, que acabam interferindo também na forma como o(a) profissional lida com a situação, sendo sempre esse momento uma via de mão dupla onde as relações que se estabelecem fazem total diferença no resultado da consulta.

Outro fator que agrega ao “caos” é a falta frequente de funcionários(as). Em sete meses na US, nunca vi um dia o quadro completo das equipes, sempre, pelo menos, alguém faltando, mais frequentemente no mínimo duas pessoas. Não foram raros os dias que a US abriu só com um médico e uma enfermeira até às dez horas e trinta minutos da manhã, quando o preconizado seria dois profissionais de cada expertise.

Assim sendo, todos(as) profissionais destacam cansaço, esgotamento e uma demanda muito mais alta do que conseguem suprir. Como exemplos de falas sobre o cotidiano: “Eu acho que o posto ali, aquele posto especificamente, ele tem uma população muito grande e acaba sempre apagando incêndio. Então eu acho que talvez durante o turno da tarde, durante o dia a gente consegue um pouquinho mais, mas durante a noite acaba sendo meio UPA.” (Enf. Polina).

Por fim, agregado a esses pontos, nestes meses de observação, outro fator a ser destacado, e, que torna o cotidiano mais estressante, segundo a maioria dos(as) profissionais, com quem conversava, é o das relações interpessoais. Visto que um fator que parece ajudar nesse distanciamento é uma certa “rixa” entre turno da manhã (7:00-16:00) e da noite (13:00-22:00), sendo três equipes de manhã e duas de noite. A manhã acha que a noite não faz coisa alguma e a noite acha que o trabalho da manhã é muito fácil, segundo a enfermeira Cássia. Nas

entrevistas com os(as) funcionários(as) da US, a maioria apontava não sentir que as relações internas atrapalhavam os atendimentos.

Os pontos que aqui tratamos são essenciais para pensarmos em como os(as) jovens e profissionais de saúde se relacionam com a US, e vão ser centrais adiante quando analisarmos a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens nos ambientes da US e nas escolas que também trouxemos neste capítulo. A seguir, olharemos para as bases de trabalho de professores(as) e funcionários(as) da US no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, adentrando em seus cotidianos de trabalho.

6. “SEGUIMOS AS DIRETRIZES”

As políticas públicas circundam a nossa vida e atravessam nossos cotidianos, nós percebendo ou não. Hyatt et al (2023, p. 62, tradução nossa) falam disso quando destacam que “todos nós existimos nas interseções de uma variedade de programas e políticas, iniciativas e incentivos, desincentivos e dissuasores. Não nos movemos por estes campos sobrepostos como autômatos soberanos”.

“Seguimos as diretrizes” é uma frase dita tanto na escola quanto na US ao perguntar para os(as) agentes de saúde e de educação como abordam as questões de saúde sexual e reprodutiva juvenil. Sabemos que as políticas são muito mais do que documentos contendo regras e diretrizes, elas se dão no cotidiano de atuação dos(as) agentes, mas para entender o trabalho destes(as), precisamos primeiro conhecer as políticas que os embasam.

Um primeiro ponto a se destacar é que as normas e leis brasileiras num geral são mais progressistas do que a sociedade num geral. Esse é um ponto que vemos com clareza quando falamos da SSR juvenil no que se refere aos protocolos de atendimento da unidade de saúde, que destaca que os direitos sexuais e reprodutivos dos(as) jovens devem ser respeitados, mas que não vemos na última publicação da BNCC do Ensino Fundamental e Médio onde a palavra “gênero” foi retirada das discussões e a sexualidade juvenil foi resumida a “reprodução humana” (Brasil, 2017, 2018).

Nesta tese entendemos que as normas, diretrizes e protocolos são documentos importantes para ajudar na regência do trabalho dos(as) burocratas de nível de rua, mas que a implementação das políticas públicas vai muito além deles. Como já vínhamos discutindo no capítulo dois, a implementação se dá no cotidiano, na relação estabelecida entre agente e usuário(a) da política pública, sendo a norma uma parte que influencia nesse encontro, mas que ela sozinha não implementa nenhuma política. A norma é um importante guia, mas não conhece cada contexto, cada usuário, nem cada situação que os(as) BNR enfrentam. Por isso, a agência dos(as) profissionais também é importante para que a política seja implementada da melhor forma possível.

Ainda, a norma algumas vezes pode não respeitar os direitos sexuais e reprodutivos juvenis, e caso isso aconteça, pois a norma não pode ser considerada como uma verdade indiscutível. Ou seja, seguir a norma sempre não vai nos levar ao melhor resultado possível para garantir os direitos juvenis. Na sequência, iremos apresentar as principais políticas para a atuação dos(as) agentes de nível de rua da saúde e educação de Porto Alegre, no que concerne

a saúde sexual e reprodutiva dos jovens, mas não com o objetivo de colocar elas como verdades absolutas, mas de anotar em que medida estão presentes no cotidiano dos(as) profissionais. Começaremos pelas escolas que acompanhei, ambas da rede estadual de ensino e, após, iremos para a unidade de saúde. Inicialmente faremos uma análise documental e na sequência trabalharemos a partir de entrevistas e observação de cunho etnográfico.

6.1 DA LEI AO CHÃO DA ESCOLA

No que se refere à saúde sexual e reprodutiva dos jovens bem como políticas voltadas para o ambiente escolar no Ensino Médio, um primeiro ponto a ser destacado é a dificuldade de encontrar uma plataforma ou base onde todos os documentos estejam inseridos, o que, pensando no cotidiano de professores(as) é um obstáculo principalmente devido à demanda de trabalho e, em alguns casos, entraves que estes(as) possam ter na utilização das plataformas digitais.

Por isso, como base inicial da discussão, partimos de políticas no nível macro e que chegam até o nível municipal - nem sempre da mesma forma que destacado pela União. Primeiro temos a Lei nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996. Esta lei organiza o sistema de ensino no Brasil, mas não chega a citar termos como “saúde sexual” ou “saúde reprodutiva”. De toda forma, a LDB destaca a formação integral do(a) aluno(a), ou seja, olhar para seus aspectos físicos, emocionais e sociais e cita a importância de se trabalhar com temas transversais.

Oriunda dela, temos a promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que são documentos organizados pelo Ministério da Educação (MEC), principalmente entre 1997 e 2001, visando orientar os currículos das escolas do Ensino Fundamental e Médio. Um dos temas transversais dos PCNs é “Orientação Sexual”. Lê-se:

Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano, do nascimento até a morte. Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática e pluralista. Inclui a importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/Aids e da gravidez indesejada na adolescência, entre outras questões polêmicas (Brasil, 1997, p. 287).

Aqui, não se destacou apenas o fator biológico da sexualidade, mas também o entendimento da sexualidade como construção social e parte importante do desenvolvimento dos(as) alunos(as) onde o trabalho com o tema deve ocorrer dentro da programação das aulas,

em conteúdos transversais, em diferentes áreas do currículo e não somente nas aulas de Ciências e em programações extras como palestras (Brasil, 1997; Altmann, 2001; Demartini; Silva, 2016).

Em extensão aos PCNs foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) em 2000 (Brasil, 2000). Leite (2019) analisou a falta da palavra “gênero” e/ou “sexualidade” nos documentos dos PCNEMs enquanto ambas se mantinham ainda nos PCNs. Em 2015, foi lançado o PCN+ Ensino Médio Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e em sugestões de discussão e argumentação de temas de interesse de ciência e tecnologia lê-se:

Analisar de que maneira textos didáticos, revistas, jornais, programas de tevê e rádio tratam questões relativas à sexualidade como as questões de gênero, às expressões da sexualidade, às relações amorosas entre jovens, às doenças sexualmente transmissíveis, distinguindo um posicionamento isento, bem fundamentado do ponto de vista científico, da simples especulação, do puro preconceito ou de tabus (Brasil, 2015, p. 38).

Aqui, apontam-se alguns temas relacionados à sexualidade no que se refere aos fatores biológicos, com pequeno destaque às discussões sobre sexualidade. Para alguns pesquisadores, este documento destaca o foco biológico, uma abordagem superficial das questões de gênero, higienista da sexualidade e heteronormativa (Marins et al, 2023). Apesar disso, “o documento oficial (PCN) corresponde à legitimação da abordagem da diversidade sexual e de gênero na escola” (Silva; Brancaleoni; Oliveira, 2019, p.1539) sendo um marco importante na história da educação e ensino no Brasil.

Os Parâmetros são orientações e sugestões de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, mas não precisam ser necessariamente seguidos e isso, segundo Vieira, Matsukura e Vieira (2017) e Coelho e Belchior (2017) acaba refletindo na falta de conhecimento e disseminação dos PCNs entre os(as) professores(as).

Depois dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Lei nº 13.415 de 2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo novas regras para o Ensino Médio, o conhecido Novo Ensino Médio (Brasil, 2018). Em 2017 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) mesmo sem uma parte específica voltada ao Ensino Médio. Dela foram retirados os termos “gênero” e “orientação sexual”, temas que passaram a estar subsumidos nas “dimensões da sexualidade humana” (Brasil, 2017, p. 347). Se olharmos para os temas integradores e contemporâneos da BNCC, observamos que não há referência à

temática gênero e à sexualidade. Logo, como destaca Marins et al (2023), apagam-se estas discussões.

Na versão oficial da BNCC do Ensino Fundamental, a menção explícita da temática sexualidade observa-se apenas no componente de Ciências e restrita ao oitavo ano do ensino fundamental:

Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. (EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) (Brasil, 2017b, p. 349).

Apesar de sublinhar as perspectivas sociocultural, afetiva e ética, ao analisarmos todo o texto da BNCC do Ensino Fundamental, vemos uma abordagem que foca na dimensão biológica que busca prevenir a gestação e as ISTs. Vicente (2024) destaca “Enquanto em 1997 os Parâmetros Curriculares de Orientação Sexual são oficializados para serem implementados nos currículos escolares, decorridos vinte anos o quadro revela um profundo cerceamento em torno dessa temática.”

A BNCC especificamente no que se refere ao Ensino Médio não traz em nenhum momento qualquer referência à saúde sexual e reprodutiva, sexualidade ou gênero. O único momento em que aparecem discussões sobre reprodução é ao falar de competências específicas: “Nessa competência específica, podem ser mobilizados conhecimentos conceituais relacionados a: origem da Vida; evolução biológica; registro fóssil; exoBiologia; biodiversidade; origem e extinção de espécies; [...] reprodução e hereditariedade; genética mendeliana; ” (Brasil, 2018, p. 556). Nesse sentido, a reprodução aparece na legislação como uma temática possível de ser abordada, mas num viés biologicista.

Logo, professores(as) não têm uma base de conteúdos para trabalhar a sexualidade durante o Ensino Médio. Eles podem trabalhar? Nada impede-os(as), mas a escolha parte da disponibilidade e pretensão de cada professor(a), entrando aí a agência (Maynard-Moody; Musheno, 2022) e abrindo amplo espaço para os valores morais destes(as) profissionais entrarem em cena. Como destacam Xavier e Dias (2023), normalmente as aulas no Ensino Médio acabam tratando apenas de gestação e das ISTs, restringindo todo um diálogo possível sobre a sexualidade.

Como falamos anteriormente, os professores e a professora de Biologia têm pouco tempo em sala de aula, e isso também influencia na forma com que eles abordam a SSR, sendo que o pouco tempo de aula influencia negativamente no espaço para discussões sobre SSR para além do contexto biologizante. O interessante é que mesmo com poucos períodos de aula na semana, os(as) profissionais ainda falam sobre o “problema da gravidez na adolescência” com as turmas, sempre que observam a possibilidade.

Ainda, é importante apontar a resolução que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, promulgadas em 2018, tendo em vista as alterações introduzidas na Lei nº 9.394/1996 (LDB) pela Lei nº 13.415/2017. Aqui, lê-se em dois momentos sobre sexualidade ao apontar que a proposta pedagógica das escolas deve considerar a:

XV – promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos a raça e etnia, religião, gênero, identidade de gênero e orientação sexual [...] XIX – atividades intersetoriais, entre outras, de promoção da saúde física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de drogas (Brasil, 2018, p. 13).

As Diretrizes servem como base para organizar os currículos, mas não existe qualquer tipo de obrigatoriedade em segui-las, diferente do que acontece com a BNCC que define o conjunto mínimo e obrigatório de competências a serem desenvolvidas. Logo, mesmo as Diretrizes citando a importância das discussões de gênero e orientação sexual, elas são apenas recomendações, ficando a cargo dos estados e, depois, das escolas, apoiarem seus currículos nelas.

Para Marely (2024, p. 41), ao analisar a BNCC, “relegar as discussões sobre gênero, diversidade e educação sexual a um plano secundário nas diretrizes curriculares nacionais, abre-se espaço para que concepções particulares e crenças individuais acabem por direcionar ou impedir o necessário debate plural e laico acerca desses temas no ambiente escolar.”

As críticas à BNCC são intensas e não vão apenas para o campo da falta de discussão sobre sexualidade em seus múltiplos aspectos (Xavier, Dias, 2023; Sartori, 2022; Vicente, 2024, Marins et al, 2023). Atores como Santos, Miesse e Carvalho (2021) e Branco et al (2018) também apontam para a desigualdade educacional imposta pela BNCC, criada em um viés de políticas neoliberais, uma vez que o currículo visa formar mão de obra para atender ao mercado de trabalho.

No que se refere à BNCC em nível de Rio Grande do Sul, falamos do Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio (RCGEM) publicado pelo Governo Estadual em 2021 e que visa complementar a BNCC e é referência obrigatória para a elaboração dos currículos das escolas do Estado. Ali há um subcapítulo dedicado aos “temas contemporâneos e transversais”

onde um subitem é intitulado “Saúde, sexualidade e gênero” (Rio Grande do Sul, 2021). Este aponta para a escola como um importante espaço de sociabilidade e que

não deve ser o espaço de reproduções dos padrões de comportamento sociais de representações estereotipadas de sexualidade. A escola, por essa transversalidade, pode contribuir para superar introjeções culturalmente instaladas na sociedade desde a violência sexual, o respeito ao corpo, às vontades e às necessidades individuais, até as superações das discriminações de gênero e das linguagens hegemonizadamente masculinizadas que reproduzem violências e discriminalizam ações contra a vida e as individualidades (Rio Grande do Sul, 2021, p. 77).

Aqui, não fala-se especificamente em “orientação/diversidade sexual”, mas apresentam-se diversas questões que não eram trazidas na BNCC como superação da discriminação de gênero, heteronormatividade, respeito ao corpo e à individualidade. Em nenhum momento se cita a gravidez na juventude como uma questão, pelo contrário, busca-se afastamento da noção biologicista.

Neste documento temos um quadro com as habilidades da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias onde uma das ementas se refere a identificar e analisar vulnerabilidades que os jovens estão expostos buscando desenvolver sua prevenção e saúde. Lê-se: “Propor ações coletivas com o intuito de informar e instruir o estudante, identificando e incorporando valores importantes para si e para o coletivo quanto: às IST’s, aos vícios, às drogas, à diversidade e à sexualidade, vinculados aos estudos de bioquímica, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema digestório, compostos orgânicos.” (Rio Grande do Sul, 2021, p. 107).

Em quadro referente à estrutura curricular do Modelo de Itinerário Formativo Saúde I, duas das sugestões de objetos do conhecimento são: “Sistema reprodutor; Sexualidade e identidade de gênero.”(Rio Grande do Sul, 2021, p. 2023). Assim, a partir do RCGEM a sexualidade e identidade de gênero ganhariam um espaço de maior destaque nas salas de aula do Rio Grande do Sul.

Gigante (2024) aponta para a diferença entre a BNCC e RCGEM e que os últimos não temem tanto o uso dos termos “sexualidade”, “sexo”, “diversidade” e “gênero”. Segundo ela:

Isso não significa que o estudo da sexualidade nas escolas gaúchas esteja assegurado, uma vez que os RCGs deixam em aberto para os municípios a elaboração dos seus próprios referenciais. Modificações e até a exclusão total dos termos e do tema podem ocorrer em algumas cidades. A discrepância entre os documentos destaca a influência da regionalização na educação e sugere que a implementação prática da Educação Sexual pode variar significativamente dependendo do quadro adotado (Gigante, 2024, p. 25).

Ou seja, embora o RCGEM destaque a sexualidade juvenil, a eficácia de sua aplicação não depende apenas desse documento, mas das formas com que o município adota ou não tal Referencial. E ainda, caso adote, a forma com que os(as) profissionais irão lidar com a temática podendo, como sabemos, escolher não abordar alguns assuntos.

No atual contexto de recrudescimento das discussões de gênero e sexualidade da BNCC, em tempos de crescimento do movimento “Escola Sem Partido” e de indícios de crescimento do pânico moral em relação à sexualidade juvenil, temos também a retirada dos termos “diversidade sexual” e “gênero” de 77% dos Planos Estaduais de Educação, segundo Almeida (2018), sendo que apenas sete mantiveram a menção à diversidade de gênero e sexual, estando o RS entre eles: AL, AP, MA, MT, PR, RS, RN.

A Lei nº 14.705, de 2015, instituiu o Plano Estadual de Educação (PEE) do Rio Grande do Sul em cumprimento ao Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014. O PNE não cita em qualquer momento a palavra “gênero” ou “orientação sexual” ou “sexualidade”, falando apenas em garantir políticas de combate à violência sexual nas escolas (Brasil, 2014).

Enquanto o texto do Projeto do PEE RS fazia vinte e nove menções aos termos “gênero”, “sexualidade” e “diversidade/orientação sexual”, o texto final tem apenas seis (Santos, Beatrice, 2020). O PEE RS defende o respeito à orientação sexual em duas oportunidades: a estratégia 8.10 visa a garantia da formação permanente aos docentes de todos os sistemas de ensino, com diversos temas incluindo “gênero e sexualidade, fortalecendo a função social da educação como indutora de práticas de respeito ao outro e como propulsora de ações solidárias, que ajudem a desenvolver o espírito republicano ” (Rio Grande do Sul, 2015, p. 25). Já a estratégia 8.12 aponta para a promoção de condições para a “elaboração de propostas curriculares que incluam como temas transversais as questões de inclusão, direitos humanos, etnias, gênero e sexualidade, de modo a estimular as discussões sobre formas de superar as discriminações e os preconceitos” (Rio Grande do Sul, 2015, p. 25).

Nesse sentido, vemos que o PEE RS aponta, não necessariamente, para como professores(as) devem organizar suas aulas, mas em ferramentas para ajudá-los(as) a trabalhar com “gênero e sexualidade”, porém, como já trouxemos brevemente, veremos que estes(as) profissionais não recebem formação ou auxílio para pensar nessas temáticas, seja ao longo da formação acadêmica ou em formações posteriores junto da escola.

O panorama traçado até aqui, em nível nacional e estadual, nos leva até o município, no nosso caso, Porto Alegre. Na capital gaúcha, a Lei nº 11.858, de 2015, instituiu o Plano Municipal de Educação (PME) que tem validade de 10 anos. A Lei traz as diretrizes, as metas

e as estratégias do município, no que se refere à educação, onde não é citado em momento algum educação sexual, saúde sexual e reprodutiva ou gênero, lacunas nas discussões que apontam para a falta de importância dada à temática pela Secretaria de Educação.

Há uma referência à gravidez na juventude quando a Lei cita a meta de universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevar a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio. Uma das estratégias colocadas é:

3.8 - criar, até o segundo ano deste PME, em regime de colaboração, políticas municipais de acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda no ensino médio, observando frequência, aproveitamento escolar e interação com o coletivo, bem como situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude (Porto Alegre, 2015).

Aqui, mostra-se a preocupação em manutenção de jovens mães e pais nas escolas. Em três momentos distintos aparece a preocupação do Plano com a violência sexual, mas nunca relacionada com discussões de gênero, orientação sexual ou de saúde sexual e reprodutiva, como destacam Borges e Borges (2018).

Então, se pensarmos no nível nacional e nas discussões de gênero, que eram presentes com mais força nos PCN e PCNEM, na ideia de temas transversais, passando pelas DCN e DCNEM, pelo RCGEM e pelo PEE RS, onde estas discussões eram mais presentes e profundas - mesmo com suas ressalvas por ainda destacarem majoritariamente o lado biologicista -, acabamos chegando em um PME que não aborda a sexualidade, o que é coerente com a principal legislação nacional, a BNCC do Ensino Médio, não destacar a necessidade de discussões sobre a sexualidade juvenil.

O que podemos apontar diante de tudo isso é o “recuo nas políticas públicas de gênero e sexualidade” (Seffner, Parker, 2016, p. 29). Cohen (1972) e Bozon (2002) apontam para a noção de pânico moral, a qual usamos aqui para entender as mudanças desde a LDB de 1996 até os dias atuais. Este pânico se mobiliza, segundo Borges e Borges (2018, p. 16) pela “disseminação de crenças alarmistas em torno da “ideologia de gênero” e, portanto, tais constatações levam à observação de um retrocesso conservador na sociedade brasileira, em que vetar o estudo sobre a diversidade nas escolas é, sobretudo, a negação da existência da diversidade humana.”

Por exemplo, no que se refere à sexualidade e a BNCC, a retirada das discussões nas escolas sobre sexualidade e gênero traz riscos de reforçar discriminação e preconceito com aqueles(as) que não correspondem ao padrão heteronormativo, podendo levar inclusive a

evasões escolares. Ainda, a falta de informações sobre camisinhas, contracepção e ISTs, bem como a falta de abertura para falar com professores(as), pode fazer com que aumentem os casos de infecções e gravidez não desejadas pelos(as) jovens, consequentemente aumentando as desigualdades no acesso à saúde sexual e reprodutiva de camadas populares.

Já em um nível micro temos os Planos Políticos Pedagógicos da Escola A e da Escola B. Nenhum deles aponta para a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens. Ainda, nos Regimentos Escolares e Currículos Escolares de ambas as instituições também não constam informações sobre a temática.

Aqui, vimos que as bases legislativas do trabalho de professores(as) atualmente são o PCNEM, o BNCC Ensino Médio, o Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio, o Plano Municipal de Educação e os documentos que integram a identidade e diretrizes de cada uma das escolas. São as bases legislativas que apoiam - ou deveriam apoiar - os(as) professores(as), seja na elaboração dos conteúdos de aula ou em suas formações continuadas. Essas são as políticas que os(as) circundam em relação à escola e à sexualidade, mas o quanto os três professores e a professora que acompanhei conhecem dessas políticas? O quanto as utilizam? Fazem diferença no trabalho deles(as)?

6.1.1 “Ah, isso tem lá na BNCC”

Ao iniciar minhas observações na escola A, eu me encontrei com o professor de Ciências e de Biologia, do turno da manhã, Felipe. Ele possui 48 anos, é branco, heterossexual, atua como professor nessa escola há quase dez anos e sempre lecionou na rede estadual de ensino. Ele também fez mestrado em Ensino de Ciências. Quando expliquei para o professor Felipe sobre a minha pesquisa e falei do interesse em observar as aulas e acompanhar como a temática da sexualidade era tratada em sala, recebi a seguinte resposta: “Ah, isso tem lá na BNCC, que falam no oitavo ano, né? Teria que acompanhar minhas aulas com eles, estou trabalhando nisso agora.” Ele comentou que as meninas disseram: “Deus me livre de ter filho.” “Não quero ter filho.” Ele disse que tinha uma turma “bem legal de acompanhar” porque já tem “mais discernimento”, tem “mais noção”, segundo ele.

Na mesma escola, o professor de Biologia da noite é Gabriel, 33 anos, branco, heterossexual, se formou em Biologia em 2015 e desde então atua como professor da rede estadual. Ele dá aulas para as turmas do Ensino Médio noturno. Ao iniciar as conversas com

Gabriel, ele prontamente disse que não trabalha com o tema: “Acho que é coisa de oitavo ano, né? Lá na BNCC.” E disse que eu poderia realizar atividades com as turmas para conversar um pouco sobre “porque é o único jeito de tu ver sexualidade aqui.” (Prof. Gabriel).

A conversa com os professores da escola A foi muito similar com a minha entrada na escola B, dialogando com a professora Monique, branca, heterossexual, 38 anos, que se formou em Biologia em 2015 e trabalha desde então como professora da rede estadual de ensino, sendo há oito anos nesta escola. Atualmente, ela está com uma pós-graduação em suspensão na temática de metodologia do ensino de Ciências.

Na escola, ela atua com turmas de primeiro e terceiro anos do Ensino Médio na parte da manhã e com todas as turmas do Ensino Médio à noite. Assim, como Felipe, Monique foi solícita para disponibilizar a minha entrada em sala de aula e me deixou à vontade para que eu acompanhasse o quanto eu quisesse, mas depois de três semanas também sugeriu que eu “desse umas aulas sobre (SSR) porque os alunos vão gostar muito.” Falávamos bastante sobre como o tema era importante “porque é algo que não se ouve em casa e são assuntos do cotidiano deles que é necessário se falar.” (Prof. Monique). Ela lamentava que ele não fosse mais trabalhado na escola, mas também não dava indícios de que ela mesma abordaria em algum momento, se isentando de qualquer responsabilidade em relação a isso.

O outro professor da escola B, Ricardo, colega de trabalho de Monique, dá aulas de Biologia no Ensino Médio apenas para o segundo ano. Ele tem 44 anos, é branco, heterossexual, trabalha desde 2011 nesta escola e antes disso trabalhou em outras duas escolas estaduais, tendo se formado na graduação em 2004. No momento está cursando também Química e faz uma especialização chamada Ciência 10. Desde nosso primeiro contato, ele disse que não trabalhava sobre SSR, que isso não era tema de segundo ano e que seguia a BNCC.

As quatro primeiras conversas com os professores e a professora citam a BNCC e o trabalho no currículo no oitavo ano. Ao longo dos dias de observação das aulas, conversas de corredores e acompanhamento da sala dos(as) professores(as), eu incentivava os professores e a professora a falarem sobre qualquer espécie de regimento, plano e/ou diretriz curriculares que utilizassem em seus trabalhos.

Certo dia, o professor Ricardo tinha uma aula de trilhas de aprendizagem com um segundo ano e decidiu que iriam para o pátio e os(as) estudantes poderiam praticar algum esporte e/ou conversar, pois ele “não sabia mais o que passar de conteúdo nessa trilha.” (Prof. Ricardo). Enquanto os(as) jovens estavam sentados, eu e o professor falávamos sobre as atividades que ele já tinha feito sobre sexualidade, que ele relatou ser de 2022 e que antes disso ele não dava esta atividade visto que, segundo ele, não tinha referências na BNCC.

Novamente, mais um professor fala somente de BNCC e não cita, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio ou até mesmo os Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio. Já durante a entrevista com o professor Felipe, este também aponta a BNCC como central:

Pela LDB existe aí e daí isso geralmente bate no terceiro ano início lá e bate no oitavo ano também. Pela Base Nacional Comum Curricular, se eu não me engano era isso. Mas sempre se fala. A partir do momento que vai trabalhar segundo ano e vírus e bactérias, trabalho toda a parte sexual também no sentido de contaminação, o que contamina, o que pode fazer, o que não pode, tratamentos, enfim. Volta uns assuntos, mas não que seja específico. O mais específico é o oitavo ano que vem a descoberta do corpo humano com órgãos sexuais masculinos e femininos, doenças associadas (Prof. Felipe).

Aqui, assim como na fala de Ricardo, aparece uma incerteza por parte do professor Felipe sobre como se estrutura a BNCC. Como acabamos de ver, na BNCC do Ensino Médio não há referência sobre saúde sexual e reprodutiva. Mesmo assim, o professor aborda de alguma maneira apesar de afirmar que o momento que se discute em profundidade realmente é o oitavo ano do Ensino Fundamental.

Gabriel, professor à noite na Escola A, também destaca principalmente que se baseia na BNCC: “Eu me baseio na BNCC, né? BNCC. Tem... como é que é? Referencial... Referencial curricular gaúcho. Referencial não sei lá, não lembro o nome direito, que é do Rio Grande do Sul. Mas na BNCC tem tudo.” (Prof. Gabriel).

Já a professora Monique foi a única que não citou a BNCC como sua base de planejamento de aulas no momento da entrevista. Ela aponta o seguinte:

Eu trabalho ainda o antigo, que é no segundo ano que a gente trabalha o tema da sexualidade. Não falo nem da embriologia que a gente trabalha lá nos embriões e tal. Eu falo da sexualidade, do fato do nome específico do órgão sexual deles porque eles não conhecem, eles conhecem como piu-piu, pinto, tudo que é coisa que tu possa imaginar, mas não conhecem o nome, eles não conhecem as funções, eles não sabem nem o porquê. [...] Até entrar o novo ensino médio era o que nós trabalhávamos. Até posso te mandar o que eu trabalho, pois as coisas antigas, não esse novo, porque esse novo não dá (Prof. Monique).

Perguntei a que “antigo” Monique se referia e ela disse que não lembrava, mas que podia separar o material e me encaminhar. Ela me relatou estar com dificuldade para lembrar o nome, até que conseguiu: PCNs Ensino Médio. Ela é a única dos quatro que se baseia nos Parâmetros e não na Base Nacional.

Na sequência, eu falei sobre ter acompanhado as aulas do professor Ricardo no segundo ano do Ensino Médio e ele não discutir questões referentes à saúde sexual e reprodutiva. Ela

concordou e disse que era um professor que “trabalha uma matriz curricular nova” e que os(as) alunos(as) chegam ao terceiro ano do Ensino Médio “sem embasamento nenhum.” São os dois professores da escola B de Biologia, porém com conteúdos e didáticas que divergem.

Certo dia, conversava com o professor Felipe no intervalo da aula e ele tratava sobre as normas que regem o trabalho dos(as) professores(as): “Ah, essas políticas muda o tempo todo, daqui a pouco sai o Novo Ensino Médio, acaba o negócio de trilhas e só o professor que se ferra.” (Prof. Felipe). Ele demonstrava indignação ao falar, sendo as trilhas sempre uma questão vista com muita negatividade pelos(as) agentes das escolas A e B.

Aqui, se estamos falando das diretrizes que estes(as) agentes usam, não podemos deixar de tratar sobre a formação que eles têm acerca da saúde sexual e reprodutiva. Formação esta que todos(as) destacaram como inexistente com falas muito similares tendo apenas discutido sobre fatores biológicos reprodutivos durante a graduação. Este é um ponto muito importante também para analisarmos o quanto os(as) professores(as) falam sobre esse tema e os motivos para sua presença e/ou sua ausência.

Vale citar novamente o estudo de Martin (2010), que trouxe as percepções de professores(as), destacando as dificuldades no trabalho a respeito da saúde sexual e reprodutiva juvenil, sendo uma delas a falta de maior aprendizado acerca da temática nos cursos de graduação e de formação continuada sobre o tema. Ainda, Silva et al (2018) identificou que 95% dos alunos de Biologia já tinham tido contato com o tema na universidade, mas ao aprenderem sobre sexualidade, o fazem quase que estritamente discutindo sobre reprodução.

Vimos que as políticas de nível estadual e municipal são quase inexistentes na fala dos(as) agentes de educação. Fica evidente a falta de conhecimento sobre o Plano Municipal de Educação e do Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio. Também não se fala dos Parâmetros Curriculares Nacionais que, apesar de terem sido substituídos pela BNCC, ainda poderiam ser usados como referencial de trabalho. O Plano Político Pedagógico ou outros documentos de base, do funcionamento da escola, também não são citados em nenhum momento.

Na escola A e B não há uma regulação e controle direto acerca dos planos de aulas de professores(as) por parte da supervisão da escola, sendo a autonomia dos(as) professores(as) um dos grandes diferenciais de seu trabalho e uma das características que estes(as) mais valorizam (Puentes-Montoya, 2018). Tanto que vemos professores como Ricardo, que não discutem sobre saúde reprodutiva em sala de aula e professores como Gabriel e Felipe que o fazem.

Guimarães, Bernardo e Borde (2022, p. 10) apontam para o trabalho relacional que professores(as) exercem com os(as) estudantes como um ponto central de sua agência e também “suas possibilidades de adaptar ou mesmo suplantar currículos abstratos em sua prática cotidiana, conforme acredita ser o mais adequado aos seus alunos. Destarte, ele se torna elaborador de currículos e não seu mero implementador, como nos alerta Lipsky (1980), e tal discricionariedade altera significativamente a política original.”

Como os(as) agentes têm agência, isso os(as) possibilita tomar decisões para além daquilo que se coloca na norma escrita. E porque fazem esses deslocamentos? E o que eles significam? É nesse momento que entram os mecanismos de governança reprodutiva que estaremos focando, nosso olhar, nos capítulos seguintes. Antes disso, também olharemos para a legislação na unidade de saúde.

6.2 DA LEI AO CHÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

No campo da saúde, diferente do que acontece na educação, no município de Porto Alegre, existe uma plataforma onde as bases legais para o trabalho dos(as) agentes de unidades de saúde de Porto Alegre estão localizadas: a Biblioteca Virtual de Atenção Primária à Saúde (BVAPS)³. É a partir dela que foi feita a pesquisa das políticas que circundam o trabalho de enfermeiros(as), médicos(as), agentes comunitárias(os) de saúde e técnicas(os) de enfermagem, no que se refere à saúde sexual e reprodutiva juvenil.

Na sequência, iremos destrinchar os conteúdos da Biblioteca. Inicialmente, falaremos de um programa que visa unir escola e unidade de saúde: o PSE. Em Porto Alegre, todas as escolas da rede pública são pactuadas com o Programa totalizando 568 estabelecimentos. No Relatório Anual da Gestão de 2024, do município de Porto Alegre, aponta-se que mais de 80% das escolas pactuadas receberam alguma ação do PSE em 2024, o que consideram “bastante significativo” (Porto Alegre, 2025, p. 277). Em 2024 foram 8 ações referentes à prevenção da Covid-19, 233 referentes à alimentação saudável, 137 referentes à antropometria, 89 à acuidade visual e 182 referentes à verificação vacinal. Não há referências às ações de saúde sexual e reprodutiva, dado que é muito significativo em nossa pesquisa.

Foi o decreto nº 6.286, de 2007, em parceria com Ministério da Saúde e Ministério da Educação, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE). No quarto artigo do decreto lê-se

³O link para acesso da biblioteca é o seguinte: <https://prefeitura.poa.br/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/programa-saude-na-escola>

sobre as ações em saúde previstas no âmbito do PSE, considerando a atenção, a promoção, a prevenção e a assistência, a serem desenvolvidas numa parceria entre escola e unidades de saúde. Uma das ações é a “XII - promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva” (Brasil, 2007, p. 3).

Uma das linhas de ação do Programa é chamada “Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE): Educação para a Saúde Sexual, Saúde Reprodutiva e Prevenção das DST/Aids e de Hepatites Virais” (Brasil, 2011). Aqui, atividades nos temas que envolvem gravidez na juventude são citadas, considerando que devem ser desenvolvidas sem atitudes preconceituosas e repressoras. O mesmo também ocorre com atividades ligadas a direitos sexuais e reprodutivos.

A importância de discutir os marcos legais dos direitos sexuais e reprodutivos também aparece no documento: “realizar atividades abordando as temáticas da saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das DST/aids e hepatites virais no cotidiano da escola.” (Brasil, 2011, p.18). Depois de 2013, não houve mais publicação de documento com caráter de guia ou diretrizes voltadas ao PSE especificamente tratando de sexualidade juvenil.

Tratando-se, especificamente, de Porto Alegre, a Biblioteca Virtual apresenta o que é o Programa Saúde nas Escolas e os materiais associados ao mesmo. Há guias específicos no que se refere à saúde bucal, saúde mental, saúde alimentar, entre outros, mas nenhum sobre saúde sexual e reprodutiva. Este tema aparece algumas vezes em documentos do site. Primeiro no “Checklist de ações do PSE” em que consta: “Direito sexual e reprodutivo: Foi realizada atividade que abordou direito sexual e reprodutivo (prevenção de gravidez na adolescência, saúde sexual, importância do uso de preservativo, higiene menstrual, conversa sobre ISTs/HIV).” (Porto Alegre, 2023, p.1). Verificamos que essa informação foi replicada do “Caderno do gestor do PSE” (Brasil, 2022) onde saúde sexual e reprodutiva é indicada como um dos campos de temáticas a serem trabalhadas.

Para além do PSE, voltando ao site da Biblioteca Virtual, no guia de políticas é possível acessar a subguia saúde do adolescente⁴, onde constam quatro blocos: Te Liga!; Biblioteca Virtual Te Liga!; Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente (PAIGA); e Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em “Te Liga!”, destacamos um guia: Adolescer - Guia prático de orientações para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens. De início, podemos problematizar o próprio

⁴ Link para acesso da Biblioteca: <https://prefeitura.poa.br/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/saude-do-adolescente>

nome do guia elaborado pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com a Unisinos - uma das universidades da região metropolitana de Porto Alegre - no ano de 2020. O guia possui um tema para cada letra da palavra “Adolescer”. O S nos interessa ao se referir à saúde sexual e reprodutiva onde lê-se:

Tem alguma dúvida que gostaria de compartilhar? Retome o princípio da confidencialidade. Já teve relações sexuais? Idade? Tem parceiro(a)? Sabe como funciona a retirada de preservativos na Rede? Unidade? Gostaria de receber informações sobre contracepção e testes rápidos? Métodos disponíveis na rede: dispositivo intrauterino (DIU), preservativos masculinos e femininos, implante anticoncepcional, contraceptivos injetáveis e orais. Orientar sobre a importância da dupla proteção, que é o uso concomitante do preservativo e método anticoncepcional, para: prevenção de gravidez não planejada, IST/HIV, hepatites B e C. Se você estivesse grávida, contaria primeiro para quem? Gravidez: acompanhamento pré-natal? Convive com o pai da criança? Suporte familiar? Atentar para vulnerabilidades especialmente entre 10-14 anos: circunstância em que ocorreu a gravidez, vínculo com o pai da criança, suspeita de violência? Para estes casos, verificar na biblioteca virtual orientações e serviços especializados disponíveis na rede (Prefeitura Porto Alegre, 2020, p. 6).

Aqui, dá-se uma atenção, principalmente, aos métodos contraceptivos e à gravidez na juventude, enquanto que questões voltadas para orientação sexual, discussões sobre gênero, prazer no sexo e outras não são mencionadas. Por ser um guia, não é obrigatório que os(as) profissionais de saúde o utilizem em seu cotidiano, mas é um instrumento criado para auxiliar no trabalho destes(as) e que se encontra na Biblioteca.

Já o bloco “Biblioteca Te Liga!” nos leva à biblioteca, a qual é uma criação do grupo de Pesquisa de Indicadores de Saúde de Adolescentes e Jovens, vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Unisinos. A Biblioteca Te Liga! busca reunir e disponibilizar os documentos, os protocolos e as publicações, referentes à atenção integral à saúde de jovens.

A terceira aba da página se refere ao Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente (PAIGA) e consta um *card* que apresenta o Programa e outro documento que fala do fluxo do mesmo. O Programa tem como principal função dar assistência ambulatorial a jovens de até 19 anos, que estão grávidas, em um hospital que é referência para esse tipo de atendimento em Porto Alegre, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Ele oferece atendimento integral por meio de equipe multidisciplinar composta por médicos(as), assistentes sociais, enfermeiros(as) e psicólogos(as). Para o(a) profissional solicitar o atendimento, é necessário “solicitar agenda de alto risco, descrevendo que trata-se de gestante adolescente”.

Apesar de o Programa destacar que a condição da gestação na adolescência não é critério absoluto para o encaminhamento ao Pré-Natal de Alto Risco (PNAR), veremos adiante que a maioria das jovens, da unidade de saúde estudada, acabam sendo delegadas para o alto risco,

pois muitos(as) profissionais da enfermagem e medicina encaminham a gestante sempre que ela for jovem, sendo algo de praxe e comum entre eles(as).

Há um documento com uma tabela intitulada “Programas Saúde do Adolescente” e nele constam o PSE, Porto Olhar Alegre e Programa Nacional de Imunização (PNI) - Calendário Vacinal. Também está anexada a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes (PEAISA).

Esta Política foi promulgada em 2010 após a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, de 2006. Naquela ocasião, no que se refere à saúde sexual e reprodutiva, destaca-se:

Garantir os direitos reprodutivos a adolescentes e jovens, de ambos os sexos, no contexto dessa Política, significa assegurar, em todos os casos, as condições de escolha para aqueles que não querem engravidar ou querem planejar uma gravidez, como também a assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, que deve ser assegurada de modo irrestrito, de maneira que a gravidez possa ser desejada, planejada e vivenciada de maneira saudável (Brasil, 2006, p. 26).

Na sequência da criação da Política Nacional, foram criadas as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (2010), que afirmam os direitos sexuais e reprodutivos dos(as) jovens e apontam para a necessidade das políticas atentarem para separação dos papéis de gênero, de trajetória de vida, de preconceitos e estigmas e, inclusive “é fundamental que as linhas de cuidado em saúde considerem a atividade sexual e a vontade de ter filhos, que esses jovens vêm como ‘normal’ e como partes da vida às quais legitimamente têm direito, organizando a rede de saúde para esse atendimento sem interdições e julgamentos discriminatórios.” (Brasil, 2010, p. 84).

Aqui, a Política Nacional e as Diretrizes fazem uma tentativa de parar com a discriminação da gravidez na adolescência, considerando que pode ser sim escolha de alguns(as) jovens gestarem e que os serviços devem estar prontos para atendê-los(as) da melhor forma possível. Este ponto que aparece nas Diretrizes Nacionais não volta a se repetir na Política Estadual de Atenção Integral da Saúde de Adolescentes e Jovens do RS e nem nos protocolos de enfermagem à nível municipal.

A Política Estadual do Rio Grande do Sul busca promover a saúde integral de sujeitos entre 10 e 19 anos e possui três eixos sendo o segundo “Saúde sexual e reprodutiva”. Ele aponta para a importância da dupla proteção, acesso aos métodos contraceptivos, preservativos e planejamento familiar, também trata especificamente da realização de ações educativas para o exercício da paternidade responsável, atenção aos casos de violência sexual e “atenção especial

à adolescente no puerpério, visando evitar uma segunda gestação não planejada.” (PEAISA, 2019, p. 5).

O eixo II segue falando sobre oferecer testes de HIV/Aids, “dispensar atenção especial a adolescentes com maior vulnerabilidade - Redução de danos” (PEAISA, 2019, p. 7), aumentar a vacinação de Hepatite B e HPV e de testes rápidos para HIV e sífilis, com aconselhamento antes do teste e acompanhamento após. Também fala de um acolhimento humanizado quando jovens realizarem teste de gravidez e, em caso negativo, encaminhamento direto para consulta de planejamento familiar. Importante observar como o discurso muda do nível nacional de acolher a jovem que planejou a gestação para o nível estadual visando “evitar segunda gestação não planejada.” (PEAISA, 2019).

Nesse contexto, a Biblioteca Municipal traz também a Nota Técnica Estadual nº 01/2018, de 10 de setembro de 2018, que foi promulgada pensando no processo de criação da PEAISA e teve como assunto os adolescentes e o direito de acesso à saúde. No que se refere à saúde sexual e reprodutiva, o documento aponta para os direitos de jovens como informação e educação sexual, acesso a preservativos e lubrificantes, acolhimento e aconselhamento pós teste de gravidez e direito

à decisão livre e responsável sobre a própria vida sexual e reprodutiva; ao planejamento reprodutivo: escolha livre e bem informada do método contraceptivo para o exercício de uma vida sexual saudável e responsável - anticoncepcional oral ou injetável, diafragma, DIU, preservativos masculino/feminino e, se preciso, a contracepção de emergência (pílula do dia seguinte) (Rio Grande do Sul, 2018, p. 4)

A nota técnica segue discutindo sobre direitos de jovens no tratamento de HIV e sífilis, sobre o pré-natal apontando a inclusão do pai em toda a gravidez e puerpério, fala sobre direito à escola e apoia socialmente o futuro dos(as) jovens falando sobre Bolsa Família, profissionalização, entre outros. Novamente, vemos a saúde sexual e reprodutiva centrada na temática da gestação, apesar de algumas tentativas de falar sobre educação sexual, mas sem citar orientação sexual, prazer sexual ou discussões de gênero, por exemplo. Vemos que o documento faz menção aos jovens homens, apenas no que se refere ao incentivo da paternidade com um olhar focado no período gestacional da mulher, sem uma atenção específica à saúde do homem.

Carneiro, Santos, Macena e Vasconcelos (2016) apontam para a falta de acompanhamento da saúde dos homens nas unidades de saúde, sendo que o cuidado do homem não é visto como central pela equipe de enfermagem e nem pelos próprios homens. Aqui,

podemos citar Barata (2009) e a forma como o determinante social da saúde de gênero influencia o acesso de homens aos serviços.

Nesse contexto, não há nenhuma referência na Biblioteca Virtual do município sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Leal, Figueiredo e Nogueira-da-Silva (2012) analisaram a implementação desta Política em unidades de saúde e constataram que os(as) profissionais tinham pouca ou nenhuma familiaridade com a política, alguns(as) nunca tendo lido a mesma ou tendo participado sobre formações acerca da saúde do homem. Mais de dez anos depois, percebemos que a falta de discussões acerca da saúde do homem segue, refletindo, claro, na juventude.

A última aba da página de políticas da Biblioteca é destinada à violência sexual contra crianças e adolescentes, onde há duas diretrizes importantes: Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; orientações para profissionais dos serviços de atendimento direto a crianças e adolescentes e Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e orientações para profissionais da assistência social, saúde e educação. Ambas Diretrizes falam sobre violência física, psicológica, institucional e sexual e dão informações de como acolher, como proceder no atendimento e como denunciar.

Todos os documentos citados até então são, a princípio, documentos que os(as) profissionais de US têm como base para seus trabalhos, mas chamamos a atenção para o fato de o Plano Municipal de Saúde de Porto Alegre de 2022-2025 não estar presente no site da Biblioteca de Porto Alegre. O Plano cita “A gravidez na adolescência ainda é uma dificuldade encontrada no distrito.” (Secretaria de Saúde Porto Alegre, 2021, p. 233) se referindo a um distrito de saúde específico do município. Assim, vemos a referência da Secretaria à gravidez como um “problema”. O Plano também traz o Calendário de datas comemorativas para a Secretaria Municipal de Saúde e destaca de 01 a 08/02 Semana de Prevenção a Gravidez na Adolescência.

Não há nenhuma referência à Semana no site da BVAPS, mas é importante citá-la já que está no calendário da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ela foi instituída nacionalmente pela Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019, a qual acrescenta mais um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 2019). O artigo institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que deve ser realizada anualmente no início de fevereiro e que tem o “objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.” (Brasil, 2019, p. 1). Esta Lei foi promulgada pelo presidente Bolsonaro e pelos ministros do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) e do Ministério da Saúde (MS).

A primeira campanha da semana foi intitulada “Adolescência primeiro, gravidez depois: tudo tem seu tempo”. Em um dos posters de divulgação, tem-se o seguinte texto: “GRAVIDEZ NÃO COMBINA COM ADOLESCÊNCIA e traz consequências para toda a vida. Informe-se. Reflita. Converse com sua família. Planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde.” Junto deste texto, uma imagem de uma mulher recebendo o diploma universitário. Nas imagens relacionadas à campanha encontram-se mulheres em destaque, reforçando o papel das mulheres na gestação e na maternidade, colocando em segundo plano os homens e a paternidade.

Antes mesmo de ser lançada oficialmente, a campanha recebeu críticas. A Defensoria Pública da União oficializou recomendação, ao Ministério da Saúde, do dia 31 de fevereiro para que não fosse lançada a campanha, porque não há evidências que comprovem a efetividade da abstinência sexual (Zylberkan, 2020). Já o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou recomendação para que o MS e o MMFDH cancelassem a campanha pelo mesmo motivo (CNS, 2020).

Em 2024, sob gestão do governo Lula, foi lançada Nota Técnica nº 2/2024-CACRIAD/CGACI/DGCI/SAPS/MS, que tem como título da Semana: Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência “Prevenção da Gravidez na adolescência, promovendo a saúde e garantindo direitos”. Um ponto inicial importante é o fato de considerarem que: “A gravidez na adolescência pode ser vista com diferentes conotações, tanto como um problema de saúde pública, quanto como um fenômeno social. [...] É importante também destacar as desigualdades sociais e de raça/etnia ao abordar os determinantes da gravidez na adolescência.” (Brasil, 2024, p. 4). A Nota ainda traz sugestões para a APS de como atender e qualificar a atenção à saúde dos(as) jovens, entendendo a importância de ouvi-los(as) e acolhê-los(as) sem discriminação ou moralismos.

Assim, vemos uma mudança expressiva na forma de tratar a gravidez na juventude desde 2019 até atualmente. De toda forma, a nível municipal não foi localizada qualquer informação sobre campanha realizada em 2024, ano em que se fez a pesquisa de campo da tese, mesmo estando no calendário de atividades da Secretaria Municipal de Saúde dentro do Plano Municipal da Saúde.

Voltando à BVAPS, esta também possui um bloco referente a “áreas profissionais” onde, pelas conversas com os(as) agentes foi possível identificar que se concentra a atenção destes(as). No que abarca a área de agentes comunitários de saúde, a página encontra-se sem dados. Já no que se refere à medicina, não apresenta documento em relação à saúde sexual e reprodutiva de jovens. No que concerne à enfermagem temos mais documentos: Protocolo de

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Infecções Sexualmente Transmissíveis, o Protocolo de Enfermagem - Saúde da Criança e do Adolescente e o Protocolo de Enfermagem de Pré-Natal de Risco Habitual.

O Protocolo de Enfermagem - Saúde da Criança e do Adolescente foi publicado em novembro de 2024. Aqui, citamos o protocolo, mas apontamos que a pesquisa ocorreu ao longo daquele ano, sem os(as) agentes de saúde terem acesso ao mesmo, então não abordaremos ele de forma aprofundada.

Outro documento basilar para a equipe de enfermagem é o Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Infecções Sexualmente Transmissíveis, também de 2024. Ele cita a adolescência ao falar sobre rastreamento de IST, a ser realizado, anualmente, em adolescentes e jovens (menor ou igual a 30 anos) e aponta para os critérios de indicação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), sendo que jovens a partir de 15 anos estão no grupo, desde que sexualmente ativos sob risco aumentado de infecção pelo HIV (Porto Alegre, 2024a).

O último protocolo é o do Pré-Natal de Risco Habitual publicado também em 2024. Ele destaca os métodos contraceptivos ofertados pelo SUS e a necessidade dos(as) profissionais ofertarem todos e analisarem junto da paciente qual seria o melhor para ela, sendo sempre uma escolha desta. Os métodos são: anticoncepcional oral combinado, anticoncepcional oral apenas de progestogênio, contracepção de emergência, injetável mensal, injetável trimestral, implanon - em alguns casos mais específicos - e DIU (Porto Alegre, 2024b).

Quando se fala em "avaliação de risco da gestação", adolescentes com abortamento de repetição são enquadradas no "nível intermediário de risco" (Porto Alegre, 2024b). Novamente, a gravidez ligada ao "risco". Tratando-se das consultas de binômio, mães adolescentes aparecem, é preciso:

Observar os sinais de apego ao recém-nascido, atentando para possíveis sinais de alerta, principalmente se apresentar fatores de risco (gestação indesejada, primeira gestação, mãe adolescente, família desestruturada, falta de apoio social e/ou familiar, ausência de companheiro, abuso de drogas, não ter realizado Pré-Natal, tentativa de aborto desta gestação e outros) (Porto Alegre, 2024b, p. 112).

Aqui, vemos a gestação na adolescência sendo colocada dentro dos fatores de risco, lado a lado com família “desestruturada”, ausência do companheiro, abuso de drogas e outros. Altmann (2009) já nos alertava para o fato de a gravidez nessa faixa etária sempre vir carregada com adjetivos como “indesejada”, “de risco” e “precoce”. Não podemos deixar de criticar a própria noção de “família desestruturada”. O que seria uma família desestruturada? Então

também há uma norma de família a ser seguida? Se for mãe solo já é considerada uma família desestruturada? E considerada por quem?

Na sequência do Protocolo é citada a importância de, nos atendimentos aos(as) jovens, debater com eles acerca do gênero, sexualidade, violência, distribuição de preservativos e outros métodos contraceptivos, bem como o acesso ao aborto seguro e o apoio aos jovens em suas decisões referentes à saúde sexual e reprodutiva (Porto Alegre, 2024b).

Outro ponto importante do documento em relação aos(as) jovens se refere ao roteiro de assistência de enfermagem no planejamento reprodutivo. Na parte destinada à abordagem de jovens e adolescentes trata-se do respeito ao sigilo, orientação sobre métodos de escolha, reforçando dupla proteção, e tratar das necessidades de jovens em educação sexual e planejamento reprodutivo (Porto Alegre, 2024b).

Nesta seção vimos que os documentos envolvendo a saúde sexual e reprodutiva juvenil são mais numerosos do que os da educação, como já era esperado. Para guiar seus(as) trabalhos, as enfermeiras, técnicas de enfermagem da US, médicos(as) e ACSs, segundo consta na Biblioteca Virtual de Atenção Primária, têm os documentos do Programa Saúde na Escola, normas do Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente, o guia *Adolescer - Guia prático de orientações para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens* e documentos da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes. Ainda, aos(as) enfermeiros(as) é direcionado o Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Infecções Sexualmente Transmissíveis e o Protocolo de Pré-natal de Risco Habitual para guiar seus trabalhos. A seguir, assim como fizemos com os(as) professores(as), olharemos para o quanto os(as) profissionais da saúde se utilizam destes documentos no dia a dia.

6.2.1 “A gente segue os protocolos”

Durante a pesquisa, focamos em ACSs, técnicas de enfermagem, enfermeiros(as) e médicos(as) e em seus passos dentro da US. Inicialmente, como as técnicas de enfermagem são a porta de entrada dos(as) jovens na unidade, entender como elas estruturam seus trabalhos, em relação a este público, é essencial apesar de passarem pouco tempo em acolhimento com os(as) jovens. Foram entrevistadas três técnicas e acompanhado o cotidiano de trabalho na unidade no acolhimento, durante os meses no espaço. Uma delas segue atuando na US e duas foram transferidas por pedido próprio.

Um primeiro ponto que chama a atenção é a falta de um protocolo para auxiliar na forma em que será realizado o acolhimento, quando realizar uma interconsulta com o médico ou a enfermeira, quando agendar uma consulta, como realizar a administração de medicamentos ou vacinação e etc. Logo, uma técnica pode agendar consulta para uma jovem que tem uma dúvida sobre seu contraceptivo, enquanto outra pode fazer uma interconsulta com o(a) enfermeiro(a) e apenas repassar as informações que este deu para a paciente. A única coisa que observei ser unanimidade entre as técnicas é que ao começar o anticoncepcional, as jovens devem passar em consulta com enfermeiro(a).

Outro elemento que observei é a falta de comunicação entre a equipe de enfermagem para discutir como deve ser realizado o acolhimento e alinhar diretrizes. Ao perguntar para as técnicas quais critérios elas utilizavam ou não para marcar uma consulta, me respondiam coisas como “É, a gente sabe o que fazer, dependendo se vai precisar de médico, de enfermeiro ou não precisa de nada.” (Tec. Enf. Ana).

Sobre reuniões de equipe para alinhar ações, a técnica Ana aponta que “Já foi feito, já foi feito isso agora, começo do mês e na metade do mês, mas a gente pode falar 500 mil vezes que a coleguinha não faz, que a coleguinha precisa disso. Mas, pô, fica sempre passando por cima. Não muda muito. Não muda muito.” (Tec. Enf. Ana).

Ao perguntar sobre a existência de protocolos em relação à saúde sexual e reprodutiva destaca-se: “Acho que tem, mas na verdade eu vou te confessar que eu não conheço assim, não é uma coisa que eu uso, assim. É mais dos adultos mesmo.” (Tec. Enf. Maria). Já Ana aponta com certeza para a inexistência deles:

Não, nada ainda foi passado para nós. Não sei se foi passado para o meu enfermeiro ou algo do tipo, assim, mas nada foi passado para nós. Mas qualquer dúvida que eu tenha, que eu não consegui ainda aprender ou, tipo, não. Eu sempre venho até o meu enfermeiro, pergunto para ele qual seria a conduta (Tec. Enf. Ana).

A técnica Sofia durante conversas informais e entrevista destacou que existem protocolos de enfermagem que as técnicas podem olhar, mas que não há nada especificamente para estas, e que seria importante haver. Assim como Maria e Ana, falamos sobre a dificuldade de padronizar os atendimentos e sobre como o acolhimento acaba mudando muito de profissional para profissional. Sofia, assim como as outras duas técnicas, também nunca participou de uma formação que abordasse saúde sexual e reprodutiva de jovens.

Em conversas com os(as) jovens do território, o acolhimento sempre foi motivo de reclamação com “técnicas mal encaradas”, “sem vontade”, “que não acreditam na gente”. Essa porta de entrada na unidade de saúde onde os(as) jovens realmente deveriam se sentir acolhidos

é central para aproximação do serviço de saúde, mas acaba não se tendo uma proximidade maior entre usuário(a) e agente, o que também corrobora com a utilização de micromecanismos, uma vez que as técnicas não têm um maior conhecimento do(a) jovem para poder conversar com este(a) acerca da SSR.

As técnicas de enfermagem são subordinadas aos(as) enfermeiros(as), que são aqueles(as) que têm maior contato com os(as) jovens visto que a maioria das consultas deste grupo acaba passando por eles(as). Durante a pesquisa de campo da tese, um enfermeiro e quatro enfermeiras foram entrevistados(as), sendo que nenhum(a) destes(as) trabalha mais na US. A frase que dá título a este capítulo foi dita por todos(as) eles(as) tanto nas entrevistas quanto nas conversas dentro das salas de atendimento. “Seguimos os protocolos que estão na BVAPS” (Enf. Cássia). Tratando-se de saúde sexual e reprodutiva, como vimos, seriam os protocolos referentes ao Pré-Natal de Risco Habitual e de ISTs.

A partir das observações de cunho etnográfico, se percebeu muito pouco a utilização do protocolo de ISTs com jovens, até porque foram poucas as consultas deste tema que acompanhei, uma vez que não são frequentes na unidade. Já o protocolo de gestação foi usado rotineiramente em consultas com as jovens grávidas.

Quando os(as) enfermeiros(as) falam que seguem o passo a passo dos protocolos, no geral o que acontece é que cada enfermeiro(a) segue uma rotina de perguntas a serem feitas conforme a consulta, mas que não são, em qualquer um dos casos, totalmente iguais aos protocolos. Eles(as) falam que criam estes “guias” a partir de protocolos e de suas experiências de trabalho. Logo, “faz meio que um *script* mental, assim, pra tu não esquecer, né?” (Enf. Polina). Não há mudanças expressivas de um(a) enfermeiro(a) para outro(a). Segue fala de Rafael:

Mas a gente acaba, eu digo por mim, eu entro tão no automático, assim, que às vezes eu não procuro tantos protocolos, né? O bom é que a gente tem outros profissionais ali que a gente tem umas ideias, assim, de troca, né, principalmente a figura do médico ali, né, acaba que muitas condutas passam por eles, assim, apesar de a gente ter bastante autonomia. [...] Mas eu sei que tem o protocolo ali pra gente seguir, tem as orientações, enfim, apesar de eu achar que cada caso tu tem que olhar de uma forma. Por isso que eu não me vínculo tanto a protocolos assim, eu acho, mas isso de geral. Claro, tem, os protocolos são engessados, né, então a gente precisa ter um olhar diferente, assim (Enf. Rafael).

A enfermeira Olívia também destaca a BVAPS como fonte de informações para a atuação deles: “Tudo que a gente faz é a partir do que está ali.” (Enf. Olívia). Apesar de todos os documentos que citei anteriormente estarem na BVAPS, no dia a dia, os(as) profissionais olham muito pouco para eles, se olham, conforme foi observado ao longo dos meses na US.

Durante as entrevistas não foi citado qualquer vez a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes, por exemplo, nem outro documento da Biblioteca para além do protocolo de gestação e de ISTs.

Ainda, o passo a passo da gestação, como os próprios enfermeiros destacam, não tem diferença de gestante adulta para jovem, além do fato do encaminhamento para a gestação de alto risco se for jovem: “Não, não, não muda nada, a gente só encaminha sempre para o alto risco também.” (Enf. Polina).

Na escolha sobre enviar a jovem para o alto risco ou não, destaca-se o alto nível de agência dos(as) profissionais para tomar a escolha, que é central para o acompanhamento da gestação. Apesar do protocolo destacar adolescentes como grupo que deve ser encaminhado ao alto risco, o Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente (PAIGA) coloca a não obrigatoriedade de encaminhar as adolescentes apenas pela idade.

Ao conversarmos sobre encaminhamento de alto risco, nenhum(a) dos(as) enfermeiros(as) sabia dizer com exatidão a idade que consta no Protocolo de Pré-natal e nem citaram alguma vez o PAIGA, que é o Programa específico para tratar da gestação juvenil. Realmente, o Protocolo de Pré-Natal não destaca uma idade mínima ou máxima para encaminhamento, o que aponta para esta “confusão” entre os(as) profissionais que acabam encaminhando da forma que consideram melhor, utilizando de sua agência, e acredito, de seus valores morais.

Sobre consultas de contracepção para as jovens, enfermeiro e enfermeiras destacam que “seguem o protocolo” (Enf. SRT). Estes(as) têm já anotado, assim como para pré-natal, algumas perguntas base para fazer à jovem que vem em busca da contracepção. Porém, conforme foi observado, nem todos os métodos que constam no Protocolo de Pré-Natal são sempre oferecidos e nem sempre a jovem tem total escolha sobre o que utilizar. Por exemplo: nunca foi citado em consulta a contracepção de emergência ou falado sobre o método de barreira da camisinha vaginal ou diafragma.

Acerca dos protocolos, uma enfermeira destaca a falta de tempo para acessar os mesmos e estudá-los. Aqui, veremos como as formações dos(as) profissionais e o tempo que eles(as) têm de estudo durante o trabalho também influenciam na utilização de micromecanismos. Segue fala de Polina:

O protocolo de saúde da criança, por exemplo, estou atendendo uma pueri [puericultura e aí eu vou talvez (olhar). Ou: ah, tem uma pueri hoje e vai olhar o protocolo. Infelizmente a gente às vezes não consegue, tipo de antemão revisar todos os protocolos antes. Então os protocolos ainda estão indo. Ainda estou, todos os dias

aprendendo um pouquinho de novo, pegando o que mudou, o que não mudou. Os colegas também ajudam (Enf. Polina).

Polina também fala de poucas discussões acerca da sexualidade juvenil nos protocolos. Cássia é outra enfermeira que aponta que “os adolescentes estão num limbo do sistema de saúde que tu vê pelos protocolos. Nós não temos um protocolo de saúde do adolescente, ele tá misturadinho no final da pediatria.” (Enf. Cássia). A enfermeira Polina, além da falta de olhar para os(as) jovens, destaca a falta de um cuidado maior com a mulher, num geral, no Protocolo de Pré-Natal:

Tipo, eu olhava sempre a mulher primeiro, né? Porque não adianta nada tu fazer toda a consulta de pré-natal, gestação, pensar só na criança e tu não cuidar da mãe, né? Eu tenho muito isso na cabeça. Por isso que eu fiz o grupo aqui da festa junina diferente, não falando só do nenê, falando da mãe, saúde mental e que elas podiam tudo e tal, né? Porque falta, né? Falta. E falta falar isso nos protocolos, por exemplo, tá? No protocolo de pré-natal não se fala sobre isso. Tipo assim, ah, tem ali parte de anamnese que tu faz, mas é muito clínico, entendeu? É muito, assim, sabe? Não é aquela coisa, assim, tipo, do olhar, sabe? Da mulher, assim, né? Que eu já prezo mais, tu entende? Por isso que eu demorava mais nas consultas. Então, que nem a gente tinha falado, depende muito do profissional. Só que isso não deveria ser assim, né? Isso deveria estar no protocolo (Enf. Olívia).

Ao longo das entrevistas e do período de observação participante, realmente a enfermeira Olívia era a única que destacava com mais atenção a saúde da mulher, um olhar mais específico de como a gestante estava se sentindo, “se organizando”, tentando dar mais atenção à sua saúde física e mental. Aqui, fica evidente que a enfermeira desenvolve sua agência ao escolher dar mais atenção à saúde da mãe da criança.

Outro fato de destaque é que o Protocolo de Pré-Natal destaca que questões de gênero, sexualidade e violência devem ser discutidas nas consultas, o que não observei durante o ano em que fiz a observação na unidade de saúde. Nenhuma vez esse trecho do protocolo aparece na fala dos(as) enfermeiros(as), apesar de, como destacado acima, algumas enfermeiras reclamarem da falta de discussões sobre sexualidade no Protocolo. Ainda, não se tem discussões sobre planejamento reprodutivo com os(as) jovens, logo, o roteiro de assistência de enfermagem no planejamento reprodutivo, que consta no Protocolo, não é utilizado e em momento algum, comentado por enfermeiro e enfermeiras.

Nesta seção ainda vale lembrar que o Protocolo de Enfermagem - Saúde da Criança e do Adolescente, que foi publicado no final de 2024, não era conhecido ainda pelos(as) profissionais durante meu período de pesquisa de campo. Sobre o documento, a enfermeira SRT conversou comigo três dias depois da reunião de enfermeiros, em que o protocolo foi

apresentado, e destacou que passaram basicamente todo o tempo discutindo sobre o atendimento às crianças e que não teve nenhuma fala específica para os(as) jovens: “Estava ali escrito, mas nem chegamos nessa parte.” (Enf. SRT).

Nesta conversa, SRT também destacou que foi comentado com os(as) enfermeiros(as) sobre a criação de um protocolo para manejo de gravidez na adolescência, mas que ainda não tinha data para lançamento. Segundo ela, funcionários da Secretaria de Saúde apontaram que estavam fazendo o protocolo naquele momento, pois entendiam que era importante tratar, especificamente, este grupo e que tinham várias pesquisas sendo feitas sobre gravidez na adolescência. SRT concluiu a conversa: “Barbs, eu até achei que a tua pesquisa era uma dessas que eles falaram que estavam sendo feitas e que serviu de incentivo para quererem criar o protocolo.” (Enf. SRT).

Ainda sobre o Protocolo da Saúde da Criança e do Adolescente veio uma fala muito similar de colega de trabalho de SRT sobre a capacitação:

Foi mais um encontro que eu entendi meio marketing, assim, pra falar do protocolo, que eles fizeram o protocolo, que ele tá todo renovado, que eles fizeram quase tudo em canva, com imagens, que é pra tentar vincular mais fluxo e nada daquele conteúdo pesado, né? Então eles não entraram a fundo nas coisas. Se discutiu algumas coisas que geraram polêmica ali, mas, particularmente, eu ainda não sentei, não peguei o protocolo e não li ele de cabo a rabo, né? Não, não fiz isso ainda. E isso eu até faria em casa, porque é uma coisa, é bom saber. Mas acho que eu vou até imprimir ele. Mas quero ver ainda. Mas se falou muito mais, assim, principalmente saúde da criança, assim, não do adolescente, apesar de o protocolo ser saúde da criança e adolescente, falou-se muito mais das crianças, assim, principalmente do nascimento ali (Enf. Rafael).

Este novo protocolo, lançado em capacitação, nos faz refletir sobre como são estes encontros e o quanto elas ajudam os(as) agentes em seu cotidiano de trabalho. Nenhum dos entrevistados destaca especificamente formações voltadas à saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens e apontam que seria importante terem mais: “Não era específico para jovens. Nossa, nunca nem vi tipo assim para se inscrever, para participar. Nunca nem vi, vou te dizer.” (Enf. Cássia).

Os três médicos entrevistados e a médica - três deles já se desligaram da US - também retratam a falta de cursos acerca da saúde sexual e reprodutiva juvenil de maneira muito similar aos(as) enfermeiros(as):

Falta preparatório. Falta capacitação. Falta, talvez, a formação de um protocolo de capacitação. Formação de um protocolo de pré-natal desses jovens. Falta uma capacitação, anamnese, capacitação de jovens homens pro convívio dentro da unidade para que sementes deem frutos. Pra que seja um investimento a longo prazo. Isso é

dinheiro. Isso é questão pública. Isso é política. Tudo volta à base. Isso é política (Med. Benjamin).

Da mesma forma, a médica Amarilis destaca que existe muito material, mas “é mais uma questão da forma de abordagem mesmo. Eu acho que deveria ser abordado mais, ensinado mais, porque acaba que é uma coisa que entra também na questão das habilidades de comunicação.” (Med. Amarilis). Aqui temos novamente a questão da formação continuada dos(as) profissionais e também relações que estabelecem com usuários(as) como pontos importantes do contexto de trabalho na US, e que irão influenciar na utilização dos cinco micromecanismos.

Acerca das diretrizes para seus trabalhos, os médicos e a médica também citam a Biblioteca Virtual de Atenção Primária em Saúde, mas vimos na subseção acima (6.2) que ali não consta nenhum direcionamento específico sobre saúde sexual e reprodutiva juvenil no que se refere à medicina. O médico JP destaca que para falar sobre esse tema, usa geralmente o Protocolo da Saúde da Mulher que, segundo ele, está na Biblioteca Virtual, mas, como vimos, não se encontra lá. Também cita um protocolo sobre saúde do homem, apesar dele não entrar tanto na parte de sexualidade, segundo JP.

Já o profissional de medicina, Cláudio, segue a mesma linha: “Eu sempre sigo o protocolo vigente do Ministério da Saúde, assim, e tem na BVAPS ali que eles são bem bons, tem todos os protocolos de todas, de tudo ali.” (Med. Cláudio). Já Benjamin aponta que a falta de oportunidade de realizar formações sobre saúde sexual e reprodutiva fazem com que: “Então, meus protocolos foram muito mais em relação do bom senso, principalmente. E que é triste, na verdade, né. Não é bom. Não deveria ser só isso, né.” (Med. Benjamin). É neste “bom senso” ao que o médico se refere que se encontram os valores e moralidades de cada um e que a agência entra em ação.

Ao observar o cotidiano de trabalho dos médicos e da médica, eles(as) não atendem um número considerável de jovens, sendo que eles(as) destacaram para mim que essa demanda fica normalmente com a enfermagem. Os(as) médicos(as) não apontaram para mim um protocolo de ISTs, por exemplo, ou algum outro protocolo que trate de saúde sexual e reprodutiva. Quando atendem jovens, normalmente, é para fazer o pré-natal de uma jovem e, nessas situações os(as) profissionais referem que seguem o protocolo que consta na BVASP de pré-natal de risco habitual da equipe de enfermagem para saber informações como o espaço de tempo entre uma consulta e outra e, quando fazer a próxima testagem para ISTs.

Questionando sobre o encaminhamento de jovens para o alto risco, as respostas dos médicos(as) são variadas, assim como são para os(as) enfermeiros(as): “Gravidez adolescente,

em tese, sempre é alto risco. Se ela era sempre acompanhada em alto risco, é questionável.” (Med. Benjamin). Já outro médico, JP, destaca que pela idade, especificamente, não tem obrigatoriedade de encaminhamento, mas ele prefere encaminhar para as jovens terem dois espaços de acompanhamento: na unidade e no PNAR.

A médica que acompanhei também destaca que nem sempre encaminha as jovens para o alto risco, apesar de destacar que o protocolo pede para fazê-lo:

Geralmente não, isso também vai muito da minha avaliação, porque tem umas gestantes que apesar de jovens, elas têm uma formação corporal, um perfil que tá bem assim pra levar a gestação sem nenhuma questão. E tem outras que tem um perfil diferente, que são realmente um corpo um pouco mais infantilizado e tudo. Então eu como médica de família tenho uma questão com encaminhamentos que às vezes os encaminhamentos fazem a gestante ou qualquer outro paciente ficar girando muito. Então não vai acompanhar aqui, vai deixar de acompanhar aqui, vai acompanhar em outro local e às vezes não tem necessidade porque é uma gestação sem intercorrências. Então se as taxas estão boas, se a pressão tá boa, se tá evoluindo bem, às vezes nem precisa. Então não é algo que eu faço rotineiramente. Segundo o protocolo, sim, geralmente é pra encaminhar, mas como, enfim, quando eu me sinto segura pra acompanhar, às vezes eu não encaminho (Med. Amarilis).

Assim como já falávamos acerca da enfermagem, aqui o PAIGA também não foi citado uma única vez e vemos claramente a presença da agência dos(as) médicos(as) em uma decisão que tem grande peso para as gestantes, visto que um encaminhamento para o alto risco pode significar a realização de dois pré-natais simultâneos e de uma maior aderência à unidade ou não.

Por fim, mas não menos importante, devemos falar do trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs). Durante a maior parte da realização da pesquisa de campo, a unidade de saúde, apesar de ter cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), possuía apenas duas ACSs. Outras duas iniciaram seus trabalhos três meses antes do fim do ano, então não foi possível acompanhá-las com maior intensidade.

As duas ACS que acompanhei, Fernanda e Carolina, nunca realizaram formação acerca da saúde sexual e reprodutiva de jovens e, também, ao conversar no dia a dia, elas não atuam diariamente com jovens. Carolina é a que mais atua, uma vez que participou, na maior parte do tempo em que estive na unidade, do Grupo de Gestantes que se reunia semanalmente e onde participavam algumas jovens.

Sobre os protocolos de trabalho das ACSs, vimos, anteriormente, que não consta documento na BVAPS direcionado especificamente para elas. Sobre as diretrizes que orientam seus trabalhos, Carolina e Fernanda falam que não há nada específico sobre jovens: “Não, específico para jovens, não. É o que eu te falei: a minha formação, assim, a minha conduta para

atendimento a jovens é mais focada, assim nessa questão mesmo administrativa e gerenciar os conselhos. E essa bagagem, assim, que eu já trago, assim, das formações mesmo.” (ACS Fernanda). Carolina aponta: “Tem um protocolo ali mais ou menos do que é o nosso trabalho. Das visitas domiciliares. O que é considerado.” (ACS Carolina) mas acaba não destacando os(as) jovens.

Assim como técnicas, médicos(as) e enfermeiros(as), as ACS também não receberam formação sobre saúde sexual e reprodutiva de jovens, ao longo de seus anos de trabalho na unidade. Conforme fui acompanhando no dia a dia, esse tema não é muito comentado, a não ser quando uma ACS é responsável por acompanhar um pré-natal de uma jovem, ou no caso do Programa Saúde na Escola (PSE).

O PSE acaba por envolver toda a equipe da unidade de saúde - ou pelo menos deveria. A ACS Carolina estava à frente do PSE há anos dentro da unidade e, nos últimos, junto da enfermeira Olívia. A agente falou diversas vezes, saudosa, sobre as atividades que realizavam na escola próxima da US, de como eram as atividades referentes à sexualidade e da importância destas.

Em 2024, foi lançada uma normativa em que a enfermeira responsável pelo território, de cada escola, iria fazer atividades do PSE e o território de Carolina não tinha qualquer escola. Mesmo assim, ela participou de atividade do PSE acerca de saúde mental a pedido da enfermeira responsável pelo Programa. Também participei desta atividade, juntamente de uma acadêmica de enfermagem, onde realizamos atividade com as turmas de sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.

Outra atividade do PSE foi referente às pediculoses nas turmas de terceiro e quarto ano do Ensino Fundamental, da mesma escola. Participaram da atividade eu, uma técnica em enfermagem, uma enfermeira e uma ACS. O tema da conversa foi solicitado pela escola. Ainda, houve outra atividade da odontologia, onde foram eu, dois dentistas e uma técnica de odontologia conversar com alunos de primeiro e segundo ano sobre higienização bucal e alimentação saudável.

Em conversa com a gerente da US - que também não trabalha mais na unidade - tratamos sobre a escolha dos temas do PSE e ela apontou que são de direção da enfermeira de cada equipe em conversa com o restante da equipe de Saúde da Família e em diálogo com a escola. A ACS Carolina não concorda com a falta de discussões sobre sexualidade com os jovens e “fico bem chateada com isso, deveríamos ter mais tempo com eles para falar sobre, fazer um trabalho aprofundado como a gente fazia.” (ACS Carolina).

Aqui, vemos novamente uma grande liberdade de escolha dos(as) enfermeiros(as) acerca de como realizar o PSE, ficando ao seu encargo liderar o projeto, o que delega alto grau de agência. Também percebemos a dificuldade de diálogo entre US e escola, onde não foi realizado em qualquer um dos casos um trabalho de parceria com professores(as), como as diretrizes do PSE propõe. Ainda, vale destacar que quase nenhum dos(as) profissionais que foi até a escola, foi porque quis, com exceção de Carolina. Todos(as) reclamavam de sua participação e foram “porque tinha que ir, tinha que fazer” sendo que eu fui requisitada nos três momentos de PSE para organizar o mesmo “porque tu gosta dessas coisas, Bárbara”. (Enf. SRT).

Acerca das diretrizes que baseiam o trabalho dos(as) agentes das ESFs, vemos que as enfermeiras são aquelas que possuem mais protocolos no que se refere à saúde sexual e reprodutiva juvenil, mas mesmo assim estas destacam que faltam mais discussões sobre a sexualidade. Médicos(as) não têm protocolo para tratar, especificamente, de jovens e é raro que esses usuários cheguem a consultar com um deles(as), sendo que acompanham somente gestantes jovens, as quais dependendo da relação estabelecida entre médico(a) e usuária, encaminham para o pré-natal de alto risco. As ACSs e as técnicas de enfermagem também não têm protocolo que fale como lidar com a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens.

Todos(as) entrevistados(as) destacam a falta de capacitações acerca de saúde sexual e reprodutiva juvenil desde técnicas até médicos. Tratando-se de supervisão, as ACS respondem à enfermeira de sua equipe, assim como o fazem as técnicas de enfermagem. Já médicos(as) e enfermeiros(as) não têm uma supervisão direta, mas respondem à gerência quando solicitados(as).

A seguir, iremos explorar a fundo a agência dos(as) profissionais no que se refere à saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens, entendendo que ela aponta micromecanismos de governança reprodutiva, que estruturam as relações entre agentes de nível de rua - professores(as), enfermeiros(as), médicos(as), técnicas de enfermagem e ACSs - e os(as) jovens do bairro.

7. “SIM, JÁ OUVI FALAR EM PRESERVATIVO. E A SENHORA JÁ OUVIU FALAR EM GRAVIDEZ QUE A GENTE QUER?”

A frase que dá título a este capítulo foi dita por uma jovem para uma médica na US, durante uma consulta que não pude acompanhar, mas que a ACS Fernanda compartilhou comigo durante nossa entrevista. Adiante, contextualizamos melhor esta fala, mas ela dá o tom do debate da seção em torno do direito à saúde sexual e reprodutiva, ser também o direito de decidir gestar ou não quando a jovem desejar.

Começaremos falando da gestação, pois quando tratamos de jovens e sexualidade, ela sempre é o primeiro assunto a aparecer entre os(as) agentes de educação e da saúde, apesar de o número de gestações, até os 20 anos incompletos, vir diminuindo ano após ano no Rio Grande do Sul. Em 2022, o percentual foi de 1,54%, segundo o IBGE (2022).

Aqui, olharemos para o cotidiano de trabalho de agentes de saúde e educação, juntamente com as experiências dos(as) jovens que acessam as escolas e a unidade de saúde. Focaremos em agentes e usuários(as), concomitantemente, por entender que a política se dá justamente nas relações que se estabelecem entre ambos, nos encontros cotidianos no pátio da escola, na sala de enfermagem da US e até mesmo na rua, conversando com a ACS. É aí que se faz a política pública.

Focaremos nos micromecanismos de governança no cotidiano de atuação dos(as) agentes de políticas públicas. Nesse sentido, formulamos a noção de contenção reprodutiva inspiradas na noção de coerção reprodutiva de Miller, Jordan, Levenson e Silverman (2010). O micromecanismo de contenção se refere às formas com que os(as) agentes de saúde e da educação buscam coibir as jovens e os jovens - mas majoritariamente as primeiras - a gestar e reforçam discursos acerca das dificuldades e problemas que a gravidez ocasiona segundo as suas percepções.

7. 1 VISÕES SOBRE A GESTAÇÃO NA JUVENTUDE

Conhecer as percepções dos(as) usuários(as) e agentes no que tange a gestação é central para entendermos quais os micromecanismos de governança utilizados pelos(as) profissionais e como se estabelecem as relações entre agentes e jovens, o que influencia diretamente na implementação das políticas (Wendel et al, 2005; Shore; Wright, 2011; Lotta, Santiago, 2017; Bruhn, Ekström, 2017).

Começaremos pelos(as) jovens. A maioria dos(as) alunos(as) têm a visão da gravidez na juventude como negativa. As(os) jovens dizem: “Deus me livre” (Sônia, 16 anos, sem experiência reprodutiva), “Acho que eu fugia (risos)” (Marcos, sem experiência reprodutiva).

Caso engravidassem, a maioria destacava que assumiria, mas que não queria agora. Normalmente, para eles(as), antes de ter filhos era necessário ter “estabilidade financeira e boa mentalidade, que não adianta nada ter mentalidade ruim” (Marcela, 19 anos, sem experiência reprodutiva). Todos(as) concordam que é necessário ter uma boa rede de apoio e a maioria das mulheres aponta que “atrasaria” alguns planos.

Durante as rodas de conversa, em uma turma da escola A, no primeiro ano, uma jovem já tinha um filho, comentou que foi em um “descuido”, mas que amava muito o filho e dizia com muito orgulho sustentá-lo sem o pai. Para ela a vida mudou, mas não necessariamente para pior. Na escola B, também no primeiro ano, ao conversarmos sobre as percepções acerca da gestação, um colega de uma jovem, que era mãe, falou mal dela ao que uma amiga saiu em sua defesa e causou uma discussão generalizada na turma: “Mas eu acho que a Madalena tem o direito de ficar brava porque ela não pediu ajuda de ninguém pra cuidar da filha dela, ela não precisa de ninguém. Ela assumiu a responsabilidade. Ela não pediu pra ninguém ser pai, nem dinda e muito menos cuidar.” (Sara, sem experiência reprodutiva).

Das dez jovens gestantes e/ou mães que entrevistei, que passaram pela gestação entre 16 e 19 anos, uma delas planejava a gestação (Jasmin com experiência reprodutiva), outra estava “indecisa” (Sabrina, 20 anos, com experiência reprodutiva) quanto a querer ou não, uma “não planejava, mas sentia que logo viria [...] até porque não usava proteção” (Letícia, 18 anos, com experiência reprodutiva). As demais, não planejaram a gestação e dizem que ela ocorreu em uma “injeção que não aplicaram certo no posto” (Camille, com experiência reprodutiva) ou uma falta de cuidado.

Todas elas aceitaram a gestação e três delas são mães solo. Sobre suas percepções acerca de ser mãe nessa faixa etária, quatro acham que existem momentos melhores para gestar: “Ah, pra mim, tem que ter uma casa primeiro pra tu engravidar. [...] Tu tendo tua casa e tendo teu marido ali, é a melhor coisa. Porque daí tu pode fazer tudo o que tu quer. Tu vai entrar numa rotina com a tua filha. Isso pra mim é bom.” (Laura, com experiência reprodutiva). Já outra que se aproxima mais da fala dos(as) professores(as) e funcionários(as) da US:

É bem melhor engravidar quando tu tá estabilizada financeiramente, principalmente porque é uma criança que gasta demais. E tu tem uma estrutura também, tipo, rede de apoio, familiar, acho que isso tudo conta também. Idade também, emprego e situação financeira, pra mim é isso, eu acho que tu tem que estar estabilizada pra ter uma criança (Kailany, com experiência reprodutiva).

Seis jovens mães e/ou gestantes afirmam que não existe momento melhor ou pior, sendo Deus rememorado em suas falas: “Tipo, não é a gente que escolhe, né? É tipo, ah, se Deus... Como é que ele falou aquele dia? Ah, se Deus achar que é a hora certa, ele vai nos dar.” (Heloá, 16 anos, com experiência reprodutiva).

Não coletei percepções de jovens pais acerca do que pensavam, pois não foi possível localizá-los e, quando localizados, diziam que iam participar da pesquisa, mas acabavam não retornando as mensagens. Mas o silêncio deles também nos fala sobre a responsabilidade acerca da gestação e do cuidado posterior, onde, segundo todos(as) os(as) agentes de saúde e educação e conforme as jovens mesmo destacam, na maioria dos casos, “os homens somem”.

Tanto na escola A quanto na escola B, sempre que eu conversava sobre a gestação com os(as) estudantes, eles(as) me falavam do “pai que saiu para comprar cigarro”. É a expressão que usam para falar que foram abandonados(as) pelos pais. Virou uma brincadeira interna deles(as) e sempre falam em tom de piada, arrancando risos de colegas. Até mesmo nas rodas de conversa quando falamos sobre a responsabilidade dos pais, algumas meninas dizem, por exemplo: “Ih, sora, nem dá bola pra esse daí, certeza que ele ia sair pra comprar cigarro e não voltava se engravidasse alguém.” (Isabel, sem experiência reprodutiva).

As próprias jovens e os jovens incorporam narrativas de assimetria de gênero e as jovens sabem que, em última instância, o cuidado da criança ficará sob sua responsabilidade, apesar de a maioria destacar “não acho isso certo não, sora, deveria ser uma divisão igual de cuidado” (Sara, sem experiência reprodutiva). E essa visão não muda a depender da idade (16 ou 20 anos) e a depender da raça/etnia, seja ela branca, parda ou preta.

Claramente, as jovens têm uma preocupação muito maior que os homens, que costumam responder com frases como “ia ter que pagar pensão, né?” (Nilton, sem experiência reprodutiva). Como já vínhamos discutindo, o gênero tem aqui um papel central. Heilborn (2012, p. 65) destaca que “As relações de gênero encarnam formas desiguais de poder que assumem modulações específicas em cada esfera da vida e contexto social.”

Em relação às falas de jovens com experiência reprodutiva, temos algumas anotações importantes: das dez jovens, cinco destacam que a responsabilidade maior é delas. Elas têm 16, 19 e 20 anos de idade, três são pretas, uma é parda e uma é branca. Todas se autodenominam como de camadas baixas. Heloá destaca: “Ah, acho que a criança prefere a mãe, né? Mas, tipo, de dia claro, vou ficar com ela, né? Mas de noite, quando o Fabiano chegar, daí a gente divide.” (Heloá, com experiência reprodutiva).

Duas jovens gestantes, Gabriele e Letícia, apontam que estão dividindo as responsabilidades, durante a gestação, com o companheiro e acreditam que seguirá da mesma forma após o nascimento da criança. Como coloca Gabriele: “Eu acho que vamos dividir o cuidado do bebê. Eu, nossa, eu fico mais feliz ainda porque eu vejo como, a maneira como ele é com criança, tipo, ele é apaixonado por criança. [...] Ele é super empenhado em montar o quarto do bebê.” (Gabriele, com experiência reprodutiva). Gabriele e Letícia são pardas, ambas têm 18 anos e são de camadas populares.

E as outras três jovens com experiência reprodutiva? Consideram que são suas mães que têm maior responsabilidade pela criança. Camille, Martina, Alice e Natália são de camadas populares e têm respectivamente 19, 17 e 16 anos. A primeira é branca e as demais são pretas. Como destaca Camille: “Eu acredito que a minha mãe, acho que o pai dela é próximo, mas também não é tanto. Ele ajuda mais no financeiro.” (Camille, 19 anos, com experiência reprodutiva).

O dado de mais jovens colocarem as suas próprias mães, outras figuras femininas, à frente de si mesmas e dos genitores é um ponto que vale a pena ser destacado. Como diversos(as) profissionais também destacaram, muitas vezes é a avó que mais cuida da criança e que dá o sustento financeiro. Ou seja, mais uma figura de uma mulher cuidadora, antes da figura masculina. Federici (2017, 2019) é uma das autoras que citamos ao longo da tese e que discute como o trabalho reprodutivo sempre fica ao encargo das mulheres e que o cuidado se torna sumariamente trabalho das mulheres, independente da idade.

Vale a pena destacarmos a centralidade das avós ao longo da pesquisa - principalmente mães da jovem gestante -, que aparecem tanto nas consultas, acompanhando as jovens gestantes quanto na fala destas sobre a importância das mesmas no processo de gestação. Diversas pesquisas no Brasil e na América Latina apontam para a centralidade das avós no processo e, como Fonseca (2025, informação verbal) destacou durante um seminário, “No Brasil, a maternidade se dá na triangulação entre criança, mãe e avó.”, ponto que afirmamos constantemente na realidade das camadas populares do território que pesquiso.

Neste caso, as jovens entendem que caso tivessem filhos, assumiriam uma responsabilidade maior, sobre uma possível gestação e uma criança, do que o genitor. Entendemos que “As jovens do universo popular tendem a ser mais cobradas a assumir papéis restritos ao lar e ao filho, sobretudo se vivem com um companheiro. (Vieira, Bousquat, Barros e Alves, 2017, p. 9).

Para além do marcador social de gênero, se olharmos para a idade, tanto as jovens de 16 anos quanto as de 20 anos, têm a percepção similar de que a gravidez nessa fase da vida não é

boa para elas. Os jovens homens, independente da idade, também relatam que não querem ter filhos neste momento da vida.

Outro marcador social importante em muitas pesquisas é o de classe social, porém, como já demonstramos aqui, o bairro em que foi realizada a pesquisa é de camadas populares, então não temos diferenças importantes entre as rendas das pessoas jovens com quem conversei, ao longo da pesquisa, seja nas entrevistas, nas rodas de conversa ou nos diálogos informais pelos corredores das escolas.

No que se refere à raça/etnia, a maioria dos(as) jovens do bairro é negra e também não temos diferenças significativas nas falas das(os) jovens, sendo que a maioria destes(as), independente da raça, refere ser necessário uma estrutura financeira e psicológica para gestar. Inclusive, na fala dos(as) jovens, a raça não é um marcador que aparece como chave, seja na gestação, na contracepção, no conhecimento sobre ISTs ou em outros temas ligados à saúde sexual e reprodutiva. Mas é importante citar que a maioria das jovens do território que frequentam a US e as escolas A e B é preta ou parda.

Raça e classe social podem ter certa relação ao analisadas em conjunto, mas não em todos os casos. Algumas jovens pretas e de camadas populares, que já foram mães ou que são gestantes, destacam falas de que não há um momento ideal, como acabamos de ver, mas boa parte das jovens pretas nas escolas dizem que existe um período ideal para gestar. Das seis jovens entrevistadas, que têm visão de não haver um momento certo para engravidar, cinco se auto determinam pretas e uma se refere como parda. Hoje,

Em contextos fortemente marcados por desigualdades de gênero e classe social, a maternidade se apresenta não apenas como ‘destino’, mas talvez como único projeto possível de reconhecimento social para jovens mulheres cujos eventuais projetos educacionais e profissionais dificilmente poderão se concretizar (Aquino et al, 2006, p. 352).

Como já vimos no capítulo anterior, o ensino profissionalizante e superior muitas vezes não é uma possibilidade para as jovens, que, inclusive, em alguns casos, não sabem de sua existência. Ademais, as perspectivas de trabalho são poucas, principalmente de trabalho com maiores salários. Assim, ser mãe na comunidade traz diversos pontos positivos para as jovens, como sair da casa dos pais, trazendo maior independência, ter proteção em meio ao território do tráfico, principalmente ao se relacionar com homens envolvidos no meio, e realizar o trabalho doméstico enquanto o parceiro trabalha fora de casa. Observei estes pontos a partir de conversas com as jovens, com os(as) funcionários(as) das escolas e da US. Ser mãe acaba sendo o “curso natural” da vida, como destacou o professor Ricardo em aula.

Os três professores e a professora que acompanhei concordam que a gestação na juventude “não é fácil, então, aproveitar cada fase deles ali pra não ter isso aí antes, né.” (Prof. Gabriel), mas todos(as) falam muito mais da dificuldade da mulher do que do homem. O professor Ricardo: “Eu acho pior. [...] A transformação foi para o lado ruim né. Porque deixou de estudar.” O professor Felipe aponta o mesmo que Ricardo e segue: “Eu acho que existe um problema social e que isso abrange a comunidade, abrange os alunos: essa falta de conhecimento, de amadurecimento e gravidez precoce. Eu acho que sim, eu acho que talvez deveria ser trabalhado” (Prof. Felipe).

A professora Monique também deixou claro, durante meu tempo na escola, que ela entende a gravidez na juventude como um problema, mas cita durante entrevista que “têm alguns que é de uma naturalidade que parece uma coisa que realmente eles acham bem natural, bem natural mesmo sabe? Tem outros que realmente assim, eles custam pra contar pra mãe e pai.” Ela também fala que depende do apoio familiar e que nem sempre a aluna vai deixar de frequentar a escola. O professor Ricardo também aborda que “é natural. Eu acho que facilita a pobreza. Eu acho que facilita a questão da vulnerabilidade. Vai ter a vulnerabilidade, vai ter menos coisas para fazer, né?”

Aqui, todos os professores são brancos, de classe média e com experiência reprodutiva, sendo que o mesmo ocorre com a professora. O que rege o pensamento destes(as) educadores(as)? Temos que falar dos regimes morais (Morgan; Roberts, 2012) que apontam para o que é “certo e errado”, “moral ou imoral”, “normal ou anormal”.

Também, nos cabe aqui o conceito de pânico moral (Bozon, 2012) que trata do alarmismo sexual dos adultos, em torno da sexualidade dos(as) jovens, o que nos ajuda a explicar este medo em torno da gestação. Ainda, o próprio contexto social e cultural onde os(as) profissionais se encontram que repreende a gestação juvenil, é um fator que influencia na utilização do micromecanismo de contenção reprodutiva, bem como o contexto de trabalho dos(as) agentes, o qual têm pouco tempo, poucos recursos, não têm formação sobre SSR juvenil e também não têm uma relação de proximidade com os(as) jovens, para criar um diálogo mais horizontal sobre o planejamento familiar e vontades de gestar do(a) jovem.

Todos estes pontos levam à ação dos(as) agentes a partir de micromecanismos de contenção reprodutiva, onde os jovens homens e mulheres, mas principalmente mulheres, são inibidos(as) a gestarem devido aos “problemas” que isso irá trazer na vida deles(as), segundo a visão dos(as) profissionais.

Estes(as) profissionais de saúde e educação têm uma visão do que deve ser a parentalidade positiva e ela não está associada aos(as) jovens. Nesse sentido:

Assim, uma gravidez nessa faixa etária parece nunca ser chamada simplesmente de gravidez. Ao contrário, ela é recorrentemente adjetivada de, por exemplo, “na adolescência”, “precocidade”, “indesejada”, “não planejada”, “de risco” ou “inesperada”. Cabe observar que, sendo a idade adulta o período da vida considerado ideal para gerar um filho, não se fala, por exemplo, em gravidez na idade adulta ou “gravidez na adulescência” - expressão que nem mesmo consta nos dicionários. É necessário nomear apenas o que foge à norma (Altmann, 2009, p. 178).

Heilborn (2006) também destaca a construção da noção de que a gravidez na juventude é um problema social, vista como um evento perturbador. Para ela, essa visão ignora a diversidade de circunstâncias e de desdobramentos que a maternidade e paternidade juvenil podem trazer.

Se na escola os profissionais têm essa visão da gestação como um problema, o mesmo se mantém na maioria dos(as) funcionários da US. Aqui, não iremos abordar um(a) a um(a) em suas falas, mas destacar discursos que seguem o mesmo padrão e aqueles que fogem desta “norma”.

“Problema”, “risco”, “complicado”, “eu não entendo como querem ter filho nessa idade”, “não sabem a ordem das coisas” são exemplos de falas que ouvi de funcionários(as) da US quando apresentei minha pesquisa no que se referia à gestação. Durante as entrevistas, médicos, médica, enfermeiro e enfermeiras mantiveram o discurso dos problemas da gravidez, no que se refere não tanto à saúde biológica, mas ao contexto social normalmente associando a questão financeira. Ter “estrutura” ou ser “desestruturada” contavam muito na percepção deles(as) para destacar a gravidez como inapropriada ou não.

Aqui, vale apontar que o próprio Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, e que é a base para o trabalho dos(as) profissionais, principalmente enfermeiros(as), destaca a gestação juvenil como de “risco intermediário” (Porto Alegre, 2018b). Apesar de nenhum(a) profissional destacar esse trecho do Protocolo em suas falas, vemos também neste documento destacado o “risco” da gestação na juventude.

Alguns(as) profissionais citaram contextos das jovens para justificar porque elas acabavam gestando, mas ainda sem concordar. Os pontos envolviam “medo de violência e [...] questão cultural, de que a mãe teve tantos filhos, a avó teve tantos filhos [...], envolve afastamento deles da escola, envolve afastamento deles da possibilidade de uma independência financeira” (Med. Benjamin).

A ACS Fernanda também concorda com os pontos que o médico destacou. A enfermeira Cássia e outras destacam o papel que ser mãe exerce também, na comunidade, o “ser respeitada”. A médica Amarilis, próximo do que fala Cássia, destaca: “muitas adolescentes vêm

com uma questão da gravidez como se fosse um passe de liberdade, um passe para a vida adulta precoce.” (Med. Amarilis).

Um consenso entre todos é que ter uma “estrutura familiar”, leia-se estrutura financeira e família heterossexual - pai e mãe -, é importante para minimizar os “problemas” da gestação. Trazemos aqui a discussão da parentalidade positiva e os julgamentos acerca de quem deve gestar, como e de que forma cuidar da criança. Como destaca o enfermeiro Rafael: “quando é planejada, ela já tem realmente um preparo emocional um pouco melhor. Mas aí depende de outros fatores também: envolve essa questão da rede de apoio, da questão familiar, da questão financeira, do trabalho. Se isso tá bem articulado ali, tem chances de fluir bem.” (Enf. Rafael).

A maioria dos(as) agentes de saúde e educação destacavam sua incompreensão ao fato de jovens quererem gestar: “Aí, eu perguntei para ela assim: ‘Tu queria essa gestação?’ Ela disse: ‘Eu queria.’ 14 anos! 14 anos! Eu não sei se tu brincava com o boneco, mas puta que pariu, vai brincar, sabe. Vai ter *crush* na escola, velho.” (Med. Benjamin).

A ACS Fernanda conversava comigo um dia, em sua sala, sobre um grupo de planejamento familiar e disse: “Eu não consigo ficar feliz com as grávidas aqui do território. É mais uma criancinha para correr na vila. Mais uma para traficar.” (ACS Fernanda). Ela seguiu falando que normalmente eram crianças de “famílias desestruturadas”. Quem tem o direito de gestar?

Apesar de não concordarem com o fato de jovens quererem gestar, uma funcionária e um funcionário da US entendem os motivos das jovens gestarem: uma técnica de enfermagem que - coincidentemente ou não - já foi ACS durante mais de dez anos, e um médico:

Assim, não vejo tanto problema, principalmente ali no território até por conta daquela questão que nós conversamos sobre os planos, as expectativas que a grande maioria, mesmo por ser uma gravidez não planejada, uma das coisas que elas almejavam durante a adolescência ali era ter filhos. E não necessariamente isso impede ela de seguir a vida. Porque, sei lá, muitas vezes a gente vê a gravidez como algo que dificulta tu fazer uma faculdade, tu progredir numa carreira, só que não atrapalha tanto, né? E ali no bairro eu noto que muitas vezes elas não reclamam disso, tipo assim: “Ah, acabou minha vida.” Elas vêm com uma forma, tipo assim: “Ah, aconteceu, beleza.” As que não planejam, né? Dizem: “Vamos lá Sim, vamos seguir, né? Vamos seguir adiante” (Med. JP).

A fala da técnica Maria é próxima desta, onde o médico se coloca no lugar do paciente e tenta avaliar a situação a partir dali, entendendo o território, o contexto da jovem e como funciona a sua dinâmica e, acima de tudo, respeitando as escolhas dela. A técnica Maria destaca:

Tipo, as pessoas ficam: “aí, mais uma menina grávida.” A maioria fala isso mesmo. Eu no meu caso gosto de ver todo o contexto, mas existe bastante isso: ‘ai, mais uma,

ai não se cuidou, aí nos dias de hoje...’ entendeu? Mas não vê o lado delas. Às vezes é que elas querem. E tudo bem, né, se quiser também porque é a vida dela. Às vezes tu ganha um papel mais na comunidade de ser mãe, tu vê sentido naquilo. Agora eu sou mulher, sou dona de mim. Sair da casa dos pais. Tem uma importância, ela se sente importante (Tec. Enf. Maria).

Qual a diferença no perfil deste médico, desta ACS e da técnica de enfermagem com o restante? O médico é branco, de camadas médias, tem 25 anos, não reside próximo ao território, sem experiência reprodutiva, é heterossexual. Já a técnica é preta, de camadas populares, tem 47 anos, com experiência reprodutiva, reside em um bairro próximo e também é heterossexual.

Inclusive, a técnica Maria teve uma filha aos 19 anos jovem e traz este fato para a entrevista:

Eu tive um filho muito nova, mas depois com o decorrer da vida eu penso que tive na idade certa. Varia muito de pessoa para pessoa, o que tu quer da tua vida. Algumas coisas tu vai ter que abrir mão, aí depois tu vai ter que retomar ou não. Eu acho que a maioria das gestantes é mais vulnerável. E não são todos os pais que acompanham, elas são mais sozinhas mesmo e é bem tipo o que eu passei, eu me identifico. Eu gosto quando elas me dão abertura, que daí eu consigo falar um pouco. Eu falo: “Não é o fim da tua vida, tu tem que continuar os teus planos futuros. Claro, dependendo tu vai ter que dar uma segurada, mas depois tu pode retomar. É só uma fase.” É tipo minhas filhas assim (risos). (Tec. Enf. Maria).

No caso desta técnica, o que ajuda a explicar sua acolhida maior em relação às gestantes jovens é sua própria experiência reprodutiva e, segundo ela mesma me relatou durante a entrevista, o fato de já ter sido agente comunitária de saúde por dez anos, o que faz “Ter esse olhar mais abrangente, de ver o contexto.” (Tec. Enf. Maria).

Agora o que explica a aceitação do médico com os casos de gestação na juventude? Ele tem um perfil muito similar aos dos outros dois médicos, uma médica, quatro enfermeiras e um enfermeiro que entrevistei, porém estes(as) percebem a gestação como um grande problema. Aqui, o médico não traz o pânico moral que os demais têm no seu entendimento da gestação das jovens de seu território.

Moraes e Ceccin (2017) trazem uma revisão da literatura de Dias e Teixeira (2010) sobre gravidez juvenil e que aponta para o que aqui queremos chamar a atenção:

a literatura biomédica utiliza expressões como ‘gravidez precoce’, ‘indesejada’, ‘não-planejada’ e ‘de risco’ para descrever e enfatizar as consequências sociais e biológicas ‘negativas’ associadas ao fenômeno, estabelecendo-se uma ideia de adolescência ‘na qual a gestação não está incluída como experiência normativa’, mas, ao contrário, vista como um ‘desvio de percurso’, um ‘evento não desejado’ pelas adolescentes e cujas consequências frustram o que seria considerado uma ‘boa’ adolescência. (Moraes; Ceccin, 2017, p. 376).

Os estudos acadêmicos relatam que os profissionais de saúde definem a existência de um “normal”, “ideal” e “padrão” de momento para a reprodução. Isso nos levanta questionamentos acerca da saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens, sendo que a sexualidade juvenil é taxada *a priori* como sexualidade de risco (Bozon, 2009).

Agora nos perguntamos como profissionais de duas áreas distintas - educação e saúde - com formações completamente diferentes e relações com jovens tão diversas têm a mesma perspectiva da gestação na juventude como um problema? Podemos aqui explorar construções sociais, moralidades, pânico de deles(as) e seus contextos de atuação que enfrentam inúmeras limitações de tempo, dinheiro, apoio de Secretaria de Saúde e Educação, formações acerca da SSR juvenil, dentre outros pontos que vemos ao longo da tese.

Assim: “Quando se trata da sexualidade adolescente, imbricada no fenômeno da gravidez dita precoce, desenha-se um imaginário de tintas dramáticas sobre a erotização de pessoas consideradas muito jovens, associada com frequência com o que é qualificado como desestruturação familiar.” (Heilborn, 2012, p. 65).

Ainda, cabe trazer o conceito de reprodução estratificada desenvolvida por Colen (1995). Relembrando o que vimos no capítulo dois, este conceito destaca que certos grupos de pessoas são encorajadas a reproduzir, enquanto que em outros não e ainda são estigmatizados e/ou punidos por gestar. Entendemos que essa diferenciação tem relação com gênero, idade, classe social, território, entre outros.

Pelo fato de os(as) profissionais de saúde e educação terem a visão da gestação como um problema, essa percepção reduz as experiências juvenis, que fogem do padrão de normalidade que estes(as) consideram adequado: estudar, ter renda estável, construir uma “família estruturada”, casar e só depois gestar. Assim:

Apesar de os profissionais de saúde geralmente perceberem a gravidez na adolescência como indesejada, é preciso levar em consideração que, algumas vezes, a adolescente a almeja, a planeja e se frustra ao conferir que a gravidez não aconteceu. A gestação entre as adolescentes, principalmente nas camadas de baixa renda da população, não condiz, necessariamente, com uma perda ou descontinuidade dos seus projetos de vida. A gravidez muitas vezes aparece enquanto um valor de ônus social que não é assumido como um fato que impeça os planos futuros das adolescentes gestantes (Sena Filha, Catanha, 2014).

Na nossa situação de pesquisa, identificamos classe social, idade e território como marcadores sociais centrais para entendermos este pânico moral e os regimes morais em torno da gestação por parte dos(as) profissionais. A maioria dos(as) trabalhadores(as) da US ou escola citam a falta de recurso financeira das jovens como uma das causas para a gestação ser um

problema. E, aqueles(as) que não citam diretamente, se referem a isso nas entrelinhas como “não está ainda preparada com uma estrutura” (ACS Fernanda).

A enfermeira Cássia destacou em entrevista: “E quando a família tem um financeiro, facilita.” (Enf. Cássia). Certo dia, acompanhando a enfermeira Katucia, ela atendeu uma jovem de 18 anos, para abertura de pré-natal, e depois que acabou o atendimento ela conversou comigo: “Como eu sempre falo: a família tem base. Tu vê que são pessoas instruídas. Ele trabalha no quartel, ela também tem emprego, são pessoas interessadas.” (Enf. Katucia). Todas as falas dela referente ao problema da gravidez na juventude ficam muito ligadas à questão financeira. Quando jovem tem dinheiro e recurso, tem uma família entre aspas “estruturada” como ela fala, fica tudo mais fácil, mais “tranquilo” (Enf. Katucia).

Ou seja, ter recursos financeiros é considerado um requisito importante para os(as) profissionais, mas sabemos que a realidade da comunidade é justamente de renda baixa, onde, segundo a técnica de enfermagem Ana, aproximadamente 90% da população depende de alguma forma do Bolsa Família. Logo, se formos seguir a lógica deles(as), poucas mulheres poderiam gestar naquela comunidade, pois poucas têm a família “estruturada”, isto é: homem, mulher, casa própria e ambos com emprego fixo.

Outro fator é o território. No capítulo cinco, já trouxemos uma análise do território em que se inserem as escolas e a US, por entendermos que ele é um dos determinantes sociais da saúde e também da educação. O território também aparece como um fator negativo para os(as) profissionais, apesar de a maioria não falar diretamente dele nas entrevistas.

Eles(as) falam das condições de moradia e do próprio entorno para o crescimento da criança, como já trazido na fala de Fernanda: “Eu não consigo ficar feliz com as grávidas aqui do território. É mais uma criancinha para correr na vila. Mais uma para traficar.” (ACS Fernanda). Se não se deve ter crianças circulando neste território, então, em última instância, nenhuma mulher da comunidade deve gestar?

A questão da escolaridade também é citada pela grande maioria dos professores, pela professora e funcionários(as) da US: “Muitas vezes a jovem desiste da escola.” (Prof. Felipe) ou “A gravidez interrompe os estudos.” (Med. Benjamin). E, associado à escolaridade, o marcador social mais central para os(as) profissionais aqui é a idade. Fator que tem total relação com o pânico moral em relação com a sexualidade juvenil. A maioria dos entrevistados falam em “queima etapas” (ACS Fernanda), “são imaturas” (Enf. Polina) e “não conseguir aproveitar a juventude” (Prof. Monique).

Ao questionar os(as) entrevistados(as) se todas as jovens eram “imaturas” ou “irresponsáveis”, eles(as) apontavam que nem todas, mas era o perfil da maioria:

Tem meninas que chegam ali com 18 anos, assim, mas elas conduzem super bem, levam todo o pré-natal super a sério, né. Mas das meninas que a gente tinha ali, das que eu acompanhei também, né, nem todas, foram poucos os pré-natais que eu abri e conduzi até o final ali, pelo meu tempo de unidade. Mas das que eu acompanhei, assim, ao longo do pré-natal com menos de 20, é, acho que posso dizer que a maioria delas não era tão assídua nas consultas, tão comprometida com a realização dos exames, assim, e eu acho que muito, um pouco por causa disso, assim, imaturidade, sabe? De compreensão ali da seriedade, né, do que tá acontecendo (Enf. Cássia).

Assim, parte-se do pressuposto que existe uma idade certa da vida para se gestar, uma idade “ideal”. Ideal da perspectiva dos(as) profissionais, que nem sempre é a mesma das jovens. E quais implicações isso tem na prática? Na sequência iremos tentar responder esta questão observando como se dão os encontros entre profissionais de educação e de saúde e jovens.

A percepção dos professores e da professora sobre a gestação influencia certamente sobre a forma com que eles lecionam e o que falam - ou não - acerca da gravidez na juventude. O mesmo acontece com funcionários da US, mas ainda mais intensificado, pois eles(as) têm importância central, desde o processo de decidir gestar ou não, de como será o pré-natal e do pós, como veremos.

7.2 DIÁLOGOS COM OS(AS) PROFESSORES(AS) DE BIOLOGIA

Como já discutido, a BNCC do Ensino Médio - que é o parâmetro de trabalho de três professores - destaca na competência dois “[...] reprodução e hereditariedade” (Brasil, 2018, p. 556). Nesse sentido, a reprodução aparece na legislação como uma temática possível de ser abordada, mas num viés biologicista, do qual já comentamos diversas vezes o motivo de não concordarmos.

Ao conversar com os(as) jovens nas escolas, a maioria, quando se lembram de já terem falado sobre SSR alguma vez, foi “quando era mais novo, que a profe de Ciências falou sobre” (Sandro, sem experiência reprodutiva). As falas dos(as) jovens acerca de não se lembrarem muito bem do que era discutido também eram frequentes.

Segundo todas as alunas, as falas sobre gravidez sempre eram voltadas para “fazer com que a gente não engravidasse” (Alice, sem experiência reprodutiva). Já os jovens não comentavam muito sobre o que aprenderam acerca da gravidez: “Falavam pra gente se cuidar, né? Usar camisinha” (Caio, sem experiência reprodutiva).

Tratando-se dos professores que davam aula para Ensino Fundamental, o professor Felipe, escola A, apontou trabalhar a gestação em sala de aula com os oitavos anos a partir do

viés biologicista, seguindo o livro didático, assim como o professor Ricardo da escola B. Ou seja, eles falam sobre a reprodução, trazendo os órgãos feminino e masculino, explicando o processo de fecundação, trazendo o preservativo peniano e reforçando a preocupação com a gestação na adolescência. Liz, que teve aulas com o professor Ricardo, disse: “Passaram pelo sistema reprodutivo e deu. Tanto, tipo, ó. Só a minha aqui. Dando uma ênfase mais em células, sabe. Mais Biologia, né. No caso do Ricardo. O Ricardo é mais focado em Biologia. Então é só célula, célula, célula.” (Liz, sem experiência reprodutiva).

No Ensino Médio, todos os professores trabalharam de alguma forma a temática da gravidez durante o ano em que acompanhei as atividades. O professor Felipe, escola A, abordou no início do ano com uma das duas turmas de terceiro ano que ele leciona. Eu não pude acompanhar esta aula, mas ele me contou sobre ela quando nos conhecemos e também em entrevista, apontando que foi um momento de troca entre ele e alunos e que a relação mais aproximada que tinha com as alunas, as quais ele conhecia desde o sexto ano, ajudava a tratar da temática com mais naturalidade. Segue:

Quando foi o conteúdo sexual, a gente perguntou de onde essas informações vieram, se foi da família ou de amigos, da própria vida. E daí, se eu não me engano, uns dois ou três ali falaram que tinham bastante informação em casa. [...] Então não só a parte sexual, mas a prevenção contra a gravidez, a prevenção contra doenças, a responsabilidade de cada um. Isso porque eles também estão entrando, alguns já namoram, já estão morando juntos, inclusive. [...] Eu volto ao assunto dizendo: “Quando o pai saiu pra buscar cigarro e nunca volta.” Daí chama os guris: “Imagina você não ter pai porque o pai saiu pra comprar cigarro. Guris, gostariam disso?” “Não, não.” Então tem que ser presente sim. Assim como também a questão para elas: “Gente, isso é uma questão de escolha, escolha também quem vai ser o teu parceiro.” Não é aleatório e depois nunca mais vai aparecer, então precisa-se namorar, ter um desenvolvimento, um conhecimento para daí então as coisas acontecerem e tu formar um casal, digamos assim, não aleatoriamente. Então eu toquei nesse assunto no terceiro ano e as gurias deram um (ele fez gesto de abrir os olhos mais e ficar mais atento): **“Não dá pra escolher qualquer um, sair e depois querer que seja pai, a pessoa vai correr.”** Por mais que não seja o normal, não deveria, mas... Daí eu falo: “Então temos responsabilidade também meninas: saber com quem a gente tá lidando, saber o grau de envolvimento” (Prof. Felipe, grifo nosso).

Aqui, vemos que o professor aponta para uma aula focada no diálogo, não sobre conteúdo em si, quase como se fosse uma roda de conversa e destacando a responsabilidade que os(as) jovens teriam com uma gestação e de como evitar que acontecesse. Aqui é a primeira vez que nos aparece o micromecanismo de contenção reprodutiva em ação, uma vez que o professor tenta coibir os(as) jovens de gestar, falando sobre as dificuldades que isso traria a elas.

Também vemos uma responsabilização maior da mulher em escolher seu parceiro “bem”, pois muitos parceiros vão “correr”. Já para os meninos, o professor pede para “não saírem para comprar cigarro”. Aprofundaremos mais adiante estas assimetrias de gênero, mas

aqui aparece o micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina, que se refere à ação dos(as) profissionais que ratifica a centralidade feminina e a inércia dos homens em suas responsabilidades antes da gestação, durante e após, com o cuidado da criança.

A atividade acima descrita foi feita em uma aula de uma das trilhas de aprendizagem que o professor ministrava. Ao perguntar o motivo dele não ter realizado a conversa no outro terceiro ano que ele também leciona, ele destacou que: “é muito corrido. Eu tenho apenas um período semanal e fica mais difícil realizar discussões, investigar e tudo mais.” (Prof. Felipe). Aqui, vemos o tempo disponível para os profissionais também ser um dos fatores que leva a utilização dos micromecanismos de governança.

Volta aqui a discussão da falta de horários de aula, de disciplinas base como Biologia, e como a saúde sexual e reprodutiva (SSR) acabam ficando em segundo plano, visto que existem diversos outros conteúdos para ministrar em pouquíssimo tempo. Mesma escola, mesmo ano, mesmo professor, mas uma turma discutiu sobre SSR e a outra, não. A segunda, inclusive, não teve oportunidade de acompanhar muitas vezes, pois a aula de Biologia era nos últimos períodos, que muitas vezes não ocorriam devido ao término mais cedo da aula e ao fato de a maioria dos(as) jovens necessitar sair mais cedo para trabalhar, como já comentado em capítulo anterior, ao falarmos sobre o território.

No Ensino Médio, apesar de apenas falar em sala de aula naquele momento sobre a gestação, o professor Felipe relata ter mais conversas com alunas pelos corredores da escola, sendo que jovens homens não o procuram para conversar sobre o assunto. Apesar disso, ele relata que percebe uma certa barreira em relação às jovens, devido a ele ser homem, mas que mesmo assim algumas alunas ainda conversam com ele, sendo questionado sobre ISTs, menstruação e fecundação, normalmente. Aqui, no contexto de atuação dos(as) agentes da escola, também temos o fator de relações distantes e verticais influenciarem na forma com que se é discutida a SSR.

Já o professor da mesma escola no turno da noite, Gabriel, apontou durante entrevista que segue a BNCC e que “esse conteúdo é lá do oitavo ano, né?” (Prof. Gabriel). Porém eu acompanhei uma aula que ele ministrou, falando sobre reprodução para o primeiro ano do Ensino Médio. O professor passou o conteúdo no quadro, e a maioria copiou. Depois ele foi explicando e algumas pessoas prestaram atenção. Ele estava falando em um formato de palestra sobre reprodução, gravidez e a tabelinha. Ele disse que essa não era a melhor técnica por causa de IST, que tinha que usar camisinha e anticoncepcional. Ele desenhou a vagina, mostrou no quadro sobre quando menstruava. Nenhum(a) aluno(a) fez algum comentário ou pergunta.

A aula acabou não gerando nenhuma discussão e não tendo uma relação mais aproximada e horizontal entre professor e alunos(as), o que também já apontamos como uma das causas da utilização de micromecanismos. O fato de um relacionamento incipiente e distante entre alunos(as) e professor, o qual observei ao longo do meu tempo na escola, sendo que a aula de Biologia só acontece uma vez na semana e durante cerca de trinta minutos.

Nessa aula do primeiro ano do Ensino Médio, vemos os micromecanismos de contenção reprodutiva nos momentos que o professor abordou os “problemas” que a gestação traz e reforçou a contracepção, frisando evitar a gestação. No momento da entrevista, ao perguntar para o professor Gabriel sobre esta aula em questão, ele destacou o seguinte: “Pois é, pra tu ver, agora tu me pegou porque isso aí é um conteúdo que eu dou pro terceiro ano, assim, então eu não lembro como que eu cheguei naquilo ali na aula. Sim. Eu acho que foi pela diferença entre a espermatogênese, né? Que é a formação do espermatozoide para a ovulação da mulher.” (Prof. Gabriel).

Tempos depois, eu fiz uma roda de conversa com aquela turma e os(as) jovens apontaram que o professor nunca tinha falado sobre SSR nas aulas do Ensino Médio. Então, não é só uma questão de “passar o conteúdo”, mas sim de conseguir engajar os(as) alunos(as) na discussão de alguma forma. Estes(as) se lembravam mais da conversa que tiveram no oitavo ano na aula de Ciências do que do conteúdo de duas semanas atrás.

O professor Gabriel apontou que ele abordava reprodução no terceiro ano, mas acompanhei diversas aulas dele acerca de reprodução naquela turma e em nenhuma delas ele falou sobre gestação, prevenção da gestação ou ISTs. Perguntei se falava da gravidez na juventude e ele:

Não costumo trabalhar, assim, não. Sim, é algo que a gente acha que pode constranger alguém, alguma coisa lá, mas é um, um, é um conteúdo a ser abordado, sim. [...] É que geralmente ali no terceiro ano, coisa ali, de noite ali, tem elas, têm filhos, têm filha, elas têm tudo, então geralmente pode ser meio constrangedor (Prof. Gabriel).

Já no que se refere às conversas fora de sala de aula, o professor Gabriel aponta que são poucas as alunas que conversam com ele na escola sobre questões de contracepção, gestação e ISTs e, muito menos, jovens homens. Noto que o relacionamento entre professor e aluno(a) é mais distante do que com o professor Felipe. As turmas só têm uma aula de Biologia por semana, durante 30 minutos, e o professor só está uma noite por semana na escola, sendo que não são turmas que ele conheça há muito tempo, como é o caso do professor Felipe. Isso também

dificulta uma abertura maior para falar sobre o assunto que ainda é tratado como tabu por muitos.

Acerca da sexualidade como um tabu, observei várias vezes essa expressão tanto em profissionais de saúde e de educação quanto nos(as) jovens. Ferreira, Piazza e Souza (2019) corrobora com esse achado ao trazer que a sexualidade permanece como um “tabu social” rodeada de estereótipos, valores, crenças e moralidades. Devido a isso, a sexualidade acaba sendo abordada de forma superficial entre pais e filhos(as) e em um modelo biologicista do currículo escolar.

Em relação ao professor e ao(a) aluno(a), diferente de Gabriel, Monique, professora da escola B, tem uma relação de proximidade com a maioria dos(as) estudantes. A professora se denomina como “mãezona” dos(as) estudantes e chama estes(as) de “meus bebês”. Ela foi aluna da escola B e está há mais de oito anos atuando nela como professora e, mais recentemente, como presidente do Conselho Escolar, o que ela aponta como fator que a aproxima ainda mais dos(as) alunos(as) e da comunidade escolar.

Acompanhando as aulas no dia a dia sempre vi Monique muito próxima dos(as) jovens, inclusive, durante as entrevistas e rodas de conversa com alunos(as) da escola B, ao perguntar se se sentiriam à vontade de conversar com alguém de lá sobre sexualidade, sempre respondiam o nome dela. E a justificativa era: “Porque ela nos entende, nos dá abertura e não fica só nos julgando.” (Fabiano, 18 anos, sem experiência reprodutiva).

A professora Monique me relatou vários momentos em que dialogou com alunos e alunas fora de sala de aula, principalmente alunas: sobre camisinha, relacionamento, contracepção, ISTs e gravidez. Inclusive, tratou do caso de uma aluna que queria que a professora contasse para seus pais que estava grávida, por medo da reação deles. Ela confiou primeiro na professora para falar.

Monique aponta que segue os PCNs e que aborda a questão da gravidez na adolescência e ISTs no segundo ano do Ensino Médio. Ao questionar sobre a forma que ela aborda a questão da gravidez, responde:

A gente fala sobre gravidez, a importância de saber em que momento começar a construir uma família. Do fato de que alguns são tão jovens e já são casados, já são casados, já vivem juntos. Temos uma aluna à noite que ela deve ter dezessete anos já tá com o menino, já tá morando. Então eu digo que é duas crianças que na realidade precisam ter todo o cuidado pra não fazer uma nova criança (Prof. Monique).

No que se refere à gestação, ela conta que conversa no sentido de “preservar”, de “dar tempo às coisas” e no sentido de prevenção com eles(as), logo, micromecanismos de contenção

reprodutiva, que ela utiliza ao conversar com as jovens sobre saúde sexual e reprodutiva, sempre focando em evitar a gestação, a qual teria um “tempo certo”.

O professor Ricardo se refere também à sexualidade como conteúdo do oitavo ano e destaca que até cerca de três anos atrás, ele não abordava a SSR com os mais novos, pois não estava na BNCC, mas que agora “comecei a passar para eles.” (Prof. Ricardo). Sobre suas aulas no Ensino Fundamental, quando perguntei o que aborda, ele respondeu:

Reprodução humana. Daí vai ali falar sobre menstruação. Sobre o sistema genital. E a questão dos hormônios. E a doença sexualmente transmissível. Falar que existe isso também. Às vezes os métodos anticonceptivos. Isso tudo está no livro. E daí num outro capítulo, a sexualidade. Às vezes, conforme dá tempo, tu exploras. Na verdade, eu acho que está no mesmo capítulo. E não aborda muito (Prof. Ricardo).

Sobre a ótica dos(as) jovens, nas rodas de conversa e/ou entrevistas, quando questionados(as) sobre atividades em sala de aula com professores, não era comentado outra atividade além da “clássica” aula de Ciências/Biologia sobre a reprodução humana. E, pelo que os(as) estudantes falam, fica claro que as aulas eram compostas de meninos fazendo piadas, professor(a) falando sobre reprodução no sentido biologicista e tratando da importância do uso de camisinha para prevenir gestação e infecções sexualmente transmissíveis. É isso que ficou na memória dos(as) jovens até hoje: “Ah, falava sobre usar camisinha, gravidez e aquelas doenças lá, né?” (Marcos, sem experiência reprodutiva).

O professor Ricardo aponta que toda vez que falou sobre gravidez, ele citou “E principalmente nessa parte deles se protegerem, da preocupação de ter um filho, de cuidar.” (Prof. Ricardo). O discurso sobre a gestação sempre está ligado a micromecanismos de contenção reprodutiva. Ricardo fala também sobre a dificuldade de alunas se manterem na escola e sobre as questões financeiras sempre alertando os(as) jovens para o “risco”. Fora da sala de aula, ele diz que é muito pouco procurado para tirar dúvidas ou conversar acerca da SSR.

Em relação aos marcadores sociais da diferença, se olharmos para o quanto os(as) jovens tiveram acesso às discussões sobre sexualidade, novamente, não conseguimos fazer uma distinção significativa de classe social, visto que a maioria é de camadas populares e estudou nas mesmas escolas estaduais no Ensino Fundamental. Porém, durante as rodas de conversa, tive o caso de duas alunas que destacaram terem tido mais informações sobre contracepção em escolas que estudaram fora do bairro, nas quais eram bolsistas.

No que se refere à raça, não houve nenhuma distinção de conhecimentos adquiridos na escola acerca de SSR percebida, em se tratando dos(as) alunos(as) pretos(as), pardos(as) ou

brancos(as), sendo que a maioria dos(as) jovens do território - cerca de 70% - é negro(a), segundo minhas observações do cotidiano no espaço. Conversei e trouxe aqui falas de jovens entre 16 e 20 anos, sendo que as informações que estes(as) tiveram no ambiente escolar são similares, independente de estarem no primeiro ou no terceiro ano do Ensino Médio. Em geral, os três professores e a professora falam que trabalham esse conteúdo em pelo menos um destes anos, mas os(as) alunos(as), ao serem questionados(as), com exceção da aula com o professor Felipe no Ensino Médio, não se recordam de explicações para além daquelas ministradas no Ensino Fundamental. Alguns(as) estudantes tiveram mais acesso às palestras sobre SSR através de pessoas advindas de universidades, mas não é uma diferença considerável.

No que se refere a gênero, as jovens têm mais predisposição a conversar com a professora Monique do que os jovens da escola B. Percebemos aqui um distanciamento maior dos jovens homens, no que tange o cuidado com sua saúde sexual e reprodutiva, fator que iremos acompanhar intensivamente no serviço de saúde. Ainda, percebemos que os jovens citaram que tiveram aulas, mas sem dar maior importância para o assunto, enquanto que as jovens destacam que eram muito mais pressionadas e alertadas sobre os riscos de uma gravidez na juventude. Aqui, temos dois micromecanismos em ação: contenção reprodutiva e acumulação reprodutiva feminina.

A responsabilização por parte dos três professores e da professora continua sendo direcionada para a mulher, sendo as falas mais pontuais para os problemas que a jovem vai enfrentar caso gestar: mudar totalmente a rotina, parar de estudar, dificuldades financeiras, vergonha em estar gestante, entre outras. Enquanto que a vida do homem “segue a mesma”. (Prof. Felipe). Logo, micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina são aqui percebidos.

Aqui, trouxemos a visão de quatro professores(as) de escolas estaduais que trabalham de forma diversificada a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens no que se refere à gestação. No Ensino Fundamental, todos(as) têm o discurso de que a reprodução é discutida nas aulas no oitavo ano, mas no Ensino Médio, espaço que focamos aqui, a questão já muda de figura com mais ou menos intensidade nas falas, mais ou menos abertura com os(as) alunos(as) e diferentes comportamentos de acordo com as turmas.

Todos os professores e a professora têm perfis similares que já discutimos na seção anterior (7.1) no que se refere a ser de camadas médias, brancos, heterossexual e ter experiência reprodutiva. Todos(as) têm um alto grau de agência, e novamente entram em cena os regimes morais e pânico moral que rege as escolhas dos(as) professores(as), culminando em micromecanismos de contenção reprodutiva na fala de todos(as) ao frisarem para os(as)

estudantes que estes(as) não devem gestar neste momento da vida, reafirmando as visões sobre a gestação que trouxemos na seção 7.1. Ainda, em diversos momentos, os professores e a professora agem a partir de micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina.

Se olharmos para os marcadores sociais da diferença entre os quatro professores das escolas A e B, o marcador que se diferencia é o de gênero. Como citamos aqui, a diferença percebida é de que jovens mulheres se sentem mais à vontade para dialogar com a professora do que com os professores. Claro que há o fato de ela ser uma professora comunicativa e que trata os(as) estudantes de maneira mais aproximada, porém entendemos que o fato de ela ser mulher também auxilia nessa relação mais aproximada. Nesse caso, não há a barreira de gênero a ser vencida.

7.3 E PARA ALÉM DOS(AS) PROFESSORES(AS) DE BIOLOGIA?

Quando eu conversei com as turmas nas rodas de conversa, com alunos(as) nos corredores e nas entrevistas, estes(as) destacaram outras poucas intervenções para além das aulas de Ciência, normalmente de alunos de uma universidade próxima que “vieram falar sobre essas coisas de cuidado pra não ficar grávida e não pegar essas doenças” (Aline, sem experiência reprodutiva).

Jovens que estudaram em uma escola de Ensino Fundamental, aqui chamaremos de escola C, e outros(as) que estudaram em outra de Ensino Fundamental, aqui será escola D, ambas no território, relatam que tiveram mais atividades sobre gravidez e métodos contraceptivos do que alunos(as) que não estudaram em qualquer uma destas instituições.

A escola C é aquela que fica ao lado da US em que desenvolvi a pesquisa de campo e os(as) alunos(as) comentam sobre atividades do PSE, que foram realizadas ali: “já veio tia do posto falar com a gente sobre esses bagulhos de camisinha, proteger doenças e pra não ficar ‘grávido’.” (Cristian, 2024, sem experiência reprodutiva).

Trago um diálogo sobre atividade do PSE, envolvendo alunos(as) da escola A durante roda de conversa:

Clarice: Na escola, a mulher do posto ia lá. Ah, ela fazia a gente escrever num papelzinho e perguntar as coisas. Ela não sabia quem perguntou, elas colocavam várias. Daí pra ninguém saber o que a pessoa perguntou.

ENT: Tu lembra se tu perguntou alguma coisa?

Clarice: Não perguntei, fiquei com vergonha.

ENT: Mas foi legal essa aula que vocês tiveram? Teve dúvidas interessantes assim, sei lá.

Erick: Pelo visto não aprendeu a não ter filho.

Clarice: Eu já tava grávida, não adiantava mais. (Roda de conversa, terceiro ano do EM)

Clarice concordou com ele e a sala ficou alguns segundos em um silêncio constrangedor. Os(as) estudantes entendem que as atividades do PSE buscam dissuadir a gestação. As atividades do PSE que foram comentadas eram realizadas pela ACS Carolina e pela enfermeira Olívia, ambas participantes da pesquisa e funcionárias da US. Alunos(as) que fizeram o Ensino Fundamental em outras escolas não citam terem tido atividades sobre sexualidade com agentes de serviço de saúde, o que não significa que não tenham havido momentos, mas denota que, caso houve, não foram marcantes para recordarem até hoje.

Acerca do PSE, ensinar sobre prevenção da gestação, focando em uso de camisinha e falar sobre ISTs, sempre foi o foco da enfermeira e da ACS da US. A ACS Fernanda diz que é apaixonada pelo PSE e destaca:

Eu sempre brincava. Que eu fazia um PSE Plus. Né? Porque não é só eu ir ali um dia. Sabe? [...] Então quando eu ia eu falava sobre redes protetivas, sobre vínculos, sobre bullying, álcool e drogas, sobre as ISTs, sobre gravidez na adolescência, sabe. Então tipo, é um trabalho maravilhoso. Mais elaborado. Três meses. Tinha dias que eu ia duas, uma vez por semana, manhã e tarde. [...] Sobre gravidez falava que é um menino que também a culpa não é só da menina de ter gestado, ele tem que ter essa responsabilidade de perguntar. Isso é uma coisa que eu falo na escola, de tu perguntar se a tua companheira se tá tomando anticoncepcional, de vir com ela numa consulta pra tirar dúvidas do anticoncepcional, de tentar entender qual é o melhor, qual não é. Porque tu tem toda a responsabilidade: se ela engravidar foi 50% teu e 50% dela (ACS Carolina).

A ACS Carolina também fala sobre uma caixa de perguntas anônimas que ela e a colega disponibilizavam para as turmas e na aula seguinte elas respondiam. Ela considera que tinham “perguntas cabeludas” sobre gestação como “pode engravidar dando o cu?” e “Primeira relação não engravida?” (ACS, Carolina). Carolina conta que no passado fazia todo um trabalho mais longitudinal e que era muito importante para criar vínculos com os(as) jovens, assim como destaca a enfermeira Olívia:

Isso na época que eu fiz de sexualidade, saúde mental álcool e drogas veio muito jovem no posto. Então alguns que tinham passado por mim lá ou irmãos, tipo assim: Ah, tem uma enfermeira muito legal, não sei o que. E vai lá. Aí o irmão da fulana que tinha passado comigo no Chico Mendes vinha, os pais vinham também. Isso é bacana. E eu acho que isso também é pouco aproveitado (Enf. Olívia).

Apesar de não ter acompanhado qualquer trabalho do PSE, acerca da temática da sexualidade no ano em que estive em campo, uma das enfermeiras, antes de ser desvinculada da US, tinha o planejamento de realizar um:

Então, ali a gente tava com um plano de fazer sobre sexualidade, né. Mas muito por conta da tua presença ali, na verdade, que inspirou a gente. E a gente ia fazer uma ação de sexualidade com os jovens. E, daí, a gente ia, a gente tava estruturando, eram os oitavos e os nonos anos, né. Os oitavos e os nonos anos, assim, daí a gente tinha algumas, algumas coisas estruturadas (Enf^a Cássia).

Pouco depois, esta enfermeira foi realocada para outra US e a atividade não teve sequência, mas, um dia no serviço de saúde ela havia me dito: “Vamos falar sobre saúde sexual e disse que tu ia falar. A gente vai ir junto com a Bárbara, não a Bárbara que vai junto com a gente. A gente segura o cartaz e a Bárbara fala.” (Enf. Cássia). Quando ela falou isso, comecei a rir, mas ela me disse: “Não, eu tô falando sério.”

Assim como com os(as) professores(as) que sugeriram que eu fizesse as rodas de conversa, pois “é importante alguém falar com eles sobre esse assunto (saúde sexual e reprodutiva)” (Prof. Ricardo), a equipe da US queria que eu ministrasse uma atividade que era de sua responsabilidade. Em ambos os casos, percebi que para além de um receio de falar sobre SSR, os profissionais têm despreparo para fazê-lo.

Ainda, no caso dessa atividade do PSE, a minha presença na US certamente influenciou a escolha da temática, sendo que a própria enfermeira Cássia me disse: “Estava pensando em fazer o PSE sobre saúde sexual que daí ia ser legal pra tua pesquisa.” (Enf. Cássia). De toda a forma, a atividade acabou não acontecendo e foi realizada uma sobre pediculoses em seu lugar.

Vale citar um caso relacionado com moralidades em torno da sexualidade que ocorreu em 2023, envolvendo este Programa e a US, e que também tem relação com o contexto social e cultural conservador que vivemos atualmente, o qual já destacamos que pode influenciar na utilização dos micromecanismos: a ACS Carolina me relatou que não conseguiu fazer o trabalho do PSE sobre sexualidade numa turma de oitavo ano, pois a professora da turma barrou a atividade por entender que não era adequada para os(as) alunos(as). Ela conta que também não foram mais atrás para conversar com a direção ou com a professora novamente depois da recusa.

Mas, fora esse episódio, algumas mães já foram até a unidade para saber mais do que tinha sido ensinado aos filhos durante o PSE e, depois de entenderem, não repudiaram as ações. Toda vez que realizavam ações do PSE acerca da SSR, a ACS e enfermeira enviavam uma autorização para ser assinada pelos responsáveis para que o(a) estudante pudesse acompanhar as atividades do PSE.

Já os(as) jovens que estudaram na escola D relatam terem tido aula sobre “essas coisas aí [se referindo à SSR] com uma supervisora da escola” (Cauã, sem experiência reprodutiva). “A Samanta mostrava camisinha, ela mostrava posição. Ela desenhava o pênis e uma periquita

no quadro e ia falando. Ela falava, falava. Às vezes chamava aluno na frente. Ela falava também de doença, uso de camisinha.” (Kátia, 19 anos, sem experiência reprodutiva).

Ao conhecer o território da pesquisa, fui até a escola D - que também fica próxima da US - e conversei com esta supervisora, Samanta, sobre realizar ali parte do estudo. Chegamos à conclusão que não seria tão frutífero, pois a maioria dos(as) alunos(as) tinham até 15 anos. Ela me disse que organizava em média três aulas sobre SSR “porque aqui é uma população muito carente, têm filhos cedo demais e eles precisam saber.”

As atividades que ocorriam na escola C estão relacionadas a uma política pública, agora, as atividades da escola D são organizadas partindo da coordenadora, a qual a maioria dos(as) alunos(as) lembra com carinho e falou ter uma boa relação. Aqui, vemos uma agência muito forte dessa funcionária que não era professora, mas que via a necessidade de dialogar com os(as) estudantes sobre a SSR, principalmente sobre a gestação, desembocando na utilização de micromecanismos de contenção reprodutiva e também de coerção contraceptiva.

Ainda, poucos(as) estudantes citaram, mas alguns participavam de atividades no Serviço de Apoio Sócio Educativo (SASE) onde Fabrício destaca que:

Uma coisa boa do SASE é que lá no SASE a gente recebeu uma ginecologista. E daí a gente falou bastante sobre como funcionam os organismos, e foi muito bom. A gente falou sobre as camisinhas com sabor, a gente falou sobre também um pouquinho das doenças, mas eu não lembro porque faz bastante tempo. A gente conversou sobre o sistema genital da mulher e do homem, como ele funcionava, meio que, ah, o desenho deles ali no, tipo, raio X. Tinha 13 anos (Fabrício, sem experiência reprodutiva).

Então, vemos que para além das aulas de Ciências no oitavo ano sobre reprodução, que nem todos(as) estudantes tiveram, não há uma regularidade nas conversas sobre gestação. Depende muito do professor(a) que se tem e se a US vai até a escola fazer atividades sobre sexualidade, através do PSE. Ou seja, vemos aí a agência e notamos micromecanismos de contenção reprodutiva e também de coerção contraceptiva, quando os(as) profissionais coíbem as jovens a utilizarem contracepção muitas vezes não trazendo todos os métodos que existem, não explicando totalmente seus prós e contras e/ou direcionando as jovens a usarem um método diferente daquele que elas desejavam. Discutiremos melhor a contracepção no capítulo oito da tese.

Na realidade, muitos(as) jovens destacam que tiveram comigo pela primeira vez uma conversa sobre saúde sexual e reprodutiva. Acredito que eu mesma poderia me colocar nesse grupo de atividades que os(as) jovens têm acesso e como uma “sora” que eles(as) procuram para tirar dúvidas acerca de contracepção, prazer feminino, dor na relação sexual, ida a US, entre outras. Mas, mesmo eu, não pude estar presente em todas as turmas da escola A, como

pude na escola B, devido à abertura dada pelos(as) diferentes professores(as). Aí podemos falar em agência novamente, ou seja, na escolha que os(as) profissionais tiveram de me deixar participar de mais atividades com as turmas ou não.

7.4 GESTAÇÃO E PUERPÉRIO NA ESCOLA

Depois que é confirmada a gestação, em dado momento a jovem vai ter licença para não frequentar mais a aula. Neste ponto, todos(as) os(as) professores(as) com quem conversei destacam deixar material na escola para as gestantes buscarem, mas que elas nem sempre vão. Ademais, o material nem sempre é distribuído por todos os professores, como conta Felipe. Eu acompanhei duas gestantes durante este ano que estão fora da escola devido à gestação, mas também duas que se mantiveram indo à escola e, posteriormente, pegando o material na escola para fazerem as atividades em casa.

Todas as gestantes que seguiram buscando materiais na escola relatam a dificuldade de compreensão e a falta de conteúdos de todas as matérias. Fabiana, aluna do primeiro ano noturno da escola A, destacou:

Eles me deram, só que daí eu voltei pra ir pra escola. E daí eu parei porque eu não entendi. É, eles só me davam as coisas, não tinha nenhuma explicação junto. Vinha só as matérias e o conteúdo, né, pra gente saber. Ah, eu não entendia nada. Eu falei que não tinha explicação. Eles falaram que era mais fácil eu voltar se eu não entendi. Aí eu voltei depois (Fabiana, com experiência reprodutiva).

Após o nascimento, ao voltarem para a escola, as jovens recebem tratamento diferenciado, podendo sair mais cedo para amamentar. Segundo a professora Monique, existe “alguma lei” que ela não lembra mais qual é, que fala sobre isso. A lei a que se refere é a Lei nº 14.952/24, a qual garante um regime escolar especial para mães lactantes, incluindo-as na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e aborda sobre um regime especial que permite a continuidade das atividades escolares para estudantes que não podem frequentar as aulas presencialmente, mas não trata sobre a saída de mães jovens mais cedo da escola (Brasil, 2024). Uma das entrevistadas está nesse processo de retomada da escola agora e destaca que “está sendo bem tranquilo, eu posso sair mais cedo quando precisa”. (Janaína, com experiência reprodutiva).

Após a aula, conversei com o vice-diretor da noite e ele disse que Madalena pediu no dia anterior se podia trazer a criança e ele disse que só um dia. O vice-diretor falou para mim que ela tinha que estudar e assim não conseguia, não dava para ela se concentrar. E também

reclamou que a criança ficava passando na mão de todo mundo e que distraía todo mundo. Ademais, destaca que o ECA aponta para a necessidade de estudar, que é um direito de Madalena vir para a escola, mas eles não têm estrutura para a criança, não tem espaço para ela ficar.

Dias depois, durante a roda de conversa com a turma de Madalena, ela citou esse dia descrito acima:

Madalena: Não, foi a única vez que levei minha bebê. É porque ele foi um escroto, né? Eu fui no banheiro e daí uma amiga segurou minha filha e ele disse: “Não é pra deixar ninguém pegar tua filha.” Eu falei: Como assim? O filho é meu.
Tatiane: Ele disse pra mim: “Não, a filha é dela, ela que tem que pegar. Não fica acostumando ela, senão ela vai te dar a criança pra pegar toda hora.”
Talia: Daí quando a Madalena disse que não tinha ninguém para deixar, ele disse que não era pra trazer para a escola, que não era problema dele (Roda de conversa, 16 anos, jovens com e sem experiência reprodutiva).

Aqui, observamos a falta de acolhimento para com a jovem mãe. Na mesma escola, estas alunas disseram que de manhã uma colega também teve filho, que ela também estava no primeiro ano do Ensino Médio e foi muito mais bem tratada que Madalena, se sentindo incluída. Conversei com essa mãe e ela disse que foi “tudo muito tranquilo”. Então, novamente na mesma escola, mas posicionamentos diversos.

Eu perguntei nas rodas de conversa se os(as) jovens conversariam com professores ou direção sobre a gestação e na escola A, que responderam que não, sendo que na escola B citaram a professora Monique como alguém que recorreriam para tratar da gestação. Uma aluna destacou:

Eu lembrei da Tânia entregando atestado de ultrassom e aí a vice ficou olhando com cara feia pra ela tipo: Que porra é essa? Sem contar que tem mais uma menina que ganhou bebê recentemente na outra turma e ela foi super rejeitada na escola. Não acolheram ela. É muito difícil, eu acho, sora, acolherem uma pessoa que engravida na adolescência. Eu acho que as pessoas mais julgam do que acolhem, sabe? Isso é algo muito difícil pra pessoa. Entendeu? E tipo: “ah, ela não se cuidou.” Tá, foda-se. Já tem essa criança ali, vai fazer o quê? Vai continuar julgando? (Katrine, sem experiência reprodutiva, roda de conversa).

Outro aluno da escola B falou: “Se as gurias falassem com a coordenação que estavam grávidas, eles só iam falar: vai criar teu filho longe daqui.” (João, 19 anos, sem experiência reprodutiva). Em outras rodas de conversa, em ambas as escolas, respostas similares foram dadas: “Não se sentir confortável”, “não têm abertura”. Mais uma vez, como a relação entre usuário(a) e professor(a) interfere diretamente no cotidiano da política pública, assim, como veremos a seguir no serviço de saúde. Relações que também podem influenciar na utilização

dos micromecanismos, uma vez que os(as) profissionais não conseguem desenvolver uma melhor relação com os(as) jovens para poder discutir temas mais sensíveis como a gestação.

7. 5 GESTAÇÃO, PUERPÉRIO E UNIDADE DE SAÚDE

Agora, ao falar na US, temos alguns pontos-chaves para analisarmos no cotidiano do serviço de saúde, principalmente antes de adentrarmos na gestação. Já no planejamento familiar veremos em grande quantidade os micromecanismos de contenção reprodutiva. Como discutimos na primeira subseção deste capítulo (7.1), a grande maioria dos(as) profissionais de saúde e de educação entendem que a gestação na juventude causa problemas, é um risco e não ocorre no momento ideal. Os regimes morais e o pânico moral dos(as) profissionais afetam diretamente os atendimentos onde se discute planejamento familiar.

São poucos os momentos em que médicos(as) e enfermeiros(as) têm a oportunidade de falar em planejamento familiar, pois são pouquíssimas jovens que procuram a unidade buscando gestar. Não há nenhum protocolo ou norma que destaque que os profissionais devem tentar adiar a gestação juvenil, muito pelo contrário, o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual destaca que “No atendimento aos adolescentes, a atenção à saúde relativa à sexualidade, ao planejamento e à saúde reprodutiva, deve resguardar princípios éticos de respeito à integridade e à autonomia pessoal, sem qualquer tipo de constrangimento.” (Porto Alegre, 2024a, p. 134). Ou seja, quando os(as) profissionais tentam dissuadir a gestação juvenil, eles(as) estão atuando a partir de sua agência e utilizando de micromecanismos de contenção reprodutiva. Outra enfermeira também tem o mesmo posicionamento:

É, uma menina de 17 anos, ela veio em consulta, em demanda espontânea, porque ela queria saber se ela era fértil. Aí eu questionei o porquê dessa preocupação com 17 anos, né? Aí ela, claramente, me passou um miguê. Ela falou assim: “não, é que eu gosto de planejar toda a minha vida e tudo mais. Então, se eu tiver algum problema pra minha vida, eu já quero saber desde agora, né. Porque eu sou uma pessoa que gosta de planejar tudo, né. Todos os âmbitos da minha vida eu gosto de ter esse planejamento e tudo mais. E eu quero ser mãe, então se eu tiver algum problema eu já quero saber desde agora, mas não pra agora. Não quero ser agora. Não quero ser agora.” [...] Então, o que eu trouxe pra ela foi isso, assim, que: “Cara, se você não tem nenhum sintoma, se você não tem um problema, dificilmente você vai ter algum problema, né.” E eu tentei convencer ela sobre o anticoncepcional. Então eu disse: “Olha, se não é pra agora, então quem sabe a gente já inicia o anticoncepcional, e tudo mais.” E aí ela queria, né: “Ah não, mas eu quero fazer os exames primeiro pra ver se tá tudo certo, questão hormonal, e aí sim eu começo o anticoncepcional.” Então deu pra entender ali o que que ela queria realmente engravidar. E aí é bem complicado, assim, e aí é um público que geralmente não volta na consulta, né. Aí eu solicitei alguns exames, aí solicitei que ela voltasse pra mostrar os resultados dos exames assim que fizesse. Mas é difícil tu conseguir dissuadir, né, uma pessoa de 17 anos com preocupação de se é

fértil. Olha só que coisa. Não é nem uma preocupação que eu deveria ter agora, né (Enf. Polina).

Não pude acompanhar essa consulta e conversar com essa jovem, mas temos duas possibilidades: ou realmente ela ainda não queria gestar e a enfermeira fez um prejulgamento dela afirmando que ela queria, ou a jovem realmente queria e mentiu para não ser julgada pela enfermeira. Ambos os cenários são negativos visto que no primeiro a enfermeira fez um prejulgamento da jovem e no segundo a jovem não se sentiu confortável de falar com a enfermeira e iniciar um planejamento familiar.

“Eu sempre assusto muito”, como disse a médica Sara, é na realidade o que a maioria dos(as) profissionais fazem, mas buscam fazer de formas diferentes sendo que alguns(as) são mais incisivos(as) em suas falas. Temos de pensar sobre direitos reprodutivos que aqui são postos em cheque a partir da reprodução estratificada (Morgan; Roberts, 2012) levando à criação de micromecanismos de contenção reprodutiva.

Aqui, os exemplos de falas citadas acerca da dissuasão da gestação vieram de profissionais brancos, com Ensino Superior, homens e mulheres, heterossexuais, de camadas médias ou altas e que não residem no território da US. Ainda, são poucos(as) que já têm filhos(as). E eles(as) fazem referências aos jovens de camadas baixas, que ainda não concluíram o Ensino Médio, que não têm “família estruturada” e que são “ainda crianças” (Enf. Cássia). Como já destacado, o fator raça das jovens gestantes não apareceu como um marcador social determinante para os(as) profissionais apoiarem a gestação juvenil, sendo que a questão econômica, de ter estrutura familiar (pai e mãe) junto da faixa etária são as mais relevantes para os(as) agentes considerarem a gestação com um “problema”.

O outro momento em que se fala em planejamento familiar, sem ser quando jovens procuram o serviço, é no final do terceiro trimestre de gestação ou na consulta de binômio, ou seja, a primeira consulta da mãe e do bebê após o parto. Se discute o planejamento familiar não no sentido de realizar o mesmo, mas sim de evitar uma nova gestação, a qual os(as) profissionais consideram *a priori* indesejável. A recomendação da própria OMS é de um espaçamento de três anos entre as gestações, porém, para além da preocupação com a saúde, os(as) profissionais se preocupam com a jovem de camadas populares gestar novamente.

As falas das diversas consultas que acompanhei eram no sentido de abordar: “então, vamos voltar a usar que método?” (Enf. Olívia). Claro que uma gestação logo após outra pode trazer riscos para a saúde física da mãe e do feto, mas médicos(as) e enfermeiros(as) não falavam sobre os riscos de saúde com as mães, demonstrando um medo maior que elas gestem por acharem que não têm condições de criar mais filhos seja por financeiro ou mental.

Aqui, é importante falar da ACS Fernanda e da ACS Carolina que trouxeram diversas vezes em tom saudosista do grupo de planejamento familiar que existia anos atrás na unidade e como ela queria que ele voltasse:

O planejamento familiar que a gente fazia antigamente, a gente falava sobre métodos contraceptivos, a gente falava sobre o corpo da mulher, a gente falava sobre a questão menstrual, ali, o que que é normal, o que que não é normal. Sobre as dores, porque às vezes tu tem as cólicas, os diferentes tipos de dores, o que é normal, o que não é. [...] A questão dos ferros, a questão da vitamina D, vitamina K. Então tudo isso estava dentro do planejamento, porque quando tu vai gestar ou não, tu precisa estar organizado, teu corpo precisa estar, porque senão vai dar deficiência, vai dar malformação, vai dar alteração. Tanto se tu quiser gestar, quanto se tu não quiser gestar. Tu precisa estar saudável. Corpo. Mente. A gente trabalhava a mente, a gente trabalhava empoderamento feminino, sabe, que eu sou uma mulher, eu me reconheço nesse corpo, eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas vontades. Eu posso dizer para o meu parceiro se eu quero ou não me relacionar com ele, se eu desejo ou não e ele tem que respeitar esse meu desejo: que hoje eu quero, que amanhã eu não quero, que hoje eu estou aberta, eu estou disponível, amanhã eu não estou (ACS Fernanda).

O grupo, segundo a ACS Fernanda, realmente destacava diversos pontos importantes do planejamento familiar e não só passava métodos contraceptivos para as jovens e mulheres que participavam do grupo. Bem como disse ela que as jovens têm o direito de escolher se querem gestar ou não. Vale citar que apenas mulheres eram permitidas no grupo, então novamente vemos os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina sem dar importância para que homens possam entender mais sobre o planejamento familiar sobrecarregando as mulheres, independente de suas idades.

Durante sua entrevista, a ACS Fernanda contou que houve uma mudança no formato do grupo nos últimos anos, da qual ela não compactuava: o nome seguia como planejamento familiar, mas “só fazer renovação de receita [...] Isso não é planejamento familiar.” (ACS Fernanda). A ACS Carolina tentou durante todo o ano, em que estive na Unidade, conseguir que uma enfermeira reavivasse a ideia do grupo, mas sem sucesso.

Os jovens rapazes com quem conversei nas escolas e US nunca haviam escutado falar em planejamento familiar, inclusive não sabiam o que significava, assim como a maioria das jovens. Ao explicar um pouco sobre o significado de planejamento familiar, as jovens destacavam que não conversavam sobre isso na escola ou na US, mas sempre se falava que tinham que usar camisinha para não engravidar - micromecanismos de contenção reprodutiva. Nenhuma das jovens com quem eu conversei relatou já ter ido a US para iniciar um planejamento ou conversado na escola com o(a) professor(a) acerca disso.

A partir do momento em que se descobre a gravidez, “Enfim, quando já está dado o fato, não tem muito o que se fazer, né.” (Enf. Cássia). Aqui, vale citar uma história que a ACS Fernanda me contou sobre uma jovem que descobriu sua segunda gravidez na US:

Ela disse que na segunda gestação dela, a médica pegou e disse pra ela: “Ah, tá grávida de novo!?” Daí ela: “Sim, doutora, pois é”. E ela: “Já ouviu falar em preservativo?” Daí ela olhou, assim, pra médica e disse: **“Sim, já ouvi falar em preservativo. E a senhora já ouviu falar em gravidez que a gente quer?”** E ela disse: “Essa idade não é pra querer.” Daí ela disse: “Bom, mas eu tenho uma cabeça e eu quero.” Então, assim, tu não tá respeitando a liberdade daquela pessoa de escolher a gestação. Ok, se ela tem condição, se ela não tem condição, é uma outra questão que tá vindo ali à luz naquele momento. Mas tem que respeitar, tem que respeitar. É um ser humano que tem um desejo, que tem uma escolha, que tem o seu corpo. E ele faz com o seu corpo o que ele achar que deve. E a gente não tá aqui como profissional pra julgar, muito menos pra usar esse tipo de conduta. Aí eu disse pra ela: “Olha só, a verdade foi bem infeliz, a conduta foi péssima. Só posso te pedir desculpa, é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Desculpa é pouco, pouquíssimo, mas é tudo que eu tenho, né. Mas assim, o direito é teu, o corpo é teu, a vida é tua e as regras são tua. Se tu optou por ter um outro bebê, ok. Eu te diria o quê? Por te conhecer, por ter uma intimidade, porque eu tenho uma intimidade contigo. Eu conheço tua casa, tuas situações, a situação da tua família. Eu sei o quanto é difícil pra ti com uma criança. Eu sei o quanto vai ser difícil com uma segunda criança. Mas eu vivencio contigo a tua experiência na tua casa diferente da médica. Ela nem sabe onde é que tu mora. Ela nem sabe as condições que tu vive. Já pra te dar essa marretada assim. Pra te dar um pré julgamento. Ela não deveria nem fazer isso. Ela deveria ter uma abordagem diferente contigo por ser muito nova” (ACS Fernanda).

Aqui, vemos que a médica agiu a partir de seus regimes morais e teve uma fala que é o retrato do pânico moral com a gestação na juventude. Por sua vez, a ACS falou de forma mais branda sobre as condições financeiras e de rede de apoio da gestante, buscando fazer ela entender que a gestação “não seria fácil”, mas que iria receber apoio.

Normalmente, na primeira consulta, ao abrir o pré-natal as gestantes jovens são encaminhadas para realização do pré-natal de alto risco (PNAR), se o(a) médico(a) ou enfermeiro(a) considerar adequado. Como vimos em capítulo anterior (capítulo 6), na própria Biblioteca Virtual de Atenção Primária localiza-se o PAIGA (Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente), o qual destaca que nem toda a jovem de até 19 anos precisa ser encaminhada ao alto risco (Porto Alegre, 2023, p. 1): “A condição de gestação na adolescência não é critério absoluto para encaminhar ao PNAR, ela pode ser acompanhada pelo SUS”.

O PNAR consiste em realizar consultas em um hospital mais bem equipado, com possibilidade de realizar mais exames e acompanhamento, com mais profissionais como assistente social e psicólogo(a). Mesmo a gestante sendo indicada para o alto risco, é preconizado que ela siga na unidade de saúde (Porto Alegre, 2024b).

Ao serem questionados(as), médicos(as) e enfermeiros(as) têm falas diversas quanto ao encaminhamento: alguns(as) destacam que deve ser encaminhado seguindo o protocolo, outros(as) que nem sempre deve se encaminhar. Há profissionais que sempre encaminham, mas alguns(as) que dizem avaliar a condição da jovem para decidir sobre o encaminhamento e que idade não é um fator isolado.

Novamente, temos a agência dos(as) profissionais que de acordo com os seus valores e percepções acerca da jovem, encaminham ela para o alto risco ou não. Motivos para encaminhar ao alto risco variam desde idade, passando por assiduidade na US e grau de comprometimento com a gestação até fatores econômicos. A raça não aparece como um marcador social determinante, sendo que classe social e idade são centrais.

Aqui, para explicar o encaminhamento para o PNAR de alguns(as) profissionais e de outros(as) não, trazemos a noção de micromecanismos de vigilância reprodutiva. Este se refere às formas que os(as) agentes de saúde encontram para buscar controlar e vigiar a gestação das jovens e os primeiros meses após o nascimento da criança. A expressão “vigilância” teve inspiração em Foucault (1975) e seu clássico “Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão”. Ao indicar a jovem para o PNAR, é uma forma de ela dar sequência com dois pré-natais e a jovem estar “mais acompanhada” (Med. JP), “é uma ajuda a mais pra acompanhar essa gestação que é difícil” (Enf. Cássia).

Acerca das falas dos(as) profissionais, o médico Benjamin aponta que “Gravidez adolescente, em tese, sempre é alto risco.” (Med. Benjamin) enquanto outro destaca: “assim, a idade não é um determinante. Isso não é um determinante. Quer dizer, é um determinante se for abaixo de 16, né, e/ou, por exemplo, assim, uma paciente, tu vê que é menor de idade, e aí tu vê que não é aceito, assim, tu acaba encaminhando, assim, pra manter esse cuidado, assim.” (Med. Cláudio).

O enfermeiro Rafael tem posição parecida com a de Cláudio: “Claro, a idade é um fator, né, de sinal de alarme, assim, pra mim, por exemplo, né, que entra muito no comprometimento, na aceitação da gestante, na vinculação com o serviço, que são as coisas que a gente já entende.” (Enf. Rafael). Já a enfermeira Cássia aponta: “Sim, eu vou encaminhando (para o pré-natal de alto risco)” (Enf. Cássia).

Rafael nos demonstra a agência em sua fala: “pra mim, por exemplo, né”. A ação se torna pessoalizada. O médico JP afirma que varia de profissional para profissional. Aqui, as falas dos(as) médicos(as) e enfermeiros(as) acerca do PNAR divergem e, ao analisar os perfis destes profissionais, todos(as) acabam sendo aproximados sem ter um fator em comum entre eles(as) para explicar as divergências. Todos(as) que citei são brancos(as), de camadas médias

ou altas, não residem no território e não têm experiência reprodutiva. Inclusive, todos(as) têm entre 25 e 33 anos. O que explica as mudanças na forma de tratar o pré-natal juvenil? Valores morais.

Sobre acessar ou não o pré-natal de alto risco, algumas gestantes entrevistadas dizem que gostam de acompanhar lá e outras que não iam e me respondiam timidamente que era porque não queriam, não se sentiam confortáveis ou que era muito ruim fazer dois. A gestante Heloá é uma das que relata gostar do PNAR: “Ah, eu acho muito interessante porque lá é muito bom e aqui é bom também.” (Heloá, com experiência reprodutiva). Sabrina, uma das jovens entrevistadas, trouxe um ponto que alguns(as) profissionais da US reclamam que é a desvinculação da Unidade para ficar somente no PNAR:

Eu não fiz no posto porque ali no posto as menores têm o privilégio de fazer no hospital. É melhor fazer no Presidente [Hospital Presidente Vargas] que daí tu faz várias eco, várias e daí não precisa ficar pagando, daí eles preferem que tu faça. Aí eu desisti do posto. Eles: aí, vai lá no posto, tu precisa ir no posto. Eu: não vou fazer mais no posto. Aí eu fiz só lá (Fabiane, com experiência reprodutiva).

Duas jovens que eu entrevistei e acompanhei durante o pré-natal acabavam indo para as consultas de alto risco, mas não recebiam passagem para ir fazer os exames que solicitavam no hospital. A enfermeira que as atendia me disse: “E aí eu juntei todos os cartõezinhos para dar para elas as passagens, para fazer os exames e tal. Eu dei para um monte de gestante aqueles cartõezinhos. Por isso que eu falei que depende do profissional, entendeu?” (Enf. Olívia).

Certo dia, encontrei uma gestante no corredor da US e fomos conversando sobre como ela estava, sobre como ia a gestação e ela: “Ah, agora eu fui encaminhada para o alto risco, né, daí tenho que ficar lá indo fazer um monte de exame.” (Jasmin, 19 anos, com experiência reprodutiva). E eu: “Ué, mas porque alto risco? Tá tudo bem?” Ela: “Eu acho que sim, não sei porque me mandaram também, o médico só disse pra ir.” (Jasmin, 19 anos, com experiência reprodutiva). Então, a comunicação também não é compreensível para que as jovens entendam o porquê do alto risco, como se os(as) profissionais julgassem que não era importante explicar para as gestantes os motivos de estas acessarem o PNAR.

Ao analisar as falas sobre o cotidiano de gestação, das dez jovens com experiência reprodutiva, na percepção delas não houve nenhuma diferença significativa nas relações que estabeleciam com os(as) profissionais da US independente de idade - 16 ou 19 anos, por exemplo -, raça, condição econômica, escolaridade ou local em que vive. Apesar de que, como vimos, estes fatores podem ter influenciado na decisão do(a) profissional de encaminhar a

gestante para o PNAR, o que alterou todo o processo de seu pré-natal, sem mesmo a jovem saber.

Durante a gestação, “o dano já foi causado”, como me disse certa vez o médico Cláudio, então a saída é manter o pré-natal com consultas que todos(as) falam serem “protocolares”, seguindo as diretrizes de medicação, aferição, resultados de exame “como se fosse um pré-natal normal”. No caso das jovens, é consenso geral dos(as) agentes de saúde que se faz necessário ficar mais atento(a), pois elas são mais “fujonas”, “imaturas”, “irresponsáveis”, algumas categorias utilizadas pelos(as) profissionais tanto de enfermagem, quanto ACSs e médicos(as) para descrever as pacientes.

Esta categorização *a priori* das jovens levam os(as) profissionais a ficar “muito mais em cima delas” (ACS Carolina). Aqui, se revelam micromecanismos de vigilância reprodutiva. Além de seguir as consultas protocolares, o médico Benjamin destaca que “se avalia a questão mais das dificuldades socioeconômicas e outros fatores que podem prejudicar ela.” (Med. Benjamin). Em outros fatores, ele se refere à escola e à manutenção de vínculos e frequência na US.

O que os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) me relataram no cotidiano são falas como: “Tenho um maior cuidado em entender se essa gravidez é planejada ou não.” (Enf. Cássia); “Tento entender se tem rede de apoio.” (Med. Benjamin); “Me preocupo como vai ficar a escola.” (Enf. SRT); “Tento vincular ela mais porque é mais fácil de não seguir o pré-natal.” (Enf. Olívia); e “Explico tudo muito bem explicado para que entenda bem.” (Med. Amarilis).

Se existe essa preocupação com as jovens, poderíamos pensar que os(as) profissionais buscam estabelecer vínculos mais aproximados com as gestantes, porém isso não ocorre com todos(as). Ao longo da prática de cunho etnográfico observei que a aproximação entre usuária e profissional varia de profissional para profissional e de usuária para usuária. Uma enfermeira fala sobre tratar com mais “leveza”, como é o caso de Polina:

Mas muitas coisas assim eu falava com ela num tom de brincadeira. Por exemplo: Ela não fazia exames e eu: Aí vou te pegar pelo pescoço, como assim tu não fez? Então trazia esse tom de brincadeira pra tirar essa parede que tem entre profissional e paciente que às vezes a gente tem um distanciamento porque enfim, o profissional tá ali num pedestalzinho, tá atrás da mesa olhando pra você” (Enf. Polina).

Todos(as) os(as) agentes de saúde entrevistados(as) falavam sobre buscar um diálogo mais horizontal, mas destacaram que alguns casos era mais difícil quando a jovem não queria a gestação ou era mesmo mais fechada, sendo que o risco de não aderir ao pré-natal era maior. Certamente o vínculo com a enfermeira era maior do que com médicos(as) devido à questão de

gênero - a maioria da US é composta por médicos -, tempo de consulta maior da enfermagem do que da medicina - 30 minutos para a primeira de enfermagem e 20 para a segunda - por dia e a própria posição das enfermeiras que, no geral, é mais horizontal do que a dos(as) médicos(as).

Cássia denota um cuidado maior com as jovens que “fogem”, buscando um olhar mais “maternalista”:

Quando é muito difícil, busca ativa, ir na casa delas e procurar. Primeiro, o básico: liga, manda um WhatsApp. Quando não respondeu, bom, vamos em casa: a gente vai em casa, a gente reforça com elas a importância, o que é muito importante pra ela, muito importante pro bebê. [...] É por isso que a gente vai pegando elas de volta, assim, facilita muito, né, essa pessoa que foge, assim, a gente tem que ter cuidado mais maternalista com a pessoa. [...] Mas esses pacientes, assim, gestantes principalmente, fazemos um esforço a mais. E eu percebo que tem toda uma tensão em torno das gestantes, né, enquanto ela está gestando na unidade bem, bem grande (Enf. Cássia).

Aqui, ela reafirma a noção de micromecanismo de vigilância reprodutiva ao trazer que a unidade tem um olhar especial em torno das gestantes jovens. E, normalmente, este micromecanismo é acionado quando os(as) profissionais não têm uma relação de maior proximidade com a jovem, o que faz com que eles fiquem com mais “medo” que ela fuja. A enfermeira Olívia traz outra fala que revela este mesmo micromecanismo:

Assim, tem a questão de marcar mais vezes, não é nem a questão da idade. É realmente individualizar o cuidado, entendeu? Por exemplo, a Jusiele, que tem uma questão de saúde mental, eu marcava mais seguido, porque a gente tinha que ver também a questão da saúde mental. Entendeu? Mas o adolescente em si, como ele é um grupo de risco, é um grupo que tem que ficar mais atento (Enf. Olívia).

“Grupo de risco”, “prioridade”, “cuidado maior” são palavras que esta enfermeira e os demais agentes de saúde já utilizaram para se referir às jovens gestantes. Vale citar novamente a consulta que acompanhei com a enfermeira Carla, onde destaca não se preocupar com a jovem, achando que será um “pré-natal tranquilo porque ela tem uma boa estrutura.” (Enf. Carla). Nesse caso, ter mais condições financeiras “tirou” a jovem de um “pré-natal complicado” e “de risco”, ou seja, a camada social é um determinante para a gravidez ser de “risco”. Já vimos que essa última expressão é utilizada por adultos que entendem a gestação na juventude como algo fora do padrão (Bozon, 2009; Altmann, 2009; Moraes; Ceccin, 2017).

Durante a entrevista com a enfermeira Olívia, ela destaca: “Então, a frequência de atendimentos vai ser a mesma do resto, mas se tu vê que é um adolescente que precisa de mais atenção, que tu precisa conversar mais, tu vai marcar mais perto. Vai ficar mais próximo.” (Enf. Olívia). Ou seja, aqui vemos em ação micromecanismos de vigilância reprodutiva que são

acionados devido à agência da profissional a partir de seus valores e moralidades, bem como o contexto social e cultural em que está inserido onde a gravidez na juventude, num geral, é entendida como de risco e que deve ser acompanhada de perto.

A enfermeira Olívia também conduzia o Grupo de Gestantes e era a profissional que tinha mais afinidade com as gestantes pelo próprio envolvimento semanal do Grupo, tendo mais contato com as grávidas, mas também muito devido ao seu interesse pelo tema da saúde da mulher. Ela disponibilizava seu contato pessoal para as gestantes sob seus cuidados, que lhe faziam perguntas, mesmo depois que ela foi desligada daquela US. Ela sempre dava um “jeitinho” de atender as gestantes mesmo no meio do expediente sem tempo, e seus atendimentos eram muito voltados para as gestantes expressarem suas dúvidas e conversarem abertamente.

Segundo o médico JP:

Mas na forma como se estabelece a relação médico-paciente, eu acho que sim. Não sei nem se é sobre maturidade, sobre vivência. Muitas vezes uma pessoa com 30 e poucos, ela vai ter uma relação diferente, é, comigo que tenho 25, do que eu de 25 para Lara que tem 15, né? E é normal, porque são diferenças de geração, né? (Med. JP).

Novamente, aparece a categoria “imatura” que, segundo JP, muda a forma de atendimento. Nas suas consultas de pré-natal que acompanhei aparece muito uma relação vertical e não horizontal - como a maioria dos(as) profissionais diz que se propõe a fazer -, onde JP vê exames, avalia o corpo da mãe, ouve os batimentos do feto, preenche a caderneta de gestante e pergunta sobre como a jovem está. Normalmente elas falam algo como “tudo bem” ou “senti um enjoo tal dia”. Então o médico passa algumas instruções acerca disso e a consulta é finalizada.

As jovens que entrevistei e que estavam ou já haviam concluído o pré-natal na US relataram que as consultas eram “normais” e “de boas” (Alice, com experiência reprodutiva). Raramente havia um vínculo forte, como cita Heloá (com experiência reprodutiva): “Porque é bem variado, né? Tem alguns profissionais agora, que quando eu voltei pra cá, que eu nem conhecia.”

Além das mudanças de profissionais, que ocasionou, por exemplo, a jovem Letícia ter um atraso de quase um mês nas suas consultas semanais da gestação, a falta de comunicação também é um ponto citado pelas gestantes, pois várias vezes consultas são canceladas e não avisam antes as gestantes e/ou mães. Letícia apontou: “No começo foi bom, assim, mas no finalzinho eu vi que era muito de cancelamento. Fiquei meio preocupada, porque eles

cancelaram muitas vezes a consulta. Mas até agora tá bom. Tá sendo bom pra mim.” (Letícia, com experiência reprodutiva).

Kailany, mãe de Francisco, aponta para relações muito boas com a enfermeira que fez todo o seu pré-natal - a qual foi remanejada no primeiro mês do meu trabalho de campo e não tive muito contato -, mas “os médicos, tá toda hora trocando, então eu não vou dizer que eu tenho carinho por um médico, porque eu não conheço quase nenhum, tá sempre trocando. Já tive, eu já tive da minha área uns quatro, eu acho.” (Kailany, com experiência reprodutiva). No próprio dia da nossa entrevista, ela iria ter uma consulta de puericultura do seu filho - consulta para acompanhar o crescimento do bebê que é feita até este atingir um ano de idade - e remarcar pela terceira vez porque o médico em questão pediu desligamento da US, no contexto do processo de parcerização da atenção primária.

Acerca dos marcadores sociais e diferenças nas relações que se estabelecem entre as jovens gestantes entrevistadas e os(as) profissionais, apesar das jovens não chamarem atenção para um fator em específico, ao longo da observação participante e entrevistas, ficou claro que médicos(as) e enfermeiros(as) têm uma relação de cobrança de assiduidade e de cuidado maior ao longo da gestação com as jovens que têm condições financeiras mais baixas e não têm uma “família bem estruturada” em detrimento de outras gestantes. A preocupação mais presente em torno da gestante de quinze anos, Laura, que estava na unidade enquanto realizei a pesquisa, foi um notável exemplo da utilização de micromecanismos de vigilância reprodutiva. Ela tinha quinze anos, branca, não frequentava mais a escola, não trabalhava, namorava um jovem de 18 que não tinha renda fixa e era de camadas populares.

Nas relações estabelecidas na US, quase todas as gestantes e/ou mães que entrevistei participaram pelo menos uma vez do chamado Grupo de Gestantes, o que costuma aproximar as jovens do serviço de saúde. O grupo era organizado pela enfermeira Olívia e ACS Carolina durante a maior parte do tempo que estive na unidade, mudando de liderança ao final devido à demissão da primeira e desejo de saída da segunda.

O grupo ocorria semanalmente às sextas-feiras à tarde com cerca de duas horas de duração e normalmente uma semana era destinada a discussões sobre o primeiro trimestre do pré-natal e na outra, sobre o terceiro. Em algumas datas eram realizados encontros diversos, como foi o caso de uma festa junina em que se tratou de saúde mental da mulher.

As gestantes tinham uma boa assiduidade no grupo, sendo que, ao meu ver, esses encontros são uns dos poucos momentos da US que é colocada realmente em prática a atenção primária em saúde, uma vez que no grupo se faz uma promoção e proteção da saúde, as quais são pilares essenciais da APS. Camille e Sabrina foram duas gestantes que eu entrevistei e que

sempre estavam no grupo e relataram como era importante ouvir outras mães e tirar dúvidas, sendo que se sentiam muito bem naquele ambiente.

Estive no primeiro dia do grupo de uma jovem gestante, Laura, - não cheguei a entrevistá-la - e vale aqui apontar como foi o encontro. Enquanto ela se apresentava, a enfermeira Olívia fez a pergunta que sempre fazia de praxe para as novas participantes do grupo: “A gravidez foi planejada ou não?” A jovem respondeu que sim. Olívia a olhou com uma cara de espanto, arregalando os olhos e disse com um riso constrangido: “Ah, é mesmo? Muito bem então.” Laura balançou timidamente a cabeça, visivelmente desconfortável com a situação e exposição já que as demais presentes tiveram a mesma reação da enfermeira.

Fora este ingresso de Laura no grupo, não houve mais falas direcionadas para ela e, apesar de ela sempre vir acompanhada de uma amiga gestante mais velha, ela nunca falava nada, nem quando era instigada a participar com frases como: “O que vocês acham?” ou “Como vocês percebem isso?” Seu médico, JP, relatou que a jovem não era participativa nas consultas, mas “o grupo foi muito importante para ela se integrar, estava preocupado de ela não aderir ao pré-natal.” (Med. JP).

Durante o pré-natal no serviço de saúde, a preocupação dos(as) profissionais é toda centrada na gestação e não na mulher; no grupo de gestantes acabava por ser muito similar, apesar de ter uma abertura maior para as futuras mães dialogarem sobre aquilo que sentiam e para trocarem experiências. Inclusive, as conversas entre gestantes eram muitas vezes voltadas para a falta de ajuda dos homens para a qual a ACS Carolina usou mais de uma vez o discurso acerca de que “demora mais para o homem cair a ficha” de que tem um filho(a).

Aqui, percebemos como valores e moralidades da agente comunitária são repassados para as gestantes e reafirmados diversas vezes. Um espaço em que poderia haver uma discussão maior sobre direitos sexuais e reprodutivos, envolvendo a questão de gênero, acaba não tendo abertura para a temática, apesar de o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual destacar a importância de se discutir gênero e buscar que o genitor esteja presente durante todo o pré-natal (Porto Alegre, 2024b).

Vemos aqui o micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina. Relembramos que este micromecanismo se refere à ação dos(as) profissionais que ratificam a centralidade feminina e a inércia dos homens em suas responsabilidades antes da gestação, durante e após, com o cuidado da criança. Olhando para o micromecanismo de acumulação reprodutiva, relembro do dia que a vinda de um pai à unidade e como a vinda foi celebrada por todos(as), demonstrando como era raro um pai estar no ambiente do grupo.

A enfermeira e a ACS responsáveis pelo Grupo indicam que pais devem vir pelo menos uma vez nos encontros, incentivam a presença deles, mas que espaço realmente eles têm ali? Aqui se faz essencial uma discussão de assimetrias e hierarquias de gênero onde o cuidado tem um lugar central como já vínhamos discutindo com Federici (2017, 2019).

Ainda, os jovens homens praticamente não acessam a US, principalmente os pais. Como diz o médico Benjamin: “As gestantes não dão pra contar nos dedos. Foram mais de 100. Mas e os pais? Acho que eu conto nos dedos os que tiveram presente.” (Med. Benjamin). Segundo o colega de Benjamin:

Mas assim, eles são, generalizando, né, são bem mais imaturos que as mães na mesma idade. Geralmente levam tudo meio que na brincadeira, não entendem um pouco a importância, talvez, do acompanhamento do pré-natal e tal. Mas eu acho que deve ter tido um ou dois casos só. Geralmente o pai por si só ele já não é tão assíduo do pré-natal. Na paternidade também não. Também não (Med. JP).

A enfermeira SRT também destaca que os jovens pais “são mais imaturos”, e têm “menos responsabilidade” (Enf. SRT). Também, é comentado sobre muitos dos pais trabalharem nos horários de consultas. Ademais, alguns(as) profissionais também destacam a sua culpa nesse processo de ausência do jovem pai na unidade:

Agora se tu for parar pra pensar, a gente pensou muito na adolescente como prevenção. Por que a gente não pensou no menino? O menino acaba ficando de escanteio. A menina tem que ser responsável por tomar anticoncepcional, ela tem que ser responsável por prevenir uma gestação, a menina tem que ser responsável por prevenir uma IST. E o menino? (ACS Fernanda).

Na caderneta de gestantes há um pequeno espaço destacado como “pré-natal do parceiro” onde se colocam os resultados dos testes rápidos que este deve realizar no início da gestação. Este é o único momento onde a presença do genitor é solicitada com maior insistência para uma consulta onde se coletam os testes rápidos para ISTs, mas mesmo assim, muitas vezes, o homem não comparece à US. Um exemplo é de uma jovem gestante de 16 anos que estava em sua terceira consulta de pré-natal e pela terceira vez o médico JP pediu se o namorado não conseguia ir à Unidade para realizar os testes rápidos. Ela negou e JP pediu o CPF do jovem, fez uma solicitação de exames de sangue e pediu que a moça trouxesse de volta os resultados na próxima consulta. Depois da consulta, o médico me disse que pelo menos assim ele teria os resultados dos exames do jovem.

O médico Benjamin, ao falar sobre a falta de pais no serviço de saúde, destaca: “Então, isso é muito difícil, especialmente numa comunidade onde a questão de desequilíbrio nas relações de gênero é muito difícil.” (Med. Benjamin). Outros(as) não chegam a trazer o conceito

de gênero, mas todas as falas perpassam as assimetrias estabelecidas no papel de ser homem e ser mulher.

Todas essas falas acabam reforçando a centralidade da mulher no cuidado pré, durante e após a gestação, evidenciando os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina que se dão também nessas lacunas de discussões mais aprofundadas de gênero, responsabilização e cuidado com as próprias gestantes.

Acerca do momento do nascimento das crianças, as jovens que eu entrevistei relatam que “foi bom”, “normal”, “sempre tranquilo” e “tudo certo”. Porém, durante o tempo que estive na US, o caso da Laura foi diferente:

Hoje eu cheguei na cozinha e a ACS Carolina estava falando que tinha algo para me contar. ela disse: "é sobre nossa amiga Laura". Ela começou a me contar que a sogra da Laura entrou em contato com ela para pedir ajuda referente ao que estava acontecendo com a jovem no hospital. E Carolina apavorada me contou um monte de coisa muito, muito rápido. A Laura baixou o hospital porque estava fazendo o PNAR lá. A primeira coisa que falaram para ela foi que o pai não poderia entrar, mas o pai tem 19 anos. A sogra também não podia entrar porque, segundo a assistente social, eles não eram família, eles chegaram a dormir na rua porque não deixaram nem ficar no saguão do hospital. E a sogra disse que "a Laura só sabe fazer chorar: também, traumatizaram totalmente menina." Daí ela teve que chamar uma tia para ficar com ela "porque era de sangue e os outros dois não." A ACS seguiu contando que quando a Laura disse que tinha direito a acompanhante, um enfermeiro falou: "não, tu não tem direito tu é de menor." Todos ficaram revoltadíssimos com a situação e a enfermeira Cássia falou: "violência obstétrica só porque ela é adolescente" (Diário de campo).

Aqui, temos toda uma discussão sobre direitos reprodutivos das jovens que são colocados em xeque. Os(as) profissionais que atenderam a jovem naquele hospital também fizeram uso de mecanismos de governança reprodutiva, apesar de não ser nosso foco aqui tratar das ações nestes locais, até porque se estabelecem relações muito diversas das da US em hospitais.

Após o nascimento das crianças, como pude observar ao longo dos meses na US, a saúde da mãe fica “esquecida” em detrimento do(a) recém-nascido(a) apesar de que o Protocolo de Pré-Natal destaque a importância de atentar para a saúde da mulher (Porto Alegre, 2024a). E a própria mãe também não busca por um atendimento específico para si, possivelmente, por estar centrada na criança. O micromecanismo de vigilância reprodutiva dos(as) profissionais para com a jovem não se mantém com a mesma intensidade após o nascimento da criança, sendo que alguns(as) funcionários(as) denotam maior preocupação com a assiduidade, mas outros(as) destacam que as consultas seguem “normais” e no “protocolo” tanto para mulheres mais velhas quanto para jovens.

Os(as) profissionais relatam maior tranquilidade nas consultas subsequentes: “Ah, vem pra consulta e a gente segue o acompanhamento normal, né?” (Med. Cláudio). Já a ACS Carolina destaca que “se a mãe faltou, eu vou atrás para ver o que aconteceu.” (ACS Carolina). E há algumas mães jovens, como ela disse certo dia em conversa, que ela “fica mais de olho”.

Segue trecho do diário de campo de puericultura de Madalena que acompanhei. Essa jovem não teve uma aderência constante ao pré-natal e estava com a consulta protocolar, de um mês da criança, atrasada a quatro meses.

A enfermeira Cássia me falou que estava preocupada com essa consulta porque ainda não tinha visto a bebê que já tinha 5 meses. E nem conhecia a mãe ainda. Chegou a hora da consulta e ela atendeu de forma atenciosa. Cássia me olhava volta e meia com uma cara meio assustada durante a consulta. Ao longo da consulta fui percebendo que Cássia foi explicando com muita calma e parecia quase como se estivesse falando para uma criança. Em um momento, Madalena foi colocar a filha na balança e a cabeça da bebê bateu na mesma. A enfermeira fez uma cara de medo e respirou fundo. Depois da consulta ela me falou: “Meu deus, tu viu a cabecinha da bebê batendo? Me deu uma coisa no coração. Eu fiquei com muito medo pela bebê, nossa. Dava para ver que ela não sabia o que estava fazendo.” Ela seguiu: “Me dá uma agonia mãe adolescente, uma agonia.” “Ela é uma criança, nem eu com 30 anos saberia como cuidar de uma bebê, imagina ela” (Diário de campo).

Na entrevista, a enfermeira relembrou deste atendimento e me falou:

E eu fiquei muito preocupada com aquela consulta, com o manejo dela com o bebê, fiquei preocupada com o bebê. Porque por mais que ela fosse muito bem intencionada, ela era bem mais imatura, achei ela bem mais imatura. E ela não tinha muito manejo com o bebê, ela não tinha. [...] Mas ela parecia uma menina brincando com uma boneca no corredor, assim, parecia. Justamente parecia, assim (Enf. Cássia).

Aqui, vemos que a enfermeira julgava o comportamento daquela mãe, categorizando ela como uma “criança” e, ao analisar a consulta, destaquei que houve formas de falar com a jovem diferentes do que teria com a adulta e de uma certa percepção de julgamento negativo, que a própria jovem deve ter notado durante a consulta. Estes julgamentos e aflição da enfermeira são compreensíveis pelo fato de a jovem estar há quatro meses atrasada com uma consulta importante para a saúde da sua filha recém nascida.

Nas outras consultas de puericultura de jovens gestantes que foram acompanhadas não percebi uma relação tão tensa quanto na consulta de Madalena. As outras mães não haviam faltado consultas anteriores, aparentavam ter mais conhecimento sobre as formas de cuidado com a criança e já tinham em média 19 anos, o que possivelmente também auxiliava no fato do(a) profissional entender que a mãe tem mais “maturidade”.

As jovens gestantes ou que já estavam no puerpério e que entrevistei tinham boas percepções acerca dos atendimentos em geral. Porém, não há um destaque para o pós-parto, como pude observar. Vale citar que, buscando melhorar a relação das mães com a Unidade, em novembro de 2024, no final do período da pesquisa de campo, foi criado um Grupo de Puericultura na US, o qual eu ajudei na organização, participando das reuniões e dos dias de grupo que ocorriam quinzenalmente. Segundo o médico JP:

Eu acho que o grupo de puericultura é muito pertinente principalmente para tu manter tanto a mãe quanto a criança perto da unidade. Porque o que acontece muitas vezes é de, pela dificuldade de agenda, essa criança consulta ali até os seis meses e depois não consulta mais. E talvez o grupo da puericultura, ele seja bom pra aos poucos as mães irem entendendo que a criança tem que estar sendo acompanhada não só quando tá com algum problema. É um espaço que é positivo para as mães conversarem também (Med. JP).

Uma das jovens que entrevistei já participou do Grupo e depois me disse que tinha gostado, que a filha também tinha se divertido e que era interessante para trocar informações com as outras mães. Os assuntos até então abordados foram fases do desenvolvimento, amamentação e introdução alimentar. Algo que chama atenção é a participação majoritária de mulheres, sendo que em dois dias o pai de um bebê veio junto com a mãe “porque eu arrastei ele” e todos(as) acharam esse fato incrível, inclusive os(as) profissionais presentes. Novamente, micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina reforçam a centralidade da mulher em detrimento do homem no cuidado do(a) filho(a).

Vale citar que algumas das jovens sem experiência reprodutiva com quem eu conversei relataram que não gostavam de ir na US, justamente porque sempre que estavam mal e iam até o local, os(as) profissionais pressupunham que era uma gestação. Sempre há uma pressuposição de que a jovem que vem para a US com dor de barriga e enjoos está grávida, segundo apurei em conversas com todos(as) os(as) agentes de saúde. Também, sempre há uma suposição de que a jovem gestante não queria estar gestando. E, principalmente, sempre há uma crença prévia de que a jovem gestante vai ter um pré-natal e uma puericultura difíceis de lidar.

Segue trecho de roda de conversa em que jovem de 16 anos falou sobre uma situação que passou há alguns meses:

E eu tava quase vomitando lá. Daí a mulher me olhou com cara assustada: “Tu tá grávida?” Eu não sabia onde me enfiar. Eu não sabia. Toda minha vida. Eu nunca fiquei tão revoltada e eu falei: “Não, moça, eu só tô doente.” E eu pesando 53 kg, quando eu contei pra sora Denise, ela falou pra mim: “Se tu tá grávida, o que que resta pra mim?” Daí a mulher pegou o negócio que sente o coração na barriga e me apertaram. E eu tava só vomitando até as minhas tripas. Elas já me apertaram direto para ver se eu tava ou não por causa que normalmente tem bastante guria adolescente

grávida. Daí já pegaram direto para meter: “ah não, vamos ver aqui. Vai que tem uma coisinha aqui.” E eu deitada assim assustada. Foi uma médica que fez isso (Liz, sem experiência reprodutiva).

Aqui, vemos o peso que a jovem tem sobre ela e uma suposição de associar seu mal estar com uma gravidez. Entendemos que os(as) próprios(as) profissionais colocam pesos diferentes para homens e para mulheres, revelando questões de gênero enraizadas em nossa sociedade patriarcal.

Finalizando este capítulo sobre a gestação, após olharmos para agentes de saúde e de educação, nos perguntamos por que tanto um quanto o outro - profissões com formações diferentes em sua quase totalidade -, têm, no geral, um discurso tão similar em torno da gestação na juventude? Pânico moral e valores morais novamente surgem com força aqui.

Ao olharmos para os marcadores sociais da diferença, encontramos diversas semelhanças entre os(as) dezoito profissionais entrevistados(as): quatorze são brancos(as) - as duas ACSs e duas técnicas de enfermagem são pretas -; quatorze moram em regiões afastadas do território onde trabalham - novamente desconta-se as duas ACSs, um professor que escolheu morar próximo ao lugar devido ao trabalho, mas que não circula pela região, e uma técnica de enfermagem que mora num bairro próximo; treze têm Ensino Superior completo e duas estão cursando faculdade - uma ACS e uma técnica de enfermagem; e a maioria é de camadas médias, principalmente professores, professora, profissionais da medicina e enfermeiros(as).

Também há diversos fatores que explicam a centralidade dada à maternidade em detrimento da paternidade e que estão embrenhadas na estrutura patriarcal e capitalista de nossa sociedade. Por isso mesmo é normal ouvir de profissionais frases como “Não deveria ser maior a responsabilidade da mulher, mas a gente sabe que acaba sendo.” (Enf. Cássia). E acaba que essa noção da mulher ter maior responsabilidade perpassa a ação dos(as) profissionais de saúde.

No capítulo seguinte, continuaremos falando da acumulação reprodutiva feminina entre outros micromecanismos de governança focando no cotidiano de atuação de professores(as), médicos(as), enfermeiros(as) e técnicas de enfermagem no que tange a contracepção, assunto que não é central nas escolas, mas com certeza é na unidade de saúde. Também, olharemos para o que as(os) jovens têm a dizer sobre o uso de anticoncepcionais, injeções, DIU, “chip” ou outros.

8. “TEM QUE COLOCAR A CONTRACEPÇÃO NELAS PARA ELAS NÃO ENGRAVIDAREM.”

A frase que dá título a este capítulo foi dita pelo enfermeiro Rafael durante uma conversa sobre contracepção, dentro de seu consultório, e dá o tom do que veremos neste capítulo. Apesar de a contracepção não estar tão em foco nos discursos de profissionais de saúde e de educação quanto o medo da gravidez na adolescência, ambas andam lado a lado e são complementares, se cruzam e se conectam o tempo inteiro, inclusive nos micromecanismos de governança reprodutiva dos(as) profissionais, misturando contenção reprodutiva e coerção contraceptiva.

Relembrando, os micromecanismos de coerção contraceptiva se referem às ações dos(as) agentes que visam à pressão e/ou à imposição de um método contraceptivo. Relaciona-se também ao impedimento das mulheres de acessarem o método que desejam, ou a ocultação de informações acerca de todos os métodos disponíveis no sistema de saúde e/ou o compartilhamento de informações errôneas sobre algum método contraceptivo.

Veremos que os(as) agentes da US são “fãs número um” do anticoncepcional, sendo que a maioria dos atendimentos realizados ali são voltados para iniciar um método. Na escola, as discussões não estão presentes, em geral, em sala de aula, mas quando estão, se traz a centralidade do preservativo peniano.

8.1 ESCOLA E CONTRACEPÇÃO

No capítulo sete trouxemos o dia a dia de professores(as) de Biologia da escola A e da escola B, falando sobre a gestação. Agora, tratando de contracepção, eles(as) seguem abordando

um pouco o conteúdo no oitavo ano quando se fala de reprodução, mas sem maior relevância nas aulas, passando majoritariamente a importância do preservativo peniano: “muitos nem sabiam colocar camisinha, então tu pega e explica direitinho pra eles.” (Prof. Felipe)

No Ensino Médio, a professora Monique, funcionária da escola B, aponta que fala da contracepção no segundo ano do Ensino Médio. Ela destaca que explica como ocorre a reprodução e fala com os(as) jovens para sempre se “protegerem” e “prevenirem”, mas “Só que a gente não acaba entrando num assunto, por exemplo, o uso da camisinha.” (Prof. Monique). Ela relata que fala com eles sobre no dia a dia:

Eu converso muito com eles sobre o uso da camisinha quando eu sei que eles estão namorando. Então, assim, é mais uma parte teórica. Mas eu converso muito com eles quando sei que estão namorando: “Faz uso, não faz uso, não é assim.” Que nem os meninos, eu brinco muito com os meninos aqui da turma x. Eles trocam de namorada como trocam de sapato. Eu digo: “Seguinte vou dizer uma coisa pra vocês: vocês vão pegar uma pereba. Eles: “Ah, mas vão pegar uma pereba.” Eu: “Não, só um pouquinho, gente, não é assim, não é esse oba-oba. Vocês estão com os hormônios lá no teto, mas não é esse oba-oba. Vocês se cuidem, vocês se preservem porque realmente as doenças estão aí. Elas são bem fáceis de ser adquiridas e muito preocupantes” (Prof. Monique).

Esta é uma fala voltada ao preservativo peniano, focando em doenças e com alunos(as) específicos, quando sabem que estão namorando. Ela relata que também fala sobre o anticoncepcional com as jovens: “Não basta só usar camisinha, que eles têm que usar o anticoncepcional e o anticoncepcional já não é 100%.” (Prof. Monique). Fora isso, algumas jovens lhe pedem ajuda sobre contracepção como dicas do que usar ou não e sobre como funciona o preservativo vaginal, por exemplo.

O outro professor da escola B, Ricardo, relatou, em sua entrevista, que às vezes faz uma referência à contracepção, mas não trouxe mais detalhes. Ao perguntar sobre conversas fora de sala de aula, ele também não destaca qualquer uma relacionada com a contracepção e ele mesmo diz que acredita que essa falta de conversas se dê devido a ele ser um professor, vendo no gênero uma barreira.

Alunos(as) da escola B, como já dito, destacam que somente conversam ou conversariam com a professora Monique sobre sua saúde sexual, pois têm proximidade e se sentem seguros(as) com ela. Na escola A também há essa diferença de relação entre alunos(as) e os dois professores de Biologia: Felipe é o professor das turmas da manhã e deu aula para muitos(as) de seus(as) alunos(as) do Ensino Médio desde o sexto ano do Ensino Fundamental. Ele mesmo já destacou em conversa que acha que ser homem pode dificultar um pouco as meninas conversarem com ele, mas ainda acontece essa aproximação. Já o professor Gabriel, do turno da noite, não relata algum(a) jovem ter conversado com ele fora de sala de aula.

Durante a entrevista, Gabriel aponta o que fala sobre contracepção: “É isso aí, de usar camisinha, né, sempre se proteger. Falo pra usar anticoncepcional, né.” (Prof. Gabriel). Mas, não cita maiores explicações sobre preservativo interno, por exemplo, ou tipos de contracepção. Na mesma oportunidade, ele disse o seguinte sobre aulas ao terceiro ano do Ensino Médio:

Aí a gente trabalha, né, trabalha as doenças. No terceiro ano, sempre, porque a primeira parte é em biologia, ali. Sim. Então, sempre vai cair DSTs, os preservativos, né, os métodos contraceptivos que existem. Eu peço uma pesquisa com todos que tem, detalhadamente, aí eles veem, assim, que tem uns que eles não sabiam que existiam. Tipo, o diafragma, né (Prof. Gabriel).

Ao realizar a roda de conversa com alunos(as) desta turma, eles(as) não citaram algum trabalho que tenha sido desenvolvido com este professor nas aulas. Um aluno cita as aulas que teve com o professor Felipe quando era mais novo, no oitavo ano, e outros colegas apontam o mesmo. Ademais, citam uma ou outra palestra que tiveram de um grupo de acadêmicos de uma universidade próxima.

Acerca da contracepção, o professor Felipe diz que sempre que tem a oportunidade, destaca a importância de “se proteger” e “se cuidar.” Porém, em suas aulas que acompanhei no terceiro ano do Ensino Médio enquanto estive em campo, não foi tocado no tema da contracepção para além de, no máximo, o Felipe dizer para os(as) alunos(as) usarem preservativo.

Certo dia na escola A, acompanhei uma aula do oitavo ano do Ensino Fundamental acerca de ISTs. Os(as) alunos(as) estavam montando cartazes sobre infecções sexualmente transmissíveis para apresentar para a turma e eu estava ajudando um grupo a pendurar o preservativo interno no seu cartaz e o professor chegou na classe e falou: “Gurias, essa parte grande aqui meio esponjosa não vai junto.” E ficou dando risadas e seguiu: “Imagina colocar isso dentro de vocês.”

Aqui vemos micromecanismos de coerção contraceptiva em ação, uma vez que os(as) professores(as), ao falarem sobre contracepção com os(as) estudantes, não apontam para todas as possibilidades de contracepção disponíveis para os(as) jovens e/ou transmitem informações errôneas sobre os métodos, mesmo que não sejam suas intenções primárias, como certamente não era a intenção de Felipe.

Ao conversar com as jovens nas entrevistas, pelos corredores da escola e/ou rodas de conversa sobre a contracepção, elas falam que conversam mais entre amigas sobre o assunto, sendo que algumas tinham abertura com as mães, mas o(a) professor(a) nunca surgia como

opção para conversa. O exemplo mais corriqueiro: “Ah, isso de anticoncepcional eu fui pro posto pra ver quando comecei a ter relação.” (Maria Clara, sem experiência reprodutiva).

As atividades em sala de aula sobre contracepção, diferentemente daquelas sobre gestação, eram raras. Vivian (sem experiência reprodutiva) conversando comigo certo dia no intervalo disse: “É, aqui a gente ouve que não é pra engravidar, que tem que se proteger e falam lá das doenças também, mas isso de anticoncepcional e tal, não tem.” Se as jovens não falam sobre, podemos imaginar o que resta para os jovens homens: um total desconhecimento e desinteresse. Ou seja, o foco dos(as) professores(as) é evitar a gestação, mas estes(as) não discutem como operacionalizar isso com os(as) estudantes.

Num geral, o que todos(as) educadores(as) falam é: “tem que se proteger”, “prevenir”, “cuidar” e sempre com a perspectiva do preservativo peniano para evitar a gestação. Aqui, o micromecanismo que se apresenta é o da coerção contraceptiva - criação inspirada em Senderowicz (2019) - e aqui utilizamos a expressão entendendo que a coerção não se dá somente na tentativa de induzir a jovem a um determinado método, mas também ao não falar sobre todos os métodos disponíveis, sobre seus potenciais riscos e benefícios de cada um, e/ou não aceitar a escolha da jovem por determinado método.

No nosso caso, os(as) professores(as) trazem poucos métodos - na maioria das vezes só um, o preservativo peniano - e agem com insistência para que os(as) alunos(as) façam uso de algum método contraceptivo. No caso dos três professores e da professora, eles não podem, por exemplo, prescrever um método contraceptivo, mas podem favorecer ou não que a jovem tenha conhecimento sobre o DIU, por exemplo.

E o micromecanismo de coerção está ligado aos regimes morais e ao pânico moral que cercam a ação dos(as) profissionais de educação, tanto seus próprios como o da sociedade em geral. Ainda, a falta de formação dos profissionais sobre SSR juvenil é algo que pode influenciar na utilização deste micromecanismo, uma vez que os(as) professores não recebem mais informações sobre métodos contraceptivos.

Se formos olhar para os marcadores sociais que regulam as falas dos(as) educadores, gênero é o que têm mais força, visto que a professora Monique tem uma relação próxima em que as alunas se sentem mais à vontade em conversar com ela sobre contracepção do que com o professor Gabriel, por exemplo.

Ao avaliar se os professores e a professora têm falas diferenciadas a depender do(a) jovem, destacamos também o gênero como principal marcador social da diferença. Quando ocorre alguma discussão sobre os métodos contraceptivos, ela é voltada com mais intensidade

para as jovens mulheres, o que nos apresenta um micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina.

Não notamos diferenças de tratamento no que se refere à raça/etnia. Idade também não é um fator que muda conhecimentos que os(as) jovens tiveram acerca da contracepção no ambiente escolar. Isso se dá porque, como já vimos, ao falar dos micromecanismos de contenção reprodutiva, os(as) alunos(as) possuem informações na escola muito parecidas já que tanto jovens de 16 quanto de 19 anos já tiveram aulas no oitavo ano do Ensino Fundamental sobre reprodução, que é onde este conteúdo é trabalhado com maior intensidade.

Apesar do foco no oitavo ano, o professor Felipe destaca que tem uma abertura maior para falar sobre essa temática conforme as alunas vão ficando mais velhas:

Mas no terceiro ano é tudo muito mais light, mais livre. Até porque já tem idade de desenvolvimento sexual, já deve estar em desenvolvimento sexual também. Então tem mais interesse e as coisas um pouco mais detalhadas, mais científicas, enquanto os outros ainda vão conhecer um preservativo, ainda vão. Então tem isso. No terceiro ano eles chegam com dúvidas mais bem formuladas. (Prof. Felipe).

Assim como ele, Monique comentou comigo algumas vezes sobre ter maior abertura com os(as) estudantes do Ensino Médio e conversas mais “avançadas” tratando de relações sexuais. Acima, já citamos o exemplo que ela trouxe para os jovens de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, falando abertamente sobre contracepção. O fato é que independente da idade, a coerção contraceptiva segue sendo um micromecanismo utilizado pelos(as) professores(as) para tratar da contracepção.

Quando conversava com os(as) jovens perguntando se fora da aula de Biologia já tiveram discussões sobre contracepção com outros(as) professores(as), alguns(as) citavam frases como essa de Frederico (2024): “Uns quantos professores me falaram para não ter filhos. Aqueles bagulhos que sempre falam.” “Só falam: Não faça sexo. E falam da camisinha e deu.” (Liz, sem experiência reprodutiva) contou durante entrevista da sua experiência com outros(as) educadores(as). Logo, incentivos à abstinência sexual, os quais não são citados pelos(as) professores(as) de Biologia participantes da pesquisa, acabam aparecendo nas falas dos(as) alunos(as).

Certo dia em uma roda de conversa, Fernando (sem experiência reprodutiva) falou: “Tinha uma professora numa escola minha que distribuía camisinha, só que as outras professoras julgavam muito ela. Mas ela falava: a minha parte eu fiz. Ela faleceu de Covid.” Sobre julgamentos de profissionais, a professora Monique já me disse que sabia que colegas

também criticavam-na por ter relação mais aberta com alunos(as) e “falar sobre essas coisas de sexualidade com eles”.

Outro momento, fora as aulas de Biologia, que os(as) alunos(as) poderiam discutir acerca da contracepção é com as atividades do Programa Saúde na Escola. Os encontros do PSE são mais recorrentes na fala de alunos(as) que estudaram na escola C, onde a enfermeira Olívia e ACS Carolina faziam as atividades. Segue trecho de entrevista:

Daí eu levei todo aquele aparato lá das meninas, levei todos os anticoncepcionais pra mostrar que tinham na unidade, levei os preservativos interno e externo, levei um DIU pra mostrar, levei a maquetezinha pra mostrar o que era o preventivo, onde era o colo do útero. Foi muito legal e as meninas adoraram. E elas queriam que eu ficasse mais tempo e tal. E aí teve várias que foram na unidade depois pra perguntar coisas. Foi muito legal, muito legal. É uma pena que não teve dois, mas a gente fez com todas as turmas os sextos, sétimos e oitavos anos (Enf. Olívia).

Ao falar com os jovens e as jovens sobre contracepção e PSE, eles(as), normalmente, não me indicavam o que Olívia falou acerca do DIU, por exemplo. Sempre o assunto foi relacionado ao preservativo peniano: “Uma vez o posto veio na escola. Daí as gurias ficavam numa sala e os guris em outra. Ela ensinou como colocava camisinha e é bem complicado colocar a feminina.” (Suélen, sem experiência reprodutiva).

Uma das jovens mães que entrevistei, Alice, tratou sobre uma atividade do PSE em que se recorda da ACS Carolina:

Acho que foi a Carolina já uma vez falar sobre sexo. Falou que.... Tipo, de se prevenir, eu me lembro que ela estava falando dos meninos para usar camisinha, que tinha a camisinha das meninas também. Que com 14, se não me engano 15, já dava para ir sozinha no posto se não se sentiria bem, tipo com a tua mãe, sabe? De tomar vacina, essas coisas para não engravidar, ou anticoncepcional. (Alice, com experiência reprodutiva).

A maioria das falas das jovens aponta que em atividades do PSE lhes ensinaram a colocar o preservativo peniano, diferente de Alice que apontou também para a ACS, indicando “ir tomar vacina”, expressão que muitas jovens usam para se referir à contracepção de injeção mensal e/ou trimestral. Fica evidente a distância considerável nas relações entre estudantes e promotores(as) do PSE: normalmente os(as) jovens ainda não conheciam eles(as), relatam não se sentirem à vontade para falar sobre os assuntos ligados à sexualidade e refletem para como “elas só aparecem uma vez na vida e depois nunca mais.” (Caio, sem experiência reprodutiva). Aqui, voltamos ao ponto da relação entre usuário(a) e agente de saúde e que a educação deve ser central para a implementação do Programa.

Como já destacado anteriormente, em diretrizes sobre o PSE lê-se: “Direito sexual e reprodutivo: Foi realizada atividade que abordou direito sexual e reprodutivo (prevenção de gravidez na adolescência, saúde sexual, importância do uso de preservativo, higiene menstrual, conversa sobre ISTs/HIV).” (Porto Alegre, 2023, p.1). Assim sendo, os(as) profissionais que realizam atividades do PSE tratam a contracepção seguindo as diretrizes e focando em uso de preservativo. A agência está nas formas com que vão abordar o uso do mesmo.

Além das aulas de Biologia, de outros(as) professores(as) tratarem da contracepção em “N” momentos e do PSE, temos outras atividades que jovens já participaram como palestras de estudantes de alguma universidade próxima, onde eles sempre destacam que se falava sobre o preservativo peniano, ISTs e cuidado para não engravidar.

Um dia, acompanhei uma atividade sobre contracepção com duas alunas do primeiro ano do Ensino Médio da escola B, durante um evento de uma universidade da região que apresentava os cursos de graduação. As meninas queriam ir para uma palestra do curso de Medicina. Era uma oficina dividida em três partes: contracepção, ISTs e saúde sexual da população LGBTQIAPN+. Na mesa sobre contracepção, as universitárias mostraram e explicaram como funcionava o DIU, o Implanon, os preservativos e o diafragma. Enquanto a estudante de medicina explicava, ela dizia que não é normal sentir dor durante o sexo. Então uma das alunas olhou assustada para mim e perguntou baixinho: “Não é normal?” Eu falei que não era e depois expliquei para ela sobre as dores em relações sexuais.

Nesse dia e em muitos outros que estive nas escolas, eu acabei me tornando referência para falar de aspectos da SSR. Seja nas rodas de conversa onde as jovens me perguntavam sobre diferenças de injeções, sobre efeitos colaterais, sobre uso de preservativo interno, DIU, Implanon.

São muitas histórias de jovens, principalmente mulheres, me pedindo informações. Vale citar, em especial, uma das rodas de conversa que eu fiz na escola B, com uma turma do terceiro ano do E.M., onde só havia alunos naquele dia. Eles tinham muitas dúvidas referentes à contracepção associada ao têsão da mulher (se o fato de tomar anticoncepcional diminui a libido da mulher), como tinha que tomar o contraceptivo e como era o preservativo interno.

Ao entrevistar Anderson, jovem de 17 anos sem filhos, que era um dos sete alunos presentes naquele dia, eu questionei se ele falaria com algum professor sobre qualquer questão relacionada à sexualidade. Ele me disse: “Tu te considera uma professora daqui?” (Anderson, sem experiência reprodutiva). Eu respondi que não e ele: “Então não.”

Aqui, temos vários fatores para pensar na relação que eu estabeleci com estes(as) jovens: sou mulher, tenho idade próxima da deles, 27 anos, mas vários(as) destacam que eu tenho “tipo

cara de 20, 21”. Também não sou uma professora, sou uma pessoa desconhecida do círculo escolar deles(as), ou seja, não há uma relação de tanta verticalidade. Mas, o mais importante, foi a abertura diária que dei aos(as) jovens falando pelos corredores, intervalo ou nas rodas de conversa. Me parece que essa relação entre usuário(a) e agente de educação não é medida, principalmente, pelo tempo de convívio, mas pela abertura e disposição a ouvir os(as) jovens.

8.2 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E O SERVIÇO DE SAÚDE

Na US, a contracepção é central e percebida como a salvação para evitar a gestação na juventude. Os(as) profissionais se apegam à contracepção como se ela fosse a resposta para todos os problemas das jovens. Pode acompanhar vários atendimentos de iniciação de contracepção de jovens e poucos sobre reajuste de contracepção ou mudança de método, sendo que não houve relato de algum jovem homem procurando informações sobre contracepção. É no Protocolo de Enfermagem de Pré-Natal de Risco Habitual que se encontram informações sobre a contracepção e se destacam todos os métodos contraceptivos disponíveis no SUS, lembrando que cada método possui vantagens e desvantagens, sendo que nenhum método é garantidamente 100% eficaz (Porto Alegre, 2024b).

Normalmente são as enfermeiras ou o enfermeiro que conduzem as consultas de contracepção e todos(as) costumam perguntar para a jovem ao começar o atendimento se ela já iniciou a vida sexual, data da primeira menstruação, o motivo da busca por contraceptivo e se já teve alguma experiência usando. Depois, falam as opções que normalmente incluem injeção mensal, trimestral e contraceptivo diário, já indicando qual é o da preferência do(a) agente de saúde. Normalmente a jovem adere sem objeções ao que o(a) enfermeiro(a) indica e a consulta finaliza com este(a) ressaltando a importância de se proteger usando preservativo peniano, nunca citando o preservativo interno.

Sobre as consultas de início de contracepção algo sempre chamou a minha atenção: nunca se falou para nenhuma das jovens sobre efeitos adversos do contraceptivo hormonal, como a perda de libido. Todos os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) querem sempre que as jovens usem um contraceptivo, então faz sentido nunca terem falado sobre pontos negativos.

Todas as consultas seguem um certo padrão, mas com algumas pequenas diferenças na forma de abordar a contracepção, dando mais ou menos explicações sobre as injeções contraceptivas ou o anticoncepcional oral, que o SUS oferece. Mesmo que algumas enfermeiras expliquem um pouco mais que as outras, as falas continuam sendo superficiais como “a injeção é melhor pra quem esquece de tomar comprimido todos os dias” (Enf. Cássia, conversa durante

consulta), ou “a injeção de três em três meses menstrua menos” (Enf. Polina, conversa durante consulta).

Sobre recomendação de outro método além da injeção mensal, trimestral ou comprimido diário, foi em apenas uma consulta que ouvi falar sobre o DIU quando uma jovem de 19 anos consultou sobre contracepção com o enfermeiro Rafael e ele perguntou se ela já havia ouvido falar sobre o DIU. Ela disse que não tinha certeza se sabia o que era e o enfermeiro respondeu que no futuro conversariam sobre a possibilidade deste método.

Aqui, temos muito clara a agência do enfermeiro Rafael: sua decisão de não falar sobre todos os métodos disponíveis e não tratando de informações que poderiam ser importantes para a jovem, até porque Rafael destaca que não se sente confortável em abordar a temática. Esta é uma das formas que os micromecanismos de coerção contraceptiva aparecem no cotidiano do serviço de saúde: a partir da ausência de diálogo dos(as) profissionais sobre todos os métodos disponíveis pelo SUS e de seus pontos positivos e negativos.

Aqui, vemos que um dos fatores que também influencia na decisão do profissional de não abordar todos os métodos é a questão relacional: para ele é uma barreira falar sobre contracepção com uma jovem, pela questão do gênero e também porque não tem uma relação aproximada e horizontal de diálogo com ela.

O SUS, na realidade, disponibiliza os seguintes métodos: preservativos masculinos e femininos, pílulas anticoncepcionais (orais e de emergência), injetáveis mensais e trimestrais, DIU de cobre e implantes subdérmicos. (Porto Alegre, 2024a), mas na maioria das vezes apenas três destes são destacados pelos(as) profissionais da US.

Quando conversava com jovens sobre idas à US, elas costumavam destacar frases como a de Aline (sem experiência reprodutiva) “Fui na US para começar o anticoncepcional e depois só quando me sentia mal ou alguma coisa assim.” A grande maioria das jovens ia com a mãe para a primeira consulta, pois tinha iniciado num relacionamento ou começado a menstruação.

Sobre consultas de contracepção, as jovens relataram coisas como “foi uma consulta normal”, “ela falou que seria bom usar a injeção e foi isso que peguei” ou “Ah, nada demais, ela falou uns negócios lá, me deu o papel e comecei a usar.” A gestante Heloá, de 16 anos, destacou:

Primeiro ela perguntou qual que eu queria. Se eu queria tomar de um em um mês ou de três em três meses. A enfermeira disse que é de três em três. Porque tem umas que não menstrua, né? É, até tentou me explicar sobre isso também, mas eu não entendi muito bem. Aí, ela disse que era melhor tomar de três em três, porque senão depois ficava inchada a barriga, ou não sei o que, ou não sei o que. Aí eu disse: “Tá”. Daí eu tomei de três em três. Aí, aí eu só vim aqui também, daí ela disse que eu só tinha que

voltar depois tal dia. Não conversamos sobre essas coisas de camisinha, IST. Só foi isso de, aí depois volta em três meses pra aplicar a próxima. Aí, nisso eu fui embora daí (Heloá, com experiência reprodutiva).

Podemos ver pela fala da gestante sobre o início da sua contracepção que ela recebeu prontamente a opção das injeções sem ter outra possibilidade, e, ela mesma não compreendeu exatamente o que se referia. Ela aceitou e a isso se resumiu sua consulta. Logo, a escolha das jovens por método x ou y é perpassada por micromecanismos de coerção contraceptiva.

Em conversas com outras jovens, as histórias são similares, sendo que algumas nunca acessaram a US, porque “demora muito e está sempre lotado” e “precisa ir uns três dias diferentes até conseguir a injeção.” Várias acabam tomando o que a amiga ou a mãe usam. Além das jovens reclamarem da demora para o acolhimento, tem-se a demora até conseguir a receita do anticoncepcional. No caso, é necessário passar pelo acolhimento, marcar um horário com a enfermeira, que às vezes não tem mais vaga no dia, então é preciso voltar no dia seguinte. Em alguns casos, se pede também exame de sangue para confirmar que a jovem não é gestante e este precisa ser realizado em outro local e demora alguns dias para ficar pronto.

O enfermeiro Rafael (2024) traz um relato sobre as barreiras no atendimento:

Sei que ela ficou aguardando um período considerável de tempo, né, pra poder iniciar o método contraceptivo. E já era a terceira vez que ela estava ali na unidade. Ela foi uma primeira vez. Daí foi dada a recusa. Tava cheio o posto. A segunda vez já fizeram o teste de gravidez pra iniciar o método. Só que não conseguiram colocar ela numa demanda. Então, na verdade, já era uma terceira vez, né, que a própria técnica me passou: “Olha, se a gente não atender ela agora, talvez ela não volte.” Isso que eu peguei no corredor, assim, não era eu que tava ali fazendo essa intervenção. Mas tentei, né, colocar uma pra demanda do dia, que nem a gente conversou agora, e realmente não tinha horários. Foi a hora que chegou a acadêmica. Com a acadêmica ainda a gente conseguiu, né, pelo menos colocar a paciente em sala e a acadêmica conversar (Enf. Rafael).

A acadêmica no caso é uma aluna de enfermagem que estava realizando estágio curricular na unidade. Outra dificuldade relatada tanto por profissionais da US quanto por jovens é o período em que a injeção de três meses esteve em falta no SUS, sendo que foi em torno de quatro meses. Caroline (sem experiência reprodutiva) destaca: “É, daí o posto não tem mais a de três meses e tô tendo que comprar na farmácia. E se daqui a pouco eu não tiver mais dinheiro?”

A técnica Ana comentou comigo certo dia no acolhimento: “Sim, essa falta está causando vários transtornos e muitas vezes é nessa troca de anticoncepcional que elas engravidam.” (Tec. Enf. Ana). Outra enfermeira: “É péssimo não termos como ofertar e

sabemos que é uma população vulnerável, então muitas não têm condição de ficar comprando mesmo.” (Enf. Cássia).

Além da demora para o atendimento, a necessidade de realizar exame de sangue para confirmar a inexistência de gravidez, fora da Unidade de Saúde, e a falta de injeções contraceptivas, o outro problema é que apenas uma médica na US sabe realizar o procedimento de colocação e retirada do DIU. E, durante grande parte da minha pesquisa de campo, esta médica ainda não fazia parte do quadro de funcionários(as), ou seja, ninguém na US tinha essa habilitação e as jovens necessitavam se deslocar para um outro serviço no centro da cidade para a colocação do dispositivo, o que lhes custaria no mínimo R\$ 10,00 de passagem com o transporte público. A ACS Fernanda destaca:

E inclusive, eu converso muito aqui com outras equipes que ia até pedir pra Agatha a questão dos profissionais estarem mais habilitados a colocar o DIU na unidade para facilitar o acesso e o fluxo. Porque senão a gente faz o atendimento, só encaminha e vai lá colocar no GHC ou lá no Presidente Vargas. Não tem dinheiro pra passagem. Se o adulto às vezes já não tem dinheiro pra passagem. Se o jovem já não consegue, né, se organizar aí, o jovem também já não vai para colocar. Mas eu falo muito também às meninas da questão do implanon, né. A gente deveria ter os Implanon disponíveis na rede e com colocação nas unidades (ACS Fernanda).

Assim, o custo de colocar o DIU devido ao deslocamento se torna alto para as jovens da comunidade, e vale lembrar que são jovens de camadas populares. Já o Implanon é disponível para as jovens, no SUS, a partir de alguns critérios como o de não ter se adaptado a outro método, o que dificulta o acesso, sendo que a colocação também não é na Unidade. Todas estas barreiras são enfrentadas pelas jovens na garantia do acesso à sua saúde sexual e reprodutiva bem como seus direitos.

Há relatos mais complexos de impedimento ao serviço de saúde, como o de Franciele:

Eu fui no posto. E aí as mulheres no posto, tipo, na época era uma coisa tipo bem, tipo, não era um, como é que eu posso te falar? Não era nada tipo uma conversa civilizada assim, sabe? Tipo, mais delicada. Tipo, eu cheguei na recepção do posto com a minha mãe. Ela pediu para eu tomar anticoncepcional e a mulher da recepção, assim, falou, tipo, em alto e bom som para todo mundo ouvir: “Mas ela já transa com essa idade?” Me julgando já, né? Tipo, porque eu ia ter 14 anos. E aí nisso todo mundo já começou a me avaliar, assim. E eu fiquei, meu Deus, que vergonha. Aí minha mãe: “não, ela não transa, não sei o que. Ela não tem relações ainda, mas eu já quero que ela comece a tomar.” E a mulher: “não, se ela não tem relações, ela não precisa.” E tipo, foi assim. Daí, como no posto não quiseram me receitar, em casa mesmo, a minha irmã falou: “ah, eu tomo esse comprimido aqui.” Não mudou nada no meu corpo. É um comprimido bem pequenininho, não tem tanta coisa assim. Daí a minha mãe liberou. Daí eu tomei esse comprimido aqui. Não mudou nada no meu corpo (Franciele, sem experiência reprodutiva).

Vemos aqui regimes morais (Morgan; Roberts, 2012) e pânico moral (Bozon, 2012) perpassando a visão dos(as) profissionais. Estes também estão na base das noções dos(as) funcionários(as) da US acerca da gestação na juventude como um problema, o que leva ao micromecanismo de contenção reprodutiva e, consequentemente, coerção contraceptiva. Através deste último micromecanismo, todos(as) os(as) enfermeiros(as), médicos(as), técnicas e ACS destacam para as jovens em consultas ou em conversas na rua - como é o caso das ACSs - que é necessário usar algum método contraceptivo, porém indicam apenas alguns métodos dentre todos os disponíveis no SUS.

Quando se trata da consulta de contracepção, na maioria das vezes, a jovem vem acompanhada da mãe ou de uma amiga. Dependendo dos casos, alguns(as) profissionais atendem a jovem sem um(a) responsável junto, mas algumas vezes a falta de um(a) responsável se torna impeditivo para consultas, o que por lei não é permitido. A partir dos 12 anos é possível se consultar sozinho(a) (Brasil, 2022), mas a ACS Carolina mesmo fala que há diversos colegas que não sabem disso. E, realmente, ao conversar com eles(as), muitos não tinham certeza da idade exata que era permitido se consultar sozinho(a).

Certo dia, acompanhei na prática um impeditivo de atendimento de uma jovem de 17 anos que foi à Unidade para tomar a injeção de três em três meses, mas o farmacêutico não liberou que a técnica de enfermagem pegasse a contracepção na farmácia e ele disse que a jovem precisava de um responsável junto para poder liberar. A jovem foi embora frustrada e indignada depois de mais de três horas esperando.

Se é necessário o aval de um responsável pela jovem, como fica a questão do direito ao sigilo da paciente? Em alguns casos pode acontecer de estar fazendo uso da contracepção sem conhecimento dos pais. E como proceder, então? Nunca mais vi aquela jovem na US, talvez tenha voltado, talvez não, mas caso tenha, ela, como já disse ACS Carolina, “tem que ter muita paciência, pois só jovem com muita paciência consegue esperar nisso daqui.” Este relato também traz um exemplo de micromecanismos de coerção contraceptiva, uma vez que não dá à jovem acesso aos métodos contraceptivos.

E, realmente, muitas jovens, que conversei, relatam histórias de demora para atendimento e início da contracepção. Também, já tive relatos de jovens assim, como o caso da usuária de 17 anos:

Eu usava o ciclo 21 e agora nem uso mais. Eu comecei a usar por conta, mas parei porque estava me engordando. Eu fui uma vez no posto. Eu cheguei lá e falei que queria marcar uma consulta. Eu não sabia muito bem como falar. Aí eu fui lá, tinha

que fazer o teste de gravidez. Isso foi na primeira vez. Daí a segunda vez que eu fui tentar fazer isso daí, eles falaram que eu tinha que fazer um exame de sangue isso e aquilo e como eu era de menor a minha mãe tinha que ir junto. Daí eu não fui mais (Beatriz, 17 anos, sem experiência reprodutiva).

Beatriz disse que precisava da mãe para o exame de sangue e não sabia me referir exatamente se foi o laboratório que pediu ou a própria US, mas o fato é que ela não teve seu acesso facilitado e seguiu sem fazer uso do método contraceptivo. Ela contou que não poderia falar para a mãe, pois ela não aprovaria.

Outro momento em que podemos ver o micromecanismo de coerção contraceptiva em ação é, por exemplo, quando ocorre a falta de qualquer informação sobre pílula do dia seguinte na unidade de saúde. Quando perguntei se falavam sobre a pílula na US, uma enfermeira respondeu: “Não, mais raro, bem mais raro. Tem contraceptivo de emergência no SUS. É uma coisa que realmente é uma boa tu trazer, assim porque eu acabo não falando. A gente trata muito mais com o preventivo do que o pós, caso aconteça.” (Enf. Polina).

Nunca, em consulta, a pílula foi mencionada, em nenhuma conversa minha com enfermeiros(as) e apenas nesta entrevista com a enfermeira Polina. Eu, inclusive, acreditava que a pílula não estava disponível no SUS, pois não era trazida pelos(as) profissionais, mesmo sendo um direito das jovens terem acesso a esse tipo de informação: um direito sexual e reprodutivo.

Agora, o ponto em que os micromecanismos de governança, envolvendo a coerção contraceptiva, mais aparecem foi descrito pelo enfermeiro Rafael ao conversar comigo sobre as consultas acerca da contracepção. Ele me disse que “tem que colocar a contracepção nelas para elas não engravidarem.” Ele seguiu falando que às vezes se sente meio mal, pois é “impositivo” e “meio duro”, mas que “precisa ser feito”. Porque necessariamente precisa ser feito? Porque para ele a gravidez na adolescência é um grande problema e ele tem que impedir o máximo que conseguir.

Eu perguntei para todos os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) que entrevistei se eles(as) falavam sobre contracepção nas consultas, caso não fosse o tema central da mesma, e apenas uma médica disse que sim, que quando sobra tempo ela tenta ver como está a saúde sexual da jovem e indica métodos de contracepção. Sobre isso, uma das enfermeiras destaca:

É mais difícil, assim, né, porque a gente tá sempre na correria. Então, se sobra um tempinho na consulta, a gente vai atender outro. Né, vai desafogar, vai ajudar uma interconsulta pro técnico, daqui a pouco a minha consulta ali foi mais rapidinha, veio aí, era um curativo na mão, aí eu liberei ela, sai, me sobrou 10 minutos, eu fui pra

consulta no acolhimento. Então, eu acho que é mais difícil a gente conseguir fazer isso. (Enf. Polina).

Já, uma das técnicas de enfermagem que acompanhei me relatou que ofertava uma consulta para iniciar contracepção para jovens que acessavam a US:

Que nem eu te falei, a maioria que vem é por IST ou Bolsa Família, que daí vem com a mãe, as adolescentes, né, que eu tento até ofertar algum método, né, ou marcar uma consulta com a enfermagem pra discutir sobre o caso da menstruação ou sobre camisinha, mas as mães não deixam nem as filhas responder, né. As mães mesmo já se negam já em falando que não precisa. Eu sempre tento ofertar pra, por fim, não tem mais uma gestante adolescente ainda aqui no bairro, né. E daí as mães se negam, falam: “Não, minha filha é virgem, minha filha não vai tomar nada por enquanto.” E no fim é capaz da filha não ser mais virgem, tá escondendo da mãe e a mãe não tenta uma consulta com o superior pra tentar ajudar. (Tec Enf Ana).

As outras técnicas com quem eu dialoguei não relatam ofertar a contracepção durante o acolhimento. Mais uma vez percebemos a agência da profissional, sendo que os regimes morais que motivaram sua ação, nesse caso, seu receio de mais uma jovem gestante no território, é a utilização de micromecanismos de coerção contraceptiva.

Todas as técnicas de enfermagem que acompanhei concordam com o fato de que se a jovem quiser iniciar a contracepção, ela deve passar em consulta com a equipe de enfermagem. Mas caso for renovação de receita depois de um ano, elas fazem uma interconsulta com o(a) enfermeiro(a), a qual consiste em apontar para o(a) colega de trabalho que a jovem quer renovar a receita e este(a) faz uma nova receita. O(a) enfermeiro(a) acaba não tendo nenhum contato com a jovem. Sobre isso, uma enfermeira destaca:

Vou carimbar, vou renovar. Eu vou olhar só depois, no final do dia, quando eu parar pra evoluir os atendimentos. Daí eu vou olhar que é uma menina de, tipo, 17 anos. Eu vou olhar e ela só teve uma injeção e daí ela já foi embora, entendeu? Perdi a chance de ter agendado. É, eu podia renovar naquela hora para ela aplicar hoje? Podia, mas eu podia dar uma consulta programada pra ela voltar, né? Para gente conversar, ver como é que foi esse primeiro ano de contraceptivo (Enf. Cássia).

Aqui, vemos que a enfermeira tem grande margem de atuação, podendo escolher o que fazer com a jovem. E, via de regra, na unidade de saúde, as jovens só voltam a ser atendidas referente à contracepção se elas quiserem mudar de método ou estiverem se sentindo enjoadas, com dor de cabeça e/ou outro desconforto com o atual. Ou seja, elas acabam acessando pouquíssimas vezes o serviço de saúde.

Quanto à aplicação das injeções mensais e trimestral de contracepção, no geral, as técnicas de enfermagem aplicam a injeção de maneira rápida, tirando dúvidas apenas caso a

jovem pergunte, o que é raro. Todas as aplicações que acompanhei duraram em torno de cinco minutos no máximo.

Ainda, acerca dos micromecanismos de coerção contraceptiva, me recordo de outro acolhimento que acompanhei com uma jovem, Sofia, de cerca de 20 anos. Durante o acolhimento, ela explicou que parou de tomar anticoncepcional porque queria voltar a menstruar. Então a técnica disse: “O ideal seria tu tomar ou colocar o DIU.” Daí a menina não pareceu muito confortável com a resposta e disse que poderia ser comprimido então. A técnica saiu para pegar a receita com uma enfermeira e eu fiquei sozinha com a jovem. A primeira coisa que eu pedi para ela quando eu comecei a falar foi: “tu quer ter filhos logo mais?” Ela falou envergonhada que talvez sim. Daí eu disse que ela poderia pensar mesmo se queria voltar a tomar anticoncepcional e que ela poderia marcar uma consulta para pensar em planejamento familiar.

Aqui, vemos narrativas das enfermeiras que entendem o anticoncepcional como indispensável, da técnica de enfermagem que oferece durante outras consultas a contracepção e da técnica que não perguntou para a jovem se ela queria gestar ou não. Logo, a coerção contraceptiva está intimamente ligada à contenção reprodutiva. Assim como no capítulo anterior, surge a questão: quem tem o direito de escolher quando e como gestar?

Além do momento em que as jovens vão até a US iniciar a contracepção, as gestantes discutem - ou deveriam discutir sobre contracepção - no terceiro trimestre da gestação e/ou primeira consulta da mãe do bebê na unidade. As grávidas que eu entrevistei alteravam entre terem tido essa conversa ainda gestando ou após, mas todas elas afirmam que os(as) enfermeiros(as) e médicos(as) tinham grande preocupação com isso. Sabemos que para além dos possíveis problemas de saúde que a gestante e o feto possam enfrentar, tendo uma gravidez tão próxima da outra, há um “medo que a jovem se descuide de novo e engravide”, como me disse a enfermeira SRT certo dia. Aqui, a coerção contraceptiva entra novamente em cena.

O médico Benjamin destaca que sempre ofertam a contracepção para a mãe nas últimas consultas antes do nascimento ou na primeira após:

Então, a gente tende a ser um pouco mais incisivos na parte de oferecer. Então, né, ganhou, já tacou na mão: “E aí? Vai querer escolher alguma coisa? Não vai querer escolher alguma coisa pra usar?” [...] Então, já aproveita, né, aquele desespero inicial, para não dizer outra coisa, né, pra tentar iniciar já a questão da anticoncepção com a puerpera, né, a nova mãe. Pra tentar prevenir uma gravidez em sequência (Med. Benjamin).

No que se refere às relações dos(as) profissionais de saúde com as jovens, estas destacavam que não conheciam e nunca tinham visto antes muitos(as) daqueles(as)

profissionais. Poucas realmente tinham lembranças de quem eram as pessoas com quem consultavam. E em apenas dois casos as enfermeiras me falaram de jovens que voltaram mais de uma vez, em consultas, para falar do andamento da contracepção, as quais elas destacaram como “caso muito raro.” (Enf. Cássia e enf. Olívia).

No capítulo sete, já olhamos para os marcadores sociais da diferença entre os(as) profissionais de saúde e vimos que eles(as) possuem mais semelhanças do que diferenças: cor de pele, renda, escolaridade, faixa etária, residem fora do território e a maioria não tem experiência reprodutiva.

Vimos que os(as) profissionais de saúde omitem informações sobre todos os métodos de contracepção disponíveis na US e isso ocorre, principalmente, com os(as) enfermeiros(as) que são os que mais atendem consultas de saúde da mulher. Esta falta de informações acaba direcionando a jovem para uma gama de métodos, em específico, que o(a) profissional considera melhor. Esta predefinição dos(as) profissionais se dá a partir da categorização da jovem como “esquecida” e “que não presta atenção”.

O incentivo dado para a utilização da contracepção ocorre com as jovens buscando evitar a gestação em um primeiro momento, sendo que para as jovens que já gestaram, tal incentivo é ainda mais acentuado. Isso devido ao medo de uma segunda gestação da jovem. Ainda, quanto mais jovem a pessoa, mais pressão será colocada para que ela passe a fazer uso da contracepção. Não vimos diferença de tratamento das jovens no que se refere à cor/raça ou, novamente, à condição econômica, visto que todas são de camadas populares.

Para as jovens que entrevistei e conversei, tanto com experiência reprodutiva quanto sem, tanto com 16 ou 20 anos, brancas ou negras, os diálogos sobre contracepção na US são muito similares: não há discussão sobre os vários métodos contraceptivos disponíveis ao iniciar a contracepção e depois disso é só o processo de renovação de receitas, o qual na maioria das vezes é feito pelas técnicas de enfermagem.

Dentre todas as jovens que conversei e entrevistei, apenas duas usam um método diferente do comprimido diário, injeção mensal ou injeção trimestral. Apenas uma jovem usa o DIU e uma usa o Implanon, sendo que ambas não colocaram em uma US e sim em hospitais, enquanto faziam o acompanhamento do parto. No geral, mesmo as jovens que já foram mães demonstram não ter muitos conhecimentos acerca da contracepção para além do preservativo peniano, injeções e anticoncepcional de ciclo vinte e um dias.

8.3 “ANTICONCEPCIONAL É COISA DE MULHER!” SERÁ?

“Anticoncepcional é coisa de mulher.” Essa frase ouvi de muitos jovens, pelo menos um em cada uma das dez turmas que fiz as rodas de conversa. Também ouvia esse tipo de fala quando conversava com os alunos das escolas A e B pelos corredores ou nas entrevistas. Na seção anterior, ao tratarmos da US, jovens homens não apareceram nas falas dos(as) profissionais, o que não é uma surpresa, visto que eles quase nunca estão no serviço, como já vínhamos discutindo, e devido às barreiras de gênero que envolvem a contracepção.

Sempre que eu perguntava o porquê de contracepção ser algo “só de mulher”, as alunas rebatiam e também queriam saber o motivo disso: “Ah sim, pra fazer filho que é bom tudo bem, né?” (Helena, 18 anos, sem experiência reprodutiva). A maioria dos rapazes conhecia alguns contraceptivos, mas chamavam de remédio (comprimido diário) ou vacina (alguma injeção). E os conhecimentos também paravam por aí. Ao seguirmos conversando sobre o assunto, eles não mantinham a atenção e dispersavam para outras conversas paralelas.

Assim, para as jovens fica o peso e a responsabilidade de buscar formas de evitar uma possível gravidez, que não desejam naquele momento. O que, no futuro, também culmina em falas comuns de jovens homens que são ouvidas como “tu que não te cuidou e ficou grávida.” A responsabilização pela contracepção e pela gestação fica toda com a mulher. E isso na fala das jovens e dos jovens, mas também vemos esse discurso em agentes de saúde e educação, destacando micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina em ação.

Apenas um dos cinco rapazes que eu entrevistei já tinha conversado com uma mulher - sua parceira da época - sobre contracepção para ajudá-la a pensar o que faria uso e entender melhor como funcionava. Na escola A, nenhum aluno veio me procurar, pelos corredores, para saber mais sobre métodos contraceptivos. Já na escola B, um aluno me questionou sobre o comprimido do ciclo 21: “Precisa tomar todo dia no mesmo horário? Nem sempre minha ‘mina’ tá tomando no mesmo.” (Luan, sem experiência reprodutiva).

Se formos falar sobre a falta de conhecimento dos jovens, na própria escola A e na escola B, temos que destacar que não há muitas discussões sobre métodos contraceptivos movidas pelos professores e a professora de Biologia. Quando há algum comentário, este é basicamente voltado para as jovens e nunca instigado para os rapazes.

A US, por sua vez, é um lugar que os rapazes acessam muito pouco, como já referido aqui. Eles mesmos falam que não iriam para lá falar sobre sua sexualidade. Profissionais do serviço de saúde destacam que eles só vão para tratar de ISTs quando a situação está lhes incomodando e/ou doendo. Mesmo essas consultas, de ISTs, são raras e nos meses que estive lá só acompanhei uma consulta onde em nenhum momento foi comentado sobre qualquer questão referente a métodos contraceptivos, além da importância do uso do preservativo

peniano para evitar ISTs. Também, em nenhum momento foi tratado de evitar a gestação, como fazem com as jovens mulheres. Mais uma vez, os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Certa vez, dialogando com a enfermeira Cássia sobre as diferenças no acesso entre jovens homens e mulheres, ela destacou que realmente os jovens pouco acessam a US e, quando estes acessavam, nunca se falava nada com eles acerca da contracepção, só com a mulher, como se realmente “fosse só coisa de mulher, mas não deveria ser.” (Enf. Cássia). Até mesmo quando a unidade tinha um olhar mais voltado para a questão dos direitos sexuais, através do grupo de planejamento familiar, apenas mulheres podiam participar do mesmo. Que acesso está sendo possibilitado para os jovens também?

A contracepção que os(as) jovens mais conhecem é o preservativo peniano, popularmente conhecido como camisinha. Acerca do preservativo interno, as jovens relatam que já viram, mas “acho estranho”, “não usaria”, “usei e não me senti confortável”. Os jovens referem nunca terem tido relações com alguém que usava o método, e também achavam “estranho”.

Os preservativos peniano e interno são distribuídos gratuitamente na US junto de lubrificante, sendo que este costuma esgotar mais rapidamente. Toda vez que perguntava às turmas se iriam até uma unidade buscar preservativo, a maioria falava que não e seguia com expressões como “que nojo”, “credo”, “camisinhas muito ruins”, “tudo furada, sora”. Raros eram os casos de jovens homens que acessavam o preservativo peniano na US e foram inexistentes qualquer referência de mulheres jovens fazendo o mesmo. K, homem jovem, relatou:

Eu já acompanhei um amigo depois da escola no posto pra ir pegar. Ele tava com muita vergonha de pegar sozinho, e aí eu acompanhei ele, aí tipo assim, aí a gente chegou lá, né ficou de frente pros preservativos, né. E aí ele ficou me olhando, ele falou “pega aí pra mim” aí eu peguei e “falei tá bom, vai” aí eu peguei e comprei como se fosse pra mim, né? (K, sem experiência reprodutiva).

A vergonha também é relatada como um sentimento, além do medo do preservativo estar furado e do fato de “não ser boa.” Um aluno inclusive me perguntou: “Mas, Sora, tem certeza que funciona a camisinha do posto igual as outras? Não sei não, hein.” (Luan, sem experiência reprodutiva). Na US, os preservativos e lubrificantes ficam na recepção, espaço onde todos(as) observam e são observados. Logo, explica-se a vergonha dos(as) jovens. Certo dia, estava na recepção observando quando uma mulher de cerca de 40 anos veio pedir para

mim onde ficavam os preservativos em um tom quase inaudível. Ainda é um tabu muito grande, mesmo para muitos(as) adultos(as).

A presença de preservativos somente na recepção, e não nas salas dos consultórios, é algo que sempre me chamou atenção e pensava que seria uma boa possibilidade de mais pessoas acessarem o insumo. Parece que o enfermeiro Rafael ouviu meus pensamentos:

Hoje fui até a unidade porque iria entrevistar um jovem lá. Fui à sala do Rafael conversar com ele e eu vi em cima de uma mesa que tinha uma caixa com preservativos. Eu aponte para ela e falei: “Olha só, que legal!” E ele: “São pros teus jovens.” E ficou dando risada. Esse teus jovens teve um significado muito forte para mim e fiquei pensando em quanto a minha estadia na US tinha modificado a forma dos profissionais atenderem ou, se não modificado, tinha pelo menos feito eles ficarem mais atentos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens. (Diário de campo).

Meses depois, perguntei ao enfermeiro se as pessoas tinham acessado mais o preservativo e ele me relatou que sim, que tinha surtido mais efeito do que deixar apenas na recepção, onde todos(as) conseguem ver quem está retirando, mas não relatou especificamente jovens pegando mais, até porque são poucos os que vão à unidade. Aqui, mais uma vez vemos a agência do profissional ao colocar os preservativos em sua sala, ação que foi motivada pela minha presença na unidade.

Alguns jovens, além de não utilizarem os preservativos ofertados pelo serviço de saúde, não usam preservativo simplesmente. Como Fernando (sem experiência reprodutiva, roda de conversa) disse: “Eu faço sem Sora, se vejo que a mina é meio suspeita, coloco.” E outros vários concordaram com ele.

Sempre que falas como esta apareciam, eu tentava dialogar sobre o que seria uma jovem “suspeita” para eles e me respondiam que “a gente sabe, que anda muito pelo mundo e tal” ou “tem guria que tem cara”. Estas frases eram seguidas de risadas incrédulas das jovens e risadas genuínas dos rapazes.

Aí está uma grande dificuldade que os(as) profissionais da escola relatam com propriedade por conviverem, diariamente, com os(as) jovens e que também é ouvida pelos(as) funcionários(as) da US: “Os meninos não usam preservativo, não adianta.” Hoje, no território, muitas jovens ainda se relacionam seja por amor, pressão ou “N” outros motivos com homens sem uso de preservativo. Uma das jovens que eu entrevistei se tornou mãe, afirmando que “meu namorado não queria usar preservativo porque ele não gostava e eu respeitava ele.” (Alice, com experiência reprodutiva).

Nesse contexto, destacamos que a vivência da sexualidade na juventude e as decisões que rondam as experiências sexuais, principalmente sem uso de preservativo, são influenciadas

diretamente por assimetrias de gênero (Silva; Borba, 2018; Barbosa et al, 2022; Cid, Sousa e Duarte, 2020).

E se os(as) agentes de saúde e educação sabem da dificuldade de jovens homens aceitarem usar o preservativo peniano, por quais razões este segue sendo o único método de barreira citado nas escolas e na US? A escolha de não falar, por exemplo, do preservativo interno aponta para a utilização do micromecanismo de coerção contraceptiva que acaba por, em algumas ocasiões, facilitar com que a jovem engravide, o que é justamente o que os(as) profissionais mais têm medo.

Falamos até então neste capítulo acerca da contracepção focada em medo da gestação na juventude com os(as) profissionais, colocando em segundo plano as ISTs quando se trata de saúde sexual e reprodutiva juvenil. Mesmo assim, é um tema que aparece no cotidiano dos(as) agentes e que atravessa os(as) jovens, como veremos a seguir.

9. “IST? AH, AQUELAS DOENÇAS LÁ, NÉ?”

IST? AH, aquelas doenças lá, né? - que dá título a este capítulo - foi uma frase dita por Raquel (sem experiência reprodutiva) certo dia quando conversávamos entre uma aula e outra e falávamos sobre ISTs. Além de Raquel, muitos outros(as) jovens demonstraram pouco conhecimento acerca das ISTs, principalmente jovens homens.

Neste capítulo iremos seguir falando dos cotidianos de trabalho dos(as) agentes de saúde e de educação de Porto Alegre, mas agora no que tange às discussões acerca das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que por vezes profissionais e jovens ainda se referem como doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Ao olharmos para os ambientes das escolas e da US, e também ao conversarmos com os(as) jovens, estamos olhando para o cotidiano da política pública onde veremos que as diferenças de gênero seguem tão presentes quanto nas discussões sobre gestação e contracepção.

9.1 ESCOLAS E OLHARES PARA “AQUELAS DOENÇAS SEXUAIS LÁ”

Aquelas doenças sexuais lá - parte do título dessa seção - é uma expressão que faz referência à forma com que muitos(as) jovens se referem às ISTs: eles(as), em geral, sabem que as infecções existem, conhecem as principais como aids e sífilis, já tiveram algumas informações sobre o tema na escola e entendem que o preservativo peniano é o principal meio de evitar que “se pegue doença” (Sara, sem experiência reprodutiva).

Como já vimos nos dois capítulos anteriores, no oitavo ano do Ensino Fundamental há uma parte do livro didático destinada à discussão sobre o corpo humano, tratando da reprodução e de ISTs. Na BNCC do Ensino Fundamental, no referido ano, lê-se: “Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção” (BNCC, 2017, p. 378).

Dos três professores e a professora que acompanhei, apenas dois atuam ainda no Ensino Fundamental e apontam para a realização de atividades voltadas às ISTs, normalmente, trazendo trabalhos de pesquisa com os(as) alunos(as) acerca. Pude acompanhar o professor Felipe, em algumas destas aulas, onde estudantes fizeram cartazes e depois apresentaram para os(as) demais colegas. Era perceptível a falta de interesse dos alunos, muitos de fone de ouvido, muitos dando risadas. E a grande maioria lendo os cartazes que apresentava. Certa altura da aula, uma jovem leu com dificuldade a sigla “IST” escrita no trabalho e disse “não sei o que é isso.”

Se aquela jovem não sabia o que significava ISTs, provavelmente muitas outras(os) colegas também não. Ao conversar com os(as) jovens nas escolas ou nas entrevistas que realizei, aqueles(as) que tiveram aula sobre a temática no oitavo ano se recordam pouco, explicando: “Ah, falaram das doenças lá” (Caio, sem experiência reprodutiva, 2024) ou “Sei da aids, sífilis, também tem herpes” (Sabrina, sem experiência reprodutiva).

Durante uma roda de conversa na turma do terceiro ano, do noturno da escola B, uma aluna destacou falas que são recorrentes entre a maioria dos(as) jovens:

Eu acho que nas escolas até poderia ser mais abordado isso. Eu acho que pode ser um pouco abordado, mas é muito raro. No caso eu mesmo acho que foi na quinta, sexta série. Mas falaram muito pouco e depois nunca mais, foi naquela aula de Ciências falando sobre reprodução humana. Mas falar de camisinha, IST e era isso. E do órgão sexual (Camila, sem experiência reprodutiva, roda de conversa).

Aquela aula de Ciências que normalmente ocorria no oitavo ano é a referência da jovem. A maioria cita que os(as) colegas riam muito durante as aulas e que “os profes queriam mesmo nos assustar com aquelas imagens das doenças” (Fábio, sem experiência reprodutiva). Porém, muitos(as) jovens citam não ter tido alguma atividade sobre ISTs na escola, como é o caso de Liz: “Não, nada sobre doença sexualmente transmissível. Só falam: Não faça sexo. E falam do anticoncepcional, e deu.” (Liz, sem experiência reprodutiva).

Falando em atividades realizadas no Ensino Médio, que é o nosso foco maior aqui, o professor Gabriel, professor do turno da noite da escola A, destaca:

E aí logo depois eu já peço, já peço o trabalho sobre as DSTs. Depois que eu termino o sistema genital masculino e feminino, eu peço o trabalho das DSTs e dos métodos contra as DSTs. Daí pede um trabalho pra eles escrito, assim, e tal. É, pesquisa. É um período, né, então não tem muito, né, não tem muito espaço pra ficar pedindo também. É, faz uma pesquisa e já matam a charada. (Prof. Gabriel).

Eu acompanhei por algum tempo as aulas do professor Gabriel, com a turma de terceiro ano da escola A, e naquele período estavam tratando de reprodução humana, mas em nenhum momento se falou em ISTs ou métodos contraceptivos. Ao realizarmos nossa roda de conversa, nenhum(a) dos(as) estudantes destacou ter tido alguma atividade no Ensino Médio falando sobre ISTs com algum professor, o que mostra que, se o professor Gabriel tratou do conteúdo nessa turma, não gerou lembranças aos(as) jovens.

O outro professor da escola A, Felipe, além de trabalhar no oitavo ano, apontou que abordou em uma aula do terceiro ano a temática da reprodução em conversa com os(as) jovens, destacado já durante o sétimo capítulo, onde tratou principalmente da gestação, mas disse que

falou também sobre “o cuidado para se proteger de doenças” (Prof. Felipe). Ao realizar uma roda de conversa com aquela turma, os(as) jovens destacaram que este professor costuma falar todos os anos com eles(as): “Ah, sempre que dá ele está falando pra gente cuidar.” (Sabrina, sem experiência reprodutiva, roda de conversa). Porém, da mesma forma, o discurso não vai além do cuidado com o preservativo peniano para impedir doenças, sem falar mais sobre as infecções.

Já na escola B, o professor Ricardo, que dá aula de Biologia para o segundo ano do Ensino Médio, destaca que não trata com seus alunos sobre ISTs e que este é um tema para o oitavo ano do Ensino Fundamental. A professora Monique comenta abordar em sala de aula sobre ISTs no segundo ano do Ensino Médio noturno: “só essa questão sexualidade, daí depois eu vou trabalhar o início da genética, quando termina a sexualidade eu já começo a trabalhar. Eles aprendem lá todos os conceitos de genética, como é que se dá a questão do DNA, então é tudo isso aí, das doenças” (Prof. Monique).

Ela diz que fala sobre as infecções apenas naquele momento da entrevista e depois não aborda mais. Ao conversar com a turma, que a professora Monique referiu tratar sobre sexualidade, os(as) estudantes, assim como os da escola A, não referem ter tido aula sobre essa temática ao longo do ano.

Fora daquele momento, em sala de aula específico sobre sexualidade que a professora Monique relatou, ela mantém um diálogo próximo com diversos(as) alunos(as) e diz conversar com eles(as) acerca de assuntos referentes à sexualidade. Como já destacado nos capítulos anteriores, os(as) jovens com quem conversei apontam para esta professora como a única da escola com quem tratariam do tema.

Aqui, novamente, temos a questão de relações entre jovens e agentes interferindo nos acessos às informações sobre saúde sexual e reprodutiva, uma vez que essa distância inibe jovens de questionar os(as) professores(as) sobre possíveis dúvidas que tenham, por exemplo, em relação aos testes rápidos para ISTs. Como os(as) professores(as) não abordam o assunto em sala de aula, os(as) jovens acabam não sabendo, por exemplo, que existem os testes e que estão disponíveis no SUS. Aqui, relembremos Silva e colaboradores, que destacam que “o sucesso dos programas de [promoção de saúde sexual, saúde reprodutiva e] prevenção das DST/Aids depende do diálogo com os sujeitos nos termos de sua vida cotidiana e de seu cenário sociocultural.” (Silva et al., 2008, p. 685). E isso vale para além de ISTs, como contracepção e gestação também.

Sobre as conversas que tem com alunos(as), a professora Monique destaca:

Que nem os meninos, eu brinco muito com os meninos aqui do terceiro ano. Eles trocam de namorada como trocam de sapato. Eu digo: “Seguinte, vou dizer uma coisa pra vocês: vocês vão pegar uma pereba, ah, mas vão pegar uma pereba”. Eles: “Ah, mas a gente...” Eu: “Não, só um pouquinho, gente, não é assim, não é esse oba oba. Vocês estão com os hormônios lá no teto, mas não é esse oba oba. Vocês se cuidem, vocês se preservem porque realmente as doenças estão aí. Elas são bem fáceis de ser adquiridas e muito preocupantes. Depois, então, lá na frente vocês vão pensar no que eu estou falando e vão lembrar que estão passando por certas coisas porque não se cuidaram. Então acalmem um pouco” (Prof. Monique).

Novamente, são falas para cuidar das “perebas”, mas sem trazer maiores informações sobre como funcionam, sintomas, efeitos, entre outros. Ainda, aqui podemos pensar em micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina devido à professora trazer a prevenção de ISTs, mas não a importância de preservativo para não ter uma gestação. Sempre ao falar sobre preservativo com as jovens, ela cita a gestação. E por que não com os meninos?

A professora conta de outro momento:

Esses dias teve uma pergunta de um menino, uma noite, muito interessante. Ele me perguntou: “É verdade que a gente deve forrar o assento porque pegam algumas doenças e tal?” Eu: “Isso aí. Não só doenças sexualmente transmissíveis que a gente pega, a gente pode pegar doença até no sentar ali, né? No teu contato, então ali ficam várias bactérias várias.” Então ele: “Ah, Sora, então é verdade?” “Sim, é verdade” (Prof. Monique).

Aqui, vemos que a própria professora traz uma informação errônea para o aluno e seus(as) colegas, o que acaba, provavelmente, aumentando seus receios de “pegar uma doença”. Era um momento que o aluno trouxe a dúvida e poderia ter sido mais bem explorado. Os demais professores não apontam para alunos questionando acerca de ISTs.

Assim, vimos que em todos os exemplos do cotidiano dos professores e da professora, as ISTs aparecem de forma pouco expressiva ao longo do Ensino Médio e, quando aparecem, é com o discurso do cuidado para que os(as) jovens não se infectem, destacando o uso do preservativo peniano. Maiores informações acerca dos tipos de ISTs, preservativo interno ou testes rápidos não são trazidas para os(as) estudantes. Pelo contrário, algumas das poucas informações dadas aos jovens estão equivocadas.

Se olharmos para os mecanismos de governança reprodutiva, a noção de coerção contraceptiva segue presente, mas, nas discussões acerca de ISTs, muito mais num sentido de proteção na contaminação, através do ato sexual, do que na prevenção da gestação. Vale destacar que a coerção tem um discurso de maior intensidade com o intuito de evitar a gestação para as jovens mulheres e de evitar IST para os jovens homens.

Novamente, olhando para os marcadores sociais da diferença, o gênero segue se sobressaindo. Entre os(as) quatro professores(as) que acompanhei, apenas a professora Monique destacou que orientava os alunos a ter cuidado com as ISTs. Mas essa fala ela sempre destacava a eles e não às jovens? E por quê? Aqui, novamente entram as discussões de assimetrias de gênero e o fato de que sabemos que muitas vezes são os homens que têm o poder de escolha acerca do uso do preservativo nas relações. Fora isso, ela aponta para os jovens terem uma vida sexual mais ativa que as mulheres. Porém, ao mesmo tempo que a professora reforça esse cuidado para os homens, ela deslegitima o poder e a importância da mulher em escolher usar o preservativo, colocando-a justamente num lugar de subserviência.

Aqui, no que se refere ao marcador social da faixa etária, como vimos, os professores e a professora destacam que abordam ou no segundo ano ou no terceiro do Ensino Médio sobre ISTs, ou seja, em torno de 17 e 18 anos de idade. No que se refere à raça, à classe ou ao território, não vemos nenhuma diferença na forma de abordagem.

Se olharmos para as falas dos(as) alunos(as) das escolas A e B, novamente o marcador social que mais se sobressai é o de gênero. Jovens mulheres costumam ter mais conhecimento acerca de ISTs que os jovens homens, apesar do esforço da professora Monique, por exemplo. As mulheres costumam saber algumas ISTs a mais que homens, mas mesmo assim, com um conhecimento muito limitado.

As jovens das escolas A e B, que já têm experiência reprodutiva, não apontam ter um conhecimento maior acerca das infecções que os demais, mesmo tendo feito diversas vezes testes rápidos para ISTs como o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual de Porto Alegre destaca necessário (Porto Alegre, 2024b). Suas frases costumam ser como a de Madalena (16 anos, com experiência reprodutiva, roda de conversa): “Ah, sim! Eu fiz lá no posto algumas vezes, tinham que ficar furando meu dedo pra ver se eu tinha essas doenças aí.”

No que tange a idade, seja 16 ou 20 anos, não vimos diferença significativa na fala das pessoas entrevistadas, o que nos leva a crer que o tempo de vida sexual ativa não interferiu nos conhecimentos acerca das infecções, sendo esta uma discussão que os(as) jovens também relatam não ter no ambiente familiar para além do “Minha mãe disse que tinha que usar camisinha para se proteger das doenças, né?” (Lucas, sem experiência reprodutiva, roda de conversa). Fala que é muito semelhante ao tipo de informação que eles(as) recebem na escola, nas aulas de Biologia.

Mais uma vez, raça, classe e território não são marcadores de diferença entre os(as) alunos(as), uma vez que a maioria é de jovens negros(as), de camadas populares e que moram no território aproximado. As jovens brancas tinham tanto conhecimento quanto as jovens

negras, com quem conversei, e o mesmo se repetia para os homens. Mesmo as pessoas com maior poder aquisitivo - ainda que de camadas baixas - não apresentavam diferenças em seus conhecimentos acerca das ISTs.

E para além das aulas de Biologia? Na escola, os(as) jovens destacam, assim como já vimos nos dois capítulos anteriores, as faltas de discussões em outros ambientes que não a aula de Ciências e/ou Biologia. Diferente do que acontece quando se fala em gestação ou contracepção, não há falas de outros professores(as) da escola sobre ISTs. Também, pouquíssimas referências são feitas às atividades de universitários na escola tratando da temática.

Pude acompanhar uma atividade realizada por uma acadêmica do curso de Biomedicina, de uma faculdade de Porto Alegre, e ela fez uma apresentação acerca do Papilomavírus Humano (HPV) em formato de vídeo. Porém, no dia da apresentação, não teve acesso a um retroprojetor, então pediu que os(as) alunos(as) das três turmas do Ensino Médio acompanhassem o vídeo pelo celular.

O vídeo foi enviado por WhatsApp para um grupo criado na hora pelo professor da faculdade que acompanhou as acadêmicas naquele dia. Houve vários problemas: nem todos(as) tinham celular, nem todos(as) tinham dados móveis para conseguir acessar o vídeo, também não eram todos que tinham fones de ouvido, logo, os sons se misturavam e ficavam inaudíveis. Depois das falhas técnicas, o vídeo era muito longo, pouco didático e claramente ninguém prestou atenção nele. Eu mesma perdi a concentração ainda no primeiro minuto de vídeo. Depois de olharmos, a acadêmica não falou mais nada e ficou por isso.

Não haver comentários da aluna acerca do vídeo, nem mesmo uma abertura para o diálogo, acaba impossibilitando discussões acerca das ISTs. Nesta mesma escola, acompanhei uma atividade de saúde da mulher referente à campanha de saúde Outubro Rosa onde algumas acadêmicas da Liga Acadêmica de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia de uma universidade próxima vieram à escola. Elas colocaram em uma mesa folhetos explicativos sobre câncer de mama, a maquete de uma mama para simularem nódulos e ficaram atrás da mesa esperando receber os(as) jovens. Porém, aquele era o dia da festa de Halloween da escola, de noite, e apenas três alunas foram até as acadêmicas.

As estudantes de Enfermagem falaram da importância do autocuidado e do conhecimento sobre si mesmas, sendo que a professora universitária falou para as estudantes do Ensino Médio olharem suas próprias vaginas: “Não é só se cuidar com a gestação, é cuidar com ISTs.” Também disse: “Se conhecer para saber o que gosta e o que não gosta, porque vocês merecem o respeito, saber os limites.” Foi uma fala muito interessante em uma abordagem bem

delicada, mas infelizmente somente três alunas ouviram e as acadêmicas não retornaram em outro momento.

Já na escola B alguns(as) alunos(as) destacaram durante as rodas de conversa que receberam um grupo de alunas de uma faculdade que veio falar com eles: “Aqueles mulheres falaram sobre usar camisinha, prevenir a gravidez e cuidar com as ISTs.” Da mesma forma, os(as) estudantes que tiveram esta palestra não destacaram ter aprofundado as discussões sobre ISTs.

Alguns(as) dos(as) alunos(as), ao falar de ISTs, também citaram as atividades do PSE, mas sem dar muita relevância a tais ações: “Ah, falaram que tinha as doenças, que era pra se proteger e tal” (Rodrigo, 18 anos, sem experiência reprodutiva, roda de conversa). Outros(as) jovens que entrevistei nem mesmo citavam as atividades do Programa como lembranças de momentos em que discutiram sobre ISTs.

Ainda, alguns(as) que estudaram na escola onde Samanta é supervisora, destacam que tiveram atividades com ela e que “ela falava de doenças e dessas coisas”, mas apontavam muito mais para ela discutindo a forma como ocorriam as relações sexuais, gravidez e uso de preservativo. A própria Samanta já me indicou em conversa que focava em “prevenir a gravidez” que seria algo que acontece muito no território.

Franciele, jovem que entrevistei e sem experiência reprodutiva, ao ser questionada se já havia conversado acerca de ISTs na escola, destacou: “Não, foi só quando tu apareceu mesmo ali pra conversar com nós, fazer aquela roda, porque até então ninguém tinha conversado com nós sobre nada” (Franciele, sem experiência reprodutiva, entrevista). Diversos outros(as) jovens relataram o mesmo.

Certo dia, estávamos falando eu e mais dois jovens e uma jovem, do primeiro ano da escola A, sobre ISTs, e um deles me disse que não tinha chance de ele pegar IST porque ele não namorava com ninguém. Então, eu expliquei para ele como acontecia a transmissão das infecções e seguimos conversando mais. Outras questões sobre como pegar sífilis e/ou herpes também apareceram. Dúvidas sobre transmissão de infecções a partir do sexo oral também eram frequentes.

Outro ponto que poucos(as) tinham conhecimento, e que surgiam várias dúvidas quando eu citava, era acerca dos testes rápidos para ISTs: muitos jovens não sabiam o que eram, para o que serviam ou o porquê de realizar. Um jovem me disse: “Mas eu faço sempre os testes de sangue todo ano pra ver como tá o colesterol e aquelas paradas”. Então, eu explicava o que eram os testes rápidos, sua importância e o fato de serem gratuitos na US, o que espantava vários(as)

deles(as). Foram poucos os casos de jovens homens que já tinham feito estes testes, os quais eram um pouco mais frequentes nas mulheres, mesmo assim muito pouco presentes.

Ao longo dessa seção, vimos que há um apagamento das discussões sobre ISTs nas escolas A e B, não aparecendo como central para os(as) professores(as) tanto de Biologia quanto de outros conteúdos. Ademais, também não é tema central em se tratando de PSE - o que poderia fazer com que os(as) jovens agora no Ensino Médio tivessem um conhecimento mais estruturado acerca do assunto - ou das aulas da coordenadora da escola D, professora Samanta.

No caso da utilização de mecanismos de governança reprodutiva, alguns(as) alunos(as) citavam o fato de que os(as) professores(as) sempre tinham o discurso relacionado a não ter relações sexuais, o que evitaria a gestação e as infecções. Nestes casos, temos o mecanismo de contenção reprodutiva muito presente. Segue trecho de roda de conversa com a turma do primeiro ano da escola B:

Bárbara: E como é quando algum professor conversa com vocês acerca da sexualidade?

Marcela: É sempre “não transem”.

Fátima: Sim, o que é muito errado [dizer para jovens não praticarem sexo].

(Vários outros colegas concordando).

Silvana: Até porque o transar, dependendo da tua idade ajuda muito o estresse, a ansiedade, uma vida sexual ótima. Quem tem vida sexual ótima não faz fofoca da vida dos outros, gente. Mas, dependendo ajuda muito, senhora. Porque não é lá o bicho de sete cabeças. Porque se fosse o bicho de sete cabeças, ninguém faria. Mas, assim, eu acho que o “não transem” é muito errado falar. Se é uma pessoa com 14 anos e tu fala, eu acho que é muito errado. Com 16 anos tu tá entrando numa fase mais adulta, mais festa, eu acho que não é errado falar sobre. É só falar pra tu te proteger. Tem um tabu muito grande ainda pra falar sobre, Sora (Jovens 16 anos, sem experiência reprodutiva).

Apesar de ocorrerem mais falas no sentido de denúncia aos professores(as) que referiam a abstinência sexual como caminho a ser seguido, estas não são maioria nas salas de aula em rodas de conversa. Também, nas entrevistas individuais realizadas, nenhuma das quinze jovens mulheres e cinco jovens homens referiu este tipo de situação.

Majoritariamente, as falas sobre ISTs se restringem ao “cuidado para não pegar doença” (Prof. Monique) sempre fazendo uso de preservativo peniano. Discussões mais aprofundadas sobre quais são as ISTs, tipos de transmissão, o que causam e/ou realizações de testes rápidos não são realizadas no ambiente escolar. Também, nunca foi comentado por algum(a) profissional sobre a prevenção combinada, nem Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e tampouco Profilaxia Pós-Exposição (PEP). A preocupação maior dos(as) agentes de educação segue

sendo a gestação em detrimento das infecções. A seguir, veremos se o mesmo padrão se repete na unidade de saúde.

9.2 OS ATENDIMENTOS NA US ACERCA DE ISTS

Como já vínhamos discutindo, os(as) jovens não acessam com frequência a US, a não ser que precisem no caso de que “eu esteja quase morrendo” (Ivan, sem experiência reprodutiva). As jovens acessam para realização de pré-natal, quando grávidas, e também para dar início à contracepção e para aplicação da “injeção” (método contraceptivo hormonal injetável, com frequência mensal ou trimestral). Ao questionar os(as) jovens acerca de ISTs e US, a maioria destaca que nunca foi à Unidade fazer os testes rápidos e nem mesmo sabiam da sua existência.

As dez jovens gestantes e mães que entrevistei só passaram a ter conhecimento sobre a existência de testes rápidos para as infecções quando iniciaram o pré-natal, como destaca Alice (com experiência reprodutiva): “Não, nunca, nunca ouvi falar. E teste rápido, eu sei que a gente faz na gravidez, né?”. É preconizado que ao longo do pré-natal, caso seja uma gestação oriunda de relacionamento monogâmico, a gestante faça pelo menos três vezes os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites; os testes devem ser feitos pelo menos uma vez com o genitor. O chamado pré-natal do parceiro consiste justamente na realização dos testes rápidos para ISTs uma única vez (Porto Alegre, 2024b).

Acompanhei alguns atendimentos de pré-natal com as jovens na US, onde se realizaram testes rápidos, mas nunca se discutiu realmente as ISTs. Tanto na abertura de pré-natal de gestante jovens ou de adultas, o discurso é basicamente o mesmo: “A gente tem que fazer os testes só pra garantir que não tenha nenhuma doença que pode ocasionar problemas pra ti ou pro bebê. Ok?” (Enf. SRT, observação de consulta). As gestantes acenam positivamente com a cabeça, é feito o teste e mais nada é comentado sobre, a não ser que dê algum positivo.

Ou seja, mesmo o jovem que acessa a US para realizar os testes rápidos não tem um diálogo acerca destes. Na placa apresentam-se informações de como se pode adquirir sífilis, HIV, hepatites B e C. Ou seja, são pouquíssimas informações que mesmo aqueles que acessam a US conseguem ter informações sobre estas infecções. Não há referência a outras ISTs para além destas quatro. Em outras consultas que não envolviam gestantes o mesmo padrão de poucas explicações foi observado.

Era no grupo de gestantes que havia algumas informações a mais sobre ISTs. No grupo, o tema aparece ao se trazer a importância de realizar os testes rápidos. Em todos os encontros que acompanhei, a enfermeira Olívia trazia uma fala similar: “Vocês têm que fazer os testes três vezes ao longo do pré-natal para garantir que esteja tudo certo, não dê nenhum problema. Trouxe aqui a sífilis porque é uma das que mais tem aparecido no território e se não tratar direito pode até deixar o bebê cego ou outras coisas” (Enf. Olívia). As informações, entretanto, não eram ampliadas para além disso.

Nas entrevistas, além das gestantes jovens ou no puerpério, uma jovem entrevistada já havia feito os testes. Ella fez os testes a pedido de sua ginecologista, médica à qual tinha acesso via plano de saúde que sua mãe acessava através do seu trabalho. Um tempo depois, sua mãe começou a trabalhar em uma US - próxima da que realizei a pesquisa - e Ella conta que hoje tem muita abertura para conversar com sua médica. Ela é a única jovem entrevistada que se refere à “minha médica”, “vou sempre nela” e “me sinto confortável para falar com ela.” (Ella, sem experiência reprodutiva).

Natália, gestante, destacou que “Quando eu vinha [na consulta médica de pré-natal] era só, tipo, ah, fazer o exame. Não, nunca falamos mais nada sobre doenças ou algo assim. Não explicaram nada aqui. Elas aplicavam e era isso. E pronto. Nunca tive dúvida assim, nunca perguntei, assim, elas também nunca me falaram.” (Natália, com experiência reprodutiva).

Uma relação muito diversa daquela destacada por Ella no parágrafo acima, sendo que ambas frequentam a mesma US. Aqui, vemos novamente como as relações entre agente e usuário são centrais para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dos(as) jovens e como mudam a forma de atendimento, sendo que uma boa relação com o(a) profissional possibilita um ambiente mais seguro para estabelecer diálogos.

Os cinco jovens que eu entrevistei nunca realizaram exames para ISTs. Ao conversar com as quinze jovens entrevistadas e cinco jovens homens, seus conhecimentos sobre as infecções eram advindos da escola “onde o professor falou lá pra gente das doenças quando estava no Ensino Fundamental” (Patrícia, sem experiência reprodutiva) ou mesmo inexistentes como destaca o jovem K:

É até, até cômico. Mas, é, o que aconteceu foi que, recentemente, eu tive que me alistar, né? Teve o alistamento do quartel. E aí, lá eles fazem toda a questão médica. Certo? E aí tem uma parte onde tu tem que ficar pelado de frente pro médico lá. E aí, depois quando eu cheguei em casa, eu comentei com as minhas irmãs, que teve lá a ficha, e na ficha perguntava se eu tinha DST ou alguma coisa do gênero, e eu tinha dito que eu não sabia pras minhas irmãs, porque eu nunca tive esse contato de conversar com as pessoas. E sobre sexo. E aí, eu falei que eu não sabia se eu tinha, né,

e a minha irmã me explicou que DST, tu não tem, só tem a partir do momento que tu, que tu se relaciona com alguém, certo? E essa pessoa tem. Ou se tu tiver, tu também tem como ter através de beijo. Se tu tiver uma ferida na boca e a pessoa tiver, você consegue ter. E esses foram os únicos contatos que eu tive, assim, com o assunto (K, sem experiência reprodutiva).

Este jovem possui 18 anos e está no terceiro ano do Ensino Médio e não tinha conhecimento do que eram infecções sexualmente transmissíveis. Conversei com ele também sobre a questão da transmissão vertical e acerca de PrEP e PEP, temas que ele nunca tinha acessado. Aliás, apenas um entre mais de cem jovens com quem eu conversei ao longo da pesquisa sabia o que era PrEP e PEP. Durante a roda de conversa, o aluno, Fernando, do terceiro ano do Ensino Médio foi explicando para os demais colegas como funcionava e como tinha sido o acesso à US para conseguir a PrEP. Ele destacou sobre a burocracia do processo e que tinha que ir para o centro da cidade buscar os comprimidos, o que dificultava seu acesso devido ao dinheiro para o transporte e o tempo de deslocamento.

No período em que estive na US, acompanhei apenas uma consulta com a enfermeira Olívia onde um homem de 24 anos desejava iniciar o uso de PrEP. Ela fez uma consulta muito atenciosa com ele, explicando cada passo, conversando com ele sobre como funcionava o atendimento e mantendo a US à disposição caso ele precisasse. Depois da consulta, ela me relatou que consultas como esta são raras. Nenhum(a) dos(as) outros(as) profissionais da US me relataram sobre PrEP ou PEP, tanto da equipe de enfermagem, quanto dos ACSs ou dos médicos(as). Nunca, em qualquer consulta em que foram feitos testes rápidos para ISTs, foi falado sobre estas estratégias de profilaxia.

Durante as atividades do PSE na escola que a ACS Carolina e a enfermeira Olívia ministravam, também não era um assunto comentado, assim como a coordenadora da escola D, Samanta, tampouco falou sobre o assunto. Nem mesmo os professores(as) nas escolas A e B trataram em algum momento sobre. Ou seja, os(as) jovens que sabem sobre a existência de PrEP e PEP, o sabem devido a diálogos para além da escola ou US, provavelmente em conversa com amigos ou pela internet.

Todas as enfermeiras, enfermeiro, médicos, médica e técnicas de enfermagem que entrevistei e acompanhei destacaram que são poucos os jovens que realizam exames de ISTs e acessam a US para fazê-los, isso ocorre somente quando percebem alguma diferença física na região do pênis e/ou estão com alguma secreção diferente do que consideram normal: “Algo mais visível. Afetou o pênis, o homem aparece na Unidade, se não, é mais difícil.” (Enf. Polina).

Muitas vezes, as técnicas de enfermagem destacam que passam no acolhimento por elas falando de tosse ou outros sintomas respiratórios e ao chegar no médico(a) ou enfermeiro(a):

Daí eles chegam, às vezes eles chegam muito assim, principalmente os meninos, muuuito assim pelas beiradas: “Ah, tô com tosse.” Chega lá na frente, passa em demanda de enfermagem. Chega lá dentro: “Bah, olha só, fiquei com vergonha de te dizer, mas tô com uma secreção assim, assim e tô com tal coisa e eu queria fazer aqueles testezinhos.” Tu vai lá, faz e positiva alguma coisa (Enf. Cássia).

Aqui, temos algumas barreiras que dificultam o acesso dos jovens para além da demora no atendimento - assunto que eles mais comentam -, sendo o constrangimento o principal deles. Barreiras de gênero também são percebidas por enfermeiras que atendem jovens homens. Um rapaz me disse certo dia, no intervalo da aula: “Tá louco que eu vou deixar uma mulher que eu nunca vi na vida olhar ali [na região do pênis]” (Marcos, sem experiência reprodutiva). Além do constrangimento, claro que há o medo de realmente ter uma infecção. Ao entrevistar a ACS Fernanda, ela destacou esta questão do constrangimento:

Porque às vezes a gente encontra, eles veem um e outro assim, mais acanhadinhos. E aí fica assim: “Vim fazer teste rápido.” (cochichando) “Teste rápido de que, querido?” “Ah, esse do sangue, do dedo do HIV, porque, ah, eu fui no pancadão lá, não sei o que.” E eles vêm muito assim, encolhido, meio, pedindo permissão, sabe? Aí tu diz: “Ok, é tem direito, vamos lá, vamos lá, vamos pegar uma enfermeira, vamos sentar ali e fazer.” “Ah, tia, mas eu posso?” “Tu deve, é teu direito. Eu só preciso que tu tenha um documento de identidade para que tu possa levar o laudo contigo. Se tu tiver um documento de identidade ali, um documento com foto, tu pode levar teu laudo. Se tu não tiver, daí a gente faz e não pode te fornecer o laudo. Mas pode fazer isso”. “Ah, tá, não, eu não sabia, eu fiquei com medo, né, não sei o que” (ACS Fernanda, 2024).

E para além do constrangimento e medo, o enfermeiro Rafael apontou uma barreira que ele identificou durante uma consulta de um jovem de 14 anos: Rafael me relatou que o jovem veio à unidade sozinho, passou pelo acolhimento e disse para a técnica que queria fazer exames de ISTs e que a mãe tinha pedido para ele vir à unidade. A técnica chamou Rafael e ele disse que pediram para o paciente voltar com a mãe.

Eu perguntei o porquê e ele falou que “estava muito confusa a história, não quis atender sem responsável junto” (Enf. Rafael). Ele não soube me dizer se o rapaz retornou novamente para atendimento. Mas, como já comentamos ao falar de contracepção, é preconizado no SUS que pessoas entre 12 e 18 anos podem ser atendidas sem responsáveis caso assim desejem (Brasil, 2022). Em outra oportunidade, perguntei ao mesmo enfermeiro se ele sabia a partir de que idade poderia ser realizado o atendimento de jovens sozinhos(as) e ele respondeu: “Eu acho

que até, de repente tem, mas assim, específico eu não sei te definir mesmo, mas eu fico devendo, tem que dar uma olhada.” (Enf. Rafael).

Acompanhei pouquíssimos atendimentos de jovens no que se refere às ISTs dentro da US, o que condiz com a fala dos jovens que não acessam o serviço e dos(as) funcionários(as) que dizem atender raramente estes casos e, quando atendem, costumam ser de jovens que vêm levados pela mãe. Dos atendimentos que acompanhei, todos seguiram um padrão de poucas explicações sobre ISTs.

A enfermeira Polina aponta que trata de maneira mais aprofundada a questão das ISTs, explicando quais testes serão realizados, qual o método, sobre janela imunológica e da importância do preservativo. Os demais profissionais de saúde também falam que explicam os testes, como funcionam e perguntam se os jovens têm alguma dúvida, mas normalmente, segundo os(as) funcionários, os(as) jovens respondem de forma negativa.

Um dos médicos traz um ponto interessante para a nossa análise:

Acontecia muito e é uma coisa que eu acho interessante da questão da pesquisa também, que muitas vezes isso já era resolvido dentro do acolhimento. Como? Chegava na porta, gurizinho com isso, né, com uretrite, né, tem que dar astro, benzetacil e mais alguma coisa. Né, então, toda essa questão. Então, muitas vezes a gente só fazia sem, muitas vezes ver o paciente, né. Porque era a forma, né, como a gente desafogava muitas vezes. Então a gente não conseguia conversar com o paciente, fazer essa consulta, que custa tempo, e tempo de atendimento é curto. Ainda mais numa unidade que tá explodindo gente pelas paredes, que fazia trinta atendimentos por dia. Né, então, uma unidade que, né, não conseguia, muitas vezes, estancar isso. Né, às vezes, até o próprio enfermeiro, tipo, isso, tratamento desse tipo de coisa, desse tipo de infecção, muitas vezes, que era quando o homem chegava, era o enfermeiro que abordava. Que pode, que pode tratar, que pode prescrever. E tá tudo certo. Às vezes, a gente nem ficava sabendo médico, assim (Med. Benjamin).

Neste tipo de caso, não é feita uma conversa acerca de prevenção das ISTs ou uma mínima explicação sobre quais são elas, como são transmitidas e o que causam. Como disse o médico Benjamin, são muitos os atendimentos realizados na Unidade e que são considerados “mais importantes” do que discutir sobre saúde sexual. Assim, se houver um atendimento do caso sem que seja feita consulta com profissionais de Ensino Superior, o caso terá uma resolução mais rápida e fácil para a US, mas com menos informações para o jovem.

Se os jovens vêm para tratar de lesões e realizar os testes quando acham que estão com uma infecção, os(as) profissionais da US destacam que as jovens frequentam muito mais para iniciar a contracepção. Porém, como discutido no capítulo anterior, os(as) profissionais falam sobre a importância de se proteger e usar o preservativo peniano porque existem infecções, mas

também não aprofundam mais sobre estas nas consultas com as jovens. Quando eu perguntei às jovens se na consulta dialogavam sobre ISTs, elas respondiam que “Era mais pegar a receita para a injeção mesmo.” (Fabiana, sem experiência reprodutiva).

Pude acompanhar apenas uma consulta em que uma jovem foi à US procurando entender mais sobre ISTs. Segue trecho do diário de campo:

Foi uma sorte minha, um achado eu estar na sala do JP naquela hora. Foi a primeira consulta até então que alguém veio para conversar sobre sua saúde sexual sem estar com algum problema físico. Foi uma conversa muito agradável para ambos: ele tirando dúvidas dela sobre sentir dor na relação, conversando sobre tipos de contraceptivos e sobre cuidados para evitar ISTs. Todas as dúvidas partiram dela. Ela saiu bem feliz da consulta, aparentemente. Ela agradeceu bastante e disse se sentir mais segura para suas relações agora. Quando ela saiu, JP virou pra mim com uma cara toda feliz e animada: “Nossa, foi muito legal, né? E nunca tinha visto uma consulta dessas antes.” Fiquei pensando o quanto isso era atenção primária em saúde, o quanto isso era promoção e prevenção que tanto se fala que seria importante, mas quase nunca acontece (Diário de campo).

Aqui, pelo espanto e felicidade genuína do médico, percebemos como é raro ele ter esse tipo de atendimento, sendo que nunca nenhum(a) profissional destacou algum atendimento neste sentido para jovens homens. Aqui, temos uma discussão de gênero a ser realizada como alguns(as) dos(as) próprios(as) profissionais da US, destacando que o homem não tem a cultura de cuidar de sua saúde.

Na US não há nenhum tipo de trabalho de promoção e prevenção da saúde no que tange às ISTs atualmente, logo, o diálogo acerca deste tema fica a cargo do(a) jovem procurar a US e este(a) não procura com frequência, como já vimos. E, mesmo quando o(a) jovem procura, não é acolhido(a) com informações sobre quais são as ISTs, o que causam, como se prevenir, tratamento, entre outras.

Aqui, no cotidiano da US no que se refere às ISTs não destacamos mecanismos de governança reprodutiva como ocorreu na escola com professores falando que os(as) jovens não devem ter relações sexuais para não adquirirem doenças ou engravidarem. Na realidade, o que destacamos é a falta de discussões sobre ISTs na unidade para além do tratamento da infecção que o(a) jovem possui.

Se olharmos para os marcadores sociais da diferença, no caso dos(as) profissionais, o enfermeiro Rafael e os três médicos destacaram ao longo das suas entrevistas que, quando atendem jovens mulheres relacionadas às IST, percebem que elas ficam constrangidas, mas isso não costuma acontecer, visto que são poucas mulheres e no acolhimento as técnicas já

costumam direcionar para outras profissionais. O mesmo acontece com as quatro enfermeiras e uma médica que entrevistei ao atenderem jovens homens.

Salvo estas relações de gênero, podemos citar que a questão da proximidade entre usuário(a) e agente influencia nas discussões sobre prevenção das ISTs. Ella, jovem entrevistada de 17 anos, que relatou ser atendida com maiores explicações, pois tinha uma relação aproximada com a profissional médica, porém na US nenhum(a) profissional destaca ter afinidade com algum(a) jovem, até porque a rotatividade de funcionários(as) é espantosa.

Ainda, trouxemos a questão da entrevista do enfermeiro Rafael e o fator da idade como um marcador importante, onde o profissional não seguiu as diretrizes do SUS do atendimento individualizado. Não tive acesso a mais casos como esse, sendo que o que os(as) profissionais trazem para mim em conversas informais são julgamentos acerca dos(as) jovens terem ISTs, pois: “Não sabem se cuidar” (Tec. Enf. Daniela), “Só transam sem camisinha” (Tec. Enf. Renata).

Os(as) profissionais destacam as jovens como “não quererem muito nada com nada”, “não prestam muita atenção”, “ficam de risadinha”, “não entendem muita coisa”. Percebo que essa categorização afeta diretamente na falta de uma atenção maior e uma melhor explicação aos jovens, tanto homens quanto mulheres quando veem a US para tratar de ISTs. Para além disso, formula-se uma visão dos(as) jovens como “desinteressados”, o que acaba respingando na fala da enfermeira Camila quando diz que não acha uma boa fazer um grupo sobre planejamento familiar porque “as jovens não vão aderir”.

A partir das conversas com os(as) jovens vimos que independente do gênero, eles(as) acessam pouco a US para tratar da sexualidade, inclusive IST. A falta de conhecimento das próprias jovens com experiência reprodutiva escancara a falta de diálogo acerca das infecções dentro da unidade. Independente de ser homem ou mulher, ter 16 ou 20 anos, ter filhos(as) ou não, ser preto(a), pardo(a) ou branco(a), camadas populares ou com um maior poder aquisitivo (o que são raras exceções), os(as) jovens com quem conversei que frequentam a US destacam o mesmo tipo de tratamento que se resume a inexistência de informações maiores sobre as ISTs, e o discurso de “use camisinha para se proteger”.

Se os espaços para diálogo acerca de ISTs são escassos dentro das escolas e na unidade de saúde, o(a) leitor(a) já deve imaginar que discussões sobre orientação sexual ou prazer sexual, por exemplo, sejam ainda mais envoltas por pânico morais e regimes morais do que as conversas sobre infecções. É o que veremos a seguir.

10. “NÃO TEMOS ESSAS DISCUSSÕES SOBRE SEXUALIDADE AQUI”

A frase que dá título a esse capítulo é a resposta do professor Gabriel ao meu questionamento sobre terem discussões acerca da sexualidade para além de contracepção, reprodução e prevenção de ISTs. Tanto nas escolas quanto na US, os(as) profissionais dizem que não há espaço para tratar da sexualidade e os(as) alunos(as), em sua grande maioria, reafirmam o que estes(as) profissionais destacam: falta de discussões sobre saúde sexual e até mesmo saúde reprodutiva nesses dois ambientes.

Nossa pergunta de pesquisa se refere a como os agentes de saúde e de educação abordam a saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens em seus trabalhos e como estes cotidianos revelam mecanismos de governança reprodutiva. Até aqui, falamos dos três aspectos que mais apareceram na fala de jovens, professores(as) e profissionais da US por ordem de relevância, segundo os três grupos de pessoas participantes da pesquisa: gestação, contracepção e ISTs.

Todavia, tratar da saúde sexual e reprodutiva vai muito além destes três pontos, como destacamos já na introdução, sendo que ter saúde sexual significa poder expressar sua sexualidade sem riscos à saúde física e psicológica. Ainda, é ter acesso às informações de qualidade sobre sexualidade no que tange orientação sexual, contracepção, ISTs, prazer sexual, violência sexual e discussões de gênero.

E, como saúde sexual e saúde reprodutiva estão interligadas, uma acaba influenciando a outra. Entendemos por saúde reprodutiva o direito de decidir ou não gestar, quantas vezes e das formas que desejar, bem como ter acesso aos serviços e às informações corretas para realização do planejamento familiar. Também cuidados durante a gravidez, parto e puerpério, tendo os direitos da pessoa garantidos.

Logo, entendemos que a SSR abrange mais do que vimos até então na tese, como acabamos de destacar: orientação sexual, violência e coerção sexual, prazer sexual e discussões de gênero que cercam todas as discussões sobre SRR. Este capítulo observará os silêncios em relação a estes temas e como, na realidade, eles nos dizem muito sobre como a SSR é tratada no âmbito da educação e saúde.

10.1 ORIENTAÇÃO SEXUAL: “MELHOR NÃO FALAR”

Sempre que perguntava para os(as) jovens se eles iriam até a US para tratar de sua sexualidade, eles riam e falavam que nunca iriam ou que, caso fossem, não atenderiam eles lá

para falar disso. No meu tempo em campo na US, não presenciei qualquer cena exatamente no contexto de negativa de atendimento acerca da sexualidade, mas da forma com que é abordada a contracepção e o cuidado com ISTs na unidade, eu acho bem plausível que isso ocorra. O mesmo destaca o médico JP:

Porque eu já ouvi relatos de pacientes que foram, sei lá, foram maltratadas no acolhimento, na administração de medicamento, na vacina, sabe? Com piadinhas debochadas: “Na hora de fazer, na hora de engravidar foi bom, agora tu não quer tomar injeção?” Umas coisas assim, sabe? Querendo ou não acaba que os próprios profissionais, às vezes, jogam contra as políticas de saúde. Aí tu pensa: se uma jovem que tá grávida, que tá ali pra tomar uma medicação é tratada assim, eu entendo esse jovem que só quer ir falar sobre sexualidade (Med. JP).

O médico aponta para os valores morais das técnicas de enfermagem para com as jovens, sendo que o acolhimento é a porta de entrada na US, ou seja, as técnicas são as primeiras pessoas com quem os(as) jovens dialogam. Se são mal atendidas no acolhimento, os(as) jovens ficarão com uma relação desgastada com o serviço. E é justamente isso que a maioria destes(as) fala sobre o atendimento na US: demora muito e são “deseducados”, “atendem de má vontade” (Fabiana, sem experiência reprodutiva).

Entrevistei somente um jovem que se considera gay, Fabrício, e este relatou nunca ir a US falar sobre sua sexualidade, que foi se descobrindo sozinho e que não se sentiria à vontade para buscar apoio na escola ou na Unidade. A maioria dos(as) jovens fica apavorado quando eu falo sobre ir na US discutir sobre aspectos relacionados à saúde sexual “Não, né, Sora, não viaja.” (Fernando, sem experiência reprodutiva) ou “Nunca, nunca.” (Amanda, sem experiência reprodutiva).

Em conversas no cotidiano da US com o enfermeiro Rafael, ele disse: “Não tem espaço mesmo pros jovens no posto, não tratamos disso aqui.” se referindo à sexualidade de jovens. Eu tive acesso a exemplos de diálogos sobre orientação sexual na US somente a partir de algumas falas de enfermeiro e enfermeira de um ou outro caso escasso que já atenderam.

Para esta falta de discussões temos vários aspectos a serem levados em consideração: falta de formação dos(as) profissionais das escolas e US, pouca abertura para discussões sobre a orientação sexual na escola e também na US. Ainda, na US, temos a demora nos atendimentos e a falta de um acolhimento, falta de tempo e espaço para discussões acerca da sexualidade no serviço. Como disse a enfermeira Olívia: “Tem que colocar prioridades e saúde sexual dos jovens não é uma aqui.”

Aqui, podemos voltar nosso olhar para a noção de regimes morais de Morgan e Roberts (2012) e de pânico moral de Bozon (2012) que tratam a sexualidade juvenil como sexualidade

de risco, como “imoral”. Existe uma espécie de medo da maioria dos(as) profissionais ao tratar de escolhas sexuais na US, assim como na escola. Mas, para além disso, olhamos para a falta de tempo dos profissionais em suas consultas ou em sala de aula, falta de formações específicas sobre a temática e o próprio contexto social e cultural que estão inseridos, que, como já vimos, destaca a sexualidade como um tabu.

Ao olharmos para os marcadores sociais da diferença vemos que independente da raça/cor, camada social, nível de escolaridade, idade e/ou gênero, nenhum(a) dos(as) profissionais de saúde procura tratar da sexualidade juvenil. Estes(as) apenas atendem àqueles(as) que vierem até eles(as) para dialogar, o que, como vimos, ocorre em pouquíssimos casos.

Já para quem frequenta a US, os marcadores também não trazem diferenças em relação ao acesso do serviço e à discussão acerca da sexualidade: independente de raça/cor, camada social, idade ou gênero, o serviço de saúde não é procurado para tratar da sexualidade, orientação sexual ou identidade de gênero.

No que se refere à educação, a BNCC destaca como uma das competências do Ensino Fundamental, nas aulas de Ciências, a discussão de “argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).” (BNCC, 2017). Na BNCC do Ensino Médio não aparece nenhuma menção à saúde sexual e reprodutiva, sendo que a omissão de termos como "gênero" e "orientação sexual" acaba por afastar ainda mais as discussões sobre sexualidade em sala de aula. Novamente, regimes morais e pânicos morais interligados à onda de conservadorismo no País (Brandão, Cabral, 2023).

O que tem-se no sentido da sexualidade é a renovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, promulgadas em 2018 com a “XV - promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos à raça e à etnia, à religião, ao gênero, à identidade de gênero e à orientação sexual.” (Brasil, 2018, p. 13). O Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio (RCGEM) publicado pelo Governo Estadual em 2021 também aponta para a importância de discussões acerca da sexualidade em sala de aula. Porém, como vimos, nenhum(a) profissional fez referência a estes documentos no seu cotidiano ou nas entrevistas.

Logo, em se tratando das escolas, a sexualidade dos(as) jovens também não tem espaço para discussão, seja abordando a orientação sexual ou identidade de gênero. Como já vimos, os professores e a professora no Ensino Médio, quando, e se, tratam de temas referentes à sexualidade, o fazem num esquema biologicista sem apontar para aspectos relacionados à orientação sexual e muito menos à identidade de gênero. Como os(as) alunos(as) me falavam,

eles(as) não entendem, em sua grande maioria, a escola como um local que se sinta confortável para abordar sua sexualidade.

O professor Ricardo me relatou de uma atividade que buscou fazer, envolvendo sexualidade para além da reprodução humana, ainda com uma turma do oitavo ano, visto que no Ensino Médio ele não aborda essa temática:

Tu tem essa parte de reprodução humana que tu fala das doenças, fala ali e depois tem uma parte de sexualidade e que é muito amplo. Quando tu vai pesquisar, tu vê que é muito amplo. E o aluno veio com histórias de ideologia de gênero, não sei o que. Eu até dei opção: “ah, tu não quer fazer o trabalho não faz. Se tá te afetando tanto fazer o trabalho, não faz o trabalho, não vou te botar na lata.” Só olhando lá pra saber de que que era o trabalho, não me lembro, faz três anos isso aí, né? Mas eu pesquisei esses textos que eu queria comentar: é um negócio assim, mostra um leque de... sabe, tu vai falar sobre sexualidade daí tu vai pesquisar e daí tem sexualidade aí relacionada com a política, com o sexo em si, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um negócio assim, muita coisa, relacionada a tudo da tua vida. E não só necessariamente o sexo, entendeu? E não só a sexualidade: ah, tu é gay, tu não é, tu é mulher, tu é homem (Prof. Ricardo).

Em outro momento de conversa, na escola, o professor Ricardo havia me falado deste trabalho, mas não se recordava como exatamente tinha sido a organização da atividade. O que ele afirmava com certeza é que não trabalharia mais a temática porque “era muito difícil”, “deu problema com uns alunos” e “melhor não falar” (Prof. Ricardo). Ou seja, melhor o silêncio uma vez que a própria comunidade em que a escola se insere possui pânico morais em relação à gestação na juventude.

A outra professora que teve um relato referente a algo que poderia se aproximar de uma discussão sobre diversidade sexual e orientação sexual foi a professora Monique:

Teve um caso uma vez, até foi bem engraçado, do beijo grego, que eles queriam saber. E daí a gente fez uma aula mais explicativa do que consistia. E eu não sei, alguns eram a favor, outros eram contra. E então a gente fez uma dinâmica, né, bem engraçada, porque alguns realmente nem sabiam o que que era. E outros, maior preconceito assim, sabe, contra. Então, realmente, essa parte da Biologia, que eu digo, a sexualidade, **ela é pros fortes, né?** Não é qualquer um que consegue trabalhar isso. Porque a aula tem que saber muito bem dominar a aula, porque senão vira uma bagunça. E isso foi um dos temas, assim, que mais eu tive dificuldade para manter o foco. **Hoje eu não, sinceramente, vou te ser bem sincera, que faz tempo que eu não faço isso.** Porque a gente não entra nesse assunto, sabe? Ninguém entrou no assunto e eu realmente deixei meio de lado, assim, porque causa uma estranheza neles, sabe? Tem alguns que são evangélicos que saem da sala quando começamos, assim, sabe, que pedem pra sair. A gente respeita, mas eu fico com pena porque muitos deveriam escutar até pra poder, né, saber, se cuidar, saber. Mas tem uns que não fazem questão (Prof. Monique, grifo nosso).

Então, esta questão surgiu a partir da dúvida dos alunos e não de uma discussão organizada pela professora para tratar de orientação sexual ou, quem sabe, algo relacionado à identidade de gênero. Ela segue destacando que “faz tempo” que não aborda nenhuma dessas questões, em sala de aula, apesar de ela relatar que segue os PCNEM para organizar suas aulas e nestes consta tratar das questões relativas à sexualidade, envolvendo suas formas de expressão, gênero e relações amorosas entre jovens (Brasil, 2015).

Aqui, a professora destaca a questão da religião e este é um marcador social que, diferente de minha hipótese inicial, apareceu poucas vezes nas falas dos(as) profissionais da escola, não demonstrando ser um impeditivo para abordarem contracepção, reprodução e ISTs em sala de aula, até porque a discussão ocorre apenas no aspecto biologicista. Ao fugir da alçada estritamente biológica, Monique traz a religião retomando os discursos de regimes morais, pânico moral e conservadorismo.

Em conversas com professores(as), não só os de Biologia, e diálogos com ACS, técnicas de enfermagem, enfermeiras(os) e médicos(as), a religião não é algo que se sobressai. No geral, estes(as) profissionais apontam que são mais alguns pais que são religiosos, mas que entre os(as) jovens não é comum a prática religiosa.

Como já destacado no capítulo em que falamos no território, a técnica de enfermagem Ana revelou que algumas mães são contra o uso de contracepção devido à religião, mas não é algo recorrente na fala das outras profissionais na mesma função. Apenas um jovem, Emanuel, destacou em entrevista que devido à sua religião evangélica, ele não tem relações sexuais, namora ou beija outras pessoas. Algumas outras entrevistadas destacaram serem de alguma religião, mas não que ela tivesse qualquer interferência na sua vida amorosa, saúde sexual e saúde reprodutiva.

Voltando à escola, a professora Monique relembra um educador de História que já atuou neste ambiente e abordou a questão do beijo grego ao ser questionado por um aluno. E o professor comentou, segundo ela: “Não é assunto para uma aula de história.” Ela destacou que na realidade seria para todas as aulas, mas “às vezes não tem esse entendimento, esse entendimento para eles é só realmente quando a professora de Biologia chega e conversa sobre isso.” (Prof. Monique). Aqui, sabemos que este é o próprio entendimento da direção da escola em que ela trabalha, bem como da outra em que fiz parte de minha pesquisa ao, desde o início da minha entrada em campo, me direcionarem somente para os profissionais de Biologia.

Ao olharmos para os marcadores sociais da diferença entre professores e professora de Biologia, vemos que o único marcador que diferencia os(as) profissionais das escolas é o

gênero, mas a partir dele não notamos mudanças na forma de abordar a orientação sexual, visto que dois professores não abordam e o professor Ricardo e a professora Monique já trataram em algum momento da temática da orientação sexual, mas desistiram devido a ser “muito complicado” (Prof. Ricardo).

No que tange os marcadores sociais da diferença na fala de jovens, percebemos que as jovens da escola B estão mais inclinadas a buscarem apoio na professora Monique enquanto o mesmo não acontece com os alunos. Aqui temos novamente a relação de gênero como uma barreira ou uma aproximação entre professor e aluno.

No que se refere às falas dos(as) jovens acerca de ensinamentos sobre sexualidade, por parte de professores(as) nas escolas, independente do gênero, idade, raça/cor, camada social ou território, os(as) estudantes destacam que essas discussões não acontecem. E, pela fala dos(as) jovens, também não ocorre em suas casas, sendo que dialogar com amigos(as) é o mais seguro, apesar de ali mesmo alguns(as) relatarem que não se sentem confortáveis para tanto, falando que ainda é um “tabu”. Já ter tido experiência reprodutiva também não é um fato que aponta para os(as) jovens terem algum tipo de conhecimento sobre orientação sexual ou identidade de gênero.

Logo, tanto na US quanto nas escolas A e B, a falta de discussões acerca das escolhas sexuais, identidade de gênero e relacionamentos, para além do espectro heterossexual da binaridade homem cisgênero e mulher cisgênero, são gritantes. Aqui, não destacamos nenhum mecanismo de governança reprodutiva, mas diríamos que existem micromecanismos de omissão da sexualidade, e uma forma de reproduzir o discurso da heteronormatividade que estão presentes nas falas nas escolas e US. Estes(as) profissionais são envolvidos ainda pelo pânico moral em torno da sexualidade juvenil e por regimes morais que apontam para a heteronormatividade tanto diante de seus atendimentos na US como ao falarem, na escola, apenas sobre o uso de preservativo peniano.

10.2 VIOLÊNCIA E PRAZER SEXUAL

Quando se trata de violência sexual na juventude, as enfermeiras e médicos relatam não receber casos deste tipo na US, mas também nunca dão uma abertura nas consultas com jovens para falar sobre consentimento, violações e abusos, o que, certo dia, a enfermeira Polina disse que lhe preocupava, pois ela acredita que existe um número muito maior de mulheres que sofrem violências do que aquelas que ela recebe na Unidade.

Das quinze jovens que eu entrevistei, sete delas já sofreram algum tipo de violência sexual. Uma das entrevistadas me relatou o seguinte:

É que uma vez, né, eu vi um caso muito, muito louco na televisão de uma mulher que ela disse que foi abusada, né. Mas ela falou, né, como é que foi e tal. E, tipo, o marido dela queria fazer com ela. Só que ela tava dormindo. Aí eu achei bem, assim, bem louco, assim. Eu não sabia. Eu soube depois que era violência. Depois de que eu vi o caso dela no Instagram. Eu fiquei pensando, assim, nossa, achei bem interessante. Daí várias outras mulheres começaram a falar também porque elas não sabiam também (Heloá, com experiência reprodutiva).

A jovem gestante tinha 16 anos na época da entrevista e não sabia que relação sexual sem consentimento da outra pessoa, independente de ser namorado, companheiro e/ou marido, era uma violência sexual. E quantas outras jovens também não sabem, pois nunca tiveram acesso a essas discussões em lugar nenhum?

Na Biblioteca Virtual de Saúde, que é base para os(as) profissionais de USs de Porto Alegre, no que se refere à violência, há duas diretrizes que tratam de orientações para profissionais dos serviços de assistência social, saúde e educação em como proceder para assegurar a segurança dos(as) jovens, mas nenhum(a) funcionário(a) da US chega a citar estes. Nos protocolos de Pré-Natal e de Saúde da Criança e do Adolescente (Porto Alegre, 2024a, 2024b), temos menção à violência no sentido dos(as) profissionais ficarem atentos aos sinais e o que devem fazer caso sejam identificados.

Na escola, se tratar das escolhas sexuais de jovens é um grande tabu, quem dirá falar sobre violência. Na BNCC não há referências à violência sexual e nunca um professor ou a professora chegou a tratar dessa temática durante o ano que estive acompanhando as escolas A e B. Os(as) alunos(as) já me falaram diversas vezes que a escola deveria tratar da violência sexual “principalmente pros mais novinhos, pra eles é muito importante porque muitas vezes não sabem e o abuso vem de casa.” (Ana Luiza, sem experiência reprodutiva).

Aqui, independente do gênero do(a) jovem, de ter experiência reprodutiva, da idade, da raça/cor, camada social ou até mesmo religião, a violência sexual nunca é discutida. O mesmo ocorre com os(as) profissionais da US e escolas: invariavelmente, nenhum(a) deles(as) fala sobre violência sexual, seja professor, professora, médico(a), enfermeiro(a), técnica de enfermagem ou ACS.

Já no que se refere ao prazer sexual, também não existem diálogos em US ou em escolas. Não há referência na BNCC do Ensino Médio ou PCNEM acerca do prazer. Já foi citado no capítulo sobre a contracepção e a pergunta da jovem para mim durante palestra na faculdade de

Medicina da PUCRS, questionando se não era normal ter dor durante a relação sexual. Expliquei para ela que não era normal, que ela deveria procurar o serviço de saúde e ela me referiu ter vergonha. Eu incentivei ela e dias depois a mesma voltou animada me contando que tinha ido e tinha sido uma conversa bem acolhedora.

Outro momento a ser destacado, e que se refere ao prazer sexual, foi retirado do meu diário de campo:

Ao final da roda de conversa com o primeiro ano, uma menina se aproximou timidamente de mim e me pediu: “Profe, teve uma coisa que eu não entendi que você falou. Começava com li, liri...” Enquanto ela se esforçava para lembrar, eu tentei entender ao que ela se referia e falei “Libido?” E ela: “Isso, isso daí. O que é isso?” Então fiquei um tempo conversando com ela sobre o que era e destacando questões relacionadas ao prazer sexual. Me vi muito naquela jovem, pois eu fui ouvir falar sobre libido com 18 anos, mas queria que ela já tivesse ouvido em outro lugar que não apenas comigo. E quantas outras jovens não sabem que o prazer sexual é um direito delas na relação? (Diário de campo).

Este fato me lembra do diálogo com a supervisora e a diretora da escola A no turno noturno assim que fui apresentar minha pesquisa. Uma delas disse: “Ai, tu vai falar sobre prazer sexual feminino também? Ia ser tão importante e ninguém nunca fala com elas.” Realmente, ninguém nunca fala sobre, em ambas as escolas, e na US também não se discute a temática.

Nos documentos que se encontram na BVAPS, o Protocolo de Pré-Natal destaca que na anamnese da paciente na abertura de pré-natal deve-se: “Abordar as questões referentes às parcerias, à identidade de gênero, à orientação sexual e à satisfação sexual pessoal e/ou do casal” (Porto Alegre, 2024a, p. 136), o que não vi acontecer na prática em nenhuma das consultas que observei.

No serviço de saúde, o que aparece são relatos de profissionais acerca de mulheres com mais de 30 anos que confessam durante a consulta que sempre tiveram dor nas relações sexuais e nunca antes tinham se sentido confortáveis para falar sobre. JP (2024) destacou: “Imagina se essas mulheres adultas não sabem que o sexo não deve doer, quem dirá as jovens.”

A enfermeira Polina apontou que “Não, as gurias não falam sobre isso, o que às vezes as mulheres mais velhas, assim, ali, menopausa e tudo mais, que começa aquela baixa lubrificação, ou tá fazendo CP e tem uma dor, aí elas conversam sobre isso, mas as gurias novinhas é um tabu.” (Enf. Polina). Mas será que também ela mesma enquanto profissional de saúde não contribui para este “tabu”? Regimes morais e pânico moral aqui presentes.

Segundo a ACS Fernanda, quando questionada acerca de jovens vindo à US tratar de sua sexualidade, ela apontou: “Mas muito pouco, assim porque o jovem já tem essa questão,

assim, desse distanciamento com a saúde, que é isso que eu te falei. Acaba que a figura nossa não acolhe eles, não aproxima eles. E a gente também não faz nada pra que isso fique diferente.” (ACS Fernanda).

E novamente nenhum(a) dos(as) jovens, mesmo as jovens que me destacaram que já sofreram violências sexuais - destacaram que foram estupradas - , falaram que foram até a US ou que compartilharam com algum professor(a) na escola sobre o ocorrido. Nenhum(a) profissional investiga sobre possíveis violências, tanto na escola quanto na US, independente de ser homem ou mulher.

Nestes exemplos aqui, temos a atuação do micromecanismo de omissão da sexualidade e temos uma relação forte dessa omissão com o fato da falta de relacionamentos construídos entre profissionais de saúde e da educação e os(as) jovens: como uma jovem vai ter coragem de falar sobre um caso de violência sexual, que sofreu, se nunca viu antes a enfermeira que atende na US? Ou quando só tem uma vez por semana aula com o professor x?

10.3 GÊNERO: QUASE COMO UMA PALAVRA PROIBIDA

No que se refere à educação, a BNCC, como já discutimos, tirou de seu texto a palavra “gênero”. Apesar disto, documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Brasil, 2018) e o Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio (RCGEM) publicado pelo Governo Estadual em 2021 trazem a importância das discussões de gênero para a escola, porém, os(as) professores(as) não têm conhecimento destes documentos.

A única professora que não segue exclusivamente a BNCC, Monique, cita que trabalha a partir dos PCNs e apesar de lá constar tratar das questões relativas à sexualidade envolvendo suas formas de expressão, gênero e relações amorosas entre jovens (Brasil, 2015), ela não costuma abordar em sala de aula, pois acha que é melhor não fazê-lo, como já me disse durante uma conversa na sala de professores(as) e também durante nossa entrevista. Aqui, temos novamente o micromecanismo de omissão da sexualidade.

Os(as) alunos(as) não trouxeram, seja nas rodas de conversa, em entrevistas ou em conversas informais pelas escolas, qualquer discussão sobre gênero que tenha sido realizada nas escolas e que envolvesse a saúde sexual e reprodutiva. Se não falam em orientação sexual, prazer sexual e/ou violência sexual, era de se esperar que as discussões sobre gênero também não acontecessem.

No que se refere às discussões sobre gênero na US, no final de 2024, foi lançado o Protocolo de Saúde da Criança e do Adolescente que aborda a liberdade de identidade de gênero dos(as) jovens. O mesmo acontece no Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual onde se destaca a importância de “Abordar as questões referentes às parcerias, à identidade de gênero” (Porto Alegre, 2024b, p. 135). Nenhum destes protocolos é seguido por qualquer profissional independente de seu gênero, raça/cor, experiência reprodutiva, idade, escolaridade, camada social ou território em que vive. Porém, como já vimos, essas discussões sobre diferentes parcerias e identidade de gênero não são feitas. Novamente, micromecanismos de omissão da sexualidade.

As discussões de gênero são centrais para que se tenha acesso à saúde sexual e reprodutiva plena, mas não acontecem na US ou nas escolas. O que acontece, como já vimos, é a utilização de mecanismos de acumulação reprodutiva feminina por parte dos(as) agentes onde é normal “o pai sair para comprar cigarro e não voltar” e micromecanismos de omissão da sexualidade, onde se foca apenas no binômio homem cis e mulher cis.

Neste caso, as jovens seguem cercadas de discursos que pregam a mulher como cuidadora e responsável principal pela contracepção e possível futura gestação, enquanto que “a gente sabe que o homem amadurece depois, entende mais tarde o que é ser pai e tem o jeito dele de cuidar que nem sempre é tão bom, mas é porque ele está aprendendo.” (ACS Carolina), como disse a ACS durante uma atividade do Grupo de Gestantes da US.

Nos poucos atendimentos de jovens homens na US acerca de ISTs, se fala sobre a importância do preservativo peniano para evitar ISTs e não para evitar a gestação como é feito com as jovens. Ainda, não se citam nunca outras formas de contracepção reafirmando o papel da mulher no cuidado com que método usar e na necessidade dela conhecer as possibilidades de prevenção.

Assim, a gravidez não é colocada para os jovens homens, como um problema, da mesma forma que é no atendimento das jovens que estão iniciando a contracepção ou em outras consultas acerca de ISTs. Para os jovens que acessam a US procurando cuidados referentes a ISTs, apresenta-se um discurso de cuidado com as doenças, enquanto que para as jovens é de cuidado com a gravidez. Ou seja, micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Não há discussões sobre responsabilização dos jovens acerca do uso de preservativos e da gestação, tampouco na escola, onde um professor em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio chegou a dizer que as alunas têm responsabilidade em escolher um parceiro que não vai abandoná-las.

Estas jovens sentem o peso da responsabilização, que se expressam em suas falas: “Eu não fiz sozinha, mas eu tive que criar sozinha”, me disse certo dia uma jovem de 18 anos, que foi mãe aos 14, e agora está concluindo o Ensino Médio sem ter tido um auxílio sequer do pai da criança.

O silenciamento das discussões de gênero, como vimos, estão colocadas no documento da BNCC, mas não nos protocolos de saúde da US. Porém, tanto em escolas quanto em US, não se têm discussões mais aprofundadas sobre gênero, pelo contrário: são reforçados padrões patriarcais em que o cuidado para não engravidar, durante a gravidez e após é colocado como problema feminino. Vemos aqui o micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina, que se forma a partir dos regimes e moralidades dos(as) profissionais, mas também da própria estrutura da sociedade patriarcal, machista e sexista que vivemos. Novamente, nós chamamos a atenção para o fato de que o contexto social e cultural em que o agente atua é central para a utilização dos micromecanismos.

11. “SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA? AH, SORA, TU VEIO FALAR SOBRE GRAVIDEZ, NÉ?”

A frase que dá título a este capítulo foi dita por uma aluna da escola A, Gabriela, após eu ter falado algo como o seguinte: “Eu vou começar a acompanhar as aulas aqui na escola, pois estou estudando sobre saúde sexual e reprodutiva. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar sobre?” (Bárbara). Então eu fui apontando para as estudantes que a saúde sexual e reprodutiva era muito mais que apenas gravidez, que se referia também à orientação sexual, ao prazer sexual, à violência, às discussões de gênero, ao uso de métodos contraceptivos, às infecções sexualmente transmissíveis, dentre outros.

Pelo que vimos nos capítulos anteriores que mostraram a realidade das escolas e da US no que tange a saúde sexual e reprodutiva, não é de se impressionar que Gabriela se focaria justamente na gestação ao me responder sobre o que era SSR. Como vimos, tanto profissionais da US quanto das escolas tratam a gestação na juventude como um problema que deve ser evitado a todo o custo, ficando discussões sobre ISTs e contracepção em segundo plano e discussões sobre outros aspectos da SSR fora do horizonte.

Neste capítulo, iremos buscar entender o porquê das discussões sobre SSR serem centradas na gestação, contracepção e ISTs durante o cotidiano de trabalho dos(as) agentes de saúde e educação, retomando a teoria que discutimos na primeira parte da tese. Iniciaremos falando justamente da implementação de políticas públicas, afinal, toda a tese se resume a este momento em que usuário(a) e agente de nível de rua se encontram - ou não - e interagem - ou não. Seguiremos abordando teoricamente cada um dos micromecanismos que utilizamos.

11.1 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E GOVERNANÇA

No segundo capítulo da tese iniciamos as discussões partindo de uma visão *bottom-up* da implementação de políticas públicas, tendo como fundamento Lipsky (1980) e suas reflexões acerca da burocracia de nível de rua (BNR), que se refere justamente à atuação das pessoas que trabalham diretamente com os(as) usuários(as) das políticas, entendendo que são estes(as) burocratas que fazem a política para além das leis e diretrizes que seguem, uma vez que possuem discricionariedade. Ao olharmos para a discricionariedade conseguimos visualizar o cotidiano das políticas públicas e como os(as) agentes alteram as mesmas, sendo que dentro de um mesmo

ambiente de trabalho, diferentes agentes podem implementar de maneira diversa uma política, o que pode resultar em políticas diversificadas (Lotta, 2010, 2015).

Diversos(as) autores(as) trabalham o conceito de discricionariedade em suas pesquisas (Lotta, 2010, 2022, 2015; Pires; Lotta; Junior, 2018; Assis, 2023; Fernandez; Guimarães, 2020; Oliveira, 2012, Ferreira; Medeiros, 2016; Bonelli et al, 2019, Lotta; Pires, 2020), apontando justamente para o fato de entender o que mobiliza os(as) agentes em seus cotidianos de trabalho, sendo aqui também importante olhar para a relação agente/usuário(a).

Buscamos também apoio nas leituras de antropologia das políticas públicas. Apesar deste campo não trabalhar com a noção de discricionariedade como o campo das políticas públicas faz. O campo da antropologia traz a centralidade das relações face a face, pois se entende que estas são muito mais do que documentos contendo regras e diretrizes: as políticas públicas acontecem na relação entre agente e usuário(a) e estão embrenhadas de valores, normas e moralidades destes sujeitos (Shore; Wright, 1997, 2011).

Ou seja, “De uma perspectiva antropológica, o que acontece na sala de reuniões do conselho executivo, na reunião do gabinete ou na assembleia geral anual dos acionistas, não é menos importante do que o que acontece ao nível do chão de fábrica ou da localidade” (Wendel et al, 2005, p. 34, tradução nossa). O mesmo ocorre na perspectiva do campo de políticas públicas: Bartels (2014) indica que o processo e resultado das decisões dos(as) agentes depende da interação entre estes(as) e os(as) cidadãos(as). Bruhn e Ekström (2017) destacam que as ações de agentes deveriam ser vistas como “conquistas relacionais” (p. 199, tradução nossa), pois sempre dependem das interações que se estabelecem.

Logo, no cotidiano de implementação das políticas há fatores para além daqueles da norma e da regra oficiais das políticas, uma vez que os(as) agentes orientam suas ações, como destaca Zacka (2017), a partir de seus próprios valores e visões sobre aqueles(as) que estão atendendo e a forma com que se dá a relação.

Aqui, entendemos que os encontros entre implementador(a) e receptor(a) são moldados também a partir dos valores pessoais e das moralidades dos(as) agentes de nível de rua. Assim, o conceito de agência de Maynard-Moody e Musheno (2022) é central para nós. Para estes autores, os(as) agentes da linha de frente não se limitam a implementar políticas seguindo as regras. Em vez disso, atuam como agentes morais que fazem julgamentos com base em seus valores e crenças. Assim, a agência se dá nos microencontros e desencontros entre agentes, no nosso caso de saúde e educação, e usuários(as), aqui, jovens.

Na tese, o que buscamos fazer do capítulo seis ao dez foi justamente olhar para a agência dos(as) professores de Biologia da escola A e B, dos(as) médicos(as), enfermeiros(as), técnicas

de enfermagem e ACSs, e buscar entender como tal agência interfere nos beneficiários(as) finais da política, ou seja, como interfere nos acessos dos(as) jovens acerca da saúde sexual e reprodutiva nas escolas e unidade de saúde.

Nosso enfoque sendo SSR, trazemos para além do conceito de discricionariedade e agência, um conceito do campo da antropologia, que acreditamos que nos ajude a olhar para a implementação de políticas públicas no contexto específico da SSR: mecanismos de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012).

Já trouxemos no capítulo dois toda uma discussão sobre o termo governança e aqui vale frisar que a governança dá conta das estruturas formais e também do que Lynn, Heinrich e Hill (1999) chamam de exercício informal de julgamento dos(as) atores e atrizes envolvidos na implementação de políticas. No caso, as escolas e a US possuem seus protocolos de trabalho, como os protocolos de enfermagem, a BNCCEM e os PCNEM que regem os trabalhos dos(as) profissionais. Para além destas formalidades, temos a informalidade que aqui entendemos se dar através da agência.

Assim como entendemos que a governança também se dá através justamente da agência. Parte da literatura entende a governança num nível global, mas aqui estamos olhando para o nível local ou, como destacam Lynn, Heinrich e Hill (2000), o nível primário. Junto da noção de nível primário, temos a noção de mecanismos de governança (Crouch, 2005). Ao falar de comportamento, Crouch (2005) está falando de valores e normas que regulam a atuação dos(as) agentes de políticas públicas.

Logo, os mecanismos são construídos a partir de relações de poder que englobam normas e valores dos sujeitos em relação uns com os outros. No nosso caso, a sexualidade é um instrumento que regula, disciplina e normaliza corpos dentro da escola (Foucault, 1980) e na unidade de saúde.

Assim, chegamos ao conceito de mecanismos de governança reprodutiva de Morgan e Roberts (2012) que nos foi aqui essencial para entender como os(as) profissionais da saúde e de educação implementam as políticas públicas no cotidiano, no que se refere especialmente à saúde sexual e saúde reprodutiva.

As autoras Morgan e Roberts (2012) abordam os mecanismos de governança reprodutiva numa perspectiva voltada ao nacional e/ou global, mas aqui entendemos que também podemos olhar para o nível dos microencontros entre usuários(as) e agentes de políticas públicas. Nestes microencontros, como demonstramos ao longo da tese, é possível analisar os micromecanismos de governança reprodutiva que refletem diretamente nos compartilhamentos

- ou na falta deles - em sala de aula, nos corredores das escolas e nos atendimentos - ou falta deles - junto dos(as) jovens na unidade de saúde.

Na base das discussões sobre mecanismos de governança reprodutiva está a noção de regimes morais (Morgan, Roberts, 2012). Ela nos ajudou a entender os padrões de moralidade, que são usados para governar comportamentos íntimos, julgamentos éticos e suas manifestações públicas. Nesse caso, como a expressão já se refere, os regimes apontam para o que é “bom” ou “ruim”, “moral” ou “imoral”. No caso das discussões sobre saúde sexual e reprodutiva, elas estão entrelaçadas com os regimes morais (Silva, 2023).

Junto da ideia de regimes morais, temos a noção de pânico moral proposta por Bozon (2012), que se refere ao pânico moral adulto em relação às juventudes, aqui especialmente ligado à sexualidade, e aos referidos alarmismos sexuais. Ponto que vemos diariamente nas falas de professores(as) e funcionários(as) da US ao trazerem seus medos em relação à gestação na juventude, o que acaba influenciando naquilo que falam quando se trata de planejamento familiar, contracepção, ISTs ou em relação aos demais temas que envolvem a saúde sexual e reprodutiva.

Bozon também traz a noção de que a sexualidade juvenil é vista *a priori* como sexualidade de risco (Bozon, 2004), o que, mais de vinte anos depois de sua fala, seguimos percebendo nos discursos de professores(as) e agentes de saúde e que vai interferir na falta de discussões sobre sexualidade na escola e na US, bem como prejulgamentos acerca da necessidade de controle da sexualidade juvenil. Aqui, também é central as discussões sobre parentalidade e quem exerce um “bom” ou “mau” cuidado da criança.

Pânico moral e regimes morais são conceitos que consideramos chave e que perpassam todos os micromecanismos que relacionamos a seguir: contenção reprodutiva, coerção contraceptiva - este conceito foi criado por Senderowicz (2019) e remanejado por nós para trabalhar a partir da noção de mecanismos - acumulação reprodutiva feminina e vigilância reprodutiva.

Aqui temos que reforçar a antropologia das políticas públicas como um importante pilar não só teórico, mas também metodológico, ao destacar que o estudo da implementação das políticas públicas deve focar tanto no(a) agente quanto no(a) usuário(a), mas mais que isso, atentar para os momentos em que se relacionam. Assim, a observação de cunho etnográfico nos foi essencial para mergulhar no campo e estar num contato diário com profissionais e jovens ouvindo suas histórias e vendo na prática a política pública acontecer.

Magnani (2009) destaca que a etnografia é prática e experiência, que ela tem a possibilidade de fazer o(a) pesquisador(a) imergir em campo e retornar para a teoria com muito

mais propriedade, por ter estado e vivido lá. Essa proximidade de interação que eu acredito que me permitiu um diálogo muito aproximado com os(as) jovens nas rodas de conversa, nas entrevistas e no acompanhamento dos(as) agentes das escolas e US em seus cotidianos.

Logo, a etnografia é uma ferramenta que nos ajudou a olhar com mais clareza para os valores e moralidades que circulam os(as) agentes acompanhando e escutando diversos casos, que auxiliaram na construção da tese. Inclusive, a observação participante, ferramenta etnográfica aqui utilizada, também auxiliou na construção do roteiro das entrevistas, visto que estas só foram iniciadas após meses de acompanhamento dos(as) profissionais e jovens. Entender a organização das escolas e da US, a maneira que ocorre a gerência dos(as) profissionais, o local em que atuam, os recursos e estrutura que possuem foi central na estruturação das perguntas, por exemplo, acerca da parceirização para os(as) profissionais da US ou sobre os horários de saída de aula para os(as) professores(as) das escolas A e B. As narrativas dos(as) profissionais tanto durante as entrevistas quanto no cotidiano da escola A, B e US foram interpretadas, tendo em mente a noção de mecanismos de governança reprodutiva, a partir da análise de conteúdo de Bardin (2016).

Ainda, a antropologia das políticas públicas deu suporte para que olhássemos para o território além do espaço físico, mas pensando nas relações que ali se estabelecem, nas possibilidades de acesso ao lazer, à cultura, ao emprego, à educação, ao saneamento básico e tantas outras questões, que já discutimos ao longo do capítulo cinco e entendemos, que influenciam diretamente nas visões de jovens e agentes de saúde e de educação acerca da SSR e, conseqüentemente, na utilização dos micromecanismos de governança reprodutiva, como veremos agora.

11.2 APROFUNDANDO O ENTENDIMENTO DA AÇÃO DOS(AS) PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS E US

Nos capítulos anteriores trouxemos inúmeras falas de jovens, médicos(as), enfermeiros(as), técnicas de enfermagem, ACS, professores(as) acerca da gestação, contracepção, ISTs e outros aspectos da SSR - que, infelizmente, vimos que não são discutidos tanto nas escolas quanto na unidade de saúde.

Vimos ao longo da tese que os(as) profissionais de escolas e da US corroboram com o foco na mulher e na sua habilidade - ou não - de ser uma boa mãe, de ser “estruturada” e “organizada” e que, consideram que as jovens do território não são. E devido a esse julgamento, os(as) agentes irão se utilizar de micromecanismos diversos que veremos a seguir, ou seja, a

centralidade das políticas de família é uma das causas da utilização de micromecanismos de governança reprodutiva.

Antes de focar nos micromecanismos, que aqui utilizamos, analisaremos mais o contexto de atuação dos(as) profissionais a partir de autores do campo de políticas públicas, entendendo que estes fatores também influenciam na utilização dos(as) profissionais dos micromecanismos. Em seguida, veremos como se deu a construção de cada um dos micromecanismos que desenvolvemos tanto a partir da prática em campo - onde a antropologia das políticas públicas nos foi alicerce fundamental - quanto a partir de outros aportes teóricos do campo das políticas públicas e dos estudos da sexualidade. Ao mesmo tempo, buscaremos observar como os micromecanismos mudam o cotidiano de atuação dos(as) profissionais ou não.

11.2.1 Contexto de atuação dos(as) implementadores(as) de políticas públicas

Antes de olhar para os micromecanismos, devemos analisar o contexto de trabalho em escolas e na US, pois são fatores centrais para que profissionais se utilizem da agência e, por conseguinte, que os micromecanismos entrem em ação - ou não. A partir das leituras do campo de políticas públicas entendemos que importa olhar para o contexto social em que os(as) profissionais atuam, para as regras que regem o trabalho dos(as) profissionais, para a *accountability*, os recursos que os(as) profissionais têm a sua disposição (financeiros e de tempo), nas relações que estabelecem com usuários(as), na sua estrutura de trabalho, no modelo de gestão, nos fatores emocionais dos(as) BNR, nas categorizações que agentes fazem de usuários(as), para a discricionariedade, mas para além dela, analisar a agência a partir de normas e valores que os(as) funcionários(as) têm e utilizam ao realizar julgamentos dos(as) usuários(as) das políticas (Maynard-Moody; Musheno, 2022; Bonelli et al, 2019; Ferreira; Medeiros, 2016; Lotta, 2015; Lotta; Kirschbaum, 2022; Chang, 2022, Mikkelsen; Madsen; Baekgaard, 2024; Bonelli; Fernandes; Coêlho; Palmeira, 2019).

Primeiro, é importante falarmos sobre como o contexto em que se encontram as escolas e a US influenciam na agência dos(as) profissionais, e, por consequência, a atuação através dos micromecanismos. Hoje, o Brasil encontra-se inflado por uma onda de conservadorismo e visões que destacam a SSR juvenil como um tabu, sendo que o território onde foi feita a pesquisa não é diferente. Neste contexto, não é de se estranhar que os(as) agentes alertem às jovens a evitar a gestação, vejam a gestação como um problema, busquem que as jovens sempre

usem algum método contraceptivo, vigiem as jovens gestantes e não discutem aspectos relacionados à sexualidade juvenil para além do fator de evitar a gestação.

Já em se tratando das leis e normas que regem o trabalho dos(as) agentes, Lotta e Santiago (2017) apontam para a importância de observar a existência de regras e normas que podem ser muito abrangentes, conflituosas e/ou dicotômicas, o que leva o(a) agente de nível de rua a ter um nível maior de autonomia. Também, a importância de olhar para “elementos organizacionais, como a gestão, o controle, a relação de mando e obediência, a padronização de processos etc” (Lotta, Santiago, 2017, p. 25).

No capítulo seis apresentamos as normas e regras que regem o trabalho dos(as) BNR das escolas A e B e da US que acompanhamos e depois olhamos para como elas se apresentam em seus contextos de atuação. As normas e regras que os(as) professores(as) dizem seguir, no que se refere à SSR, são a BNCCEM e os PCNEM. A primeira delas faz referência apenas à possibilidade do estudo da reprodução humana, enquanto que a segunda destaca a importância de discussões acerca da sexualidade, mas sem dar grande atenção à temática.

Já no que se refere à saúde, os(as) profissionais apontam que seguem os protocolos que estão na Biblioteca Virtual da Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre para tratar da SSR juvenil. Na época em que estive em campo, dois protocolos tratavam de jovens em dados momentos: Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Infecções Sexualmente Transmissíveis e Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual. Ambos abordaram brevemente a sexualidade juvenil com informações que, para utilizar de Lotta e Santiago (2017) são muito abrangentes e pouco detalhadas sobre a juventude.

A partir das colocações de Lotta e Santiago (2017), destacamos nos ambientes escolares que os(as) professores(as) são pouco controlados(as) por gestão das escolas sem haver essa relação de mando e obediência, padronização de atuação e cobrança por resultados. Eles(as) seguem seus trabalhos sem normas claras e discussões com coordenação e supervisão, o que é propício para que os(as) profissionais tenham maior autonomia.

Já na US, a situação muda de figura com protocolos mais explícitos do que deve ser feito, maior controle do número de atendimentos realizados e da evolução das consultas feitas. Os(as) próprios(as) colegas têm acesso a estas informações pela plataforma de trabalho e atua-se, por vezes, numa espécie de “vigiar e punir”, principalmente quando há desgaste nas relações interpessoais dos(as) profissionais, o que já destacamos aqui fazer parte do cotidiano de trabalho da US.

Se olharmos para técnicas de enfermagem, elas respondem aos(as) enfermeiros(as), tendo uma relação clara de mando e obediência. Os(as) enfermeiros(as), por sua vez, não têm

de responder a alguém, hierarquicamente, dentro da Equipe de Saúde da Família, assim como os(as) médicos(as), porém, ambos(as) são chamados pela gerente para reuniões sempre que esta considerar necessário, além de terem junto ao hospital que parceirizou para a US um responsável técnico da enfermagem e um da medicina. As ACS têm uma reunião semanal com a enfermeira de suas equipes, mas tanto Fernanda quanto Carolina destacam que recebem ordens da prefeitura de Porto Alegre e não da gerente da US ou da enfermeira.

Assim, já vemos *accountability* diferente em cada um dos ambientes analisados (escolar e de saúde), sendo que os modelos de gestão também são diversos nos dois espaços. Ferreira e Medeiros (2016) já nos sinalizaram para a importância de olhar estes modelos para entender como se dá a implementação das políticas.

As escolas aqui analisadas são estaduais, mas com pouca interferência direta da Secretaria Estadual de Educação, como relatado em diversas conversas com direção das escolas e professores(as). Na US há uma gerente que é vinculada ao hospital, que tem o contrato de trabalho com a Secretaria de Saúde do Município, sendo que a última realiza mensalmente um *check-list* das atividades que vem acontecendo na US, mas que alguns(as) funcionários(as) afirmam que não é executado corretamente, uma vez que diversos problemas na estrutura, nos recursos e na atuação de colegas se mantêm.

Essa falta de um olhar mais atento da Secretaria de Saúde e de Educação para os(as) agentes e, inclusive, para a temática da SSR, também é um ponto que nos ajuda a entender o porquê de os(as) profissionais fazerem uso dos micromecanismos da forma que fazem: eles(as) não têm apoio para trabalhar a SSR através de um aprofundamento das discussões teóricas, em torno da identidade sexual e/ou do prazer sexual, por exemplo.

No que diz respeito aos recursos, Chang (2022) criou um modelo formal teórico para explicar o comportamento dos BNR a partir de princípios econômicos e institucionais. Aqui, não iremos aprofundar este modelo, mas entendemos, assim como Chang (2022), que o trabalho dos(as) profissionais necessita de uma alocação estratégica de tempo e recursos, baseada em custos de atendimentos, das recompensas institucionais e normativas e da autonomia e restrições institucionais.

No que se refere às escolas, os(as) professores(as) de Biologia têm tempo e recursos financeiros escassos. Nestes locais, as trilhas de aprendizagem ocupam horários de aulas que antes eram de conteúdos como Biologia, Física, História, entre outros. Vimos o exemplo do professor Felipe que trabalhou sobre sexualidade no terceiro ano do Ensino Médio apenas com uma turma, pois na outra ele tinha somente um horário de Biologia por semana e, segundo ele, tinha que priorizar outros conteúdos.

No caso do professor Ricardo da escola B, ele possui apenas um período de Biologia por semana com uma turma do segundo ano do Ensino Médio, mas este é alocado no último período de aula da manhã, sendo que a aula normalmente não ocorre devido ao término mais cedo do dia letivo, pois professores(as) faltaram e/ou alunos(as) são liberados antes para irem ao trabalho. Até novembro de 2024, o professor não havia dado uma aula de Biologia naquela turma durante o ano. Ou seja, os(as) professores(as) não têm tempo hábil para tratar da SSR em sala de aula. Por isso também utilizam os cinco micromecanismos que vimos ao longo da tese.

Os professores e a professora também não recebem recompensas institucionais por, por exemplo, terem a maioria dos(as) estudantes com conceito elevado de desempenho no boletim escolar, e, como já vimos, têm muita autonomia e pouquíssimas restrições. Estes fatores são importantes para entendermos como os(as) profissionais conseguem exercer sua ação discricionária e sua agência. Por exemplo, se não há recurso financeiro para a compra de um molde de vagina e pênis para trabalhar com os(as) alunos(as) nas escolas, já é um fator que delimita as aulas em se tratando de SSR e favorece a atuação dos micromecanismos.

No que se refere à US, se olharmos a partir da lente de Chang (2022), os recursos financeiros e de tempo, dos(as) profissionais, foi sempre uma questão central dentro do serviço de saúde e com ressonância significativa nas formas de trabalho dos(as) profissionais. Como já vimos, tanto técnicas de enfermagem, no acolhimento, quanto médicos(as) e enfermeiros(as) em consultas estão sempre “apagando o fogo” (Enf. Cássia). Eles(as) relatam que possuem pouquíssimo tempo para realizar os atendimentos e sempre têm filas de espera na recepção da US.

As consultas médicas devem ser realizadas em até 20 minutos, enquanto as de enfermagem em até 30 minutos, o que todos(as) estes(as) agentes de saúde referem ser muito pouco para conhecer o(a) paciente, verificar o que está se passando e fazer os encaminhamentos necessários. As técnicas de enfermagem não possuem um tempo limite no acolhimento, mas são pressionadas pela quantidade de pessoas para atender e, normalmente, o acolhimento dura em média cinco minutos. Esta falta de tempo também impede um olhar mais humanizado e completo para o(a) usuário(a), inclusive no que se refere à SSR, sendo que isso pode, muitas vezes, aumentar a utilização de micromecanismos, principalmente de omissão da sexualidade, da contenção reprodutiva e da coerção contraceptiva.

Todos esses fatores somam na escolha, por exemplo, de não encaminhar uma jovem para uma consulta com a enfermeira para reavaliar, depois de um ano, o uso de seu anticoncepcional, onde a própria técnica de enfermagem faz uma nova receita e apenas solicita que a enfermeira carimbe. Ou, na falta de prioridade que se dá a uma jovem que veio realizar

testes de IST, em detrimento do atendimento de uma criança que está com dores de ouvido e diarreia, por exemplo.

Além do tempo, os recursos financeiros também são escassos. Há constantemente falta de materiais básicos na unidade como luvas, soro e, mais especificamente no nosso caso de SSR, durante cerca de três meses a US esteve sem repasse da injeção trimestral e diversas jovens tiveram que trocar o método, pois não tinham recursos para pagar a injeção em farmácias. Ou no caso de o DIU não poder ser colocado na unidade de saúde, pois esta não possui profissionais qualificados(as). Nesta situação, as jovens devem ser encaminhadas para outro hospital, mas sem o custo da passagem de transporte público sendo disponibilizado, ou seja, dificultando o acesso de muitas. Não raro, profissionais me relataram terem pago passagens, pago medicamentos ou exames para usuários(as) da US.

Ao considerar recompensas institucionais e normativas, autonomia e restrições institucionais (Chang, 2022), temos que relembrar as metas da US. Elas são uma forma de controle do trabalho dos(as) profissionais e, se formos comparar com as escolas, só nisso já se exerce uma pressão muito maior nos(as) agentes do serviço de saúde. Não existe nenhuma meta específica, no que tange à saúde sexual e reprodutiva juvenil, para além da necessidade de, no mínimo, seis consultas de pré-natal com a gestante - o que é obrigatório independente da idade da mesma. Porém, o fato de haver outras metas, por exemplo, para atendimentos de diabéticos, influencia os(as) profissionais a darem mais atenção para este grupo, em detrimento de um olhar para a SSR juvenil. Logo, abre-se espaço para a maior utilização dos cinco micromecanismos que aqui estudamos.

Ademais, para entender o cotidiano de trabalho dos(as) agentes de saúde e educação, se faz necessário olhar para a estrutura física das escolas e US, o que, claro, está interligado com recursos financeiros. Como vimos, a escola B possui uma estrutura de salas de aula e ambientes de convívio coletivo escolar melhores que a escola A, onde há janelas quebradas, falta de ventiladores, não há sala de informática ou uma sala de atividade multimídia e o laboratório de Ciências está praticamente abandonado. Estes fatores limitam que professores da escola A realizem atividades diversificadas para além do quadro e do giz. Já na escola B, apesar de uma estrutura melhor, a sala de informática e sala multimídia são raramente utilizadas pelo professor e professora de Biologia, bem como o laboratório de Ciências.

Um outro ponto que precisamos olhar para entender o contexto de atuação dos(as) agentes de escolas e US é a formação e capacitação destes(as) profissionais, no que se refere à SSR juvenil, pois este é um dos fatores que influencia na implementação das políticas (Assis, 2025). Ele destaca que a falta de conhecimento especializado abre margem para maior

discrecionariiedade dos(as) agentes. Percebo que quanto menos conhecimento especializado, mais os profissionais tendem a usar de suas normas e valores pessoais para julgar os(as) usuários das políticas, exercendo maior agência, fato este que vemos claramente no que se refere à saúde sexual e reprodutiva.

A falta de capacitações acerca da SSR, seja na universidade ou em ações angariadas pela Secretaria Estadual de Educação e/ou outras entidades é sentida pelos três professores e pela professora que acompanhei. Todos(as) relatam ter tido aulas apenas sobre reprodução: “Na Biologia sim, na parte reprodutiva, na parte animal, na parte anatômica. Daí acaba se estudando alguns conceitos, algumas coisas que eu passo em aula. Eu falo pra se cuidar e tal.” (Prof. Felipe).

O mesmo se repete na unidade de saúde onde nenhum(as) dos(as) profissionais destaca já ter tido uma formação específica referente à saúde sexual e reprodutiva dos(as) jovens, fator que estimula ainda mais a utilização da agência ao tratar desta temática. Apenas um médico, Benjamin, citou que certa vez iria realizar uma formação sobre colocação de DIU, mas teve que permanecer na US no dia devido à falta de profissionais.

Há um outro ponto muito importante, também do contexto de trabalho dos(as) profissionais de escolas e da US, que precisamos nos atentar: os fatores emocionais dos(as) profissionais, como estudam Mikkelsen, Madsen e Baekgaard (2024). Eles estudaram a relação entre o nível de estresse dos burocratas de nível de rua e as experiências relatadas pelos usuários de serviços públicos no setor de seguro-desemprego na Dinamarca. Os autores chegaram à conclusão de que quanto mais estressados, mais os(as) BNR diminuem a empatia e o engajamento emocional com os(as) usuários(as) e mais o cidadão sente que o serviço é burocrático, desorganizado, demorado ou hostil. Pontos que vemos também aqui na pesquisa.

Em ambos os ambientes, escolas e US, os(as) profissionais demonstram um alto nível de descontentamento com o atual contexto de trabalho. Nas escolas, como já aprofundamos no capítulo cinco, ao falar do ambiente escolar e seus entornos, professores(as) têm salários baixos, falta de reconhecimento por parte dos(as) estudantes e da comunidade escolar, pouca relação com a coordenação, alunos(as) sem interesse e respeito pelo(a) professor(a) e falta de estrutura física para ministrar suas aulas.

Já na US, como vimos no capítulo cinco, segundo a maioria dos(as) funcionários(as) é “um caos”, onde “não se consegue fazer atenção primária direito” e “estamos sempre apagando o fogo”. Profissionais reclamam da altíssima demanda da US, da falta de estrutura física adequada, da falta de profissionais com o quadro da unidade nunca completo, entre outros.

Vários(as) jovens relataram frases como “As mulheres [técnicas de enfermagem] estão sempre com o cu virado pra lua, mal comidas e daí descontam na gente.” (Kátia, sem experiência reprodutiva). Ou na escola: “Os professores vivem faltando e não têm a menor vontade de nos dar aula, então é melhor pedir demissão.” (Robson, sem experiência reprodutiva). Ou seja, influências diretas nas relações com usuários(as) que, como já vimos ao longo da tese, também respingam nas formas de atendimento, discricionariedade e agência.

Maynard-Moody e Musheno (2022) ao apontarem para a agência, destacavam que as relações entre usuário(a) e profissional eram fundamentais para definir como o encontro entre estes iria se desenrolar. Shore e Wright (1997, 2011) também apontam para a centralidade das pessoas beneficiárias das políticas e como elas podem influenciar no resultado das mesmas. Enquanto isso, diversos outros autores do campo de públicas também estudam como se estabelecem as relações entre usuário(a) e profissional (Bartels, 2014, 2013; Lotta; Costa, 2020; Raaphorst; Loyens, 2018; Follet, 2013; Oldenhof; Linthorst, 2022; Raaphorst, 2018) e destacam para distâncias desde a forma de se comunicar, passando pelo nível de conhecimento de cada um, o que culmina muitas vezes em hierarquias rígidas e sem espaço para o(a) usuário(a) ter maior aproximação e explicar melhor a situação que está vivenciando.

Tate (2020) que aponta para o fato de as políticas acontecerem nessas relações que se estabelecem entre agentes e usuários(as) e nos processos de governança. Ainda, Bonelli, Fernandes, Coêlho e Palmeira (2019) apontam que a atuação dos(as) burocratas implementadores de políticas públicas tem três dimensões, sendo uma delas a relacional onde a intensidade das relações, frequência de interações, quantidade e qualidade de informações e tipos de relações de poder, importam.

No caso das escolas, quanto menos relações de poder hierárquica e maior frequência de interações, percebemos que mais os(as) jovens buscam conexões com os(as) professores(as). Vemos que essa relação aproximada se estabelece principalmente com a professora Monique, tendo aí um determinante de gênero que já foi explorado anteriormente. Conversando com os(as) jovens e com os(as) professores(as) entendemos que relações mais próximas são centrais para que haja algum diálogo sobre preservativos, por exemplo. O(a) estudante precisa se sentir confortável com o(a) profissional para falar.

Já na US, um dos princípios da atenção primária em saúde é o vínculo entre paciente e profissional, porém relações aproximadas dentro da unidade entre estes sujeitos são raras, principalmente no que se refere aos(as) jovens. Somente uma entrevistada de dezesseis anos destacou que tinha uma relação próxima com a médica da US, que lhe atendia, e muito devido ao fato de sua mãe trabalhar no local e ela ter uma abertura relacional.

Vale aqui darmos atenção à parcerização que foi trazida por todas as quatorze pessoas entrevistadas, na maioria das vezes como um ponto negativo, visto que a forma que ela foi implementada naquela gestão e naquela US gerou uma grande rotatividade de profissionais nas unidades de saúde. “Somos só números” (Enf. Bruna), me disse certo dia uma enfermeira enquanto almoçávamos.

Se pensarmos em Bonelli, Fernandes, Coêlho e Palmeira (2019) apontamos que a atuação dos(as) burocratas, implementadores de políticas públicas na US com os(as) jovens, são pouco intensas, pouco frequentes, com pouca quantidade e pouca qualidade de informações e com uma relação de poder hierárquica bem definida e verticalizada. Ou seja, o pacote completo para uma relação distante onde jovens preferem não ir a US e percebem o local como ruim para eles(as).

As relações entre usuários(as) e profissionais também acontecem, segundo Lotta (2015), Lotta e Kirschbaum (2022), Lotta (2019) e Lotta e Costa (2020), a partir das categorias que os(as) profissionais criam para poder lidar com os(as) usuários(as). Estas são criadas a partir de valores, de moralidades e de referências da vida dos(as) agentes, que se transformam em percepções daquilo que é ou não certo, aceitável, e quais situações têm mais ou menos importância. Em última instância, qual perfil de usuário(a) é mais merecedor(a) de atenção. Ou seja, relações entre usuários(as) e profissionais e categorização são parte essencial do nosso entendimento sobre agência.

Na escola, as categorias que os(as) professores(as) têm dos(as) estudantes são relacionadas à imaturidade e irresponsabilidade, está ligada, principalmente, aos jovens homens. O professor Felipe destaca estes como pessoas que “vão correr [da gestação]” (Prof. Felipe) e reafirma o mesmo em conversas informais com o fato de “jovens pais não existem”.

A professora Monique refere que os(as) jovens “são duas crianças que têm que cuidar para não fazer mais uma criança.” (Prof. Monique). Em conversas informais, os professores Gabriel e Ricardo também trazem falas sobre os(as) estudantes serem muito jovens para terem filhos. Na primeira seção do capítulo seis é possível atentar com mais profundidade para as visões destes profissionais. Falas sobre mães jovens estão ligadas à imaturidade, enquanto pais da mesma idade são categorizados pelos professores e pela professora como “fujões”.

Os(as) profissionais da US, assim como os das escolas, trazem categorias para se referirem aos(as) jovens, o que já interfere, *a priori*, nas relações que se estabelecerão durante os atendimentos e, conseqüentemente, no resultado dos encontros e na implementação da política pública.

Lotta e Pires (2020) estiveram no serviço de saúde e analisaram as categorias de usuários(as) "fáceis" e "difíceis" que são feitas a partir dos valores e moralidades dos(as) profissionais do serviço ao avaliarem sobre a "inadequação do comportamento" dos(as) usuários(as). Apesar dos(as) profissionais com quem estive não se referirem à nomenclatura "fácil" e/ou "difícil", percebemos como suas categorias também apontam sempre para a "inadequação do comportamento". Ou seja, jovens que querem gestar estão erradas, pois não é o momento ideal. Jovens que não querem tomar o anticoncepcional estão erradas, pois é necessário se prevenir da gestação. Jovens que se relacionam sexualmente com várias pessoas estão errados, pois vão adquirir uma IST. Inclusive, jovens que vão ao posto de saúde, alegando estarem mal, e que não conseguiram trabalhar naquele dia, sempre estão mentindo e "só querem atestado" (Tec. Enf. Maria).

Como já vimos, a maioria destes(as) profissionais têm a percepção da gestação na juventude como um problema e que deve ser evitada, logo, a categorização que fazem dos(as) jovens segue essa toada: "imaturos(as)", "uma criança ainda", "irresponsáveis", "fujonas" - esta principalmente para jovens mulheres realizando o pré-natal. Enquanto isso, é importante citar também categorias específicas que criam para os jovens pais: "são mais imaturos" (Med. Amarilis), e têm "menos responsabilidade" (Enf. Stefani).

Durante todo o período em que estive na US, apenas duas vezes vi adjetivos positivos, para mães jovens, advindos de duas enfermeiras após consultas de pré-natal. Ambas as jovens que se consultaram eram brancas, tinham renda familiar fixa, estudavam, tinham boas condições de moradia, "família estruturada" - leia-se com condições financeiras melhores - e estavam em um relacionamento com os genitores das crianças. As duas enfermeiras categorizaram estas gestações como "tranquilas", justamente citando todos os fatores que eu mencionei acima, menos o fato da cor da pele.

Dito isso, na prática os(as) profissionais costumam categorizar os jovens que buscam informações sobre contracepção como pessoas que são "esquecidas" "não prestam atenção", "entra num ouvido e sai no outro", "não entendem o que a gente fala". A maioria dos(as) profissionais que cita a falta de atenção das jovens já o faz como que justificando a falta de informações qualificadas sobre métodos contraceptivos que repassam para elas.

Até aqui abordamos as atuações de profissionais das escolas e da US, a partir das regras que devem seguir, *accountability*, recursos, estrutura de trabalho, modelo de gestão, relações com usuários(as), desgaste emocional, falta de capacitações e categorização dos(as) usuários. Assim, buscamos atentar para como a implementação da política pública envolve muito mais do que apenas a lei em si, envolve o contexto de atuação daqueles que a implementam.

Para além destes pontos aqui citados, entendemos que os valores e moralidades que os(as) profissionais de saúde e educação têm exercem um peso maior quando se trata da implementação das políticas de saúde sexual e reprodutiva. Afirmamos isso, pois apesar de agentes de saúde e de educação atuarem em áreas muito distintas, com atividades a executar muito diversas, com formações totalmente diferentes, com regras que divergem, diferentes níveis de *accountability*, recursos, estrutura de trabalho, modelo de gestão e relações com usuários(as), que mudam de escola para US, eles(as) têm discursos acerca da SSR muito similares e tratam dela de maneiras muito aproximada. E por que isso acontece?

Nossa resposta reside nos micromecanismos de governança reprodutiva, entendendo que estes se originam a partir da agência dos(as) profissionais, que levam em conta seus valores e moralidades nos encontros com os(as) jovens. Aqui, temos a centralidade dos regimes morais (Morgan; Roberts, 2012) e pânico moral (Bozon, 2012) que regulam a atuação tanto de profissionais da escola quanto de US.

Mas para além desses pontos, temos todos os demais fatores que vimos no que se refere ao contexto de atuação dos profissionais e que interferem na utilização dos micromecanismos: falta de tempo e recursos financeiros, falta de formações sobre SSR, falta de apoio das secretarias de Saúde e Educação para atuar, no que se refere à SSR, e dificuldades nas relações entre agentes e usuários(as), no caso, jovens, que, quanto mais distanciadas, mais difícil se discutir sobre temáticas tão sensíveis quanto a identidade sexual, por exemplo. A seguir, olharemos, novamente, para os micromecanismos e como estes interferem no cotidiano da política.

11.2.2 Micromecanismos de contenção reprodutiva

Chegamos, assim, aos micromecanismos. Primeiro, os micromecanismos de contenção reprodutiva, os quais se referem às formas com que os(as) agentes, no nosso caso de saúde e educação, buscam coibir as jovens e os jovens - mas principalmente as primeiras - a gestar e reforçam discursos acerca das dificuldades e problemas que a gravidez ocasiona segundo as seus valores e moralidades, conseguindo, por vezes, conter a reprodução.

Onde e como estes micromecanismos são usados? No capítulo sete já discutimos a gestação juvenil e como os(as) profissionais de saúde e educação têm fortes valores e moralidades acerca da mesma, sendo que apenas dois entre dezoito profissionais entrevistados(as) não consideram a gravidez na juventude como um problema. Eles(as) levam

estes valores para os seus cotidianos de sala de aula e atendimentos, fazendo uso dos micromecanismos de contenção reprodutiva.

No caso da escola, estes mecanismos se dão sempre no diálogo com alunos(as) acerca da importância de prevenir a gestação, do "atraso" que causaria na vida das jovens e de que existe um “momento ideal para gestar”. Isso dito durante aulas de Biologia ou outros momentos que os(as) professores(as) julgaram adequado em sala, mas que ocorreram poucas vezes. Ainda, nos diálogos fora de sala de aula com os(as) estudantes caso eles(as) venham a ter questionamentos.

Aqui, relembramos da importância das relações que se estabelecem entre professores(as) e estudantes, pois os jovens homens raramente se sentem confortáveis em pedir algo para um(a) professor(a). Já as jovens, apenas da escola B, destacam que conversariam com a professora Monique "porque ela é mais aberta", "mais tranquila", como destacou Silvana (19 anos, sem experiência reprodutiva, roda de conversa).

E, se olharmos nos PCNEM e na BNCCEM bem como nos Planos Políticos Pedagógicos das escolas A e B, não se encontra nenhuma informação sobre realizar atividades de prevenção da gestação na juventude. Mesmo assim, os(as) estudantes entendem muito bem o “recado” que os(as) professores(as) de Biologia querem lhes passar acerca da reprodução, como já destacamos anteriormente: “Queriam fazer com que a gente não engravidasse” (Alice, sem experiência reprodutiva). Os jovens já não comentavam muito sobre o que aprenderam acerca da gravidez: “Falavam pra gente se cuidar, né? Usar camisinha” (Caio, sem experiência reprodutiva).

É importante sinalizar, no que se refere aos(às) jovens, que tanto para jovens no primeiro ano do Ensino Médio - em torno de 15 a 16 anos de idade - quanto jovens no terceiro ano - média de 18 a 19 anos, a utilização de micromecanismos de contenção reprodutiva segue a mesma, o que sugere que a preocupação maior é com a "estrutura" da jovem, principalmente financeira do que com o fato de ela ter 15 ou 17 anos.

Para analisar os micromecanismos de contenção reprodutiva utilizados pelos(as) profissionais trazemos a categorização feita por Crouch (2005) e entendemos que estes são mecanismos de governança endógenos - de dentro da escola para os(as) estudantes - informais - baseados em costumes e normas sociais -, substanciais - focam no tema da gestação na juventude -, de diálogo - ocorrem a partir das conversas com alunos(as) - e verticais - não horizontais. Ainda, são de aplicação fraca uma vez que dependem do consentimento dos(as) estudantes, de alcance limitado, pois atuam em contextos específicos da escola, de saída fácil -

caso profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todos(as) estudantes da rede pública de ensino das escolas A e B.

Entendemos que a contenção reprodutiva recai principalmente sobre as jovens, também nos trazendo outro micromecanismo: o de acumulação reprodutiva feminina, que exploraremos mais na sequência. Para nós, fica claro que a camada social é o principal determinante para que surjam mecanismos de contenção reprodutiva por parte dos(as) professores(as).

Já na unidade de saúde as discussões sobre gestação são muito mais presentes, como podemos imaginar e já discorremos ao longo do capítulo sete. No capítulo seis, fizemos uma apresentação completa dos protocolos, políticas e diretrizes que se referiam à saúde juvenil junto da Biblioteca Virtual da Atenção Primária da Saúde e apontamos para: Guia Adolescer, documentos sobre o PSE, sobre o Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente (PAIGA), a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes (PEAISA), Nota Técnica Estadual nº 01/2018, “Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes: orientações para profissionais dos serviços de atendimento direto a crianças e adolescentes” e “Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes orientações para profissionais da assistência social, saúde e educação”. Todos estes documentos são endereçados para todos(as) os(as) profissionais de saúde que aqui acompanhamos.

Agora, em se tratando especificamente de cada função - médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde - apenas os(as) enfermeiros(as) têm protocolos específicos que tratam da saúde sexual e reprodutiva de jovens: Protocolo de Enfermagem - Saúde da Criança e do Adolescente, Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Infecções Sexualmente Transmissíveis e o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual.

Ao perguntar o que as ACSs, técnicas de enfermagem, médicos(as) e enfermeiros(as) conhecem em relação à saúde sexual e reprodutiva juvenil, a resposta sempre se refere a estes dois protocolos e não cita nenhuma outra diretriz daquelas que vimos acima. Vemos que os(as) enfermeiros(as) são os(as) únicos(as) que têm protocolos especificados para tratar de saúde sexual e reprodutiva e, mesmo assim, eles(as) têm um alto grau de agência que ocorre, assim como todos(as) demais profissionais das escolas e US, devido a, principalmente, seus pânicos morais em relação à sexualidade juvenil e regimes morais que circundam este tema. ACSs, médicos(as) e técnicas de enfermagem não têm nenhum protocolo específico do que devem realizar, no caso de saúde sexual e reprodutiva, logo, sua ação fica ainda mais centralizada na agência.

E como os micromecanismos de contenção reprodutiva atuam na US? Os atendimentos às jovens que vão até a unidade, desejando fazer um planejamento familiar são resolvidos

através destes micromecanismos, onde profissionais tanto médicos(as) quanto enfermeiros(as) tentam dissuadir as jovens e, por vezes, conseguem adiar a gestação delas. É importante frisar que nenhum documento que os(as) profissionais têm acesso aponta que deve ser feita uma dissuasão da gestação juvenil, apesar de ser exatamente isso que os(as) profissionais costumam fazer. E, ao fazerem, acabam por pressionar as jovens e, muitas vezes, afastá-las da US, onde por vezes não querem nem realizar o pré-natal devido ao julgamento dos(as) profissionais acerca da sua gestação.

A contenção reprodutiva também é um mecanismo observado nas consultas de início de contracepção das jovens, onde não se discute, por exemplo, sobre ISTs, mas se fala em evitar a gestação na juventude, sendo que os(as) profissionais, majoritariamente enfermeiros(as), costumam trazer este discurso muito presente sem citar os reais malefícios e benefícios dos métodos contraceptivos.

Ainda, vale citar casos, como o da técnica de enfermagem Ana, que no acolhimento questiona para algumas jovens se elas não querem iniciar a contracepção, mesmo não havendo nenhuma indicação para que ela faça o mesmo. Ademais, a discussão sobre contracepção com a gestante e/ou puérpera juvenil também é marcada por falas dos(as) profissionais no sentido de que as jovens precisam voltar a usar contracepção para evitar uma próxima "gestação tão jovem" (Enf. Olívia, conversa durante consulta). Não há nenhum protocolo que destaque que ela deva fazer qualquer questionamento neste sentido relacionando gestação e idade.

No que se refere à tipologia de Crouch (2005) que aqui analisamos para melhor entender os micromecanismos de contenção reprodutiva, apontamos que eles são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Aqui, temos mudanças no que se refere à escola, pois são micromecanismos de aplicação forte, uma vez que os(as) profissionais de saúde falam de um local de maior poder e conhecimento sobre questões da saúde sexual e reprodutiva, o que algumas vezes tem efeito de postergar a gestação. Eles seguem sendo de saída fácil - caso os(as) profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todos(as) jovens que acessam o serviço de saúde em busca de informações sobre a gestação.

Logo, entendemos que os(as) profissionais da US, principalmente médicos(as) e enfermeiros(as), utilizam da agência a partir da noção da gestação na juventude como um problema e, por isso, fazem uso de micromecanismos de contenção reprodutiva para com as jovens mulheres, sendo que com os homens a possibilidade de uma gestação nunca é discutida, como já observamos ao tratarmos dos micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina. Fica o questionamento novamente: quem pode gestar? Vemos aqui que o marcador etário é importante, mas não nos parece tanto quanto o marcador da classe social.

11.2.3 Micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina

Os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina são centrais, nesta tese, e importantes para entendermos tanto a contenção reprodutiva quanto a coerção contraceptiva e a vigilância reprodutiva. Na realidade, eles andam lado a lado com todos os demais. Isso porque este micromecanismo se refere à ação dos(as) profissionais que ratifica a centralidade feminina e a inércia dos homens em suas responsabilidades, antes da gestação, durante e após, com o cuidado da criança.

Se olharmos para os documentos que regem a atuação dos(as) agentes de educação, na BNCCEM não há nenhuma referência à palavra gênero ou qualquer discussão oriunda daí. Como vimos, os três professores - Ricardo, Gabriel e Felipe -, que apontam seguir a Base, não trabalham questões de gênero em sala de aula, diferente do que ocorre, por exemplo, com a prevenção da gestação na juventude. Por que será? Pânicos morais e regimes morais que dão muito mais relevância a uma gestão do que discussões sobre papéis de gênero.

Muitos dos diálogos de professores(as) que vimos nos capítulos sete a dez representam micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina, uma vez que reforçam o cuidado que a jovem deve ter em evitar a gestação e, caso engravide, em como ela ficará responsável pela criança e isso afetará seus estudos, sua vida social, seu financeiro, entre outros. E, como disse o professor Felipe "a vida do homem segue a mesma." (Prof. Felipe).

Ao conversar com as jovens tanto em entrevistas quanto em rodas de conversa ou pelos corredores da escola, elas destacavam que sentiram sempre que os(as) professores(as) tinham um discurso de responsabilização maior da mulher em relação à gestação e cuidar da criança do que os homens.

Os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina se dão justamente a partir da noção de que a mulher é aquela que terá sua vida totalmente modificada, enquanto que o homem vai "correr", "sumir". E realmente, ao conversar com os alunos e alunas, eles(as) destacam justamente essa noção de que: "Ah, o pai ali saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou." (Caíque, sem experiência reprodutiva). Mostramos ao longo dos capítulos, principalmente, no sete, como a gestação é um grande medo para as mulheres, mas não tanto para os homens, que costumam responder com frases como: "Se acontecesse, ia ter que criar." enquanto que as meninas respondem muitas vezes com "Eu me matava." ou "Ia mudar totalmente a minha vida."

Os professores e a professora acabam reforçando os discursos que os(as) próprios(as) estudantes têm, o qual se construiu principalmente a partir de suas vivências no território, onde é comum terem sido criados(as) por mães solas ou terem pais que não ajudam em nenhum afazer doméstico. O espaço escolar, que é propício para discussões de gênero, acaba reforçando as assimetrias e hierarquias de gênero.

Outro momento em que os micromecanismos estão em ação na escola é na fala sobre contracepção ser voltada sempre para as jovens, colocando sob elas a responsabilidade pela gestação, mesmo que indiretamente. Por exemplo, presenciei uma aula do professor Gabriel, com uma turma do primeiro ano do Ensino Médio da escola A, onde ele falou sobre gestação e uso de tabelinha, colocando a centralidade do cuidado na mulher. Ele não disse algo como: caso você não consiga controlar pela tabelinha, vai engravidar e a culpa será sua, mas, como dizem: para boa entendedor, meia palavra basta. E as jovens entendem bem desta responsabilidade e deste peso que às acompanha.

Os micromecanismos também são percebidos quando a professora Monique destacou que tinha o costume de conversar com os jovens de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio sobre eles cuidarem para não "pegar uma pereba" (Prof. Monique) através do uso de preservativo. Observe que em nenhum momento ela falou com eles sobre usar preservativo visando evitar uma gestação, fala que com certeza já teve mais de uma vez se referindo às jovens. E por que falar para uma e não para outra? Aqui, mesmo sem ser uma fala destinada às alunas, a professora agiu a partir de micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Nas escolas, assim como micromecanismos de contenção reprodutiva, os de acumulação reprodutiva feminina são percebidos nas outras atividades que abordam de alguma forma saúde sexual e reprodutiva na escola, tanto em PSE, em palestras de acadêmicos e/ou nas referidas conversas com a professora Samanta, coordenadora de uma escola de Ensino Fundamental e que abordava sobre prevenção da gestação e contracepção com os(as) estudantes.

Este é um dos micromecanismos em que mais fica clara a individualização do cuidado e a centralidade das políticas de família ao invés de políticas públicas. Nesse contexto, o cuidado é feminino e a mulher deve ser uma "boa mãe" e garantir educação, alimentação, moradia, entre outros, de qualidade para seu filho(a). É ela que deve exercer uma parentalidade positiva, a qual sempre passa pelo poder aquisitivo, por normas e valores do que as camadas médias e altas consideram "ideal".

A partir de Crouch (2005) entendemos que os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina dos professores e da professora são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Ademais, são de aplicação forte, pois claro que

dependem de um consentimento dos(as) estudantes, mas já é algo tão naturalizado naquele contexto que a fala dos(as) profissionais apenas reitera o que todos(as) já sabem. Também é de alcance limitado, pois atuam em contextos específicos da escola, de saída fácil - caso profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todos(as) estudantes da rede pública de ensino das escolas A e B.

Logo, os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina são exercidos através do diálogo tanto por parte dos professores quanto por professoras. Gênero não é um impeditivo para que as profissionais de saúde e educação façam uso de falas que coloquem a mulher como cuidadora e o homem em um espaço secundário. Estes micromecanismos são reflexos da nossa sociedade patriarcal, machista e sexista e têm, por óbvio, maior peso na vida de jovens mulheres que estão na maioria das vezes fadadas a carregar o medo de uma possível gravidez sozinhas.

A unidade de saúde também seria um espaço onde as discussões de gênero poderiam ser potencializadas, mas isso não ocorre. Já discutimos aqui o contexto de trabalho dos(as) profissionais da US, falamos de marcadores sociais e, assim como na escola, o gênero dos(as) agentes não impede que estes(as) façam uso de mecanismos de acumulação reprodutiva feminina na mesma medida ou senão até mais que homens.

Se apontamos que os(as) profissionais de saúde têm agência para tratar as jovens com maior centralidade que os homens no processo reprodutivo, temos que olhar para o que as normas que regem o trabalho na US têm a nos dizer sobre isso. No Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual, ao falar sobre planejamento reprodutivo, há uma passagem que cita discussões de gênero dentre outras coisas e se refere à Brandão et al. (2021). Lê-se:

No atendimento aos adolescentes, a atenção à saúde relativa à sexualidade, ao planejamento e à saúde reprodutiva, deve resguardar princípios éticos de respeito à integridade e à **autonomia pessoal, sem qualquer tipo de constrangimento**. Além disso, deve ser acompanhado do debate sobre gênero, sexualidade, violência, na ampla distribuição de preservativos em locais de sociabilidade juvenil, na provisão de outros métodos contraceptivos, no acesso ao aborto seguro e no apoio aos jovens em suas decisões (Brandão et al., 2021) (Porto Alegre, 2024b, p. 134, grifo nosso).

Logo, destaca-se a importância de discussões sobre gênero, mas não vemos elas acontecendo na US, como pudemos perceber ao longo de toda a tese. O mesmo Protocolo destaca que “Os profissionais devem buscar inserir o pai da criança durante os atendimentos, caso seja a vontade da mãe.” (Porto Alegre, 2024b, p. 112), mas também abre margem para interpretação, uma vez que não refere como inserir o pai. De toda a forma, como já vimos, ele só é requisitado para os exames de ISTs uma vez durante o pré-natal e depois não é mais incentivado, pelos(as) profissionais, a vir.

A Política Estadual do Rio Grande do Sul, promulgada em 2019, aponta para a necessidade da saúde integral dos(as) jovens e possui um eixo de “Saúde sexual e reprodutiva”, o qual aborda, dentre outras questões, a "realização de ações educativas para o exercício da paternidade responsável". (PEAISA, 2019, p.5). Ou seja, vários documentos abordam também a participação dos genitores na gestação e puerpério, mas, como vimos, nada impede que o discurso sobre a centralidade da mãe seja replicado por todos(as) profissionais.

Só tive contato com dois jovens pais durante meus meses na US e não foi por falta de momentos presentes na mesma, mas sim porque, como diz o médico Benjamin "todas as jovens parece que estão parindo Jesus, porque não tem pai." (Med. Benjamin). Associada à discussão sobre a presença dos pais na US está a própria presença do homem, que é diminuto, principalmente se olharmos para o homem jovem. Os determinantes sociais da saúde, especialmente o de gênero, nos ajudam a entender o porquê disso (Barata, 2009). Esta autora aponta para a construção social do cuidado sempre associado ao feminino, inclusive o autocuidado, então "homem não chora" e "homem não pode sentir dor", são expressões presentes no cotidiano dos jovens com quem conversei.

Este fato está diretamente correlacionado com o micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina, uma vez que tanto nas falas de médicos(as), enfermeiros(as), ACSs e técnicas de enfermagem, a mulher sempre tem um papel maior de cuidado em detrimento do homem. E isso desde a consulta de contracepção, passando por planejamento familiar, por todo o pré-natal e pelas consultas de puericultura depois.

A grande maioria das jovens com quem conversei relatou que quando começavam a menstruar ou ao assumir o primeiro namorado, suas mães as levavam para a US para iniciar a contracepção, enquanto que aquilo que os jovens conhecem sobre contracepção vem a partir do que ouviram na escola ou com amigos/familiares.

O ponto é que não existe na unidade nenhum tipo de incentivo para os jovens conhecerem mais sobre métodos contraceptivos e quando estes vêm a US, normalmente para consultas de IST, não é discutido com eles a importância do preservativo, o que seria um momento também para responsabilizá-los acerca de uma possível gestação. Assim, o micromecanismo de acumulação reprodutiva feminina se dá justamente na ausência de qualquer fala acerca da prevenção da gestação com homens enquanto esta ocorre aos montes para as mulheres.

Jovens homens também nunca foram vistos na US tratando de planejamento familiar e nas narrativas de enfermeiras e médicas sobre consultas neste estilo, elas nunca perguntaram se

a jovem tinha um parceiro e se este também poderia vir para uma consulta ou sequer trataram do apoio paterno. Desde o início, a gestação fica por conta da mulher.

Temos o exemplo claro de micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina no grupo de gestantes da unidade, onde a ACS Carolina e enfermeira Olívia, dirigentes do grupo, tinham falas todo encontro - ou seja, semanalmente - sobre como sabiam que o trabalho ficava mais com a mulher e que o homem demorava mais tempo para "cair a ficha" (ACS Carolina, grupo de gestantes). O próprio nome, grupo de gestantes, já é indicativo de para quem o grupo se propõe.

No que se refere à tipologia de Crouch (2005), que aqui analisamos para melhor entender os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina, apontamos que eles são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Aqui, temos mudanças no que se refere à escola, pois não são micromecanismos de aplicação fraca uma vez que os(as) profissionais de saúde falam em um local de subserviência da mulher que já é comum para aquela comunidade e aquelas jovens. Eles seguem sendo de saída fácil - caso os(as) profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todos(as) jovens que acessam o serviço de saúde.

Aqui, vimos como este mecanismo é central para entendermos mais sobre o processo pré, durante e pós gestação que notamos ser de grande preocupação, em torno da mulher, tanto para profissionais das escolas quanto para a saúde. Notamos que as discussões sobre sexualidade aqui continuam basicamente restritas à saúde reprodutiva. Tanto PCNEM quanto legislações da saúde do município de Porto Alegre não corroboram com essa falta de discussões, o que não muda o resultado da ópera: profissionais se preocupam com o fato das jovens, de camadas populares, gestarem e terem filhos para cuidar depois, sem tratar do papel do jovem homem no processo.

11.2.4 Micromecanismos de vigilância reprodutiva

Os micromecanismos de vigilância reprodutiva também estão intimamente relacionados com os de acumulação reprodutiva feminina, pois se referem às formas que os(as) agentes de saúde encontram para buscar controlar e vigiar a gestação das jovens e os primeiros meses após o nascimento da criança. Aqui, nos referimos às jovens, pois é o grupo alvo da pesquisa, mas certamente estes micromecanismos também se dão com mulheres de outras faixas etárias, como

por exemplo, mulheres adultas com histórico de toxicodependência. Mais estudos deveriam ser feitos para corroborar essa ideia, sem dúvida os meses de observação na US indicam que sim.

Estes micromecanismos são utilizados, então, a partir da descoberta da gestação das jovens, quando os(as) profissionais falam que "paciência, não tem mais o que fazer" (ACS Carolina). Para entender como se dão estes micromecanismos, precisamos antes olhar para os regulamentos em torno do pré-natal e posterior a ele.

Olhando para os regulamentos em torno da gestação e puericultura, o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual destaca diversos pontos referentes a como deve ser organizado o pré-natal da gestante e um fluxograma se destaca na abertura do pré-natal:

Acolher a pessoa gestante. Iniciar o pré-natal o mais precocemente possível e explicar a rotina do acompanhamento; Preencher e fornecer a Caderneta da Gestante; Cadastrar a gestante no prontuário eletrônico; Realizar anamnese, exame físico geral e específico, avaliação nutricional, solicitação de exames e testes rápidos sorológicos, prescrever suplementação de ácido fólico e ferro e realizar a estratificação de risco gestacional” (Porto Alegre, 2024b, p. 27).

Em nenhum momento há uma referência à abertura de pré-natal ou as consultas subsequentes serem realizadas com maior controle caso a gestante for uma jovem, o que os(as) profissionais acabam fazendo a partir de micromecanismos de vigilância reprodutiva. O que o Protocolo define é que mães adolescentes são um “risco intermediário” (Porto Alegre, 2024b). Dentro do novo Protocolo de Saúde da Criança e do Adolescente (Porto Alegre, 2024a), já vimos que a gestação é um dos “fatores de risco modificáveis para exacerbações”. (Porto Alegre, 2024a, p. 77). Aqui também não há em nenhum momento qualquer referência a tratamentos diferenciados no que tange às consultas de pré-natal ou na puericultura de jovens mães e suas crianças.

Novamente, vemos que a própria legislação traz a palavra “risco” diversas vezes, denotando também os protocolos serem constituídos em parte pelo pânico moral em relação à gestação na juventude e pelos regimes morais em relação à sexualidade juvenil. A presença destes termos de “risco” é um dos fatores que também propicia a construção da agência dos(as) profissionais em torno da gestação juvenil e, futuramente, utilização de mecanismos de governança reprodutiva que viemos aqui tratando.

Já o pré-natal de alto risco (PNAR) deve ser realizado em um hospital concomitante com a US, sendo que, na unidade, o protocolo de atendimento deveria seguir o mesmo de um pré-natal de risco habitual. Porto Alegre possui um Programa de Atenção Integral à Gestante Adolescente (PAIGA) e este destaca que nem toda a jovem de até 19 anos precisa ser

encaminhada ao PNAR (Porto Alegre, 2023, p.1): “A condição de gestação na adolescência não é critério absoluto para encaminhar ao PNAR, ela pode ser acompanhada pelo SUS”. Logo, as pacientes não devem ser encaminhadas *a priori* apenas pela sua idade.

Como vimos no capítulo sete, alguns(as) profissionais encaminham todas as jovens menores de dezoito anos sem exceção ao PAIGA enquanto outros(as) avaliam as condições da jovem para além da idade. E esta escolha é feita a partir de categorias que os(as) profissionais - sempre médicos(as) ou enfermeiros(as) atribuem às jovens. Comumente estas recebem categorias como “imaturas”, “irresponsáveis” e “crianças”, então os(as) profissionais entendem que é necessário que elas tenham o máximo de acompanhamento possível “para não fugirem” (Enf. Rafael).

Trazemos justamente a noção de vigilância reprodutiva, pois apesar da normativa do PAIGA não indicar que automaticamente toda jovem até 18 anos deve ser encaminhada para o alto risco, muitos(as) acabam enviando para a jovem estar “mais acompanhada” (Med. JP), “é uma ajuda a mais para acompanhar essa gestação, que é difícil” (Enf. Cássia). E, quando a jovem está no PNAR, a princípio ela precisa realizar dois pré-natais: no hospital de referência e na US, o que automaticamente faz com que se tenha um maior controle sobre aquela gestação.

O enfermeiro Rafael aponta que: “Claro, a idade é um fator, né, de sinal de alarme, assim, pra mim, por exemplo, né, que entra muito no comprometimento, na aceitação da gestante, na vinculação com o serviço, que são as coisas que a gente já entende.” (Enf. Rafael). Já a enfermeira Cássia aponta: “Sim, eu vou encaminhando [para o pré-natal de alto risco]” (Enf. Cássia).

Se olharmos para marcadores sociais da diferença no que tange ser encaminhado ou não para o PNAR, apesar de nenhum(a) profissional referir diretamente condição econômica das jovens, percebo que também é um fator que eles(as) atentam visto que, segundo eles(as), quanto menos condições, pior será a “estrutura familiar” e mais “difícil” a gestação.

Alguns(as) profissionais destacam que têm que “ficar mais de olho” (ACS Carolina). Este olhar atento está ligado aos micromecanismos de vigilância reprodutiva e normalmente é direcionado para jovens de baixa renda, pois são justamente elas as que geram maior preocupação em torno da gestação na juventude para os(as) profissionais. Vimos que a todo momento falamos da jovem gestante, mas em nenhum momento do genitor, sendo que sobre este não se exerce nenhum tipo de micromecanismo de vigilância reprodutiva o que de certa forma é sinal de micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Agora, se olharmos para o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual, que é aquele que os(as) profissionais apontam seguir, (Porto Alegre, 2024b), vale destacar que ele aponta entre

os fatores de risco a se observar na primeira consulta da mãe com o bebê se esta é mãe adolescente:

Observar os sinais de apego ao recém-nascido, atentando para possíveis sinais de alerta, principalmente se apresentar fatores de risco (gestação indesejada, primeira gestação, mãe adolescente, família desestruturada, falta de apoio social e/ou familiar, ausência de companheiro, abuso de drogas, não ter realizado Pré-Natal, tentativa de aborto desta gestação e outros) (Porto Alegre, 2024b, p. 112).

Ser mãe adolescente enquadra a jovem num lugar de “risco”, tanto quanto abuso de drogas, por exemplo. Então, os(as) profissionais também têm onde se espelhar para entender a gestação na juventude como de “risco”. Aqui, vemos também a “família desestruturada”, que conforme acompanhamos ao longo da tese, tem sido muito apontada pelos(as) profissionais da US como um fator a ser observado. Porém, o que seria uma “família desestruturada”? Aí entra a agência dos(as) profissionais da forma que irão responder, normalmente, significando que a família não tem condições financeiras, rede de apoio e homem presente no lar.

Além de seguir as consultas protocolares, o médico Benjamin aponta que “se avalia a questão mais das dificuldades socioeconômicas e outros fatores que podem prejudicar ela [a gestante].” (Med. Benjamin). Aqui, aparece o determinante social de classe como já viemos destacando durante toda a tese.

Ao serem questionados(as) sobre mudanças entre o pré-natal de uma mulher adulta e de uma mulher jovem, os(as) médicos(as) e enfermeiros(as) me relatam que não há diferenças no protocolo, mas apontam que ficam mais atentos(as) a esta gestação que à outra. Como vimos, falas sobre maior atenção e cuidado com as jovens acontecem por parte de todos(as) profissionais. A enfermeira Olívia destaca que “marca [consultas] mais perto” caso veja que é uma adolescente e que precisa de mais atenção.

As ACS também exercem estes micromecanismos de vigilância reprodutiva sobre as jovens nos casos em que percebem que “elas são mais fujonas, daí tem que ficar mais em cima.” (ACS Carolina). Enquanto médicos(as) e enfermeiros(as) não destacam tanta preocupação com as consultas de puericultura das crianças com as mães jovens, a ACS Carolina destaca que “se a mãe faltou, eu vou atrás para ver o que aconteceu.” (ACS Carolina). E há algumas mães jovens, como a Agente disse certo dia em conversa, que ela “fica mais de olho”. Como vimos, não há nenhum protocolo que guie o trabalho da ACS no que se refere à saúde sexual e reprodutiva juvenil, mas mesmo assim ela decide “ficar mais em cima” através de micromecanismos de vigilância reprodutiva.

Ao analisar os micromecanismos de vigilância reprodutiva a partir de Crouch (2005), destacamos que eles são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Aqui, não são micromecanismos de aplicação fraca, principalmente o encaminhamento ao PNAR, uma vez que este muda totalmente a forma como se vai dar o pré-natal da jovem, pois ela acaba tendo que se deslocar para dois lugares, fazer mais exames e ter acompanhamento com mais profissionais. Eles seguem sendo de saída fácil – caso os(as) profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todas as jovens gestantes e mães que acessam este serviço de saúde.

Logo, percebemos que os micromecanismos de vigilância reprodutiva são utilizados por profissionais da saúde devido a seus próprios pânicos morais em torno da gestação na juventude e regimes morais que consideram *a priori* esta gestação como “de risco” e “inadequada”. Por conseguinte, a jovem deve ser acompanhada com maior atenção, visto que esta já é uma gestação “indesejada” e que a mãe “é imatura”. Após o nascimento da criança, seguem algumas cobranças sobre a mãe jovem e o acompanhamento das consultas de puericultura, mas não tanto quanto durante a gestação. Se falarmos em escolas, estes micromecanismos não aparecem, uma vez que as instituições, inclusive, discriminam as jovens pela gestação e costumam não a acolher bem durante o processo e após o nascimento da criança.

11.2.5 Micromecanismos de coerção contraceptiva

Mais um micromecanismo, intimamente ligado com o de acumulação reprodutiva feminina e contenção reprodutiva, o último que traremos aqui é o micromecanismo de coerção contraceptiva que atinge principalmente as jovens. Este último micromecanismo se refere às ações dos(as) agentes que visam à pressão e/ou imposição de um método contraceptivo, também ao impedimento das mulheres de acessarem o método que desejam, bem como a ocultação de informações acerca de todos os métodos disponíveis no sistema de saúde e/ou compartilhamento de informações errôneas sobre algum método contraceptivo.

Já tratamos aqui da BNCCM onde não consta nenhuma informação acerca de contracepção, assim como nos PCNEM, com a diferença que os últimos apontam para questões relativas à sexualidade, porém sem citar os métodos contraceptivos. Como já vimos, no que tange às categorias que os(as) professores(as) utilizam, elas são de imaturidade e irresponsabilidade dos(as) jovens.

Aqui, assim como em todos os demais micromecanismos, também temos o fator de regimes morais e pânico moral em relação à gestação na juventude. Se a gestação é um problema, logo os(as) professores(as) entendem que sempre é importante a utilização de métodos preservativos, se referindo majoritariamente ao preservativo peniano.

Temos falas muito aproximadas sobre “se proteger e usar camisinha” de todos os professores, assim como da professora. Em relação aos alunos, percebemos que eles têm muito menos conhecimento sobre métodos de contracepção, praticamente nulos a não ser pelo preservativo peniano. E aqui entra um ponto importante de ser destacado: muitos alunos me relataram em conversas informais e/ou rodas de conversa que “não uso camisinha porque cuido pra não ter doença então não fico com qualquer uma” (Jackson, sem experiência reprodutiva) ou “só uso se a mina for meio estranha”. (Richarlison, sem experiência reprodutiva).

Temos aqui a assimetria e a hierarquia de gênero muito presentes, pois sabemos que realmente a maioria dos jovens não utiliza o preservativo peniano e nunca nem ouviu falar no feminino. Souza, Muños e Visentin (2020) realizaram estudo que abordou justamente como, o que eles chamam de vulnerabilidade de gênero, interfere na utilização do preservativo peniano onde apontaram também para a baixa frequência do preservativo” inferindo a predominância do poder do homem sobre a mulher, inclusive nas práticas sexuais seguras. É neste contexto que as relações assimétricas de gênero e poder tornam as mulheres mais suscetíveis ao HIV/aids.” (Souza, Muños, Visentin, 2020, p. 258).

No nosso caso, os professores e a professora destacaram em conversas informais o quanto é difícil que os jovens queiram usar preservativo e como muitas vezes as jovens se submetem a suas vontades. Então, já que falam sobre preservativo peniano e sabem que os homens têm esse poder sobre as mulheres, por que não falam de outros métodos de contracepção? Por que não falar do preservativo interno? Este inclusive dá mais liberdade para as mulheres nas relações. Aqui temos micromecanismos de coerção reprodutiva, mas que podem resultar naquilo que os(as) profissionais mais tem medo: gestação na juventude. Como foi o caso de Alice: “Meu namorado não queria usar preservativo porque ele não gostava e eu respeitava ele.” (Alice, 16 anos, com experiência reprodutiva).

Ao analisar outros marcadores sociais para além do gênero, não observamos diferença no tratamento com os(as) jovens devido a camada social, raça, território, religião ou outro fator. Até porque, o perfil dos(as) alunos(as) se mantém o mesmo nas duas escolas de maneira geral.

Aqui, ao classificar os micromecanismos de coerção contraceptiva, de acordo com Crouch (2005), destacamos que estes são mecanismos de governança endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Ainda, são de aplicação fraca uma vez que

dependem da vontade dos(as) jovens, de alcance limitado, pois atuam em contextos específicos da escola, de saída fácil - caso queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afeta todos(as) estudantes da rede pública de ensino das escolas A e B.

Logo, os micromecanismos de coerção contraceptiva se dão de maneira muito semelhante tanto na escola A quanto na B: professores e professora reforçam a importância da proteção, mas apenas abordam o preservativo peniano. As falas sobre prevenção seguem sendo direcionadas mais para as jovens e abordam principalmente a prevenção da gravidez na juventude para as jovens e para os jovens o cuidado com ISTs. Ou seja, até então vimos que os micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina também têm nos acompanhado.

Então ao mesmo tempo que os professores e a professora buscam um controle sobre a contracepção eles(as) não abordam todos os métodos contraceptivos disponíveis ou dão espaço para que jovens falem sobre métodos que desejem utilizar. Ou seja, utilizam-se dos três fatores que caracterizam os micromecanismos de coerção reprodutiva: pressão, ocultação de informações e falta de diálogo sobre as vontades de utilização de métodos das jovens.

Na US, temos algumas mudanças de figura no panorama da coerção contraceptiva, uma vez que estes(as) profissionais têm maior influência e poder de persuasão sobre as decisões das jovens acerca da contracepção, uma vez que são profissionais da saúde. Como já destacado, estes(as) profissionais têm sobre si um controle mais rigoroso de suas atuações e têm diversos documentos na Biblioteca Virtual da Atenção Primária em Saúde que abordam a contracepção.

O mais citado pelos(as) profissionais - e aqui novamente centramos nosso olhar para enfermeiros(as) e médicos(as), pois são eles(as) que podem indicar métodos contraceptivos - é o Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual de Porto Alegre. Nele constam todos os métodos disponíveis e ofertados - ou que pelo menos deveriam ser - pelo SUS: anticoncepcional oral combinado, anticoncepcional oral apenas de progestogênio, contracepção de emergência, diafragma, injetável mensal, injetável trimestral, Implanon - em alguns casos mais específicos em jovens que não se adaptaram a outros métodos⁵ - e DIU. (Porto Alegre, 2024b). Ainda, o preservativo peniano e o preservativo interno bem como lubrificante devem ser disponibilizados em todas as unidades de saúde com acesso facilitado (Porto Alegre, 2024b).

Destaca-se em diversos documentos que as jovens mulheres têm direito à escolha de qual método contraceptivo utilizar, como é o exemplo da Nota Técnica Estadual nº 01/2018 de que tem como assunto os adolescentes e o direito de acesso à saúde: "Os adolescentes têm direito: ao planejamento reprodutivo; escolha livre e bem-informada do método contraceptivo

⁵ Em 2024, momento da pesquisa, ainda não havia sido ampliado o acesso ao Implanon pelo Ministério da Saúde, o que foi sinalizado em 2025 (Brasil, 2025).

para o exercício de sua vida sexual; à anticoncepção de emergência, a qual deve ser utilizada nas primeiras 72 horas após a relação sexual desprotegida.” (Rio Grande do Sul, 2018, p. 4).

Mas na prática os(as) profissionais costumam categorizar as jovens, que buscam informações sobre contracepção, como pessoas que são “esquecidas” “não prestam atenção”. Juntando com estas categorias, somam-se aquelas que já falamos aqui e que apontam para a imaturidade. Temos que ter em mente que os(as) profissionais atuam a partir de seus valores e moralidades e, como já vimos, estes têm pânico moral em relação à gestação na juventude e são cercados de regimes morais em torno da sexualidade juvenil que apontam, principalmente, para o fato de existir um momento “certo” para gestar, que seria na adultez e com maior estabilidade financeira.

Logo, os micromecanismos de coerção contraceptiva são extremamente perceptíveis na US. Se os(as) profissionais não desejam que as jovens engravidem, logo, pressionam que elas usem alguma forma de contracepção: “Tem que colocar a contracepção nelas” (Enf. Rafael). Logo, “Então, muito a gente acaba fazendo, né, quase como anticoncepção e prevenção de como, né, de barreira, quase como se fosse epidêmica, assim, né.” (Med. Benjamin).

Este tipo de atuação são os exemplos claros de micromecanismos de coerção contraceptiva onde as jovens não chegam a ser forçadas a utilizar alguns métodos, mas são pressionadas de forma incisiva pelos(as) profissionais. O que, diferente da escola, na maioria das vezes funciona devido a autoridade de saúde que enfermeiros(as) e médicos(as) representam. Na grande maioria das vezes, se estabelece uma relação totalmente vertical entre usuário(a) e profissional sem margem para diálogo, como já destacaram jovens com quem falei nas escolas e entrevistas: “Fui lá e só me falaram para usar esse anticoncepcional e era isso.” (Tatiane, sem experiência reprodutiva).

Se os micromecanismos de coerção aparecem na pressão para utilização do método, também aparecem igualmente nas informações que as jovens recebem acerca destes. O contexto de discussão acerca da contracepção na US é, basicamente, resumido ao momento que as jovens procuram o local para iniciar a contracepção ou no final da gestação/início do puerpério.

Na grande maioria das vezes, as enfermeiras só falavam dos dois tipos de injeção e do anticoncepcional de ciclo de 21 dias nas consultas que acompanhei. Ainda, não explicavam todos os prós e contras dos métodos, como, por exemplo, a perda de libido. Informações sobre Implanon, DIU, diafragma, anticoncepcional oral apenas de progestogênio e contraceptivo de emergência nunca eram citados. A camisinha feminina também nunca fez parte de nenhuma conversa de qualquer consulta que eu já tenha participado e nem foi citada por profissionais durante as entrevistas como algo importante nestas consultas.

Aqui, claramente vemos micromecanismos de coerção contraceptiva quando as profissionais diminuem o número de informações das jovens acerca da contracepção, influenciando diretamente na escolha delas. Normalmente elas acabam escolhendo a injeção e, como a enfermeira Cássia já me relatou, às vezes ela nem cita o anticoncepcional diário, pois sabe que a jovem “provavelmente vai se esquecer.” (Enf. Cássia).

No capítulo oito, trouxemos mais exemplos de atendimentos relacionados à contracepção, mas aqui fica claro novamente como as categorias criadas pelos(as) profissionais, o pânico moral com relação à gestação na juventude e os regimes morais acabam interferindo na implementação das políticas públicas no nível micro.

Olhando para os marcadores sociais da diferença, novamente o gênero ganha centralidade. Jovens homens e jovens mulheres têm acessos muito diversos às informações sobre contracepção, uma vez que com os jovens a temática nunca é discutida. O que por sua vez essa fala, sobre contracepção, ocorre em consultas de início da mesma, sendo somente com mulheres. Nem mesmo em consultas de homens sobre ISTs se discute alguma questão ligada à contracepção e muitas vezes o preservativo peniano não chega a ser citado. Novamente, micromecanismos de acumulação reprodutiva feminina.

Percebemos que a pressão pela contracepção advém justamente pelo fato dos(as) profissionais destacarem que a gestação não deve ser vivenciada por jovens, de camadas baixas, em idade escolar e, em última instância, como já vimos algumas falas, que moram neste território da pesquisa.

Olhando novamente para Crouch (2005) apontamos que os micromecanismos de coerção contraceptiva são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais. Aqui, temos mudanças no que se refere à escola, pois não são micromecanismos de aplicação forte uma vez que os(as) profissionais de saúde falam de um local de maior poder e conhecimento sobre contracepção, o que, em todos os casos que acompanhei, levou à utilização do método que o(a) profissional indicou para a jovem. Eles seguem sendo de saída fácil - caso os(as) profissionais queiram abandonar estes mecanismos - e de bens públicos, pois afetam as jovens que acessam o serviço de saúde em busca de informações sobre a contracepção.

11.2.6 Micromecanismos de omissão da sexualidade

Ao longo da tese, mas majoritariamente no capítulo dez, apontamos para o micromecanismo de omissão da sexualidade, que apesar de não ter sua inspiração nos

mecanismos de governança reprodutiva de Morgan e Roberts (2012), por não influenciar diretamente na reprodução dos(as) jovens, é um fator importante para pensarmos naquilo que é considerado “moral” e “ideal” no que se refere ao gênero. Aqui, as discussões sobre saúde sexual e reprodutiva ficam restritas ao viés cisgênero e heteronormativo.

O micromecanismo de omissão da sexualidade é percebido nas consultas dos agentes de saúde quando não abordam nenhum tema relacionado à orientação ou identidade sexual, apesar de os protocolos de enfermagem - que vimos no capítulo seis - tratarem da importância de se discutir essas temáticas em consulta. Não temos exemplos de atendimentos de médicos(as) e ou enfermeiros(as) onde a temática da sexualidade foi tratada. Até porque, como os(as) jovens já destacaram diversas vezes, eles(as) não se sentem confortáveis de falar sobre isso na US.

Na escola, o micromecanismo de omissão da sexualidade entra em ação quando os(as) professores não discutem aspectos da sexualidade com os(as) estudantes e abordam apenas a reprodução a partir do aspecto biologizante. Vale lembrar que a BNCC destaca a importância de se estudar “argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).” (BNCC, 2017). Como vimos, a professora Monique disse que é um “assunto complicado” e que ela “não aborda mais”. O professor Ricardo destaca que já tentou tratar o conteúdo da orientação sexual em uma aula, mas que “deu muita confusão” - se referindo a um aluno que reclamou da atividade ser uma forma de ideologia de gênero - e que “não faço mais a atividade” (Prof. Ricardo).

O único jovem homem que entrevistei que se entende como um homem gay, Fabrício, refletiu que nunca conversou sobre seu processo de “descobrimento”, como ele se refere, com alguém em uma US e que não se sentiria confortável em conversar até hoje. Ele é aluno da escola B e destaca que também não sente abertura para conversar com nenhum professor(a) sobre a temática. A questão do relacionamento entre jovem e profissional de saúde e/ou da educação é um ponto chave para pensarmos no micromecanismo de omissão da sexualidade, pois quanto mais distante for o relacionamento, mais provável de haver a omissão de discussões sobre orientação, identidade e relacionamentos fora do padrão heteronormativo. A partir de Crouch (2005) apontamos que os micromecanismos de omissão da sexualidade são endógenos, informais, substanciais, de diálogo e verticais - não horizontais.

Agora, partiremos para o capítulo das considerações finais da tese onde faremos um sobrevoo pela tese e traçaremos os pontos mais centrais da discussão aqui feita. Desde já é importante destacar que essa tese não supre - muito pelo contrário - as discussões em torno da implementação de políticas públicas no campo da saúde e da educação no que se refere à saúde sexual e reprodutiva, mas esperamos que as discussões aqui feitas ampliem ainda mais o campo

de estudos que envolve as temáticas aqui trabalhadas.

12. "MAS O QUE TU VAI FAZER COM ESSA PESQUISA, SORA?"

A pergunta que dá título a este capítulo foi feita para mim por Erick, um aluno de dezessete anos da escola A quando apresentei minha pesquisa. Eu poderia falar que essa pesquisa era necessária para finalizar o doutorado, mas de que adiantaria isso? Os jovens daquela escola muitas vezes nem conhecem a universidade, então quem dirá o conceito de doutorado. E eu também nunca vi essa tese apenas como uma etapa para a obtenção de mais um título.

Assim, eu comecei explicando para Erick que eu queria olhar para o dia a dia dele e dos(as) outros(as) jovens dentro das escolas do bairro e em uma US para entender se tinha alguma aula que envolvesse temas relacionados à sexualidade e se eles(as) iriam na US para buscar, por exemplo, mais informações sobre a utilização dos métodos contraceptivos. Eu seguia falando que depois de ver isso, a ideia era escrever sobre e apresentar para os(as) professores(as), funcionários(as) de US e também “pessoal da Secretaria de Saúde e Educação que cuidam de como vai ser a educação e saúde de vocês, para que eles(as) vejam melhorias a serem feitas.” (Bárbara). Erick falou: "Legal, Sora. Estamos precisando melhorar mesmo." (Erick, sem experiência reprodutiva). Assim como Erick destacou, espero que essas reflexões ajudem a “melhorar”.

A escolha da temática da tese e dos objetivos aqui trabalhados se deu a partir da vontade da pesquisadora, por óbvio, de estudar a temática da SSR juvenil, mas o foco em olhar para a implementação no nível de rua, levando em conta que a saúde e a educação veio através de leituras do campo de políticas públicas, antropologia das políticas públicas e de uma revisão narrativa da literatura acerca do que se tem discutido no Brasil sobre a temática de SSR juvenil, saúde e escolas.

Esta revisão está descrita com mais detalhes no capítulo quatro da tese, onde analisamos 78 artigos e notamos pontos de interesse e reflexão importantes: pouquíssimos estudos traziam o ponto de vista dos(as) jovens acerca da SSR em escolas e nas US; poucos estudos realizaram observações de cunho etnográfico em maior profundidade; as pesquisas focaram em jovens mulheres e não traziam a percepção dos jovens homens; os estudos focaram fortemente na gestação e muito pouco em outros temas como contracepção, ISTs e outros pontos da SSR como prazer sexual, por exemplo; e nenhum estudo analisava com um olhar mais crítico a SSR juvenil a partir da literatura de implementação de políticas públicas tendo uma atenção especial para o

conceito de agência (Maynard-Moody; Musheno, 2022) ou governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012).

A partir dessas lacunas, esta tese se propôs a olhar para o campo de políticas públicas centrada na fase da implementação das políticas, mais especificamente na famosa burocracia de nível de rua (Lipsky, 1980). Aqui, a partir de autores como Lotta (2010, 2022, 2015), Fernandez e Guimarães (2020), Oliveira (2012), Ferreira e Medeiros (2016) e Bonelli et al (2019) se pode perceber que para entender a implementação das políticas é preciso estar atento ao cotidiano dos(as) agentes implementadores e observar como estes(as) agem para além dos regimentos e normas que direcionam suas atuações.

Através da centralidade dos(as) agentes de nível de rua, o foco se deu em relação a dois autores que aqui foram centrais: Maynard-Moody e Musheno (2012, 2022). Eles apresentam o conceito de agência e atentam para como os(as) profissionais têm diferentes valores e moralidades que influenciam diretamente na forma com que eles(as) atuam.

Neste momento também são feitas conexões com os estudos de antropologia das políticas públicas, que apontam para a centralidade dos(as) profissionais da linha de frente na implementação de políticas públicas, olhando para seus valores e ações cotidianas, bem como as relações que estabelecem com os(as) usuários(as) das políticas, visto que estes encontros são decisivos na implementação (Shore; Wright, 1997). Por isso, focamos também em realizar rodas de conversa e entrevistas com jovens homens e mulheres que estão no território, visto que eles(as) também têm papel de destaque na implementação.

Vale destacarmos o quanto a relação entre o campo de políticas públicas e as leituras do campo de antropologia das políticas públicas foi benéfico para o desenvolvimento da tese, tanto a partir de convergências teóricas, no que se refere à centralidade dos agentes da linha de frente para a implementação de políticas públicas, quanto a importância das relações estabelecidas entre agentes e usuários(as) e um olhar aguçado para os valores e moralidades dos(as) profissionais. Ademais, a antropologia das políticas públicas nos deu apoio ao escolhermos trabalhar com observações de cunho etnográfico e rodas de conversa com os(as) jovens alunos(as), pontos que se tornaram essenciais para a análise aqui desenvolvida.

Após decidirmos olhar para a agência dos(as) profissionais de saúde e da educação, focamos nos valores e nas moralidades destes(as) profissionais no que tange a saúde sexual e reprodutiva e foi em leituras de antropologia que encontramos a noção de mecanismos de governança reprodutiva (Morgan; Roberts, 2012).

Relacionamos, então, a noção de agência com a de governança reprodutiva a partir da ideia de que a agência dos(as) profissionais pode ser percebida a partir de seus

micromecanismos de ação cotidiana e, no nosso caso, micromecanismos de governança reprodutiva uma vez que estamos tratando da SSR juvenil. Para estruturar os micromecanismos no contexto de atuação dos(as) profissionais de saúde e da educação, apontamos também para as noções de regimes morais (Morgan; Roberts, 2012) e de pânico moral (Bozon, 2012).

Tendo essa reflexão teórica formulada, partimos para o campo de pesquisa e, através das experiências ali coletadas, criamos os quatro micromecanismos de governança reprodutiva que analisamos ao longo da tese: contenção reprodutiva, coerção contraceptiva, acumulação reprodutiva feminina e vigilância reprodutiva. Ademais, o micromecanismo de omissão da sexualidade é central para entendermos como se dão as discussões sobre saúde sexual, ou melhor, a falta delas.

Estes cinco micromecanismos estão inseridos dentro de um território, elemento central para a nossa discussão e para o qual dedicamos o quinto capítulo da tese. É no território que se inscreve o cotidiano das políticas públicas, ele não é visto apenas como um lugar, mas como um espaço social de extrema relevância na vida cotidiana no acesso à cultura, à saúde, ao lazer, à educação, à habitação, entre outros direitos básicos. Aqui, analisamos um território marcado por vulnerabilidades sociais, forte presença do tráfico e pouca perspectiva de ascensão social por parte da comunidade. Destacamos, então, que este é um território conflagrado, utilizando da definição de Costa, Baptista e Cunha (2022).

Ao olharmos para o território, focamos especificamente na escola A, escola B e na US. Vimos que estes três espaços apresentam desafios de infraestrutura, falta de equipe e falta de equipamentos adequados. Também, os(as) profissionais dos três locais se encontram mentalmente esgotados e sobrecarregados com a carga de trabalho intensa, relações internas conflituosas e falta de material - no caso da US - ou com o desrespeito de alunos(as), salários baixos e currículo atual das escolas - no caso das escolas A e B.

Também é importante ressaltar que tanto agentes de saúde quanto de educação não receberam formações acerca da saúde sexual e reprodutiva juvenil, ao longo de sua vida profissional. Os professores e a professora de Biologia destacam que aprenderam o básico sobre reprodução a partir de um viés biologicista na universidade, enquanto que nenhum profissional da US já teve alguma formação sobre SSR junto da prefeitura ou de outra instituição. Este é um ponto para se ter em mente quando tentamos entender as faltas de discussão sobre SSR no ambiente escolar e da US e a agência destes(as) profissionais.

Ao longo da tese, buscamos analisar como a agência de profissionais de saúde e educação pode ser percebida a partir de micromecanismos, sendo uma função importante a da relação que se estabelece entre usuário(a) e agente (Raaphost, 2018; Bartel, 2014, Shore;

Wright; Però, 2011, Bruhn; Ekström, 2017, Wendel et al, 2005) e também as categorias que os(as) profissionais utilizam em seus cotidianos (Barberri, 2022, Lotta, 2015, Lotta; Kirschbaum, 2022, Lotta, 2019; Lotta; Costa, 2020), sendo que a categoria “imatura”, por exemplo, já nos dá indícios da utilização de micromecanismos de contenção reprodutiva, coerção contraceptiva e vigilância reprodutiva.

Também, para a análise dos micromecanismos é importante destacar Crouch (2005) e sua categorização dos mecanismos que nos ajudou a entender mais do cotidiano de atuação dos(as) profissionais nesta tese. Normalmente os micromecanismos de governança reprodutiva são endógenos, informais - baseados em costumes e normas sociais -, substanciais - focam no tema da gestação na juventude -, de diálogo - ocorrem a partir das conversas com jovens - e verticais - não horizontais.

Buscamos atentar para cada um dos objetivos da pesquisa, olhando para as leis e normas que regem o trabalho dos(as) professores(as) de Biologia e que atuam na US e observar se eles(as) fazem uso dessas normas e diretrizes. O que observamos é que estas políticas, que seriam a base de trabalho deles(as), não são seguidas à risca no cotidiano, dando lugar a diversos valores e moralidades dos agentes através dos micromecanismos de governança reprodutiva. E vemos isso ao longo de toda a tese, tanto quando falamos de contracepção, até chegar ao ponto da falta de discussões acerca da violência sexual, por exemplo.

Ao termos analisado as relações que se estabelecem entre os(as) agentes e jovens no domínio da saúde sexual e reprodutiva juvenil percebemos como os(as) profissionais da US têm relações distanciadas com os(as) jovens, onde estes(as) não se sentem confortáveis de abordarem questões referentes à saúde sexual e reprodutiva. Este é um fator complicador no cotidiano de implementação das políticas, uma vez que os relacionamentos criados interferem diretamente na forma com que a política é implementada. Na escola, os relacionamentos seguem distantes, apenas com exceção de uma professora, Monique, que é a “mãezona” dos(as) alunos(as), mas apesar desse relacionamento aproximado, ela não abarca questões de saúde sexual e reprodutiva em seu cotidiano de trabalho.

Também examinamos a experiência dos(as) jovens no serviço público de saúde quanto à sua saúde sexual e reprodutiva e, como, no ambiente escolar, se dão as discussões acerca da saúde sexual e reprodutiva dos jovens. Nas escolas, os silêncios em torno da temática da SSR eram sempre mais volumosos do que as discussões em sala de aula. Falar sobre gênero, sexualidade e sexo era considerado raro pelos(as) alunos(as) e os(as) professores(as) de Biologia que acompanhei destacavam sempre falar sobre “prevenir a gravidez”, mas nunca uma discussão sobre coerção sexual, por exemplo.

Quando se trata da Unidade de Saúde, as jovens acessam a mesma, majoritariamente, para tratar da contracepção e/ou gestação, sendo que outras discussões que abarcam a SSR não são trazidas pelas jovens e/ou pelos(as) profissionais de saúde. Já os jovens acessam menos ainda a US e quando o fazem referente à SSR é apenas em casos extremos - que estejam com dor e/ou ferimento visível - para tratar de ISTs. Também, nenhuma discussão é levantada sobre gestação, contracepção ou outro fator relacionado ao sexo ou sexualidade.

A tese buscou identificar de que forma o cotidiano dos(as) agentes de escolas e unidade de saúde revelam micromecanismos de governança reprodutiva em relação a jovens porto-alegrenses residentes em uma periferia. Ao longo da tese tivemos capítulos para falar de contracepção, gestação e ISTs, questões centrais para professores(as) e funcionários(as) da US, quando se fala em SSR, e tivemos um capítulo justamente focado na lacuna das discussões das demais temáticas que abarcam a SSR como coerção e violência sexual, orientação sexual e sexualidade, prazer sexual e discussões sobre gênero.

Vimos aqui que o micromecanismo de contenção reprodutiva é constantemente acionado pelos(as) agentes de educação sempre que encontram a oportunidade de falar sobre gravidez com os(as) jovens, seja em conteúdos de aulas ou no cotidiano. Também os(as) agentes de saúde fazem uso dos micromecanismos de contenção reprodutivas em consultas de jovens que querem iniciar o uso do contraceptivo, falando sobre a importância para não ter “problema” de engravidar e também para jovens que querem gestar, buscando dissuadir as mesmas da ideia de uma gestação na juventude, “pois não é a hora certa” (Enf. SRT).

Já o micromecanismo de coerção contraceptiva é percebido tanto nas escolas quanto na US, mas na última com maior força, quando os(as) profissionais tratam da contracepção com as jovens. Eles(as) não abordam todos os métodos contraceptivos disponíveis pelo SUS e ainda direcionam jovens a usarem x método ao invés de y. Professores em escolas, inclusive, transmitem informações errôneas sobre o uso de contraceptivo. E vale pontuar que estes direcionamentos sempre para as jovens mulheres e nunca trazendo essa preocupação para os jovens homens.

Isso nos leva ao terceiro micromecanismo: acumulação reprodutiva feminina. Sempre, tanto nas falas de profissionais das escolas quanto da US, as jovens sempre são lembradas do “problema” de engravidar e das responsabilidades, enquanto que, como destacou a professora Monique em entrevista, ela lembra os jovens de usar camisinha para “não pegar pereba” e não para não engravidar. Segundo todos(as) os(as) profissionais que entrevistei e conversei, é a jovem que tem a responsabilidade de criar o(a) filho(a) e seus discursos no cotidiano de sala de aula e/ou atendimentos reforça esse papel.

Aqui, vale uma atenção especial para o cuidado que é uma palavra e foi fio condutor ao longo de toda a tese: o cuidado para não ter filho e o cuidado do filho. Como Federici (2017, 2019) destaca, o cuidado é desde o princípio imposto como algo feminino, sendo o trabalho reprodutivo e feminino em sua totalidade. Ao longo da pesquisa, percebemos como o cuidado é associado ao feminino quando são as meninas que têm que cuidar para não engravidarem, pois a responsabilidade será delas. Elas têm que cuidar da criança depois que ela nasce e, quando elas não são as principais cuidadoras das crianças, o papel fica com as avós, como me contaram três jovens que eu entrevistei.

Ainda, o micromecanismo de vigilância reprodutiva é percebido somente na US, onde as EeSF devem ficar atentas às jovens gestantes para que sigam o pré-natal de forma correta, pois são mais “imaturas” e “irresponsáveis”, como alguns categorizam. Esse olhar atento passa por sempre verificar se as jovens estão indo às consultas e, em alguns casos, fazer mais VDs para analisar a situação das jovens gestantes.

Por fim, se faz importante citar o micromecanismo de omissão da sexualidade que acompanha o cotidiano das escolas A e B e da US. A falta de discussão sobre identidade e orientação sexual bem como relacionamentos para além do padrão heterossexual é recorrente na US quando os(as) profissionais destacam não falar sobre essas temáticas, salvo quando algum(a) jovem solicitar em consulta. Nas escolas, o assunto é um tabu sendo que somente o professor Ricardo abordou em um ano brevemente o tema da orientação sexual com os(as) estudantes e depois parou porque era “muito complicado” (Prof. Ricardo).

É importante lembrarmos que a utilização de micromecanismos pelos(as) profissionais de saúde e da educação revelam maneiras deles(as) atuarem para além daquilo que a norma escrita apresenta e também são formas que os(as) próprios(as) profissionais encontraram para trabalhar com uma temática que é “delicada e complicada”, como já destacou a enfermeira Polina, e que tem inúmeros tabus e controvérsias no entorno.

Aqui, para além do fato dos valores e das moralidades dos(as) profissionais influenciarem na forma com que eles(as) trazem os micromecanismos, o ponto central é que a comunidade ao redor dos(as) profissionais - seja comunidade escolar, pais, responsáveis e sociedade num geral - precisaria ser mais aberta às discussões sobre SSR nas escolas e USs, pois o conservadorismo e tabus em torno da SSR da sociedade interferem, por certo, na forma dos(as) agentes atuarem em seus cotidianos e utilizarem os micromecanismos.

Ainda, os(as) profissionais deveriam ter mais tempo disponível no dia a dia para abordar a saúde sexual e reprodutiva, seja em aulas ou em consultas na US, pois, como vimos, por exemplo, o tempo de consulta de um(a) médico(a) é de vinte minutos, o que é pouco para

desenvolver assuntos mais avançados acerca da SSR. Além do tempo, a falta de maiores recursos financeiros é um ponto a ser levado em conta ao, por exemplo, pensarmos no motivo de os(as) profissionais não falarem sobre o DIU com as jovens, pois sabem que é preciso se deslocar até o centro da cidade para fazer o procedimento e muitas delas não têm condições financeiras.

Outro fator é a falta de incentivo e apoio dos(as) superiores(as) para que atividades acerca da SSR aconteçam na US ou nas escolas. Caso a gerência da US, a diretoria da escola e as próprias secretarias de Saúde e Educação do município de Porto Alegre dessem mais atenção à temática da SSR, os(as) profissionais se sentiriam mais encorajados a discutir o assunto em salas de aula. Junto disso, não podemos deixar de apontar para o fato de que, como todos(as) os(as) agentes de saúde e educação já destacaram ao longo das entrevistas e observação do cotidiano, eles(as) não possuem formações acerca de SSR juvenil durante a graduação ou após, junto das secretarias de Educação e Saúde. Como trabalhar uma temática que eles(as) nunca tiveram acesso?

Outro ponto que também influencia os(as) agentes na utilização dos micromecanismos é o fato de que as relações que se estabelecem entre agentes e usuários(as) - no nosso caso, os(as) jovens - são relações hierarquizadas de diálogo vertical e que dificultam uma relação mais aproximada em que ambas as partes se sintam confortáveis para tratar, por exemplo, da identidade sexual levando à utilização de micromecanismos de omissão da sexualidade.

Assim, após trazermos todo esse contexto de atuação dos(as) agentes, é importante destacar que os micromecanismos de coerção contraceptiva, a contenção reprodutiva, a omissão da sexualidade, a acumulação reprodutiva feminina e a vigilância reprodutiva, além de revelarem regimes morais e pânico moral dos(as) agentes, também são formas destes(as) criarem escudos para se protegerem em seus cotidianos de trabalho. Proteção contra a direção das escolas, a gerência da US, as secretarias de Saúde e da Educação e principalmente, a comunidade como um todo, sobretudo pais e responsáveis, que - num geral - também são guiados pela onda de conservadorismo, que entende que as discussões sobre SSR devem ser silenciadas. Se os(as) agentes de saúde e da educação possuem regimes morais e pânico moral em relação à SSR juvenil é, em partes, também porque eles(as) estão em uma sociedade que, num geral, alimenta o tabu em torno da temática.

O que nos fica claro ao realizarmos a leitura da atuação de profissionais das escolas e da US em relação à SSR é o fato de que os direitos sexuais e reprodutivos juvenis não estão sendo plenamente respeitados, principalmente os direitos das jovens. São as jovens mulheres de camadas populares entre 16 e 19 anos e em sua maioria negras as que mais sentem no corpo

a ação dos micromecanismos de coerção contraceptiva, da contenção reprodutiva, da acumulação reprodutiva feminina e da vigilância reprodutiva.

Como poderíamos, então, pensar em SSR nas escolas e unidades de saúde de uma forma que respeitasse os direitos sexuais e reprodutivos dos(as) jovens? Temos algumas ideias - criadas a partir daquilo que os(as) jovens falam sobre as aulas e a atenção primária em saúde e daquilo que vimos no cotidiano destes espaços - que podem vir a ajudar profissionais de saúde e educação a pensar em suas atuações e a quem mais interessar.

Começando pelas escolas, acreditamos que o ponto chave para tratar da saúde sexual e reprodutiva é o diálogo com os(as) jovens e o respeito a estes(as) e as suas opiniões sempre que se abordar as temáticas de gestação, contracepção, ISTs, sexualidade ou qualquer outro assunto que envolva a saúde sexual e reprodutiva. É preciso que os(as) profissionais das escolas tratem os(as) jovens como pessoas que têm capacidade cognitiva para discutirem aspectos de sua saúde sexual e reprodutiva, pois apenas assim os(as) agentes tratarão destas temáticas com o devido cuidado e profundidade que merecem. E aqui falamos em profissionais para além dos(as) professores(as) de Biologia e/ou Ciências. O professor de História pode abordar, por exemplo, sobre a sexualidade, ao trazer a discussão da Grécia Antiga para sala de aula.

Podemos falar da discussão que é mais recorrente na escola: gestação. Normalmente, como vimos, os(as) professores(as) “colocam medo” nos(as) alunos(as) para que estes(as) não gestem e apontam para o uso do preservativo peniano como principal método de contracepção. Entendemos que haveria uma discussão muito mais engajada e frutífera em sala de aula caso o(a) professor(a) tratasse de como ocorre a gestação em uma roda de conversa, dando espaço para que os(as) jovens destaquem o que pensam sobre a gravidez e depois apontasse as várias formas de prevenção disponíveis no SUS para aqueles(as) que quisessem fazer uso delas, sem pressionar de maneira verticalizada os(as) estudantes a não gestarem. Justamente, os direitos reprodutivos se referem ao(à) jovem poder escolher quando e como gestar, tendo conhecimento de como ocorre o processo e quais suas consequências para que então ele(a) faça a escolha.

Outra opção de discussão de aspectos que abrangem a SSR é, por exemplo, a violência sexual a partir da organização de diferentes atividades envolvendo vários componentes curriculares da escola, durante a semana em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Nas aulas de Português, por exemplo, os(as) jovens poderiam redigir textos sobre os direitos das mulheres e a violência sexual. Nas aulas de matemática, os cálculos poderiam trazer números acerca da violência de gênero no Brasil, no Estado e em Porto Alegre. Na aula de história, poderia se discutir a origem do Dia Internacional da Mulher e sua importância hoje em nossa sociedade.

Para realizar esse tipo de atividade é cada vez mais necessário que os(as) profissionais enfrentem o “tabu”, expressão que os(as) professores(as) e alunos(as) que acompanhei trazem constantemente como a principal barreira para se falar sobre a sexualidade. Este “tabu” em torno da SSR é alimentado constantemente por discursos conservadores e por uma agenda que prega a heterossexualidade como norma. Os(as) profissionais, por óbvio, estão inseridos dentro de nossa sociedade e têm contato com este tipo de visão, a qual alimenta, em maior ou menor grau, os valores e pânico moral dos(as) agentes de educação em torno da SSR juvenil. O mesmo vemos no que se refere ao campo da saúde.

Neste caso, o caminho para garantir os direitos sexuais e reprodutivos dos(as) jovens não é muito diferente da escola: é necessário um diálogo horizontal, respeitando os interesses dos(as) jovens e dando abertura para que estes(as) se sintam confortáveis para trazerem aspectos para as consultas, para além da contracepção, como, por exemplo, identidade sexual.

Um “caso clássico” de possibilidade de mudanças dentro do cotidiano da US é nos atendimentos de planejamento familiar com jovens mulheres. O próprio Protocolo de Pré-Natal de Risco Habitual de Porto Alegre (Porto Alegre, 2024b) destaca que as consultas de planejamento familiar devem se basear no diálogo e respeitar os interesses das pessoas envolvidas no atendimento. Destacamos aqui a importância dos(as) profissionais conduzirem as consultas de planejamento familiar desta forma mais horizontal e com um acolhimento voltado para o diálogo e não um pré-julgamento da jovem que deseja gestar. Dessa forma, ao iniciar uma consulta em que a jovem afirma “quero engravidar”, o(a) agente de saúde deve explicar para ela como funcionaria o processo, o que é importante utilizar ou não, que cuidados são necessários, visando sempre o acompanhamento de saúde para escolha consciente da jovem.

Outro exemplo possível para trabalhar de forma mais horizontal e sem “tabus” a temática da SSR seria a criação de mais espaços de diálogos entre profissionais da US e jovens para além do consultório. Nesse sentido, o Programa Saúde na Escola pode ser mais desenvolvido em se tratando de atividades sobre SSR pensando em, por exemplo, rodas de conversas acerca da contracepção, gestação e sexo. Nestas rodas, a ideia é que os(as) profissionais possam escutar os(as) jovens em suas dúvidas e criar um vínculo para que estes(as) se sintam confortáveis em discutir sua saúde sexual e reprodutiva na US.

Também, um espaço possível para abordar a SSR é com a própria criação de um grupo para tratar da saúde juvenil na US. O grupo poderia se reunir semanal ou quinzenalmente - dependendo da demanda - e nele se discutiria com os(as) jovens sobre acesso e cuidados com a saúde juvenil, abrangendo ali também a SSR com discussões sobre prazer sexual, por exemplo.

Estes exemplos são pensados a partir de uma necessidade percebida ao longo da tese, principalmente segundo as falas dos(as) jovens que apontam para uma relação verticalizada e distanciada com as escolas e unidades de saúde. Acreditamos que se os(as) agentes de saúde e de educação abrirem mais espaços para o diálogo, respeitarem os interesses dos(as) jovens e confiarem que os(as) jovens têm capacidades cognitivas para discutir mais sobre SSR, os micromecanismos que são hoje em dia utilizados pelos(as) profissionais seriam menos presentes no cotidiano de atuação.

Antes de finalizarmos este texto é necessário falar que apesar dos esforços empreendidos ao longo desta pesquisa, é necessário reconhecer alguns pontos de possíveis melhorias. Um primeiro ponto - que fugiu de nosso controle, mas que acabou nos atingindo - é que a pesquisa de campo pôde ser iniciada apenas após o período das enchentes em Porto Alegre em 2024, o que diminuiu em dois meses o tempo de acompanhamento das escolas e da US.

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, a análise concentrou-se em um grupo específico, em um território específico, o que limita a apreensão de experiências e perspectivas mais diversas. Investigações futuras poderiam contemplar outros atores, ampliando o diálogo entre diferentes narrativas e contribuindo para uma compreensão mais plural do fenômeno.

Outro ponto foi a escolha de acompanharmos apenas uma US do território e não mais de uma. Essa escolha se deu devido ao tempo e ao espaço para o estudo, decidindo focar em uma, por ela ser a maior Unidade, e a que recebe a maioria dos jovens da comunidade, ficando próxima das escolas de Ensino Médio que acompanhamos, mas entendemos que a análise ficaria mais completa com o acompanhamento das outras USs que fazem parte do território.

Pensando nas possibilidades para o campo de pesquisa, acredito que novas pesquisas podem trabalhar a partir da noção de micromecanismos de coerção contraceptiva, de contenção reprodutiva, de acumulação reprodutiva feminina e de vigilância reprodutiva.

Esperamos que essa lente possa trazer mais reflexões acerca da saúde sexual e reprodutiva juvenil e adulta tanto em escola, quanto em unidades de saúde e espaços de assistência social - como CRAS e CREAS -, espaços como Conselhos Tutelares, espaços de acolhimento de crianças e jovens, entre tantos outros ambientes que usam de mecanismos para o controle da saúde sexual e reprodutiva da população, principalmente feminina.

Aqui, entendemos que as lacunas nas discussões em torno da saúde sexual e reprodutiva, nas escolas e na US, são resultados de uma agenda conservadora que vem crescendo no Brasil desde os anos 2010, assumindo seu auge com o bolsonarismo e em crescente nos últimos anos. As tentativas de silenciar as discussões sobre SSR, principalmente nas escolas, são percebidas

a nível nacional e, como vimos aqui, também local. O silêncio foi meu companheiro constante nesta pesquisa, infelizmente.

Por fim, a pergunta que mobilizou e foi pano de fundo de toda a tese: Quem pode decidir quando e como gestar? Os(as) profissionais, de saúde e da educação, que acompanhei diriam que mulheres jovens, de baixa renda e em situação de vulnerabilidade não deveriam ter essa liberdade de escolha. No final, os micromecanismos de governança reprodutiva são utilizados justamente para controlar o direito à reprodução e, em última instância, o direito ao corpo das jovens dos territórios periféricos.

REFERÊNCIAS

ABELLA, J. **Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada**. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2002. (Serie Sociología, S2001/03).

ABRAMO, H. W.; VENTURI, G.; CORROCHANO, M. C. Estudar e trabalhar: um olhar qualitativo sobre uma complexa combinação nas trajetórias juvenis. **Novos Estudos Cebrap**, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 523-542, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/nec/a/HffJZGdxz6Z36cqybFwQ5nH/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 15 ago. 2024.

ACOSTA, T. Produções de verdade perante as vivências da sexualidade juvenil a partir da troca de fotos em aplicativos de celulares. **Revista Periódicus**, Salvador, v. 1, n. 12, p. 384-403, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/28280>. Acesso em: 15 mar. 2024.

ALEGRIA, P. "Vai ter viado se beijando, sim!": gênero, sexualidade e juventude entre alunos do movimento estudantil secundarista de uma escola pública federal do Rio de Janeiro. **Teoria e Cultura**, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, p. 44-62, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/TeoriaeCultura/article/view/12395>. Acesso em: 20 abr. 2024.

ALMEIDA, V. R.; SILVA, C. G. "Religião não se discute?": decifrando a construção dos papéis sociais entre jovens de escola pública em São Vicente/SP a partir de uma perspectiva de gênero. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, Salvador, v. 1, n. 1, p. 76-95, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/14775>. Acesso em: 10 maio 2024.

ALMEIDA, E. L. As lutas no campo da sexualidade: diversidade sexual na educação e além dela. In: **ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO NORDESTE**, 24., 2018, João Pessoa. Anais [...]. João Pessoa: ANPED, 2018. Disponível em: http://anais.anped.org.br/regionais/sites/default/files/trabalhos/12/3829-TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf. Acesso em: 1 maio 2024.

ALMEIDA, E. S.; SANTOS, E. M. D.; SOUZA, R. Prevenção ao câncer de próstata, masculinidade e cuidado: articulações possíveis a partir de revisão bibliográfica. **Revista APS**, Juiz de Fora, v. 23, n. 1, p. 76-90, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/26062>. Acesso em: 14 set. 2024.

ALMEIDA, M. Intersectorialidade e melhorias urbanas em territórios periféricos: o caso de São Miguel Paulista. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 37, n. 109, p. 41-56, set. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/rpRgtx4TLCjg3fNZBprG8QP/?lang=pt>. Acesso em 20 mai. 2025.

ALTMANN, H. Educação sexual em uma escola: da reprodução à prevenção. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 136, p. 175-200, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/KXthwVJ3PzMtmSpycSxbPyQ/abstract/?lang=pt>. Acesso em 23 mai. 2024.

- ALTMANN, H. Orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 575-585, 2001. DOI: 10.1590/S0104-026X2001000200014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/PthD6cgdcDC7MMvJw5zxXDr/abstract/?lang=pt>. Acesso em 20 jun. 2025.
- ALVARENGA, L. M. C. A.; MARTINS, C. L. De que território os médicos do Programa de Saúde da Família estão falando? **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 17, p. 16-23, 2010. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/176>. Acesso em 12 abr. 2024.
- AMARAL, E. et al. Gravidez na adolescência: análise de fatores de risco para baixo peso, prematuridade e cesariana. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 8, p. 2453-2462, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/gBmNMnrVBmqpjV9GBNqGx5r/?lang=pt>. Acesso em 22 jun. 2024.
- AMORIM, R. M.; MAIA, A. C. B. Sexualidade na adolescência: dúvidas de alunos de uma escola pública. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 7, n. 4, p. 95-106, 2013. DOI: 10.21723/riaee.v7i4.6290. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/6290>. Acesso em 9 jan. 2025.
- AQUINO, E. M. L. et al. Adolescência e reprodução no Brasil: a heterogeneidade dos perfis sociais. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 7, p. 1377-1388, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/6khBZqPXRp49jJxKLWrGJbJ/?format=html&lang=pt>. Acesso em 25 abr. 2025.
- ASSIS, M. **Burocratas de nível de rua do Sistema Único de Assistência Social: o que fazem, como interagem e classificam usuários?** 2023. 228 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/2ed741da-7fba-45af-a63e-000c983b5b51>. Acesso em 12 mar. 2025.
- BABBIE, E. **The practice of social research**. 14. ed. Boston: Cengage Learning, 2014.
- BARATA, R. B. Relações de gênero e saúde: desigualdade ou discriminação? In: BARATA, R. B. **Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. p. 73-94.
- BARBOSA, N. G. et al. Oficinas de educação sexual e reprodutiva para adolescentes. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, Chapecó, v. 13, n. 2, p. 187-199, 2022a. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RBEU/article/view/12487>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- BARBOSA, N. G. et al. Educação sexual na adolescência: relato de experiência de três anos no Programa Educacional Pequeno Cientista. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, Chapecó, v. 13, n. 3, p. 277-290, 2022b. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RBEU/article/view/12488>. Acesso em: 4 dez. 2024.

BARDACH, E. **The implementation game**: what happens after a bill becomes a law. Cambridge: MIT Press, 1977.

BARBERI, N. Categorização e discricionariedade na implementação de políticas públicas. In: CIORDIA, C. et al. (org.). **Por una antropología de las políticas públicas**: perspectivas de análisis y cambios de signo en la región. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2022. p. 145-178.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARNES, L.; FLEDDERJOHANN, J. Reproductive justice for the invisible infertile: a critical examination of reproductive surveillance and stratification. **Sociology Compass**, v. 14, n. 8, e12745, 2020. DOI: 10.1111/soc4.12745. Disponível em: <https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12745>. Acesso em: 3 fev. 2025.

BARROS, C. T. et al. "Mas se o homem cuidar da saúde fica meio que paradoxal ao trabalho": relação entre masculinidades e cuidado à saúde para homens jovens em formação profissional. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 423-434, abr. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/LYvZz3DxY4t83kVqV9wRNkN/abstract/?lang=pt>. Acesso em 20 jun. 2025.

BARTELS, K. P. R. Public encounters: the history and future of face-to-face contact between public professionals and citizens. **Public Administration**, Oxford, v. 91, n. 2, p. 469-483, 2013. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9299.2012.02101.x>. Acesso em 23 dez. 2024.

BARTELS, K. P. R. **Communicative capacity**: public encounters in participatory theory and practice. Bristol: Policy Press, 2014.

BASTOS, G. D.; LÜDKE, E. Reflexões sobre gênero no ensino de biologia: um olhar sobre o discurso de estudantes do primeiro ano do ensino médio acerca da gravidez na adolescência. **Revista Contexto & Educação**, Ijuí, v. 32, n. 101, p. 142-174, 2017. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/6690>. Acesso em: 6 jul. 2024.

BEAUD, S.; WEBER, F. **Guia para a pesquisa de campo**: produzir e analisar dados etnográficos. Tradução de Sérgio Joaquim de Almeida. Petrópolis: Vozes, 2007.

BELLENZANI, R.; SANTOS, A. O.; PAIVA, V. Agentes comunitárias de saúde e a atenção à saúde sexual e reprodutiva de jovens na estratégia saúde da família. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 637-650, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/3nnc4VdjycJrry55mddmxgM/?lang=pt>. Acesso em; 24 mai. 2025.

BEN AYED, C.; BROCCOLICHI, S. Quels liens entre réussite scolaire, inégalités sociales et lieu de scolarisation? **Revue Ville École Intégration Diversité**, Paris, n. 155, p. 66-71, déc. 2008. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2008_num_155_1_3002. Acesso em 10 abr. 2025.

BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. **A construção social da realidade**: tratado de sociologia do conhecimento. Tradução de Floriano de Souza Fernandes. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 1985.

BERQUE, A. Território e pessoa, a identidade humana. **Revista de Ciências Sociais PUC-Rio**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 11-23, 2010. Disponível em: <https://krisis.puc-rio.br/index.php/krisis/article/view/100>. Acesso em: 15 mar. 2025.

BEZERRA, Y. R. N.; FEITOSA, M. Z. S. A afetividade do agente comunitário de saúde no território: um estudo com os mapas afetivos. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 813-822, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/TjrZ6csxpxBwtYQk7cyYssj/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BICHARA, C. N. C. et al. Análise das percepções de profissionais da saúde e usuários atendidos em uma unidade básica de saúde acerca da saúde do homem. **Peer Review**, [s. l.], v. 5, n. 19, p. 270-284, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373347882_Analise_das_percepcoes_de_profissionais_da_saude_e_usuarios_atendidos_em_uma_unidade_basica_de_saude_acerca_da_saude_do_homem. Acesso em: 22 maio 2025.

BITTENCOURT, T. A.; FARIA, J. R. V. Distribuição de investimentos públicos, infraestrutura urbana e desigualdade socioespacial em Curitiba. **Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 13, p. e20190300, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/f4FLrDnMPZr5mzfKxYGRMry/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 05 jun. 2025.

BONELLI, F. et al. A atuação dos burocratas de nível de rua na implementação de políticas públicas no Brasil: uma proposta de análise expandida. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 17, n. esp., p. 800-816, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/wt3kd4KCtSJB39TwQTjpVFfn/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 12 jun. 2025.

BORDUQUE, G. B. et al. Educação sexual e a importância de sua abordagem em ambiente escolar: prática pedagógica voltada a adolescentes de uma escola pública de ensino fundamental. **Metodologias e Aprendizado**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 283-298, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/metapre/article/view/5648>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BORGES, R. O.; BORGES, Z. N. Pânico moral e ideologia de gênero articulados na supressão de diretrizes sobre questões de gênero e sexualidade nas escolas. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 23, e230039, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/PK43y8kghf9JDty4pftJS4n/abstract/?lang=pt>. Acesso em 20 abr. 2025.

BOZON, M. **Sociologia da sexualidade**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

BOZON, M. Amor, sexualidade e relações sociais de sexo na França contemporânea. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 122-135, 2009. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/ref/v03n01/v03n01a08.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2024.

BOZON, M. **Sociologie de la sexualité**. 3. ed. Paris: Armand Colin, 2012.

BOZON, M.; HEILBORN, M. L. Iniciação à sexualidade: modos de socialização, interações de gênero e trajetórias individuais. In: HEILBORN, M. L. et al. (org.). **O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros**. Rio de Janeiro: Garamond: Fiocruz, 2006. p. 155-205.

BOZON, M.; RENNES, J. Histoire des normes sexuelles: l'emprise de l'âge et du genre. **Clio. Femmes, Genre, Histoire**, [s. l.], n. 42, p. 7-23, 2015. Disponível em: <https://journals.openedition.org/clio/12823?lang=fr>. Acesso em 12 mai. 2024.

BRANCO, E. P. et al. Uma visão crítica sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular em consonância com a reforma do Ensino Médio. **Debates em Educação**, Maceió, v. 10, n. 21, p. 47-70, 2018. Disponível em: <https://ufal.emnuvens.com.br/debateseducacao/article/view/5087/0>. Acesso em: 18 jun. 2024.

BRANDÃO, E. R. Métodos contraceptivos reversíveis de longa duração no Sistema Único de Saúde: o debate sobre a (in)disciplina da mulher. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 875-879, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/YwDdkKZ3FpvxvwNzxzYy4GN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRANDÃO, E. R.; CABRAL, C. S. Vidas precárias: tecnologias de governo e modos de gestão da fecundidade de mulheres "vulneráveis". **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, v. 27, n. 61, p. 47-84, set./dez. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/SHfFRFSTrzFz3mwhkvrKqbT/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 maio 2025.

BRANDÃO, E. R. What to do with teenage sexuality? The anthropology of forms of government in Brazil. **Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology**, [s. l.], v. 20, p. e20807, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/vb/a/T4mx76x5vMqxTZxdjctCmdP/>. Acesso em: 4 set. 2024.

BRANDÃO, E. R. et al. Hormônios sexuais e saúde: uma análise crítica da (in)visibilidade dos efeitos colaterais da contracepção hormonal. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, e310423, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/FFZJHjtxWzJ3pckbhwnBN5c/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 10 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde inicia capacitação nacional para a oferta do Implanon no SUS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/ministerio-da-saude-inicia-capacitacao-nacional-para-a-oferta-do-implanon-no-sus>. Acesso em: 10 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros curriculares nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual**. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro101.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996] 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Direitos sexuais e direitos reprodutivos: uma prioridade do governo.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/direitos_sexuais_reprodutivos.pdf. Acesso em: 08 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Marco teórico e referencial: saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_teorico_referencial_saude_sexual.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde na escola.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_escola_caderno_1.pdf. Acesso em: 05 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de atenção básica: atenção ao pré-natal de baixo risco.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf. Acesso em: 15 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_integral_saude_adolescente_jovem.pdf. Acesso em: 02 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf. Acesso em: 18 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2021.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Número Especial, dez. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-2021.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Sífilis 2019.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. Número Especial, out. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2019/sifilis>. Acesso em: 20 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 set. 2017a. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular:** educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110517_versoes_finais_2.pdf. Acesso em: 14 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular:** ensino médio. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EM_REVI_site_2.pdf. Acesso em: 02 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica**. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_saude_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf. Acesso em: 19 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica n. 2/2022-COSAJ/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-2-2022-cosaj-cgcivi-dapes-saps-ms/view>. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde do homem:** cuidado e prevenção devem ser feitos em todas as fases da vida. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/saude-do-homem-cuidado-e-prevencao-devem-ser-feitos-em-todas-as-fases-da-vida>. Acesso em: 14 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Técnica nº 2/2024-CACRIAD/CGACI/DGCI/SAPS/MS: Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-2-2024.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.952, de 6 de agosto de 2024**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer regime escolar especial para atendimento a educandos nas situações que especifica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 ago. 2024b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114952.htm. Acesso em: 10 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. **Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. 132 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Passo a passo PSE: Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. 46 p. (Série C. Projetos, programas e relatórios). Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/passos_a_passo_programa_saude_escola.pdf. Acesso em: 18 maio 2024.

BRIGGS, L. **How all politics became reproductive politics**: from welfare reform to foreclosure to Trump. Berkeley: University of California Press, 2017. (Reproductive Justice: A New Vision for the 21st Century, v. 2).

BRONZO, C.; COSTA, E. C. R.; GUIMARÃES, F. A burocracia de nível de rua na implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): percepções e traduções de normativas nas políticas públicas. **Administração Pública e Gestão Social**, Viçosa, v. 14, n. 2, p. 1-18, 2022. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3515/351570330006/351570330006.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRUHN, A.; EKSTRÖM, M. Towards a multi-level approach on frontline interactions in the public sector: institutional transformations and the dynamics of real-time interactions. **Social Policy & Administration**, [s. l.], v. 51, p. 195-215, 2017. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spol.12282>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRUNELLO, N. **Práticas e sentidos do trabalho de ACS na atenção primária à saúde**. 2018. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018. Disponível em: . Acesso em: 05 jun. 2025.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

CALDEIRA, T. P. R. **Cidade de muros**: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2011.

CAMPOS, P.; SILVA, E. Modos de ensinar e aprender a ser menina e a ser menino. **Revista de Educação PUC-Campinas**, Campinas, v. 19, n. 3, p. 215-225, 2014. Disponível em: <https://periodicos.puc-campinas.edu.br/reeducacao/article/view/2826>. Acesso em: 27 abr. 2024.

CAPANO, G.; HOWLETT, M.; RAMESH, M. (ed.). **Varieties of governance**: dynamics, strategies, capacities. London: Palgrave Macmillan, 2015. (Studies in the Political Economy of Public Policy).

CARLOMAGNO, M. C.; ROCHA, L. C. Como criar e classificar categorias para fazer análise de conteúdo: uma questão metodológica. **Revista Eletrônica de Ciência Política**, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 173-188, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/politica/article/view/45771>. Acesso em 22 mar. 2025.

CARMO, M. E.; GUIZARDI, F. L. O conceito de vulnerabilidade e seus sentidos para as políticas públicas de saúde e assistência social. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, e00101417, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/ywYD8gCqRGg6RrNmsYn8WHv/>. Acesso em: 8 jun. 2024.

CARNEIRO, L. M. R. et al. Atenção integral à saúde do homem: um desafio na atenção básica. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, Fortaleza, v. 29, n. 4, p. 554-563, 2016. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/5301>. Acesso em 20 abr. 2025.

CARRANO, P. C. R. **Jovens, escolas e cidades**: entre diversidades, desigualdades e desafios à convivência. In: REUNIÃO CIENTÍFICA REGIONAL DA ANPED, 2., 2011, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: ANPEd Sul, 2011. p. 1-18. Disponível em: <http://www.observatoriojovem.uff.br/?q=materia/jovens-escolas-e-cidades-entre-diversidades-desigualdades-e-desafios-%C3%A0-conviv%C3%Aancia>. Acesso em 14 mai. 2024.

CARRUTHERS, C. Reproductive governance in Nordeste/Northeast (Juan Solanas, 2005, Argentina/France/Belgium/Spain). **Bulletin of Latin American Research**, [s. l.], v. 42, n. 2, p. 197-211, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.13439>. Acesso em 27 mar. 2024.

CARVALHAES, R. S.; CÁRDENAS, C. M. M. "Namorar é só sofrência": violências na relação afetivo-sexual de adolescentes de uma escola na região Costa Verde, Rio de Janeiro, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 2719-2728, 2021. Disponível em: <https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/namorar-e-so-sofrenca-violencias-na-relacao-afetivosexual-de-adolescentes-de-uma-escola-na-regiao-costa-verde-rj/18048>. Acesso em: 2 jul. 2024.

CARVALHO, M.; ALMEIDA, E. L. Educação para a sexualidade a partir da biologia: vamos falar de Kinsey? **Diversidade e Educação**, Rio Grande, v. 9, n. 1, p. 93-123, 2021. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/11958>. Acesso em: 30 jul. 2024.

CASTRO, A.; SINGER, M. (ed.). **Unhealthy health policy**: a critical anthropological examination. Walnut Creek: AltaMira Press, 2004.

CASTRO, A.; SAVAGE, V. Obstetric violence as reproductive governance in the Dominican Republic. **Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness**, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 123-136, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30433822/>. Acesso em 20 mar. 2024.

CAVALCANTE, P. Convergências entre a governança e o pós-nova gestão pública. In: CAVALCANTE, P.; PIRES, R. (org.). **Boletim de Análise Político-Institucional**: governança pública. Brasília, DF: Ipea, 2018. p. 17-24.

CEDARO, J.; VILLAS BOAS, L.; MARTINS, R. Adolescência e sexualidade: um estudo exploratório em uma escola de Porto Velho - RO. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 32, n. 2, p. 320-339, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/PcLR5TbvBd5qLzPP8RGcCdC/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2024.

CHANG, A. A formal model of street-level bureaucracy. **Rationality and Society**, Thousand Oaks, v. 34, n. 1, p. 6-27, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354571389_A_formal_model_of_street-level_bureaucracy. Acesso em 23 abr. 2025.

CHECA, M. E.; SCISLESKI, C. O silêncio como discurso: o projeto de lei "Escola Sem Partido" e a invisibilidade da juventude LGBT na lógica da mordaza. **Revista Ñanduty**, Dourados, v. 6, n. 8, p. 91-113, 2018. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/nanduty/article/view/8842>. Acesso em: 28 set. 2024.

CID, A.; SOUSA, L.; DUARTE, E. Aprendendo a desaprender: a (des)construção do discurso de gênero com jovens de uma escola pública de ensino médio. **Revista Sociais e Humanas**, Santa Maria, v. 33, n. 3, p. 1-18, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/42016>. Acesso em: 9 dez. 2024.

CIORDIA, C. Implementação de políticas públicas: práticas e sentidos do trabalho cotidiano. In: CIORDIA, C. et al. (org.). **Por una antropología de las políticas públicas**: perspectivas de análisis y cambios de signo en la región. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2022. p. 89-120. CNS. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, DF: CNS, 2016.

COBO, B. O trabalho doméstico no pós-pandemia. **Terapia Política**, [s. l.], 2020. Disponível em: <https://terapiapolitica.com.br/2020/06/25/o-trabalho-domestico-no-pos-pandemia/>. Acesso em: 3 jan. 2024.

COBO, B.; CRUZ, C.; DICK, P. C. Desigualdades de gênero e raciais no acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 9, p. 4021-4032, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/kKcDWgfGzS58qxCKG7QHdVj/abstract/?lang=pt>. Acesso em 14 mai. 2025.

COELHO, A. L.; BELCHIOR, Y. BNCC e a História Antiga: uma possível compreensão do presente pelo passado e do passado pelo presente. **Mare Nostrum**, São Paulo, v. 8, n. 8, p. 62-78, 2018. Disponível em: <https://revistas.usp.br/marenostrum/article/view/138861>. Acesso em 26 mai. 2025.

COHEN, S. **Folk devils and moral panics**: the creation of the Mods and Rockers. London: MacGibbon and Kee, 1972.

COLEN, S. "Like a mother to them": stratified reproduction and West Indian childcare workers and employers in New York. In: GINSBURG, F. D.; RAPP, R. (ed.). **Conceiving the new world order**: the global politics of reproduction. Berkeley: University of California Press, 1995. p. 78-102.

COLOGNESE, S. A.; MÉLO, J. L. B. A técnica de entrevista na pesquisa social. **Cadernos de Sociologia**, Porto Alegre, v. 9, p. 143-159, 1998. Disponível em: https://docs.fct.unesp.br/docentes/geo/necio_turra/PESQUISA%20EM%20GEOGRAFIA/A%20t%E9cnica%20da%20entrevista%20na%20pesquisa%20social.pdf. Acesso em 10 mai. 2024.

CONCEIÇÃO, P. O.; COSTA, L. T. Práticas de enfermeiros para prevenção do HIV/AIDS na adolescência: análise representacional. **Revista de Enfermagem UFPE online**, Recife, v. 11, n. 12, p. 4805-4816, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/25147>. Acesso em 22 set. 2024.

COSTA, V. C.; BAPTISTA, T. W. F.; CUNHA, M. B. O SUS em territórios vulnerabilizados: reflexões sobre violência, sofrimento mental e invisibilidades nas favelas do Rio de Janeiro. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. esp. 2, p. 368-380, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/8GTJmnK8DVRxsMhbBpgXMXs/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 6 set. 2024.

CROUCH, C. **Post-democracy**. Cambridge: Polity Press, 2005.

CUNHA, V. H. **Quando viver é driblar o risco**: racismo de Estado, políticas de morte e violência na adolescência desde uma perspectiva localizada. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/253297>. Acesso em: 4 out. 2024.

DEJOY, D. M. Behavior change versus culture change: divergent approaches to managing workplace safety. **Safety Science**, [s. l.], v. 43, n. 2, p. 45-65, 2019. Disponível em: <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=1293980>. Acesso em 10 out. 2024.

DEMARTINI, G. R.; SILVA, A. F. G. A articulação entre Paulo Freire e Herbert Marcuse: educação sexual emancipatória em uma escola estadual do município de Sorocaba-SP. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 56-81, 2016. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/26333>. Acesso em: 11 abr. 2024.

DERTHICK, M. **New towns in-town**: why a federal program failed. Washington, D.C.: The Urban Institute, 1972.

DOUGLAS, M.; PESSOA, S.; CUNHA, M. M. Reflexões sobre diversidade sexual e de gênero nas aulas de biologia. **Eventos Pedagógicos**, Sinop, v. 11, n. 2, p. 327-336, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/rep/article/view/10301>. Acesso em: 8 set. 2024.

DYE, T. R. **Understanding public policy**. 13. ed. Boston: Longman, 2010.

DUFFY, D. et al. Information flow as reproductive governance: patient journey analysis of information barriers and facilitators to abortion care in the Republic of Ireland. **SSM - Population Health**, [s. l.], v. 19, p. 101155, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35711728/>. Acesso em: 22 set. 2024.

ÉRNICA, M.; BATISTA, A. A. G. A escola, a metrópole e a vizinhança vulnerável. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 42, n. 146, p. 640-666, maio/ago. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/ZfKXfNYDspZSkbzQpmGkJVD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 25 maio 2024.

EZZAMEL, M.; REED, M. Governance: a code of multiple colours. **Human Relations**, [s. l.], v. 61, n. 5, p. 597-615, maio 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/247717855_Governance_A_code_of_multiple_colours. Acesso em 23 nov. 2024.

FAQUINELLO, P.; CARREIRA, L.; MARCON, S. S. A Unidade Básica de Saúde e sua função na rede de apoio social ao hipertenso. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 19, n. 4, p. 736-744, out./dez. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/K3ZLZ3wMKLVF8ZRY6PqwZBk/>. Acesso em: 12 jun. 2024.

FASSIN, D. Another politics of life is possible. **Theory, Culture & Society**, [s. l.], v. 29, p. 44-60, 2009. Disponível em: <https://scispace.com/papers/another-politics-of-life-is-possible-1lql2yngpg>. Acesso em 10 mar. 2024.

FARIA, R. M.; BORTOLOZZI, A. Espaço, território e saúde: contribuições de Milton Santos para o tema da geografia da saúde no Brasil. **Ra'e Ga**, Curitiba, v. 17, p. 129-144, 2009. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/11995>. Acesso em 20 abr. 2025.

FEDERICI, S. **Calibã e a bruxa**: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.

FEDERICI, S. **O ponto zero da revolução**: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019.

FERNANDEZ, M.; GUIMARÃES, N. Caminhos teórico-metodológicos para a análise da burocracia de nível de rua. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Brasília, n. 32, p. 5-22, 2020. Dispon[ível em: <https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/CCSM5zx4N8ffqvjqBQMdXMB/> Acesso em 4 abr. 2024.

FERRARI, W.; PERES, S.; NASCIMENTO, M. Experimentação e aprendizagem na trajetória afetiva e sexual de jovens de uma favela do Rio de Janeiro, Brasil, com experiência de aborto clandestino. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 9, p. 2937-2950, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/QKtgD6d8JzQB7Td5sXBJYBd/>. Acesso em: 1 set. 2024.

FERREIRA, G. S.; MENEZES, D. B. **Relatório de análise socioeconômica da cidade de Porto Alegre**. Porto Alegre: FEE, 2017. Disponível em: <https://arquivofee.rs.gov.br/relatorios/relatorio-analise-socioeconomica-da-cidade-de-porto-alegre/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

FERREIRA, I. G.; PIAZZA, M.; SOUZA, D. Oficina de saúde e sexualidade: residentes de saúde promovendo educação sexual entre adolescentes de escola pública. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, p. 1788, 2019. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1788>. Acesso em: 6 mar. 2024.

FERREIRA, V. R. S.; MEDEIROS, J. J. Fatores que moldam o comportamento dos burocratas de nível de rua no processo de implementação de políticas públicas. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 776-793, jul./set. 2016.

FOLLET, M. P. **The new state**: group organization the solution of popular government. University Park: Penn State University Press, 2013.

FONSECA, C.; MARRE, D.; RIFIOTIS, F. Governança reprodutiva: um assunto de suma relevância política. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, v. 27, n. 61, p. 7-46, set./dez. 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ha/a/XvKr7jZYGHDc3Frc5D8FGPw/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 4 out. 2024.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. 13. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

FOUCAULT, M. **Power/Knowledge: selected interviews and other writings, 1972-1977**. New York: Pantheon Books, 1980.

FOUCAULT, M. Governmentality. In: BURCHELL, G.; GORDON, C.; MILLER, P. (ed.). **The Foucault effect**. London: Harvester Wheatsheaf, 1991. p. 87-104.

FRANCO, D. **Governança e políticas públicas: uma revisão**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2016. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/6761/TCC%20DOUGLAS%20VINICIUS%20FRANCO%20-%20GOVERNAN%C3%A7A%20E%20POLITICAS%20PUBLICAS%20UMA%20REVISAO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 10 mar. 2025.

FREITAS, D. P. **A gestão da saúde reprodutiva em uma Clínica da Família no município do Rio de Janeiro: práticas de saúde na fronteira entre cuidado e violências**. 2024. 141 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1592795>. Acesso em 3 jul. 2024.

FRITSCH, R. et al. Percursos escolares de estudantes do ensino médio de escolas públicas do município de São Leopoldo, RS: desempenho escolar, perfil e características. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 104, p. 543-567, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/wJ6wnrdWkGbrcjTmL5fMN6r/?lang=pt>. Acesso em 27 ju. 2025.

GAIGHER, A. V.; MARELY, M. Para além do silêncio: a sexualidade entrelaçada nas diretrizes educacionais brasileiras. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 47, e236467, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/wJ6wnrdWkGbrcjTmL5fMN6r/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 30 out. 2024.

GALVÃO, A. L. M. et al. Determinantes estruturais da saúde, raça, gênero e classe social: uma revisão de escopo. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 30, n. 2, e200743, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/rPgBQsrGNMDmvt5FJFLz6sS/?lang=pt>. Acesso 22 set. 2024.

GALVÃO, W. N. M. et al. Vulnerabilidades sociais e educacionais associadas ao efeito território em escolas do Ceará. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, Brasília, v. 38, e121446, 2022. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/rbpa/article/view/121446>. Acesso em 13 set. 2025.

GIGANTE, A. S. **Sexualidade e currículo escolar: análise das diretrizes no Referencial Curricular Gaúcho e na BNCC**. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/279797>. Acesso em 10 mai. 2025.

GINSBURG, F. D.; RAPP, R. **Conceiving the new world order: the global politics of reproduction**. Berkeley: University of California Press, 1995.

GUIMARÃES, J.; CABRAL, C. S. Pedagogias da sexualidade: discursos, práticas e (des)encontros na atenção integral à saúde de adolescentes. **Pro-Posições**, Campinas, v. 33, p. e20200043, 2022. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8669269>. Acesso em: 6 maio 2024.

GUIMARÃES, T. C. A.; BERNADO, E. S.; BORDE, A. M. A burocracia de nível de rua na discricionariiedade docente. **Educação e Realidade**, Porto Alegre, v. 47, e117396, 2022. Disponível: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/9cbMZhSKsXrfw4FdxjzLqrS/>. Acesso em 1 jun. 2025.

GUIMARÃES, N. A.; HIRATA, H. S. **O gênero do cuidado: desigualdades, significações e identidades**. Cotia: Ateliê Editorial, 2020. 296 p.

HAALAND, M. E. S. et al. Silent politics and unknown numbers: rural health bureaucrats and Zambian abortion policy. **Social Science and Medicine**, [s. l.], v. 251, p. 112909, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32179365/>. Acesso em: 4 out. 2024.

HEILBORN, M. L. (org.). **O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros**. Rio de Janeiro: Garamond: Fiocruz, 2006.

HEILBORN, M. L. Por uma agenda positiva dos direitos sexuais da adolescência. **Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 57-68, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pc/a/f3rcpqWssvByWqQkBjVz9dN/>. Acesso em 3 mai. 2025.

HEMER, S. Reproductive governance and the politics of reproduction in Papua New Guinea. **Medical Anthropology**, [s. l.], v. 38, n. 7, p. 575-588, 2019.

HJERN, B. Implementation research: the link gone missing. **Journal of Public Policy**, [s. l.], v. 2, n. 3, p. 301-308, 1982. Disponível em: <https://docs.opendeved.net/lib/A2VG2LQS>. Acesso em 5 abr. 2025.

HJERN, B.; HULL, C. Implementation research as empirical constitutionalism. **European Journal of Political Research**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 105-115, 1982. Disponível em: <https://resolve.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-political-research/article/implementation-research-as-empirical-constitutionalism/C144237C77ACDD88BEB4FC7D3970A987>. Acesso em 2 mar. 2024.

HONORATO, G. et al. Gravidez na adolescência: impactos físicos e emocionais. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, [s. l.], v. 17, n. 10, p. e12191, 2024. Disponível em:

<https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/12191>. Acesso em: 30 out. 2024.

HYATT, S. B. et al. Part 3: Anthropology of policy. **Learning and Teaching**, [s. l.], v. 16, n. 3, p. 56-87, 2023. DOI: 10.3167/latiss.2023.160305. Disponível: <https://diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1848373>. Acesso em 10 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico 2010 Porto Alegre**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/porto-alegre.html>. Acesso em: 5 jul. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: 2019**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html>. Acesso em 17 abr. 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019: acidentes, violências, doenças transmissíveis, atividade sexual, características do trabalho e apoio social**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101800>. Acesso em: 20 mar. 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html>. Acesso em: 26 abr. 2025.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar 2015**. Brasília, DF: INEP, 2015. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_do_censo_escolar_2015_matriculas.pdf. Acesso em 12 jun. 2024.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar 2021**. Brasília, DF: INEP, 2021. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2021/apresentacao_coletiva.pdf. Acesso em 25 out. 2024.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **IDEB: resultados**. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb>. Acesso em: 10 jan. 2025.

IVO, A. B. L. A noção de governança: um novo regime de ação para o desenvolvimento sustentável e a produção das ciências sociais. In: IVO, A. B. L. (org.). **A reinvenção do desenvolvimento**. Salvador: EDUFBA, 2016. p. 37-103.

JESUS, L. E. S. Periferia, um termo crítico: distanciamentos espaciais, sociais e simbólicos nas cidades. **Geosaberes**, Fortaleza, v. 12, n. 30, p. 158-170, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistamseu/article/view/244989>. Acesso em 28 ago. 2024.

KOOIMAN, J. **Governing as governance**. London: Sage Publications, 2006.

KOTNI, M.; SINGER, E. O. Human rights and reproductive governance in transnational perspective. **Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness**, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 113-122, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2018.1557164>. Acesso em: 2 out. 2025.

LANDER, E. Las políticas públicas y la disputa político-cultural: la mirada antropológica sobre la política sociolaboral relacionada con el trabajo en casas particulares. In: CIORDIA, C. et al. (org.). **Por una antropología de las políticas públicas: perspectivas de análisis y cambios de signo en la región**. Buenos Aires: Editorial Teseo, 2022. p. 179-210.

LEAL, A. F.; FIGUEIREDO, W. S.; NOGUEIRA-DA-SILVA, G. S. O percurso da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens (PNAISH), desde a sua formulação até sua implementação nos serviços públicos locais de atenção à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2607-2616, out. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/wZsmyXhQz3XnkvzBNYBXVZK/abstract/?lang=pt>. Acesso em 1 nov. 2024.

LEITE, V. "Em defesa das crianças e da família": refletindo sobre discursos acionados por atores religiosos "conservadores" em controvérsias públicas envolvendo gênero e sexualidade. **Sexualidad, Salud y Sociedad**, Rio de Janeiro, n. 32, p. 119-142, maio 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sess/a/Cc68BmV888KZbTkwjwr495M/?format=html&lang=pt>. Acesso em 4 fev. 2025.

LIMA, L. L.; D'ASCENZI, L. Implementação de políticas públicas: perspectivas analíticas. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 21, n. 48, p. 101-110, dez. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/zpwj63WjFbZYVkSXgnXDSjz/?lang=pt>. Acesso em 3 dez. 2024.

LIMA, M. et al. Gravidez na adolescência e evasão escolar: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, n. 5, e20210521, 2022. Disponível em: <https://ud10.arapiraca.ufal.br/repositorio/publicacoes/5084>. Acesso em 25 set. 2024.

LIPSKY, M. **Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services**. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

LISBOA, M. S. **The mental health network for homeless people with mental health problem**. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/17023/1/Milena%20Silva%20Lisboa.pdf>. Acesso em 10 mar. 2025.

LOPES, M. C. L. et al. Tendência temporal e fatores associados à gravidez na adolescência. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 54, e03639, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/PHz7cjXNk9f58d7KbTCSWcL/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 27 nov. 2024.

LOTTA, G. S. **Implementação de políticas públicas**: o impacto dos fatores relacionais e organizacionais sobre a atuação dos burocratas de nível de rua no Programa Saúde da Família. 2010. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-20102010-120342/pt-br.php>. Acesso em 9 jan. 2024.

LOTTA, G. S. **Burocracia e implementação de políticas de saúde**: os agentes comunitários na Estratégia Saúde da Família. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2015.

LOTTA, G. S. A política pública como ela é: contribuições dos estudos sobre implementação para a análise de políticas públicas. In: LOTTA, G. S. (org.). **Teoria e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil**. Brasília, DF: Enap, 2019. p. 11-38. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://bibliotecadigital.enap.gov.br/bitstream/1/4162/1/Livro_Teorias%20e%20An%C3%A1lises%20sobre%20Implementa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%ABlicas%20no%20Brasil.pdf. Acesso em 2 fev. 2024.

LOTTA, G. S.; KIRSCHBAUM, C. Dois pesos e duas medidas na sala de aula: análise das redes sociossemânticas de categorização operadas por professores. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 56, n. 1, p. 100-133, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/Q9CTfmfkNNpTSbrykBw46HN/>. Acesso em 20 mar. 2024.

LOTTA, G. S.; PIRES, R. R. C. Categorizando usuários "fáceis" e "difíceis": práticas cotidianas de implementação de políticas públicas e a produção de diferenças sociais. **Dados**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 4, e20190112, 2020. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://www.scielo.br/j/dados/a/cKV4L7jPJwPyFT87HLq7LkN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 ago. 2024.

LOTTA, G. S.; SANTIAGO, A. Autonomia e discricionariedade: matizando conceitos-chave para o estudo de burocracia. **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB**, São Paulo, n. 83, p. 21-41, 2017. Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/426>. Acesso em: 4 mai. 2024.

LOURO, G. L. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L. (org.). **O corpo educado**: pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

LYNN JR., L. E.; HEINRICH, C. J.; HILL, C. J. Studying governance and public management: challenges and prospects. **Journal of Public Administration Research and Theory**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 233-262, apr. 2000a. Disponível em: <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/10/2/233/986113>. Acesso em: 3 jul. 2024.

LYNN JR., L. E.; HEINRICH, C. J.; HILL, C. J. Studying governance and public management: why? how? Chicago: Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago, 1999. (Working Papers, 9924).

LYRA, J. et al. Homens e cuidado: uma outra família? In: ACOSTA, A. R.; VITALE, M. A. F. (org.). **Famílias**: redes, laços e políticas públicas. 3. ed. São Paulo: Cortez: IEE/PUC/SP, 2007. p. 79-92.

MAGNANI, J. G. C. Etnografia como prática e experiência. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 15, n. 32, p. 129-156, jul./dez. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/6PHBfP5G566PSHLvt4zqv9j/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 mai. 2025.

MALUF, S. W.; TORNQUIST, C. S. (org.). **Gênero, saúde e aflição: abordagens antropológicas**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2010.

MARINS, I. et al. Dos Parâmetros Curriculares Nacionais aos Temas Contemporâneos Transversais: o ensino de sexualidade sob o domínio da "Escola Sem Partido". **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 28, e280048, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373406284_Dos_Parametros_Curriculares_Nacionais_aos_Temas_Contemporaneos_Transversais_o_ensino_de_sexualidade_sob_o_dominio_da_Escola_Sem_Partido. Acesso em: 6 jul. 2025.

MARELY, M. **Para além do silêncio: a sexualidade entrelaçada nas diretrizes educacionais brasileiras**. 2024. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. Disponível em: <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9939>. Acesso em 2 mar. 2025.

MARTIN, S. **Educação sexual na escola: concepções e práticas de professores**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2010. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/92237?locale-attribute=pt_BR. Acesso em 3 jul. 2025.

MASSONI, N. T.; ALVES-BRITO, A.; CUNHA, A. M. Referencial curricular gaúcho para o Ensino Médio de 2021: contexto de produção, Ciências da Natureza e questões étnico-raciais. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 38, n. 3, p. 1587-1617, 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/223026>. Acesso em: 24 ma. 2025.

MAYNARD-MOODY, S.; MUSHENO, M. State agent or citizen agent: two narratives of discretion. **Journal of Public Administration Research and Theory**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 329-358, abr. 2000. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3525647>. Acesso em 23 mai. 2023.

MAYNARD-MOODY, S.; MUSHENO, M. **Cops, teachers, counselors: stories from the front lines of public service**. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2022.

MAYNARD-MOODY, S.; MUSHENO, M. Social equities and inequities in practice: street-level workers as agents and pragmatists. **Public Administration Review**, Washington, v. 72, p. 16-23, 2012. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2012.02633.x>. Acesso em 30 jun 2023.

MAYNARD-MOODY, S.; MUSHENO, M. Playing the rules: discretion in social and policy context. In: HUPE, P.; HILL, M.; BUFFAT, A. (ed.). **Understanding street-level bureaucracy**. Bristol: Policy Press, 2015. p. 169-186.

MEDEIROS, T. F. R. DE . et al.. Vivência de mulheres sobre contracepção na perspectiva de gênero. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 37, n. 2, p. e57350, 2016. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/hRjDHgJfsM8G3krqGc4Vb3g/?lang=pt>. Acesso em 10 abr. 2024.

MELLO, B. B. **O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo**: criação e primeiros anos de atuação (1990-1993). 2019. Monografia (Licenciatura em História) – Universidade Feevale, Novo Hamburgo, 2019. Disponível em: <https://pergamum.feevale.br/acervo/274246>. Acesso em 14 abr. 2023.

MELLO, B. B. **Conselhos Tutelares e infâncias**: etnografando 30 anos de existência do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo/RS. 2022. Dissertação (Mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social) – Universidade Feevale, Novo Hamburgo, 2022. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.feevale.br/Vinculo2/000032/000032e2.pdf>. Acesso em 8 abr. 2023.

MIKKELSEN, K. S.; MADSEN, J. K.; BAEKGAARD, M. Is stress among street-level bureaucrats associated with experiences of administrative burden among clients? A multilevel study of the Danish unemployment sector. **Public Administration Review**, Washington, v. 84, n. 2, p. 248-260, 2024. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4589964. Acesso em 6 abr. 2025.

MILANEZI, Jaciane; SILVA, Graziella Moraes. Silêncio reagindo à saúde da população negra em burocracias do SUS. in: MILANEZI, Jaciane; SILVA, Graziella Moraes. **Implementando desigualdades**: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,, 2019. p. 441-461.

MORAES, R. Análise de conteúdo. **Revista Educação**, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. Disponível em: <http://pesquisaemeducacaoufrgs.pbworks.com/w/file/fetch/60815562/Analise%20de%20conte%C3%BAdo.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2024.

MORAES, M.; CECCIN, R. B. (org.). **Educação e saúde**: ensino e cidadania como travessia de fronteiras. Canoas: ULBRA, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/VdPNdYy66RSD7QwqWVHYsxj/?lang=pt>. Acesso em 4 abr. 2025.

MORÁN FAÚNDES, J. M.; MORGAN, L. M. La vida no es una sola: los usos políticos de la "vida" en Latinoamérica. **Culturales**, Mexicali, v. 6, n. 1, p. 1-35, 2018. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912018000100102. Acesso em 20 mar. 2024.

MORGAN, L. M. Reproductive governance, redux. **Medical Anthropology**, [s. l.], v. 38, n. 2, p. 113-117, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2018.1555829>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MORGAN, L. M.; ROBERTS, E. F. S. Reproductive governance in Latin America. **Anthropology & Medicine**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 241-254, 2012. DOI: 10.1080/13648470.2012.675046. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13648470.2012.675046>. Acesso em: 15 abr. 2024.

MOCELIN, E. et al. Gravidez na adolescência: impactos na vida escolar e perspectivas de futuro. **Revista Foco**, Curitiba (PR), v.17, n.2, p.01-18, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4506>. Acesso em 10 mai. 2024.

NASCIMENTO, A.; HELENA, M.; CRUZ, S. Gênero, sexualidades e juventudes: regulações e subversões dos corpos no cotidiano escolar. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, Salvador, v. 4, n. 3, p. 14-38, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/25591>. Acesso em: 14 set. 2024.

NERY, I. S. et al. Reincidência da gravidez em adolescentes de Teresina, PI, Brasil. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 64, n. 1, p. 31-37, jan. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/p6JNd4Mv8VdHZnNVyNtXWzL/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

NUNES, A. S.; LOTTA, G. S. A implementação de políticas públicas no contexto de vulnerabilidade: o papel dos agentes comunitários de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 12, e00230318, 2019.

OLDENHOF, L.; LINTHORST, E. Public encounters and the role of citizens' impression management. In: HUPE, P. **The politics of the public encounter: what happens when citizens meet the state**. [S. l.]: Edward Elgar Publishing, 2022. p. 45-68.

O'LEARY, Z. **The essential guide to doing your research project**. Los Angeles: SAGE, 2014.

OLIVEIRA, R. N. G.; FONSECA, R. M. G. S. Amor e violência em jogo: descortinando as relações afetivo-sexuais entre jovens à luz de gênero. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 23, e180354, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/ZjcYhzzJsRv6JFR3QMynZpD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 15 abr. 2024.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health**, 28-31. Genebra: OMS, 2002. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2009/defining_sexual_health.pdf. Acesso em: 10 abr. 2025.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde; OMS. Organização Mundial da Saúde. **La salud del adolescente y el joven en las Américas**. Washington, DC: OPAS/OMS, 1995. (Publicación Científica, 552).

PAIVA, S. P.; BRANDÃO, E. R. Abstinência sexual como política pública? Governo Bolsonaro e a (des)educação em sexualidade. **Revista Em Pauta: Teoria Social e Realidade Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 53, p. 1-18, 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaempauta/article/view/78949>. Acesso em: 5 set. 2024.

PARIZ, J.; MENGARDA, C. F.; FRIZZO, G. B. A atenção e o cuidado à gravidez na adolescência nos âmbitos familiar, político e na sociedade: uma revisão da literatura. **Saúde e**

Sociedade, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 194-208, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/d4wG5ZYGRZbGHD597wpLzfs/?lang=pt>. Acesso em 5 abr. 2025.

PEAISA. Porto Alegre. **Plano Estadual de Atenção Integral à Saúde do Adolescente**. Porto Alegre: Secretaria Estadual de Saúde, 2019. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20180152/18085217-peaisa-rev-abril-2010.pdf>. Acesso em 11 abr. 2023.

PEIRANO, M. Etnografia não é método. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/n8ypMvZZ3rJyG3j9QpMyJ9m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 13 abr. 2025.

PETERS, B. G. **American public policy: promise and performance**. Chatham: Chatham House, 1986.

PINHEIRO, R. Cuidado em saúde. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, J. C. F. (org.). **Dicionário da educação profissional em saúde**. 2. ed. Rio de Janeiro: EPSJV, 2020. p. 110-114.

PINTO, A. G. A. et al. Vínculos subjetivos do agente comunitário de saúde no território da Estratégia Saúde da Família. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 789-802, set. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/5RjYgPrMjPmZnhTbBzQGy9p/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 4 mai. 2025.

PIRES, R. R. C. Burocracias, gerentes e suas "histórias de implementação": narrativas do sucesso e fracasso de programas federais. In: FARIA, C. A. P. (org.). **Implementação de políticas públicas: teoria e prática**. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2017. p. 182-220.

POLLITT, C.; HUPE, P. Talking about government: the role of magic concepts. **Public Management Review**, [s. l.], v. 13, n. 5, p. 641-658, 2011. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2591049>. Acesso em: 4 abr. 2024.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório Anual de Gestão 2024**. Porto Alegre: SMS, 2025. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/filefield_paths/RAG%202024%20_Final.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde: infecções sexualmente transmissíveis**. Porto Alegre: SMS, 2024a. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/Protocolo%20-%20Infecções%20Sexualmente%20Transmissíveis.pdf. Acesso em: 20 maio 2024.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **PAIGA**. Porto Alegre: SMS, 2023. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/paiga>. Acesso em: 3 out. 2024.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde: pré-natal de risco habitual**. Porto Alegre: SMS, 2024b. Disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/Protocolo%20de%20Enfermagem%20-%20Pré-Natal%20de%20Risco%20Habitual%20-%202024.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde. **Plano Municipal de Saúde 2022-2025**. Porto Alegre: SMS, 2021. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/instrumentos-de-planejamento-em-saude>. Acesso em: 15 mar. 2024.

PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Saúde; UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS. **Adolescer: guia prático de orientações para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens**. Porto Alegre: SMS, 2020. 6 p. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/Guia%20-%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Integral%20-%202020A.D.O.L.E.S.C.E.R..pdf. Acesso em 5 mar. 2024.

PRADO, G. A. S.; CAETANO, M. V. A. Apontamentos sobre a noção de território no campo da saúde coletiva: determinação, identidades e territorialidades. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. esp. 2, e8730, 2024. Disponível em: <https://saudeemdebate.org.br/sed/article/view/8730>. Acesso em: 22 abr. 2024.

PRESSMAN, J. L.; WILDAVSKY, A. **Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland**. Berkeley: University of California Press, 1973.

PUENTES-MONTOYA, G. La gobernanza reproductiva como marco analítico para el estudio de las políticas de salud sexual y reproductiva. **Revista Gerencia y Políticas de Salud**, Bogotá, v. 17, n. 35, p. 1-14, 2018. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10438/26121>. Acesso em: 10 jun. 2024.

QUINTERO-VELOZ, X. et al. Análisis de narrativas del personal prestador de servicios anticonceptivos en México: entre la autonomía reproductiva y la coerción anticonceptiva. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 2, e00103324, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/56qZbd57wZqfh7hdCPcDx5n/abstract/?lang=es>. Acesso em: 2 set. 2024.

RAAPHORST, N. How to prove, how to interpret and what to do? Uncertainty experiences of street-level tax officials. **Public Management Review**, Abingdon, v. 20, n. 4, p. 485-502, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2017.1299199>. Acesso em: 9 jul. 2025.

RAAPHORST, N.; LOYENS, K. From poker games to kitchen tables: how social dynamics affect frontline decision making. **Administration & Society**, Thousand Oaks, v. 52, n. 1, p. 31-71, 2018. Disponível em: <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/70597>. Acesso em: 9 jan. 2025.

REIS, A. P.; RODRÍGUEZ, A. D. P. T.; BRANDÃO, E. R. A contracepção como um valor: histórias de jovens sobre desafios no uso e manejo dos métodos. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 33, n. 1, e230803pt, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/K9fVgdt5nTcmSmHFJvCjGts/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 24 jun. 2024.

REYES, D. J.; ALMONTES, M. P. Elementos teóricos para el análisis del embarazo adolescente. **Sex., salud soc.** (Rio J.) ; (17): 98-123, May-Aug/2014. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.br/j/sess/a/pp6N7tDZcdgxrkJYXR73YmL/?format=pdf&lang=es>. Acesso em 3 abr. 2023.

REZENDE SALES, S. S.; FERREIRA, A. G.; VARGAS, F. A. Juventude, gênero e sexualidade no ciberespaço: algumas possibilidades da extensão universitária. **Revista Triângulo**, Uberaba, v. 7, n. 1, p. 1-15, 2015. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/revistatriangulo/article/view/514>. Acesso em: 9 jan. 2025.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 14.705, de 25 de junho de 2015**. Institui o Plano Estadual de Educação – PEE. Porto Alegre: Assembleia Legislativa, 2015. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/rs/lei-ordinaria-n-14705-2015-rio-grande-do-sul>. Acesso em: 20 mar. 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. **Nota Técnica nº 01/2018**: adolescentes e o direito de acesso à saúde. Porto Alegre: SES/RS, 2018. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/saude-do-crianca-e-adolescente>. Acesso em: 15 abr. 2024.

RINALDI, A. A.; RIFIOTIS, F. C.; MARRE, D. A família é mais que "uma palavra": considerações sobre arranjos contemporâneos de convivência. **Civitas: Revista de Ciências Sociais**, Porto Alegre, v. 24, n. 1, e46967, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/civitas/a/BRWWRqZpjJtNK3NNr8wgGyw/>. Acesso em 4 jul. 2025.

ROCHA, A. L. C.; ECKERT, C. **Etnografia da duração**: antropologia das memórias coletivas nas coleções etnográficas. Porto Alegre: Marcavíslua, 2013.

ROHR, K. F. L.; SCHWENGBER, M. S. V. Gravidez na adolescência: significados atribuídos por adolescentes de classes populares. **Revista Contexto & Saúde**, Ijuí, v. 10, n. 20, p. 613-622, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/QJnyHXBstVq6yzxmSBpHKxn/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 4 out. 2024.

ROSE-ACKERMAN, S. What does "governance" mean? **Governance**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 23-27, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/QJnyHXBstVq6yzxmSBpHKxn/abstract/?lang=pt>. Acesso em 2 ma. 2024.

SÁ, S. L.; DUTRA, P.; ANINGER, P.; PEREIRA, V. Dialogando sobre a gravidez na adolescência com estudantes da Escola Municipal José Esmerindo Ribeiro – Petrolina/PE. **InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**, Grajaú, v. 5, n. 16, e11338, 2019. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/233161457.pdf>. Acesso em: 5 out. 2024.

- SAMANTA, A.; HAND, L. C. Examining the "in-between" of public encounters: evidence from two seemingly disparate policy contexts. **Public Policy and Administration**, [s. l.], v. 37, n. 4, p. 478-501, 2022. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09520767211020986>. Acesso em 20 mai. 2024.
- SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. Análise de conteúdo categorial: manual de aplicação. Brasília, DF: Enap, 2021.
- SANTOS, M. **O espaço dividido**: os dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1979.
- SANTOS, M. O dinheiro e o território. **Geographia**, Niterói, v. 1, n. 1, p. 7-13, 1999. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001477200>. Acesso em 11 out. 2025.
- SANTOS, M. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2004.
- SANTOS, M.; MIESSE, M.; CARVALHO, F. As questões de gênero e sexualidade e o movimento Escola Sem Partido: qual o impacto para a Base Nacional Comum Curricular? **Diversidade e Educação**, Rio Grande, v. 9, n. esp., p. 509-531, 2024. DOI: 10.14295/de.v9iEspecial.12588. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/12588>. Acesso em: 9 jan. 2025.
- SANTOS, O. S.; BEATRICI, A. F. Gênero e sexualidade no plano estadual de educação do Rio Grande do Sul – do projeto à lei aprovada. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 86689-86700, 2020. Disponível <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/19650>. Acesso em: 13 nov. 2024.
- SARTORI, T. L. Analysis of Brazilian education in the study of sexuality: marginalization of sexual education at BNCC. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 3, e25810313254, 2021. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/download/15558/13230>. Acesso em: 4 mar. 2025.
- SAVEGNAGO, S. D. O.; ARPINI, D. M. Conversando sobre sexualidade na família: olhares de meninas de grupos populares. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 43, n. 150, p. 924-947, set./dez. 2013. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/2687>. Acesso em: 1 out. 2025.
- SCHABBACH, L. M. Os usos (e abusos) do conceito de governança na análise de políticas públicas. **Barbarói**, Santa Cruz do Sul, n. 62, p. 1-25, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/255654>. Acesso em: 3 mar. 2024.
- SCHMIDT, J. P. Para estudar políticas públicas: aspectos conceituais, metodológicos e abordagens teóricas. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 56, p. 119-149, set./dez. 2018. Disponível em: <https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/12688/7826>. Acesso em: 3 abr. 2024.
- SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721>. Acesso em: 30 jun. 2023.

SECCHI, L. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019.

SEFFNER, F.; PARKER, R. A neoliberalização da prevenção do HIV e a resposta brasileira à AIDS. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS (org.). Mitos vs. realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e AIDS em 2016. Rio de Janeiro: ABIA, 2016. p. 27-39.

SEIXAS, R.; FAVARO, D. M. M. Histórias em quadrinhos (HQ) como método avaliativo usado na educação sexual: investigações acerca da gravidez na adolescência. *Revista Memorare*, Tubarão, v. 7, n. 1, p. 27-52, 2020. Disponível em: https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/memorare_grupep/article/view/8986. Acesso em: 9 jan. 2025.

SENA FILHA, V.; CASTANHA, A. Profissionais de unidades de saúde e a gravidez na adolescência. **Psicologia & Sociedade**, Belo Horizonte, v. 26, n. esp., p. 79-88, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/sx4YsPf8mSgL6RbLwKr9PNq/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 mai. 2023.

SENDEROWICZ, L. "I was obligated to accept": a qualitative exploration of contraceptive coercion. **Social Science & Medicine**, [s. l.], v. 239, p. 112531, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619305258>. Acesso em: 21 mai. 2024.

SILVA, C.; BORBA, P. Encontros com a diferença na formação de profissionais de saúde: juventudes, sexualidades e gêneros na escola. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 27, n. 4, p. 1134-1146, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/K5XyfxFXRNGkJrfvLZ8kKjL/>. Acesso em: 1 out. 2024.

SHORE, C. La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" de las políticas. **Antípoda**, Bogotá, n. 10, p. 21-49, 2010. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/814/81415652003.pdf>. Acesso em: 21 out. 20023.

SHORE, C.; WRIGHT, S. **Anthropology of policy**: critical perspectives on governance and power. London: Routledge, 1997.

SHORE, C.; WRIGHT, S.; PÉRO, D. **Policy worlds**: anthropology and the analysis of contemporary power. Oxford: Berghahn Books, 2011.

SILVA, H. R. S. A situação etnográfica: andar e ver. **Horizontes Antropológicos**, Porto Alegre, ano 15, n. 32, p. 171-188, jul./dez. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/qg3G8GrBsYz7H56nCzJWymx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 4 out. 2024.

SILVA, C. S. F.; BRANCALEONI, A. P. L.; OLIVEIRA, R. R. Base Nacional Comum Curricular e diversidade sexual e de gênero: (des)caracterizações. **Revista Ibero-Americana**

de Estudos em Educação, Araraquara, v. 14, n. esp. 2, p. 1538-1555, jul. 2019. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/12051>. Acesso em: 23 mai. 2025.

SILVA, E. R. A.; OLIVEIRA, R. M. **O adolescente em conflito com a lei e o debate sobre a redução da maioridade penal**: esclarecimentos necessários. Brasília, DF: Ipea, 2015. (Nota Técnica, n. 20). Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5696>. Acesso em: 18 maio 2024.

SILVA, C. G. et al. Religiosidade, juventude e sexualidade: entre a autonomia e a rigidez. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 13, n. 4, p. 683-692, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/qLHLpmHbpmGzkKVX5Xjv8BL/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 abr. 2025.

SILVA, L. A. Juventude e sexualidade: percepções de adolescentes sobre saúde sexual e reprodutiva. **Revista de Enfermagem UFPE On Line**, Recife, v. 17, n. 6, p. 1-12, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/JCgFkHfdtNpBRssCcg86r6R/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 jun. 2024.

SILVA, R. F.; ENGSTROM, E. M. Atenção integral à saúde do adolescente pela Atenção Primária à Saúde no território brasileiro: uma revisão integrativa. **Interface: Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 24, supl. 1, e190548, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/vhxBeLFd8J6GrVGTF7DWPSd/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 10 mai. 2025.

SILVA, C. et al. Sexualidade, diálogo e extensão universitária: ações em promoção à saúde. **Revista ENCITEC**, Santo Ângelo, v. 8, n. 1, p. 18-30, 2018. Disponível em: <https://san.uri.br/revistas/index.php/encitec/article/view/2492>. Acesso em: 9 jul. 2024.

SILVA, A.; DIAS, T.; BEZERRA, F. Linguagem, gênero e sexualidade na educação de jovens e adultos: uma proposta de multiletramentos críticos. **Revista do GELNE**, Natal, v. 23, n. 1, p. 99-117, 2021. DOI: 10.21680/1517-7874.2021v23n1ID22564. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/22564>. Acesso em: 9 jan. 2025.

SINASC. Porto Alegre. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgvs/default.php?p_secao=2444. Acesso em: 10 fev. 2024.

SOUZA, F. M. A.; MUÑOZ, I. K.; VISENTIN, I. C. Contexto de vulnerabilidade de gênero no uso do preservativo masculino. **Revista Humanidades & Tecnologia (FINOM)**, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 25-38, 2020. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/download/1004/723. Acesso em: 12 ma. 2025.

SOUZA, R. F.; OLIVEIRA, T. F. A doxa e o logos na educação: o avanço do irracionalismo. In: FRIGOTTO, G. (org.). **Escola "sem" partido**: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ: LPP, 2017. p. 113-130.

SOUZA JÚNIOR, M. B. M.; MELO, M. S. T.; SANTIAGO, M. E. A análise de conteúdo como forma de tratamento dos dados numa pesquisa qualitativa em Educação Física escolar.

Movimento, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 29-47, jul./set. 2010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/11546>. Acesso em: 10 jul. 2024.

TAETS, A. R. F. **Abrindo e fechando celas: narrativas, experiências e identidades de agentes de segurança penitenciária femininas**. 2012. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-09112012-111252/pt-br.php>. Acesso em: 13 jul. 2025.

TATE, W. Anthropology of policy: tensions, temporalities, possibilities. **Annual Review of Anthropology**, [s. l.], v. 49, p. 83-99, 2020. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-anthro-010220-074250>. Acesso em: 1 abr. 2024.

TAMASHIRO, L. M. C.; FONSECA, L. M. M. Desenvolvimento de serious game para aprendizagem sobre sexo seguro e contracepção na adolescência. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 32, e4182, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/TdZKLnRLJYwhkBRnRxTkqyP/>. Acesso em: 17 jun. 2024.

TEIXEIRA, L. C. Políticas públicas de saúde reprodutiva: análise da implementação em contextos de vulnerabilidade. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, e320301, 2022. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/f7/pdf/teixeira-9788523209209-06.pdf>. Acesso em: 4 mai. 2025.

TRONCO, G. B. Políticas públicas. In: SANTOS, E.; BAQUERO, M. (org.). **Qualidade democrática, capacidades estatais e cultura política: desafios em tempos de crise política no Brasil**. Porto Alegre: Editora da PUCRS, 2018. p. 55-78.

TRONTO, J. C. **Un monde vulnérable: pour une politique du care**. Tradução de Hervé Maury. Paris: La Découverte, 2009. 238 p. (Textes à l'appui).

UNESCO. **International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach**. Paris: UNESCO, 2018. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/international-technical-guidance-sexuality-education-evidence-informed-approach>. Acesso em: 2 mar. 2025.

ULRICH, M. R.; FOWLER, L. R. Continuous reproductive surveillance. **Journal of Law, Medicine & Ethics**, v. 51, n. 3, p. 570-574, 2023. Disponível em: https://scholarship.law.bu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4705&context=faculty_scholarship. Acesso em: 3 fev. 2025.

VICENTE, L. S. A educação sexual nas diferentes versões da Base Nacional Comum Curricular: da abertura ao silenciamento em torno da temática. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 40, e45439, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/45439>. Acesso em: 9 jan. 2025.

VIEIRA, P. M.; MATSUKURA, T. S.; VIEIRA, C. M. Políticas públicas e educação sexual: percepções de profissionais da saúde e da educação. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 751-768, 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6127002.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2025.

VIEIRA, U. A. et al. Percepção dos enfermeiros sobre a (não) procura dos homens por atenção primária à saúde. **Revista de Saúde Coletiva da UEFs**, Feira de Santana, v. 10, n. 1, p. 1-6, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/5454>. Acesso em: 3 mar. 2025.

VIEIRA, E. M. et al. Gravidez na adolescência e transição para a vida adulta em jovens usuárias do SUS. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, art. 25, p. 1-10, 2017. Disponível em: <https://rsp.fsp.usp.br/artigo/gravidez-na-adolescencia-e-transicao-para-a-vida-adulta-em-jovens-usuarias-do-sus/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

WEDEL, J. R. et al. Toward an anthropology of public policy. **The Annals of the American Academy of Political and Social Science**, Thousand Oaks, v. 600, n. 1, p. 30-51, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279641693_Toward_an_Anthropology_of_Public_Policy. Acesso em: 2 mar. 2023.

WORLD BANK. **Improving public sector performance:** through innovation and inter-agency coordination. Washington, DC: World Bank, 2018. (Global Report on Public Sector Performance). Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/publication/global-report-on-public-sector-performance>. Acesso em: 7 abr. 2024.

WENDT, A. et al. Health inequalities in Brazilian adolescents: measuring and mapping gaps in a cross-sectional school-based survey. **Health Science Reports**, [s. l.], v. 6, n. 12, e1761, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/279641693_Toward_an_Anthropology_of_Public_Policy. Acesso em: 4 jun. 2023.

XAVIER, M. N.; DIAS, V. B. Gênero e sexualidade no ensino de Ciências e Biologia: uma análise da BNCC. **Com a Palavra, o Professor**, Vitória da Conquista, v. 8, n. 21, p. 107-130, 2023. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/807>. Acesso em: 23 jun. 2024.

ZACKA, B. **When the state meets the street:** public service and moral agency. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017.

ZYLBERKAN, M. A educação sexual no Brasil: tensões e desafios contemporâneos. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 36, e229610, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PolisePsique/article/view/124178/84792>. Acesso em: 5 mar. 2025.

APÊNDICE

APÊNDICE A

ROTEIRO ENTREVISTA BNR ESCOLA

1. PERFIL BNR

- Qual sua idade?
- Como se identifica em termos de identidade de gênero?
- Você circula bastante pelo bairro?
- Atualmente, você está estudando ou faz algum curso? Qual?
- Onde você fez graduação? Quando?
- Antes de trabalhar na escola, trabalhou em outros lugares?

2. TRABALHO ATUAL – entender fluxos desse emprego atual

- Conte mais sobre as atividades que exerce. Como é o cotidiano?
- Como é a relação com os demais colegas de trabalho?
- Como é relação com coordenação e direção? E com representantes do estado?
- Tem relações com outras instituições? Quais?
- Qual é o perfil dos alunos da escola na sua visão?
- Pode contar alguns exemplos de como é a relação com os alunos além da sala de aula?

3. COTIDIANO DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA SEXUAL E REPRODUTIVA

3.1 CONHECIMENTOS SOBRE EXPERIÊNCIA SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL

- Nos seus cursos, graduação, pós entre outros, quais conhecimentos adquiriu sobre saúde sexual e reprodutiva dos jovens?
- Já teve alguma formação ofertado pela prefeitura, estado, alguma organização, sobre saúde sexual e reprodutiva dos jovens no ambiente escolar?
- Você já tem muitos anos de experiência trabalhando com o tema da saúde sexual e reprodutiva?

3.2 EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO À SEXUALIDADE JUVENIL

- No seu trabalho, quando e como aparecem assuntos relacionados à sexualidade juvenil?

- Os/as jovens chegam até ti para conversar sobre algo relacionado à sexualidade? Qual o perfil desses jovens?
- Como é explorado na escola o tema da sexualidade?
- Você trabalha em sala de aula? Por que trabalha sobre isso?
- Existe alguma diretriz que você tem que seguir? Acha que eles contemplam tudo que precisa?
- O que você faz nessas aulas?
- O que você não deixa de falar em uma atividade desse tipo? Que você acha muito importante.
- Além das atividades contigo, tem palestras? Vocês vão com os alunos para algum local, universidade, posto?
- Teria como citar exemplos de aulas que trabalhou sexualidade juvenil?
- o E os jovens gostam dessas aulas?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nessas atividades?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que eles sobre isso?
- o Já teve alguma situação em que queria fazer algo, mas suas regras de trabalho não permitiam? Como agiu daí?
- o Estabelece uma boa relação com os alunos?

3.3 GRAVIDEZ

- Já acompanhou muitos casos de gravidez na juventude nos seus anos de trabalho?
- Considera que a gravidez na juventude pode trazer algum problema?
- Qual o perfil desses jovens grávidos?
- Como é dar aula para jovens gestantes (mulheres e homens)?
- Mantém relação com alunos no período da gravidez? E, depois, mantém vínculo?
- O que você não deixa de falar quando um/a aluno/a vem conversar sobre gravidez com você já estando gestante? Que você acha muito importante.
- Teria como citar exemplos de vivências suas com alunos e alunas com experiência reprodutiva?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir com jovens gestantes?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que eles sobre a gestação?

- o Já teve alguma situação em que queria fazer algo, mas suas regras de trabalho não permitiam? Como agiu daí?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?

4. MATERNIDADE NA JUVENTUDE

- Você conversa com as jovens sobre a maternidade na escola?
- Como segue o acompanhamento escolar da mãe depois do nascimento do bebê?
- Acha que as jovens mães enfrentam dificuldades ou não?
- Ser mãe transforma de que forma a vida dessa jovem?
- Teria como citar exemplos de experiências falando com jovens sobre maternidade?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses casos?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Estabelece uma boa relação depois?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que eles sobre esse período?

5. PATERNIDADE NA JUVENTUDE

- Você conversa com os jovens sobre a paternidade?
- Você tem muita relação com os jovens pais? Como é sua atuação com eles?
- Estabelece uma boa relação depois?
- Como é que age em relação ao pai jovem?
- Acha que os jovens pais enfrentam dificuldades ou não?
- Ser pai transforma de que forma a vida desse jovem?
- Teria como citar exemplos de experiências falando com jovens sobre paternidade?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses casos?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Estabelece uma boa relação depois?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que eles sobre esse período?

6. ENCERRAMENTO

- Tem mais algum tópico que gostaria de tratar?
- O que achou da entrevista?
- Quer receber a transcrição da entrevista para ver possibilidades de alteração?

- Gostaria de receber a pesquisa final?
- Qual pseudônimo você gostaria de ter na pesquisa?

APÊNDICE B

ROTEIRO ENTREVISTA BNR US

1. PERFIL BNR

- Qual sua idade?
- Como se identifica em termos de identidade de gênero?
- Você circula bastante pelo bairro?
- Atualmente, você está estudando ou faz algum curso? Qual?
- Você fez graduação? Qual? Onde? Quando?
- Antes de trabalhar na US, trabalhou em que outros lugares?

2. TRABALHO ATUAL

- Conte mais sobre as atividades que exerce. Como é o cotidiano?
- Poderia falar um pouco sobre a parceirização?
- Qual é a experiência dentro da atenção primária?
- Como é a relação com demais colegas? Como é relação com gerência? Com a empresa que parceirizou a US? E com prefeitura?
- Tem relações com outras instituições? Quais?
- Existem metas que você tem que cumprir todo o mês?
- Percebo que são poucos jovens que acessam a unidade, por que você acha que isso ocorre? Qual o perfil em geral deles(as)? Quais as demandas que o(a) jovem tem?
- Pode me contar sobre os últimos casos de jovens que atendeu? Como era? Como lidou?
- Tem diferentes abordagens no seu trabalho com um jovem do que teria com um adulto?

3. COTIDIANO DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA SEXUAL E REPRODUTIVA

3.1 CONHECIMENTOS SOBRE EXPERIÊNCIA SEXUAL E REPRODUTIVA JUVENIL

- Nos seus cursos, graduação, pós, entre outros, quais conhecimentos adquiriu sobre saúde sexual e reprodutiva dos jovens?
- Já teve alguma formação ofertado pela prefeitura, Divina, alguma outra organização, sobre saúde sexual e reprodutiva dos jovens na US?

- Você já tem muitos anos de experiência trabalhando com saúde sexual e reprodutiva? E algo mais específico voltado para jovens?

3.2 EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO À SEXUALIDADE JUVENIL

- No seu trabalho, quando e como aparecem assuntos relacionados à sexualidade juvenil?
 - O que você faz nesses atendimentos?
 - Quais são as diretrizes e os protocolos que você segue? Acha que eles contemplam tudo que precisa?
 - O que você não deixa de falar em uma consulta sobre saúde sexual? Que você acha muito importante.
 - Tem ações que a unidade já fez em parceria com escola ou com uma associação do bairro em se tratando de saúde sexual e reprodutiva? A comunidade já pediu algo nesse sentido?
 - Teria como citar exemplos de vivências suas no trabalho que tem relação com sexualidade juvenil?
- o Já teve alguma situação em que queria fazer algo, mas suas regras de trabalho não permitiam? Como agiu daí?
- o Você acha que tem mais conhecimento que jovens sobre esses assuntos? (explorar se assume narrativa de detentor de conhecimento)
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Acha que os jovens saem satisfeitos das consultas? Acha que as consultas fazem diferença na vida deles?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses atendimentos?
- o Como leva em considerações questões como escola, território, família, violência sexual, drogas na hora de fazer o atendimento?

3.3 GRAVIDEZ

- Tem muitos casos de gravidez na juventude atendidos no posto?
- Considera que a gravidez na juventude pode trazer algum problema? Algo lhe preocupa nessas gestações mais do que em outras?
- Qual o perfil desses jovens grávidos?
- Quais são as diretrizes, protocolos que segue?

- Costumam encaminhar para gestação de alto risco? Por que?
- Tem algum apoio do telessaúde, contato com alto risco?
- O que você não deixa de falar em uma consulta desse tipo? Que você acha muito importante.
- Tem alguma diferença no pré-natal de uma jovem e de uma mulher adulta?
- Teria como citar exemplos de vivências suas no trabalho atendendo casos de gravidez na juventude?
- o Já teve alguma situação em que queria fazer algo, mas suas regras de trabalho não permitiam? Como agiu daí?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que eles sobre esse período?
- o Estabelece uma boa relação nesses atendimentos? E depois deles mantém vínculo? São jovens que já viu mais vezes?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Como leva em considerações questões como escola, território, família, violência sexual, drogas na hora de fazer o atendimento?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses atendimentos?
- o Acha que os jovens saem satisfeitos das consultas? Acha que as consultas fazem diferença para eles?
- o Falam sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar nesse período?

4. MATERNIDADE NA JUVENTUDE

- Como a equipe se organiza para a chegada do bebê?
- Como funciona a questão do nascimento no hospital e depois a volta pra US?
- Você conversa com as jovens sobre a maternidade em consultas?
- Como é o acompanhamento das mães e bebês após o nascimento?
- Acha que as jovens mães enfrentam dificuldades ou não?
- Ser mãe transforma de que forma a vida dessa jovem?
- Teria como citar exemplos de experiências falando com jovens sobre maternidade?
- o Como segue o acompanhamento da mãe depois do nascimento do bebê?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses atendimentos?
- o Utiliza como os dados anteriores da jovem para fazer a consulta?

- o Estabelece uma boa relação depois?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que elas sobre esse período?

5. PATERNIDADE NA JUVENTUDE

- Você conversa com os jovens sobre a paternidade?
- Como é o acompanhamento dos pais e bebês após o nascimento?
- Acha que os jovens pais enfrentam dificuldades ou não?
- Ser pai transforma de que forma a vida dessa jovem?
- Teria como citar exemplos de experiências falando com jovens sobre paternidade?
- o Como segue o acompanhamento da mãe depois do nascimento do bebê?
- o Já teve conversas com colegas de trabalho para pensar em como agir nesses atendimentos?
- o Utiliza como os dados anteriores da jovem para fazer a consulta?
- o Estabelece uma boa relação depois?
- o Tem táticas que você usa com os jovens para eles fazerem o que você deseja?
- o Você acha que tem muito mais conhecimento que elas sobre esse período?

6. ENCERRAMENTO

- Tem mais algum tópico que gostaria de tratar?
- O que achou da entrevista?
- Quer receber a transcrição da entrevista para ver possibilidades de alteração?
- Gostaria de receber a pesquisa final?
- Qual pseudônimo você gostaria de ter na pesquisa?

APÊNDICE C

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA COM JOVENS

1. PERFIL SOCIOECONÔMICO E FAMILIAR

- Quando e onde você nasceu?
- Como se identifica em termos de cor ou raça?
- Como se identifica em termos de identidade de gênero?
- Como você classifica a sua classe/condição socioeconômica? Por quê?
- Tem religião? Você é praticante?
- Com quem você mora? (pensar também na questão de rede de apoio) Mora a bastante tempo nesse lugar?
- E sobre sua família: tem irmã(o)s? Qual a idade e eles trabalham?
- E sobre seus pais, especificamente: qual a idade deles? Qual a escolaridade deles? Quais profissões exercem atualmente?
- Você ou alguém da sua família recebe algum tipo de ajuda ou colaboração econômica de alguém? Ex.: Bolsa família

2. SOCIABILIDADE, TRABALHO E EDUCAÇÃO DO/A JOVEM

- Gostaria de saber um pouco mais sobre a sua vida em geral, entender melhor como é seu cotidiano. O que faz? Com quem sai? Como se diverte?
- Como é o bairro onde você mora? Você gosta? (Explorar se aparece questão de violência e tráfico. Caso não, atentar se aparece ao longo da entrevista ou fazer alguma discussão sobre ao final).
- Tem algum grupo de amigos ou de outras pessoas que você participa bastante? Onde se encontram e como é?
- Está em algum relacionamento amoroso?
- Atualmente, você está estudando ou faz algum curso? Qual? Estuda em escola/faculdade pública ou particular?
- Se parou: você estudou até que série/nível? Com que idade parou os estudos? Por quê?

- Você trabalha ou já trabalhou? Com que idade começou a trabalhar? Que trabalhos já teve? Todos foram remunerados?

3. CONVERSANDO SOBRE SEXO

- Lembra quando você ouviu a primeira vez falar sobre sexo?
- Você costuma conversar sobre sexo? Com quem?
- Conversa com amigos?
- Conversa com a família sobre?
- Usa da internet para saber mais sobre coisas relacionadas ao sexo?

Você também já ouviu falar sobre:

- Contraceptivos? Onde? O que ouviu? O que aprendeu?
- ISTs? Onde? O que ouviu? O que aprendeu?
- Testes rápidos? Onde? O que ouviu? O que aprendeu?
- Já conversou com alguém sobre gravidez? Com quem? Como foi?
- Quando você tem dúvidas, perguntas ou curiosidades sobre sexo e sobre os cuidados ao redor do sexo, com quem, onde ou como você tira? A quem você costuma recorrer?
- Existe espaços que você frequenta que se conversa relações sexuais, sexualidade? Um espaço de convivência? Igreja? Outro local?
- Como são as conversas nestes lugares?
- Quem participa das atividades nesses lugares?
- Quando começou a ter relações sexuais?
- Quando você começou a ter relações sexuais, tinha algum tipo de informação sobre contracepção, gravidez, DSTs? Quem te contou sobre?
- Conforme foi tendo mais relações sexuais, foi aprendendo mais? O que? Com quem?
- É um tema delicado, mas caso você se sinta à vontade para falar... Você já passou por alguma situação de violência? Pode contar um pouco...

3.1 SAÚDE

- Que lugares você frequenta para cuidar da sua saúde?
- Já frequentou o posto de saúde? Ou algum outro espaço de saúde como hospital, UPA?
- Lembra como começou a ir no posto? Quem te atendia?
- Sempre frequentou esse posto?
- Já teve contato com a ACS?
- E por quais enfermeiros e médicos você já passou?
- Teve alguma vez que conversou com eles que te marcou mais?
- Já foi alguma vez ao ginecologista? US/SUS? Consultório privado? Como/quando decidiu ir ao gineco?
- Já foi até o posto de saúde para saber mais sobre sexualidade? Como foi?
- Alguém já conversou com você no posto de saúde sobre planejamento sexual? Planejamento familiar?
- E já conversou com você no posto de saúde sobre contracepção? Ou sobre ISTs?
- Se sente confortável para ir até o posto de saúde conversar sobre sexualidade? Acha que conseguiria um bom atendimento? Tem ideias de como melhorar o atendimento nesse sentido?
- Você já frequentou algum posto de saúde para se informar sobre gravidez especificamente? Como foi recebida/o? Por quem? Quando?

3.2 AMBIENTE ESCOLAR

- Existem conversas na escola sobre sexo? Contracepção? ISTs?
- Na escola já teve conversas sobre gravidez? Com quem? Como foi?
- Teve aulas ou palestras, outras atividades específicas sobre sexualidade? Discutem gravidez?
- Lembra se alguém do posto de saúde já foi na escola fazer alguma atividade?
- Já procurou professores, coordenação, algum outro profissional da escola para falar sobre sexualidade? Gestaçao? Como foi? Como essas pessoas te trataram?
- Teve algum/a professor/a de quem você é mais próximo que se sentia à vontade para falar sobre esses assuntos?
- Lembra de algum momento específico com esse/a professor/a?
- Sente que a escola é um espaço seguro para falar sobre sexualidade?

- Acha que tem bastante discussões na escola sobre sexualidade? Tem sugestões de como poderia ser discutido?

Se não teve relações sexuais:

- Você espera ter? Gostaria de ter? Imagina a situação em que isso pode vir a acontecer ou em que você gostaria que acontecesse?

4. CONTRACEPÇÃO E ISTs

- Você conhece métodos de contracepção? Buscou informações sobre onde?
- Falou com alguém no posto? Com sua mãe? Amigas?
- Você e/ou sua parceira/o usam algum método de contracepção? Qual? Desde quando você faz uso desse método?
- Você já usou algum outro método?
- Você já ouviu falar em ISTs?
- Vocês fazem algo para prevenir IST? O quê?

Se relação sexual com parceiro sem possibilidade fisiológica de gravidez

- Vocês fazem algo para prevenir IST? O quê?
- Vocês imaginam ter filhos/as? Como? Quando? De que forma?

5. GRAVIDEZ

- Sua mãe e outras mulheres da sua família engravidaram quando? Como foi acompanhar essas experiências?
- Você conhece outras meninas da escola ou do bairro que engravidaram? Acompanhou alguma coisa da gestação delas?
- O que você pensa sobre engravidar? (explorar primeiras reações dos(as) jovens) Por quê? De onde vem esses sentimentos?

- Se você engravidasse hoje, como seria? (observar se pensa em parar de estudar (para aquelas que estudam), questões de emprego, renda, saúde)
- Tem um momento melhor ou pior para engravidar?
- Você ouviu conversas sobre gravidez na juventude no seu cotidiano? Como são? Quem fala?
- As pessoas próximas de você falam sobre a gravidez na juventude? O que? Amigos? Pessoas com quem já se relacionou amorosamente?
- Mais especificamente, como seus familiares falam sobre a gravidez? Isso influencia a forma que você pensa de algum modo sobre o assunto?
- Mulheres: Você já ficou grávida? Quantas vezes? Vamos então conversar sobre cada gravidez.
- Homens: Já engravidou alguma parceira alguma vez? Quantas vezes? Vamos então conversar sobre cada gravidez.

Gestação 1:

- Que idade você tinha? E o/a parceiro/a? Quem é/era ele/a?
- Como aconteceu esta gravidez? (como ou por que você acha que essa gravidez aconteceu?)
- Usava algum método contraceptivo? Qual? (explorar se houve falha de método)
- Quais foram seus primeiros sentimentos/percepções em relação à gravidez?
- Queria esta gravidez? E o/a parceiro/a? A gravidez foi levada até o final?
- Como ficou seu relacionamento com seus amigos/as e familiares durante a gravidez?
- Você e seu/sua parceiro/a ficaram juntos durante a gravidez? Ele lhe ajudou? Apoiou?
- Como ficou sabendo da gravidez? Teve alguma orientação? Alguém próximo de ti falou para ir até a US?
- Fez o pré-natal em posto de saúde? Rede privada?
- Já conhecia os profissionais que te atendiam no posto de saúde? Desde quando? Já tinha relação?
- Como foi todo esse processo? Se sentiu bem, acolhida/o?
- Com quem mais teve contato durante esse processo?
- Como foi o atendimento dos profissionais? Explorar médico, enfermeira, técnicos, ACS
- Teve alguma conversa que te marcou mais?

- Falavam sobre o método de contracepção durante o pré-natal?
- Você continuou frequentando a escola (para quem ainda frequentava)?
- Teve algum/a professor/a que te auxiliou durante a gestação? Conversou contigo?
- Você teve uma rede de apoio durante a gestação?
- Percebeu preconceitos ou recebeu comentários ofensivos por ser gestante com essa idade? Como isso lhe afetou? De quem recebeu?
- Como foi o pós-parto? Seguiu em acompanhamento na US/ Hospital? Conversaram o que?
- Como foi o atendimento dos profissionais? Explorar médico, enfermeira, técnicos, ACS?
- Conversou sobre mais alguém sobre contracepção depois do parto?
- Como foi seu puerpério?
- Como foi o atendimento dos profissionais? Explorar médico, enfermeira, técnicos, ACS
- E a volta para a escola (para quem ainda frequentava)?
- Teve algum/a professor/a com quem conversou mais? Que te ajudou mais? Como foi?

Se NÃO (gravidez interrompida):

- Como foi a decisão pelo aborto? Em que circunstâncias ele foi realizado? Onde fez? Tempo de gestação? Como conseguiu os meios para abortar?
- Se ela não tiver mencionado sobre o parceiro: Seu parceiro tomou conhecimento na época ou depois?
- Qual foi a reação dele?
- A sua família soube? Mais alguém soube? Teve ajuda de alguém?
- Depois desse aborto, o que aconteceu em termos de contracepção?

Para TODOS/TODAS com e sem experiência reprodutiva (expectativas em relação à reprodução):

- Você pretende ter filho(s) [ou ter mais filhos] nos próximos 5 anos? Por quê?
- Se pessoa não-hetero: de que forma imagina que possa acontecer essa maternidade/paternidade?
- Você já deixou de transar por medo de engravidar ou engravidar a parceira? Explorar essa situação.

- E se acontecer de você engravidar ou engravidar parceira sem querer? O que imagina que vai fazer?

6. MATERNIDADE E PATERNIDADE

6.1 MATERNIDADE

- Tem filhos? Quantos filhos(as) você tem/teve? Qual(is) a(s) idade(s) deles/as? Com que idade você teve o primeiro filho?
- Você tinha vontade de ser mãe?
- Como é seu cotidiano sendo mãe?
- E como era antes de descobrir a gravidez?
- Você tem se sentido como?
- Acha que tem uma idade certa para ser mãe?
- São todos de um mesmo relacionamento/parceria? Todos os filhos vivem com você? Em negativo, onde estão e por que... (Onde moram? Com quem moram?) O que vocês gostam de fazer juntos?
- Existe alguém com responsabilidade maior pela criança? Quem? Por que você acha?
- Quem é/são responsável pelo sustento financeiro da(s) criança(s)?
- Me conte um pouco como ficou a sua vida depois que seu primeiro/a filho/a nasceu.
- Você estuda? (escola, curso técnico, faculdade) Tem dificuldades na manutenção do estudo?
- Acompanha a saúde do(a) filho(a) por que meios? (UBS, médicos privados)
- Com que profissionais? Médico? Enfermeira? ACS? Como é o atendimento?
- Com quem você conta mais agora / de quem você tem mais apoio (no caso de ter filho/a)?
- Você consegue ter momentos de lazer? Como é isso/ficou isso a partir do nascimento da criança?
- Como você vê o papel do pai na criação do filho(a)?
- Acredita que sua vida sofreu mais mudanças do que a do pai do(a) filho(a)? Por quê?

6.2 PATERNIDADE (apenas para quem já teve filhos)

● Tem filhos? Quantos filhos(as) você tem/teve? Qual(is) a(s) idade(s) deles/as? Com que idade você teve o primeiro filho?

● Você tinha vontade de ser pai?

● Como é seu cotidiano sendo pai?

● E como era antes de descobrir a gravidez?

● Você tem se sentido como?

● Acha que tem uma idade certa para ser pai?

● Ser pai na adolescência pra você muda alguma coisa?

● São todos de um mesmo relacionamento/parceria? Todos os filhos vivem com você? Em negativo, onde estão e por que... O que vocês gostam de fazer juntos?

● Existe alguém com responsabilidade maior pela criança? Quem? Por que você acha?

● Quem é/são responsável pelo sustento financeiro da(s) criança(s)?

● Me conte um pouco como ficou a sua vida depois que seu primeiro/a filho/a nasceu.

● Você estuda? (escola, curso técnico, faculdade) Tem dificuldades na manutenção do estudo?

● Acompanha a saúde do(a) filho(a) por que meios?

● Com que profissionais? Médico? Enfermeira? ACS? Como é o atendimento?

● Com quem você conta mais agora / de quem você tem mais apoio (no caso de ter filho/a)?

● Você consegue ter momentos de lazer? Como é isso/ficou isso a partir do nascimento da criança?

● Como você vê o papel da mãe na criação do filho(a)?

● Acredita que sua vida sofreu mais mudanças do que a da mãe do(a) filho(a)? Por quê?

6.3 MATERNIDADE (para quem não tem experiência reprodutiva)

● Você já teve vontade de ser mãe? Por que motivos?

● Se tem vontade, mas ainda não é, por que ocorreu isso?

● Deseja ser mãe num futuro próximo?

● O que você acha que é ser mãe?

● Acha que por ser jovem, a maternidade tem um peso diferente?

● O que você acha que mudaria na sua vida?

- Como você vê o papel do pai na criação do filho(a)?
 - Existe alguém com responsabilidade maior pela criança? Quem? Por que você acha?
- Acredita que sua vida sofreria mais mudanças do que a do pai do(a) filho(a)? Por quê?

6.4 PATERNIDADE (para quem não tem experiência reprodutiva)

- Você já teve vontade de ser pai? Por que motivos?
- Se tem vontade, mas ainda não é, por que ocorreu isso?
- Deseja ser pai num futuro próximo?
- O que você acha que é ser pai?
- Acha que por ser jovem, a paternidade tem um peso diferente?
- O que você acha que mudaria na sua vida?
- Como você vê o papel da mãe na criação do filho(a)?
- Existe alguém com responsabilidade maior pela criança? Quem? Por que você acha?
- Acredita que sua vida sofreria mais mudanças do que a da mãe do(a) filho(a)? Por quê?

7. ENCERRAMENTO

- Gostaria de falar mais algo que acha que faltou?
- O que achou da entrevista?
- Tem algum nome que gostaria de ter na pesquisa?

APÊNDICE D

TCLE AGENTES

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Gravidez na juventude: olhares para as políticas públicas, para os agentes de nível de rua e para os jovens de Porto Alegre, RS”. Ela é desenvolvida no Programa de Pós- Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é compreender como os(as) jovens, homens e mulheres, percebem a gravidez na juventude, assim como a maternidade e paternidade. Depois, vamos analisar como estas ideias deles(as) podem ser relacionadas com o que dizem as políticas públicas e os profissionais que atuam nas escolas e nos serviços de saúde com os(as) jovens. Nesse caso, você é um dos(as) profissionais com os quais gostaríamos de falar.

Esperamos que os resultados do estudo possam ajudar os responsáveis pela elaboração de políticas de saúde e educação na cidade de Porto Alegre voltadas para a reprodução juvenil. Como pontos positivos para sua participação na pesquisa elencamos os seguintes: poder dialogar sobre sexualidade juvenil e gravidez na juventude, refletir sobre os acessos à educação e saúde sexual, pensar sobre suas percepções acerca da gestação e dos papéis exercidos na maternidade e paternidade e, mais relevante de tudo, pensar em como você se coloca em seu cotidiano de trabalho em relação a essas temáticas.

Os riscos e/ou desconfortos relacionados à entrevista são que você pode sentir: possível desconforto emocional diante de certos assuntos relacionados à sexualidade e à reprodução de jovens. Ao abordar certas temáticas, você pode se sentir intimidado(a), envergonhado(a), triste e/ou outro sentimento que cause mal-estar.

Para evitar o seu desconforto ou mal-estar, é importante que você saiba que é possível encerrar sua participação na pesquisa caso assim deseje sem ter qualquer tipo de prejuízo. Você não precisa responder a qualquer questionamento caso não se sinta confortável. Você pode pedir para suspender a entrevista enquanto ela já estiver ocorrendo caso sinta qualquer desconforto. Ainda, reiteramos que mesmo que com riscos mínimos, existe a possibilidade de divulgação de dados de participantes da pesquisa, o que se buscará evitar ao máximo. A entrevista poderá ser retomada quando e caso você concordar. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, você terá direito a ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, segundo a Resolução CNS 510, VI, Art. 9.

Gostaríamos de convidar você para participar do estudo. A participação na pesquisa consiste na realização de uma entrevista individual com uma a duas horas de duração, em local

privativo e conduzida por uma entrevistadora treinada. A entrevista será uma conversa sobre a vida na comunidade, sexualidade, gravidez, maternidade e paternidade. A entrevista será gravada em áudio e depois transcrita, sendo o material guardado em local seguro por cinco anos. A pesquisa também envolve a observação dos equipamentos sociais no território; se você autorizar, a pesquisadora ficará em alguns momentos acompanhando o cotidiano do seu espaço de trabalho.

Os dados da pesquisa não serão identificados, isto é, seu nome não irá aparecer em qualquer momento. Os resultados serão apresentados sem que seja possível identificar individualmente os participantes. Todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo digital, sob guarda e responsabilidade da pesquisadora, por um período de cinco anos após o término da pesquisa, para que o(a) participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro.

Garantimos aos participantes o acesso aos resultados da pesquisa. Isso se dará a partir da apresentação dos resultados da pesquisa nas escolas e no posto de saúde.

A participação no estudo é voluntária e você tem toda a liberdade para aceitar ou recusar este convite, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. Você também pode se recusar a responder alguma pergunta ou desistir da participação em qualquer momento do estudo. Se você tiver alguma dúvida sobre o estudo, poderá contatar a pesquisadora responsável Andréa Fachel Leal no telefone (51) 996681678 ou no telefone (54) 999101700. Também, pode entrar em contato com o CEP UFRGS localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: (51) 3308 3738. Ainda, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, CEP SMSPA, localizado na Rua Capitão Montanha, 27 – 6º andar (Centro Histórico). O telefone para contato é (51) 3289-5517. O e-mail para contato é: cep_sms@hotmail.com

O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS e pelo CEP-SMSPA. Um CEP é um Comitê de Ética em Pesquisa, um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar – emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos. O CEP-SMSPA delibera sobre aspecto científico e ético de projetos de pesquisa realizados em diferentes setores e secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no caso deste estudo, setores de Saúde e Educação do município. O CEP-SMSPA busca adequar as pesquisas com seres humanos à legislação e preservar a integridade dos participantes da pesquisa.

Data:

Assinatura do Participante

Assinatura da Pesquisadora

APÊNDICE E

TCLE JOVENS

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Gravidez na juventude: olhares para as políticas públicas, para os agentes de nível de rua e para os jovens de Porto Alegre, RS”. Essa pesquisa é desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queremos compreender o que vocês, jovens, pensam sobre a gravidez na juventude e sobre ser mãe ou ser pai. Estamos também analisando as políticas públicas e o que profissionais de educação e de saúde têm a dizer sobre o assunto.

Esperamos que os resultados do estudo possam ajudar os responsáveis pela elaboração de políticas de saúde e de educação da cidade de Porto Alegre. Se você aceitar participar deste estudo, você terá a oportunidade de conversar, de forma confidencial e segura, sobre sexualidade e sobre gravidez na juventude, refletir sobre seu acesso à educação e à saúde, além de pensar sobre suas percepções acerca da gestação e dos papéis exercidos na maternidade e paternidade.

Em qualquer situação de pesquisa, pode haver riscos e/ou desconfortos. Numa situação de entrevista, você pode eventualmente sentir desconforto emocional diante de certos assuntos abordados, como, por exemplo, a gravidez. Também é possível que se sinta tímido(a), envergonhado(a), triste ou mal-estar. Para evitar que você se sinta mal ou mesmo ofendido(a), você pode interromper a conversa/entrevista em qualquer momento. Pode também escolher não responder a qualquer uma das perguntas que sejam feitas. E, se você desejar interromper a entrevista, mas depois quiser retomar a conversa em outro momento, isto também é possível. Não queremos provocar qualquer desconforto ou mal-estar. Ainda, reiteramos que mesmo que com riscos mínimos, existe a possibilidade de divulgação de dados de participantes da pesquisa, o que se buscará evitar ao máximo. Se você entender que houve algum dano decorrente da sua participação na pesquisa, terá direito a ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, segundo a Resolução CNS 510, VI, Art. 9.

Este é um convite para você participar do estudo. A participação na pesquisa consiste na realização de uma entrevista individual com duração de cerca de uma hora, em local privativo e conduzida por uma entrevistadora treinada. A entrevista será uma conversa sobre a vida na comunidade, sexualidade, gravidez, maternidade e paternidade.

A entrevista será gravada em áudio e depois transcrita, sendo o material guardado em local seguro por cinco anos. Os dados da pesquisa não serão identificados, isto é, seu nome não

irá aparecer em nenhum momento. Os resultados serão apresentados sem que seja possível identificar individualmente os participantes. Todos os dados coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em arquivo digital, sob guarda e responsabilidade da pesquisadora principal, por um período de cinco anos. Assim, se você decidir em qualquer momento (mesmo depois que esta pesquisa já terminou) que você prefere retirar sua participação, você pode informar à pesquisadora principal.

Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados de mais de uma maneira. Nós planejamos divulgar os principais resultados na própria comunidade, discutindo a pesquisa na escola e no serviço de saúde. Além disso, vamos discutir os resultados com os gestores e com os profissionais que atuam na escola e no posto de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre o estudo, poderá contatar a pesquisadora responsável Andréa Fachel Leal no telefone (51) 996681678 ou no telefone (54) 999101700. Também, pode entrar em contato com o CEP UFRGS localizado na Av. Paulo Gama, 110, Sala 311, Prédio Anexo I da Reitoria - Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060. Fone: (51) 3308 3738. Ainda, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, CEP SMSPA, localizado na Rua Capitão Montanha, 27 – 6º andar (Centro Histórico). O telefone para contato é (51) 3289-5517. O e-mail para contato é: cep_sms@hotmail.com.

O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS e pelo CEP-SMSPA. Um CEP é um Comitê de Ética em Pesquisa. É um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar – emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito da instituição. O CEP-SMSPA delibera sobre aspecto científico e ético de projetos de pesquisa realizados em diferentes setores e secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no caso deste estudo, setores de Saúde e Educação do município. O CEP SMSPA busca adequar as pesquisas com seres humanos à legislação e preservar a integridade dos participantes da pesquisa.

Data:

Assinatura do Participante

Assinatura da Pesquisadora

APÊNDICE F

RODA DE CONVERSA COM JOVENS

1. PERFIL DOS ALUNOS

- Qual a idade média de vocês?
- Vocês moram em que bairro?
- Além da escola, que atividades exercem?
- Alguém trabalha?
- Tem um outro curso que estão fazendo?
- Quais os espaços que circulam aqui pelo bairro?

2. CONVERSANDO MAIS

- Lembra quando você ouviu a primeira vez falar sobre sexo?
- Você costuma conversar sobre sexo? Com quem? Conversa com amigos? Conversa com a família sobre?
- Usa da internet para saber mais sobre coisas relacionadas ao sexo?
- E contraceptivos? Vocês conhecem? O que sabem sobre?
- Falando em proteção, vocês conhecem ISTs? Aprenderam com quem? O que sabem?
- Já conversou com alguém sobre gravidez, contracepção, ISTs? Com quem? Como foi?
- Quando você tem dúvidas, perguntas ou curiosidades sobre sexo e sobre os cuidados ao redor do sexo, com quem, onde ou como você tira? A quem você costuma recorrer?
- Existe espaços que você frequenta que se conversa sobre relações sexuais, sexualidade? Um espaço de convivência? Igreja? Outro local? Como são as conversas nestes lugares? Quem participa das atividades nesses lugares?
- Quando você começou a ter relações sexuais, tinha algum tipo de informação sobre contracepção, gravidez, ISTs? Quem te contou sobre?

2.1 SAÚDE

- Que lugares você frequenta para cuidar da sua saúde?

- Já frequentou o posto de saúde? Ou algum outro espaço de saúde como hospital, UPA?
- Lembra como começou a ir no posto? Quem te atendia?
- Sempre frequentou esse posto?
- Já teve contato com a ACS? E por quais enfermeiros e médicos você já passou?
- Já foi alguma vez ao ginecologista? US/SUS? Consultório privado? Como/quando decidiu ir ao gineco?
- Já foi até o posto de saúde para saber mais sobre sexualidade? Como foi? Falaram também sobre planejamento familiar? ISTs? Contracepção? Questão de gravidez?
- Se já teve consulta sobre essas questões, como é a relação com eles?
- Teve alguma vez que conversou com eles que te marcou mais?
- Você acha que essas conversas mudaram alguma coisa na vida de vocês?
- Se sente confortável para ir até o posto de saúde conversar sobre sexualidade? Acha que conseguiria um atendimento bom? Tem ideias de como melhorar o atendimento nesse sentido?

2.2 AMBIENTE ESCOLAR

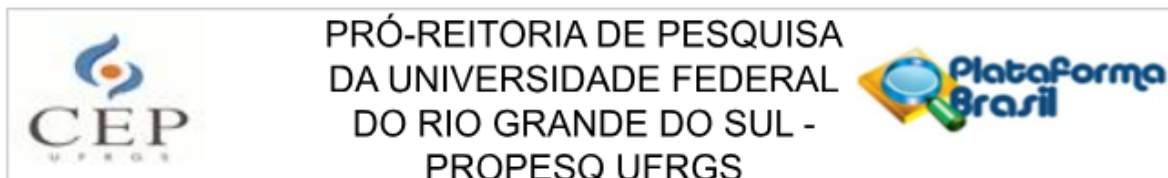
- Existem conversas na escola sobre sexo? Contracepção? ISTs? Gravidez?
- Teve aulas ou palestras, outras atividades específicas sobre sexualidade? Discutiram o que? Como se sentiu?
- Você acha que essas conversas mudaram alguma coisa na vida de vocês?
- Lembra se alguém do posto de saúde já foi na escola fazer alguma atividade?
- Você acha que essas conversas mudaram alguma coisa na vida de vocês?
- Já procurou professores, coordenação, algum outro profissional da escola para falar sobre sexualidade? Gestaç o? Como foi? Como essas pessoas te trataram?
- Teve algum/a professor/a de quem voc     mais pr  ximo que se sentia   vontade para falar sobre esses assuntos?
- Lembra de algum momento espec  fico com esse/a professor/a?
- Nessas aulas, palestras, atividades e at   perguntas no particular com o professor, que rela  es foram estabelecidas?
- Sente que a escola   um espa  o seguro para falar sobre sexualidade?
- Acha que tem bastante discuss  es na escola sobre sexualidade? Tem sugest  es de como poderia ser discutido?

3. GRAVIDEZ

- Sua mãe e outras mulheres da sua família engravidaram quando? Como foi acompanhar essas experiências?
- Se você engravidasse hoje, como seria?
- Tem um momento melhor ou pior para engravidar?
- Existe alguém com responsabilidade maior pela criança? Quem? Por que você acha?
- Como você vê o papel do pai na criação do filho(a)? E da mãe?
- Alguém quer compartilhar um pouco sobre sua gestação, caso se sinta à vontade?
- Alguém quer compartilhar sobre como é sua experiência sendo mãe e/ou ser pai?

ANEXO

ANEXO A



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: Gravidez na juventude: olhares para as políticas públicas, para os agentes de nível de rua e para os jovens de Porto Alegre, RS

Pesquisador: ANDREA FACHEL LEAL

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 75941623.5.0000.5347

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.715.966

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento Informações Básicas da Pesquisa n.º 2300227_E1, datado em 07/03/2024.

Introdução:

Dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Governo Federal (Governo Federal, 2022), o SINASC, apontam que, desde 2019, o número de mães com idades entre 10 e 19 anos, diminuiu, em média, 18%. Apesar da crescente redução dos casos de gravidez na juventude, ela é tratada como grande problemática por diversos setores da sociedade brasileira. Reyes e Almontes (2014) indicam que a percepção da gravidez na juventude como um problema é justificada por alguns fatores principais: infrequência escolar, riscos de saúde, dificuldades de conseguir emprego e manutenção da pobreza. Porém, os autores demonstram que a maioria dos jovens desistem da escola antes de engravidar, que jovens enfrentam condições de saúde impróprias muito antes de ter filhos, que os pais e as mães adolescentes já não conseguiam trabalho antes do nascimento da criança e que os jovens já estavam na condição de pobreza antes de passarem pela experiência de reprodução sexual. Heilborn (2006) também aponta para a construção da noção de que a gravidez na juventude é um

problema social, vista como um evento perturbador. Para ela, essa visão ignora a diversidade de circunstâncias e desdobramentos que a maternidade e paternidade juvenis podem trazer. A partir disso, nos perguntamos: o que torna a gravidez na juventude um problema social ou não? Inicialmente, apontamos três fatores centrais: raça, classe e gênero, os quais discutiremos ao longo dessa tese. E, se políticas públicas existem para resolver problemas sociais, como boa parte da literatura sobre políticas públicas destaca, também nos perguntamos: que políticas públicas existem no que tange a reprodução juvenil? Como os atores de políticas públicas entendem a gravidez na juventude? Aqui, a partir da perspectiva da *anthropology of policy* (Shore; Wright; Però, 2011; Shore; Wright, 1997), entendemos que as políticas não são simplesmente coisas, elas são *„assemblages“*: *„Policies are not simply `transferred`, they are reinterpreted as they travel across cultural boundaries.“* (Shore; Wright, 2011, p.20). Assim, ao analisar políticas públicas, estamos discutindo o contexto social, econômico e cultural em que nos inserimos e como este é formulado. Nesta tese, buscamos focar nas políticas públicas juvenis de saúde e educação voltadas para a reprodução. Aqui, buscamos atentar para como se constroem as representações sociais acerca da gravidez, maternidade e paternidade juvenis, tanto por parte das narrativas oficiais das políticas quanto por parte de jovens com e sem experiência reprodutiva e dos agentes de nível de rua que trabalham em escolas e postos de saúde. Tudo isso no contexto da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Na presente pesquisa, problematizamos a gravidez na juventude entre os(as) jovens de 16 a 20 anos, então esta será a faixa etária da pesquisa. Vale esclarecer também que quando falamos em experiência reprodutiva, nos referimos tanto às experiências gestacionais que resultaram em nascimentos de crianças quanto, possivelmente, àquelas que não. Temos como problema de pesquisa: quais as distâncias e/ou aproximações entre as representações sociais acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade que os e as jovens porto-alegrenses têm, entre as narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de saúde e de educação de Porto Alegre voltadas para a reprodução e entre os agentes de nível de rua que atuam nesses contextos?

Metodologia Proposta:

Para atingir o objetivo de analisar as políticas públicas juvenis voltadas para a reprodução, partimos de uma análise documental de dados secundários em corpos normativos no nível federal, estadual (Rio Grande do Sul) e municipal (Porto Alegre). Foi feita uma entrada em campo de caráter exploratório no bairro Mário Quintana, na Região Nordeste de Porto Alegre,

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

que possui a maior taxa de natalidade a cada 1.000 jovens (12,68/1.000). O bairro Mário Quintana foi escolhido para ser o universo empírico no qual a pesquisa será desenvolvida. Neste território serão observados os serviços de saúde, e serão convidados para entrevistas jovens e agentes de nível de rua. Seguindo preceitos da OPAS/OMS (OPAS,

1995), gravidez na juventude aquela que ocorreu entre os 10 e 20 anos de idade incompletos, então este é o primeiro recorte a ser levado em conta. No presente estudo, optamos por entrevistar jovens entre 16 e 20 anos de idade (considerando que a experiência da gestação pode ter se dado aos 19 anos e vamos fazer a entrevista logo depois desse evento). Para o objetivo de analisar as representações sociais dos e das jovens com e sem experiência reprodutiva entre 16 e 20 anos, serão feitas entrevistas semiestruturadas. Estima-se entrevistar 24 jovens (12 mulheres e 12 homens), além de 8 agentes públicos (professores e agentes de saúde). O número total de entrevistas estimado pode variar de acordo com o nível de saturação dos conteúdos. A forma de contato com os(as) possíveis entrevistados(as) se dará por intermédio dos agentes de nível de rua que

acessaremos no bairro Mário Quintana. Após estabelecer contato com os primeiros entrevistados, a sequência de captação dos mesmos se dará através do recurso de bola de neve (a pessoa entrevistada será convidada a indicar outros potenciais participantes para a pesquisa). Prevê-se uma a duas horas de duração para cada entrevista, que será agendada previamente em função da disponibilidade e preferência do interlocutor, em local

de sua preferência. A entrevista será gravada com gravador de voz e transcrita na íntegra, sendo os arquivos de áudio e de transcrição armazenados em HD externo criptografado por um período de cinco anos após o término da pesquisa, para que o(a) participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro. Pelas resoluções 466 e 510, a princípio menores de 18 anos têm de assentir (TALE) e os seus responsáveis têm de consentir com sua participação na pesquisa (TCLE). Solicita-se a dispensa do TCLE para responsáveis por jovens de 16 e 17 anos, mantendo-se o TCLE para os jovens entrevistados. Se for necessário o consentimento de

responsável, em se tratando de uma pesquisa que aborda a sexualidade juvenil, possivelmente alguns responsáveis não deixariam os(as) jovens participarem ou já buscariam direcionar suas falas. Observa-se que o CONEP aprovou recentemente pesquisa desenvolvida por este mesmo grupo de pesquisa em que as pesquisadoras atuam, por essas mesmas razões. Trata-se do estudo ¿Contextos de vulnerabilidade ao HIV entre jovens de

camadas populares: um estudo multicêntrico em cinco cidades do Brasil - Espaços Jovens¿,

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

CAAE 36495120.7.0000.5327. Todos(as) os(as) participantes da pesquisa, jovens e agentes públicos, deverão assinar o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todos terão a garantia de que sua identidade não será revelada e que a entrevista será transcrita e utilizada para fins desta pesquisa. Além das entrevistas, será feita

observação de cunho etnográfico junto dos agentes e seus ambientes de trabalho entendendo a importância de conhecer mais as dinâmicas que envolvem seus trabalhos e poder ter mais subsídio para analisar as representações sociais que estes têm acerca da gravidez, maternidade e paternidade juvenis.

Critério de Inclusão:

Como critérios de inclusão no que se refere aos(as) jovens que serão entrevistados(as), têm-se ter entre 16 e 20 anos de idade e residir em Porto Alegre. No que se refere às entrevistas e observação de cunho etnográfico com agentes de nível de rua, tem-se os seguintes critérios de inclusão: ser funcionário(a) da área da saúde ou educação de Porto Alegre, especificamente atuando em unidades de saúde e/ou escolas da rede pública de ensino no território do bairro Mário Quintana.

Critério de Exclusão:

Como critérios de exclusão para os(as) jovens têm-se: possuir menos de 16 anos ou mais de 20 anos de idade e não residir em Porto Alegre. Como critério de exclusão dos agentes de nível de rua, têm-se não ser funcionários de escolas da rede pública e ou unidades de saúde do bairro Mário Quintana.

Tamanho da Amostra no Brasil: 32 participantes.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Debater as representações sociais de jovens homens e mulheres, alguns com e outros sem experiência reprodutiva, acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade e confrontá-las com as representações sociais das narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de educação e saúde voltadas para a reprodução e com as representações sociais dos agentes de nível de rua que atuam nestes contextos.

Objetivos Secundários:

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

Como objetivos específicos, têm-se: analisar as políticas públicas juvenis do setor de educação e do setor da saúde voltadas para a reprodução; registrar, brevemente, o perfil socioeconômico e familiar dos(as) entrevistados(as) da pesquisa, tanto jovens quanto agentes de nível de rua; analisar as narrativas dos agentes acerca das políticas públicas juvenis de saúde e educação voltadas para a reprodução e analisar as narrativas dos(as)

jovens acerca de suas concepções sobre a gravidez, maternidade e paternidade na juventude.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos e/ou desconfortos relacionados à entrevista são possível desconforto emocional diante de certos assuntos relacionados à sexualidade e à reprodução de jovens. Ao abordar certas temáticas, o(a) entrevistado(a) pode se sentir intimidado(a), envergonhado(a), triste e/ou outro sentimento que cause mal-estar.

Para evitar o desconforto ou mal-estar dos(as) participantes da pesquisa, é importante que o(a) entrevistado(a) saiba que é possível encerrar sua participação na pesquisa caso assim deseje sem ter qualquer tipo de prejuízo. Ele(a) não precisa responder a qualquer questionamento caso não se sinta confortável. Ele(a) pode pedir para suspender a entrevista enquanto ela já esteja ocorrendo caso sinta qualquer desconforto. A entrevista

poderá ser retomada quando e caso ele(a) concordar. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o(a) entrevistado(a) terá direito a ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, segundo a Resolução CNS 510, VI, Art. 9.

Benefícios:

O principal benefício em potencial é indireto através da produção e divulgação do conhecimento científico que pode vir a aprimorar políticas públicas. Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados de mais de uma maneira. Nós planejamos divulgar os principais resultados na própria comunidade, discutindo a pesquisa na escola e no serviço de saúde. Além disso, vamos discutir os resultados com os gestores e com os profissionais que atuam na escola e no posto de saúde. Como potenciais benefícios para os(as) jovens entrevistados(as) acerca de sua participação na pesquisa elencamos os seguintes: poder dialogar sobre sua sexualidade e pensamentos acerca da gravidez na juventude, refletir sobre seus acessos à educação e saúde sexual, pensar sobre suas percepções acerca da gestação e dos papéis exercidos na maternidade e paternidade. Ainda, após o fim da pesquisa, receber um retorno de sua participação através de divulgação da tese por parte da acadêmica e conhecer também

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

trajetórias e entendimentos de outros jovens acerca da gestação, maternidade e paternidade juvenis.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Apresentação de emenda a projeto de pesquisa já analisado e aprovado por este CEP com a seguinte justificativa:

"Justificativa da Emenda: Solicita-se Emenda ao Projeto, com a inclusão da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre como instituição co-participante desta pesquisa. A inclusão se dá por que uma parte da coleta de dados da pesquisa será na Unidade de Saúde Chácara da Fumaça, bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Buscaremos também conversar com professores e diretores das seguintes escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Victor Issler, Escola Estadual de Ensino Médio Mariz e Barros e Escola Estadual de Ensino Médio Professor Alcides Cunha. Incluímos na Plataforma Brasil (PB) documentos em que os responsáveis por estes equipamentos sociais manifestam sua anuência e concordância: a carta de aceite da pesquisa assinada pelos responsáveis por cada uma das instituições citadas acima, o Termo de Anuência Institucional da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre através da Coordenação de Gestão Estratégica da Atenção Primária à Saúde - DAPS/SMS e o Termo de Anuência Institucional da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre através da Equipe de Indicadores - CGDI/SMED. Gostaríamos de informar que, pensando nas escolas estaduais, fizemos consulta ao CEP da Escola de Saúde Pública e fomos informadas de que não haveria necessidade de o projeto ser apreciado por aquele CEP. A nossa consulta e a resposta é um documento também incluso na PB agora. Sobre os equipamentos sociais e o campo de pesquisa, detalhamos a seguir o que gostaríamos de fazer. Na Unidade de Saúde Chácara da Fumaça, a perspectiva é de acompanhar o trabalho de enfermeiras(os) e agentes comunitárias de saúde com jovens gestantes, principalmente no Grupo de Gestantes que se reúne na unidade. Também serão feitas entrevistas com as(os) profissionais de saúde. Nas escolas, pretendemos acompanhar professores(as) em aulas, palestras e/ou atividades nas quais se discuta a saúde sexual e reprodutiva. Além disso, serão feitas entrevistas com professores(as). Assim como prevê-se que serão obtidas indicações para entrevistas com jovens a partir dos agentes que trabalham na Unidade de Saúde, o mesmo espera-se que ocorra em contato com os(as) professores(as) das escolas. As entrevistas serão sempre realizadas em local da preferência da pessoa entrevistada, assegurando o maior conforto e a privacidade da pessoa sendo entrevistada."

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre foi inserida como instituição coparticipante no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil. Assim, o projeto seguirá para apreciação pelo CEP-SMSPA.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram observados óbices éticos nos documentos da emenda.

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP-UFRGS, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação da emenda proposta para o projeto de pesquisa.

Reitera-se aos pesquisadores a necessidade de elaborar e apresentar os relatórios parciais e final da pesquisa, como preconiza a Resolução CNS/MS nº 466/2012, Capítulo XI, Item XI.2: "d".

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_2300227_E1.pdf	07/03/2024 20:35:35		Aceito
Outros	Emenda_Projeto_Gravidéz_na_juventude.pdf	07/03/2024 20:33:31	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	Consulta_CEPSESP.pdf	07/03/2024 20:32:58	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	TAI_SMED_27481335_SMS____.pdf	07/03/2024 20:27:45	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	TAI_SEI_PMPA.pdf	07/03/2024 20:26:32	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	carta_aceite_pesquisa_unidade_saude.pdf	07/03/2024 20:24:37	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	cartas_aceite_escolas.pdf	07/03/2024 20:21:05	Bárbara Birk de Mello	Aceito

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_de_tese_CEP_Barbara_Mello_ alteracoes_emenda.pdf	07/03/2024 20:18:17	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_jovens.pdf	05/12/2023 12:11:49	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_agentes.pdf	05/12/2023 12:11:36	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	Dispensa_TCLE.pdf	22/11/2023 09:57:22	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_assinado_AFL_Barbara.p df	22/11/2023 09:57:02	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 21 de Março de 2024

Assinado por:
Patrícia Daniela Melchioris Angst
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

ANEXO B

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PORTO ALEGRE/
SMSPA



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituição Coparticipante

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Gravidez na juventude: olhares para as políticas públicas, para os agentes de nível de rua e para os jovens de Porto Alegre, RS

Pesquisador: ANDREA FACHEL LEAL

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 75941623.5.3001.5338

Instituição Proponente: SMSPA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.803.607

Apresentação do Projeto:

TRATA-SE DE RETORNO DE PENDÊNCIAS - PARECER CONSUBSTANCIADO 6.757.503 DE 11/04/2024.

Trata-se de uma pesquisa não experimental de caráter qualitativo. A gravidez na juventude foi e continua sendo tema de diversas discussões no campo das políticas públicas juvenis. O presente estudo tem como problema de pesquisa: quais as distâncias e/ou aproximações entre as representações sociais acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade que os e as jovens porto-alegrenses têm, entre as narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de saúde e de educação de Porto Alegre voltadas para a reprodução e entre os agentes de nível de rua que atuam nesses contextos? Tem-se como objetivo central debater as representações sociais de jovens homens e mulheres, alguns com e outros sem experiência reprodutiva, acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade e confrontá-las com as representações sociais das narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de educação e saúde voltadas para a reprodução e com as representações sociais dos agentes de nível de rua que atuam nestes contextos. Para tanto, parte-se da anthropology of policy (Shore; Wright; Però, 2011; Shore; Wright, 1997). Aqui, fazemos uso de análise documental de dados secundários e advindos das

escritas de políticas públicas ; entrevistas semiestruturadas com jovens (homens e mulheres) com e sem experiência reprodutiva entre 16 e 20 anos. Ainda, entrevistas semiestruturadas e

observação de cunho etnográfico com agentes de nível de rua de escolas e unidades básicas de saúde. Estes materiais serão analisados à luz da análise de conteúdo (Bardin, 2011) em software de análise de dados qualitativos, Nvivo. Acredita-se que o estudo possibilitará uma análise crítica acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade juvenis a partir de três níveis distintos, mas genuinamente interligados: as narrativas oficiais das políticas públicas, o trabalho dos agentes de nível de rua e os(as) jovens porto-alegrenses. Dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Governo Federal (Governo Federal, 2022), o SINASC, apontam que, desde 2019, o número de mães com idades entre 10 e 19 anos, diminuiu, em média, 18%. Apesar da crescente redução dos casos de gravidez na juventude, ela é tratada como grande problemática por diversos setores da sociedade brasileira. Reyes e Almontes (2014) indicam que a percepção da gravidez na juventude como um problema é justificada por alguns fatores principais: infrequência escolar, riscos de saúde, dificuldades de conseguir emprego e manutenção da pobreza. Porém, os autores demonstram que a maioria dos jovens desistem da escola antes de engravidar, que jovens enfrentam condições de saúde impróprias muito antes de ter filhos, que os pais e as mães adolescentes já não conseguiam trabalho antes do nascimento da criança e que os jovens já estavam na condição de pobreza antes de passarem pela experiência de reprodução sexual. Heilborn (2006) também aponta para a construção da noção de que a gravidez na juventude é um problema social, vista como um evento perturbador. Para ela, essa visão ignora a diversidade de circunstâncias e desdobramentos que a maternidade e paternidade juvenis podem trazer. A partir disso, nos perguntamos: o que torna a gravidez na juventude um problema social ou não? Inicialmente, apontamos três fatores centrais: raça, classe e gênero, os quais discutiremos ao longo dessa tese. E, se políticas públicas existem para resolver problemas sociais, como boa parte da literatura sobre políticas públicas destaca, também nos perguntamos: que políticas públicas existem no que tange a reprodução juvenil? Como os atores de políticas públicas entendem a gravidez na juventude? Aqui, a partir da perspectiva da *anthropology of policy* (Shore; Wright; Però, 2011; Shore; Wright, 1997), entendemos que as políticas não são simplesmente coisas, elas são *¿assemblages¿*:

¿Policies are not simply `transferred¿, they are reinterpreted as they travel across cultural boundaries.¿

(Shore; Wright, 2011, p.20). Assim, ao analisar políticas públicas, estamos discutindo o contexto social, econômico e cultural em que nos inserimos e como este é formulado. Nesta tese, buscamos focar nas políticas públicas juvenis de saúde e educação voltadas para a reprodução. Aqui, buscamos atentar para como se constroem as representações sociais acerca da gravidez, maternidade e paternidade juvenis, tanto por parte

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

das narrativas oficiais das políticas quanto por parte de jovens com e sem experiência reprodutiva e dos agentes de nível de rua que trabalham em escolas e postos de saúde. Tudo isso no contexto da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Na presente pesquisa, problematizamos a gravidez na juventude entre os(as) jovens de 16 a 20 anos, então esta será a faixa etária da pesquisa. Vale esclarecer também que quando falamos em experiência reprodutiva, nos referimos tanto às experiências gestacionais que resultaram em nascimentos de crianças quanto, possivelmente, àquelas que não. Temos como problema de pesquisa: quais as distâncias e/ou aproximações entre as representações sociais acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade que os e as jovens porto-alegrenses têm, entre as narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de saúde e de educação de Porto Alegre voltadas para a reprodução e entre os agentes de nível de rua que atuam nesses contextos? Quanto à metodologia, ocorrerá uma análise documental de dados secundários em corpos normativos no nível federal, estadual (Rio Grande do Sul) e municipal (Porto Alegre). Foi feita uma entrada em campo de caráter exploratório no bairro Mário Quintana, na Região Nordeste de Porto Alegre, que possui a maior taxa de natalidade a cada 1.000 jovens (12,68/1.000). O bairro Mário Quintana foi escolhido para ser o universo empírico no qual a pesquisa será desenvolvida. Neste território serão observados os serviços de saúde, e serão convidados para entrevistas jovens e agentes de nível de rua. Seguindo preceitos da OPAS/OMS (OPAS, 1995), gravidez na juventude aquela que ocorreu entre os 10 e 20 anos de idade incompletos, então este é o primeiro recorte a ser levado em conta. No presente estudo, as pesquisadoras optaram por entrevistar jovens entre 16 e 20 anos de idade (considerando que a experiência da gestação pode ter se dado aos 19 anos e vamos fazer a entrevista logo depois desse evento). Para o objetivo de analisar as representações sociais dos e das jovens com e sem experiência reprodutiva entre 16 e 20 anos, serão feitas entrevistas semiestruturadas. Estima-se entrevistar 24 jovens (12 mulheres e 12 homens), além de 8 agentes públicos (professores e agentes de saúde). O número total de entrevistas estimado pode variar de acordo com o nível de saturação dos conteúdos. A forma de contato com os(as) possíveis entrevistados(as) se dará por intermédio dos agentes de nível de rua que acessaremos no bairro Mário Quintana. Após estabelecer contato com os primeiros entrevistados, a sequência de captação dos mesmos se dará através do recurso de bola de neve (a pessoa entrevistada será convidada a indicar outros potenciais participantes para a pesquisa). Prevê-se uma a duas horas de duração para cada entrevista, que será agendada previamente em função da disponibilidade e preferência do interlocutor, em local de sua preferência. A entrevista será gravada com gravador de voz e

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

transcrita na íntegra, sendo os arquivos de áudio e de transcrição armazenados em HD externo criptografado por um período de cinco anos após o término da pesquisa, para que o(a) participante possa decidir livremente sobre sua participação e sobre o uso de seus dados no momento e no futuro. Pelas resoluções 466 e 510, a princípio menores de 18 anos têm de assentir (TALE) e os seus responsáveis têm de consentir com sua participação na pesquisa (TCLE). Solicita-se a dispensa do TCLE para responsáveis por jovens de 16 e 17 anos, mantendo-se o TCLE para os jovens entrevistados. Se for necessário o consentimento de responsável, em se tratando de uma pesquisa que aborda a sexualidade juvenil, possivelmente alguns responsáveis não deixariam os(as) jovens participarem ou já buscariam direcionar suas falas. Observa-se que o CONEP aprovou recentemente pesquisa desenvolvida por este mesmo grupo de pesquisa em que as pesquisadoras atuam, por essas mesmas razões. Trata-se do estudo „Contextos de vulnerabilidade ao HIV entre jovens de camadas populares: um estudo multicêntrico em cinco cidades do Brasil - Espaços Jovens“, CAAE 36495120.7.0000.5327. Todos(as) os(as) participantes da pesquisa, jovens e agentes públicos, deverão assinar o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todos terão a garantia de que sua identidade não será revelada e que a entrevista será transcrita e utilizada para fins desta pesquisa. Além das entrevistas, será feita observação de cunho etnográfico junto dos agentes e seus ambientes de trabalho entendendo a importância de conhecer mais as dinâmicas que envolvem seus trabalhos e poder ter mais subsídio para analisar as representações sociais que estes têm acerca da gravidez, maternidade e paternidade juvenis.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo primário:

Debater as representações sociais de jovens homens e mulheres, alguns com e outros sem experiência reprodutiva, acerca da gravidez na juventude, maternidade e paternidade e confrontá-las com as representações sociais das narrativas oficiais das políticas públicas juvenis de educação e saúde voltadas para a reprodução e com as representações sociais dos agentes de nível de rua que atuam nestes contextos.

Objetivos Secundários:

Analisar as políticas públicas juvenis do setor de educação e do setor da saúde voltadas para a reprodução;
Registrar, brevemente, o perfil socioeconômico e familiar dos(as) entrevistados(as) da pesquisa, tanto jovens quanto agentes de nível de rua;

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

Analisar as narrativas dos agentes acerca das políticas públicas juvenis de saúde e educação voltadas para a reprodução e analisar as narrativas dos(as) jovens acerca de suas concepções sobre a gravidez, maternidade e paternidade na juventude.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Segundo as autoras:

Riscos: Os riscos e/ou desconfortos relacionados à entrevista são possível desconforto emocional diante de certos assuntos relacionados à sexualidade e à reprodução de jovens. Ao abordar certas temáticas, o(a) entrevistado(a) pode se sentir intimidado(a), envergonhado(a), triste e/ou outro sentimento que cause mal-estar. Para evitar o desconforto ou mal-estar dos(as) participantes da pesquisa, é importante que o(a) entrevistado(a) saiba que é possível encerrar sua participação na pesquisa caso assim deseje sem ter qualquer tipo de prejuízo. Ele(a) não precisa responder a qualquer questionamento caso não se sinta confortável. Ele(a) pode pedir para suspender a entrevista enquanto ela já esteja ocorrendo caso sinta qualquer desconforto. A entrevista poderá ser retomada quando e caso ele(a) concordar. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o(a) entrevistado(a) terá direito a ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei, segundo a Resolução CNS 510, VI, Art. 9. Ainda, mesmo que mínimo, há o risco de divulgação dos dados dos participantes de pesquisa, o que se buscará evitar ao máximo.

Benefícios: O principal benefício em potencial é indireto através da produção e divulgação do conhecimento científico que pode vir a aprimorar políticas públicas. Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados de mais de uma maneira. Nós planejamos divulgar os principais resultados na própria comunidade, discutindo a pesquisa na escola e no serviço de saúde. Além disso, vamos discutir os resultados com os gestores e com os profissionais que atuam na escola e no posto de saúde. Como potenciais benefícios para os(as) jovens entrevistados(as) acerca de sua participação na pesquisa elencamos os seguintes: poder dialogar sobre sua sexualidade e pensamentos acerca da gravidez na juventude, refletir sobre seus acessos à educação e saúde sexual, pensar sobre suas percepções acerca da gestação e dos papéis exercidos na maternidade e paternidade. Ainda, após o fim da pesquisa, receber um retorno de sua participação através de divulgação da tese por parte da acadêmica e conhecer também trajetórias e entendimentos de outros jovens acerca da gestação, maternidade e paternidade juvenis.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

- a. Título: GRAVIDEZ NA JUVENTUDE: OLHARES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA OS

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

AGENTES DE NÍVEL DE RUA E PARA OS JOVENS DE PORTO ALEGRE.

- b. Pesquisador responsável: Andrea Fachel Leal
- c. Assistentes de pesquisas: Barbara Birk de Mello
- d. Nível da pesquisa: Doutorado
- e. Curso: Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFRGS
- f. Local de realização do estudo: Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Victor Issle e Unidade de Saúde Chácara da Fumaça
- g. Duração do estudo: 21 meses
- h. Número de sujeitos da pesquisa: 32
- i. Data prevista para conclusão do estudo: dezembro de 2026.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

A Folha de Rosto foi assinada por Jefferson Cardia Simões, Vice-Pró Reitor de Pesquisa da UFRGS, em 21/11/2023. A Anuência Institucional da SMS/PMPA foi assinada por Vânia Maria Frantz (Diretora), em 26/02/2024. O Termo de anuência Institucional da SMED, foi assinado por Aline Rocha Mendes, Chefe de Unidade, em 19/02/2024. A pesquisa também apresentou cartas de aceite das Instituições participantes, tanto da Educação, quanto da Saúde; além disso, apresentou os TCLE para os participantes.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

ANÁLISE DAS RESPOSTAS ÀS PENDÊNCIAS MENCIONADAS NO PARECER CONSUBSTANCIADO 6.757.503 DE 11/04/2024.

Pendência 1/4 - No parágrafo sobre os riscos, incluir que sempre há o risco de divulgação dos dados dos participantes da pesquisa, mesmo que seja mínimo.

Resposta: No parágrafo sobre os riscos, incluímos que há o risco de divulgação dos dados dos participantes da pesquisa, mesmo que seja mínimo. As alterações, além de ocorrerem nos TCLEs, foram grifadas em amarelo no projeto de pesquisa. Também, foram anexados os TCLEs com mudanças na Plataforma Brasil. Segue reformulação que foi a mesma em ambos os TCLEs:

¿Ainda, reiteramos que mesmo que com riscos mínimos, existe a possibilidade de divulgação de dados de participantes da pesquisa, o que se buscará evitar ao máximo.¿

Análise: pendência atendida.

Pendência 2/4 - Nos TCLE não consta a informação da apreciação ética pelo CEP da PMPA/SMSPA. Favor inserir os dados e o telefone e e-mail de contato, com uma breve

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

explicação sobre o que é um CEP.

Resposta: Foi incluído nos TCLEs a informação da apreciação ética pelo CEP da PMPA/SMSPA. Foram inseridos os dados e o telefone e e-mail de contato, com uma breve explicação sobre este Comitê. As alterações, além de ocorrerem nos TCLEs, foram grifadas em amarelo no projeto de pesquisa. Também, foram anexados os TCLEs com mudanças na Plataforma Brasil. Segue reformulação que foi a mesma em ambos os TCLEs:

¿Ainda, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, CEP SMSPA, localizado na Rua Capitão Montanha, 27 ¿ 6º andar (Centro Histórico). O telefone para contato é (51) 3289-5517. O e-mail para contato é: cep_sms@hotmail.com.

O projeto foi avaliado pelo CEP-UFRGS e pelo CEP-SMSPA. Um CEP é um Comitê de Ética em Pesquisa, um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, cuja finalidade é avaliar ¿ emitir parecer e acompanhar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos. O CEP-SMSPA delibera sobre aspecto científico e ético de projetos de pesquisa realizados em diferentes setores e secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no caso deste estudo, setores de Saúde e Educação do município. O CEP-SMSPA busca adequar as pesquisas com seres humanos à legislação preservar a integridade dos participantes da pesquisa.¿

Análise: pendência atendida.

Pendência 3/4 - Ainda sobre o TCLE, o mesmo não se apresenta em forma de convite, o que deve ser alterado;

Resposta: Os TCLEs, foram modificados adequando ao formato de convite, conforme solicitado. As alterações, além de ocorrerem nos TCLEs, foram grifadas em amarelo no projeto de pesquisa. Também, foram anexados os TCLEs com mudanças na Plataforma Brasil.

Análise: pendência atendida.

Pendência 4/4 - No cronograma apresentado, a etapa de coleta de dados está desatualizada. Considerando que o projeto ainda se encontra em avaliação no Sistema CEP/Conep, neste CEP SMSPA, solicita-se esclarecimento e adequação do cronograma, incluindo o compromisso do pesquisador que a pesquisa não será iniciada antes da aprovação pelo CEP SMSPA.

Resposta: No cronograma apresentado, a etapa de coleta de dados foi modificada para iniciar em maio de 2024, levando em conta que o projeto ainda se encontra em avaliação no Sistema

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

CEP/Conep. Assim, reiteramos o compromisso das pesquisadoras de que a pesquisa não será iniciada antes da aprovação pelo CEP SMSPA. Também anexamos na Plataforma Brasil um Termo de Compromisso de Pesquisa, que aponta o compromisso de iniciar a mesma somente após aprovação do referido CEP. A alteração do cronograma foi grifada em amarelo no projeto de pesquisa. Também foi modificada na Plataforma Brasil no referido espaço de cronograma. Segue alteração:

¿Após a aprovação pelo CEP, será iniciada a observação de cunho etnográfico junto dos(as) agentes de nível de rua, as coletas de entrevistas realizadas com os(as) jovens e com os policy-makers. Previmos iniciar o campo em maio, caso haja aprovação pelo CEP ainda em abril. O trabalho de campo se dará ao longo do segundo semestre de 2024 até dezembro.¿

Análise: pendência atendida.

Considerações Finais a critério do CEP:

O parecer de aprovação do CEP SMSPA deverá ser apresentado à Coordenação responsável, a fim de organizar a inserção da pesquisa no serviço, antes de seu início. Os relatórios semestrais devem ser apresentados ao CEP SMSPA, através de submissão na Plataforma Brasil, como "Notificação".

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_PROJETO_2308306.pdf	12/04/2024 12:02:09		Aceito
Declaração de Pesquisadores	TERMO_DE_COMPROMISSO_DE_PESQUISAassinado12042024.pdf	12/04/2024 12:01:39	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
Outros	Carta_resposta_CEP_SMSPA.pdf	12/04/2024 11:58:03	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_jovens_atualizado.pdf	12/04/2024 11:57:31	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_agentes_atualizado.pdf	12/04/2024 11:57:10	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_de_tese_CEP_Barbara_Mello_alteracoes_finais.pdf	12/04/2024 11:56:33	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito
Outros	Emenda_Projeto_Gravidex_na_juven	07/03/2024	Bárbara Birk de	Aceito

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

Outros	tude.pdf	20:33:31	Mello	Aceito
Outros	Consulta_CEPSESP.pdf	07/03/2024 20:32:58	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	TAI_SMED_27481335_SMS____.pdf	07/03/2024 20:27:45	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	TAI_SEI_PMPA.pdf	07/03/2024 20:26:32	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	carta_aceite_pesquisa_unidade_saude.pdf	07/03/2024 20:24:37	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Outros	cartas_aceite_escolas.pdf	07/03/2024 20:21:05	Bárbara Birk de Mello	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_de_tese_CEP_Barbara_Mello_ alteracoes_emenda.pdf	07/03/2024 20:18:17	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_jovens.pdf	05/12/2023 12:11:49	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_agentes.pdf	05/12/2023 12:11:36	Bárbara Birk de Mello	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	Dispensa_TCLE.pdf	22/11/2023 09:57:22	ANDREA FACHEL LEAL	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 03 de Maio de 2024

Assinado por:

Alexandre Luis da Silva Ritter
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Capitão Montanha, 27 - 6º andar

Bairro: Centro Histórico **CEP:** 90.010-040

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3289-5517 **Fax:** (51)3289-2453

E-mail: cep_sms@hotmail.com

